

刘耀三 著 四川科学技术出版社

臟腑証治新編

脏
腑
証
治
新
編

ZANGFUZHENGZHIXINBIAN

刘耀三 著

脏腑证治新编

四川科学技术出版社

1988年·成都

责任编辑：杜英杰

封面设计：朱德祥

技术设计：张绍普

脏腑证治新编 刘耀三著

四川科学技术出版社出版、发行
(成都盐道街三号)

四川省新华书店经销

四川新华印刷厂排版

蓬溪县印刷厂印刷

ISBN 7—5364—0365—8/R·65

1988年9月第一版 开本850×1168毫米1/32

1988年9月第一次印刷 字数315千

印数1—7400册 印张17.25 插页4

定 价：5.50元

前 言

刘耀三教授年逾古稀，家学渊源，早年在四川温江地区从事中医内科专业，医德医术，载誉遐迩。1956年我国首批四所中医院校建立时，即受聘于成都中医学院，任教至今。刘老平素治学谨严，素孚众望，历届同学对其讲授，莫不倍加赞誉。当前，党和政府为了加速改变中医学后继乏人乏术的现状，提出“振兴中医”的战略号召，以适应实现社会主义四化建设需要，刘老亦以暮年壮志，伏案挥笔，将其数十年临证经验，撰成《脏腑证治新编》一书。

本书以中医脏腑系统分类学说为核心，在总论中，分别对五脏与五腑相互配合、脏腑与精津气血、脏腑与神志的生理病理关系及脏腑病变的基本规律等基础医学方面，作了透彻的论述。这是全书的指导

●脏腑证治新编●

思想。在各论中，按脏腑病机分类11章，分章分节列出常见内科疾病61种，每章于前言、结语中阐明病与病、证与证间的相互关系和辨证施治的特殊性和规律性，并附列病机简表以加深理解。其论病用方，约三分之二皆为刘老从临证中反复实践所创立的经验良方，一病一证，说理透，辨证详，一法一方，重实验，求实效，规律分明，疗效显著。这一系统而完整地体现当代名老中医临证经验和学术见解的著作，对中医教学、临床工作者和自学中医人员均有很高的参考价值。为此，谨缀数语以冠卷首。

张英秀

于成都中医学院函授部

1987年3月

2196/23

自序

祖国医学，源远流长，历代学人，从实践中发挥，发挥中发展，皇皇医籍，浩如烟海。余幼承家学，壮而业医，迄今50余载，虽苦心攻读，然犹止其门墙，未能深入堂奥。1971年以来，从临证教学中，汇编教言，初具章目，累经疏理，补缺删繁，历时12载，稿凡三易。全书以脏腑学说为基础，以临证实验为依据，首论脏腑病机明其理，次以脏腑为纲辨诸病，集常见内科疾病61种，按病机分类11章，附方235首，古方三之一，自方三分之二，非临证实效者不录。余尝谓：治病贵在明理。一病有常理，病变有规律，治有定法，方有专功。化裁通变，绳之以理，规之以法。合于理则效显，悖于理则效微。书成而名《脏腑证治新编》，盖承前人之学，抒管窥之见，欲学

者于一病一证之常变中，有理可循，有法可规。愿阅是编者，匡其不逮而惠教之，尤愿从学诸子于实践中更加发挥之，实所厚望。

刘耀三

于成都中医学院恬斋书屋

1987年3月

目 录

总 论

- 一、脏腑概论..... 4
- 二、脏与腑相互配合的生理
病理关系.....10
- 三、脏腑与精津气血的生理
病理关系.....20
- 四、脏腑与神志的生理病理
关系.....38
- 五、脏腑病变的基本规律.....47

各 论

- 第一章 卫肺疾病.....69**
 - 第一节 感冒.....70
 - 第二节 咳嗽.....79
 - 第三节 喘证.....91
 - 第四节 哮证..... 105
- 第二章 肺系疾病..... 119**
 - 第一节 肺癆..... 119
 - 第二节 肺痿..... 131
 - 第三节 肺痈..... 139
 - 第四节 失音..... 147

第三章 心肝疾病	157
第一节 郁证.....	157
第二节 眩晕.....	170
第三节 中风.....	178
第四节 厥证.....	190
第五节 癫狂.....	200
第六节 痫证.....	209
第四章 心肾疾病	217
第一节 心悸.....	217
第二节 不寐.....	225
第三节 多寐.....	231
第四节 健忘.....	234
第五节 遗精.....	239
第六节 阳痿.....	245
第五章 肝脾疾病	253
第一节 疟疾.....	253
第二节 传染性肝炎.....	265
第三节 积聚.....	275
第四节 鼓胀.....	282
附：黄汗.....	291
黄胖病.....	293
第六章 脾肾疾病	301
第一节 水肿.....	302
第二节 消渴病.....	315
第三节 淋证.....	323
第四节 癃闭.....	329
第五节 尿频不禁.....	336
第七章 肝肾疾病	343

第一节	痿证·····	343
第二节	疝证·····	351
第三节	奔豚气病·····	359
第四节	耳鸣耳聋·····	364
附:	脚气·····	371
第八章	胃系疾病·····	383
第一节	呃逆·····	383
第二节	噎膈·····	389
第三节	胃痛·····	394
第四节	呕吐·····	402
第五节	反胃·····	408
第九章	肠系疾病·····	415
第一节	霍乱·····	416
第二节	泄泻·····	424
第三节	痢疾·····	434
第四节	肠痈·····	443
第五节	便秘·····	449
第六节	虫证·····	456
第十章	痛证·····	467
第一节	头痛·····	467
第二节	面颊痛·····	475
第三节	肩臂痛·····	479
第四节	胸胁痛·····	481
第五节	关节痛·····	487
第六节	腰痛·····	495
第十一章	血证·····	503
第一节	咳血·····	505
第二节	呕血·····	511

●脏腑证治新编●

第三节	鼻衄.....	517
第四节	齿衄.....	521
第五节	尿血.....	525
第六节	便血.....	529
附:	崩漏.....	533
	风疹块.....	538

总 论

13

14

中医内科学是以脏腑病机学说为基础，并以脏腑辨证为方法，用以治疗外感六淫、内伤七情和饮食劳倦等因素所引起的一般时令性、内伤性以及一些急慢性传染性疾病的临床学科。

中医学以阴阳、五行学说为基础，以心、肝、脾、肺、肾五脏配合胆、胃、小肠、大肠、膀胱五腑为基本功能单位以统率肢体、发肤、神志、七窍、经脉、气血而建立了以整体观念为特立的、以脏腑分类为方法的人体脏腑系统分类学说。因此，无论疾病的种类如何繁多，涉及的范围如何广泛，发病的原因如何复杂，都是在病因属性的作用下，使所属脏腑的生理功能发

生病理变化而致发病。一脏一腑各有功能，脏与脏、腑与腑、脏与腑之间，以其相生相制的关系互相联系而维持人体生理功能的协调和平衡。人体受到这样或那样的病因影响，都以病因的属性影响脏腑功能并以相生相制的关系有规律地传变和发展。所以，一病有一病的发展趋势，一证有一证的发展规律。

历来中医内科杂病多采用所表现的主要证候作为病名，证与证之间，在病情发展和恢复过程中，往往又有互为转变的特点，因而某些证之间，既是相互关联的又是各具特性的。但从脏腑病机变化的规律来看，它们之间也是具有共性的。

因此，为了认识和理解病与病、证与证之间发生和发展的规律，首先对中医关于脏腑生理病理学说的讨论以理解其系统性、规律性和一致性，从而更好地掌握以脏腑病机为特点的辨证论治法则，这对指导临床实践是有重要意义的。

一、脏腑概论

脏腑即人体内脏的总称。它包括了五脏、六腑和奇恒之腑三类。心、肝、脾、肺、肾合称五脏；胆、胃、小肠、大肠、膀胱、三焦合称六腑；脑、髓、骨、脉、胆、女子胞六种器官和组织，称为奇恒之腑。古人以心包不同于

其他的腑,认为应与五脏并列而称六脏。实际上,心包表现的功能和病证,与心的功能和病证,都是一致的。六腑中的三焦,是人体津气升降出入的道路,也不同于其他脏腑组织,三焦具有总领五脏、五腑、经脉、荣卫、内外、左右、上下津气运行的功能,《灵枢·本输篇》称他为“孤府”,即言其孤大无匹,因之把三焦与五腑并列,亦是不相称的。奇恒之腑的脑、髓、骨、脉、胆分别与肾、心、肝有极为密切的关系;女子胞虽是一个独立的器官,与任脉、冲脉相联系,而任脉、冲脉表现的功能和病证,往往与肝、肾的功能和病证是一致的。基于上述理由,这里所论脏腑功能,即以心、肝、脾、肺、肾五脏配合胆、胃、小肠、大肠、膀胱五腑的基本功能及其相互关系,作为讨论中心。

脏腑一词,古称“藏象”。“藏”即人体内各个脏器,“象”即脏腑功能在生理病理方面所表现的征象或形象。所以,张景岳说:“藏居于内,形见于外,故曰藏象。”(《类经·卷三》)即是说,人体所表现的各种生理的、病理的现象,都可根据其特征以脏腑分类的方法归纳到各脏各腑的功能范围,作为对各种疾病辨证论治的依据。这是历代医家从长期临床实践中,对人体生理病理的观察,总结和建立了一套完整的、具有整体观念的脏腑系统分类的理论和方法。这是中医临床辨证的理论基础。所以,中医学的脏腑名称,虽然也包括了古代的解剖知

识（如《灵枢·经水篇》说：“夫八尺之士，皮肉在此，外可度量切循而得之，其死可解剖而视之。”）其所称之心、肝、肺、脾、肾等脏器已不单是一个解剖学的概念，而是人体生理病理方面的系统分类的概念。因此，不能把中医学的脏腑学说与现代解剖学上的概念等同起来。

脏腑与人体各个组织之间的复杂联系，以及人体与外界环境之间的相互关系，都是用阴阳、五行学说作为基础的。五脏阴阳的划分，据《灵枢·阴阳系日月篇》说：“心为阳中之太阳，肺为阴中之少阴，肝为阴中之少阳，脾为阴中之至阴，肾为阴中之太阴。”五脏分属于五行的划分：心属火，肺属金，肝属木，脾属土，肾属水。由此可见，阴阳、五行与五脏的配合，是以心、肾两脏作为主体以概括阴阳、水火的主要功能，肝木、肺金、脾土则用以说明阴阳水火的变化规律和脏腑生理功能活动的特性。这种功能和特性，不仅表现于脏与脏、腑与腑、脏与腑之间，同时表现在内脏与肢体、七窍、神志、五色、五味等各个方面，并与外界四时气候的转移变化，都是密切相关的。

脏与脏之间，是相互资生、相互制约的关系，即五行相生、相克的关系。如《素问·阴阳应象大论》说：“肝生筋，筋生心”；“心生血，血生脾”；“脾生肉，肉生肺”；“肺生皮毛，皮毛生肾”；“肾生骨髓，骨髓生肝”。这是相互资生的相生关系。如《素问·五藏生成

论》说：“肾为心之主，心为肺之主，肺为肝之主，肝为脾之主，脾为肾之主。”所谓“主”，即主宰、制约之义，亦即相互制约的相克关系。人体生理活动，就是在脏与脏之间既互相资生又互相制约来协调和维持其平衡的。如果这种生制关系受到外在的或内在的病因干扰而失去平衡，便会产生内脏功能偏衰偏盛，而出现相互乘侮，以致发生种种病变。

腑与腑之间是传化关系。即：水谷精微由此而运化转输，糟粕废物由此而传送排泄的关系。正如《素问·六节藏象论》说：“脾胃、大肠、小肠、三焦、膀胱者，仓廪之本，荣之居也，名曰器。能化糟粕转味而入出者也。”胃肠道受纳水谷、转输精微、传送糟粕的功能，是以胃满则肠虚，肠满则胃虚，虚实更替的运动形式来进行的。正如《灵枢·平人绝谷篇》所说：“胃满则肠虚，肠虚则胃满，更虚更满，则气得上下。”也正由于腑气以下行为顺，宜通不宜滞，故有腑病以通为补的理论。

脏与腑之间的关系，表现于两方面：一是相合的关系，一是表里的关系。《灵枢·本藏篇》：“肺合大肠”，“心合小肠”，“肝合胆”，“脾合胃”，“肾合三焦、膀胱”。这是相合的关系，合即合作、配合的意思。各脏各腑各有功能，然而它们间又必须在各自配合的脏与腑相互合作下，才能更好地把它们独特功能显现出来。这便是相合的功能和作用。所谓表里关系，即《素问·血气形

志篇》所说：“足太阳（膀胱）与少阴（肾）为表里，少阳（胆）与厥阴（肝）为表里，阳明（胃）与太阴（脾）为表里；是为足之阴阳也。手太阳（小肠）与少阴（心）为表里，少阳（三焦）与心主（心包络）为表里，阳明（大肠）与太阴（肺）为表里；是为手之阴阳也。”此种表里关系，主要通过手足三阴三阳十二经脉互为联络来构成。腑为阳，脏为阴，阳主表，阴主里，一脏一腑，一阴一阳，相互配合，构成体内各个脏腑基本功能单位，以表现生理病理上的相互关系。

人体肢体、七窍分属于五脏的归类，如《素问·五藏生成论》说：“心之合脉也，其荣色也”；“肺之合皮也，其荣毛也”；“肝之合筋也，其荣爪也”；“脾之合肉也，其荣唇也”；“肾之合骨也，其荣发也”。《素问·阴阳应象大论》说：“（肝）在窍为目，（心）在窍为舌，（脾）在窍为口，（肺）在窍为鼻，（肾）在窍为耳”。又因肾居下焦，为水火之宅，是元阴元阳之根，人的生殖功能为肾所主，而大、小便的排泄与肾阴肾阳的强弱也有密切关系。肾阴不足，可见小便量少，或大便干结；肾阳不足，可引起小便不禁，或大便滑泄。所以，肾在上开窍于耳，在下又开窍于前后二阴。此即肢体、七窍分属于五脏统率的关系。

中医学认为，人的神志功能，也是分属于五脏统率的。此即《素问·宣明五气篇》所说：“心藏神，肺藏

魄，肝藏魂，脾藏意，肾藏志，是谓五藏所藏。”由情绪变动而产生的喜、怒、思、忧、恐等表现，称为五志，亦分属于五脏功能范围。如《素问·阴阳应象大论》说：“人有五藏，化五气，以生喜、怒、悲、忧、恐。”“肝在志为怒”，“心在志为喜”，“脾在志为思”，“肺在志为忧”，“肾在志为恐”。这就是五神、五志与五脏功能的关系。

五色、五味也相应地配合于五脏功能范围。五色即青、黄、赤、白、黑五种色泽。正常情况下，五脏精气的华彩显露于颜面眉目之间，表现色泽腴润、神光焕发的景象。如果内脏发生病变，往往面色随之而发生变化。如心病现赤色，肝病现青色，肺病现白色，脾病现黄色，肾病现黑色。五味即甘、苦、酸、辛、咸五种味觉。五脏对五味各有不同的适应，如《灵枢·五味篇》说：“五味各走其所喜，谷味酸，先走肝；谷味苦，先走心；谷味甘，先走脾；谷味辛，先走肺；谷味咸，先走肾。”所以，人们日常饮食习惯应注意五味和调，才能适应五脏的需要。如五味有所偏嗜，就会产生如《素问·阴阳应象大论》所说“酸伤筋，苦伤气，甘伤肉，辛伤皮毛，咸伤血”等脏气失调而引起种种病变。

以上论述，说明中医学对人体生理病理的认识，都是用阴阳、五行与五脏相配合为理论基础；从而建立了以整体观念为特点的、以五脏功能为分类方法的人体脏腑

系统分类学说（表1）。

表1 人体脏腑系统分类简表

分 类		心 系	肝 系	脾 系	肺 系	肾 系
阴	阳	阳中之太阳	阴中之少阳	阴中之至阴	阴中之少阴	阴中之太阴
五	行	火	木	土	金	水
五	腑	小肠	胆	胃	大肠	三焦、膀胱
五	神	神	魂	意	魄	志
五	志	喜	怒	思	忧	恐
肢	体	血脉	筋、爪	肌肉	皮毛	骨、髓
七	窍	舌	目	口	鼻	耳及二阴
五	色	赤	青	黄	白	黑
五	味	苦	酸	甘	辛	咸

二、脏与腑相互配合的生理病理关系

脏与腑相互配合，脏的功能藏而不泻，腑的功能泻而不藏。故《素问·五藏别论》说：“所谓五藏者，藏精气而不泻也，故满而不能实；六腑者，传化物而不藏，故实而不能满。”就是说，五脏的生理功能是生化和储藏精津气血；六腑的生理功能是受纳和腐熟水谷、传化和排泄糟粕。脏为阴，腑为阳，脏以阴为体而阳为用，腑以阳为体而阴为用，阳主升，阴主降，一脏一腑，一阴一阳，一体一用，一升一降，相互配合，构成体内五大基本功能单位，从而在分工合作下以实现生化精津气血和腐熟水谷、传化糟粕的生理作用。现将五脏配合五腑所表现的

生理病理关系分述如下：

(一) 脾与胃

脾与胃并居中焦，胃主受纳水谷，腐熟水谷；脾主运化水谷，转输精微津液；共同完成饮食消化、吸收以及精气输布的功能。人禀先天之肾气而生长发育，然而更需要后天水谷之精气的不断给养和补充，才能不断地维持其生活能力。正因脾胃是供给脏腑营养、生化气血的源泉，故《灵枢·五味篇》说：“五藏六府皆禀气于胃。”所以，一般把脾与肾并列而有肾为先天之根，脾为后天之本的理论。

脾气主升，胃气主降，胃气降，胃中腐熟之水谷得以下行移入小肠；脾气升，胃及小肠吸收之精微津液得以上输于心肺。脾胃属土，脾为阴脏，属于湿土，其性喜燥恶湿；胃为阳腑，属于燥土，其性喜润恶燥。在此脾与胃、脏与腑、阴与阳相互配合下，升降相因，燥湿互济，就能发挥消化食物和转输精气的正常功能。由于脾与胃在生理上有相互利赖的密切关系，故在病理上往往互为因果。

脾不运化，则胃不受纳；胃中食滞，则脾不运行。脾虚而清气不升，不能转输精微津液，津聚为湿，脾为湿困则见纳呆、呕恶、脘腹痞胀、肠鸣泄泻等证。反之，脾津不足，胃燥失润，在上无以上润，可见口干唇燥；在下则腑气不降，可见腹胀、大便干结。正如《素问·阴阳应象

大论》所说：“清气在下，则生飧泄；浊气在上，则生腹胀。”这就是脾胃升降、燥湿功能失调所引起的病理变化和临床表现。

（二）心与小肠

心主血脉，故《素问·五藏生成篇》说：“心之合脉也”；“诸血者，皆属于心。”小肠是承受胃中经过腐熟之水谷，并继续进行消化的器官，故《素问·灵兰秘典论》说：“小肠者，受盛之官，化物出焉。”心与小肠相互配合表现的生理病理关系，有如下两方面：

1. 生化血液 《灵枢·本藏篇》说：“心合小肠，小肠者脉其应。”《灵枢·荣卫生会篇》说：“中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血。”《素问·经脉别论》说：“食气入胃，浊气（精气）归心，淫精于脉，脉气流经……。”由此可见，心与小肠相互配合与血脉相通的相应关系，主要体现于由胃及小肠腐熟水谷之精微，经脾气转输上归于心肺，进入于脉道，化以为血的关系。根据《千金方》记载，认为：小肠中“受留水谷二斗四升，一斗二升是水，一斗二升是谷”。可知小肠是容纳水谷量最多的一个器官。因此，由脾转输入心化血的精微物质，其中大部分应该是来源于小肠中的，故一般称小肠有奉心化血的功能。小肠这一功能，又必须在心阳的资助下才能实现，心与脾火土相生，心旺则脾旺，脾旺才能消化、吸

收胃及小肠之水谷精微入心化血。心阳不足,则母令子虚,脾失健运,则胃肠功能失常。于是,即可发生一系列心脾不足、气虚血少的病变。

2.泌别清浊 《灵枢·荣卫生会篇》说:“下焦者,别回肠,注于膀胱而渗入焉。”“水谷者常并居于胃中,成糟粕而俱下于大肠而成下焦,渗而俱下,济泌别汁,循下焦而渗入膀胱焉。”回肠即小肠,小肠上连于胃,下接大肠。胃及小肠中水谷精微,由脾转输上归心肺化以为血,其余水分和糟粕经小肠泌别清浊的功能,清者(水分)向前渗入膀胱而为小便,浊者(糟粕)向后下入大肠而为大便。这又是心与小肠相合体现于升清(精气)降浊(废水和糟粕)的生理功能。表现于病理方面:心经实火,可移热于小肠,小肠又能移热于膀胱,引起尿少、尿赤、排尿灼热等证。反之,小肠有热,既可循其经脉上犯于心,见心烦、舌赤、舌间糜烂等证,还可灼伤津液,影响糟粕传送,而见大便干结。又如小肠功能失调,去大肠的水分过多,可产生大便溏泄,小便短少;渗入膀胱的水分过多,又能引起小便量多,大便干结。如受到有害病因的影响,而致小肠功能紊乱,还可出现上吐下泻的严重证候。

(三) 肺与大肠

肺居上焦,主气,司呼吸,具有敷布津气外而温充肌肤、溉泽毛发,内而通调水道、下输于肾的职能。大肠居于下焦,下连广肠(直肠),其功用是把小肠中下移而来

的糟粕变为粪便，定时地排泄于体外。此即《素问·灵兰秘典论》所说“大肠者，传道之官，变化出焉”的功能。

肺与大肠通过其所属经脉互为联系，而构成上下交通的表里关系。肺气宣降则津气下输，大肠得津气助益，就能实现其传送大便的正常功能。然而肺与大肠的这一生理作用，又是依赖于肺与肾金水相通的生理关系才能实现。肺为气之主，肾为气之根，肺为水之上源，肾为受藏五脏六腑津液之脏。即是说，肺主于气，而肺主之气，则是根源于肾；肾主藏津，而肾藏之津，则是来源于肺。正常情况下，肾气旺则肺有所主，肺气旺，水道通调，津液下输，则肾有所藏。在肺与肾、津与气、上下交通、相互利赖的条件下，大肠得肺、肾津气助益便能实现传送糟粕和约制大便的功能。表现于病理方面：肺气不足，肺失宣降，气虚不能传送，则大便失畅，病为气虚便秘。肾气不足，下焦虚寒，肠道冷涩，病为虚寒冷秘；肾气不固，不能约制大便，或以肠气下陷发为肛坠，或以大便失禁发为滑泄。反之，肺中有热，津液亏伤，津气不得下润，肠脏失养，则大便秘结不通；肾阴亏虚不能润养肠脏，亦可出现大便干结。

（四）肝与胆

《灵枢·本输篇》说：“肝合胆，胆者中精之府。”胆附于肝，内藏精汁，故称为中精之府。精汁即胆汁，味苦色黄，来源于肝，禀肝之浊气而生，泄于胆中，聚合而

成。腑气以下行为顺,胆汁下行注入小肠,又有助于食物的消化和糟粕的排泄。肝与胆相合所表现的生理病理作用,有以下两方面:

1.疏泄脾胃 根据五行配合,肝胆属木,脾胃属土,木能克土,在生理上则表现为疏泄脾胃的功能。肝与脾属于脏,脏气以上升为常;胆与胃属于腑,腑气以下降为顺。因之,肝气上升,脾得肝气之助,脾气调畅则能助胃输精上归心肺;胆气下降,胃得胆气之助,胃气和降则能消化食物、传送糟粕。此即木疏土的生理功能。

表现于病理方面:肝胆疏泄功能失调,就会影响脾胃升降而见胸胁痞满、食欲不振、食后腹胀、暖气不舒、大便失畅等一系列肝脾失和证候。这便是木不疏土导致中焦升降失和的病理改变。如肝脾失和蕴遏日久,脾不健运,水湿内停,久则蕴酿生热,湿郁热蒸,阻遏肝胆,肝胆疏泄失畅,又能发生胆液不循常道溢于肌表,发生黄疸病证。所以,《临证指南》指出:“湿从火化”,“瘀热在里”,“胆热液泄”,“身目俱黄”。反之,脾病也可影响于肝,如脾气不足,运化失常,血无生化之源,又可导致肝血不足的病候。

由此可见,肝病可以传脾,脾病亦能累及于肝,故肝与脾体现于消化功能方面的生理病理关系极为密切。

2.谋断事物 《素问·灵兰秘典论》说:“肝者将军之官,谋虑出焉。”“胆者中正之官,决断出焉。”谋

虑即善于思考策划，以适应外界事物变化；中正和决断即刚正和果断地处理事物的复杂性。此即是说，肝胆相合在神志活动中，具有思考策划并果断而准确地来适应外界事物变化的功能。因此，人的多谋善虑和勇敢、虚怯与肝气的盛衰是密切关联的。

人的精神意志活动，本与心、肝、肾的关系最为密切，而胆量的勇怯则与肾气的盛衰密切关联。肝气往来于心、肾之间，具有调节神志活动，以适应事物变化的功能。肝与肾水木相生，互为依赖，肾虚则精气虚，精气虚则肝气随之而虚（母令子虚），肝肾不足则胆量虚怯。于是即可出现郁郁不乐，多疑善恐，心中惊悸，睡眠恍惚，乱梦纷纭，对事物表现为寡断多疑等神志证状。

由此说明，肝与胆相互配合所表现的生理病理关系，主要体现于疏泄脾胃方面。其谋断事物的功能，应与肝肾关系密切，似与胆腑功用无关。

（五）肾与三焦、膀胱

肾的功能受藏脏腑津液，三焦是沟通津液出入的道路，膀胱储藏肾中下移而来的津液，并使之成尿，而排泄于体外。《素问·上古天真论》说：“肾者主水，受五藏六府之精而藏之。”《灵枢·本输篇》说：“肾合膀胱，膀胱者津液之府也。”《素问·灵兰秘典论》说：“三焦者，决渎之官，水道出焉。”“膀胱者，州都之官，津液藏焉，气化则能出矣。”《灵枢·本藏篇》说：“肾合三

焦、膀胱，三焦、膀胱者，腠理毫毛其应。”由此可知，肾与三焦、膀胱相互合作的作用，主要表现于体内津液的储藏、输布和排泄等方面。这一功能的具体体现：一是布达汗液，一是排泄小便。

肾为水脏，受藏五脏六腑津液，肾中所藏津液来源于两个途径：一是来自胃中水谷经过消化吸收之津液，由脾转输于肺，再经肺气通调下输，受藏于肾；一是来自小肠把未被吸收的水液泌别而出，渗入下焦。津液汇聚下焦，经肾气的气化作用，以三焦为道路，其清者升发上行，四布于周身，并行于诸脏，布达于肤表者，可为汗而从腠理皮毛分泌于体外；其浊者下行渗入膀胱为尿而排泄。正因肾藏之津液与汗液、小便互为盈虚，故小便过多则体内津液相应减少，汗出太多则小便量相应短少。又如天热多汗而小便少，天冷汗少而小便多。

正因肾功与汗液、小便的排泄关系密切，所以，在外因或内因的病害因子作用下，都能导致水液代谢功能紊乱，发生小便不利、或遗溺失禁，甚则水液停聚泛溢肌肤，出现水肿病证。一般情况下，人体汗液是由肺气敷布津液来供给的。如在强力劳动中，肺气供应津液不及，肾气就会升发津液供应汗液分泌。当此汗出之际，或遇风邪，或入水沐浴，骤令汗孔闭塞，使从肾传来之津液，既不能为汗外出而排泄，又不得内入而返归于肾，于是留聚肌肤发生水肿。此即《素问·水热穴论》所说“勇而劳

甚则肾汗出，肾汗出逢于风，内不得入于藏府，外不得越于皮肤，客于玄府（汗孔），行于皮里，传为附肿，本之于肾，名曰风水”的病证。这是外因风邪而致水液代谢障碍所发生的病理变化。

《素问·标本病传论》说：“肾病小便闭。”“膀胱病小便闭。”《素问·经脉别论》说：“膀胱不利为癃，不约为遗溺。”由此可见，肾与膀胱排泄尿液功能失调，都能出现小便不利、或遗溺失禁的病变。一般说来，排泄和约制小便的功能，主要与肾气强弱关系密切。所以，王启玄说：“若得气海之气施化，则溲便注泄，气海之气不及，则阏隐不通。”小便不得通利，又能使水津内聚上下泛溢于肌肤，形成水肿病证。故《素问·水热穴论》指出：“肾者胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也，上下溢于皮肤，故为附肿。”这是内因肾气失调，以致排泄功能障碍而引起的病变。

三焦水道不得通利，也是造成水液代谢失调的重要因素。正如《灵枢·五癃津液别篇》所说：“三焦不写（泻），津液不化，水谷并行胃肠之中，别于回肠，留于下焦，不得渗膀胱，则下焦胀，水溢则为水胀。”由此可见，三焦水道失畅，津液不得宣化，留聚下焦则为腹胀，泛溢肌肤则为水肿。

由此说明，肾与三焦、膀胱相合对体内水液代谢的功能，在生理上是互为依赖的，在病理上也是互为因果的。

肾病可影响三焦、膀胱，三焦、膀胱有病亦能累及于肾，从而使水液输布、排泄功能失调发生水液潴留、或小便失禁等种种病变。

由上所述，说明各脏各腑相互合作所组成的五大基本功能单位，都是在一脏一腑，一表一里，一阴一阳，一升一降，相互调节的机能上体现出各脏各腑的特有功能，因而各脏各腑在病理演变中所表现证候特征，也是各有规律的（表2）。

表2 脏与腑相合的生理病理关系

脏 腑	生 理	病 理
脾与胃	腐熟水谷，转输精微。 燥湿互济，升清降浊	脾失健运，纳呆，呕恶，脘腹胀，大便泄泻。 胃津不足，口干唇燥，腹胀，大便干结
心与小肠	生化血液，泌别清浊	心移热于小肠，尿赤尿少。 小肠有热循经上犯，心烦舌赤，舌间糜烂。 泌别失调，便溏尿少，或尿多便秘。 心脾不足，气血虚少
肺与大肠	经脉相通，互为表里。 宣降津气，传送大便	肺气不足，传送无力，气虚便秘。 下焦虚寒，肠道冷涩，虚寒便秘。 津液亏伤，肠道失润，大便燥结。 气虚不固，肛坠、滑泄

肝与胆	疏泄脾胃，升清降浊。 谋虑决断，调节神志	肝脾失调；胸胁痞满，食欲不振，腹胀嗳气，大便不爽。 湿热阻滞，胆液不循常道，发黄。 脾虚不运，肝血虚少。 肝胆气虚，多疑善恐，惊悸多梦，寡断多疑
肾与三焦膀胱	储藏津液， 升发汗液， 决渎水道	汗孔闭塞，津液留聚肌肤，浮肿。 肾气不足，水道失调，或小便不利，或遗溺失禁。 三焦不利，水气泛溢，水肿

三、脏腑与精津气血的生理病理关系

精、津、气、血是构成人体生命活动的基本物质。它以先天赋予的精津气血为基础，依赖于后天的水谷精微不断地给养和补充，以维持人体生命的能力。然而精津气血的生成、储藏、输布、代谢等作用，则在各脏各腑功能的分工合作下完成。现分述如下：

（一）肝肾与精的生理病理关系

通常所称之精，有广、狭二义：广义之精，是津液和精髓的总称；狭义之精，是指具有生殖功能的精和汇聚于脑中的髓，这是维持人体生命最根本的一种物质。《灵枢·本神篇》说：“故生之来，谓之精。”《灵枢·经脉篇》说：“人始生，先成精，精成而后脑髓生。”

《素问·五藏生成篇》说：“诸髓者，皆属于脑。”《素问·解精微论》说：“脑为髓之海。”《素问·金匱真言论》说：“夫精者，身之本也。”“北方黑色，入通于肾，开窍于二阴，藏精于肾。”由此说明，精是构成人体生命的物质基础。先天之精，禀受于父母，受藏于肾，是人体发育与生殖的基本物质。后天之精，来源于水谷精微，由脾转输归藏于肾，其中渗入骨中之精，便是充养骨髓和脑髓的来源。正如《灵枢·五癯津液别篇》所说：

“五谷之精液，和合而为膏者，内渗于骨空，补益脑髓。”先天之精得到后天之精不断地给养和补充，经过齿更发长等变化，肾之精气逐渐充盛，就产生了“天癸”物质。于是，男子产生了“精子”，女子则“任脉通，太冲脉盛，月事以时下”（《素问·上古天真论》），从而男女之间就有了生殖能力。肾精不断充盛，脑的发育得到健全，记忆、视听、嗅觉、语言等功能才会得到完善。正如《医林改错》所说：“灵机记性在脑者，因饮食生气血，长肌肉，精汁之清者，化而为髓，由脊髓上行入脑，名脑髓。两耳通脑，所听之声归于脑；两目系如线长于脑，所见之物归于脑；鼻通于脑，所闻香臭归于脑；小儿周岁脑渐生，舌能言一二字。”由此说明，肾精与人体发育、生殖和灵机聪慧的关系极为密切。

先天之精得后天之精供给，藏之于肾，经肾之气化作用，化而为天癸，化而为精髓，天癸施泄于下而有生殖能

力，精髓上归于脑而有灵机记性。这个上行下施的作用，又是在肝、肾生理功能互相配合下实现的。肝、肾经脉并起下焦，肾经脉络贯脊络肾，肝经脉络入毛中络于阴器。肾主封藏，肝主疏泄。即是说，肾以生化精髓、储藏精液为职能，而精、髓上行下施的功用，则有赖于肝之疏泄来实现。正常情况下，精藏于肾，肝气调畅，肝气升发，便能使肾精上行四布以供脏腑需要，其中渗入骨中之精，即化而为髓上归于脑。在人体情欲影响下，情动则引动相火，相火动则肝阳随之而动，于是疏泄功能增强而产生肾精施泄。正如朱丹溪论“遗精”病理所说：“主闭藏者肾也，主疏泄者肝也，二者皆有相火，而其系上属于心。心，君火也，为物所感则易动，心动则相火亦动，动则精自走。”由此可见，肝与肾和精与髓的升降关系，非常密切。

正因肝、肾功能对脑、髓、骨、女子胞以及男女生殖、发育等生理关系极为密切，如以先天不足，或后天亏损，或以其他疾病影响，便可出现男子遗精，女子经病，男女不育，脑力衰弱，智力迟钝，或骨骼发育不良等疾病。所以，临床上治疗此类疾病，都以调治肝肾为辨证中心。

（二）脾肾与津液的生理病理关系

人体津液有津与液的区分。如《灵枢·决气篇》说：“腠理发泄，汗出溱溱，是谓津。”《灵枢·五癪津液别

篇》说：“津液各走其道，……温分肉，充皮肤，为其津；其流而不行者，为液。”于此可知，津，是体内出入升降润养脏腑、血脉、肌肤的一种物质，亦即体内含量最多的一种水分。液，是一种比较稠厚的液体物，此液输注于肢体筋骨关节之间，能使骨节伸屈便利，渗溢于体表能使皮肤光泽滑润。

《素问·经脉别论》说：“饮入于胃，游溢精气，上输于脾，脾气散精，上归于肺，通调水道，下输膀胱，水精四布，五经并行，合于四时五藏，阴阳揆度，以为常也。”《素问·逆调论》说：“肾者水藏，主津液。”

《素问·灵兰秘典论》说：“三焦者，决渎之官，水道出焉。”由上文献说明，人体津液的生成、储藏、输布、排泄作用，是在肺、脾、肾、三焦等脏器和组织生理功能配合下进行的。

水谷入胃，经胃与小肠的腐熟和消化，由脾运化和转输，把其中津液上输于肺。肺有宣降津液的职能，津液经肺气宣降，得以通调水道，下输于肾。再经肾之气化作用，津液乃得升发四布于周身，并行于五脏六腑。其中经心脏血脉运行而透达于肤表者为汗，经肺之鼻窍而出者为涕，经肝之目窍而出者为泪，经脾之上窍唇口而出者为涎，经肾之经脉上注于舌本（肾脉循喉咙挟舌本）而出者为唾。此即《素问·经脉别论》所说：“五藏化五液，心为汗，肺为涕，肝为泪，脾为涎，肾为唾，是谓五液。”

津液中比较稠厚之液体物，输注于肢体筋骨关节间，能使关节滑利，伸屈自如；渗溢于体表，能使皮肤润泽光滑；渗入于骨中，还可补益脊髓。此即《灵枢·决气篇》所说：“淖泽注于骨，骨属屈伸泄泽，补益脑髓，皮肤润泽，是谓液。”津液经脏腑、血脉、肢体筋骨、皮肤等组织利用以后，其废弃的水液由中焦分别清浊功能，使之下输于肾渗入膀胱，成尿而排泄于体外。津液在体内升降出入，都是以上中下三焦为道路来进行的。这便是人体津液代谢的全部过程。

肺、脾、肾三者是主持人体津液代谢的主要器官，其中以脾、肾的作用更占有主导地位。肾居下焦，为主水之脏，司气化，主开阖，具有升发津液、决渎水道职能。脾居中焦，司运化，主升降，具有转输津液、调节水道运行职能。因此，凡体内水液代谢功能发生紊乱，大体都从脾、肾功能失常引起。水液代谢失常所引起的病变，一般表现于两方面：一是水液代谢过强，产生水液过度排泄；一是水液代谢减弱，产生水液潴留。于是以两类相反的病证表现于临床。

饮食不节，损伤脾气，或肾精亏耗，精气虚亏，脾虚则运化失职，肾虚则固摄无权。于是津液偏渗于下，出现小便频数量多。津液下渗不得上承，则口中干渴而喜饮；愈饮愈消，津液耗散，胃中失养，胃燥独盛，则消谷善饥而喜食；于是出现以尿多、饮多、食多为特征的消渴病

证。本病以阴虚燥热病理出现，燥热原于津亏，津亏因于脾、肾代谢津液过强所致。

如果脾气虚弱，中焦升降津液功能减退，清者不升，浊者不降，上下不通，水气痞塞，停聚于大腹则见腹中胀满，泛溢于肌肤则见肢体水肿。所以，《素问·至真要大论》说：“诸湿肿满，皆属于脾。”如果肾功衰减，下焦气化不行，致令升发津液和排泄小便功能失职，也会发生体内水液潴留，上下泛溢于肌肤，引起头面、下肢水肿病证。正如《素问·水热穴论》所说：“肾者胃之关也，关门不利，故聚水而从其类也，上下溢于皮肤，故为跗肿。”此即因于脾、肾代谢津液功能减弱所引起的病变。

津液中比较稠厚的液体物，也与代谢功能的盛衰密切相关。《灵枢·决气篇》说：“液脱者，骨属伸屈不利。”由此可见，筋骨缺乏这种液体物质，便会产生关节伸屈不利的病证。此种疾病较以局部性病变为多见，常由病因的影响，使关节局部代谢功能障碍而致发病。如果液体物代谢过旺，一方面可见体表间脂液分泌过多，表现为汗出染衣的油汗现象；另一方面，也因脂液分泌过多，致使毛发间发生搔痒、脱落鳞屑，并可导致毛发脱落，而成油风脱发病证。此种疾病较以青壮年人为多见，似与肾之精气过旺有关。

由于脾、肾对体内津液代谢占主要地位，在病理上也往往互为因果。脾病可累及于肾，肾病亦可累及于脾，因

此临床上治疗水液代谢失常所发生的病证,都以调治脾、肾为基本原则。脾病为主,治脾为先,兼调其肾;肾病为主,治肾为先,兼调其脾。标本兼顾则脾、肾功能得以协调,由肺传来之津液亦得畅行无阻。所以,脾、肾对津液代谢的作用是有主要地位的。

(三) 肺肾与气的生理病理关系

气,是维持人体生命活动的动力。气,具有推动人体生长发育,平衡人体体温,温养脏腑经络,以及血液运行、津液输布,都是依靠气的能力来推动的。

人身之气来源于三个方面:一禀赋于先天父母之精气,一由肺呼吸而来天空之清气,一由脾胃消化而取水谷之精气。《灵枢·经脉篇》说:“人始生,先成精。”《素问·金匱真言论》说:“夫精者,身之本也。”这一禀赋于先天父母之精,以精以化气,气以养形,形以摄精的生化运动以推动人体生长发育。先天之精,受藏于肾,肾精化生肾气而产生肾阴肾阳,亦称元阴元阳。这是人体生化精津气血的根本,是生命活动最重要的物质基础。肾阳是阳气的根本,对五脏六腑、四肢百骸、经络血脉、肌肤毛发都起着温养和生化作用。肾气汇聚于下焦少腹之间,称为气海,因位居于下,亦名下气海,又称丹田。由先天之精化生而来的肾气,又需要后天水谷之精气和呼吸而来天空之清气的给养和补充,才能维持生命活动的能力。《灵枢·决气篇》说:“上焦开发,宣五谷味,熏肤

充身泽毛，若雾露之溉，是谓气。”《灵枢·刺节真邪篇》说：“真气者，所受于天，与谷气并而充身者也。”所谓所受于天的真气，即由肺呼吸而来的清气。清气与由脾转输而来的谷气（水谷之精气）相并，汇聚于上焦胸中，称为宗气，亦称大气。《灵枢·邪客篇》说：“宗气积于胸中。”《灵枢·五味篇》说：“其大气之搏而不行者，积于胸中，命曰气海。”由于胸中正当膻中部位（两乳间膻中穴部位），故《灵枢·海论》亦称“膻中者为气之海。”正因胸中气海，位居上焦，所以，又名上气海。先天之精气，汇积于下焦，为肾所主；后天之清气与水谷之精气相并，汇积于上焦，为肺所主。肺主出气，肾主纳气，肺为气之主，司呼吸而吐故纳新，肾为气之根，主摄纳而升清降浊。在此一吐一纳、一呼一吸、一升一降的运动中，就能激发和推动脏腑、经络、血脉活动以维持人体生命能力。由于呼吸的活动，肺气的宣发，天地之精气（清气）常以“出三入一”（《灵枢·五味篇》）的常度与水谷之精气相并贯注于心脉（《灵枢·邪客篇》说：“宗气积于胸中，出于喉咙，以贯心脉，而行呼吸焉。”），经心脉循行输布而充斥于周身。于是就能发挥“熏肤、充身、泽毛”（《灵枢·决气篇》）及“温分肉、养骨节、通腠理”（《灵枢·痈疽篇》）等功能，以维持人体体温的平衡。由此而透达于经脉之外，皮肤之间，具有保卫肌肤、抗御外邪、约制汗孔开合、调节体温

常度等功能的,称为卫气,亦称卫阳。由此而分布于血脉之中,营运于周身,发挥温养血脉作用的,称为营气。由此而充斥于中焦部位的,称为中气。由此而分布于各脏各腑诸经诸络的,称为心气、肝气、肺气、脾气、肾气、胃气、胆气、肠气、膀胱气及经气、脉气等等。正如张景岳所说:“真气即元气。气在天者,受之于鼻而喉主之;气在水谷者,入于口而咽主之;然鍾于未生之初者,曰先天之气;成于已生之后者,曰后天之气。气在阳分者即阳气,气在阴分者即阴气,气在表曰卫气,气在里曰营气,在脾曰充气,在胃曰胃气,在上焦曰宗气,在中焦曰中气,在下焦曰元阴元阳之气。”(《张氏类经》)

于此说明,由于气的分布不同,作用不同,各有各的名称,究其源则皆来于肺、肾吐纳升降之气,尤以肾气为诸气之根本。所以,肺肾与气的生理关系最为密切。

由于气在人体中发挥的作用颇为广泛,其病理表现也是极为广泛的。可以说,任何一种疾病,无论局部的或全身性病变,大多先从气分病变表现出来。一般来说,气分病变表现为三种类型:一为气盛,一为气衰,一为气滞。气盛则化热,气衰则功能减退,气滞则精血不畅。表现于一脏一腑、或部分肢体者,属于局部性病变;脏腑互相传变,显现多种证状者,属于全身性病变。现将主要证候列表如下:(表3、表4)

表 3

五脏气病简表

	心	肺	脾	肝	肾
气热	心烦面红，舌间糜烂，舌色红赤，脉洪数	呼吸急促，气喘咳嗽，咳吐稠稠，鼻燥口干，尿黄，舌苔黄，舌尖红，脉数	唇口生疮，善饥，便尿黄，舌脉黄厚，苔滑数	胸胁胀满疼痛，目赤头目手足苦脉多眦，昏胀，抽搐，舌红赤，弦劲数	小腹胀满，腰节胀，小便黄，短少，尿痛，热时淋，举丸红，舌红苔黄，或舌红苔少，脉数
气虚	惊悸怔忡，面白，舌淡红，脉细弱	呼吸短促，气息细弱，声音低淡，舌白，脉弱	面色萎黄，食欲不振，大便溏，四肢困倦，舌苔白，脉缓弱	耳鸣目眩，爪甲青，肢麻，舌质淡，脉弦细	腰膝软弱，冷痛，滑精，阳痿，头眩，耳鸣，下肢浮肿，疝气，小便不禁，大便滑泄，女子冷，舌沉迟，脉
气滞	胸闷胸痛，如针刺，面色青暗，舌色紫暗，脉涩、结代	胸胀闷，吐痰不爽，咳引胸痛，或痰聚血瘀，化腐成痛	脘腹痞满，左胁胀，或气滞，或血瘀，或凝块，成为脾积	胸胁痞满，右胁刺痛，或气滞，或血瘀，或凝块，成为肝积	少腹胀满，疼痛，引女子行，经不畅

表 4

五腑气病简表

	胆	胃	小肠	大肠	膀胱
气热	胸脘烦闷，右胁口吐苦水，目发黄，大便不爽，舌脉数	口渴喜饮，善饥，口臭，牙龈肿痛，大便干结，尿黄，舌红少津，脉滑数	脘腹胀满，矢气则快，大便不，小便秘，舌质黄厚，苔滑数	口燥唇焦，腹胀，挟大腹痛，硬结，泄泻，挟小腹痛，血，短赤，或黄，或滑数	小便短赤，尿时灼热，色浑，尿中不夹，舌脉数

气虚	虚烦不 眠，头 易惊， 舌红少 弦脉	口淡食 少，胸 闷，喜 饥，暖 时便 淡弱	腹中冷 痛，喜 暖，喜 按，腹 满，脉 细弱	大便溏 泄，腹 痛，喜 暖，久 泄肛 坠，舌 淡，脉 沉弱	小便频 数，尿 来不禁 ，舌白 ，苔薄 腻
气滞	右胸胁 胀，痛 拒引， 呕，尿 黄，舌 红，脉 弦实	脘腹痞 胀，痛 ，暖， 泛酸， 大便 不畅， 舌黄 ，脉弦 滑	腹中胀 满，不 矢，大 便不 便，舌 滑	脐腹痞 满，腹 痛，大 便难， 舌黄 ，脉沉 弦	小腹胀 满，小 便不通 ，如刀 割，尿 中夹有 砂石， 脉沉弦

气有余便是火，是以气盛者多实证热证。气虚则阴寒偏胜，是以气虚者多阴证寒证。气滞的形成，或气虚推动无力，致令津血留滞；或气机郁滞，以致络脉随瘀，或离经瘀血阻滞气道；或因砂石凝聚而致气道不通。所以，气滞一证，有虚有实，也有虚实兼夹的区分。

一脏一腑的疾病，常以脏腑相合、五脏生制的关系，互为影响互为传变，或由表及里，或由内及外，从而表现出全身性病变。

一般来说，致病因素不外外感、内伤两大类证：外感邪气实，多属实证；内伤正气虚，多属虚证。外感六淫诸邪，外而侵袭肌表，上而阻犯鼻窍，肌表受邪，卫气不得宣发，则畏寒发热；荣卫失畅，则肢体酸疼；肺窍不利，

则鼻塞声重。外窍不通,肺气阻遏,聚液成痰,痰气阻肺,肺失清肃,因而出现咳嗽、气喘、卫肺同病的证候。如果因于外感温邪,上则从口鼻而入,首先犯肺,外则从卫分传入气分耗伤津气,进而由肺传心、由气入营入血,还可出现高热、神昏、谵语等证。这是由外因引起伤及卫、肺气分由表及里所发生的病理变化。反之,胸中大气不足,心肺气虚,上焦不得宣发,外证现表腠疏松,自汗怯冷;内证现呼吸短气,心空心悸。心阳不足,火不生土,脾气自虚,脾虚则中气亦虚。脾居中焦,具有转输精微、升清降浊、统摄血脉的职能,如中气不足,脾不统血,男子可病便血尿血,女子可病崩漏带下。脾气一虚,土不制水,又能累及于肾,脾肾同病则输布津液功能失常,三焦受累则水道不得畅利。于是体内津液上而不得升发四布,下而不得决渎排泄,水气内聚泛溢肌肤,发为腹胀、水肿病变。这是由内虚引起由上而下的传变关系所发生的病变。如果肾气内虚,命火衰微,上而不能温生脾土,则中焦虚寒,四肢清冷;肾中精气不得升发于肺,肺肾同虚,上则出现喘促短气,气不上续;外则出现卫气不固,自汗怯冷。此即由肾虚引起由下而上由内而外的传变关系所发生的病变。总之,病及于肾则根本动摇,不仅可出现五脏互为传变产生种种衰弱证候,甚则元气厥脱危及生命。

由此说明,肺、肾与气的生理病理关系,是极为密切的。

(四) 心肝与血的生理病理关系

血即血液,循行脉中,对人体各部具有营养作用,是人体不可缺少的重要物质。《素问·痿论》说:“心主身之血脉。”《素问·脉要精微论》说:“脉者血之府也。”《素问·调经论》说:“肝藏血。”《素问·五藏生成篇》说:“人卧血归于肝,肝受血而能视,足受血而能步,掌受血而能握,指受血而能摄。”由此可见,心、肝两脏与血液的关系最为密切。血液的来源有三个方面:一由脾胃转输而来的水谷精微,如《灵枢·决气篇》说:“中焦受气取汁,变化而赤,是谓血。”这是血液来源的主要方面。一是营气对血液的生化作用,如《灵枢·邪客篇》说:“营气者,泌其津液,注之于脉,化以为血,以营四末,内注五藏六府。”一是肾精转化血液的功能,如《张氏医通·血证门》说:“血之与气,异名同类,虽有阴阳清浊之分,总由水谷精微所化。……得脾气之鼓运,如雾上蒸于肺而为气;气不耗,归精于肾而为精;精不泄,归精于肝而化清血;血不泄,归精于心,得离火之化而为真血。”由此可见,虽然血液主要来源于后天水谷之精微,而先天肾精入肝化血的作用,也是一个极为重要的方面。

关于血液的生成、储藏、输布、血量的调节、血液中废物的排泄以及这些功能与脏腑的关系,《景岳全书·血证篇》简要地概括为:“生化于脾,总统于心,藏受于肝,宣布于肺,施泄于肾。”现将这些功能的全部过程分述

如下：

1. 生化于脾 《灵枢·营卫生会篇》说：“中焦亦并胃中，出上焦之后，此所受气者，泌糟粕，蒸津液，化其精微，上注于肺脉，乃化而为血。”这是对血液生化于脾的很好说明。由脾气转输把水谷精微“注之于脉，化以为血”（《灵枢·邪客篇》），是从三个途径进行的。一是上注于肺脉，即《灵枢·营卫生会篇》所说：“化其精微，上注于肺脉。”一是归入心脏，即《素问·经脉别论》所说：“食气入胃，浊气（精气）归心，淫精于脉……。”一是散精于肝，亦即《素问·经脉别论》所说：“食气入胃，散精于肝。”由此可见，输布于肺、心、肝化生血液的物质，都是由脾来供给的。

2. 总统于心 《素问·五藏生成篇》说：“诸血者，皆属于心。”说明人体各部的血液，都归总于心脏统率。即是说，血液在“心主血脉”的统率下，以经脉为道路，以心气为基本动力，推动血液如环无端地循行于人体上下内外各个部分。正如《内经》所说：“上下相会，经脉相贯，如环无端。”（《灵枢·邪气藏府病形篇》）“经脉流行不止，环周不休。”（《素问·举痛论》）血液循行于全身，外而皮肉筋骨，内而五脏六腑，上而头目清窍，下而手足指掌，都起着营运滋养的作用。如此，目得血而能视，足得血而能步，掌得血而能握，指得血而能摄；筋骨得血，强健有力，关节清利（《灵枢·本藏篇》：“血和

则筋骨劲强,关节清利”)。由此说明,人体各部的血液供给,都是在心脏总统下进行的。

3. 藏受于肝 《素问·调经论》说:“肝藏血。”肝中所藏血液,除与心脉相通所供给的血液外,有由脾散精于肝的水谷精微入肝化血,还有由肾精转化归入于肝的血液。可见,肝是体内藏血量最大的一个器官。所以,《医学入门·肝脏赋》称肝为“血海”。肝藏的血与心脉循行的血有相互支援、相互调节的作用,正如《医学入门》所说:“人心动则血行于诸经,静则血归于肝。”说明心与肝在人体动静中有相互调节血量的功能。故血藏于肝对供给全身血液的需求与心的作用是不相上下的。

4. 宣布于肺 肺主一身之气,气为血帅,血为气母,气行则血行,气滞则血滞。于此可知,气对于血,一方面能推动血液流行,一方面能统摄血液流行,这样才能使血循常道得以周而复始地运行于全身。所以,气对于血的推动和统摄作用,是相反相成的。肺气能推动和统摄血液运行,据《素问·经脉别论》说:“食气入胃,浊气(精气)归心,淫精于脉,脉气流经,经气归于肺,肺朝百脉,输精于皮毛,毛脉合精,行气于府,府精神明,留于四藏,气归于权衡。”所谓行气于府,张景岳释为“膻中气府”,即汇积于上焦胸中的大气。由此说明,由脾转输精微上归心肺,注入于脉化以为血以后,肺为百脉朝会之脏,在肺气、心气、胸中大气的推动和鼓运下,外而布达于皮毛,

内而输布于各脏,并在肺气的统摄下,上下内外循其经脉各得其所地循行于全身。所以说,肺是宣散和输布血液的主持者。

5.施泄于肾 施泄即排泄。肾与膀胱相合,并居下焦,肾有升发精气输布于各脏的作用,又能把废弃的水液渗入膀胱排泄于体外。即是说,饮入于胃,由脾转输入于血脉之水津,经肺气与心气的推动和输布,血液中多余之水津,经肺气通调下输由肾渗入膀胱为尿排泄。水津是血液中重要的组成部分,津以养血,血以养形,对人体各部都起着营运滋养功能。水津的输入和排泄,正是维持血液与津液得以平衡的一种生理现象。所以,如反复出血,可致耗血伤津;严重的出汗、吐泻、利尿,也能导致津枯血燥。因此,肾的排泄功能,对调节体内津血平衡是十分重要的。

综上所述,血液生成、储藏、输布、调节血量、平衡津血以及血液循行,都是各个内脏共同作用的结果。从调节血量供应人体各部对血液的需求来看,心与肝的作用是占主导地位的。

由于血液运行是在各脏功能相互配合下进行,因而任何一脏功能失调,都能引起血液运行失常的病变。又因气与血有互为依赖的紧密关系,所以,在病理上也常常与气分病变互为因果。导致血液病变的原因,除外伤外,一般可由三种因素引起发病:一因于热,一因于虚,一因于瘀。邪热内传,干扰荣血;气盛化火,血中蓄热。反复出血,

荣血亏虚；脾、肾气虚，化源不足。气滞则血瘀，气寒则血凝，离经之血阻碍脉道，气血流行不畅，久则气血同瘀。凡此均能导致血液运行失常，产生种种血液病变。其中如血液运行不循常道，溢出于体外者，即表现为出血病证。血出于上，假道肺胃，可见咳血、呕血、鼻衄、齿衄；血出于下，假道二阴，可见尿血、便血、女子崩漏；血出于外，假道肌肤，可见斑疹瘀块。

1. 因于热 血热偏盛，损伤脉络，血出于外，其色鲜红，其质稠浓；溢于肌肤，发为斑疹，其色红赤，肤热发痒；均属实证，治宜清热凉血。热证出血，又可因失血量多、或反复出血，气随血耗，由实转虚。

2. 因于虚 脾失健运，化源不充，或肾气亏虚，精不化血。由脾、肾转输而来供应心肝的血量不足，人体各部对血液需求缺少，在上则清窍不利，可见头晕耳鸣、视力减退；在外则筋骨失养，可见四肢乏力、皮肤干燥、肌肤麻木、关节活动不利；血不养心，心气失守，则心悸不宁；血不养肝，神舍不安，则夜眠多梦；血不养神，神气不充，则遇事善忘。如气虚不能统血，血出于下，可见尿血、便血、崩中漏下，其血色暗，其质淡薄；血溢于外，可见肌肤衄发斑，其色青紫，不痛不痒。凡此均属虚证，治宜补气养血，兼瘀者佐以和瘀治法。

3. 因于瘀 瘀血常随其瘀阻的部位不同而产生不同证候。瘀阻于心，心络不通，可见胸闷心痛，口唇青紫；

瘀阻于胃肠,可见呕血、便黑;瘀阻于肝,可见右胁刺痛,久则聚为肝积;瘀阻于脾,可见左胁痞胀,久则聚为脾积;瘀阻于胞宫,可见少腹疼痛,月经不调,痛经,经色紫黑有块,或见经闭,或见崩漏;瘀阻于肢体,可于局部出现青紫、肿痛。瘀血病的共同特征,瘀有定处,痛如针刺,痛处不移而拒按;经脉不通,久聚成块,固定不移;血行瘀滞,唇舌青紫,舌现紫斑瘀点,脉现沉弦细涩或结代;脉道阻塞,血不循经,引起出血;瘀血未去,新血难生,肌肤经脉失于濡养,可见肌肤粗糙、面目暗黑、毛发枯干等全身证状。大凡治瘀以活血化瘀为总则,惟致瘀之因各有不同,而瘀证又以虚实互见者为多。所以,应详求病因,明辨虚实,气滞成瘀,宜于理气通络;血虚致瘀,宜于养血行瘀;因寒而瘀,温通并用;因虚而瘀,攻补兼施。总以导达经络,消磨瘀积,勿伤正气为要务。

以上所论,是肝与肾、脾与肾、肺与肾、心与肝相互合作表现于精、津、气、血的生理功能和病理关系。精津气血是维持人体生命活动的基本物质,如果脏腑功能发生病变,就会随病因的不同,使这些物质发生不同程度的局部或全身的种种病证。临床上根据各脏各腑生理特性以及脏与脏、腑与腑之间相生相制关系所表现的病理规律,用脏腑辨证法则,因其病势,调其虚实,使脏腑功能得以协调,精津气血得以和畅,人体健康就会得到恢复。

四、脏腑与神志的生理病理关系

神志即精神思维活动的总称。现代生理学以人的精神思维属于大脑中枢功能,而中医学则以人的精神意志是分属于心、肝、脾、肺、肾功能来实现的。分别概述如下:

(一) 神魂魄意志分属于五脏的生理关系

《素问·宣明五气论》说:“心藏神,肺藏魄,肝藏魂,脾藏意,肾藏志,是谓五藏所藏。”这种生理关系是怎样配合起来的呢?

“心藏神。”神即精神。《灵枢·本神篇》说:“故生之来,谓之精,两精相搏,谓之神。”说明神是与生俱来的。《灵枢·决气篇》说:“两神相搏,合而成形,常先生身,是谓精。”这个“精”就是父母之神合一于精,形成胚胎之精。此精之中便孕育了元阴元阳,而元阴元阳则以“阳化气,阴成形”(《素问·阴阳应象大论》)的规律发育成长。元阴是生形的基础,元阳是生气的基础,阴中之精华为精为髓,阳中之精华为气为神。神气以精髓为基础,精髓以神气为统帅,在相互依存条件下,就能实现“积精全神”(《素问·上古天真论》)的健康景象。心在五行中属“火”,五脏阴阳配合属于“阳中之太阳”,具有主宰一身阳气的职能,阳气的精华为神,所以说心藏神。这个神,便是总统魂魄意志、聪明智慧的统帅。

“肺藏魄。”魄为阴，属于精之神。精是生养形骸的物质，肺主气而外合皮毛，具有敷布精气外出肌肤生养形骸的职能。《灵枢·本神篇》说：“并精而出入者，谓之魄。”气为阳，精为阴，魄并于精，随气出入于形体肌表之间，发挥支配肢体活动和传导皮肤感觉的功能。所以说肺藏魄。

“肝藏魂。”魂为阳，属于气之神。肝主藏血，气为血帅，气血和调，动则血并于气行于诸经，静则气归于血入藏于肝。《灵枢·本神篇》说：“随神往来者，谓之魂。”就是说，气为阳，血为阴，魂并于血，舍藏于肝，随人之动静、寤寐而出入往来。人寤则魂随神出而主动，人寐则魂随神入而主静。所以说肝藏魂。

“脾藏意。”“肾藏志。”意即思维，如《灵枢·本神篇》说：“心有所忆，谓之意。”志有二义：一指决断，如王冰在《素问·宣明五气篇》注文所说：“专意而不移者也。”一指记性，如《灵枢·本神篇》说：“意之所存，谓之志。”肾为先天之本，生化精髓之源，积精才能全神，神全才能积记事物和决断事物。所以说肾藏志。脾为后天之本，生化气血之源，脾气健全才能资生气血以养神志，神志才能充分发挥其智力和思维的能力。所以说脾藏意。

这便是神、魂、魄、意、志分属于心、肝、肺、脾、肾的理论根据。对于神魂魄意志的相互关系，正如张景岳说：“神之为义有二：分言之，则阳神曰魂，阴神曰魄，

以及意志思虑皆神也；合言之，则神藏于心，而凡情志之属，惟心所统，是为吾身之全神也。”（《类经·卷三》）由此说明，神为全神之主，而魂魄意志则是神志活动中表现于支配肢体活动和传导皮肤感觉、主持寤寐动静以及记性、决断、思维等方面所发挥的功能，从而构成了以五脏为基础的神志系统学说。

（二）神志活动与心肝肾的生理关系

心属火，为阳中之太阳，藏神；肾属水，为阴中之太阴，藏志；肝属木，为阴中之少阳，藏魂。据《难经·四十一难》说，肝所居的位置是：“去太阴尚近，离太阳不远。”因肝气禀肾中精气而生，居于心、肾之间而又切近于肾，具有水生木、木生水母子相生的关系。《灵枢·本神篇》说：“随神往来者，谓之魂。”由此可见，肝气是随神志活动而活动的。即是说，肝气往来于心、肾之间，从于阴（精髓）则静，静则发挥其“将军”、“谋虑”的作用；从于阳（神明）则动，动则发挥其刚果不疑的“决断”作用。肝气在动静中适应外界事物变化的这一功能，《难经集注·四十一难》虞庶注文指出：“少阳之至，乍大、乍少、乍短、乍长。”这是一个非常形象的比喻。就是说，人受到外界事物刺激的时候，肝气能调节神志谋虑策划，并根据事物的复杂性和大小程度，迅速而准确地作出决断发挥其相应的能力，以适应事物变化。于此可知，肝在神志活动中起着调节的功能。

由于心、肝、肾在生理上有母子相依的关系,在病理上也是互为因果的。肾虚则精虚,精虚则肝气亦虚,肝虚则神志失守,病为善恐易惊,此属母令子虚;心旺则火旺,火旺则肝气亦旺,肝旺则神志过激,病为心烦善怒,此属子实母实。所以,临床上常用补肾养肝、清心泻肝、平肝安神等治法,就是针对此类神志病变使之得到调节而归于安宁。

(三) 神志与脑的生理关系

肾藏精,精生髓,精髓上通于脑,脑由精髓汇积而成。所以,《灵枢·海论》说:“脑为髓之海,其输上在于其盖,下在风府。”心藏神,神为阳中之精,头为诸阳之会,心为总统血脉的器官。所以,《灵枢·邪气藏府病形篇》说:“十二经脉三百六十五络,其血气皆上于面而走空窍,其精阳气上走于目而为睛,其别气走于耳而为听,其宗气上出于鼻而为臭(嗅),其浊气出于胃走唇舌而为味。”

由此可见,肾藏的精,心藏的神,都要会聚于脑,才能发挥视、听、嗅、味以及语言、喜乐(心主语言,膻中主喜乐)等功能。张志聪在《张氏内经素问集注·脉要精微论》注文中指出:“诸阳之神气上会于头,诸髓之精上聚于脑,故头为精髓神明之府。”林佩琴《类证治裁》也说:“人之神藏于心,心之精依于肾,而脑为元神之府,精髓之海,实记性所凭也。”这就把心与肾、精与神与脑的生理关系说得很明确了。正因神是精髓气血会聚于脑的

产物,所以在“积精全神”、“血脉和利”(《灵枢·平人绝谷篇》说:“血脉和利,精神乃居。”)的条件下,就能发挥巨大的记忆、思维、谋虑、决断等能力,以适应外界事物变化;就能统帅和协调人体各脏各腑、诸经脉络、四肢百骸进行正常的生理活动。故张景岳说:“心(神)为一身之主,脏腑百骸惟所是命,聪明智慧莫不由之。”

由此说明,中医学以神魂魄意志分属于心肝肺脾肾的理论,是基于五脏分类统率脏腑身形的特点,从而以阴阳、气血的属性把大脑中枢发挥的各种功能分属于五脏分别发挥其统率生理活动的功能。这便是五脏之神会聚于脑与脏腑身形互为统摄互为功用的生理关系。于此看来,中医学也认为,神在脑而不在心。

(四) 神与形在病理上的因果关系

脑为元神之府,人体脏腑身形在脑中元神的总统下,神与形互为依存互为功用,因而在病理上往往互为因果,并以五脏的病变规律体现出来。

1. 神病伤形 《素问·天元纪大论》说:“人有五藏化五气,以生喜怒思忧恐。”又说:“肝在志为怒”,“心在志为喜”,“脾在志为思”,“肺在志为忧”,“肾在志为恐”。《素问·举痛论》又说:“怒则气上”,“喜则气缓”,“悲则气消”,“恐则气下”,“思则气结”,“惊则气乱”。由此说明:(1)导致神志病变的因素,主要由于精神刺激。一般来说,喜怒忧思恐是人们生活中

常有的现象,但如忧思积虑、隐怒不解,久则伤及神志发生病变。(2)神病表现于五脏的特点:怒伤肝,过则肝气上逆冲犯神明;喜伤心,正常的喜笑能使脉气和调,荣卫通利,过则伤及心气,甚或激动肝阳冲击神舍,引起精神错乱;思伤脾,思虑过度则神气不畅,神郁则肝郁,肝郁不为疏泄脾胃,则脾气郁滞而运化不行;忧伤肺,肺主气,忧愁不解则气失调畅,久则由气及血而致气血失调;恐伤肾,大恐则神气内闭,肝气随之而下归于肾,因而肾气不得畅利;过于悲哭,能使神气消散,气血闭塞,而致“上焦不通,荣卫不散”(《素问·举痛论》);剧烈惊骇,能使神气紊乱无主,出现“心无所倚,神无所归,虑无所定”(《素问·举痛论》)的局面。这就是因于精神刺激影响“五志”累及五脏所出现的病理特征。此种五志各有所伤的病理变化,则以五脏间生制关系发生变化显现出来。肝气有调节神志活动的功能,当神志受到刺激后,肝气首先受到影响发生病变。所以,大凡治疗精神、神志疾病,多以肝为辨证重点。

精神刺激因素有多种方面,然而引起肝气病变的趋势,又可归纳为两类:一为忧愁惊恐致肝气抑制,发为抑制性神志病变;一为所求不遂、隐怒不解致肝气横逆,发为亢奋性精神病变。

神气忧郁,肝气抑制不畅,不能疏泄脾胃,中焦气阻食滞,升降失调,表现为气郁、食郁,病为肝脾失和。脾

气郁滞,不能输布津液,津聚为湿,或蕴湿成痰,表现为湿郁、痰郁;如痰气互结,上壅肺窍,阻塞咽喉,可发为梅核气病。肝气久郁又能化火,肝火内盛,上扰神明,表现为烦躁易怒,恍乱多梦,头痛耳鸣,此属火郁,病在心肝。肝郁日久,损耗气阴,由实转虚,一以血虚神弱不能自制,表现为悲伤善哭有如神灵所作,此属脏躁(多见于女性),病在心脾;一以荣阴偏亏,郁热不解,阴虚则神弱,郁热则神舍难安,表现为多疑善怒,情绪不定,平时一如常人,发时百脉俱病,此属百合病,病在心肝。如果长时期气机郁滞,气郁则血行不畅而致血郁,或以气滞血瘀出现各种痛证,女子则见痛经、经期失调;甚至由此而发展为各种癥瘕痞疾。此即因于神志因素引起气郁、食郁、湿郁、痰郁、热郁、血郁的病理变化,亦即朱丹溪创立六郁学说的由来和由此而发生的各种各样抑制性神志病变。

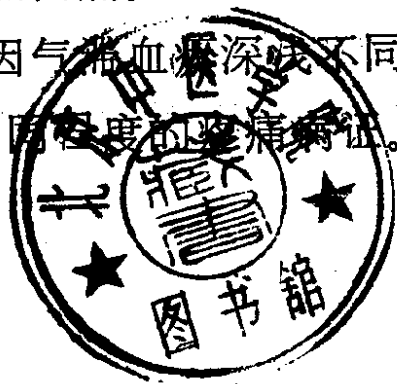
所求不遂,郁怒不解,肝气内横,侮犯脾土,脾失健运,聚湿生痰。一者,痰气互结,冲逆于上,蒙蔽神窍,出现如醉如痴,语言无序,哭笑无常,病为癫证;多由所求不遂,忧思久积,先肝郁继而损及心脾以致发病。一者,肝气内盛,郁而化火,火痰交阻,冲击神舍,出现喧闹打骂,妄乱无知,不避亲疏,病为狂证;多由恼怒忿郁不得宣泄,病在心肝。癫证久而肝郁化火,可由癫转狂;狂证久而郁火衰退,亦可由狂转癫。此即因于肝气横逆冲犯神志而发生的亢奋性精神病变。

由此可知,凡以精神因素发生的病变,均以肝气调节神志功能失常和由此而影响脏腑功能失调引起发病。所以,在治疗上都根据心肝、心脾、心肾以及气、血、食、痰等不同辨证,始终以调治肝气为基本法则。

2.形病伤神 非情志性疾病是多种多样的,能由形病而累及神病的因素也是多方面的。《素问·举痛论》说:“寒则气收,炅(热)则气泄,劳则气耗。”这是以寒、热、劳倦影响于体气的因素。生活中由于饮食失调,色欲不节,也是造成形病的重要原因。寒伤阳,寒气闭滞,可致气行不畅;热伤阴,热性耗散,可致津亏气泄;劳倦伤气,过劳则体气消散;饮食不调,脾气受伤,则生化气血之源不足;色欲过度,肾精亏损,则生养精髓之源不充。凡此都能损害脏腑身形而产生各种各样的病证。

引起脏腑身形病变的因素及所表现病证虽有多种不同,其病变趋势又可归纳为三个方面:一以气滞血瘀的趋势发展,一以阳气虚弱的趋势发展,一以阴精亏损的趋势发展。

寒气留滞,经脉流行不畅,造成气滞血瘀,产生种种痛证,甚则出现卒痛昏死的证候。正如《素问·举痛论》所说:“寒气入经而稽迟,泣(涩)而不行,客于脉外则血少,客于脉中则气不通,故卒然而痛。”“或卒然痛死不知人,有少间复生者。”还有因气滞血瘀深浅不同、部位不同而于脏腑身形各部发生不同程度的疼痛病证。这是



因于经络气血瘀滞而致神气传导失常所发生的病变。

阳中之精为神，阳气虚则神气自虚。阳气虚弱的因素，多以劳倦伤气、脾失健运、或由各种疾病演变而来。气虚则脾弱，脾弱则生化气血之源不充，气血亏虚则神气失养。于是出现肢体乏力，记忆减退，心中惊悸，眠差多梦，食欲不振等一系列心脾不足病变。这是因于气虚而致神弱所发生的病理变化。所以，此类疾病都以补气为主，兼养荣血，重在调治心脾。

阴中之精为髓，肾为藏精生髓之脏，脑为聚髓之海，髓有生养脑中元神的功能，精髓不足，脑力不充，神气自衰。引起阴精亏损的原因，或以脾失健运，中焦传来水谷精微不充；或以热病伤阴，精气未能恢复；或以色欲不节，老年体弱，精气亏损。精虚则脑海不充，清窍不利，筋骨不健，于是神气衰退而现眩晕耳鸣，视力减退，记忆衰弱，肢体酸软无力，喜静恶动等证。正如《灵枢·海论》所说：

“髓海有余，则轻劲多力，自过其度；髓海不足，则脑转耳鸣，胫酸眩冒，目无所见，懈怠安卧。”这是因于阴虚而致神衰，属于肝肾的病变。此类疾病，如果主因是由中焦疾病演变而来，当以调治脾气为主兼扶肾气；如主因在于肝肾，则于滋补肝肾同时兼顾脾气。在脾肾兼顾、标本同治的原则下，便能相互助益加速恢复精血而达到强健神志的效果。

由此说明，神志与脏腑身形互为依存互为统摄，而在

病理上则互为影响互为因果。所以，临床上用五脏辨证方法，循其规律，调其虚实，既可治疗神病伤形的病变，亦能治疗形病伤神的病变。反之，神志疾病，变化多端，证状不定，将会无从着手。

五、脏腑病变的基本规律

心、肝、脾、肺、肾五脏配合胆、胃、小肠、大肠、膀胱五腑是生化精、津、气、血的功能单位。气为阳，精津营血为阴，阴性潜藏，阳性升散，阳以阴为物质基础，阴以阳为推动能力，阴阳相济，互为依存，升降出入，贯注一身，以维持人体生命活动的能力。如果在病因作用下，致使脏腑功能失调，精津气血受到损害，就会出现阴阳偏盛偏衰的病变。为了便于理解疾病传变规律，现将脏腑阴阳升降出入的关系，示如下图：

阴阳互根的关系，在脏腑功能中以水火相济的关系体现出来。心属火，火为阳，肾属水，水为阴，心火下交于肾，肾水上济于心，阳得阴济则潜藏而无亢害，阴得阳助则升发四布以养身形。由此可知，阴与阳（水与火）在生理上的关系是以阴敛阳、以阳摄阴、互为功用的关系。关于阴阳升降出入的关系，大要言之，水谷精微为生化精津气血的主要来源，精微由脾转输，上归心肺，经肺气通调下输，归藏于肾。肝禀肾之精气而生，肝得肾气之助，升

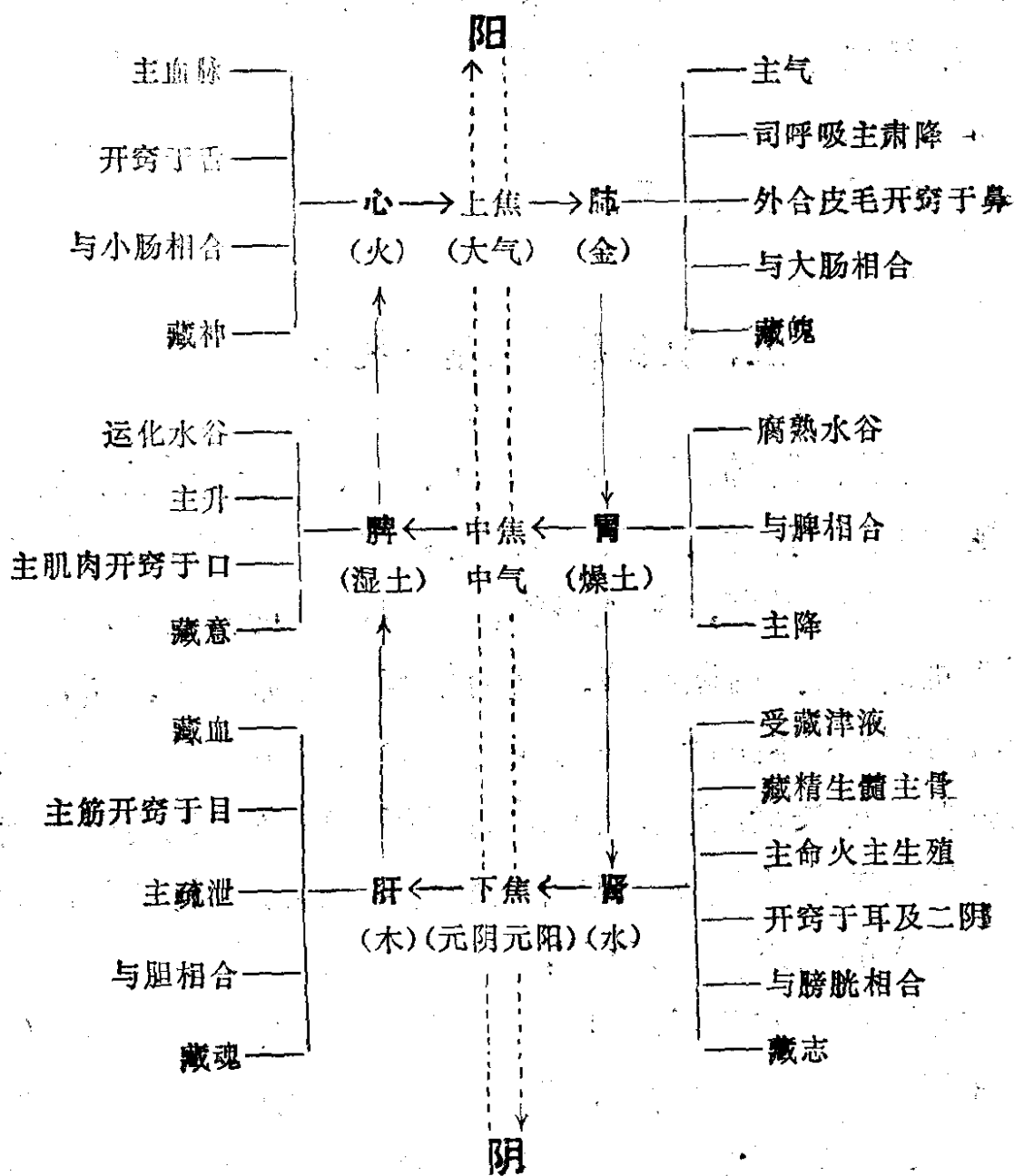


图1 脏腑阴阳升降出入的关系

--→ 示阴阳互根

—→ 示阴阳升降

发精气上济于心,再经心气、肺气、胸中大气的鼓运和宣发,精津营血以经脉、三焦为道路,外而布达于肌表,内而充斥于脏腑,如此循环往复,就能不断地保持生命活力。引起发病的因素有外感、内伤的不同,因而疾病传变又是各有规律的。现分述如下:

(一) 外感病传变规律

风、寒、暑、湿、燥、火(热)是自然界四时季节变换中的六种不同气候变化,一般称为六气。如因气候骤变,暴冷暴热,或应寒反热,应热反凉,在人体不相适应情况下,便可成为致病因素,称为六淫。外感六淫为病,多侵犯肌表,或从口鼻而入,或两者同时受邪而发病。风为六淫之首,有从阴化寒、从阳化热的特性,常兼挟寒、暑、湿、燥等邪而侵袭人体。寒性闭涩,湿性凝滞,俱属阴邪;暑即是热,燥易伤津化火,俱属阳邪。因此,外感六淫发病,以风邪为致病主因,风邪挟寒挟湿发为外感寒病;风邪挟暑挟燥发为外感热病。所以,从外感病的性质来说,又可归纳为寒、热两个大类。

1. 外感寒病 阴寒湿邪,损伤阳气,由于外邪有风寒、寒湿、风寒湿混合杂感的不同,表现证候和传变规律亦不相同。

风寒侵袭人体,首犯肌表,皮毛闭塞,荣卫失和。卫阳不能布达于外则恶寒,阳气闭阻于内则发热,荣卫失和则头身酸痛。这就是通常所称的外感风寒表证。肺主气,

司呼吸,外合皮毛,如果寒邪从其所合内传入肺,肺为寒阻则肺气失宣,于是肺气上逆而现咳嗽、喘急证候。

湿性重浊粘滞,阴寒湿邪侵及人体,往往损伤阳气,凝滞肌肤,阻碍气血,因而出现头重加裹如蒙,身体困倦乏力,四肢酸强作痛,憎恶风寒,身热不扬等外湿表证。如感伤寒湿较甚,湿邪内传常先困脾,脾失健运则见食少口腻,胸闷呕恶,脘腹痞胀,或便溏泄泻。所以,张景岳论“湿证”指出:“……及其甚也,则未有表湿而不连脏者。”

风寒湿三气杂感于人,留滞经脉关节,损害皮肉筋骨,是形成痹证的主要病机。本病以关节疼痛为主证,见肢体关节游走疼痛,痛无定处者,称为行痹,属于风气偏胜;见关节拘急不利,疼痛剧烈,得热痛减,遇冷痛甚者,称为痛痹,属于寒气偏胜;见关节重痛,固定不移,或肌肤麻木者,称为着痹,属于湿气偏胜。如果病在经络久延失治,邪从皮、肉、筋、骨、脉内传脏腑,就可产生如《素问·痹论》所说肺痹、肝痹、心痹、脾痹、肾痹、肠痹、胞痹等证。其中,尤以心痹最为临床常见。

由此说明,外感寒病均以阻遏气机、损伤阳气为特性。病在于表,如不及时解散,便可由表传里,伤害脏气,并可因脏腑间互为传变而产生种种病变。

2. 外感热病 凡以感受四时温热邪气而发病的,通称为外感热病。如风温(轻者称风热)、春温、暑温(轻者

称暑热)、湿温(轻者称湿热)、冬温、温疫、温毒等。此类病证的基本特点:(1)初起即见热病证候,而以发热为主证;(2)发病急,传变快,最易伤耗津血;(3)各个病种具有不同的季节性,而且大多具有传染性和流行性。虽然各个病种发病季节不同,感受邪气各有不同,其临床特征也各有差异,若从病机性质分类,又可归纳为温热、湿热两大类型。其病变规律大略如下图(图2):

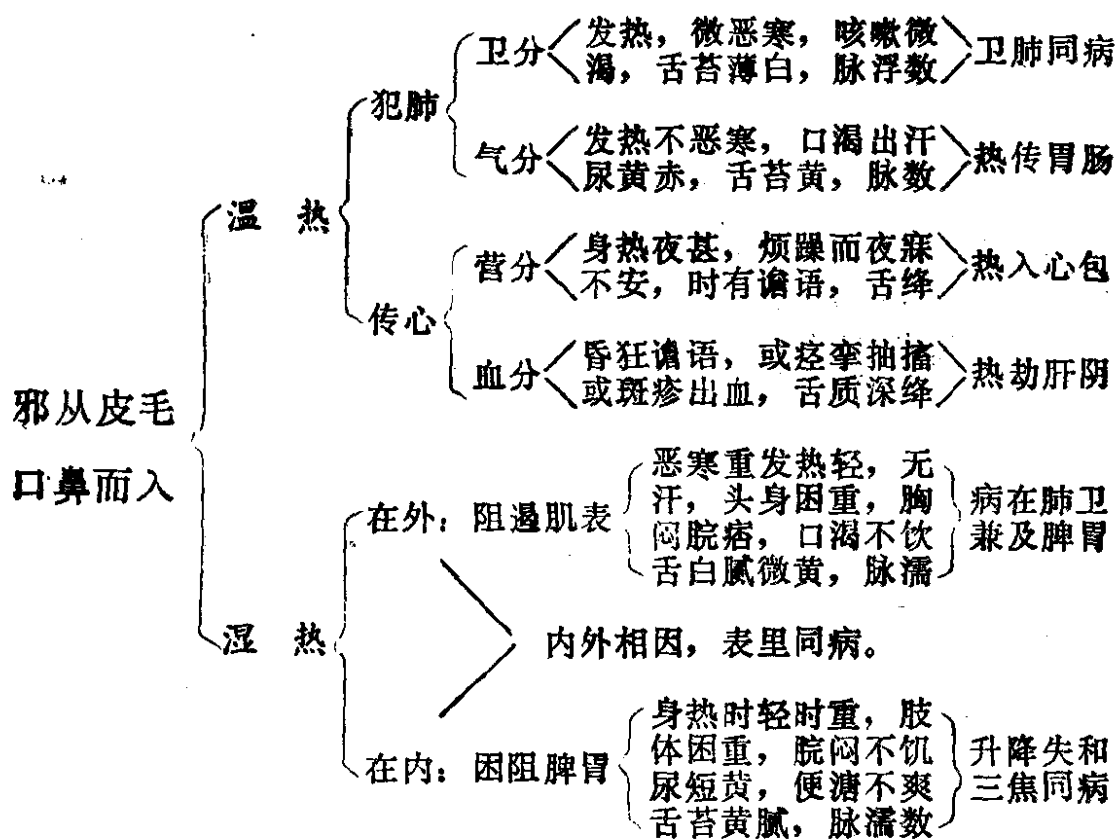


图2 外感热病病变规律

(1) 温热病 温热邪气从口鼻而入侵袭人体, 初起邪客卫分, 渐次传入气分、营分、血分, 卫与气属阳, 行于脉外, 内通于肺, 肺气宣发, 布达于体表者为卫, 充斥于

体内者为气；营与血属阴，行于脉中，内通于心，营为血之前身，血为营气所化。所以，卫、气、营、血从表里层次而言，卫与气属于表，卫浅而气深；营与血属于里，营更深而血最深。温热病发展趋势，正是以邪热耗阴由表及里、由浅入深为传变规律的。

邪犯卫分，其病初起，常表现卫肺证候。卫气与邪气相争，卫气被遏，故发热恶寒。阳热温邪，故多发热为重，恶寒轻微。卫气不畅，肺气失宣，故咳嗽。邪气浅，热未盛，津未伤，故见微渴、舌苔薄白、脉象浮数。

邪热传入气分，表现里热证候。邪已离卫，故发热而不恶寒。内热蒸腾，故出汗。热伤津液，故口渴。尿赤、舌红、苔黄、脉数，均为内热伤津证象。如热壅于肺，肺失清肃，则见咳喘气急，咳痰黄稠。热郁胸膈，心神不宁，则见烦闷懊恼，坐卧不安。热传胃腑，邪正抗争，热蒸于外则壮热汗出，津伤于内则烦渴引饮，内热奔腾则脉来洪大滑数。热结于肠，津伤肠燥，腑气不通，则见腹满硬痛，大便秘结，甚则出现舌苔黄燥或焦黑起刺，脉来沉实。

邪热突破气分，陷入营分，表现营热扰心、营阴受损的病变。邪陷阴分，故见身热夜甚。营阴受损，所以舌质红绛、脉多细数。营热扰心，神舍不宁，故烦躁而夜寐不安，甚则热入心包而见神昏谵语。如因营热窜扰血络，则可出现斑疹隐隐。。

邪热不解，深入血分，进而显现心、肝、肾的病变，

而以耗血、动血、伤阴、动风为特征。热入血分，更见壮热持续。血热内闭，神舍不清，出现昏狂谵语，甚则神识昏迷。血热蒸腾，逼血妄行，则斑疹透露，或见各种出血（如吐血、衄血、尿血、便血）。肝藏血，肾藏精，邪热耗血伤津，肝经失养，肝风内动，则现手足抽搐，颈项强直，角弓反张，双目上视，牙关紧闭等肝热挛急证候。舌质深绛，正是血热内盛的主要病证。

由此可见，热病由表传里的病理变化，与有关脏腑的病变是密切关联的。一般以卫、气、营、血渐次传变为规律，邪在卫肺传入气分，进而内传胃腑（阳明），是为顺传。如来势凶猛，传变迅速，也有由肺卫直入心营的，此属逆传，病势恶，预后差。病在营分转为气分，属于病情好转；由营入血，则属病情深重。于此说明，热病在卫分、气分阶段的治疗是十分重要的。邪在卫分，治以辛凉散热，使邪从表解；入气则宜甘寒泄热。热入营分，治以清营养阴，使其透热转气，防止邪深入血；热已入血，则须凉血养血。这是治疗热病的一般原则。对于热壅迫肺、热郁胸膈、热传胃腑、热结肠道、热犯心包、血热动风诸证，又当分别采用清宣通下、清心开窍、清热生津、凉肝息风等治法。大要言之，治热病总以撤热存阴为基本原则。

（2）**湿热病** 湿热病即湿、热合邪致病的总称，属于湿热类型的一种外感热病。薛生白指出：“太阴（脾）内伤，湿饮停聚，客邪再至，内外相引，故病湿热。”可

见, 湿热病的形成, 有外在因素, 也有内在因素。长夏之季, 气候炎热, 雨湿较盛, 热蒸湿郁, 湿热合邪, 侵袭人体, 是其主要的外在因素; 饮食不节, 恣食肥腻生冷, 损伤脾气, 聚湿蕴热, 是其内在因素。湿热外袭, 阻犯肌表, 湿热内郁, 困阻脾气, 所以, 湿热病在病机上多以内外相因、表里同病为特征, 在辨证上则有偏于表、偏于里以及热胜于湿、湿胜于热的区分。由于湿热病一般病期较长, 多留连于卫分、气分之间, 一般不易伤阴而成营分、血分热证。其病变规律常以上、中、下三焦部位相传, 而分初、中、末三个阶段。

湿热病初期阶段, 以湿邪阻遏肌表兼有脾胃见证为特征。湿为阴邪, 侵袭人体, 开始热象不显, 一般须在数日后, 才有明显的热象出现。湿困于外, 卫阳阻郁, 故恶寒无汗, 发热轻微, 或不发热。湿困于上, 则头重如裹。湿阻肌表, 则肢体困重。湿阻胸阳, 肺气不利, 故胸闷。湿困脾胃, 运化失常, 故脘痞。口渴不欲饮, 舌苔白腻微黄, 脉濡, 均为其病初起, 邪热未盛, 湿困气机所致。

湿热病进入中期阶段, 以热势明显、困阻脾胃、中焦失和为主证, 但仍兼有湿郁肌表见证。湿热由表传来, 因湿性凝滞, 来缓去迟, 故仍见四肢肌肉酸重沉困证状。热势已盛, 故现身热时轻时重, 或汗出热减, 继而复热, 或午后热甚。湿热困脾, 中焦气机不畅, 升降功能失常, 是以脘腹痞闷, 不饥不食。脾失健运, 故大便溏而不爽。湿

热阻遏，故小便短少而黄。苔黄腻，脉濡数，均为湿热郁滞病证。如因湿热蒸腾，上而阻闭清窍，可见神呆少言，甚则神识昏迷；外而郁滞肌表，则见肤色黄垢，甚则出现白痞。湿热蕴遏中焦，又可出现三方面发展趋势：（1）热胜于湿者，可因热盛耗津，从阳化燥，热传阳明，出现胃肠实热证候；或由此而热传营血，出现热入心包、或血热动风等证。（2）湿胜于热者，可因湿性伤阳，从阴化寒，伤及脾肾，出现脾肾阳虚证。（3）既不化燥，又不化寒，则以湿热的特点传入下焦，形成下焦湿热证。

湿热病进入末期阶段，由于受邪轻重不同，体质强弱的差异，可因热胜于湿从阳化燥，或湿胜于热从阴化寒而出现多种病变，就一般来说，仍以湿热的特点由中焦传入下焦者比较多见。湿热阻滞于下焦，常以小便不通、或大便秘结为主证，仍可兼见上焦、中焦的证状。肝肾属于下焦，肝主疏泄，肾司二便，湿为热阻，肾气郁滞，膀胱气化不行，因而出现小便不通；湿郁气结，肝失疏泄，肠气闭塞，传导失职，因而出现小腹硬满，大便不通。湿热蕴结于下，不得排泄于外，湿热上蒸，蒙蔽清阳，则头昏作胀，甚则神识昏蒙；湿热困脾，则脘闷不饥，渴而不欲多饮。舌黄厚腻，脉沉濡数，亦为下焦湿热常见病征。

由此可见，湿热病以内外合邪为病因，以表里同病为特点，以上中下三焦部位相传为规律，以脾胃病变为重点。由于湿性留滞、来缓去迟，一般病程较长，而以留连于卫

分、气分之间者为常见,更因病程进入后期,证变多端,所以在初期、中期的治疗是十分重要的。治湿热以清热化湿为基本原则,虽有表邪,禁用辛温发汗,防止温散助热,加速恶变;虽有里实,禁用攻下,防止损伤脾阳,转成洞泄不止。初期热势不显,病在肺卫兼及脾胃,宜于开宣肺气,和中化湿;热象已露,佐以清气透热。中期热势已盛,病在中焦脾胃,宜于清热利气,和脾运湿,以分解湿热。末期湿热蕴结,病在下焦,辨证重点在于二便阻滞,宜于清热导滞,淡渗分消,小便不通,重在利气渗湿;大便秘结,重在通腑行滞。这是治疗湿热病的一般规律。如因湿热病进入中、末期出现从阳化燥转属气分热证,或深入营血而见血热病变者,则当从温热病论治,以防病势恶变。总之,本病为湿热合邪致病,热为阳邪,非清不解;过清则伤阳助湿;湿为阴邪,非温不化,过温则害阴助热。因此,治疗方药又当以温、清、开、泄互为配合。热胜于湿,以清为主;湿胜于热,温运为先;表里合邪,重在开宣;里邪偏盛,重在泄利。所以,温热病与湿热病在治疗上是迥然不同的。

(二) 内伤病传变规律

内伤病是一切慢性疾病的总称。《素问·宣明五气篇》说:“久视伤血,久卧伤气,久坐伤肉,久立伤骨,久行伤筋,是谓五劳所伤。”《巢氏病源·虚劳候》说:“大饱伤脾,脾伤善噫、欲卧、面黄”;“大怒气逆伤肝,肝

伤少血目暗”；“强力举重、久坐湿地伤肾，肾伤少精，腰背痛，厥逆下冷”；“形寒寒饮伤肺，肺伤少气、咳嗽、鼻鸣”；“忧愁思虑伤心，心伤苦惊、喜忘、善怒”；“风雨寒暑伤形，形伤发肤枯夭”；“大恐惧不节伤志，志伤恍惚不乐”。由此可见，引起内伤病的因素和出现的病证，都是极为广泛的。总的来说，其致病原因大体可分如下几方面：

1. 禀赋不足，或母体妊娠期失于调摄，或乳婴期调养失宜，成年以后，精血亏虚，体质薄弱，易于招致疾病，病后不易恢复。如此反复，内伤日甚。

2. 劳倦过度，劳力过度则伤气，苦用神机则伤神，气虚神弱，久渐成病。

3. 房室不节，恣情纵欲，损耗肾精，精虚不能养神则神衰，精虚不能养形则形惫。形神衰惫，脏腑机能失调，诸患随起。

4. 情志所伤，思虑过度，损伤心脾，心伤则暗耗营血，脾伤则健运失司。忧愁不解则伤肺，肺伤则气机不畅而致肺气失调。忿怒抑郁则伤肝，肝伤则动风生火。恐惧不止则伤肾，肾伤则精气失于摄纳。凡此种种，均可导致脏腑功能失调，引起内伤疾病。

5. 饮食不节，或因饥饱不调，或因食物偏嗜，致使脾胃之气受伤。脾气不足，不能运化精微，气血之源日亏，内不能洒陈于五脏六腑，外不能布达于营卫经脉，渐至表

里俱虚,形衰体弱。一旦招致疾病,每多不易康复而成内伤疾病。

6.病后失调,或大病后失于调理;或病久失治,正虚邪留;或产后体虚,失于调护;或其它慢性疾病日久不愈,反复传变,精气日亏。凡此都可发展成为内伤疾病。

由上所述,虽然内伤疾病多种多样,总括起来,多以内虚为致病主因。其病机演变正如《医宗金鉴》所说:

“阳虚外寒损肺经,阴虚内热从肾损,饮食劳倦自脾成。”此即是说,内伤病的起因,一为外因病失治,或以寒病伤阳,或以热病伤阴,转为慢性;一为内因病积渐成疾,或以阳虚,或以阴虚,或以气虚,或以血虚。概要言之,总不外阳虚与阴虚两方面。肾藏五脏六腑之精,阴精虚的关键在于肾;肺主一身之气,阳气虚的关键在于肺;脾为生化气血之源,脾虚以后,或偏伤于气,或偏伤于血,故气血虚的关键在于脾。因此,内伤病的虚,又可归纳为阳虚和阴虚两个大类。人体阴阳出入升降的常态,阳以上升外出为常,阴以下行潜藏为常。如果阳虚或阴虚以后,其病机演变则以相反的形势表现出来。即阳的机能是亢奋的、上升的,反而变为衰退的、下降的;阴的机能是下行的、潜藏的,反而变为亢奋的、上升的。此种病变规律,简要言之,阳虚以从上而下、从外而内,由肺、由脾以及于肾为规律;阴虚以从下而上、从内而外,由肾、由脾以及于肺为规律。肺居上焦,外合皮毛,内通心脉;脾居中焦,

与胃相合，司运化，主升降；肝肾并居下焦，主疏泄，司开合。肺、脾、肾发生病变，必然累及心、肝以至五脏互为传变。现将阳虚与阴虚病变规律分别论述如下：

1. 阳虚病变规律 其病变规律大略如下：（图3）

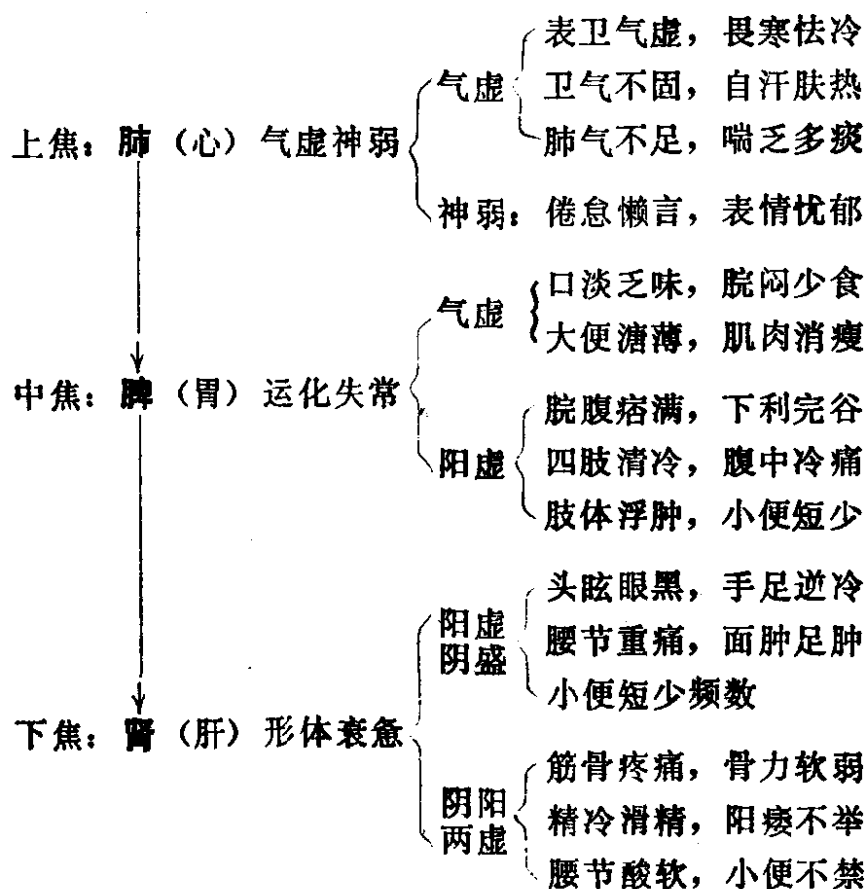


图3 阳虚病变规律

凡以外感寒证失治，或以过度劳倦思虑，均能内伤阳气而致积渐成疾。阳气内虚则阴寒偏盛，于是出现《素问·调经论》所说“阳虚则外寒”、“阴盛则内寒”的病变。此种阳虚阴盛的演变规律，一般说来，初期阶段以上焦心肺气虚为主，渐以火不生土而出现中焦脾胃虚寒，后

期则发展为下焦肝肾病变。此即张景岳所说：“伤于阳者，病必自上而下也。”

肺主一身之气，司呼吸，外合皮毛，内通心脉。肺气不能布达于体表，表卫气虚难以抗御风寒，则畏寒怯冷；卫气不固，腠理疏松，则自汗肤热；肺气不能供应呼吸，则喘乏短气；肺气不能输布津液，则聚液生痰。心藏脉，脉舍神，气虚则神弱，神弱则倦怠嗜卧，懒于语言，表情忧郁。此即阳虚初期由上由外所表现的心肺气虚病变，亦即阳虚则外寒、阳虚则自汗的病变。

继心肺气虚日渐发展，常以火不生土而致脾胃虚衰。脾虚以中焦运化失常为主，或以气虚的趋势演变，或以阳虚的趋势发展。胃虚不能消化食物，则现口淡乏味，食少脘闷；脾虚不能运化精微，则见大便溏薄，肌肉消瘦。脾胃为生化气血的源泉，气虚不能升发于肺，则肺气更虚，血虚不能输布于心，则营血虚少。表现为喘促多痰，食少便溏者，属于肺脾气虚；表现为倦怠嗜卧，多梦健忘，食少体瘦者，属于心脾不足，气血兼虚。这是气虚的一面。气虚甚者，便是阳虚，阳虚则阴寒内盛。胃中虚冷，食谷呆滞，故脘腹痞满；脾气虚寒，运化失职，故下利完谷。中焦阳虚，外而不能温达四末，故手足清冷；内而不能温润肠脏，故腹中冷痛。脾有输布津液上升下渗的本能，脾阳不振，水气停聚，泛溢于肌肤，则见肢体浮肿；不能渗利于膀胱，则见小便短少。这是阳虚的一面。此即阳虚从

上而下由肺及脾所表现的脾胃虚寒病变。应当说明，中焦阳虚也有不经上焦心肺病变而发病的，如暴饮暴食引起大吐大泻直伤脾阳，病后失于调治，亦可形成脾胃虚寒。对此则以脾虚而为传变规律。

阳虚发展到后期阶段，或以脾虚及肾，出现阳虚阴盛；或以精血日亏，出现阴阳两虚。肾为水火之脏，下焦阳虚，清阳不得升腾于上，头目失养，则见头眩眼黑；不得布达于外，四肢失温，则见手足逆冷。腰为肾之府，阳虚则内寒，腰节失温，筋骨不利，故腰节沉重作痛，甚则冷痛如坐水中。脾虚则土不制水，肾虚则水气不化，于是水气潴留，泛逆于上则面肿，流注于下则足肿；如水聚大腹，还可出现腹大胫肿重证。此属脾肾阳虚，阴寒内盛。肾藏精，肾精来源于先天，依赖后天食物精微的供给，肾精有入肝化血、补充骨髓、滋养筋脉功能。脾肾气虚，化源不充，于是肾精日亏、肝血不足，出现阳虚及阴、阴阳两虚病变。精血亏虚，筋骨失养，是以筋骨疼痛，骨力软弱；腰为肾之府，故腰节酸软无力，更为显著。阳虚不能温摄肾精，是以精冷、滑精，甚则阳痿不举，妇女则宫寒不孕。阳虚不能约制膀胱，是以小便频数不禁。肺与肾精气相通，肺肾气虚不能约制水道，则见饮一溲二。心与肾水火相济，心藏神，肾藏精，心肾同虚则见心悸、健忘、多梦、遗精、腰膝酸软。此属脾虚及肾、阴阳俱虚。此即阳虚从上而下由脾及肾所表现的肝肾病变。

由此说明, 阳虚的病机演变, 是以从上而下由肺由脾以及于肾而为规律。阳之精为神, 阴之精为精为髓, 阳虚则神衰, 精虚则形惫, 因而神气衰弱便是阳虚首先表现的主证。如果神衰而渐次出现形体瘦弱虚惫, 便是阳损及阴、阴阳虚竭的证候。阳虚的舌苔多为白、淡、滑、腻; 阳象的脉象多为缓、迟、沉、弱。如见舌体颤动无力, 舌苔淡腻灰黑; 脉现来去迟缓, 一息不足四至, 或结代, 或沉伏者, 均为阳气虚极、脏气衰微的危候。

2. 阴虚病变规律 其病变规律大略如下: (图4)

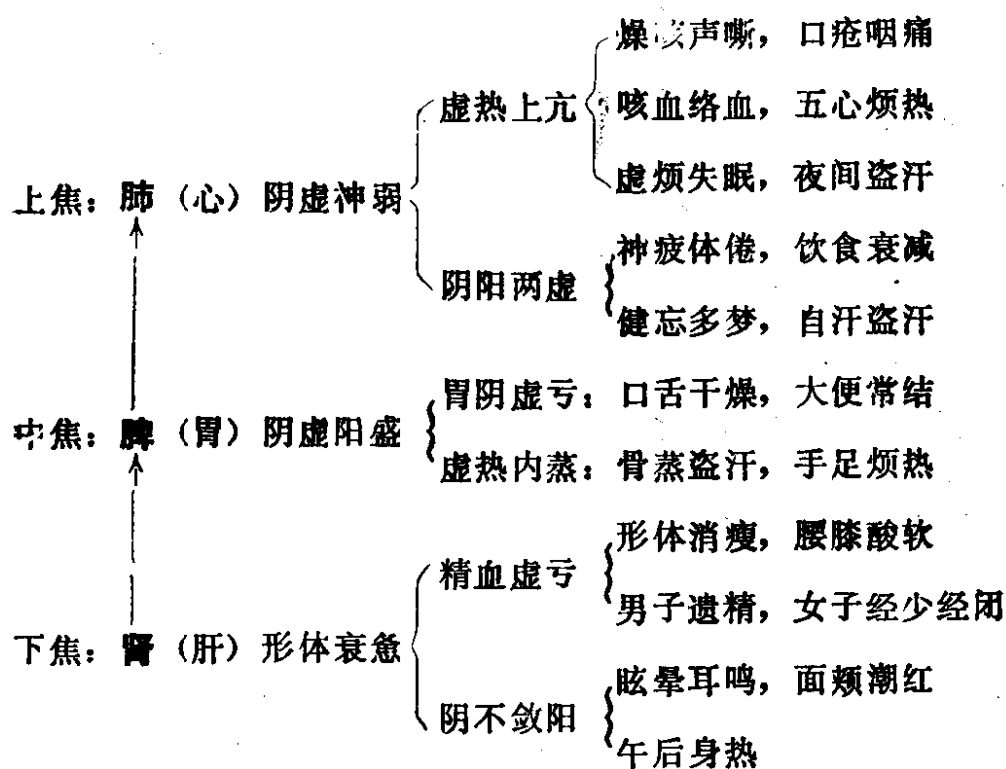


图4 阴虚病变规律

凡以各种外感热病、失血病后失于调治, 或以禀赋不足、纵情色欲, 均能耗损精血而致渐成内伤疾病。阴虚则

阳盛,于是出现《素问·调经论》所说“阴虚则内热,阳盛则外热”的病变。此种阴虚阳盛的病机演变,恰与阳虚病变相反地表现出来。即初期阶段首先表现肝肾阴虚、阴不敛阳证候;渐次以虚热内蒸而现胃阴亏损;后期则发展为心肺病变,或为虚火刑金,或为阴阳两虚。此即张景岳所说:“伤于阴者,病必自下而上也。”

肾主一身之阴液,阴液有滋润形体脏腑、充养筋骨脑髓、潜制阳盛动火、维持发育生殖等功能,是以阴虚首先显现肝肾证候。阴虚不能腠养肌肤,故见形体日渐消瘦;阴虚不能充养筋骨,故见腰膝酸软乏力。阴虚不能潜制相火,男子可因精关不固而见夜梦遗精,女子则经水不足而致经少经闭,甚则男子不育、女子不孕。这是精血亏虚的一面。阴虚不能制阳,虚阳升腾,清窍不清,则见眩晕耳鸣,两颊潮红;虚热内动,则见午后身热。这是阴不敛阳的一面。此即阴虚开始由下由内所表现的肝肾病变,亦即阴虚则阳盛、阴虚则内热的病变。

继肝肾阴虚日渐发展,常以内热耗阴致使阴愈亏而热愈盛。内热蒸腾,灼伤胃阴,津不上承则口舌干燥,津不下润则大便常结;胃阴不足,胃失和降,还可出现饥不欲食、脘痞不舒、或干呕呃逆等证。脾主四肢,虚热内蒸,热盛于外,则手足烦热,甚则出现骨蒸盗汗。此即阴虚从下而上由肾及脾所表现的胃阴亏虚病变,亦即阴虚则内热、阳盛则外热的病变。

阴虚发展到后期阶段,或以虚热上亢,损及心肺;或以阴损及阳,阴阳两虚。虚热持续,火旺刑金,肺失清润则燥咳声嘶;虚热上燔则口疮咽痛;热伤肺络,则见咳血或咯血。心阴亏损,虚火内扰,神舍难安,则见心中烦悸,虚烦不眠;虚热内蒸,热盛于外,阴分津液为热所迫,则见五心烦热,睡中盗汗。如阴虚已极,孤阳独亢,便能产生阴竭阳脱危候。另一方面,精血日亏,阴损及阳,一则精不化气,致令肺气亦虚;一则精髓不足,脑海失养,导致心虚神弱;于是出现阴阳两虚病变。证见心悸健忘,食少体倦,虚烦多梦,睡中盗汗者,属于阴虚内热、心脾气虚;证见喘促短气,食少神疲,胃脘痞闷,咳痰带血者,属于阴虚肺热、脾气兼虚;证见动则气喘,气不上续,声音低微,自汗盗汗,尿频滑精者,属于肺肾同虚、阴阳衰竭。此即从下而上由肾由脾以及于肺所表现的心肺病变。

由此说明,阴虚的病机演变,是从下而上由肾由脾以及于肺而为规律。阴虚的体征恰与阳虚相反,阳虚始于神衰而终于形惫,阴虚则始于形惫而终于神衰。即是说,阴虚开始即表现形体消瘦,由此发展可见形消骨立,如体瘦而渐次出现神气衰弱,便是阴损及阳、阴阳两虚的证候。阴虚的舌苔多为红、绛、花剥、或光嫩无苔;阴虚的脉象多为细、弦、数、急、或按之而空。如见舌体瘦薄,舌色光绛干枯;脉现来去促急,一息七至以上者,多为阴竭阳越危候。

由此可见,内伤疾病的发生,都是脏腑阴阳偏衰偏盛所引起,阳虚不能制阴,则阴寒偏盛而出现虚寒证;阴虚不能制阳,则阳热偏盛而出现虚热证。尽管疾病有多种,病因有不同,其病机演变的规律,则是一致的。临床上根据上焦心肺、中焦脾胃、下焦肝肾各个病期的证候特征,按脏腑辨证规律,便能预见病势良恶,从而把握病机作出正确的调治方法,是能够取得良好疗效的。由于内伤疾病往往虚实互见,治疗方法应以培其不足、不可伐其有余为原则。即是说,阳虚宜于温阳祛寒,过于温燥则易损耗精血;阴虚宜于益阴制阳,妄用寒凉则易伤害阳气;如此则两败俱伤,促使病情恶化。又因脾胃为后天之本,精津气血之化源,故无论阳虚与阴虚、治肺与治肾,都应始终以扶脾益胃为首务,这在治疗内伤疾病方面,又是一个不可忽视的原则。

各 论



第一章

卫肺疾病

肺居上焦，主气，司呼吸，开窍于鼻，外合皮毛，肺气宣畅，外而肌表开利，荣卫和调，上而鼻窍通畅，呼吸平匀。凡外感风邪侵袭人体，外则阻闭肌表卫阳，上则壅塞鼻窍气息，内入犯肺则能并发咳嗽、喘息、哮喘等证。故此，感冒及因感冒而引起的咳、喘、哮诸证，大都以卫肺同病的病机出现，因而总称为卫肺疾病。

一般所见慢性咳、喘、哮证，除因于外感新病失治转为慢性者外，其间也有由于各种内因疾病累及于肺而发病的。本章着重论述外感咳、喘、哮证，对慢性诸证相应论及。

肺痿、肺痈、肺癆以及其他疾病中所并发的咳嗽、哮喘证候，另详各篇。

第一节 感 冒

凡外感风邪引起以头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、恶风、发热等证为主要临床表现者，一般称为感冒。其轻者，称为伤风；其重者，称为重感冒；如在一个时期内传染流行，不分男女老幼，病状多相类似者，则称为时行感冒。

本病四时皆有，以冬春季节为多见。由于四季气候变化不同，感邪有轻重，体质有强弱，因此，在证候表现上，有风寒、风热、挟暑、挟湿的区分以及体虚感冒的不同。其发病机理皆由外邪侵袭肌表，一般表现卫肺表证，故初起治法均以解表散邪为主。虚人感冒又当祛邪与扶正兼顾，如果徒事发散，正气愈虚，反致邪留不去。

一、病因病机

风为六淫之首，往往兼挟寒、暑、湿、燥等时令之气而侵袭人体。一般说来，冬季多感风寒，春季多感风热，夏季多挟暑邪，秋季多兼燥气，淫雨季节则多挟湿。但在四时之中，若春应温而反寒，夏应热而反冷，秋应凉而反热，冬应寒而反温，在此气候反常情况下，也能出现风寒暑湿诸邪侵袭人体发生各类感冒病证，甚或引起时感流行。导致风邪侵袭的因素，每以起居不慎，寒暖失调，或贪凉露宿，冒雨涉水，致使卫肺功能失于调节，招致外邪入侵，尤以平素体质偏弱之人，表腠疏松，卫气不固，稍有不慎，更易乘虚入侵而发病。

外感风邪,从皮毛口鼻而入,首先侵袭肤表,阻犯鼻窍。肺主气,开窍于鼻,外合皮毛,职司卫外,感邪之后,皮毛闭塞,荣卫失和,鼻窍受阻,气道不利。于是邪正相争而出现头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、声重、恶风、发热等卫肺表证。感伤邪气各有不同,体质强弱各有差异,故各随其因而出现风寒、风热和挟暑、挟湿等不同证候。素体阳虚者,易受风寒;阴虚者,易受风热。体质较强,一般外邪仅袭卫肺,多以表证为主,易于从表解散;若老年、体弱,鼓荡邪气能力较差,往往邪留不去,难以速愈,甚则由表入里而致病情加剧。

二、辨证施治

感冒初起,邪犯表卫,一般表现鼻塞、流涕、喷嚏、声重、头痛、身酸、恶风、发热等表卫证状,继则邪入犯肺,引起咳嗽、喉痒、咽痛等肺系证候。由于四时气候的变化,兼挟时气的不同,感邪有深浅,证状有轻重,体质有强弱,脉证表现各有差异,因此,必须辨别风寒、风热两类不同证候及挟暑、挟湿、兼虚等不同病情,以为治疗依据。

凡治感冒,当邪在表卫还未犯肺之际,应采取发散解表治法,使腠理开泄,邪从外解。如《素问·玉机真藏论》说:“今风寒客于人,使人毫毛毕直,皮肤闭而为热,当是之时,可汗而发也。”所以,发散解表是治疗感冒初起的首要法则。证属风寒者,治以辛温发汗;证属风热者,治以辛凉解表;兼挟湿邪,宜于疏风散湿;兼挟暑热,宜

于辛凉清解；体虚者，宜固其卫气，兼解风邪。总之，治感冒须辨别寒热，详察虚实，审其轻重，顺其时令，不可表散太过，亦不可补益太早。证属风寒，误用辛凉，反使邪气留滞不得汗解；证属风热，误用辛温，必致劫津耗液化火伤肺；体虚之人，专行发散，往往愈虚其虚，反致邪留不解。

(一) 风寒

主证：恶寒发热，头痛身酸，鼻塞声重，喷嚏连连，舌苔薄白，脉浮。

兼头痛如裹，肢节重痛，身热不扬，苔白腻，脉浮紧者，属外寒挟湿。

兼喉痒咽痛，口中干渴，舌质红，脉浮数者，属外寒内热。

证析：寒为阴邪，其性凝涩，风寒侵袭人体，外而阻闭肌表，荣卫失畅，故见恶寒发热，头痛身酸；上而阻闭鼻窍，气道不通，声喉不利，故见鼻塞声重，喷嚏流涕。舌苔薄白，脉浮，均为风寒在表病证。

湿性重滞，风寒挟湿则凝涩更甚，是以见头身重痛，身热不扬；脉紧属表寒为盛之象。

寒邪闭滞于外，卫阳阻遏于内，最易郁而化热。肺内蕴热，灼伤咽喉，则喉痒咽痛；耗及阴津，则口中干渴；舌红脉数，均为热象。此属外寒内热病证。

治法：辛温解表，宣肺散寒。

主方：荆防汤^①加减。寒性凝涩，非温不散，方以温寒发汗、解表散邪立法，通治四时感冒风寒。风寒挟湿、外寒内热俱为表寒，仍以本方为主，酌加散湿、清热药物

以达表里两解之功。

凡服辛温发汗方药，宜覆被静卧，或啜热粥取汗，以遍身出透微汗为佳，得汗则止，慎避风寒。切忌过汗或大汗，以防伤阳耗津，重伤肺卫。

（二）风热

主证：发热恶风，汗出不畅，头目昏痛，鼻塞涕稠，或有喉痛，口干渴，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

如在夏令，常多兼挟暑湿时邪。如兼见高热出汗而热不解，烦渴思饮，小便短赤，舌苔黄燥，脉浮洪数者，属风热挟暑；如兼见头身酸重，倦怠，口渴不欲饮水，脘腹痞闷，舌黄腻，脉濡数者，属风热挟湿。

证析：风为阳邪，从阳化热，风热客于肌表，卫阳疏泄失调，故见恶风发热，有汗而汗泄不畅。上干头目，故头目昏痛；阻犯鼻窍，故鼻塞涕稠；灼伤咽喉，则咽喉肿痛；耗伤津液，则口中干渴。舌质红，苔薄黄，属于热象；脉浮数为风热在表。

风热挟暑，表里俱热，内热蒸腾，故高热汗出而身热不解；热盛耗津，故烦渴引饮，小便短赤。舌黄燥，脉浮洪数，均为里热兼盛病证。

风热挟湿，寒热互见，表里同病。湿为阴邪，其性重浊，风热与阴湿相兼，故外而干及肌表，兼见头身酸重，肢体困倦；内而阻困脾阳，兼见脘腹痞闷，口渴不欲饮水。苔黄腻，脉濡数，均为热湿互见之象。

治法：辛凉解表，清疏肺热。

主方：银翘散^②加减。风热温邪，非辛不散，非凉不解，故本方凉热疏风、轻解表邪，为治四时感冒风热有效

方剂。

风热挟暑，宜于辛凉重剂，用翘荷石膏汤^③以凉解表里之热，热退津回，其病自愈。

风热挟湿，宜于疏风祛湿，可用银翘香薷饮^④。此方温凉并用，寒热两解，为表里同治之法。

（三）虚人感冒

主证：区别气虚、阳虚、血虚、阴虚辨证。

气虚，恶寒甚，身热轻，头痛鼻塞，困倦无力，气短懒言，舌淡苔白，脉浮乏力。

阳虚，恶寒无热，四肢不温，头痛身痛，或自汗出，面白唇淡，舌淡苔白，脉沉无力。

血虚，身热自汗，微恶风寒，头痛身酸，面色萎黄，唇甲色淡，头晕心悸，舌淡红，脉细或浮而乏力。

阴虚，头痛身热，恶风无汗，或有微汗，头晕心烦，手足心热，口渴咽干，舌红少津，或舌苔花剥，脉浮细数。

证析：气虚甚者便是阳虚，阳虚者气必虚，阳虚则外寒，是以气弱阳虚之人，卫外不充，易于招受风寒。所以，除见头痛、鼻塞、流涕、喷嚏、恶寒、发热等一般风寒表证外，属气虚者，见恶寒甚、发热轻、困倦无力、气短懒言、脉浮乏力等表卫气虚、寒多热少证象；属阳虚者，则见恶寒不热、四肢清冷、头身疼痛、自汗出、唇淡面白、脉沉无力等阳虚阴盛、卫外不固证象。

面色萎黄，唇甲色淡，头晕心悸，是荣血亏虚的表现。血虚不能固敛卫阳，表腠疏松，复感风邪，荣卫失和，故见头痛身酸，身热自汗（或无汗），微恶风寒。舌淡红，脉细或浮乏力，为荣血内虚、表邪外客之证。

素体阴虚之人，阴虚则阳盛而多内热，风邪外侵，荣卫失和，故见头痛身热、恶风无汗或微汗等风热表证。虚热内蒸，故头晕心烦、手足心热；阴虚津少，故口渴咽干。舌红少津，或舌苔花剥，脉浮细数，均为阴虚内热所致。

治法：轻疏表邪，和调荣卫，兼顾其虚。

主方：小秦艽汤^⑤加减。虚人感冒，外实内虚，表邪宜散，散之不当，伤阳耗津，愈虚其虚；内虚宜补，补之过早，阻滞邪气，必致病势难愈。本方治感冒兼虚诸证，功能疏表而不动汗，不伤卫阳，不耗荣阴，荣卫和调，自能鼓邪外出，微汗而解。对阴、阳、气、血偏虚较甚者，可于方中加入益气、助阳、养血、滋阴药物，使其标本兼顾、扶正驱邪。

总之，感冒一病，最为多见，如能及时治疗，投剂得当，奏效亦速。反之，调护不当，或治疗失误，亦能由轻转重。所以除服药之外，必须注意休息，慎避风寒，以免加重病情发生它变。

本病在广泛流行期间，除避免接触患者预防传染外，服用荷板桑藿汤^⑥及众矾解毒方等防治方法，对控制传染流行，亦是很有良效的。

三、方药化裁

1. 荆防汤

荆芥18克 防风18克 桔梗10克 前胡10克 橘皮10克 淡豆豉10克 甘草3克 生姜3克
水煎服，卧取微汗。

此方解表散寒，开宣肺气。适用于感冒风寒，证见头痛身酸，鼻塞声重，恶寒无汗者。方中荆芥、防风辛温散寒，豆豉宣透肌表；桔梗、前胡、橘皮开宣肺气；甘草、生姜和中走表。卫肺开利，则邪从汗解。

风寒挟湿，头昏重痛为甚者，加白芷10克，川芎10克，以辛香通窍，散风止痛；肢体重痛为甚者，加羌活18克，白芍24克，以散寒祛湿，和调荣卫。

外寒内热者，加黄芩20克，淡竹叶10克，以清内热；如见咽喉肿痛者，可加板蓝根24克，射干20克，以消肿利咽。

2. 银翘散（《温病条辨》）

银花24克 连翘24克 荆芥15克 薄荷15克 淡豆豉10克 牛蒡子10克 桔梗10克 淡竹叶10克 甘草3克 鲜苇茎30克

水煎，香气大出，即取服，勿过煮。

此方辛凉透表，宣肺解热。适用于感冒风热，证见发热恶风，汗出不畅，头痛口渴，喉痒咽痛者。方中银花、连翘凉解热邪；荆芥、薄荷、豆豉辛散疏风；桔梗、牛蒡、甘草宣肺利咽；竹叶、苇茎清热生津。邪退热清，诸证得愈。

见口中干渴为甚者，加知母24克，花粉24克，以清热生津。咽喉肿痛为甚者，加板蓝根30克，玄参18克，以助消肿利咽。见鼻衄者，宜减去荆芥、豆豉，加焦栀子18克，白茅根30克，以凉血止血。

3. 翘荷石膏汤

连翘24克 薄荷15克 生石膏30克 知母24克 桔

梗10克 甘草6克 淡豆豉10克 淡竹叶10克

此方为辛凉解热重剂。适用于外感风邪，内伤暑热，或外感风热误用辛温发汗，见汗出恶风，高热不解，烦渴引饮，脉浮洪数有力等热盛伤津、表邪不退之证。方以薄荷、连翘、豆豉辛散轻疏，透解表邪；石膏、知母、竹叶甘寒泻火，凉解里热；桔梗、甘草开宣肺气。表邪解，里热清，则热退津回，烦渴自解。

4. 银翘香薷饮

银花24克 连翘24克 香薷10克 薄荷10克 桔梗10克 藿香10克 甘草3克 鲜荷叶0.5张

水煎，稍冷取服，以防隔拒作呕。

此方疏风祛湿，解表和中。适用于夏令感冒兼挟暑湿，证见恶风无汗，头身酸重，体倦脘闷，渴不欲饮，舌黄腻，脉濡数等寒热互见、表里同病者。方中银花、连翘凉解热邪；甘草、桔梗开宣肺气。香薷性味辛温，功能发汗利水，与薄荷配合，辛散透表，宣发卫阳，使在表之湿从汗而解；与藿香并用，芳香和中，发越脾阳，使在里之湿通利而消。荷叶升发清阳，善于清解暑热。寒热已解，表里自和。

如暑热偏胜，见胸中烦热者，加黄连6克，以清热除烦；口渴思饮者，加西瓜翠衣60克，以清暑生津。

如湿滞偏胜，见胸满泛呕者，加厚朴15克，橘皮10克，以导滞宽中；小便不利者，加滑石18克，以助清暑利湿。

5. 小秦艽汤

钩藤20克 秦艽20克 白芍20克 白芷10克 桔梗10克 前胡10克 甘草3克 大枣12克

此方轻疏表邪，和调荣卫。适用于虚人感冒，或因过

于发散，表虚邪留，证见头痛身酸，鼻塞声重，恶寒身热，自汗，或无汗，脉来虚弱者。方以钩藤、白芷疏利头目；桔梗、前胡宣肺疏风。秦艽能疏风活络、解热散邪；白芍能和血脉、敛阴气。甘草、大枣甘润和中，助诸药以和荣卫。方中白芷、秦艽与白芍相配，一疏一敛，使发散而不害卫，敛阴不致留邪。荣卫和调，则邪去汗止。凡虚人感冒无大虚大实者，直以本方投之，颇能取得祛邪而不伤正之良功。

气虚偏甚，气短脉弱者，加太子参30克，以扶正祛邪。寒重无汗者，加生姜3克，服药后啜以热粥，静卧以取微汗。

阳气已虚，恶寒不热，面白肢冷，脉沉无力，不能鼓荡外邪，加太子参20克，制附片10克，以助阳益气，解表祛邪。

血虚之人，表腠疏松，只宜轻疏，不可发汗，汗则伤荣耗津，愈虚其虚，故《金匱》有“亡血不可发其表”的禁例。如因寒重而见恶寒无汗者，加荆芥10克，以取汗，得汗则止，不可过剂。如因热重而见口渴咽干者，加连翘15克，黄芩15克，麦门冬15克，以清热生津。

素体阴虚，感受外邪，每易化热化燥。似此，可于方中加入薄荷10克，玄参10克，玉竹10克，连翘15克等品，以助养阴清热解散表邪。

6. 荷板桑藿汤

板蓝根10克 薄荷3克 桑叶3克 南藿香3克

此方清疏肺卫，和中解毒。时感流行期间，将本方日用1剂煎服2次，连服3天。未病可以预防，轻病亦能治疗。如集体内服，以10剂量，煎汤作30人服用。

7. 众矾解毒方

贯众50~100克 白矾30~60克

此方功能杀虫解毒。时感或瘟疫流行期间，将二药放入饮水缸内，具有饮水解毒作用，农村用之，更为适宜。

(表5)

表 5 感冒病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
外感风邪，外而侵袭肌表，腠理闭塞，荣卫失和，上而阻犯肺气，鼻窍不利，声喉受阻	感冒风寒	辛温发散	荆防汤
	感冒风热	辛凉解表	银翘散
	风热挟暑	凉解暑热	翘荷石膏汤
	风热挟湿	祛湿疏风	银翘香薷饮
	虚人感冒	轻疏表邪 兼顾其虚	小秦艽汤
	预防治法	清疏肺卫 和中解毒	荷板桑藿汤 众矾解毒方

第二节 咳 嗽

有声无痰曰咳，有痰无声曰嗽，因临床以声痰并发者常见，故总称咳嗽。

咳嗽是肺系疾患的主证之一。凡以咳嗽为主要临床表现的病证，一般分外因、内因两大类。外因之咳，常为四时感冒的并发证候，其间分风寒、风热、风燥三证。内因之咳，不外两端，一由外因之咳，失于治疗，转为慢性；一由津气内虚，或气虚生痰，或阴津亏损，累及于肺，引起咳嗽。总之，不论病因如何，咳嗽总不离于肺。所以，

《景岳全书·咳嗽篇》指出：“咳证虽多，无非肺病。”

本篇所论即四时感冒所引起的风寒、风热、风燥咳嗽（急性）及一般常见的湿痰、阴虚咳嗽（慢性）等证。至于其它疾病兼见的咳嗽证候，不属本篇讨论范畴。

一、病因病机

肺主气，位居上焦，为五脏之华盖，上连喉咙，开窍于鼻，司呼吸，外合皮毛；其体清净空虚，功能治节呼吸，输布津气，外而温养肌肤，内而腴润脏腑。因此，凡外感六淫诸邪，从口鼻皮毛而入，侵袭肺卫，或其它脏腑有病累及于肺，均能导致咳嗽发病，如陈修园《医学三字经·咳嗽篇》所说：“肺为脏腑之华盖，呼之则虚，吸之则满，只受得本然之正气，受不得外来之客气，客气干之，则呛而咳矣；亦只受得脏腑之清气，受不得脏腑之病气，病气干之，亦呛而咳矣。”由此可见，感受外邪或内脏有病，只要累及于肺，都能引起咳嗽。

（一）外邪犯肺

风为六淫之首，风邪侵袭人体，常挟寒、热、燥时令之邪，首先侵袭肌表，阻犯鼻窍，如未及时祛散，邪气由表入内累及于肺，即可引起咳嗽。肺为津气出入之道路，风寒入肺，肺气失宣，肺内津液郁而生痰，痰气阻遏，肺失安宁；风热内侵，热壅气急，肺失清肃；风燥犯肺，最易化火，燥热伤津，肺燥气逆。凡此多以卫肺同病的病机出现。

（二）津气内虚

慢性咳嗽的形成，常与外感咳嗽失治和平素嗜食烟酒、或它脏有病累及于肺等因素有关。也有因职业环境关系，长期吸入飞沙、灰尘以及辛烈刺激气体，致使肺失清肃而成咳嗽者。不论病因如何、其致病之源，总由津、气内亏所引起。肺主气，司呼吸，能敷布津液，通调水道；脾主湿，司运化，能助胃输精，上归于肺。脾气不足不能运化精微，反能聚液成痰上犯于肺；肺气不足不能敷布津液，亦能酿成痰浊阻碍气道。肺与肾津气交通，肺为津水之上源，肾为受藏津液之脏器，肺阴不足则肾失资源，肾阴不足则津不上承，阴虚不能敛阳则虚火上炎，因而肺燥气逆，清肃之令失职。所以，肺脾气虚或肺肾阴亏，均能累及于肺发生咳嗽。

总起来说，外因之咳，起因于外感邪气实，病在卫肺，多属急性实证；内因之咳，成因于内伤津气虚，多属慢性宿疾。湿痰之咳，生痰之本为虚，痰成壅肺为实；阴虚之咳，津液亏损为虚，肺燥气逆为实。故慢性咳证常多本虚标实。正因内伤咳嗽以内虚为致病之本，常以表腠疏松，卫外不固，每于气候稍变、或寒冷季节，偶感外邪而致咳嗽加剧。如此反复发作，积年累月，可使肺、脾、肾俱虚发生种种病变。

二、辨证施治

（一）外感咳嗽

此类咳嗽常起病较急，病程较短，初期多伴有寒热、头痛、鼻塞等表证，而以实证居多。治疗以疏表宁肺、卫

肺同治为基本法则。表邪偏胜，散邪为主，辅以宁嗽；表邪已衰，宁嗽为主，辅以轻疏。如专事止咳，可因邪气留滞以致咳嗽难愈；专事疏表，又能劫伤肺液而致咳嗽加剧。又因风燥咳嗽最易化火，虽有表邪不可发散，恐劫伤津液，肺燥日深。

1. 风寒咳嗽

主证：咳嗽鼻塞，咳痰清稀，鼻流清涕，头痛声重，舌苔薄白，脉浮。

兼肢体酸疼，寒热无汗者，此为表邪偏盛。

兼口干声嘶，咳痰不爽，舌尖红，苔薄黄，脉浮滑者，此为外寒内热。

证析：风寒犯肺，肺气失宣，故咳嗽鼻塞。肺气受阻，津液不得输布，故咳痰流涕。涕清痰稀，属于寒象。舌苔薄白，脉浮，主风寒在表。如表寒偏盛，肌腠闭塞，荣卫失畅，则兼见身疼、寒热、无汗；如肺气阻遏，郁而化热，则兼见口干声嘶、咳痰不爽等寒包热证象。

治法：疏风散寒，宣肺止咳。

主方：风寒阻肺，用止嗽散^①加减；外寒内热，用荆芥桑桔汤^②。

风寒咳嗽，多以肺气阻遏渐次出现化热证候，如辛温方药过量过剂，亦易促使化热而致咳嗽加剧。上两方均以轻疏表邪、宁肺利痰为主，前者重在温寒降逆；后者清疏并用，重在宁肺止咳。

2. 风热咳嗽

主证：咳痰黄稠，咳而不爽，鼻流稠涕，头痛恶风，身热汗出，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

兼口渴心烦，咽喉肿痛者，属邪热偏盛。

证析：风热犯肺，肺失清肃，热煎肺液，结而成痰，是以鼻流稠涕，咳痰黄稠，咳而不爽。邪客在表，故头痛恶风；风热郁蒸，故身热汗出。舌红苔黄，脉象浮数，为风热在肺在表。如邪热偏盛，耗伤津液，则见口渴心烦；热壅咽喉，则见咽喉肿痛。

治法：疏风清热，宣肺利痰。

主方：翘荷桔甘汤③。随肺热轻重加减化裁。

风热咳嗽，最易动汗，虽有表邪，只宜轻疏，否则耗伤肺液，咳嗽愈甚。本方轻宣肺邪而重在清热化痰。邪去则表卫和调，热退则肺气宁静。

3. 风燥咳嗽

主证：干咳无痰，或痰少粘稠不易咳出，鼻燥咽干，口唇干裂，或见咳引胸痛，或有恶风身热，舌尖红，苔薄黄而干，脉略数。

兼咽喉干痛，咳嗽气急，咳带血丝者，属风燥化火。

证析：本证多见于秋令气候干燥季节，亦可由风热化燥转变而来。风燥入肺，燥伤肺液，肺失清肃，故干咳无痰、或痰少粘稠不易咳出。鼻燥咽干，口唇干裂，均为燥热伤津所致。肺失清润，气机不利，故可见咳引胸痛。风燥之邪，客于表卫，卫气不和，故可见恶风身热。舌尖红，苔薄黄少津，均为燥热证象。如风燥化火，伤及咽喉，则咽喉干痛；肺失清润，则咳嗽气急；伤及肺络，则咳带血丝。

治法：清肺润燥，降逆止咳。

主方：桑杏知贝汤④。随燥热轻重加减化裁。

风燥咳嗽，易于化火，切忌发散，劫伤津液。本方疏

邪而不害肺，重在清润降逆，邪退津回则气降咳止。

（二）内伤咳嗽

此类咳嗽多属慢性宿疾，每因偶触外邪，引起咳嗽加剧。在治疗上，如兼外邪，仍从外感咳嗽论治，表邪已退，则从内伤咳嗽论治。此为急则治其标，缓则治其本的法则。

内伤之咳，常多本虚而标实，虚者宜补，过补则碍实；实者宜泻，过泻则防虚。所以补虚泻实，应以用药平和为原则。

湿痰之咳，本由肺脾气虚，故治痰以健脾益气为本；痰由水聚，非温不化，故治痰以温药为宜；大温或过温，痰被煎熬不易消散，故治痰又以温和宣降为佳。对痰热咳嗽，也宜采取温清并用治法。

阴虚之咳，本由肺燥津亏，肺与肾有津水交通功能，故阴虚咳嗽皆以肺肾同治为要法。由于阴虚为患，有阴愈虚、火愈炽、津愈伤而肺愈燥的演变趋势，故滋肾阴润肺燥是治阴虚咳嗽的基本原则。虚火上亢，本由津亏，故滋肾养阴即可降火；咳嗽气逆，本由肺燥，故润燥宁嗽即可保肺。惟滋阴易于滞脾，故滋肾润肺方药中，又当注意配合调理脾胃药物。

1. 湿痰咳嗽

主证：咳嗽痰多，痰白清稀，漩滑易出，伴有胸脘痞闷，或食欲不振，大便时溏，舌苔白腻，脉多见缓。

如见咳痰黄稠，吐唾不利，胸闷口苦，舌苔黄厚，脉滑者，此属湿痰化热，痰热壅肺。

证析：肺脾气虚，聚湿生痰，痰滞于肺，肺气不宁，故咳嗽痰多。痰由液聚，色白清稀，故咳而漩滑易出。痰

湿内停，是以胸脘痞闷。脾气偏弱，则见食欲不振，大便时溏。舌白腻，脉缓，主气虚湿聚。

痰热咳嗽，皆由湿痰久蕴，遏郁生热，痰遏热蒸，化为稠痰，痰阻气滞，故见咳痰黄稠、吐唾不利、胸膈作闷。口苦，舌苔黄厚，脉滑，均为痰热证象。

治法：健脾燥湿，降痰止咳。

主方：二陈汤^⑤加味。根据肺脾气虚程度（虚的方面）及湿痰壅肺轻重（实的方面）随证变化。痰热咳嗽，宜温清并用、化痰降逆，可用苏杏降痰汤^⑥。若热退痰稀，咳嗽不止，仍从湿痰咳嗽论治。

2. 阴虚咳嗽

主证：久咳不愈，干咳无痰，或痰少粘稠，或痰中带血，可伴有口燥咽干，手足心热，心烦耳鸣，两颧潮红等证，舌红少苔，脉来细数。

证析：肺阴亏损，肺燥失润，故干咳无痰、或痰少粘稠而吐唾不利。如咳甚而伤及肺络，即可出现痰中带血。阴虚则阳盛，虚火内蒸，是以可见口燥咽干、手足心热、心烦耳鸣、两颧潮红等证。舌红少苔，脉细数，均为阴虚阳盛之证。

本证与肺癆咳嗽的鉴别：肺癆之咳多属阴虚，而肺癆初起即现潮热盗汗、痰中带血；不似阴虚之咳，潮热痰血多见于久病之后。阴虚咳血以偶见为多，不似肺癆之咳，持续咳血。如因证候疑似难辨，则当借助透视确诊。

治法：滋阴降火，宁嗽保肺。

主方：百花枇杷膏^⑦。根据肺肾阴虚程度（虚的方面）及虚火上逆（实的方面）轻重随证加味。

阴虚之咳,一般难求速效,非持续用药不足为功。咳嗽较甚,可先用上方作煎剂内服,以控制咳势,咳势缓和制为膏剂常服,使其逐渐取得津回肺润之效。

总之,咳嗽要着重辨别外感、内伤两大类证。外感咳嗽,起病较急,其病尚浅,易于治疗。内伤咳嗽,多属慢性宿疾,其病较深,难求速效。在治疗中,对因工作环境如飞沙、灰尘、辛烈刺激气味,以及烟酒等因素引起发病者,应注意避免;在寒冬季节,更应防寒保暖,以利治疗。对偶感外邪而致咳嗽加剧者,切勿着眼于虚而不疏解表邪,致使邪留不解,咳嗽日深。由此又可说明,对平素体虚并无咳嗽夙根之人,如因外感引起咳嗽,若误以其虚而不疏解,亦易导致邪留肺络转成慢性咳嗽。

三、方药化裁

1. 止嗽散 (《医学心悟》)

荆芥15克 桔梗12克 紫苑20克 百部20克 白前12克 橘皮10克 甘草6克

此方疏表宣肺,利痰止咳。适用于风寒咳嗽,证见咳嗽稀痰,鼻塞声重,舌薄白,脉浮者。方以荆芥疏表散寒;桔梗、白前、橘皮、甘草宣肺利气;紫苑、百部化痰止咳。

鼻塞头痛较甚者,加白芷12克,以助辛通开窍,散寒止痛。寒热无汗,肢体酸疼者,加防风15克,以配合荆芥疏表散寒,得汗则止,防其劫伤肺液。咳痰多者,加法半夏15克,以燥痰降逆。如咳嗽较甚,可加枇杷叶30克,以加强止咳降逆之效。

2. 荆芥桑桔汤

荆芥15克 桔梗12克 黄芩20克 玄参18克 紫苑30克 桑白皮30克 冬瓜仁15克 枇杷叶30克 甘草6克

此方疏宣肺邪，开利肺气，清泻肺热，止咳化痰。适用于风寒咳嗽，肺内蕴热，证见鼻塞声嘶，口干喉痒，咳痰不爽，舌尖红，苔薄黄，脉浮滑数者。方以荆芥、桔梗疏宣肺邪；黄芩、桑皮清泻肺热；紫苑、枇杷叶、冬瓜仁化痰降逆，宁肺止咳；玄参、桔梗、甘草并用，能开宣肺气，利咽祛痰。一疏一清，一利一降，邪去痰清，肺气降而咳嗽止。外感之咳，属风寒化热者最多见，用本方治是证，一般连服二、三剂即获良效。如喉痒喉痛者，加射干20克；咳痰不利者，加川贝母6克。

3. 翘荷桔甘汤

连翘24克 薄荷15克 桔梗12克 甘草6克 牛蒡子10克 冬瓜仁15克 桑白皮30克 枇杷叶30克

此方凉解风热，宣肺利痰，止咳降逆。适用于风热咳嗽，身有微热者。方中连翘、薄荷凉解风热；桔梗、甘草开宣肺气；牛蒡子、冬瓜仁利咽化痰；桑白皮、枇杷叶泻肺止咳。肺热清除，则痰消咳止。

邪热偏盛，见口渴心烦者，加焦栀子12克，知母20克，清热除烦，生津止渴。热壅咽喉，见咽喉肿痛者，加板蓝根30克，大青叶20克，玄参18克，以清咽消肿。咳甚痰粘者，加马兜铃10克，川贝母10克，以助化痰止咳之力。

4. 桑杏知贝汤

冬桑叶12克 杏仁10克 知母18克 川贝母10克 枇杷叶30克 黄芩15克 生梨皮60克

此方清宣凉润,止咳降逆。适用于风燥咳嗽,干咳无痰,口干唇裂者。方中桑叶轻疏风邪而不害肺,杏仁甘润降逆以利肺气;配知母、川贝母、梨皮生津化痰;黄芩清除肺热。枇杷叶与杏仁、川贝母同用,止咳降逆之力更优。

燥热内盛,见口渴心烦者,加生石膏20克,麦门冬20克,以凉热生津,除烦止渴。咳甚气急,咽喉干痛者,加马兜铃10克,玄参18克,以止咳降逆,清利咽喉。咳痰带血者,加炒阿胶10克,以润燥止血。

5. 二陈汤 (《和剂局方》)

姜半夏12克 橘皮10克 茯苓24克 甘草6克

此方功能燥湿降痰,理气和脾,是治湿痰咳嗽的基本方剂。方中半夏温燥降逆以消湿痰;橘皮利气,气利则痰降;茯苓健脾运湿,湿去则痰消;甘草甘温滋润、和调诸药,使无过燥之弊。凡湿痰咳嗽即以本方为主,酌加苏子、杏仁、款冬花、紫苑、百部等温降化痰药品,以助止咳降逆功能。

咳甚痰盛(偏于实)者:咳嗽多痰,胸膈满闷者,属痰气结滞,加苏子10克,白芥子10克,桔梗10克,枳壳10克等辛润温通之品,开利胸膈,祛痰降逆。咳而脘闷食少者,属痰气滞胃,加苍术10克,厚朴12克。宽中除痰,和胃消痞。咳而呕恶痰涎者,属痰饮犯胃,可加重半夏量为18克,再加生姜6克,以加强温胃燥痰,降逆止呕。

肺脾气弱(偏于虚)者:咳而多痰,肠鸣便溏者,属脾气偏虚,加白术15克,砂仁3克,以温中健脾。咳而呕恶冷沫者,属胃气虚寒,加白豆蔻3克,南藿香10克,以温胃止呕。咳而多痰,食少短气,大便不实者,属肺脾气弱,

加太子参24克,白术15克,以益气健脾。

以上仅为用二陈汤治痰饮咳嗽的一般举例。由此推而广之,调其虚实,随证变化,用药总以温和宣降为佳。

6. 苏杏降痰汤

苏子12克 杏仁10克 黄芩20克 全瓜蒌18克 桔梗12克 紫苑24克 桑白皮30克 枇杷叶30克 甘草6克

此方豁痰清热,泻肺降逆。适用于痰热咳嗽,咳痰黄稠,吐唾不利,胸膈满闷,口苦尿黄,舌黄厚腻,脉来滑数者。方以苏子、杏仁辛润温降;瓜蒌化痰散结;桔梗、甘草宣肺祛痰;桑白皮、黄芩清泻肺热;紫苑、枇杷叶止咳降逆。方药配合,温清并用,祛散兼行,润降合施,热去则气降,痰利则咳止。

心中烦热者,加焦栀子,清热除烦;咳痰粘稠者,加川贝母,化痰散结。

7. 百花枇杷膏

米百合15克 款冬花15克 杏仁10克 玄参12克
麦门冬15克 生地黄12克 山药15克 茯苓15克 川贝母6克 枇杷叶30克 雪梨1个(切片)

上药煎服或加量制为膏剂常服。

此方滋阴润肺,宁嗽降逆。适用于阴虚久嗽,干咳少痰者。方以百合滋阴润燥,款冬花止咳下气,作为全方主药。阴虚之咳,本由虚火上亢,故用玄参养阴泻火。肾阴不足则津不上承,肺津亏损则肾失资源,故以麦门冬、生地黄滋肾养肺。滋阴防滞脾,故用山药、茯苓甘淡扶脾以行药力。燥咳气逆,非润不降,故以枇杷叶川贝母、雪梨清润宁嗽。合而用之,功能滋肾润肺,降火止咳。

虚火偏胜（偏于实）者：咳痰带血者，属热伤肺络，加黄芩15克，炒阿胶6克，或白芨20克，以清肺止血。^⑤咳而口燥咽干者，属肺胃阴亏，加玉竹10克，花粉18克，以养胃生津。咳而颧红潮热，心烦不安者，属阴虚阳盛、虚热内蒸，加银柴胡10克，地骨皮24克，以清热退蒸，甚者再加青蒿20克，其清热退蒸之效更优。

肺肾偏亏（偏于虚）者：咳而气短心悸者，属心肺阴亏、心气不宁，加明沙参24克，五味子6克，养阴宁心；若兼咳而气喘，气不上续，此属肾不纳气，方中再加蛤蚧1对，更具补肺益肾纳气宁嗽之功。

凡用本方，咳嗽甚者，先作煎剂服用，咳嗽缓和后，改作膏剂常服。总之，阴虚之咳，难求速效，用药宜于和平，始终注意保护脾胃，是治疗此类咳嗽的基本原则。（表6）

表 6

咳嗽病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
外感咳嗽	风寒袭肺，肺气失宣，或寒邪外束，肺内郁热；风热内侵，肺失清肃；燥热伤津，肺燥气逆	风寒咳嗽	疏风散寒宣肺止咳	止嗽散
		外寒内热	散寒清热宁肺降逆	荆芥桑桔汤
		风热咳嗽	疏风清热宣肺利痰	翘荷桔甘汤
		风燥咳嗽	清肺润燥止咳降逆	桑杏知贝汤
内伤咳嗽	肺脾气虚，聚湿生痰，痰随气逆；肺肾阴虚，水亏火炎，肺被火刑	湿痰咳嗽	健脾燥湿降痰止咳	二陈汤加味
		痰热咳嗽	豁痰清热泻肺降逆	苏杏降痰汤
		阴虚咳嗽	滋阴降火宁嗽保肺	百花枇杷膏

第三节 喘 证

喘证亦称上气,以呼吸急促、呼多吸少为特征,属于肺、肾气机升降失调而致呼吸出纳失其常度的一种病变。其证分实喘、虚喘二类,实喘皆由外邪袭肺,肺失宣降,呼吸不利,其病在肺,多属急性新病;虚喘常为精气内虚,或气虚肺无所主,或精虚肾失摄纳,多属慢性久病。

张景岳指出:“肺为气之主,肾为气之根,肺主皮毛而居上焦,故邪气犯之,则上焦气壅而喘”;“肾主精髓而居下焦,若真阴亏损,精不化气,则下不上交而为促”。由此说明,肺肾精气交通与呼吸出纳的关系极为密切。所以,喘证在临床上常以外因内因、从肺从肾作为辨证论治的纲领。

一、病因病机

兹以虚、实为纲概括外感、内伤诸因。

(一) 外因实喘

此类喘证多由外感风寒、邪热或燥火导致发病。风热、燥火皆属于热,故又可区分为风寒、邪热二类,而此类喘证亦多表现咳喘并见。

重感寒邪,外而闭塞肌表,内而阻遏肺气,肺气不畅,肺液郁而成痰,痰气交阻,呼吸不利,气逆为喘。如因表邪不解,肺气阻遏化热,热为寒郁,则为外寒内热。如痰饮素盛之人,平日肺气宣畅,痰随唾出,一旦风寒外侵,

肺为寒郁，气阻痰壅，逆而为喘，则为外寒内饮之证。

风热温邪，由皮毛口鼻而入，首先犯肺，肺为热迫，肺壅气急，胸中气乱，则气逆喘急。若其人痰饮素盛，邪热与痰饮交阻，上迫于肺，则为热饮迫肺而喘。若因风燥犯肺，燥从火化，或风热感冒误于发汗，津液重伤，肺燥化火，燥火壅迫，清肃失职，则为肺燥气逆而喘。

由此可见，外因实喘多为四时感冒的并发病证，其病机与外感咳嗽大致相同，咳由肺气不宁，其证轻；喘为肺气壅迫，其证重。

（二）内伤虚喘

导致虚喘的原因有多种方面，据临床所见，大多因于初患喘咳失治，邪留肺络，成为慢性。又以久病咳嗽，咳伤气阴，肺之气阴亏损，不能下荫于肾，肾之气阴日虚，则肺气失于摄纳，于是呼多吸少，虚逆而喘。所以虚喘一证，主要责之肺肾，或以肺虚少气，不足以息；或以肺肾同虚，呼吸出纳失于常度。

肺主气，肺为水津之上源，肺气宣畅，气以布津，津以养肺，一呼一吸，出纳平匀。如因久患咳嗽，或伤害肺气，或损耗肺津，气虚则肺无所主，津亏则肺燥失润，是以久咳则肺虚而日渐出现短气喘促。又因土为金母，脾乃后天生气之源；肺脉与心脉相通，肺为百脉朝会之脏。肺虚以后，或以子夺母气，累及于脾；或以肺病及心，心肺同虚。反过来说，脾虚土不生金，亦能累及于肺，肺气随虚；心虚累及于肺，也能导致心肺同病。总之，脾虚或心虚皆以肺虚为致喘之本。故《证治准绳》说：“肺虚则少气而喘。”

肾虚之喘，多以肺虚日久，累及于肾，或大病久病之后，重伤肾气，因而发病。肾为水火之脏，藏精而寓元阳，肺肾精气交通，肾气健全，阴精固密，阴以敛阳，阳以摄阴，精气上承，资助呼吸。肺虚日久，气阴不能下荫于肾，或肝肾亏虚，精气不能上承于肺，气虚则肺气无根，精虚则气失摄纳，根本不固，肺肾同虚。于是阴阳不相接续，虚气奔逆而喘。故《证治准绳》说：“真元耗损，喘生于肾气之上奔。”又因肾中命火有温生脾土职能，肾中阴精又以上济心火为常态，所以肾虚之喘，也往往伴随心、脾病变。

由此可见，内因虚喘多为慢性喘咳的继发病变，其病机演变大致与内伤咳嗽相同。久咳伤肺可令肺虚致喘，肺虚日久便能导致肺肾同虚，肺虚为轻，肾虚为重。

二、辨证施治

张景岳指出：“气喘之证，最为危候，治失其要，鲜不误人，欲辨之者，亦惟二证：一曰虚喘，一曰实喘，此二证相反，不可误也。然则何以辨之？盖实喘者有邪，邪气实也；虚喘者无邪，元气虚也。”其说扼要，堪为喘证辨证纲领。

（一）实喘

实喘的表现，病势急骤，呼吸气涌，气长有余，声高息粗，胸胁胀满，日夜不休，一般伴有恶寒发热表证，脉多数而有力。其治在肺，以散邪利气为原则，依据风寒、邪热、燥火不同辨证，分别采用散寒宣肺、疏泄肺热、清

火润燥等治法。感邪有轻重，病重药轻，其喘难平，病轻药重，易伤肺气。表邪未解，忌用收涩方药，防留邪助喘；燥火喘咳，虽有表邪，不可发汗，虽有二便短涩，慎用通下利尿，恐重伤津液，反致肺燥愈深。凡用发散重剂，可令肺气暂虚，必须慎避风寒，否则不仅易于反复，还可因肺虚邪留，由实转虚，成为慢性虚喘。又因实喘多喘咳并见，喘平而咳未止者，宜从外感咳嗽论治。

1. 风寒

主证：喘急胸闷，伴有咳嗽，咳痰色白清稀，鼻流清涕，头身酸痛，恶寒无汗，口不渴，舌苔薄白，脉浮紧。

兼喘急气逆，咳痰黄稠，小便短黄，舌质红，苔薄黄，脉浮数，为风寒在表，肺内郁热。

兼喘咳胸满，痰涎涌盛，量多而稀，不得平卧，舌苔白滑，脉浮紧，为风寒外客，水饮内聚。

证析：重感风寒之邪，外而闭塞肌表，内而阻遏肺气。肌表不通，荣卫不畅，则见头身酸痛，恶寒无汗。肺气失宣，肺液郁而生痰，寒痰交阻，肺实气壅，故见鼻流清涕，喘急胸闷，咳痰清稀。口不渴，舌苔薄白，为寒未化热。脉浮紧，主风寒外束，邪在肺卫。若寒邪未解，肺气郁而化热，则成外寒内热。热为寒郁，煎熬肺液，故咳痰黄稠。痰热交阻，上壅于肺，则喘咳气急。肺失肃降，水道不清，则小便短黄。舌红苔黄，脉象浮数，主风寒外客，肺内郁热。若痰饮素盛之人，复因外感风寒，肺气闭塞，气阻痰涌，故见喘咳胸满，痰涎涌盛，量多而稀。水饮内聚，壅肺作喘，卧则尤甚，是以不得平卧。舌白滑，脉浮紧，均为寒饮交阻之证。

治法：散寒宣肺，平喘降逆。

主方：风寒喘咳，治宜宣肺散寒，用麻桂苏朴汤①；外寒内热，治宜清宣并用，用加减华盖散②；外寒内饮，治宜温散寒饮，用小青龙汤③。

风寒喘咳，主因在寒，寒邪解散，肺气宣畅，喘急自平，故无论挟热、挟饮皆以温散寒邪为第一要法。如着重清热不散其寒，往往徒伤肺气而致邪留肺络；或着重治饮不解其表，反致水饮停留，喘难平息。

2. 邪热

主证：喘逆气急，咳痰黄稠，恶风发热，出汗，胸中烦闷，口渴思饮，甚者壮热不退，气急鼻煽，舌红苔黄，脉浮数或洪数。

见喘急而面目微肿，身热恶风，咳嗽痰涌，量多而稀，不得平卧，烦闷尿少，舌质红，苔滑多津，脉滑数者，此属热饮迫肺。

见喘逆而干咳少痰，身热恶风，鼻燥口干，咽喉干痛，小便短少，大便干结，舌红少津，脉来急数者，此属燥火伤肺。

证析：时令邪热，侵犯卫肺，邪客于表，故恶风发热。热壅于肺，肺为热迫，故喘咳气急。热壅上焦，蒸迫津液外泄，故发热而汗出不解。肺中津液为热煎熬，故咳痰黄稠不利。邪热内盛，劫耗津液，故烦闷口渴。若热势太盛，便可因内热蒸腾而见壮热鼻煽。舌红苔黄，脉浮数或洪数，均由邪热内盛所致。如痰饮素盛之人，复为邪热所侵，热与饮交迫于肺，肺为热迫则喘急，水饮上泛则面肿。痰饮壅聚于肺，故见咳嗽痰涌，量多而稀。肺气不降，水道不

行,故见烦闷尿少。肺气壅阻,卧则呼吸难通,是以不得平卧。舌红苔滑,脉滑数,均主热饮内盛。如风燥犯肺,或风热误汗,津液耗伤,燥从火化,燥火迫肺,则成肺燥喘逆,干咳少痰。津不上润,则口鼻干燥;津不下润,则大便干结。若燥火太盛伤及肺络,还可出现咳血咯血。舌红少津,脉急数,皆为燥火内炽病证。

治法:清热降逆,泻肺平喘。

主方:风热喘咳,治宜清疏肺热,用翘荷石膏汤④加黄芩、桑白皮;热饮迫肺,治宜泻肺逐饮,用苏葶泻肺汤⑤;燥火犯肺,治宜清肺润燥,用桑杏知贝汤⑥。

肺热喘咳,主因在热,热去肺清,其喘自止,故无论挟饮、挟燥均以清泻肺热为第一要法。如着重治饮不泻其热,饮终难平;或着重治燥不清其火,津亦难回。又因热喘为患,往往兼有表邪,只宜轻疏,不可发汗,汗则津愈亏而热愈炽。

(二) 虚喘

虚喘的表现,病来徐缓,时轻时重,呼吸短促,气息难续,以得深长一息为快,劳动则喘促更甚,声音低怯,脉多微弱,或浮大而虚。治宜肺肾同治,以扶补精气为原则。依据肺、肾阴、阳偏虚不同辨证,或补阴为主兼顾其阳,或扶阳为主兼顾其阴。扶阳而不顾阴,必反害阴;补阴而不顾阳,必反滞阳。故虚喘多采用精、气同治的法则。气虚治宜甘温,慎用辛热,以防壮火食气、大热害阴;阳虚专事补火温阳,也能害阴而致喘促恶变。又因虚喘患者,每以偶感外邪发病,对邪实正虚者,仍以散邪为先,邪去才可进补,先与补虚则易留邪助喘。对喘发过久,外邪未

去,正气大虚者,也应依据邪正偏盛偏衰,或于散邪中酌加补虚,或于补虚中略加疏散,此属邪正兼顾、标本同治之法。大凡虚喘,虽有表邪,慎用麻黄,恐损耗肺气,愈虚其虚;阴虚之喘,虽见烦热,慎用寒凉,恐败伤阳气,由轻转重。

1. 肺虚

(1) 肺气虚

主证:喘促短气,咳痰清稀,咳声无力,语音低弱,畏风怯冷,动则自汗,面色苍白,舌白淡,脉缓弱。

兼喘而多痰,口淡食少,倦怠乏力,大便溏薄,舌白腻,脉沉缓,属肺脾气虚。

兼喘而惕惕心悸,心中空虚,舌质淡,脉迟缓,属肺心同虚。

证析:肺主气,肺为声音之门,气虚不能供应呼吸,故喘促短气,咳声无力,语音低弱。气虚不能布津,则津聚为痰而见咳痰清稀。气虚则腠理疏松,卫外不固,是以畏风怯冷,动则自汗。面色苍白,舌白淡,脉缓弱,皆属气虚病象。肺虚日久,可因子盗母气而致肺脾同虚。肺虚脾弱,津液不得输布,则痰壅肺络,故喘而多痰。脾阳不振,故口淡食少,倦怠便溏。舌白腻,脉沉缓,亦由肺脾气虚、中阳不运所致。肺脉与心脉相通,肺虚久而累及于心,则心肺同虚。心气不足,鼓运无力,故见喘而心悸,心中空虚,舌淡脉迟。

治法:益气敛肺,平喘止嗽。

主方:用苏杏参麦汤^⑦益气定喘,肺脾气虚佐以培土降痰,肺心同虚宜加强补气宁心方药。

(2) 肺阴虚

主证：喘促短气，喘则面红，咳痰不爽，口咽干燥，舌淡红少津，脉象弦细。

兼喘而脘腹痞闷，口舌干燥，大便干涩，舌红苔剥，脉沉弦细，属肺胃阴虚。

兼喘而心悸烦闷，心中似热如饥，舌红绛少苔，脉象细数，属肺心阴虚。

证析：喘咳日久，伤津耗液，因而气虚及阴，气阴两亏。气虚则呼吸短促，阴虚则肺燥气逆，故喘促短气与喘则面红伴随出现。肺燥失养，则见咳痰不爽；阴津不能上润，则见口咽干燥。舌淡红少津，脉弦细，均为阴虚病证。肺阴亏损无以下润胃肠，胃失润降，故脘腹痞塞满闷；肠道失润，故大便干涩难通；津不上润，故口干舌燥，舌红苔剥。脉沉弦细，亦属阴亏内燥之象。肺阴久亏累及于心，则肺心同虚。心阴不足，阴不敛阳，心阳偏胜，故喘而心悸烦闷，心中似热如饥。舌红绛少津，脉来细数，均属心阴亏虚证象。

治法：养阴润燥，平喘降逆。

主方：用百花枇杷膏^⑧加味以养阴定喘，肺胃阴虚佐以益胃生津，肺心同虚宜加强养血宁心方药。

2. 肾虚

(1) 肾气虚

主证：喘促气短，气不能续，动则出汗，喘息更甚，形体瘦弱，精神痿惫，面青肢冷，舌淡白，脉沉细。

兼喘促多痰，面肿足肿，小便短频，舌淡胖白腻，脉象沉弱，属肾阳已衰、水气泛逆。

证析：喘促日久，病深及肾，肺为气之主，肾为气之根，肾气已虚，肺无所主，故喘促气短，气不接续，动则喘甚。肺肾既虚，精气衰少，故形神衰惫。肺虚，卫外不固，故动则出汗。肾虚，精气不为温养于外，故面青肢冷。舌淡白，脉沉细，俱为精气衰少之象。气虚甚者便是阳虚，阳虚不能制水，水气不化，泛逆于肺则喘促多痰，淫溢于肌肤则面肿足肿。小便短频，舌淡白腻，脉沉弱，均属肾阳已衰病证。

治法：补肾纳气，平定喘逆。

主方：以参胡安肾汤^⑨为主方；肾阳已衰，方中佐以温阳行水之药。

(2) 肾阴虚

主证：喘促短气，喘则面赤，虚烦少寐，形体消瘦，口咽干燥，腰膝酸软，舌红淡嫩，脉沉细数。

兼喘而面浮足肿，身半以下常有冷感，小便频数，脉沉细尺弱，属阴阳两虚。

证析：肾阴亏虚，阴不敛阳，虚阳上逆，故喘则面赤。肾阴不能上济于心，心阳动扰，神舍不安，故心烦少寐。阴精不能上承，则口咽干燥；不能外润肌肤，则形体消瘦；筋骨失养，则腰膝酸软无力。舌红淡嫩，脉沉细数，均为肾阴虚亏病证。阴亏日久，精不化气，则肾阳同虚。肾阳衰弱，下焦虚寒，故身半以下常有冷感。下焦阳虚，水气不化，泛逆于上则面浮，流注于下则足肿，水气不摄则小便频数。脉沉细尺弱，亦属阴阳两虚证象。

治法：滋肾敛肺，纳气定喘。

主方：以麦味地黄汤^⑩为主方；阴阳两虚者，佐以温

阳补火之品，使阴回阳复，其喘可平。

总之，虚喘为精气内虚，肺肾出纳失常，病虽在肺，关系于肾。治肺而不顾肾，则气失摄纳，治肾而不顾肺，则气无所主。所以，治虚喘当以调补精气、肺肾同治为原则。

（三）预后

预后良好：脉浮滑有力，不急数，不短涩，喘急虽甚，其病易治（《时方妙用》）。喘息重证，见脉滑而手足温者，为正气不衰，易治（《脉经》）。正虚脉实兼缓者，可治；喘势虽急而脉势和缓者，可治（《医林绳墨》）。

预后不良：上气喘急，四肢逆冷，脉涩者，属正气衰败、虚阳厥脱（《中藏经》）。喘而出气不反，口如鱼口者，为肺气已绝（《中藏经》）。喘而肩息，面目浮肿，其脉大而无根，属肾阳衰败；若加下利，则为脾阳已崩，多不可治（《脉经》）。喘逆上气，脉虚数，身热不得卧者，属真阴衰败（《张氏医通》）。喘逆不休，汗出如油者，为阴阳虚脱（《顾氏医镜》）。证实脉虚兼数者，难治；喘势不急而脉势急促者，难治；喘势又急而脉势虚促者，不治；散乱者不治；歇止者不治（《医林绳墨》）。喘而烦躁无脉，耳冷神昏者，此为阴阳气血已脱（《沈氏尊生书》）。

三、方药化裁

1. 麻桂苏朴汤

麻黄6克 杏仁10克 桂枝10克 厚朴15克 苏子10

克 白前10克 橘皮10克 甘草3克

此方散寒平喘，消痰降逆。适用于重感风寒，喘咳气逆，胸闷痰稀，鼻塞身痛，恶寒无汗，舌薄白，脉浮紧者。方中麻黄、杏仁宣肺平喘；桂枝与麻黄配合，取其疏表散寒；佐苏子、厚朴、白前、橘皮、甘草以消痰利膈，理气降逆。凡服本方后，如得汗而喘咳未平，可于方中减去桂枝，加紫苑24克，使其轻疏肺气，平定喘咳。

2. 加减华盖散

麻黄6克 杏仁10克 黄芩15克 苏子12克 橘皮10克 甘草6克 桑白皮24克

此方为《局方》华盖散去茯苓加黄芩而成，具散寒宣肺，清热平喘作用。适用于外感风寒，肺内蕴热，证见喘咳气急，恶寒鼻塞，咳痰黄稠，口干尿黄，舌红苔黄，脉浮数者。方以麻黄、杏仁散寒平喘；桑白皮、黄芩清泄肺热；苏子、橘皮、甘草消痰利气。本方寒热两解，以用于表寒不甚者为宜。如见恶寒发热，身痛无汗，烦渴思饮，脉浮紧数者，此属寒热俱盛，可于方中加桂枝10克，生石膏30克，则具大青龙汤方意，其解表发汗、清热除烦之力俱强，可使得一汗而寒热皆清。

3. 小青龙汤（《伤寒论》）

麻黄6克 桂枝10克 白芍15克 干姜3克 法半夏12克 细辛3克 五味子3克 甘草3克

此方散寒逐饮，平喘治咳。适用于外感风寒，内停水饮，证见恶寒无汗，喘咳痰多而稀，舌白滑，脉浮紧者。方中麻黄、桂枝散寒解表，宣肺平喘；桂枝、白芍相伍以和荣卫；干姜、细辛、半夏温中逐饮；配五味子敛肺降

逆。张锡纯说：“小青龙是治外感痰喘之神方。”故本方治外寒内饮之喘咳确具卓效。

4. 翘荷石膏汤

方药见本章感冒篇第三方。加黄芩20克，桑白皮30克。

本方为辛凉解热重剂，加黄芩、桑白皮，更具清泄肺热、降逆定喘之功。作者常用于邪热袭肺，见壮热出汗，喘急鼻煽，烦渴引饮，脉洪大急数之证，其解热定喘之效甚优。

5. 苏葶泻肺汤

紫苏子12克 炒葶苈20克 桑白皮30克 地骨皮24克 大枣12克 甘草3克

此方泻肺消饮，降逆平喘。适用于热饮迫肺，证见喘咳痰涌，量多而稀，面目浮肿，身热恶风，烦闷尿少，舌红苔滑，脉滑数有力者。方中苏子辛润宣肺，下气消痰；葶苈、桑白皮逐饮行水；配地骨皮以助清泄肺热；佐大枣、甘草益胃和中，以防苦寒之品伤害正气。水去则痰消，气降则喘平。服药后，如热饮已退而喘咳未止者，去葶苈，加紫苑20克，枇杷叶30克，以止咳降逆。

6. 桑杏知贝汤

方药见本章咳嗽篇第四方。

本方清宣凉润，止咳降逆，用于风燥喘咳之证，甚为适宜。如见心烦口渴，为燥热内盛，加生石膏15克，麦门冬15克，清除燥热，以消致病之源。如见大便干结难通，加麻仁15克，郁李仁15克，以滋液通便。如见喘咳唾血，为燥热伤络，加炒阿胶10克，白茅根30克，以清润止血。

7. 苏杏参麦汤

紫苏子10克 杏仁10克 太子参24克 麦门冬15克
五味子6克 紫苑20克 橘皮10克 大枣12克 甘草3克

此方益气敛肺,化痰平喘。适用于久喘气虚,证见喘促短气,咳嗽痰稀,声音低弱,动则自汗,舌淡脉弱者。方中紫苏子、杏仁温宣肺气,降痰定喘;太子参、麦门冬、五味子益气敛肺,养阴生津;紫苑、橘皮止咳化痰;大枣、甘草和中益胃。是方补而不燥,敛而不滞,用治气虚痰喘,其效颇佳。

肺心同虚,兼见喘而胸闷心悸,脉迟缓或虚数者,加黄芪24克,丹参15克,远志6克,其补气宁心之力更优。

肺脾同虚,兼见喘而多痰,食少便溏者,加白术18克,茯苓20克,半夏12克,以增强补土降痰之力。

8. 百花枇杷膏

方药见本章咳嗽篇第七方。

本方滋阴润燥,宁嗽降逆,用治阴虚肺燥,喘咳痰少者,宜于方中再加五味子6克,更能敛肺生津,平定喘息。

肺胃阴亏,兼见口中干渴,加花粉18克,玉竹10克,以滋养肺胃,生津止渴。脘腹痞满者,加谷芽24克,枳壳10克,以和中消痞。大便干涩者,加麻仁20克,郁李仁20克,以润肠通便。

肺心同虚,兼见喘而心悸烦闷,加柏子仁、枣仁、丹参、五味子等品,以助滋阴养血,敛气宁心之力。

9. 参胡安肾汤

人参3克 胡桃肉6克 苏子10克 杏仁10克 山茱萸10克 五味子6克 补骨脂10克 益智仁10克 远志6克 山药18克

作煎剂，或加量制蜜丸常服。

此方补肾益肺，敛气平喘。适用于虚喘日久，肺肾气虚，喘促短气，气不上续，动则喘息出汗，小便频数或失禁者。方以人参补气，胡桃补肾敛气，为全方主药。苏子、杏仁温宣肺气，消痰降逆。补骨脂、益智仁补肾温阳。山茱萸、五味子滋肾敛肺。佐远志以祛痰利窍，配山药以运行药力。是方补敛兼施，具有补而不燥、敛而不滞之良功。方药量轻，取其缓补，以防碍痰助实。

若肾阳已虚，见喘而多痰，面肿足肿，肢冷尿频者，方中加入白术18克，茯苓24克，制附片15克，以温肾健脾运化水湿。

凡用本方得效后，可加量制为蜜丸常服。如于方中再加蛤蚧1对（去头足研细配制蜜丸服），其补肺益肾纳气定喘之效更佳。

10. 麦味地黄汤（即“八仙长寿丸”《医级》方）

熟地黄12克 丹皮10克 山药15克 茯苓15克 泽泻10克 山茱萸10克 麦门冬15克 五味子6克

此方滋肾敛肺，纳气平喘。适用于虚喘日久，肺肾阴亏，喘而面红，虚烦少寐，口咽干燥，脉沉细数者。方用六味地黄汤滋补肾阴，麦冬润肺生津，五味滋肾敛肺。津回则肺润，气敛则喘平，故本方以治肾虚喘嗽著名。

如肾阴大亏，不宜泄利，宜去泽泻，加枸杞10克，龟板20克，其滋阴潜阳之效尤佳。

如心阴兼虚，见喘而心悸虚烦者，再加酸枣仁12克，丹参12克，以助养血宁心之力。

如阴虚而兼气弱，见喘乏短气，气不接续者，可酌加

人参一味共收气阴两补之效。

如阴虚日久，阴损及阳，其证兼见面浮足肿者，属阴阳两虚。方中加肉桂3克，制附片10克，则具肾气丸方意，更能鼓舞肾气，协调阴阳，阴回阳复，水气自消。（表7）

表 7 喘证病因病机证治简表

	病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
实喘	重感风寒邪热，寒邪外束，肺气闭塞，呼吸不利而喘；邪热犯肺，肺为热迫，热壅气急而喘	风寒喘咳	宣肺散寒	麻桂苏朴汤
		外寒内热	散寒清肺	加减华盖散
		风寒挟饮	散寒化饮	小青龙汤
		邪热迫肺	清热降逆	翘荷石膏汤加味
		邪热挟饮	泻肺逐饮	苏葶泻肺汤
		燥火伤肺	清肺润燥	桑杏知贝汤
虚喘	久患咳喘，肺肾精气亏虚，气虚肺无所主，阴虚肺失润降，肺虚不能下荫于肾，久则肾之气阴日亏	肺 气 虚	益气定喘	苏杏参麦汤
		肺 阴 虚	滋阴降逆	百花枇杷膏加味
		肾 气 虚	补肾纳气	参胡安肾汤
		肾 阴 虚	滋肾敛肺	麦味地黄汤

第四节 哮 证

哮证一称哮喘，凡医籍所载喘喝、喘鸣、呬呀、哮吼等名称，皆属于本病。

哮多宿疾，是一种发作性的痰鸣气喘疾病，以呼吸急促，喉中痰鸣，声如曳锯为主证。由于哮与喘都有呼吸急促见证，但哮见喉中痰鸣，不似喘证仅见呼吸急促，故二

者有喘不兼哮、哮必兼喘的区分。

明代李修之《证治汇补》指出：“哮即痰喘之久而常发者，因内有壅塞之气，外有非时之感，膈有胶固之痰，三者相合，闭拒气道，搏击有声，发为哮病。”由此说明，哮多慢性宿疾，皆由初患痰喘失治，痰气交阻，潜留肺络，每以偶感外邪，或饮食、情志等因素引起发病。本病也有因于南北气候不相适应而发病的。亦有发病无因，婴孩即患者，古称为幼稚天哮。

一、病因病机

哮证皆由痰留肺络阻碍气道所引起，故朱丹溪说：“哮喘专主于痰。”形成痰留肺络的起因是多方面的，概括起来，有如下几方面：

（一）环境因素

或因地区气候多变，或因南北异地，人体不相适应，易为风寒或邪热所伤，肺为邪阻，津液不布，聚为痰浊，阻塞气道，发生哮喘。也有某些职业环境因素，如煤烟、尘埃、浊气等熏染日久，肺失宣畅，气阻液聚，渐结成痰，潜留肺络，随感辄发。

（二）饮食因素

嗜食酸、咸、糖、酒以及辛辣、肥甘、生冷过度，伤于脾气，聚湿生痰，上干于肺，留滞气道，一遇外邪，肺气闭塞，则气郁痰壅而发病。所以，何梦瑶《医碥》指出：

“食味酸咸太过，渗透气管，痰入结聚，一遇风寒，气郁痰壅即发。”古医籍所载“盐哮”、“酒哮”、“糖哮”、

“醋哮”等,就是以饮食因素引起的一类哮喘病证。

(三) 体质因素

或以禀赋不足,或以病后体虚,体虚气弱,一则气不布津,聚为痰浊,留滞气道;一则卫阳不固,易招外邪。肺为邪阻,痰气壅塞,发生哮喘。古称为幼稚天哮,亦多因于禀赋不足引起。

由此可知,本病以内有宿痰停聚为主因,而生痰之源实由肺、脾病变引起。痰由津液所化,津液来源于水谷,赖脾气转输上归于肺,得肺气敷布以养形体。如脾虚不能输化津液,便能聚湿为痰上贮于肺;肺气失宣,津液不得布化,也能聚液成痰停留肺络。痰贮于肺,一般情况下,尚可随咳吐唾,不足为患。如因感受外邪,或为饮食所伤,内外相因,肺为邪阻滋生新痰,新痰引动老痰,痰气交阻,壅塞气道,气为痰阻则喘急,痰随气动则哮鸣,痰气相击,哮喘发病。正如《证因脉治》所说:“哮病之因,痰饮留伏,结成窠臼,潜伏于内,偶有七情之犯,饮食之伤,或外感时令之风寒,束其肌表,则哮喘之证作矣。”本病常因反复发作,肺气日虚,更易遭受各种因素侵袭诱致发病,尤对气候的影响最为敏感。如果肺虚日久,高源化竭,难于下荫于肾,必致肾虚精亏而现肺、脾、肾俱虚的病变。如是即可出现经常轻度哮喘难以消失,当大发作时,则表现邪实正虚的证象。

二、辨证施治

哮喘发病,多以随感辄发,突然而起,或先感喉痒鼻

塞，胸中塞闷，继则呼吸不利，喉中痰鸣，甚者张口抬肩，声如曳锯，不能平卧，患者以能得畅利咳出痰涎为快。本病分寒哮、热哮两类：寒哮常遇寒辄发，每于冬春季节或偶感风寒而发病；热哮常遇热辄发，每于夏秋季节或偶触燥热而发病。一般说来，初病不久，正气未衰，属实证；病程日久，反复发作，正气已衰，属虚证。由于哮多宿疾，且因发作时痰气壅塞，多表现为实证，发作之后，大都形气现虚，故本病常出现虚实交替证象。

治哮以消痰理肺为主法，但当分别已发未发、标本缓急而施治。哮喘发作，当从急治，宜祛邪以治其标，发作之后，宜从缓治，应扶虚以治其本，这是治哮的基本原则。现据寒热虚实有邪无邪分别为治哮七法：（1）攻邪气：哮因痰生，而痰为致病之标，生痰之本则由肺中受邪，故凡感受风寒或邪热而发病的，都当以祛散邪气为首要治法。如果只知治痰不予祛邪，不仅痰不得治，哮亦无由平息。（2）清火热：肺内郁热，煎蒸肺液，凝聚成痰，反之，肺中宿痰，蕴遏日久，亦能化热，痰热交阻，痰因火动，则发哮病。对此，欲去其痰，当先清热，热去则气可降而痰可平，故热哮当以清热为先。（3）温寒痰：寒痰的形成，一由寒邪入肺，一由肺脾气虚。痰因寒生，非温不化，痰由湿聚，温则易行。治寒哮用温法要区别有邪无邪，有邪以温散宣肺为先，无邪从温肺健脾论治。健脾则生痰之源可除，温肺则行痰之路自通。（4）消积痰：表邪已解，火热已清，体气不虚而积痰壅盛，大攻防伤气，温燥恐生热，对此则宜采取消导治法。消以散积，导以行滞，药宜和平，不宜猛烈，务使停积之痰，渐次消导而去。

避免痰郁久留而致哮喘再起。(5) 润燥痰：热哮病久，耗损肺阴，阴虚则肺燥，肺燥则痰结。燥痰内蕴，辛散既已不宜，温燥尤为所忌，偏清恐伤肺气，消导更耗阴津，只有采用甘寒润降方药，使肺得清平，燥痰可化。(6) 调虚实：哮证初起，因痰而成实，久则肺气渐虚，又可因虚而生痰。偏于温补则痰益固结，攻消太过则肺气愈虚，故对虚实互见者，要权衡虚实多少，采取调和治法。实多虚少，消痰为主，辅以扶虚；虚多痰盛，宜用寓补于攻法则。总以扶正而不碍痰，消痰而不害正为要法。(7) 扶正气：哮喘日久，正气必虚，正虚不能抵抗外邪，又易招致哮喘反复。对此，欲治其哮必先扶虚，正气恢复才能减少发病，使之逐渐治愈。所以，对体气大虚的患者，在邪去哮平以后，应当采取平时进补治法。惟哮证之虚常与痰气之实交并出现，纯补恐碍痰，消痰以伤害气，故平时进补的方药，也要注意补虚勿忘实、行实当顾虚。总之，治哮在于善治其痰，治痰在于善治致痰之本，舍本求末，则难获效。

此外，对一些药医罔效的顽固哮证，还可选择如下治疗方法：(1) 对南北气候不相适应者，可采取南北异地调治。(2) 哮证冬春易发者，可于夏秋预为治疗；夏秋易发者，可于冬春预为治疗。(3) 其诱发因素确与某些食物、物质、或职业环境有关者，应注意避免。实践中采用上述方法，往往收到满意效果。

(一) 寒哮

主证：呼吸急促，喉中哮鸣，咳出清稀白色痰涎，胸膈满闷如塞，面色晦暗，口不渴，或渴欲热饮，舌苔白滑，脉象浮滑。

兼头痛鼻塞,恶寒无汗,脉象浮紧者,属外感寒邪、寒痰壅肺。

兼哮喘短气,语声无力,动则自汗,面色苍白,舌质淡,苔白腻,脉缓弱者,属肺气偏虚;若再兼喘而心中空虚,惕惕动悸,脉缓弱而结、或虚数而促者,属肺心同虚。皆由寒哮日久,内伤阳气所致。

证析:寒痰壅肺,阻碍气道,故呼吸急促,喉中哮喘。浊痰留滞,胸阳不宣,故胸膈满闷如塞。咳痰色白清稀,口不渴,或喜热饮,面色晦暗,苔白滑,脉浮滑,皆为寒痰壅肺病象。寒为阴邪,遇寒辄发,兼头痛鼻塞、恶寒无汗、脉浮紧等表证者,属风寒外束、寒痰内壅、表里俱寒之证。寒性伤阳,寒哮病久,耗伤肺气,气虚则喘促短气,语声无力;气虚则表卫不固,动则自汗;气虚不为荣泽肌肤,则面色苍白。舌质淡,苔白腻,脉缓弱,均为肺气已虚。如肺虚日久累及于心,心虚不能自主,则见喘而心中空虚,惕惕动悸。脉来缓弱而结、或虚数而促,皆为心气不足之证。

治法:消痰散寒,理肺降逆。

主方:寒哮发病,初起偏实,属寒痰壅肺者,治宜温寒利气、消痰降逆,用三子降气汤^①;属表里俱寒者,治宜温肺散寒、豁痰利气,用小青龙汤^②。对病久气虚者,治宜豁痰理肺、益气养心,用参苏理肺汤^③随证化裁。在发作期间,亦可采用温灸肺俞、大椎、中脘等穴,以助温肺祛邪之力。

(二) 热哮

主证:呼吸急促,喉中痰鸣,声高气粗,胸膈满闷,

咳痰黄稠,吐唾不利,心烦面红,口渴喜饮,舌质红,苔黄腻,脉滑数。

兼头痛恶风,发热有汗,脉浮数者,属外感邪热、痰热交阻。

兼哮喘面红,阵作呛咳,咳痰胶粘,不易咳出,或咳带血丝,口咽干燥,舌红绛少津,脉弦细数者,为肺阴已亏;若再兼喘而虚烦心悸,心中似热如饥,脉细数或结者,属肺心同虚。皆由热哮病久,内伤营阴所致。

证析:痰随火动,气为痰阻,壅滞胸中,故见喘急哮喘,声高息粗,胸膈满闷。热蒸痰稠,故咳痰黄粘,吐唾不利。火热内蒸,故心烦面红。热伤津液,故口渴喜饮。舌质红,苔黄腻,脉滑数,均为痰热内盛病证。热为阳邪,遇热辄发,故热哮于夏秋炎热季节易于发病。如因感受邪热触发,即可兼见头痛恶风、发热出汗、脉浮数等表证。热性伤阴,热哮病久,耗伤肺阴,阴虚则肺燥,肺燥则痰结,故气逆呛咳,咳痰困难,甚或燥热伤络而见咳带血丝。口咽干燥,舌红绛少津,脉弦细数,均为肺阴亏损、津不上承之象。如肺阴亏损累及于心,阴虚不能养心,心阳独亢,故喘而虚烦心悸,心中似热如饥。脉细数或结,皆由心营失养所致。

治法:清肺散邪,利气化痰。

主方:热哮发病,初起偏实,属热痰壅肺者,治宜清肺泻热、豁痰降逆,用苏杏降痰汤^④;属邪热交阻者,治宜清肺散邪、化痰平喘,用加减华盖散^⑤加味。对病久阴虚者,治宜养阴润燥、利气化痰,用百花枇杷膏^⑥随证化裁。

大凡哮喘时发，正气必虚，俟其哮喘平息之后，当采取平时调补从本图治。治疗以补益精气、消化积痰为主，可用河车丸⑦方，根据气、阴偏虚的不同加减化裁，制作丸剂常服，使其减少复发，以期全愈。

三、方药化裁

1. 三子降气汤

紫苏子12克 白芥子10克 炒莱菔子10克 法半夏15克 橘皮10克 茯苓24克 前胡10克 紫苑24克 甘草6克

此方以养亲汤合二陈汤加味组成，功能温宣肺气，消痰降逆。适用于痰气壅塞，喘急哮喘，咳痰涌盛，量多清稀，胸闷如塞，苔白滑，脉浮滑，无热证病象者。方中紫苏子、白芥子、炒莱菔子宣肺利膈，重在温降寒痰，以治其标。

“二陈”燥痰理气，重在和中去湿，以治其本。佐前胡宣通肺气，配紫苑化痰止咳。故本方用于寒哮喘发作，痰气壅盛之证，具有温逐寒痰，标本同治之效。

如痰气壅滞，胸闷不爽甚者，可加胆南星6克，其燥湿祛痰力量更强。

2. 小青龙汤

方药见本章喘证篇第三方。

本方散寒化饮，善治外感痰喘，故用于寒哮喘因感受风寒触发，表现表里俱寒见证者，最为适宜。如服药后，表解而痰气未平，可继用三子降气汤消痰降逆。

3. 参苏理肺汤

人参3克 紫苏叶6克 杏仁6克 五味子6克 法半夏10克 橘皮10克 茯苓15克 白术15克 紫苑15克 甘草3克

此方益气宣肺，温降寒痰。适用于寒哮病久，哮鸣短气，痰多而稀，喘乏心悸，舌淡苔腻，脉象缓弱，肺心气虚者。全方以人参、紫苏作为主药。哮因痰起，紫苏、杏仁、半夏、橘皮、紫苑辛散温通，宣肺以行其痰。痰由湿聚，人参、白术、茯苓、甘草益气和中，健脾以去其湿。紫苏配五味子，散中有收，防其消痰耗气；人参配五味子，补虚敛肺，功能定喘止悸。脾气健，肺气通，补虚不碍痰，消痰不害气，痰消湿去，哮喘得以渐平。

兼食少便溏者，属肺脾同虚，可加砂仁6克，肉桂3克，以助温脾醒胃之力。

兼喘而心悸不已，动则自汗者，属心气大虚、表卫不固，加黄芪24克，酸枣仁10克，丹参15克，其补气宁心功效更佳。

4. 苏杏降痰汤

方药见本章咳嗽篇第六方。

本方清热豁痰，泻肺降逆。适用于热哮发作，痰热交阻，证见哮鸣喘急，胸膈满闷，咳痰黄稠不利，舌质红，苔黄腻，脉滑数者。

如热痰壅迫，气盛喘急者，加炒葶苈18克，以增强泻肺逐痰。如咳痰粘稠，吐唾困难者，宜酌加川贝母、竹沥，以化痰散结。

5. 加减华盖散

方药见本章喘证篇第二方。

本方清肺散邪，化痰平喘。适用于热哮发作，外有表邪，证见喘急痰鸣，头痛恶风，发热出汗，咳痰黄稠，口干尿黄，舌质红，苔黄腻，脉浮数者。本方表里两解，以邪热不甚者为宜。如见壮热喘急，心烦口渴，此属邪热内盛，应于方中加生石膏30克，以宣散肺邪，清泻肺热。如热痰壅盛，或见咽喉肿痛者，加射干20克，以消痰降逆，清利咽喉。如邪去热解，痰喘未平，宜继用苏杏降痰汤调理。

6. 百花枇杷膏

方药见本章咳嗽篇第七方。

本方养阴润燥，化痰降逆。适用于热哮病久，肺阴已亏，证见哮鸣呛咳，咳痰胶粘，或咳带血丝，口咽干燥，舌红绛，苔花剥，脉细数者。本方甘淡凉润，善于润化燥痰，且无碍脾害肺之弊。

口咽干燥甚者，加天花粉18克，玉竹10克，以养胃生津。呛咳痰粘，吐唾困难者，加苏子10克，马兜铃10克，以利痰降逆。咳带血丝者，加黄芩15克，炒阿胶10克，以清肺止血。如肺心同虚，见喘乏短气，虚烦心悸者，加人参、五味子、丹参、酸枣仁等益气宁心之品。

7. 河车丸

紫河车粉60克 人参30克 紫苏子30克 川贝母30克 茯苓30克 麝香0.3克

上药共研细末，和匀，加蜜制丸剂，每丸重3克，每服1丸，日2次，早晚空胃送服。

此为哮喘虚证平时调补方剂，功能补益精气，润化积痰。适用于哮喘久病，精气亏虚，随感辄发者。方中紫河

车补养精血，人参益气生津，相辅为用，补益精气，扶虚以治其本。紫苏子辛润宣降，川贝母清润化痰，互为配合，消痰以治其标。茯苓健脾补中，既可化饮去湿，又能运行药力。以微量之麝香为佐，使其引导诸药活络开窍，以去壅滞之痰。合而用之，补而不燥，润而不滞，协调虚实，标本兼顾。本方药性和平，精气两补，气虚或阴虚者，均可采用。对气、阴偏亏之证，亦可选用参苏理肺汤、百花枇杷膏配合进服，以加强益气、养阴的疗效。（表8）

表 8 哮喘病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证		治 则	方 药
多因于初病失治，痰留肺络，每以感受风寒邪热，肺为邪阻滋生新痰，新痰引动老痰，痰气交阻，壅塞气道，气为痰阻则喘急，痰随气动则哮喘，痰气相击，哮喘发病	寒哮喘	寒痰壅肺	温寒利气 消痰降逆	三子降气汤
		表里俱寒	温肺散寒 化痰利气	小青龙汤
		肺气内虚	豁痰理肺 益气宁心	参苏理肺汤
	热哮喘	热痰壅肺	清热泻肺 豁痰降逆	苏杏降痰汤
		邪热交阻	清肺散邪 化痰平喘	加减华盖散加味
		肺阴亏虚	养阴润燥 利气化痰	百花枇杷膏加味
	平时调补	补益精气 润化积痰		河车丸

结 语

感冒、咳嗽、喘证、哮证是临床上最为多见的病证，根据此类病证的病机关系和证候特点，可区别为外感、内伤两个大类。

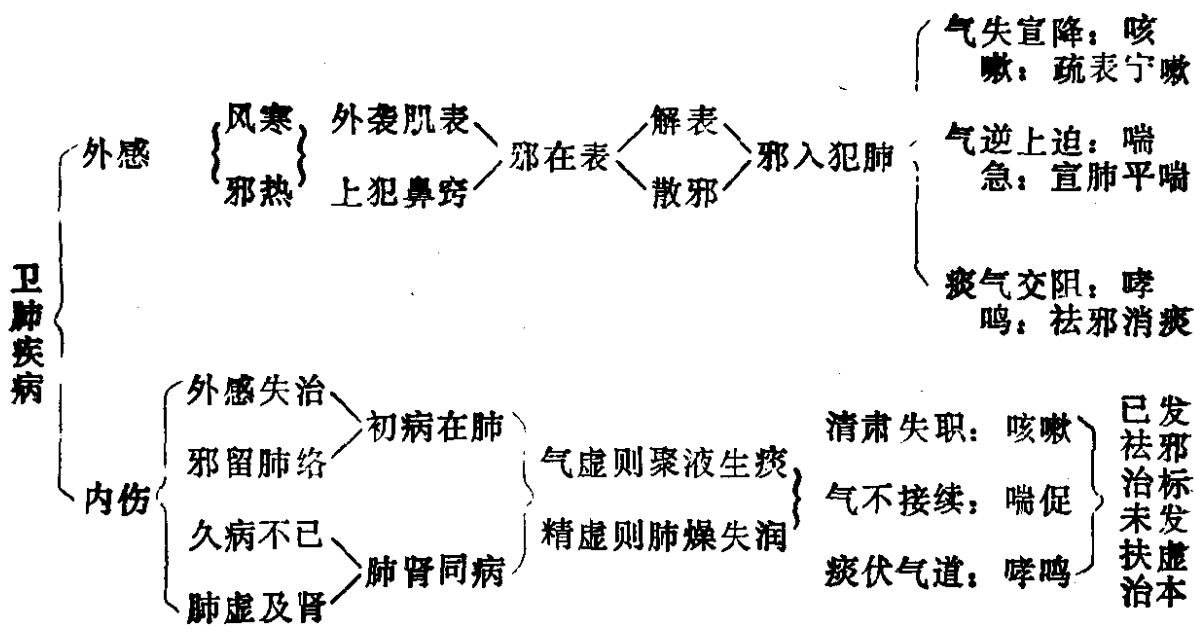
外感病以风寒、风热为两大主因。感受外邪，初起邪犯皮毛，病在表卫，即为感冒，如因感伤过重，卫肺俱伤，轻者并发咳嗽，重则为喘、为哮。因此，本章所论外感诸证，实则同出一病，只有在卫在肺之分。病在卫分，表现表证，兼咳、兼喘、兼哮则属卫肺同病。正因病机相同，故俱以寒、热为纲作为辨证纲领。外感病俱为邪实，以表证为主证，以解表宣肺为原则。病在表卫，肺未受邪，发散解表为先，应随证选用感冒病中各类发汗治法。若兼咳、兼喘、兼哮则为肺已受邪，偏于发散则伤肺，偏于治咳治喘治哮则留邪。对此，必须权衡轻重，针对病情，分别采用宣肺宁嗽、发散平喘、祛邪消痰等卫肺同治诸法。

内伤咳、喘、哮证，虽然可由多种因素形成，其间因外感新病失于治疗，以致邪留肺络转为慢性者，是最为多见的。由于肺与肾精气相通，久病不已，必渐伤肾，故慢性咳喘哮证的演变，常以由肺及肾为规律。即是说，此类疾病在病程中，虽可出现心、脾病变，但其病位主要在肺而关系及肾。所以，此类病证着重分辨气虚与精虚、肺虚与肺肾同虚。又因肺部疾患，易为外感诱发，故治疗上多采取平时补虚以治其本，发病时祛邪以治其标的原则。

(表9)

表 9

卫肺疾病病机简表



100-443887-1000

第二章

肺系疾病

本章重点论述肺癆、肺痿、肺痛、失音四个病证。癆虫传染，侵蚀肺部，病为肺癆。久患咳嗽，损伤肺气，肺叶痿弱，病为肺痿。风热邪毒，壅聚于肺，血脉瘀腐成脓，病为肺痛。喉咙是肺气出入的道路，属于肺系组织，肺主气，声音由气而发，故失音亦属肺系疾病。

第一节 肺 癆

肺癆古称癆瘵，又称传尸、尸注、瘵疾。这是一种具有传染性的慢性虚弱疾病，临床表现以形体消瘦、咳嗽痰血、潮热盗汗为主要特征。

本病起因于癆虫传染，好发于肺部，所以宋代《本事方》说：“肺虫居肺叶之内，蚀人肺系，故成瘵疾。”且因虫毒流窜传播，还能出

现许多兼并证候。如流窜于颈部经络,则成颈下瘰癧;侵蚀于骨髓,则成骨癆疽疮;下注于肠道,则见腹中结块,病为肠鸣泄泻。此即《金匱要略·虚劳篇》所说:“肠鸣、马刀、侠癭者,皆为劳得之。”唐代《外台秘要》引《崔氏别录》亦说:“其为状也,……或腹中有块,或脑后近下两边有小结,多者乃至五六。”宋代《济生方》也指出:“癆虫蚀人骨髓。”由此说明,早在汉、唐时期已认识到本病的传染性和在体内传播所发生的种种病变。

一、病因病机

肺癆发病的因素有二:一为外因癆虫传染,侵袭肺部,损伤肺络;一为内因气血虚弱,正不胜邪,虫毒滋生。二者互相为因,导致发病。

(一) 癆虫传染

《医学正传》指出:“侍奉亲密,同气连枝,熏淘日久,受其恶气,多遭传染,名曰传尸。”由此可知,凡与肺癆患者朝夕相处,共进饮食,或问病、看护接触其衣物用具,都是导致传染的因素。

(二) 气血虚弱

举凡禀赋薄弱,平素生活不节,或忧思劳倦过度,气血虚弱,正不胜邪,最易感染发病。如《中藏经》说:“传尸者,非一门相染而成也。人之气血衰弱,脏腑羸虚,辄此病死之气,染而成疾。”由此又可说明,外因仅是传染因素,内因才是导致发病的关键。临床上许多经过感染,由于正气强盛不发生证状而自愈者,确不少见。所以,徐

春圃《古今医统》有“凡人平素保养元气,爱惜精血,瘵不可得而传”的论述。

本病的病机演变,概要言之,以癆热耗阴为病变特点,以咳嗽、咳血、潮热、盗汗四大主证为临床特征。其病变过程可分三个阶段:

1.癆虫犯肺阶段 癆虫多从口鼻而入侵犯肺部,虫毒滋生,蛀蚀津血,化生毒热。津伤则肺燥,肺热则清肃失司,故肺癆初起多表现阴虚肺热病变。阴虚肺燥,则现咳嗽气逆;癆热内蒸,则现手足潮热;肺络损伤,则现咳嗽带血;津血日亏,则现形体消瘦。所以,临床上如见患者持续出现微有咳嗽,偶或咳带血丝,每于午后手足潮热,掌心尤甚,形体渐次消瘦等证状者,便是肺癆的初期见证。

2.肺肾阴虚阶段 肾为藏精之脏,肺为水精上源,癆热持续,肺阴日亏,肺阴不能下荫于肾,肾失资源,是以肺癆进一步发展,便可出现肺肾阴虚的局面。病程进入这一阶段,一因肺燥火炽,咳嗽加剧,咳血日增,肺损愈甚。一因肾阴虚亏,不能抗制癆热,火热内盛,则见骨中蒸热,睡中盗汗。一因阴亏日深,肌肤失养,形体愈渐消瘦。此属病程中期,病情日见加重,而以咳血加剧、骨蒸盗汗、体瘦日甚为主要病证。

3.阴损及阳阶段 肾为元阴元阳之本,津、液、精、髓受藏于肾,肾精充沛则精化为气。癆热内蒸,先伤津血,渐耗精髓,精亏则生气之源日惫,从而导致阴损及阳病变。这一阶段,由于肺肾阴虚逐渐加深,表现出咳声干槁,咳血频作,骨蒸盗汗,肤发枯燥,形体羸瘦,女子则经少经闭,并兼见一系列气虚证候。气虚的演变,亦以由肺由脾

以及于肾而为规律。肺气虚，不能供应呼吸，则喘促短气；不能固护表卫，则自汗怯冷。胃主纳食，脾主运化，胃虚则口淡食少，脾虚则腹满便溏，脾胃气虚不能温充肢末，则四肢怠惰，手足不温。肾气虚，封藏不固，表现遗精，甚则相火衰微而现阳痿。如气虚已甚则见阳虚，阳虚不能制水，水气泛溢，必现面浮足肿。在此精气交亏的情况下，可因五脏互为传变而致病情日趋衰竭。凡此皆属晚期重证，以形体羸瘦、自汗盗汗并见为主证。由此说明，本病以癆热耗阴为主要特点，其始损耗津血，病在于肺；继则阴虚火旺，肺肾同病；终于精血大亏，阴损及阳，阴阳两虚。但始终以阴虚为其主证。

二、辨证施治

本病的病程经过，一般分初、中、末三个阶段，初期表现为阴虚肺热，中期表现为阴虚火旺，末期多表现为阴虚气弱。其临床证候以咳嗽、咳血、潮热、盗汗为本病的四大主证，可随病情轻重、先后或合并出现于各个阶段。所以，这些主证就成为各个阶段的辨证中心。又因本病感受虫毒的轻重和人体气血盛衰的差异，其证候表现亦多不相一致。有起病缓慢逐渐加剧者，有发病急骤很快恶化者，病重者诸证俱见，病轻者诸证不必悉具。有素体气虚，起病即见气阴亏虚者；阴虚之人，罹患本病往往发展很快。因此，首先辨别其主要脉证的临床表现，对于诊断本病的轻重良恶，是十分重要的。

（一）潮热

潮热一般起于日午以后,至夜半左右,盗汗一出,其热自退。只觉手足心热者,属于微热;见全身骨蒸烦热者,属于壮热。初起热微,或微热持续时间较长,此属病轻;起病即现壮热,或壮热持续时间较久,此属病重。微热转壮热,乃病情加剧;壮热转微热,乃病情缓和。每日潮热时间逐渐缩短,为病势减轻转愈;病久出现潮热终日不退,属病情恶化,真阴亏竭。

(二) 咳嗽

肺癆咳嗽以咳而吐唾少量粘痰为多见。咳喘气急,咳痰黄稠,属肺热偏盛。咳而喘促短气,声低息微,属肺气已虚。咳嗽日久,常吐硬块痰子,多主肺损已深。久咳而见干咳无痰,常为真阴亏竭。咳嗽不除,每为导致出血的因素。

(三) 咳血

肺癆咳痰带血以量少色鲜为特点,咳出大量鲜血者极少见。咳血是否易止,每与潮热进退关系密切。咳血无热,或有热而见逐渐轻减,咳血虽甚,易于制止。反之,咳血而见潮热不减,血虽已止,亦易反复。

(四) 盗汗

盗汗与潮热常伴随出现,是以热微汗微、热甚汗甚。有热汗少,此属正气恢复,病势好转。潮热虽退而盗汗不除,此属正气虚衰,表卫不固。病久出现盗汗淋漓大出,多属精气已亏,应防亡阳虚脱。

(五) 脉象

肺癆之脉,以弦而略数为常见。兼芤为血虚;数大为阴虚火旺。洪数变细数,为真阴渐亏。忽浮涩而数,忽浮

沉而缓,属虚火之脉,主身体衰竭。脉不上寸,肺气已虚;尺脉偏弱,肾虚已甚。数脉变缓,乃病势转愈之证。凡短数、弦急、数大无根、沉微伏绝,均为忌脉,主病情严重。

由此说明,肺癆病中的四大证候,其间又以潮热为诸证之主。潮热起于虫毒,阴虚起于内热,所以本病的治疗原则,一则杀虫以治其本,一则补虚以培其元。杀虫重在清火肃肺,补虚重在滋肾健脾,滋肾可以降火保肺,健脾可以保持精血化源。实践证明,举凡肺癆病人,如能保持脾胃健旺,其病虽重易于康复。反之,脾胃一虚,化源不充,则癆热日甚而肺损日深。所以,李中梓《医宗必读》有“补脾之药,尤要于保肺”之说。临床上必须以此作为准则,根据初中末不同阶段分别辨证论治。

(一) 阴虚肺热

主证:咳嗽痰少,胸中隐痛,咳血时作,痰中挟血,血色鲜红,如丝如缕,午后微有潮热,或但觉手足心热,口燥咽干,形体渐瘦,舌红苔少,脉象弦数。

证析:肺癆初期,癆热耗阴,其病在肺,是以表现阴虚肺热证候。阴虚则肺燥,肺热则气逆,故见咳嗽痰少。虫毒蚀肺,症伤肺络,故见胸中隐痛,咳痰挟血。血色鲜红,血如丝缕,正是肺癆咳血的常见特征。病在初期,毒热未甚,阴未大伤,故仅见午后微热,或但觉手足心热。口咽干燥,舌质红,脉弦数,均为阴虚肺热病象。此属初期轻证,以咳嗽、痰血、微热、体瘦为主证。

治法:养阴清肺,止咳杀虫。

主方:白枯连部汤^①。本方功能制癆保肺,止咳止血,

是一首治疗肺癆的专方。肺癆初起，体无大虚者，单以本方常服，颇能取得良好疗效。且药性平和，久服无害。

（二）阴虚火旺

主证：咳嗽加剧，咳痰量少，色黄稠粘，反复咳血，量多色鲜，混有痰沫，胸胁掣痛，壮热骨蒸，睡中盗汗，颧颊潮红，午后尤甚，心烦不寐，性躁易怒，体瘦日甚，男子可见梦遗，舌质红绛，或苔现花剥，脉弦细而数。

证析：肺癆进一步发展，热愈盛而阴愈亏，肺阴不能下荫于肾，肾阴亦亏，故出现阴虚火旺、肺肾同病的病变。在此阶段，一因肺燥火炽，肺损日深，清肃失司，是以咳血日增，咳嗽胸痛加剧。一因肾阴虚亏，不能抗制癆热，阴不配阳，相火偏亢，心肝失养。癆热内盛，故见壮热骨蒸。血中津液为内热蒸迫，故见睡中盗汗。虚火蒸腾于上，故颧颊潮红。阴虚不能上济于心，心阳动扰，神舍难安，故心烦不寐。阴虚无以涵养肝木，肝阳易动，故性躁善怒。阴亏无以约制相火，相火偏亢，扰动精关，故见夜梦遗精。阴亏已深，肌体失养，是以体瘦更甚。舌绛红，脉弦细数，皆为阴虚火旺之象。此为病势进入中期，属于重证，以骨蒸盗汗、体瘦日甚为主证。

治法：滋阴保肺，清火退蒸。

主方：以清骨散^②为主方随证化裁；咳血甚者，兼用十灰散^③凉血止血。蒸热减退，咳血稍止，宜继用白枯连部汤，以养阴清肺止咳止血。

（三）阴虚气弱

主证：咳嗽少痰，咳声干槁，或声嘶失音，咳血频作，潮热骨蒸，睡中盗汗，肤燥发枯，形体羸瘦，男子梦遗滑

精,女子经少经闭,舌光质红,脉细数而弱。

兼喘乏短气,声音低微,形寒怯冷,动则自汗,脉不上寸者,属肺气兼虚。

兼口淡食少,脘腹痞闷,大便溏薄,肢末清冷,舌白淡,脉沉细弱者,属脾气兼虚。

兼阳痿滑精,尿频不禁,面浮足肿,腿膝酸软,舌质嫩红,尺脉偏弱者,属肾气兼虚。

证析:本病继肺肾阴虚持续发展,由于咳血日久,气血耗散,癆热内蒸,精髓日枯,精血亏损则生气之源日惫,从而进入阴损及阳阶段。这一阶段,由于肺阴大亏,声喉失养,故咳声干槁,甚而声嘶失音。肺损已深,清肃无权,故咳嗽持续,咳血频作。更因骨蒸盗汗耗伤精血,故致形体羸瘦,肤燥发枯,甚至大肉脱尽。这是阴亏日深的一面。舌光质红为阴枯之象,脉细弱而数为气阴两衰之证。如肺气偏虚,气无所主,则见喘乏短气,声音低微;卫阳不固,则见形寒怯冷,动则自汗;肺气已虚,则脉不上寸。如脾气偏虚,运化失职,则为口淡食少,脘痞便溏;中焦气虚不能温充四肢,则为肢末清冷;舌白淡,脉沉细弱,均主脾虚气弱。如肾气偏虚,封藏不固则滑精;相火衰微则阳痿;精血不足,女子则见经少经闭。肾虚不能制水,故尿频不禁;水气泛溢,则见面浮足肿。精气亏虚,筋骨失养,是以腿膝酸软无力。舌嫩红,尺脉弱,均为下焦精气两虚之象。在此精气交亏情况下,往往脏腑间互为传变而致病情趋于恶化。此属晚期证候,常以自汗盗汗并见、形体极度羸瘦为主证。

治法:补虚制癆,培健脾胃。

主方：以拯劳保阴汤④为主方，依据肺、脾、肾偏虚轻重程度随证化裁。如癆热已退而形气衰弱者，可常用龙凤散及汤⑤调补，更能滋阴补血，益气健脾。

此外，本病如因虫毒流窜，还可并发颈部瘰癧，甚则溃烂成疮（此证亦多单独发病），以儿童和青少年为多见。正如《医宗金鉴·小儿无辜疳》所说，其证“颈项生疮，或项后有核如弹，按之转动，软而不疼。”对此，应投以杀虫解毒软坚散结之剂，可用加味消瘰丸⑥方。

总的来说，肺癆初起，正气未衰，重在杀虫，辅以清火；癆热偏旺，重在清火，辅以养阴；气阴两虚，宜于扶虚，尤重调理。在用药方面，治咳宜润降，不宜祛痰，如过用桔梗、贝母，往往耗阴伤肺易于动血。治骨蒸壮热，可用清火重剂，俟热减大半，则当改用养阴清火和平方药，以防伤害正气促使恶变。气虚可用温补，但药宜和平不宜刚燥，防止伤阴助热。约而言之，清火防害气，滋阴防困脾，补气防助热，杀虫防伤正，总以药饵和平，调理无间，为治癆准则。

三、方药化裁

1. 白枯连部汤

夏枯草30克 白芨24克 胡黄连12克 百部24克
百合15克 玄参15克 枇杷叶30克 山药20克

此方清火杀虫，止咳止血。适用于肺癆咳血，午后身热者。方中夏枯草为治癆要药，配以白芨敛阴止血，胡黄连清热消蒸，百部止咳杀虫。并辅以玄参解毒，百合润燥，

枇杷叶宁肺降逆，山药甘淡健脾以运行药力。癆热得清，肺气得守，咳血自止。

咳血为甚者，加藕节30克，炒阿胶10克，以加强止血效力。咳嗽为甚者，加马兜铃10克，以助清肺降逆之力。癆热已退者，去胡黄连，以防过清害气。

凡用本方，虽见咳血、潮热消退仍须继续治疗以防反复。如欲服用方便，可将方中夏枯草、玄参、枇杷叶三味煎汤浓缩成膏，余药研为粉末，加入药膏混匀，再加适量白蜜制为丸剂，每丸重3克，每服1丸，日服2~3次，务以病情稳定为度。惟方中白芨宜另研粉末，配合丸剂冲服，取效较好，一般每服1丸，配白芨粉0.3克即可。

2. 清骨散（《证治准绳》）

银柴胡10克 胡黄连12克 秦艽15克 鳖甲24克
地骨皮24克 青蒿24克 知母20克 甘草6克

此为清火退蒸重剂，以治阴虚癆热擅长。适用于肺癆壮热，骨蒸盗汗，唇赤颧红，心烦体瘦，舌质红绛，脉弦细数者。方以银柴胡、秦艽清解虚热；胡黄连、地骨皮、青蒿合配，其清热消蒸之力颇强。辅以鳖甲、知母滋阴潜阳，以除烦热；甘草和中以养胃气。惟本方重在清火退蒸，其养阴生津作用似嫌不足，用时可酌加麦门冬、天门冬、生地黄等品。

咳嗽为甚，加马兜铃10克，枇杷叶30克，以泻肺降逆。咳血时作者，加白芨24克，藕节30克，以保肺止血。盗汗为甚，加五味子10克，浮小麦30克，以敛阴止汗。食欲欠佳者，加山药20克，炒谷芽24克，以健脾开胃。

由于本方清火之力颇强，过用亦易伤害胃气，俟其热

减大半,可改用白枯连部汤清火平剂,以巩固疗效,稳定病情。

3. 十灰散 (《十药神书》)

大蓟 小蓟 荷叶 侧柏叶 茅根 茜草根 大黄山梔 棕榈皮 牡丹皮

上药各等分,各烧灰存性,研为细粉,每服10克,用鲜藕或鲜萝卜捣汁,加水调服。

此方集凉血止血清降之品于一方,且诸药烧灰存性更具收敛止血功能,故凡因火热迫肺以致咳血、咯血、呕血诸证,其清火降逆、凉血止血作用颇为得力。肺癆各阶段,如虚火过旺,咳血太甚,便可兼用本方以遏其势。然此方究为治标之法,不宜久服,俟咳血稍止,仍应审其证情以图治本。

4. 拯劳保阴汤

黄芪20克 明沙参15克 白术10克 茯苓10克 天门冬10克 麦门冬10克 五味子6克 丹参10克 生地黄10克 白芍10克 胡黄连10克 银柴胡6克 地骨皮15克 大枣10克 甘草3克

此方益气养荣,清补兼施。适用于肺癆久病,阴虚气弱,证见潮热骨蒸,自汗盗汗,咳喘短气,倦怠少食,形体消瘦,肤发干枯,舌光质红,脉细弱而数者。方以沙参、黄芪、茯苓、白术益气健脾,扶补精血之化源;天门冬、麦门冬、白芍、生地黄、五味子、丹参生津养血,补充已亏之阴液;银柴胡、胡黄连、地骨皮清火制癆,以消郁蒸之内热。一清一补,目的在于补虚保阴扶正制癆,故以拯癆保阴立名。是方药量轻用,取其轻清缓补,防止过清伤

正、重补助邪之弊。

见自汗盗汗甚者，属肺气偏虚，表卫不固，加重黄芪量为30克，再加浮小麦30克，牡蛎20克，以固表敛汗。见食欲不振，脘痞便溏者，属脾虚胃弱，加枳壳10克，砂仁6克，鸡内金6克，以温中健脾，醒胃消痞。见尿频滑精者，属肾气偏虚，加枸杞10克，金樱子20克，以补益肝肾，固涩精关。

5. 龙凤散及汤

(1) 龙凤汤 子鸭1只（去毛取出肠杂） 鲤鱼1尾（500克，去鳞取出肠杂） 冬虫夏草15~30克

上方子鸭、鲤鱼一次只用其中一味，将虫草切细纳入其腹内，粗线缝合，用砂锅文火慢煨，炖至熟烂，去骨取其汤肉，随意食用。

(2) 参苓枳术散 人参10克 白术30克 茯苓30克 枳壳20克 砂仁（去壳）10克 鸡内金15克

上方药共研细粉，每服3克，日服2~3次，配合龙凤汤服用。

此方滋阴补血，益气健脾。适用于肺癆病人，癆热已退，咳血已止，体虚脾弱者。《随息居·饮食谱》说：“鸭甘凉，滋五脏之阴，清虚劳之热，补血行水，养胃生津。”鲤鱼性味甘平，亦具滋养脏腑、补益虚羸作用。因此，本方以子鸭、鲤鱼为主，取其清补养血。配以虫草滋肺阴、补肾气，更具气阴两补、肺肾同治功能。辅以参苓枳术散，使其益气健脾、开胃助食，共为功用以收补益气血之功。此方用作肺癆病人调补之剂，促其康复，其效甚佳。如因病情尚欠稳定，亦可用白枯连部汤丸剂配合治疗。

6. 加味消瘰丸

玄参15克 牡蛎15克 贝母10克 全瓜蒌10克 夏枯草30克 昆布15克 海藻15克 蒲公英20克 大枣12克

用上方3~5剂量,将方中玄参、大枣、夏枯草、蒲公英煎汤浓缩成膏,余药研细粉,将药粉与药膏混匀,加蜜制丸,每丸重3克,每服1~2丸,日服2~3次。

此方即《医学心悟》消瘰丸加味组成。方中皆善治瘰癧之品,具清热解毒,软坚消结作用。凡颈下瘰癧,都可用本方主治;如已破溃,则应配合外科治疗。(表10)

表10

肺癆病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
癆虫传染,侵犯肺部,蛀蚀津血,化生癆热,初起损耗肺阴,继而肺肾同虚,久则阴损及阳,精气交亏。甚者互为传变,发生颈下瘰癧、骨癆疽疮、腹中结块等证	阴虚肺热	养阴清火 止咳杀虫	白枯连部汤
	阴虚火旺	清火退蒸 凉血止血	清骨散十灰散
	阴虚气弱	补虚制癆 培健脾胃	拯劳保阴汤
	颈下瘰癧	清火解毒 软坚散结	加味消瘰丸
	平时调补	滋阴补血 益气健脾	龙凤散及汤

第二节 肺 痿

肺痿一病,始见于《金匱要略》,因于肺叶痿弱,痰

气壅滞,故名肺痿。本病以咳吐浊唾涎沫不已为主证,多为各种慢性咳、喘、哮证的继发病变。所以,久患咳喘为其前因,重伤肺气是其后果,一般分虚热、虚寒二类。俞嘉言指出:“肺痿者,其积渐已非一日,其寒热不止一端。”由此可见,本病属于慢性虚弱性疾患。

一、病因病机

肺痿的形成,大多因于久患咳喘,肺气重伤,气阴亏损,致使敷布津液气血功能障碍所引起。阴亏肺燥,热留上焦,病为虚热肺痿;气虚肺寒,痰气不化,病为虚寒肺痿。然而肺气损伤,则为二者病机所共有。

阴亏肺燥,热留上焦。导致阴亏肺燥的前因,或以久病消渴,或以肺癆久嗽,或以阴虚喘咳,均可形成。久病消渴,常以长期尿多损耗津液,致令津不上承,肺燥失润,继发肺痿。此即《金匱·肺痿病篇》所说:“或从消渴,小便利数”,“重亡津液,故得之”。肺癆属阴虚者多,癆咳日久,咳血持续,气血耗散,肺气同虚,因虚致痿。所以,《类证治裁》指出:“肺劳成痿。”阴虚咳喘失于治疗,久则咳伤肺气,因咳成痿。正如《金匱要略》所说:

“热在上焦者,因咳为肺痿。”总之,本病的虚热,起因于肺燥津枯;肺叶痿弱,成因于肺气虚损。所以,阴亏肺燥是其前因,久咳少痰,咳声燥急,是其病前历史;出现喘促短气,咳声不扬,咳吐浊唾涎沫不已,是为肺痿见证。于是一方面,肺燥津枯,虚热稽留;一方面,肺气虚弱,痰浊不化;形成燥者自燥、唾者自唾的病机局面。这便是

肺燥生热,热留上焦,因热而咳,因咳致虚,因虚而成虚热肺痿的病变经过和证候特征。

气虚肺寒,痰气不化。导致气虚肺寒的前因,皆由气虚咳喘诸证长期失治,咳愈久,气愈虚,痰愈盛,终于肺气重伤,肺叶痿弱不振,以致因虚成痿。肺主气,由中焦游溢而来的津液,得肺气输布,外而宣达于肌肤,内而洒陈于脏腑,今肺虚气寒不能为脾输布津液,津气不化,反为痰浊,壅滞于肺,则为痰嗽。惟一般痰嗽,有痰则随咳而出,无痰则不咳不唾。肺痿的痰嗽,不仅咳时吐出多量稀痰,虽不咳亦时唾涎沫不已。此即《金匱要略》所说“肺痿吐涎沫而不咳者”,“此为肺中虚冷”的缘故。总之,本病的虚寒起因于久病痰嗽,肺叶痿弱成因于肺气大虚。所以,气虚生痰是其前因,痰喘咳嗽是其病前历史;出现咳喘短气,声低息微,咳痰量多,不咳时亦吐唾痰涎不已,是为成痿见证。于是肺虚气馁,宣化无权,津尽为痰,壅滞于肺,形成了虚者愈虚、唾者愈唾的病机局面。这便是气虚生痰,痰气壅肺,因痰而咳,久咳大虚,因虚而成虚寒肺痿的病变经过和证候特征。

由上说明,肺痿皆由肺气虚衰所致。虚热肺痿,始于阴亏,成于气弱;虚寒肺痿,始于气弱,成于气衰;气弱者轻,气衰者重。所以,虚热、虚寒皆以吐唾浊痰涎沫为主证,惟虚热之唾,咳则吐唾浊痰;虚寒之唾,不咳亦吐唾涎沫不已。本病往往迁延缠绵,不易根治,如肺气大虚,肺中虚冷,还可出现肾虚、血瘀的严重病变。肺与肾精气交通,肺为水之上源,肺虚及肾,膀胱失于约束,则见小便频数,甚或不禁。气为血帅,血为气母,肺气大虚,营

血失温，络脉瘀塞，则见心悸怔忡，面色晦暗，爪甲青黑，唇舌紫绀等气虚血瘀之证。由此又可说明，肺气亏虚是形成肺痿的主要根源，而痰滞、血瘀又能加重肺痿恶变。

二、辨证施治

举凡慢性咳喘哮证长期不愈，如出现喘乏短气，时觉胸闷痰壅，咳唾涎沫不尽者，即为肺痿见证。由于肺气已虚，御寒能力薄弱，每因偶感外邪，或在深秋隆冬季节，可致病情加重。临证时，必须了解其病前历史，审察其现证舌脉，分辨其属寒属热，区别其病轻病重，方能作出准确诊断。

关于肺痿的治疗原则，俞嘉言于《医门法律》中论述极为精辟。如说：“大要缓而图之，生胃津，润肺燥，下逆气，开积痰，止浊唾，补真气以通肺之小管，散火热以复肺之清肃。”“行峻法以驱涎沫，图速效反速毙，医之罪也。”此即是说，痰因气虚，虚则宜补；痰因痰闭，痰则宜通。所以，治肺痿当以补气通肺为基本原则。虚热肺痿，肺胃兼顾，主以生津润燥益气化痰，金润则清肃可复，气旺则痰涎可化。虚寒肺痿，肺脾同治，主以补土温金宣化痰浊，补脾即可补肺，温肺便能行痰。肺痿多不渴，切勿因其不渴不与生津，否则肺枯日甚，病更加深；肺痿常多痰，切勿因其多痰妄用燥烈驱痰峻剂，否则害肺伤阴，肺损日甚。总之，本病宜于缓图理虚，不可妄求速效。又因本病多为慢性咳、喘、哮证以及消渴、肺癆等病的继发疾病，在治疗中，尚须针对病情与上述诸病治法相互配合。

(一) 虚热肺痿

主证：久病阴虚咳喘，缠绵不愈，渐见咳吐浊唾涎沫，其质稠粘，咳吐不尽，咳声不扬，喘乏短气，口咽干渴，不欲饮水，舌质红，苔花剥，脉多细数而虚。

证析：久病阴虚咳喘，是其病前历史。肺阴不足，燥热稽留，故肺气上逆为咳为喘。久咳不已，损伤肺气，终于肺虚气馁，肺叶痿弱，津聚于肺，化为痰浊，故其证由燥咳少痰，转为咳吐粘稠涎沫不已。阴亏肺燥，津不上承，故口咽干渴。因涎唾上溢，故虽渴而不欲饮水。咳声不扬，喘乏短气，是肺气已虚之象。舌红苔剥，脉细虚数，均主阴亏气弱。

治法：生津润肺，益气降痰。

主方：以麦门冬汤^①为基本方剂随证化裁；如阴虚咳喘为甚，可与百花枇杷膏^②配合，以加强滋阴宁肺、止咳降逆作用。

(二) 虚寒肺痿

主证：久病气虚痰喘，反复不愈，渐见胸闷痰壅，咳唾多量涎沫，其质清稀，不咳时亦吐唾不已，口不渴，喘乏短气，头眩怯冷，神倦怠惰，口淡食少，尿频或不禁，舌质淡，苔白腻，脉多沉缓虚弱。

证析：久病气虚痰喘，是其病前历史。肺气不足，津聚为痰，留滞于肺，或为咳喘，或为哮喘。久病不愈，肺气大伤，终于肺气虚寒，肺痿不振。肺气虚痿，宣化无权，津尽为唾，故其证不仅咳时吐出多量稀痰，虽不咳时亦吐唾涎沫不已。内无虚火，故口中不渴。肺有壅滞，故胸闷痰壅。肺气大虚则喘乏，清阳不升则头眩，阳不卫外则怯

冷,气虚神弱则倦怠。肺虚不能约束膀胱,则尿频或不禁。口淡食少,舌质淡,苔白腻,脉沉缓虚弱,皆为气馁虚寒之证。

治法:益气健脾,温化寒痰。

主方:以参苏理肺汤^③为主方,随其病情增损变化;寒痰太甚者,与甘草干姜汤^④配合,以振奋脾阳温化寒痰。

上列方药仅为治疗肺痿的基本法则。由于本病多见于中老年人,病情有轻有重,病势演变各有不同。病轻者如能慎于调养,严戒烟酒嗜好,尚期得以治愈。病重者不但难于根治,每当大暑大寒季节,或偶感外邪,不仅病情转重,甚或招致剧变,发生危重证候。虚寒肺痿,阳气本虚,可因寒气外侵,寒痰壅塞,阳气内闭,血脉瘀滞,出现痰壅气塞,喘悸加剧,面色晦暗,爪甲青黑,唇舌紫绀,手足厥冷,六脉沉伏等寒盛痰壅阳虚血瘀危急证候。对此,急宜治以温阳益气豁痰开闭,可用参附草姜汤^⑤。虚热肺痿,津气本虚,如触冒暑热亦能引起阴津大亏,虚阳浮越,出现喘促大发,心烦心悸,口渴面红,大汗淋漓,脉来急数而虚等虚脱危候。对此,急宜治以益气救阴降痰平喘,可用苏杏参麦汤^⑥。此为临险救急治法,俟病情缓解,则当针对病情,仍以缓图理虚为要务。

三、方药化裁

1. 麦门冬汤 (《金匱要略》)

麦门冬18克 法半夏10克 人参3克 甘草6克 大枣12克 粳米15克

此方生津润肺,益气降痰。适用于虚热肺痿,咳唾涎沫,喘乏短气,舌红苔剥,脉来虚数者。方以人参、麦门冬益气生津;甘草、大枣、粳米和中益胃。肺胃得润则燥热可除,肺气振作则水津四布。以半夏之辛燥反佐其间,燥润相配,互为功用,共收下逆气、止涎唾之良功。故本方用为治疗虚热肺痿的基本方剂,是非常适合的。

咳嗽为甚者,加紫苑20克,枇杷叶20克,以止咳降逆。咳痰粘稠,吐唾不爽者,加冬瓜仁12克,川贝母10克;以润利化痰。喘促为甚者,加杏仁10克,五味子6克,以敛肺平喘。

2. 百花枇杷膏

方药见第一章咳嗽篇第七方。

本方滋阴润肺,宁嗽降逆。虚热肺痿,经过治疗,涎唾已止,仍见燥咳不休者,可用本方膏剂酌加人参一味,作为常服调理,以巩固治疗效果。

3. 参苏理肺汤

方药见第一章哮喘篇第三方。

本方具有宣通肺气,益气健脾,温化寒痰,平喘降逆等功能。用于虚寒肺痿,胸闷痰壅,咳唾稀痰,喘乏短气,神倦食少,舌淡苔腻,脉来缓弱等证,极为适合。肺气通,脾气健,津液布,痰气消,咳喘可平,涎唾自止。

痰涎太盛者,宜加重半夏、橘皮剂量,以加强理气降痰功能。如见小便频数不禁,此为上虚不能制下,可再加黄芪24克,补其肺气以约制膀胱。如见大便溏薄泄利,此为脾虚不运,宜加入缩砂仁6克,以助温中实脾。

4. 甘草干姜汤 (《金匱要略》)

甘草12克 干姜（炮）6克

本方药仅二味，甘草量倍于干姜，取甘草之甘润以润肺止咳，干姜之辛热以温脾暖肺、温化寒痰。辛甘合用，温而不燥，用治虚寒肺痿寒痰太盛者，具有振奋脾阳温肺化痰功能。惟肺痿之寒因于气虚，涎唾太盛因于肺弱，此方单用亦嫌力薄。如肺痿寒痰太盛，将本方与参苏理肺汤并用，其效力更为全面。

5. 参附草姜汤

人参6克 制附片15克 甘草12克 干姜6克

此方为《正体类要》参附汤与《金匱要略》甘草干姜汤配合组成，具温阳益气，化痰开闭，回逆固脱等功能。适用于虚寒肺痿，寒痰壅塞，虚阳内闭，见痰壅气塞，喘悸气短，爪青唇紫，头汗肢冷，六脉沉微等危急证候者。由于病情危急，非力专效宏方药不足为功，故用人参、附子大温大补挽回阳气，以开闭塞；甘草、干姜甘润辛热温脾暖肺，以化寒痰。寒去痰消则肺气通利，阳回气复则血脉畅和。一俟病情稳定，即改用调理治法。

6. 苏杏参麦汤

方药见第一章喘证篇第七方。

本方具益气生津，敛肺平喘，化痰降逆等功能。用于虚热肺痿，喘促大发，气短心悸，心烦口渴，大汗出，脉虚数，有亡阴趋势者，可用本方为主，再加入人参6克，玉竹参12克，玄参15克，其气阴双补之力更宏。津回气复，则喘平汗止。俟病势缓和，再进调理治法。（表11）

表11

肺痿病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证		治 则	方 药
久患咳喘哮证，肺气损伤，肺叶痿弱，因虚成痿。津亏肺燥，热留上焦，久咳气虚，病为虚热肺痿。气虚生寒，寒痰壅滞，久咳大虚，病为虚寒肺痿	虚 热 肺 痿	阴 亏 气 弱	生津润肺 益气降痰	麦门冬汤 百花枇杷膏
		阴 亏 阳 越	益气救阴 降痰平喘	苏杏参麦汤加味
	虚 寒 肺 痿	气 虚 肺 寒	益气健脾 温肺化痰	参苏理肺汤 甘草干姜汤
		痰 壅 气 闭	温阳益气 豁痰开闭	参附草姜汤

第三节 肺 痈

肺部化脓生痈，故名肺痈，又称肺疽。本病多发病急骤，以恶寒发热，咳嗽胸痛，吐痰腥臭或咳吐脓血为主证。如《金匱要略》所说：“咳而胸满，振寒脉数，咽干不渴，时出浊唾腥臭，久久吐脓如米粥者，为肺痈。”

一、病因病机

本病多由感染风热邪毒侵袭肺部，或肺有郁热复感外邪，卫肺郁蒸，失于清解，因而发病。风热邪毒，郁蒸于肺，一以肺气郁滞，血络瘀凝；一以肺液失宣，化为痰浊；痰血相裹，毒聚热蒸，酝酿成痈。是以《金匱·肺痈篇》说：“风伤皮毛，热伤血脉，风舍于肺。”“热之所过，血为之凝滞，蓄结痈脓。”本病演变过程，始为风热壅肺，继则瘀败成痈，终于化腐溃脓。

肺痈初起，风热壅肺。风热邪毒由皮毛口鼻入侵肺系，外则表卫不和，内则肺气失宣。正邪交争，荣卫不利，则恶寒发热；肺气失宣，络瘀痰聚，则咳唾稠痰；肺有瘀凝，咳动其部，则咳引胸痛。所以，肺痈起病多以发热恶寒、咳吐痰浊、咳引胸痛为主证。此际如与一般感冒误诊，妄施辛散方药，往往促使病情加重，病变加速。

痰血相裹，蕴结痈脓。继络瘀痰聚进一步发展，热壅气滞逐渐加深，热愈盛，痰愈壅，血愈瘀。瘀热与痰涎相裹，交相蒸郁，致令血肉败坏变生痈脓。痈脓内结，则胸痛加剧；痈脓已成，则咳痰腥臭。初因邪正相争而见无汗恶寒发热，继则毒热增盛转为汗出而但热不寒。这便是肺痈进入成脓阶段的主要病证，皆由毒热壅盛所致。

瘀败肉腐，痈脓破溃。痈脓肿毒，蕴酿成熟，终于瘀败肉腐进入破溃阶段。痈肿破溃，脓毒排泄，一从咳唾而出，一从大便而下。因之，这一阶段除出现咳出多量腥臭脓痰（或脓血相兼）外，大便中也可兼见秽浊脓液随粪便排出。在此过程中，初因肺中脓肿所出现的胸痛、烦满、身热、喘急诸证，也以脓毒的排泄逐渐减退而进入恢复阶段。如果吐唾脓血，久延不净，气阴大亏，又可出现由实转虚病变。

由此说明，肺痈属热病实证，始为风热侵袭，卫肺同病；继则热壅肺络，瘀结成痈；终于血肉腐败，痈脓破溃。正因先后演变有所不同，所以，临床上要区别初起、成痈、溃脓三个阶段辨证。

二、辨证施治

本病以早期确诊，早期治疗，效果最佳，故《证治全生集》指出：“预知预治，百无一死。”惟其病初起多表现寒热胸痛、咳喘多痰而与外感咳喘、肺痿、肺癆等病混淆难辨，临证时必须详加鉴别。潘楫《医灯续焰》提出“试痈”一法：用玻杯盛水，令患者吐痰入杯中，浮于中、上层者为痰液，沉于杯底者为痈脓。将此法与临床证状结合起来，对于诊断肺痈很有帮助。

治肺痈以清热解毒、通瘀排脓为基本法则，在病程中忌用或慎用发汗、止呕、止泻以及温补保肺方药。肺痈初起，以清宣肺热、通瘀散毒为主，不可妄施辛温发汗方药，误汗可致伤津助热，加速恶变。痈脓已成，肺痈证候毕露，当以清热解毒、通瘀消痈为要法，此时不但切忌发散，尤忌温补保肺，防止阻闭毒热，堵塞痈脓。肺痈溃破，常因痈脓内溃外泄出现呕吐、泄泻证状，痈脓消减，呕泄自止，切勿妄投止呕止泻药物，以防脓毒内闭演生他变。在此阶段，须以清热保肺、排脓解毒为主，形体素强，正气不虚，仍从实证论治，主予清热消瘀、宣肺排脓，兼以滋养扶正之法。对溃后虚证，当辨别阴虚、气虚论治，荣阴偏亏，宜滋阴清热、化瘀排脓；正气偏虚，宜益气托邪、排脓解毒；此为扶正托毒治法，其间仍以解毒通瘀为基本法则。

现将肺痈各阶段治法分述如下：

（一）肺痈初期

主证：发热恶寒，咳嗽吐唾黄浊稠痰，胸中隐隐作痛，咳则胸痛尤甚，舌质红，苔黄浊，脉浮滑数。

见身热不甚，胸痛轻微，呼吸调匀，脉浮略数者，属于轻证。

见壮热振寒，胸痛剧烈，气喘多汗，心烦面红，脉洪大急数者，属于重证。

证析：风热袭表，荣卫不和，故发热恶寒。风热壅肺，肺气失宣，肺失清肃则咳嗽，肺络痰滞则胸痛，热蒸肺液则痰稠，咳动其部则胸痛加剧。舌质红，苔黄浊，为痰热壅肺之象；脉浮滑数，为风痰邪热壅阻卫肺之征。感邪有微甚，邪轻则病轻，病轻则脉证俱轻；邪重则病重，病重则脉证俱重。

治法：清宣肺热，通痰散毒。

主方：翘荷散毒汤^①。本方轻疏肺邪，开利肺气，豁痰散瘀，重在清热解毒方面，故以散毒得名。用治肺痈初期，功能消除毒热、解散瘀凝，可收到痈毒内消之良效，并可依据病情轻重酌量化裁。

（二）成痈期

主证：时冷时热，继则但热不寒，有汗，咳逆气喘，胸痛加剧，咳吐腥臭脓痰，胸胁烦满，舌质红，舌苔黄浊厚腻，脉来滑数或洪数。

见身无大热，形色鲜明，咳痰畅利，咳声清朗，脉象略数者，属于轻证。

见身有大热，形色晦暗，咳吐脓痰，其味恶臭，咳声重浊，或痰稠如胶吐唾不爽，脉来洪大急数者，属于重证。

证析：痈脓已成，内热独盛，是以外证由时冷时热转为但热不寒而有汗。热毒壅肺，肺失清肃，故咳逆气喘。痈肿结滞，故胸痛加剧，胸胁烦满。咳痰腥臭，乃痈象毕露之证。苔黄厚腻，脉滑数或洪数，皆为痰热壅肺之象。热毒轻，痈肿面小，表现多为轻证。热毒重，痈肿面大，表现多为重证。

治法：清热解毒，通瘀消痈。

主方：苇茎甘桔汤②。本方重在通瘀解毒，无论痈脓已成或破溃，均可服用。已成者，功能消除脓毒；破溃者，功能消瘀排脓。如属重证，可兼服犀黄丸③以加强解毒消痈力量。

（三）溃脓期

主证：咳吐脓痰，或如米粥，或脓血相兼，量多腥臭，身有微热，胸中烦满而痛，口渴喜饮，大便夹有脓秽，舌苔黄腻质红，脉滑略数。

见形体消瘦，午后潮热，夜间盗汗，口燥心烦，舌质红绛，脉虚数者，属荣阴偏亏。

见喘乏短气，精神倦怠，动则自汗，口淡食少，舌质淡红，脉缓弱者，属阳气偏虚。

证析：痈肿破溃，脓毒外泄，上从咳唾而出，故咳吐腥臭脓血痰液。其吐唾未出咽入胃肠者，则随大便而下，故粪中夹有脓秽。肺中蓄脓，肺气胀满，故胸中烦满而痛。脓毒外泄，热势减退，是以仅见身有微热。口渴喜饮，乃津液耗伤之象。舌黄腻，脉滑数，乃痰热未尽之证。如吐唾脓血久延不净，脓疡未愈，气阴大亏，就能出现阴虚、气虚等虚实互见之证。

治法：养阴清热，宣肺排脓。

主方：正气不虚，主以苇茎甘桔汤；兼服金鲤汤④以助滋阴解毒利痰消痈功能。荣阴偏亏者，主与养阴清热解毒排脓，可用桔梗杏仁煎⑤；阳气偏虚者，主与益气排脓清热解毒，可用黄芪桔梗汤⑥。

三、方药化裁

1. 翘荷散毒汤

连翘24克 薄荷15克 桔梗10克 甘草10克 黄芩15克 金银花24克 没药6克 全瓜蒌18克 鱼腥草30克 鲜苇茎30克

此方清疏肺热，解毒散瘀。适用于肺痈初期，证见寒热胸痛，咳痰黄稠，舌红苔黄，脉浮滑数者。方用连翘、薄荷、黄芩、金银花、苇茎、蕞菜等品，轻疏肺邪，清热解毒。桔梗、甘草、瓜蒌开利肺气，豁痰散结。没药善于活血通瘀，消肿止痛。热毒清除，肺气开利，则瘀凝散而痈肿消。如病重见壮热心烦，脉洪急数者，加生石膏30克，黄连10克，以清热除烦。见喘逆气急，不得平卧者，加炒葶苈18克，大枣10克，以泻肺定喘。

2. 苇茎甘桔汤

鲜苇茎60克 薏苡仁20克 冬瓜仁24克 桃仁10克 甘草10克 桔梗10克 没药6克 连翘24克 忍冬藤30克 鱼腥草30克

此方由《千金方》苇茎汤和《金匱要略》桔梗汤加味组成，功能清热解毒，散结驱瘀。适用于肺痈成痈或破溃，

证见发热胸痛，胸胁烦满，咳吐腥臭脓痰，苔黄腻，脉滑数者。方以苇茎汤清肺利痰，驱瘀消痈；以桔梗汤开宣肺气，解毒排脓。配没药以通瘀散结；佐连翘、忍冬藤、戴菜以增强清热解毒功能。方药配合，清解与驱瘀并重，故对肺痈已成或溃后都能适用。肺痈已成，重在清热消痈，如见身有大热，心烦口渴，脉洪大急数者，此为毒热鸱张，加生石膏30克，黄芩20克，以加强清热除烦之力。如见咳痰胶粘，吐唾不利，此为津伤肺燥，加瓜蒌18克，川贝母10克，润化结痰，以利排脓。肺痈溃后，重在驱瘀排脓，可将方中桔梗、甘草各加量为18克，其开利肺气、解毒排脓之力更强。

3. 犀黄丸（《外科全生集》）

犀黄1克 麝香5克 没药30克 乳香30克

上药共研极细末，制为丸剂，每服3克，日服2次。

此方活血行瘀，解毒消痈，以善治热证肿毒著称。肺痈成脓阶段，如见胸胁胀满疼痛，吐唾脓痰，其味恶臭者，多因痈肿面大、脓毒壅聚所致，可兼服本方以加强消痈定痛力量。

4. 金鲤汤（《外科正宗》）

活鲤鱼1尾（约250克） 川贝母10克（研细）

刮去鱼鳞，剖开鱼腹，除去肠杂，将贝母粉填入鱼腹，用线缝合，以健康儿童小便半大碗，将鱼浸入童便内，隔水煮熟，去鱼骨，分2~4次服，日尽1剂。

此方滋阴解毒，化痰消瘀。凡肺痈溃后，无论虚实皆可服用，既能滋阴养荣，亦能解毒行瘀，并有加速肿疡愈合功能。如嫌童便难服，亦可用清水炖熟去骨服汤。

5. 桔梗杏仁煎（《景岳新方》）

桔梗10克 杏仁10克 甘草10克 阿胶6克 连翘20克 川贝母10克 百合10克 夏枯草20克 金银花20克 麦门冬15克 枳壳10克 红藤20克

此方养阴清热，解毒排脓。适用于肺痈溃后，荣阴偏亏，证见咳唾脓痰，痰中带血，胸中隐痛，口燥心烦，午后潮热，脉来虚数者。方以桔梗、甘草、杏仁、贝母开宣肺气，利痰排脓。以阿胶、百合、麦门冬滋阴润燥，养肺止血。以金银花、夏枯草、连翘、红藤、枳壳清热解毒，理气消痛。如阴亏偏甚者，加生地黄、玄参；潮热偏甚者，加胡黄连、地骨皮。

6. 黄芪桔梗汤

黄芪30克 白术15克 桔梗10克 杏仁10克 甘草10克 冬瓜仁15克 川贝母10克 丹参15克 鱼腥草30克 蒲公英30克

此方清补并用，托毒排脓。适用于肺痈久久不溃，或溃后气虚，其证咳吐脓痰，喘乏短气，自汗倦怠，口淡食少，脉象缓弱者。方以黄芪、白术、甘草补中益气；桔梗、杏仁、冬瓜仁、贝母宣肺利痰；丹参养血通瘀；鱼腥草、蒲公英清热解毒。合而用之，清热消瘀，扶正排脓。肺痈日久不溃，能促使溃破排除痈脓；溃后气虚，又能益气托毒促其愈合。脓血多者，加地榆20克，藕节30克，以化瘀止血；胸痛甚者，加没药3克，乳香3克，以消肿定痛。（表2）

表12

肺痈病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
外感风热邪毒,侵袭肺部,肺气失宣,痰聚络瘀,痰血相裹,热蒸肉腐,蓄结痈脓,病为肺痈	初起	清热散毒	翘荷散毒汤
	成痈	解毒消痈	苇茎甘桔汤 犀黄丸
	溃后	养阴排脓	桔梗杏仁煎 金鲤汤
		益气托毒	黄芪桔梗汤 金鲤汤

第四节 失 音

失音又称暗,以语音不扬,甚则嘶哑不能出声为主证,属于咽喉声道的病变,故《医学纲目》又称喉暗。

本病有舌暗、子暗、暗痹、喉痈、癆暗的区分。因于中风舌强不利,语言蹇涩者,为舌暗。妇女妊娠期中,病出无因,声音嘶哑者,为子暗,分娩即愈。大病体虚,舌体痿弱,语言无力者,为暗痹。喉间生痈,语音难出者,为喉痈;或喉痈愈后,声道损伤,语音不扬,但暗无害。因于癆虫传染,侵蚀咽喉者,为癆暗,应从肺癆论治。本篇仅以临床常见的急、慢性喉暗诸证作出论述。

一、病因病机

喉咙由咽、喉、会厌、悬雍等组织组合而成,是通发声音的主要器官。所以,《灵枢·忧恚无言篇》说:“喉

咙者，气之所以上下者也。”“会厌者，声音之户也。”又因肺主气，声音由气而发，喉咙是肺气出入的门户，举凡肺与喉咙的病变，都能互为影响而致失音发病。

引起失音的病因，有外感内伤之分，其证有属虚属实的不同。急性暴暗多由外感风寒邪热，其证属实；慢性久暗多由内伤气阴亏耗，其证属虚。

暴暗常由触冒风寒或邪热而发病，属风寒者以寒邪郁热为多见。触冒寒邪，郁而化热，或先有内热，复感风寒，寒邪外束，皮毛闭塞，肺气失宣，气郁化热，灼伤咽喉，声道不利，则语音不扬。如《张氏医通》说：“暴暗总是寒包热邪。”风热之邪，从口鼻而入。上则客于喉咙，伤及会厌，内则侵袭于肺，蒸液成痰。痰热交阻，咽喉不利，则声音嘶哑。如《古今医统》说：“内热痰郁，窒塞肺金，而声哑难出。”凡此，即古人所谓“窍闭而暗”、“金实无声”的病变。

久暗多因暴暗失治，反复发病，积渐形成。亦有因咳嗽病久，高声呼叫，悲哭过度，用力歌唱，说话太多等因素，耗伤气阴，损及咽喉，而致发病。肺阴损耗，津不上承，声喉失润，燥热内炽，则语音嘶哑。如《痰火点雪》说：“水亏火炎，金伤声碎。”肺气耗伤，咽喉受损，则语言无力，发音不利。如《古今医统》说：“争竞大声号呼以致失声，或歌唱伤气而声不出。”凡此，即古人所谓“内夺而暗”、“金碎不鸣”的病变。

总的来说，本病的病变，主要在喉咙，关系到肺系。肺脉通于会厌，会厌受病，则肺窍不利；肺中气阴亏损，不能上承会厌，则无以润养声喉。所以窍闭、内夺、金

实、金碎皆可导致失音发病。

二、辨证施治

失音多与喉痛合并出现，发病有急有缓，病情轻重不一。急者骤然而起，多因触冒风寒邪热而发病；缓者积渐形成，较多见于教师及歌唱演员。但觉语音不扬，身无寒热者，属于轻证，一般养息数日，不药可愈。如见音哑不能出声，咽喉肿痛，或兼有寒热、咳嗽者，属于重证，必须注意治疗。据临床所见，本病常以初起失治，或病情轻微不加留意，平时只觉喉中不适，语音粗糙，一旦偶触外邪，或歌唱、或讲话太多，便引起音哑喉痛加剧。如此反复，转为慢性，往往累月经年难于根治。因此，切勿以失音小疾失于治疗。

治失音以清咽肃肺为基本法则。暴暗多属实证，重在治标，当以驱邪理肺为主；久暗多属虚证，重在治本，应以补养气阴为主。尤须指出，本病虽有寒邪，不可过于辛散，防止发汗耗津反易化燥；虽有气虚，不可过于温补，防止温补助热，反致喉痛转重。所以轻疏缓补又是治疗本病的一个重要准则。

（一）暴暗（急性）

暴暗骤然而起，以语音不扬，甚则音哑不能出声，伴喉中干涩或肿痛为主证，区别风寒、风热辨证施治。

1. 骤感风寒，肺内郁热

主证：卒然声音嘶哑，咽喉干涩，甚或肿痛，伴咳嗽不爽，鼻塞头痛，或恶寒发热，舌边尖红，苔薄白，脉象浮滑。

证析：外寒内热，阻遏肺窍，肺气失宣，声喉不利，轻者语音不扬，重者音哑不能出声，甚则喉中肿痛。寒邪袭表，表卫不宣，故鼻塞头痛，恶寒发热。肺热内郁，肺失清肃，故咽喉干涩，咳嗽不爽。舌边尖红，苔薄白，脉浮滑，皆为寒热互见之象。

治法：疏表散寒，清咽肃肺。

主方：可用荆芩桑桔汤^①为主方，依据寒、热偏甚随证化裁。寒去热退，肺窍开利，声音自出。

2. 风热袭肺，壅阻咽喉

主证：声音嘶哑，咽喉干涩，甚或喉痛，伴咳痰黄稠，口中干渴，或恶风发热，舌红苔黄，脉浮滑数。

证析：风热袭肺，壅阻肺窍，热蒸液聚，化为痰浊。痰热交阻，肺气不得宣畅，则声音嘶哑。热伤咽喉，则喉干或痛。肺失清肃，则咳痰黄稠。热伤津液，则口中干渴。舌红苔黄，脉浮滑数，皆为风热夹痰之象。

治法：轻疏表邪，清热利咽。

主方：可用翘荷桔甘汤^②为主方，随痰热轻重增损化裁。热去痰消，咽喉清利，则声出音清。

（二）久喑（慢性）

久喑积渐形成，平时但觉语音粗糙，喉中不适，时常咯出少量粘痰，是其主要表现。如过度烟酒、说话太多、或偶触外邪，即能引起病情加重而致音哑喉痛。区别津亏肺燥、气阴亏损辨证施治。

1. 津亏肺燥，咽喉失润

主证：声音不扬，咽喉干燥，语言稍多则声嘶喉痛，或伴呛咳，咯唾少量粘痰，舌红少津，脉象细数，或舌脉

如常。

证析：诸凡暴暗失治转为慢性，或用力歌唱，讲话太多，都是导致久暗的原因。肺津偏亏，津不上承，咽喉失润，故声音不扬，咽喉干燥。语言稍多，则津愈亏而声嘶喉痛。津亏肺燥，气失清肃，故伴呛咳气逆。因喉中干涩不适，故时以咯唾为快。舌红少津，脉细数，为燥热伤津之象。如病情轻浅，则舌脉一如常人。

治法：养阴润燥，清利咽喉。

主方：病重用清咽喻化丸^③；病轻用芷黛煎^④漱口方。大凡慢性喉暗，皆非短时可以根治，此二方均以缓取胜，只要坚持治疗，其效颇佳。

2. 气阴亏损，音哑难出

主证：声音嘶哑，日久不愈，咽喉干燥，如有物阻，语言稍多则音哑难出，伴干咳痰少，气短心悸，舌体光红，脉象细弱。

证析：久暗以津亏肺燥者多见，如日久不愈，伤及肺气，则出现气阴双亏证候。阴亏气弱，肺气不扬，故声音嘶哑，言多则音哑难出。津不上承，声道失润，故咽喉干燥，如有物阻。干咳少痰，为肺阴不足；气短心悸，为肺气已虚。舌光红，脉细弱，均属阴亏气弱病证。

治法：生津润燥，益气通音。

主方：用二参汤^⑤益气生津；兼用芷黛煎漱口方清利咽喉。二方配合，取其轻清缓补，清不害气，补不助热，但须坚持治疗，不可中断，其效方显。

大凡久暗未愈，最易触冒外邪而致急性发病。急则治标，当从暴暗论治，俟病势缓解，缓则治本，则从久暗论

治。总以清咽肃肺为基本法则。

三、方药化裁

1. 荆芩桑桔汤

方药见第一章咳嗽篇第二方。

本方轻疏寒邪，开利肺气，清泄肺热，化痰止咳。适用于风寒夹热，音暗喉干，咳嗽不爽，鼻塞头痛，舌质红，脉浮滑者。如见寒热无汗，为表寒偏甚，加防风15克，白芍18克，以助疏表散寒，和调荣卫。如见咽喉肿痛，为内热偏甚，可加板蓝根24克，射干20克，以加强清泻肺热，消肿利咽。

2. 翘荷桔甘汤

方药见第一章咳嗽篇第三方。

本方轻疏表邪，凉解风热，宣肺利痰，止咳降逆。适用于风热暴暗，咽喉干痛，咳嗽气逆者。如音哑为甚者，加胖大海3枚，蝉蜕10克，以加强清咽通音之力。喉痛为甚者，加马勃10克，板蓝根24克，以清利咽喉。口干痰稠为甚者，加知母18克，川贝母10克，以清热化痰。

3. 清咽噙化丸

桔梗10克 玄参10克 麦门冬10克 板蓝根10克
射干10克 甘草10克 鱼腥草30克（共煎3次，去滓，用文火浓缩成膏）

青黛1克 米百合10克 白芷3克 川贝母3克（研为极细粉末）

用上方5~10剂量，将药粉掺入药膏混匀，再加适

量柿霜、白蜜制为丸剂，每丸大如黄豆，每用1丸入口噙化，一日噙服2~4丸，以一个月为一疗程，可持续噙服2~3个疗程。

此方清咽润燥，消肿利痰。适用于久病喉暗，津亏肺燥，咽喉红肿，语音不扬，证无大虚者。方以丸剂小量噙服，取其轻清润利，既无害胃之弊，亦易坚持治疗。轻者噙服一个疗程，重者持续2~3个疗程，一般都能收到满意效果。

本方用于喉痹音哑，方中再加夏枯草20克，百部10克（熬膏），其清咽制痹之效，亦甚得力。

本方再加硼砂3克（火煅研细），用于鼻咽癌、喉癌等疾病，亦能取得较好疗效。

4. 芷黛煎漱喉方

青黛6克（包煎）玄参24克 白芷10克 水煎2次，去渣，放凉后以药汤漱喉，日尽1剂，连漱1~2月。

此方生津泻火，消肿止痛。适用于慢性喉暗，久病不愈，亦治口舌生疮、牙龈肿痛等证。方中青黛清泻火热，玄参生津润燥，白芷辛香通窍。合而用之，清润辛通，开利咽喉，止痛消肿。且噙漱法取效于局部，久用无害，易于坚持，余常用之，其效甚优。对顽固性口疮、慢性牙周病，均有良效。如口腔病有出血现象者，加地榆20克，更具凉血止血之力。

一鼻咽癌患者，因放疗发生口咽部红肿热痛而停止放疗，余用本方加玉枢丹（一剂配1粒，研细入药汤内），令患者噙漱日尽1剂，约1周红肿消退。患者坚持噙漱，现已5年，历次复查，咽部光滑，自觉良好。由此可见，

本方泻火解毒功能，颇为得力。

5. 二参汤

人参叶 3 克 明沙参 20 克 麦门冬 10 克 玄参 10 克
乌梅 6 克 五味子 6 克 知母 10 克 川贝母 6 克

此方生津润燥，化痰宁嗽，益气通音。适用于久病喉暗，气阴亏损，音哑难出，伴咳嗽气短者。方中参叶功同人参，其效轻补；明沙参、麦门冬、玄参生津润燥；乌梅、五味子养阴敛肺；知母、贝母化痰宁嗽。津回气复，声音自通。阴亏为甚，喉燥便结者，加胖大海 6 克，以清泄燥热。气虚为甚，喘悸无神者，加人参 3 克，以益气提神。（表 13）

表 13

失音病因病机证治简表

	病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
暴暗	骤感风寒邪热，邪阻肺窍，肺气失宣，咽喉不利，声哑难出	骤感风寒 肺内郁热	疏表散寒 清热肃肺	荆芥桑桔汤 加味
		风热袭肺 壅阻咽喉	轻疏表邪 清热利咽	翘荷桔甘汤 加味
久暗	歌唱或讲话太多，或暴暗久延失治，阴亏则咽喉干涩，气虚则音哑不扬	津亏肺燥 咽喉失润	养阴润燥 清利咽喉	清咽喻化丸 芷黛煎
		气阴亏损 音哑难出	生津润燥 益气通音	二参汤 芷黛煎

结 语

肺癆、肺痿、肺病、失音同感冒、咳、喘、哮诸证，都属于病因作用下直接或间接影响于肺的一类疾病。此类

疾病，如从发病原因、病机演变的关系来看，又可概括为外因、内因两大类证。

外因引起的咳、喘、哮、肺痈、失音等疾病，都是以感冒为中心的并发证候，都以急性新病实证表现于临床。即是说，外感风寒、邪热侵袭肌表，病为表证；内入犯肺，轻则为咳，重则为喘、为哮；伤及喉咙，则为失音；热聚血瘀，变生脓腐，则为肺痈。因此，此类疾病的证候分类、治疗法则，都是大体相同的，只是随其病邪深浅、病情轻重，所用方药有所不同而已。

肺癆病程中亦能伴发嗽、喘、失音等证。其间应当区别：属于咳伤咽喉的失音，多由阴亏肺燥、津不上承引起，其治较易；如因癆虫侵蚀咽喉，声道损伤者，病虽可愈，其音暗多不易完全恢复。

总之，此类疾病的病位皆在于肺，都以治肺或卫肺同治为主。

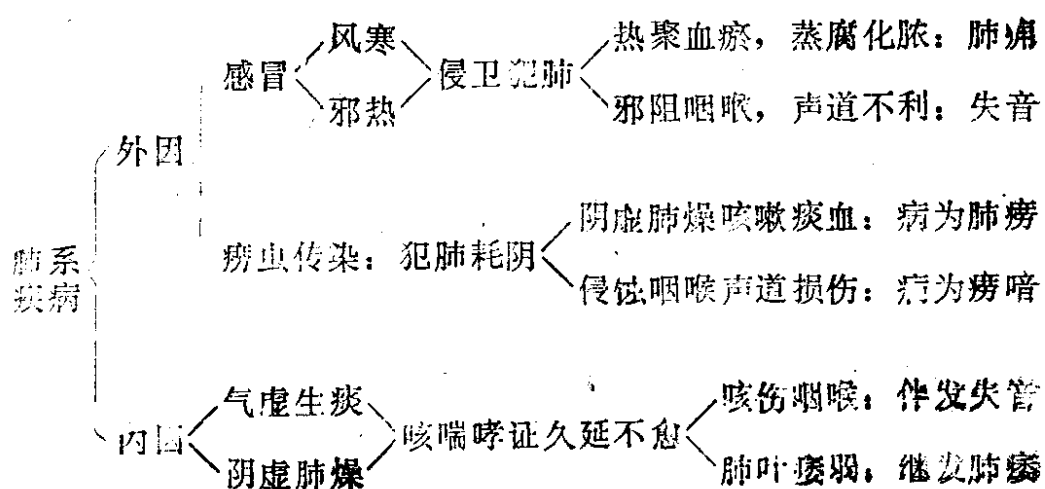
内因所引起的咳、喘、哮、肺痿、失音等疾病，都以慢性久病虚证、或虚实相兼的证候表现于临床。此类疾病，大多因于急性期失治转为慢性，仍以肺经病变为主，在演变中常与肾经病变关系密切。肺主气，为水精之上源，肾藏精，精中寓有元阳，为肺气之根本，二者有金水同源、精气互根的生理关系。所以，此类疾病大都区别为气虚、阴虚、或气阴双虚辨证论治。肺气虚，肺液停蓄，聚而为痰；肺阴虚，肺燥失养，气逆上迫。肺为清虚之脏，喜润恶燥，不能容物，今为痰浊、燥热所侮，肺失清肃则为咳、为喘、为哮。咳哮病久，既能损及咽喉，伴发失音；又能重伤肺气，致使肺叶痿弱，形成肺痿。肺已损伤，肾失资

源，肾精不足，精不化气，便能导致气阴两亏、肺肾同病的病变。正因此类疾病的病机演变，是以肺为主而兼及于肾为其特点，故治法多采取治肺兼顾到肾的原则。

由上所述，说明第一章与第二章所列各病种的病机关系，都是因果相关的。只有掌握了这些病种间的这一内在关系，在辨证治疗、遣方用药方面，才能做到融汇贯通，临证不误。（表14）

表14

肺系疾病病机简表



第三章

心肝疾病

郁证、眩晕、中风、厥证以及癲、狂、痫等疾病，虽然致病因素各有不同，在病机上则以心肝同病为其特点，故将此类病证统属于心肝疾病。

第一节 郁 证

郁证不是一个疾病的专名，乃是情绪抑郁、因郁成病的总称。朱丹溪创立气郁、食郁、湿郁、痰郁、热郁、血郁“六郁”学说以概括诸病，可见所涉及的疾病非常广泛。由于情志抑郁所导致的许多疾病，除已散见于其它各章病证外，本篇着重以气郁病机为主和由此而发生的痞气、郁火、梅核气、脏躁、百合病等疾患作出论述。

一、病因病机

郁证的发生和发展，大要言之，或以忧思曲意，久而不释，或以隐怒不解，难于伸泄，致令心神失畅，肝气内郁。心肝气郁的发病趋势，一则肝木失疏，脾气郁滞，出现气滞食阻，或聚湿生痰。一则肝气内横，气盛化火，出现火郁内热。一则心肝久郁，气阴日亏，或以气虚神弱发为脏躁证，或以阴亏内热发为百合病。更有因于气郁血滞而致络脉瘀阻，或为疼痛不移，或为月经瘀闭，甚则形成癥瘕积块等证。此即由气郁而发展为食郁、湿郁、痰郁、热郁、血郁等多方面的各种病机演变。

脑为精髓神明之府，是主宰精神意识活动的器官，而脑的这一功能则以心、肝、肾三者的生理活动体现出来。心属火，为阳中之太阳，肾属水，为阴中之太阴，阳之精为神，阴之精为髓，诸阳之神气上会于头，诸髓之精上聚于脑，因而构成精髓神明之府以主宰精神意识活动的功能。肝在精神活动中，发挥调节神志以适应事物变化的重要作用。肝属木，为阴中之少阳，位于心、肾之间，切近于肾而不离于心。肝气在精神动静中，动则肝（气）随神动而出于阳，静则肝（气）随神静而入于阴，如此往来于心肾之间，便能发挥调节神志、主持动静的功能。当人们遇到外界事物刺激时，肝气便能随神而动以适应事物的变化。由此可知，人们如因忧思、隐怒而致心神不畅，神郁则肝郁，故郁证以心肝气郁的病机演变为主。肝气郁滞，气血失和，往往侮其所胜引起种种病变。正如《丹

溪心法》所说：“气血冲和，百病不生，一有怫郁，百病生焉。”现以气郁为主的病机演变论述如下：

（一）肝郁犯胃

神志抑郁，肝气随郁，肝郁侮其所胜，首犯脾胃，故郁证多起于肝脾失和。胆附于肝，脾与胃合，肝气升发，脾气疏利，助胃输精，上归心肺；胆气下泄，胃气和降，消化食物，传送糟粕。肝气郁滞则胆气不畅，脾气不得疏利，胃气失于和降，因而脾运不健，食滞难消。食滞于胃则脘痞，气滞不疏则善噫，故肝胃气郁常以脘痞善噫为主征。如因气滞日久，胃络瘀郁，又能导致胃痛发病。

（二）痰气郁结

肝气郁滞，脾气失疏，脾不健运，则津聚为痰。痰气互结，留滞气道，随气上逆，梗阻咽喉，发为梅核气病。正如《医宗金鉴》所说：“此病得于七情郁气，凝涎而生。”由于本病属于情志病变，故往往随情绪波动而发病。情绪波动，痰气上逆，有如梅核阻塞咽喉，吐咽不去；情绪舒畅，则痰气隐伏，咽阻消退。是以其病以发作无常为特征。

（三）气郁化火

肝气内郁，气盛有余，便能化火，故郁证常见肝火内盛病变。火性炎上，郁火冲逆于上，头目不清，则头痛目赤。郁火内扰，神舍不安，则烦躁易怒，失眠多梦。于是头痛、烦躁、失眠诸证相继而起。如因郁火过旺，冲犯神明，还能导致狂证发病。如因肝热内郁，累及胆腑，胆热瘀积，腑气失畅，又可病为胆热胁痛。如因肝火久郁，暗耗营阴，形成阴虚内热，神志脆弱，即可发为百合病证。

(四) 肝郁神弱

肝郁日久，耗伤神气，或发为脏躁证、或为百合病。脏躁多见于妇女，皆由肝郁气虚所引起。肝气郁滞，脾气失畅，食谷减少，久则气血化源不充，因而导致气血俱虚，心脾亏损。气虚则神弱，血虚则神舍失守，于是表现迷乱多思，无故悲伤，善忧好哭，不能自制。正如《金匱要略》所说：“妇人脏躁 喜悲伤欲哭，象如神灵所作。”百合病由阴虚郁火所引起。肝郁化火，暗耗营阴，久则演变为阴虚内热的局面。阴虚不能养神，神气日虚，内热羁留，神舍难安，因而表现惑乱易怒，惊疑不定。平时心情舒畅，一如常人，偶有不遂，骤然发病。其病发作，一身俱病，变幻莫测，证状多端，所以《金匱要略》谓其“百脉一宗，悉致其病也。”然而阴虚郁热、心肝失调，则是其主要的病机特点。由此可知，脏躁证与百合病虽然同属神志疾患，但在病机上是不相同的。

由此说明，大凡情志所伤 皆以肝郁为起因，发生多种病变，如果肝郁日久，还可发展为种种虚损病证。可见郁证涉及的疾病，是极为广泛的。

二、辨证施治

郁证较常见于平素神志脆弱、情绪易于波动之人，其病以心情舒畅一如常人，偶触不遂，立即发病，是其特点。正因本病与精神因素关系密切，故《临证指南》说：

“郁证全在病者能移情易性。”这在治疗上是十分重要的。

治郁证重在调理肝气，调肝以顺气开郁为基本法则。一般说来，初起形气未衰，多表现为气滞实证，应依据挟食、兼痰、化火等情况分别施治，总以顺气行滞为先，不可妄用升提方药，防止升发肝阳，演生它变。脏躁证与百合病，皆由气阴亏耗，神志薄弱，其证属虚，应采取未发扶虚以治本，已发各随其证以治标的原则。现分痞气、梅核气、郁火、脏躁、百合病论治如后。

（一）痞气

主证：精神抑郁，胸脘痞胀，噫气频作，声高气长，不思饮食，大便不爽，舌苔薄腻，脉象弦滑。

肝郁痞气与脾积痞气不同：脾积痞气属于积病，其证左胁下结块，扪之有形；肝郁痞气属于气病，其证胸脘痞胀，扪之无形。二者名同实异。

证析：精神抑郁，是情志所伤的主要表现。肝经之脉，循腹挟胃布于胁肋。肝气不疏，胃失和降，则气滞食阻，中焦痞塞。在上则食滞于胃，故胸脘痞胀，不思饮食。在下则肠气不顺，传导失常，故大便不爽。肝气欲疏难疏，胃气欲降难降，气从上散，逆出于胃，所以出现噫气频作，甚则噫声高长，声震屋宇。苔薄腻、脉弦滑与前证并见，皆为肝郁气滞、升降失和所致。

治法：疏肝开郁，宽中理气。

主方：瓜蒌郁枳汤^①。本方善于开郁行滞，屡用治疗肝胃气郁而致痞胀、噫、噎诸证，俱以矢气通畅而得胸腹宽快。

（二）梅核气

主证：咽中梗阻，如有梅核，吐不出，咽不下，偶触

不遂，咽阻即显，情绪舒畅，咽阻即消，发作甚者，或见脘闷呕恶，或见喘满气急，一般以舌苔厚腻、脉象弦滑为多见。

本病应与喉暗咽阻鉴别：喉暗咽阻因于喉病，可见喉痛声嘶，咽部红肿；梅核气因于气郁，喉无病，其病发作常与情绪波动有关。

证析：肝气郁结，脾运失常，水谷津液郁而生痰，痰随气逆阻塞咽喉，故见咽中梗阻，吐咽不去。痰因气郁而生，痰随气逆而动，故其证常随情志波动而发病。如气逆犯胃，胃失和降，则见脘闷呕恶；如痰气上逆，阻碍肺气，肺失肃降，则见喘满气急。舌厚腻，脉弦滑，为痰气郁滞病证。

治法：理气开郁，化痰降逆。

主方：加味半夏厚朴汤^②。这是一首治疗梅核气病的专方，可随病情变化增损化裁。

（三）郁火

主证：胸闷腹胀，性躁易怒，睡眠多梦，口中干苦，大便秘结，或见头痛目赤，舌红苔黄，脉象弦数。

证析：肝气郁结，脾气不畅，故胸闷腹胀。肝气内横，欲伸难疏，故性情暴躁，触事易怒。郁火内扰，神舍不宁，故睡眠多梦。郁火伤津，津不上承，则口中干苦；津不下润，则肠燥便结。如郁火冲逆，上攻头目，则见头痛目赤。舌红苔黄，脉弦数，为肝火内盛之象。

治法：调理肝脾，清泻郁火。

主方：越鞠丸^③加减。本方重在理气解郁，临证运用须依据郁火轻重随证变化，方能切中病情。

(四) 脏躁证

主证：精神忧郁，迷乱多思，时时叹息，善忧好哭，甚或无故悲伤，不能自制，舌淡苔白，脉象弦细。本病以妇女患者为多见。

证析：肝郁日久，脾胃受损，气血亏伤，气虚则神弱，血虚则神舍失守，因而表现表情忧郁，心神惑乱，疑虑多思。每经一事，久久不能宽快，故时时叹息，善悲好哭。久之气愈虚而神愈弱，出现恍惚迷乱，无故悲泣，甚而患者因不能自制，怕与人言，常欲独居一室。舌质淡，脉弦细，皆为心脾不足、气血亏虚所致。

治法：养心宁神，益气补血。

主方：发病时重在养心宁神，宜与加味甘麦大枣汤④；平时重在益气补血，宜用归脾汤⑤健脾养心。如此交替治疗，神气健全，其病可愈。

(五) 百合病

主证：平日性情急躁，易动惊疑，心情舒畅，一如常人，偶有不遂，骤然发病。其病发作，心中烦乱，惊悸不安，如寒无寒，如热无热，似饱似饥，胸闷噫气，呻吟不已，患者不可名状，有如一身俱病，口干苦，尿黄赤，脉细数。

证析：本病因于阴虚神弱、郁火羁留而发病。阴虚者性常躁，神弱者善惊疑，故其人平日性躁而多疑虑。心藏神，为一身之主，心静则神静，神静则郁火隐伏，是以心情舒畅，一如常人。心动则神动，神动引动郁火，则火动神乱而发病，是以偶有不遂，其病发作。郁火扰心，神舍不宁，故烦乱惊悸，行卧不安。气机逆乱，荣卫失调，故表现身如有寒而实非寒，身如有热而实非热。肝气郁滞，

脾气不畅，故见似饥似饱，胸闷噫气。神乱不安，故见呻吟不已。口干苦，尿黄赤，舌质红，脉细数，均为阴虚内热病象。正因本病以神乱则病作，神静则病安为特点，故常表现发作无常，病来迅速，病去亦速。又因本病有轻有重，重者病变多端，轻者其证不必悉具，或只表现某一惊疑证候。

治法：滋阴清火，养血宁神。

主方：以百地丹枣汤^⑥为基本方。随其证候变化加味治疗。一般说来，本病只宜平剂调治，不可妄施补剂，尤忌发汗攻下。补剂助阳动火，易于促使病情加剧；汗下伤津耗气，易致愈虚其虚。再因其病发作，证状多端，故当遵守《金匱》治百合病各随其证治之的原则。

上列诸证，都属于因郁成病而在气郁阶段所表现的疾病。治疗此类病证，总以理气开郁为主，痞气、梅核气、郁火属于实证，主以顺气行滞、清泻肝火；脏躁证、百合病属于虚证，主以调补气阴、宁心安神。由于神志疾患，大多病期长，反复大，故应采取已发治标、未发治本的原则。同时对解除患者苦闷因素，使能转移性情，增强治疗信心，更可收到事半功倍之效。否则纯恃药石，其效不佳。至于由此发展而成胃痛、噎膈、癫狂、癥瘕以及其它种种疾病，可参考有关专篇所论治法。

三、方药化裁

1. 瓜蒌郁枳汤

全瓜蒌24克（壳仁各半） 薤白12克 郁金18克

香附15克 枳实12克 白术18克 隔山消30克 南藿香10克

此方宽胸解郁，理气行滞。适用于肝胃郁滞，证见胸脘痞胀，噫气连声，大便不爽，或结滞难通，舌白腻，脉弦滑者。方中瓜蒌、薤白宽胸散结；郁金、香附开郁理气；枳实、白术和胃行滞；隔山消、藿香和中消痞。胃气和降，肠气得通，气机顺利，痞消噫止。

一位50余岁男性病员，于8年前因心事不快而发病。治愈后，每因情绪不畅，其病发作。发病时，噫气连声，声震屋宇，脘腹痞胀，大便不爽，欲便难通。每发一次，可持续半月至一月以上，方能渐次消退。来诊时，发病已一周，舌苔厚腻，脉沉弦有力，余令服本方3剂。他服药后复诊，一剂得矢气通畅，二剂得大便爽利，三剂已痞消噫止。此后，患者如遇发病，连进本方1~2剂，便能控制病情。今已5年，未见发病。可见本方开郁顺气力量颇优。

凡用本方以大便畅通为度，如食欲未开，脘闷未除，宜改用健脾和胃方药调理。

2. 加味半夏厚朴汤

法半夏12克 厚朴15克 茯苓20克 生姜3克 紫苏叶3克 郁金15克 香附15克

此即《金匱要略》半夏厚朴汤加味而成，功能理气开郁，化痰降逆。适用于梅核气病，证见咽中梗阻，吐咽不去，发作无常，舌苔厚腻，脉象弦滑者。痰由湿聚，故用半夏、生姜温中和胃，燥痰降逆。痰由气郁，故用厚朴、茯苓宽中渗湿，散结消痰。紫苏叶开宣肺气，以通气道。

郁金、香附行气解郁，以利气机。方药配合，辛开苦降，气降则痰降，气利则痰消。如发作为甚，见脘痞呕恶者，加枳实、藿香，以消痞止呕；见喘满气急者，加乌药、沉香，以顺气降逆。

一中年妇女，初因其子暴病危急，突受惊恐而致发病，几年来偶触惊疑，其病发作。来诊时，患者自觉喉间如有物阻，吐不出，咽不下，时轻时重，时有时无，甚则烦乱不安，喘满气急，不能平卧。经医院多次检查，咽喉、心、肺均无异常，舌苔白腻，脉弦不匀。余诊为梅核气病，用本方加酸枣仁15克，远志6克，以加强宁心安神之力，令服4剂复诊。二次来诊，证状消退，舌净脉平。患者因恐病情复发，嘱赐常服方药，余以原方令其早晚各服1次，俟病情稳定逐渐停药。如此服药1年，其病未见复发。由此可知，大凡神志疾病，如不坚持治疗，是难以取得疗效的。

3. 越鞠丸（《丹溪心法》）

香附 苍术 川芎 神曲 梔子 各等分

此方行气开郁并能疏解气、血、食、痰、火热，是一首通治郁证的基础方剂。适用于肝郁化火，证见胸脘痞闷，饮食不消，心烦口苦者。方用香附、川芎行气行血，以开郁滞；苍术、神曲健脾和胃，以消食积；梔子清心除烦，以泻郁火。肝气畅，火热清，脾气升，胃气降，则气、火、食、痰诸郁自解。

如食滞气阻，胸脘胀甚者，加郁金、枳实理气消痞。如郁火内扰，心烦不眠，或睡眠多梦者，加丹参、酸枣仁、夜交藤宁心安神。如郁火上冲，头痛目赤者，去苍术，

加决明子、钩藤、菊花，以平肝热、清头目。如热甚伤津，心烦口渴者，加知母、花粉，以生津除烦；肠燥便秘者，加柏子仁、郁李仁，以润肠通便。

4. 加味甘麦大枣汤

小麦60克 甘草10克 大枣10枚 丹参10克 酸枣仁10克 钩藤20克 龙齿20克

此即《金匱要略》甘麦大枣汤加味组成，功能宁心养血，平肝安神。适用于脏躁发病，悲伤哭泣，不能自制，神恍易惊，睡眠多梦者。方中小麦性味甘平以养心气；甘草、大枣甘润养血以安神气；丹参、枣仁宁心安神；钩藤、龙齿平肝镇惊。故本方用于脏躁发病，能调节心肝而收止躁安神之效。

一王姓妇，因家事不遂，忧郁寡欢，久而出现无故悲戚，不能自主，常于梦中惊叫哭泣，醒后不知。因发病未久，投以本方，始而日尽一剂，连服一周，眠安哭止；继令3日一剂，服药3月有余，病得痊愈。说明甘草、小麦、大枣药性平和，而于脏躁一证，实有不可思议之效。

5. 归脾汤（《济生方》）

黄芪20克 太子参20克 白术15克 茯苓15克 龙眼肉3克 酸枣仁10克 当归6克 木香6克 远志6克 甘草3克 大枣3枚 生姜1薄片

此方健脾养心，益气补血。方中太子参、黄芪、茯苓、白术健脾益气；枣仁、远志、龙眼肉、当归养血宁心；甘草、大枣和中养荣；木香理气醒脾，使其补而不滞。凡因心脾不足，气虚血少，现心悸健忘，倦怠食少，不寐多梦，舌淡脉弱等证，均为本方主治范围。脏躁病久，气血

亏虚，可用本方作为调补方剂。健脾便是补血，养心即可宁神，但宜轻剂缓补为佳。

一虞姓妇，于10年前亡夫丧子，忧郁致病。平素寡于言笑，时作长叹呻吟，稍有不遂，悲伤不止，渐于月经前后无故悲泣，不能自制。现已断经3年，其证发作无间，偶与人言亦不自觉而泣泪难忍，因而常喜独居一室，不欲与人言笑。此属脏躁病久、心脾亏虚所致。因其证发无间歇，余以加味甘麦大枣汤为甲方，归脾汤为乙方，令其交替进服。开始先进甲方三剂，后进乙方一剂，继则甲、乙方各进二剂，渐次各进一剂，经治疗半年，逐渐停药而愈。本病采用安抚与调补兼施的治法，使多年顽疾取得满意疗效。

6. 百地丹枣汤

米百合15克 生地黄15克 丹参15克 酸枣仁15克

这是一首治疗百合病的基础方剂，功能养阴清热，宁心安神。适用于百合病发作，心中烦乱，惊悸不安，神思恍惚，莫名所苦者。方中百合甘淡微寒，以清气分之热；生地凉血生津，以清血分之热；二药合配，即《金匱》百合地黄汤。丹参和调血脉，清热除烦；枣仁滋肝养血，宁心安神；二药与百合、生地黄合配，其养阴清热，宁心安神之效，更臻全面。可将本方作为基础，随其证候变化增损化裁。

如口中干渴，为内热伤津，加知母、花粉生津止渴。失眠多梦者，加龙齿、夜交藤，以镇肝安神。惊悸多汗者，加五味子、麦门冬，以宁心敛阳。头目昏痛者，加钩藤、天麻，以平肝止痛。不思饮食者，加山药、谷芽，以

健脾开胃。大便干结者，加当归、柏子仁，以润肠通便。如见呕吐、腹泻者，去生地黄，加砂仁、藿香，以和胃温中。总之，凡用本方加减法，皆以中病即止，勿使过剂，防生它变。平时调理，也以和脾养胃、清心安神为主，用药宜于平和，切勿过清妄补。

一任姓妇，30余岁，因一事隐曲，久郁致病。平日性躁易怒，其病未发，一如常人，偶有不遂，骤然发病。发病时，心中烦乱，行卧不安，胸闷噎气，呻吟不已，自觉一身俱病，莫名所苦。有时出现惊悸闷乱，如寒如热，汗出如雨；有时出现呕吐、腹泻，四肢清冷。发病期间，口中干苦，舌红少苔，脉现弦细急数。服药数百剂无显效，前医用方，或以归脾汤而致彻夜不眠；或以附子理中汤而致烦渴难忍；或以龙胆泻肝汤而致腹泻肢冷。我于其发病时，按百地丹枣汤加减法治疗，一般进药2~3剂，其病即可消退。间歇期间为其拟一养阴和脾、宁心安神方药（钩藤、百合、丹参、枣仁、五味、麦门冬、山药、茯苓、制首乌、谷芽），令其常服。如此调治年余，其病渐趋稳定而愈。可见，本病妄施清、泻、温、补诸法，皆非所宜。（表15）

表15

郁证病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
忧思隐怒久而不释，心神不畅，肝气内郁。肝气犯胃，气滞食阻；肝脾失疏，气郁生痰，留滞气道；肝郁化火，神舍难安。肝脾久郁，气血亏虚，或血虚神弱，神志迷乱；或荣阴亏虚，内热羁留，神舍不安	痞气	疏肝开郁 宽中理气	瓜蒌郁枳汤
	梅核气	理气开郁 化痰降逆	加味半夏厚朴汤
	郁火	调理肝脾 清泻郁火	越鞠丸加减
	脏躁	养心宁神 益气补血	加味甘麦大枣汤 归脾汤
	百合病	滋阴清火 养血安神	百地丹枣汤随证 加减

第二节 眩 晕

眩晕是以头旋眼花为主证的一种病证。其证轻者闭目即止，重者天旋地转，如坐舟车，不能站立，甚则伴有恶心、呕吐证状。凡医籍中所称眩冒、目眩、头晕、眩晕等，皆属同类疾病。

本病可由外感、内伤及外伤等因素引起发病。本篇着重以内因肝肾、心脾亏虚导致的眩晕作出论述。

一、病因病机

关于眩晕发病的原因，历代医家各有所见，对此，陈修园《医学从众录》总结得很好。如说：“盖风非外来之风，指厥阴肝木而言，与少阳相火同居，厥阴气逆，则风

生而火发，故河间以风火立论也。风生必挟木势而克土，土病则聚液而成痰，故仲景以痰饮立论，丹溪以痰火立论也。究之肾为肝母，肾主藏精，精虚则脑海空虚而头重，故《内经》以肾虚及髓海不足立论也。其言虚者，言其病根，其言实者，言其病象，理本一贯。”由此说明，内因眩晕多因风、火、痰、虚互为因果引起发病，而以肝肾、心脾亏虚为其致病之根。

肝肾不足：肝为风木之脏，其性主动主升，肾为主水之脏，受藏脏腑之精，肝阳以肾阴为其体，肾阴以肝阳为其用，二者母子相生，互为功用。肾阴充沛，木得水涵，肝气冲和，即能升发津血精髓，外而生养形骸，内而腴润脏腑，上而滋养神明。如平日忧郁谋虑太过，气郁化火，暗耗肝阴，木少滋荣，火动风生，上扰清空；或因热病、大病之后，伤及肾阴失于调治，水不涵木，风阳升动，则头目不清。由此发生的眩晕，皆属上盛下虚，本虚标实之证。

如肝旺日久，精血日亏，或老年体衰，精气不足，或大病之后重伤肾气，又能导致精气两虚，病深及肾。肾藏精生髓，脑为髓之海，肾精亏损，精不化气，精气不能上奉于脑，则脑海空虚，于是上下俱虚，发生眩晕。

心脾亏虚：心主血脉，脾主健运，或以脾运失司，聚湿生痰，或以心脾同虚，气血虚弱，均可发生眩晕。如饮食劳倦损伤脾胃，或肝阳素旺侮其所胜，致使脾运迟滞不能运化水谷精微，于是聚湿生痰，隐伏中焦。每因烦劳恼怒，痰随气逆，或风动痰升，而致引起发病。由此发生的眩晕，其主因在于痰气上逆，故属本虚标实之证。

如脾虚日久，或平日过用神思，内伤心脾，脾虚则生化之源不足，心虚则血液循行不周，气血不能上奉于脑，于是出现头眩眼花。它如外伤、吐血、便血、衄血、妇女崩漏等因素引起的眩晕，亦多因于失血过多，气随血耗，气血虚弱，清窍失养所致。由此发生的眩晕，则属心脾同亏，上下俱虚之证。

由此可见，眩晕病机有标本虚实的不同，肝肾、心脾亏虚是其致病之本，而风（肝风）、火、痰则是致病之标。所以，其病往往互为因果，虚实互见。其间尤以肝阳素旺发生的眩晕，更应注意发展为中风先兆。

二、辨证施治

眩晕一证，以中、老年人多见，临床上着重区别风阳偏旺、痰气上逆、精气亏虚、血虚气弱四类证候。属于风阳偏旺、痰气上逆者，多本虚标实，发病期宜去实以治其标，病情缓和则当扶虚以治其本。属于精气亏虚、血虚气弱者，治宜标本兼顾，重在扶虚。现分别论治如下：

（一）风阳偏旺

主证：头目昏胀眩晕，每因烦劳或恼怒而加剧，面时潮红，急躁易怒，心烦多梦，口干苦，舌质红，苔薄黄，脉弦滑、或弦数、或弦大而劲。

证析：本病以肝阴不足为致病之本，以肝阳偏亢为致病之标。风阳偏旺，最易化火，火动风升，上扰清空，故头目眩晕，面时潮红。肝气有余，是以性躁易怒。每因烦劳恼怒，激动肝阳，是以眩晕加剧。肝阳上扰，神舍不安，

故心烦多梦。肝火内盛，耗伤津液，故口中干苦。舌红苔黄，脉弦滑、弦数、弦大、弦劲，皆为阴虚火旺、肝木失养病证。

治法：平肝息风，滋阴清火。

主方：以钩藤汤^①为主方，随证加减。本病常虚实并见，实者宜清宜镇，虚者宜滋宜补，是方治实而兼顾其虚，可视虚实多少、风火轻重而与潜镇清火、滋养肝肾药味出入化裁。

（二）精气亏虚

主证：头目昏眩，耳鸣心悸，少寐多梦，记事善忘，腰膝酸软，或见肢末麻木，脉多弦细。

兼颜面泛红，心中烦悸，手足心热，舌质淡红，脉弦细数者，属肾阴偏虚。

兼颜面苍白，手足清冷，脚胫浮肿，舌质白淡，脉沉细弱者，属肾阳偏虚。

证析：肝旺日久，或老年体衰，均可出现肾中精气亏虚病变。肝旺日久，风火内扰，劫耗肾精，或年岁日增，肾精渐虚，久则精不化气，由实转虚，病深及肾。精气不能上供于脑，清窍失养，故头眩耳鸣。精气不能奉养于心，心虚神弱，故心悸善忘，少寐多梦。肝主筋，腰为肾之府，精气亏虚，筋脉失于温养，是以腰膝酸软，或见肢末麻木。弦为肝脉，细主阴虚，故其脉以弦细为多见。偏于阴虚者，阴虚不能敛阳，阳盛而生内热，故面红烦悸，手足心热，舌淡红，脉弦细数。偏于阳虚者，阳虚水气不化，阴盛而生外寒，故面白肢冷，脚胫浮肿，舌白淡，脉沉细弱。

治法：温养肝肾，育阴敛阳。

主方：以首乌汤②为主方。本方补肾添精，补肾便是补脑，添精即可柔肝，可视其气、阴偏虚的不同，或滋肾为主兼助其阳，或温补肝肾而偏重滋阴。

上列二证，如见于平素肝旺之人，其证往往互为转化，交替出现。对此，肝旺时用钩藤汤平息肝风以治其标，肝气平息则用首乌汤育阴潜阳以治其本。

（三）痰气上逆

主证：头目眩晕，昏重如蒙，如坐舟车，不能站立，脘闷恶心，甚则呕吐，倦怠多寐，舌苔白腻，脉多弦缓。

如兼头痛鼻塞，属于外挟风邪。

如兼头目昏胀，心烦口苦，舌苔黄腻，脉象弦滑，属于痰郁化火。

证析：本病男女皆有，而以中年妇女较多见，且每因操劳过度，或触恼怒而发病。脾气素亏，聚湿生痰，平时痰气隐伏，一如常人。或以劳倦伤气，气虚则痰气泛逆；或以恼怒伤肝，肝伤则风动痰升。痰气上逆，蒙蔽清阳，故头目昏重如蒙、眩晕如坐舟车。痰气阻遏中焦，胃失和降，故脘闷恶心，甚则呕吐。脾阳不振，是以倦怠而多寐。舌白腻，脉弦缓，皆为风痰挟虚的病证。如兼头痛鼻塞，是为外感风邪、表卫失畅引起；如兼心烦口苦，苔黄脉滑，则属痰已化热。

治法：健脾渗湿，除痰降逆。

主方：以半夏白术天麻汤③为主方。本方降痰扶虚，标本兼顾，可随兼挟证候的不同及病情的轻重缓急，随证加减。

(四) 气血亏虚

主证：头目眩晕，劳累即发，面色萎黄，肤发不泽，唇甲色淡，心悸少寐，神倦懒言，口淡食少，舌质淡，脉细弱。

证析：本病可见于大病或失血之后，尤以中年妇女有月经过多疾患者，多见此证。心主血脉，其华在面，脾主健运，生化气血。心脾亏损，气血不足，不能上奉于头，清空失养，故头目眩晕，劳累即发。血虚不能荣泽肌肤肢末，故颜面萎黄，肤发不泽，唇甲色淡。血虚不能养心则心悸，不能养神则少寐。气虚则神倦懒言，口淡食少。舌质淡，脉细弱，为气血两虚之象。

治法：培补心脾，益气养血。

主方：以归脾汤④为主方。本方用于血虚眩晕，重在益气健脾，兼能补血养肝，宁心安神。如因妇女月经过多而致病者，尚应兼治其经，方能断其致病之根。对此，可参考血证中崩漏治法。

上列二证，如见于平素心脾亏虚之人，其证亦多互为转化，交替出现。余在临证中，常对眩晕发病见胸闷呕吐者，先以半夏白术天麻汤降痰止呕，俟呕势稳定即用归脾汤调补心脾，颇能取得良好疗好。由此说明，二者间的关系，又是互为因果的。

三、方药化裁

1. 钩藤汤

钩藤24克 决明子24克 茺蔚子20克 黄芩15克

夏枯草20克 丹参20克 女贞子20克 怀牛膝15克 山药20克

此方平肝息风，滋阴清火。适用于阴虚肝旺，证见头目昏胀眩晕，颜面潮红，性躁心烦，口干苦，舌红苔黄，脉弦滑或弦数者。方以钩藤、决明子、茺蔚子平肝息风；黄芩、夏枯草清泻肝火；丹参、女贞子滋肾养肝；牛膝导血下行，山药健脾运行药力。是方标本兼顾，常用于高血压属阴虚肝旺者，其效甚佳。

如眩晕而自觉上重下轻，两寸脉独见弦盛有力者，此属风阳翕张，可加龙骨、牡蛎以镇肝潜阳。如见面红目赤，心烦口苦者，此属肝火偏盛，加龙胆草、丹皮，以清肝泄火。如见心中烦悸，多梦少寐者；此属心阴不足，加酸枣仁、五味子，以养心宁神。

2. 首乌汤

制首乌20克 明天麻10克 熟地黄10克 枸杞10克
山茱萸10克 炒杜仲20克 山药20克

此方补养肝肾，育阴敛阳。适用于肝肾不足，精气亏虚，证见头晕耳鸣，心悸健忘，少寐多梦，腰膝酸软，或肢末麻木，脉象弦细者。方中首乌、熟地黄、枸杞养血添精。天麻入肝，息风止晕。山茱萸、杜仲入肾，育阴敛阳。山药入脾，使其补而不滞。肾精恢复，肝阳下潜，眩晕可止。

肝阳素旺，偏于阴虚者，可酌加钩藤、石决明、丹参、酸枣仁、麦门冬之属，平肝息风，宁心养血。年老体衰，偏于阳虚者，可酌加白术、茯苓、制附片之属，温肾助阳，健脾化湿。

3. 半夏白术天麻汤（《医学心悟》）

法半夏10克 明天麻10克 茯苓15克 橘皮10克
白术15克 甘草3克 大枣2枚 生姜1薄片

此方健脾渗湿，除痰降逆。适用于风痰眩晕，证见头晕欲倒，不能站立，胸闷呕恶，苔白腻，脉弦缓者。方以半夏、橘皮燥痰降逆；白术、茯苓健脾运湿；天麻息风止晕；甘草、大枣、生姜和中止呕。是方标本兼顾，用于风痰眩晕，确具卓效。

兼头痛鼻塞，外夹风邪者，加钩藤、白芷，以疏风散邪。兼心烦口苦，苔黄脉滑，痰郁化火者，加黄芩、龙胆草，清泻郁火。恶心呕吐甚者，宜加重半夏剂量，再加枳壳、藿香，以和胃降逆。

4. 归脾汤

方药见本章郁证篇第五方。

本方培补心脾，益气养血。适用于眩晕虚证属心脾不足者。脾为生化气血之源，脾旺则血旺，血旺则心静神安，而眩晕、心悸、健忘、倦怠诸证自可痊愈。（表16）

表16 眩晕病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
肝阴不足，风阳升动，上扰清空，本虚标实；肾精亏虚，精不化气，脑海不足，上下俱虚。 脾虚生痰，痰随气逆，蒙蔽清阳，本虚标实；心脾不足，血虚气弱，清空失养，上下俱虚	风偏阳旺	平肝息风 滋阴降火	钩藤汤
	精亏气虚	温养肝肾 育阴敛阳	首乌汤
	痰上气逆	健脾渗湿 除痰降逆	半夏白术天麻汤
	气亏血虚	培补心脾 益气养血	归脾汤

第三节 中 风

中风是以口眼歪斜，语言蹇涩，或偏侧手足麻木不遂，或突然昏仆不省人事为主证的一类疾病。由于主因属风，起病骤急，有如“矢石中的”，故名中风。此与《伤寒论·太阳篇》所论之“中风”名同实异。

本病分外中风、内中风两种病证。外中风因于荣卫稍衰，风邪乘虚入中，引起发病。其证颜面麻痹，口眼歪斜，或见偏侧手足拘急麻木，此属经络受病，风痹络瘀所致。内中风因于肝风内盛，肝阳暴动，引起发病。其证突然昏倒，不省人事，伴见口眼歪斜，舌强言蹇，半身不遂，此属脏腑受病，气血奔迫所致。外中风无昏仆，经过治疗，愈后良好。内中风于昏仆后，显现口眼歪斜，舌强言蹇，半身不遂，经过治疗，大多有不同程度的后遗症。由此可见，二者同属中风，但在病因病机和证候表现上是各不相同的，临床上应严加区别。

中风与厥证的鉴别：厥证发病，突然昏倒，不省人事，但不见口眼歪斜，手足偏废等证，以此有别于中风。

一、病因病机

荣卫稍衰，外风入中。《灵枢·刺节真邪篇》说：“虚邪偏容于身半，其入深，内居荣卫，荣卫稍衰，则真气去，邪气独留，发为偏枯。”由此可知，凡人体于窗口静坐，或于夜间睡卧之际，如腠理不密，荣卫稍衰，即易

招致风寒湿邪乘虚入中，致使经络闭塞，络瘀气阻，引起发病。邪留经络，荣卫痹阻，卫气不行，则肌肤麻木。邪中于面，受病一侧，因寒收引，络脉不畅，则发生口眼歪斜，语言不利。邪中身半，留滞荣卫，筋脉不利，则发生偏侧手足不遂，肢体拘急。《金匱·中风篇》所说：“贼邪不泻，或左或右，邪气反缓，正气即急，正气引邪，喎僻不遂。”亦即指此。

肝风内动，气血奔迫。《临证指南》说：“内风乃身中阳气之变动，肝为风脏，因精血衰耗，水不涵木，木少滋荣，故肝阳偏亢，内风时起。”由此可知，精血不足，肝阳偏亢，是造成内中风发病的前因。肝藏血，肾藏精，营血不足，血不养肝，则络脉空虚；肾精亏耗，水不涵木，则筋骨失养。肝为风脏，主动主升，肝木失涵，肝阳不潜，则肝风内盛。风阳偏旺，上扰清空，则头目眩晕；精血不足，不能润养肢末，则手指麻木；肝旺而侮犯脾土，又能聚液生痰。故内中风发病前可见头晕、指麻、多痰等先兆证候。当此之际，如将息失宜，烦劳太过，或喜怒惊恐有所过极，便能引起心火暴动，肝风翕张，火动风升，气血奔迫，并走于上，而致卒倒神昏。所以，刘完素说：“中风瘫痪者”，“非外中于风”，乃“五志有所过极”，“将息失宜”，“心火暴甚，肾水虚衰，不能制之”，故“心神昏冒，筋骨不用，卒倒无所知也”。

由上说明，外中风乃风从外至，病在经络，非关脏腑；内中风乃风从内生，病在脏腑，累及经络。同属中风，一为外中，一为内中，中经络者轻，中脏腑者重，病因不同，病机各异，必须严格区辨，不容混淆。

二、辨证施治

(一) 外中风

外中风由感受风、寒、湿邪痹阻经络引起发病，邪中于面，发为面瘫；邪中身半，发为偏瘫。

1. 面瘫

主证：颜面一侧口眼歪斜，偏侧眼睑不能闭合，不能皱眉，说话漏风，流口水，不能吹口哨，饮水易于漏出，食物咀嚼不便，患侧感觉麻木，不觉疼痛，脉多沉弦。

本病常起病突然，每在吹风受寒后，于次日晨起发现颜面喎僻不遂，较多见于中壮年病人。

证析：颜面受邪，络脉痹阻，寒性收引，故口眼一侧歪斜不遂。寒气凝涩，留着不去，荣卫不能充灌于肌肤，故病侧麻木而无疼痛。脉象沉弦，为寒气闭塞之象。

治法：疏风解痉，和荣活络。

主方：用加味牵正散^①为主方。本方功能祛风解痉，用于风痹面瘫极为得力。

2. 偏瘫

主证：或左或右，手足麻木，肌肤不仁，甚则半身不遂，可见寒热头痛，肢体拘急，手足酸重，舌苔白腻，脉多弦紧。

本病轻重不一，轻者只觉手足酸重，或有寒热；重者半身不遂，肢体拘急，伸屈不便；每于受寒受湿后发病。

证析：荣卫稍衰，腠理不密，风寒湿邪乘虚而入，身

半受邪，内居荣卫，经络痹阻，发为偏瘫。风性流窜，寒性凝涩，湿性沉滞，中邪轻者，病轻邪浅，荣卫失畅，筋脉不利，故见寒热头痛，手足酸重。中邪重者，病重邪深，荣血闭塞，卫气不行，筋脉拘急，故见半身不遂，肌肤不仁，伸屈不便。苔白腻，脉弦紧，为阴寒阻闭之证。

治法：祛风通络，益气和荣。

主方：以黄芪秦艽汤^②为主方。依据中邪浅深，病情轻重，随证化裁。

（二）内中风

内中风多见于中老年人，皆由肝风内动、气血奔迫引起发病。一般于中风前有先兆证出现，中风后有轻重不同的后遗证状，故临床上要分先兆、卒中、后遗三个阶段辨证施治。

1. 先兆证

主证：时觉头目眩晕，昏胀作痛，颜面潮红，自觉头重足轻，多痰健忘，或兼见轻微鼻衄，一侧手指发麻，肌肉微掣，短暂性语言不利等证，舌苔厚腻，脉弦大而劲。

本病以肝阳素旺为前因，上列证状不必悉具，但见一证即应注意是否中风先兆，必须立即防治。但须指出，因于烦劳或暴喜暴怒引起卒中而无先兆证状者，也不少见。

证析：肝阳素旺之人，由于肝旺日久，荣阴亏耗，日渐形成阳虚阴盛。阳盛于上，肝风时起，上扰清空，故头目昏眩胀痛，面颊潮红。上盛下虚，故觉头重足轻。血不养神，则健忘。木旺侮土，则多痰。风阳上盛，损伤脉络，故见鼻衄。营血不能充灌肢末，故见手指麻木。风阳挟痰流窜经络，则见肌肉抽掣。风痰上窜舌络，则见语言不

利。舌苔厚腻，脉弦大而劲，为阴虚阳盛、风痰内蕴之征。凡此，皆属中风先兆。

治法：镇肝息风，滋阴潜阳。

主方：肝阳偏旺，治宜镇肝息风，用钩藤^③汤；精气偏亏，治宜滋肾潜阳，用首乌汤^④。依据病情，参考眩晕证治。

2. 卒中证

主证：起病突然，昏仆无知，或左或右，口眼歪斜，舌强不语，半身不遂，肢体瘫痪，分闭证和脱证。

闭证，突然昏仆，不省人事，牙关紧闭，面赤气粗，两手握固，舌质红，苔黄腻，脉弦劲滑数，为阳闭；如牙关紧闭，静而不烦，痰涎壅盛，面白唇紫，四肢不温，苔白滑腻，脉沉弦或弦滑，为阴闭。

脱证，突然昏仆，不省人事，目合口开，鼻鼾息微，手撒遗尿，汗出肢冷，舌痿，脉细弱，为阴血大亏、元阳虚脱；如见面赤足冷，汗出痰壅，脉浮大无根，或沉细欲绝，为真阴亏竭、孤阳奔越。

凡卒中昏仆，如昏迷日深，见摇头上窜，鱼口气粗，直视痰涌，头面青紫，大吐大泻，吐血下血等证者，主危。

初中之脉，多见沉迟或沉伏，移时气还，可见弦劲、或弦大洪数。如渐次脉来缓和，属病势好转；如渐次脉现沉细、沉涩、或沉微欲绝、或浮大无根、或散乱不匀者，属于病势恶化。

证析：卒中发病，多以将息失宜，肝阳暴甚，火动风升，气血奔迫，而致仆倒神昏。气血奔逆，经络闭塞，

受病一侧络脉瘀阻，无病一侧正气独盛，病侧为正气牵引，故或左或右，口眼歪斜，半身不遂。素体强壮者，多见闭证；素体衰弱者，多见脱证；也有先闭后脱而致危及生命者。肝阳暴动，风火痰涎奔逆于上，发为闭证。阳闭为风火偏盛，气血奔逆，阻闭清窍，故面赤气粗，两手握固；风火挟痰，故舌质红，苔黄腻，脉弦劲滑数。阴闭为风痰偏盛，上壅清窍，神机闭塞，故静而不烦，面白唇紫，四肢不温；痰涎壅阻，阳气内闭，故苔白滑腻，脉沉弦或弦滑。精气虚亏，阴阳离决，发为脱证。阳气偏虚，衰微欲脱，则见目合口开，鼻鼾息微，手撒遗尿，汗出肢冷；舌痿，脉细弱，为阴亏阳微之象。阴精偏亏，孤阳上浮，则见面赤足冷，汗出痰壅；脉浮大无根，或沉微欲绝，为阴阳越脱之证。凡此，皆属危重证候，如救治不及，往往危及生命。

卒中发病，亦有不经昏仆，仅短暂迷糊，即现口眼歪斜，舌强言蹇，半身不遂等证，此属轻病。其辨证施治原则，大体与后遗证同。

治法：开闭固脱，平肝救逆。

主方：治闭证宜先开窍，阳闭为风火偏盛，先用至宝丹⑤辛凉开窍，再用羚羊夏枯汤⑥清火降逆，滋阴潜阳；阴闭为风痰闭塞，先用苏合香丸⑦辛温开窍，再用半夏白术天麻汤⑧加味，平肝息风，豁痰降逆。

治脱证宜先固脱，元阳虚脱者，急用参附汤⑨益气回阳；阴亏阳越者，可用地黄饮子⑩滋阴回阳，以防虚脱。

凡卒中初起，脉气闭塞，不可妄施方药，尤忌吹鼻取嚏治法，取嚏药多辛烈，恐促使气血奔脱，反致陷于不

救。俟其气还脉出，方可区别闭证脱证施治。总之，卒中以回苏救逆为主，清醒后以扶正救阴、平肝潜阳为主，并应慎于调护，防其复中昏迷。

3. 后遗证

主证：口眼喎斜，舌暗不语，半身不遂，肢体瘫痪，肌肤不仁，兼面白肢凉，倦乏嗜卧，舌淡苔白，脉沉细缓涩者，为气虚血滞、络脉瘀阻；兼头目昏眩胀痛，心烦面红，夜寐不安，舌红苔黄，脉弦细劲数者，为阴虚肝旺、风痰阻络。

证析：卒中轻证或重证，在神志清醒后，由于风火痰涎留滞经隧，瘀阻脉络，多有上述后遗证状可见。其人阳气素虚者，表现为气虚血滞，经隧不通。气虚不能温达于肌肤，故面白肢凉。气虚则神弱，故倦乏嗜卧。舌淡苔白，脉沉细涩，主气虚血滞。其人荣阴素虚者，表现为阴虚络瘀，风阳偏旺。风阳偏旺，上扰清空，故头目昏眩胀痛。风火内扰，神舍不安，故心烦面红，夜寐不安。舌红苔黄，脉弦细劲数，主阴虚肝旺。

治法：扶虚潜阴以治其本，化瘀通络以治其标。

主方：属气虚血滞者，治宜益气养血化瘀通络，以补阳还五汤^①为主方，补其阳气，通其瘀滞，气行则血行，血行则瘀消。属阴虚络瘀者，治宜滋阴平肝通瘀活络，以养血通瘀汤^②为主方，滋养阴血，涵敛肝阳，虽有瘀滞，增水便可行舟。

此外，还可配合针刺、按摩等法，更能提高治疗效果。（表17）

表17 外中风与内中风的鉴别

	外 中 风	内 中 风
发病年龄	青年壮年中年	中年老年
病 前 史	吹风受寒受湿，或素有风寒湿痹宿疾	肝阳素旺，病前出现手指发麻，或肌肉抽掣
发病情况	大多于睡眠后，次日晨起发病	大多因于情绪激动，突然发病
神志状态	清 醒	大多昏迷
体 征	口眼歪斜，肌肤麻木，或仅见半身不遂，肢体拘急	口眼歪斜，半身不遂，肢体瘫痪，肌肤麻木，舌强言蹇
预 后	经过治疗，无后遗症	经过治疗，一般有后遗症

三、方药化裁

1. 加味牵正散

钩藤20克 秦艽20克 白僵蚕10克 全蝎粉3克（分2次冲服） 当归10克 木瓜15克 白芍20克 制白附子10克（久煎） 大枣12克 甘草6克

此方祛风解痉，和荣活络。适用于风痹面瘫，口眼歪斜，肌肤麻木，脉象沉弦者。本方即《杨氏家藏方》牵正散加味组成。方以钩藤、白附子辛散头面之风；僵蚕、全蝎祛风解痉；辅以秦艽、白芍、当归、木瓜等品，和调荣卫，疏风祛湿，通利经络。方药配合，力强效宏，用治面瘫初起，可于3~5剂中见奇功。

如久病失治，或素体气虚者，加黄芪30克，以助扶正托邪之力。

2. 黄芪秦艽汤

黄芪30克 秦艽20克 汉防己20克 蜈蚣2条 全蝎

6克 白芍24克 当归10克 川芎9克 木瓜15克 大枣12克 甘草6克

此方益气和荣，祛风通络。适用于风痹偏瘫，邪深入络，见半身不遂。肌肤麻木，肢体拘急，舌苔白腻，脉沉弦者。本病缘于荣卫亏虚，故以黄芪扶虚，鼓舞卫气，托散外邪。秦艽、防己、木瓜祛风散湿，通利经络。蜈蚣、全蝎入络搜风，舒挛解痉。诸药与当归、川芎、白芍、大枣、甘草等品配合，更能养血和荣以开痹塞。荣卫宣畅，经脉通利，邪无留处，不遂自解。

如兼见寒热头身酸痛者，此属受邪未深，卫气有祛邪外出之势，去黄芪、蜈蚣、全蝎，加白芷、防风，使风寒湿邪从表而解；如兼内热者，加黄芩，以收表里两解之功。

3. 钩藤汤

方药见本章眩晕篇第一方。

4. 首乌汤

方药见本章眩晕篇第二方。

5. 至宝丹（《和剂局方》）

犀角 牛黄 玳瑁 龙齿 朱砂 琥珀 麝香 雄黄 安息香 金箔 银箔

上药研末，配制为丸，每用3克，研碎送服（有成药）。

此方用于卒中神昏之阳闭证，取其辛香凉热、醒脑开闭，以救一时之急。如恐辛开耗气，可用人参3克，煎汤送服亦佳。仍须得效则止，不宜过用。

6. 羚羊夏枯汤

羚羊角3克（锉细冲服） 石决明24克 龟板24克

生地黄15克 丹参20克 白芍20克 夏枯草30克

此方凉肝息风，滋阴潜阳。适用于卒中神昏，风火上盛，证见面赤气粗，烦躁不宁，舌红苔黄，脉弦劲滑数者。方用羚羊角、石决明凉肝息风；龟板、生地黄滋阴潜阳；夏枯草清肝降逆；丹参、白芍平肝和荣，以去血中壅滞。风平火降，血脉和顺，神志得以渐苏。兼有痰多者，加天竺黄、竹沥，以助化痰开窍之力。

7. 苏合香丸（《和剂局方》）

白术 青木香 犀角 香附 朱砂 诃子 檀香
安息香 沉香 麝香 丁香 荜茇 龙脑 苏合香油
熏陆香

配制为丸，每用3克 研碎送服（有成药）。

此方由大队辛香药品组成，其性偏温，确具醒脑开窍之良功。卒中神昏之阴闭证，因于风痰闭塞，蒙蔽神机，用本方辛开温化，宣利气机，促其回苏以救一时之急。惟药多辛窜，仍宜得效即止，慎勿过用。

8. 半夏白术天麻汤

方药见本章眩晕篇第三方。

本方功能息风止晕，豁痰降逆。适用于卒中回苏，风痰偏盛，证见眩晕多痰，胸脘痞闷，神识呆滞，舌白腻，脉弦滑者。取其降痰息风，稳定病势，而使神志得以渐次恢复。胸闷甚者，加瓜蒌、枳实，以消痰下气。痰气壅盛者，加胆南星以祛逐痰涎。神识呆滞者，加郁金、石菖蒲，以开郁通窍。如有化热趋势者，可酌加黄芩、黄连。

9. 参附汤（《正体类要》）

人参10克 制附片10克

加水慢火久煮浓煎，徐徐喂服。

此方益气回阳，挽救虚脱，功效卓著。适用于卒中脱证，元阳衰微，见面白神昏，汗出肢冷，息微脉弱者。虚阳暴脱，非速用大温大补之品，不足以挽回阳气，参附合用，力专效宏，可取效于顷刻。一俟阳气回复，厥回神苏，再进调理方药。

10. 地黄饮子（《宣明论》）

干地黄 3 克 巴戟 3 克 山茱萸 3 克 石斛 3 克 肉苁蓉 3 克 五味子 3 克 茯苓 3 克 麦门冬 3 克 官桂 3 克 制附片 3 克 菖蒲 3 克 远志 3 克 大枣 2 枚 生姜 1 薄片

上药慢火浓煎，频频喂服。

此方滋阴回阳，开窍醒神。适用于卒中脱证，真阴大亏，虚阳浮越，见面赤足冷，汗出痰涌，脉浮大无根，或沉微欲绝者。方中用熟地黄、山茱萸等品滋补肾阴，以敛浮阳；用官桂、附片温补肾阳，以固虚脱；佐菖蒲、远志豁痰开窍；以生姜、大枣为辅，安胃和中。阴回阳复，则真元可固；虚火降，痰气开，则神志自清。因方药偏于温补，一俟阴回阳复，则当改用平肝潜阳之剂，以防过量引动肝阳，而致演生它变。

11. 补阳还五汤（《医林改错》）

黄芪 30 克 当归尾 6 克 川芎 6 克 桃仁 6 克 红花 6 克 地龙 15 克 赤芍 15 克

此方益气养血，活络通瘀。适用于卒中后遗证，素体气虚，血脉瘀滞，半身不遂，肌肤不仁，面白肢冷，倦乏少气，舌淡白，脉沉细缓涩者。方中重用黄芪以补阳气；

当归、川芎、桃仁、红花、地龙、赤芍养血活络，以通瘀滞。气足则顽麻可除，瘀消则偏废自解。如营血已亏，再加熟地黄，更能助水行舟而利通瘀。口眼歪斜者，加全蝎、僵蚕，以助息风解痉。痰多者，加胆南星、远志。

凡用本方应注意脉证变化，若脉象由沉细缓涩转为浮弦洪盛，其证渐见面红肤热者，则当停剂以防虚风再起。

12. 养血通瘀汤

钩藤20克 天麻10克 僵蚕10克 夏枯花10克 秦艽20克 白芍20克 丹参20克 生地黄20克 大枣12克 甘草6克

此方平肝息风，滋阴活络。适用于卒中后遗证，肝阳偏旺，肢体偏瘫，头晕面红，心烦不安，舌红苔黄，脉弦细数者。方用钩藤、僵蚕、天麻、夏枯花平肝息风，清利头目，以止眩晕；丹参、生地黄养血化瘀；秦艽、白芍、大枣、甘草通利经络，和调荣卫。肝风平息，络脉通利，不遂之证可渐消除。眩晕甚者，加龙骨、石决明，以镇肝潜阳。心烦不宁者，加酸枣仁、黄连，以清心安神。口眼歪斜者，加全蝎、地龙，以息风止痉。痰多者，加知母、贝母，以清热化痰。（表18）

表18

中风病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
外中风	荣卫稍衰，吹风受寒受湿，邪中经络，邪中于面为面瘫；邪中身半为偏瘫	面瘫	疏风解痉和荣活络	加味牵正散
		偏瘫	疏风通络益气和荣	黄芪秦艽汤
内中风	精气亏虚，肝阳偏旺，每因五志过极，或烦劳太过，导致心火暴动，火动风升，气血奔迫，痰随气逆，闭塞神机，发为卒中	先兆证	镇肝息风滋阴潜阳	钩藤汤 首乌汤
		卒中证	开闭固脱 平肝息风	至宝丹 羚羊夏枯汤 苏合香丸 半夏白术天麻汤 参附汤 地黄饮子
		后遗症	扶虚潜阳 化痰通络	补阳还五汤 养血通瘀汤

第四节 厥 证

厥证又称尸厥，以突然昏仆，不省人事，四肢厥冷为主证。一般经短时昏厥，可逐渐苏醒，如发病重者，不仅昏厥时间较长，且有一厥不复而致死亡的。

中风与痫证均见突然昏仆不省人事，惟厥证清醒后无口眼歪斜、失语、偏瘫等后遗症，以此有别于中风；在昏厥中，无四肢抽搐，口吐涎沫，不发出异常叫声，以此有别于痫证。

导致厥证发病的因素很多，所以古代医籍对厥证的分

类颇为广泛,本篇仅以比较多见的气厥、血厥、痰厥、食厥、暑厥等证作出论述。由于此类厥证皆以气机突然逆乱发病,因于气盛有余者,多挟血、挟痰、挟食逆而上壅,阻闭神机;因于元气虚弱者,常以清阳下陷,血不上承,而致神机失灵发生昏厥。由此可见,因于气血痰食所发生的昏厥,皆以气厥为主证,重在区辨属虚属实。伤于暑热者为中暑,轻者为伤暑,重则为暑厥。本篇将上述厥证分气厥、中暑二类论述。

一、病因病机

厥证皆由气机逆乱,升降失常,阴阳气不相顺接,引起发病。正如《证治汇补》所说:“外因六淫,内伤七情,气血痰食,皆能阻遏运行之机,致阴阳二气不相接续而厥作焉。”

(一) 气机逆乱

《素问·举痛论》说:“怒则气上”,“悲则气消”,“恐则气下”,“惊则气乱”,“劳则气耗”。由此可见,凡恼怒惊恐,过悲过劳,都可造成气机逆乱,致阴阳气不相顺接,发生突然昏厥。形体强弱不同,因而发病有虚有实。

形体素强,肝气旺盛,若因暴怒惊骇,肝气逆乱,上壅心胸,壅阻气道,闭塞神机,气闭神昏,口噤肢冷,发为气厥。如血随气逆,壅蔽清窍,见面赤唇紫者,为血厥;如其人素体多痰,痰随气升,壅塞气道,见喉有痰声,或呕吐涎沫者,为痰厥;如因饱食之后,骤逢恼怒,气食

相并，填塞中脘，上下阻隔，神机内闭，见昏厥而兼脘腹胀满者，为食厥。凡此皆由肝气逆乱，神机闭塞所致，多属实证。

形体素虚，元气不足，或因产后及其他疾病出血过多，致气随血耗，气血俱虚。气血不足，荣运不充，不能上奉于脑，每于直立过久，或蹲下起立之际，皆易发生头晕眼花。若烦劳太过，或偶触惊恐，一时气机逆乱，则中气下陷，清阳不升，发生突然昏厥。凡此皆由阴阳气不相接续，清窍失养，神机失灵所致，属于虚证。

（二）中伤暑热

夏月炎暑季节，在烈日下劳作或远行，最易发生中暑。由于热蒸汗出，腠理开疏，人体之阴津因汗而外泄，人体之阳气随汗而消散。阴亏则内燥生热，复为暑热所加，内外交蒸，轻则热遏心胸，病为伤暑；重则热壅气闭，神机失灵，突然昏倒，病为暑厥。此因热遏气闭，手足反见厥冷，故热微则厥微，热深则厥深。

二、辨证施治

（一）气厥

1. 实证

主证：其人形体素盛，多起病于情绪刺激，突然昏倒，不省人事，手足厥冷，口噤握拳，呼吸气粗，面青唇白，脉象沉弦。

兼面赤唇紫，舌色紫暗者，属于气血壅闭，又称血厥。

兼喉有痰声，或呕吐涎沫，舌苔厚腻，脉沉弦或沉滑者，属于痰气闭塞，又称痰厥。

兼脘腹胀满，起病于饱食之后，口臭苔腻，脉象滑实者，属于食气阻隔，又称食厥。

证析：暴怒惊骇，肝气逆乱，上壅心胸，阻闭神机，故突然昏倒，不省人事。气机郁闭，不能宣达于外，故手足厥冷，面青唇白。肝气暴张，筋脉挛急，故口噤握拳。气逆上壅，肺失宣降，故呼吸气粗。脉象沉弦，主气机郁闭。如其人血气素旺，血随气逆，壅迫于上，则见面赤唇紫，舌色紫暗，此属气闭而兼血郁。如其人平素多湿多痰，痰随气升，闭塞气道，则见喉有痰声，或呕吐痰沫，此属气闭而兼痰壅。如其人起因于饱食之后，气食相并，阻隔中脘，则见脘腹胀满，口臭脉滑，此属气闭而兼食阻。

治法：昏厥时，宜于通关开闭，急救回苏；清醒后，宜于理气解郁，舒肝和胃。

主方：先用搐鼻散^①取嚏，随即灌喂苏合香丸^②。醒后用乌附芍枳汤^③为主方，兼气闭血壅者，佐以活血行瘀；兼痰气闭塞者，辅以豁痰利气；兼食气阻隔者，配以消积和中。此外，于昏厥时急用针刺人中、合谷穴位，亦有促其回苏效力。

2. 虚证

主证：其人形体素弱，多起病于惊恐劳累，甚或饥饿、登厕、妇女月经期间也能诱发，突然眩晕昏仆，不省人事，面色苍白，汗出肢冷，呼吸低微，口开手撒，舌质淡，脉沉细弱。

如见于妇女产后、或素患经血崩漏、或其它疾病出血过多之人，则属气血双虚。

证析：气血亏虚，荣运不足，一时气机逆乱，阴阳气不相接续，因而神机失灵，昏仆无知。中气下陷，血不上承，故面色苍白，呼吸低微。虚阳奔逆，表卫不固，故汗出。气虚不顺，不能温达四肢，故肢冷。荣气不足，筋脉弛缓，故口开手撒。舌质淡，脉沉细弱，为气血亏虚之象。

治法：昏厥时，宜于益气固脱，促其回苏；清醒后，宜于益气养血，培补心脾。

主方：昏厥时，切忌取嚏方药，防其耗伤元气，可用灸法温灸百会、关元穴位，随即灌喂独参汤④以益气固脱。醒后用归芪生脉汤⑤为主方以培补气血，气偏虚者，辅以益气健脾；血偏虚者，佐以补血养心。对因于其他疾病而致气血亏虚者，更应重视原有疾病的治疗。

（二）中暑

中暑又称中暈，如较长时间在烈日或高温下劳作而感到有头晕、心悸、倦乏、郁闷、恶心等证出现，多为中暑先兆，应速至阴凉处给以清凉饮料，经短时休息，证状可以消失，若未及时预防，即可导致中暑发病。一般分别轻重，偏虚偏实，辨证施治。

1. 伤暑（轻证）

主证：头晕心烦，面色潮红，身热自汗，口渴引饮，唇舌干燥，舌红苔黄，脉洪数有力，属暑热内盛，津液耗伤，其证偏实；如头晕心悸，面色苍白，口渴多汗，倦怠喘乏，舌红少津，脉洪大乏力，或脉来细数而虚，为热

伤元气，气阴两亏，其证偏虚。

证析：伤暑轻重与平素体质强弱有密切关系。伤暑虽重，体质较强，证多偏实；伤暑虽轻，体质较弱，证多偏虚。其证偏实者，由于暑热内盛，郁遏心胸，故见头晕心烦，面色潮红。热蒸液迫，腠理开疏，故身热汗出。津液内亏，引水自救，故口渴引饮。唇舌干燥，舌红苔黄，为阴液耗伤。脉洪数主热盛，脉实为正气未虚。其证偏虚者，由于体液因汗而外泄，体气随汗而消散，故现气阴两亏证候。元气耗伤，清阳不升，故头晕心悸，面色苍白，倦怠喘乏。津液内亏，肺胃失养，故口渴多汗，舌红少津。脉洪大乏力、或细数而虚，均为气液两亏，内热稽留之象。

治法：以清热救阴为基本法则。其证偏实，热势较盛，重在清热兼和其胃；其证偏虚，热势不盛，重在益气兼清其热。

主方：热盛脉实者，用竹叶石膏汤^⑥，清热生津，和胃安中；如热退而津气未复，可用增液参麦汤调理。气液两亏者，用增液参麦汤^⑦为主方，益气生津，清解暑热，并与甘淡益胃之品出入化裁。

2. 暑厥（重证）

主证：突然晕倒，昏不知人，四肢厥冷，兼无汗肤热，颜面红赤，牙关紧闭，气粗如喘，脉洪数有力，为暑热内闭，其证偏实；兼汗出肤冷，面色苍白，目合口开，呼吸短促，脉细数无力，为气阴亏虚，其证偏虚。

证析：暑热蒸迫，闭塞神机，因而突然晕倒无知。热郁气闭，故手足反见厥冷。其证偏实者，皆由热盛于内，

闭塞清窍引起。热蒸气闭，阻遏心胸，故肤热无汗，面赤气粗。津液亏耗，筋脉挛急，故牙关紧闭。脉洪数有力，为暑热内闭，脉气未虚。其证偏虚者，皆由热蒸汗出，耗伤元气引起。表卫气虚，腠理不密，故汗出肤冷。清阳不升，故面色苍白。肺气不足，故呼吸短促。目合口开，脉细数无力，为脉气已虚，气阴两亏。凡此如救治不及，均有陷于死亡的可能。

治法：以清心开窍，清热救阴为基本法则。热盛脉实者，治宜清心开窍，清气涤暑，或清荣养阴；气阴两亏者，治宜扶虚固脱，益气生津。

本病于昏厥时，应予急救，速将病人抬放阴凉处，解开衣带，用热水毛巾轻擦头额胸背，防止暑热内闭，并配合针刺人中、合谷、内关穴位，或刺委中放血，以助泄热开窍。凡在暑热内闭之际，切忌早用寒凉，以防暑热愈闭愈深，反致不得外解。

主方：昏厥时，热盛脉实者，可灌喂安宫牛黄丸^⑧或紫雪丹^⑨清心开窍；清醒后，热在气分用竹叶石膏汤清热生津，热在荣分用清荣汤^⑩养阴泄热。气阴两亏者，可先灌喂独参汤以防厥脱，神识已清，则用增液参麦汤调理。

三、方药化裁

1. 搐鼻散（《医学心悟》）

细辛 皂角 半夏

上药各等分，研极细末，每用少许药粉，吹入鼻内取

嚏。

此方药性辛烈，善于搐鼻取嚏，用于气厥实证，可收开窍回苏之效。用时以得嚏即止，不宜过用，防其耗气。暑厥与气厥虚证不可妄行取嚏，暑厥用之，恐其助热伤络；虚证用之，防其耗气致脱。

2. 苏合香丸

方药见本章中风篇第七方。

此方辛开温化，宣利气机，用于气厥实证，取其开窍醒脑，促其回苏，以救一时之急，仍应得效则止，不宜过用。

3. 乌附芍枳汤

乌药10克 制香附15克 白芍24克 甘草6克 枳实10克

此方平肝开郁，顺气降逆，是治气厥实证的基础方剂。适用于气厥实证，胸腹痞满，烦闷不食，太息暖气，舌薄腻，脉沉弦者。治厥以顺气为主，顺气必先平肝，故以乌药、香附开郁顺气；白芍、甘草平肝缓急；佐枳实以行滞降逆。用本方为基础，依据病情随证化裁。

胸腹胀满作痛者，为肝气逆滞尤甚，加沉香、木香，以加强顺气行滞力量。面赤唇紫，舌色紫暗者，为血随气滞，酌加当归、丹参、红花，活血行瘀，气顺血和，则瘀阻自消。喉中痰鸣，或呕吐痰沫者，为痰气壅滞，加法半夏、胆南星，以祛痰降逆。脘腹痞满，不饥不食，暖腐食臭者，为气食阻隔，加焦山楂、莱菔子，以消积和中。

4. 独参汤（《古方八阵》）

人参3~6克

加水浓煎,用参汤徐徐灌喂。

人参益气生津,大补元气,一味单行,功专效宏。适用于诸厥虚证,或因大出血虚极欲脱,脉微欲绝者,有益气固脱,立挽危急之功。如嫌煎剂不及,用人参精(成药)亦佳。

5.归芪生脉汤

黄芪30克 当归6克 太子参24克 麦门冬15克 五味子10克 大枣10克 甘草6克

此方补心益气,养血生津。适用于气厥虚证初醒,心悸气短,声低息微,动则自汗,脉来微弱者。方以当归、黄芪益气养血;太子参、麦门冬、五味子养阴宁心,敛阴止汗;甘草、大枣和中养荣。合用而成补气宁心之剂。

见倦怠食少,大便溏薄,唇舌淡白者,属脾虚气弱,加白术、茯苓、砂仁,以健脾醒胃。见夜寐不安,大便干结,唇舌干燥,舌质淡红者,属心血虚少,加熟地黄、柏子仁、酸枣仁,以养血安神。

6.竹叶石膏汤(《伤寒论》)

竹叶15克 生石膏24克 法半夏10克 人参3克 麦门冬15克 甘草6克 粳米15克

此方清热生津,益气和中。适用于中伤暑热,其证偏实,热在气分,身热多汗,烦闷欲呕,口渴喜饮,短气少气,舌红苔黄,脉象洪数者。方中竹叶、石膏清热除烦;人参、麦门冬益气生津;半夏降逆止呕;甘草、粳米和胃安中。故用于中暑之后,暑热内郁,气液已伤,在清补兼施中,且能清热而不害正,补虚而不恋邪。

7.增液参麦汤

人参 3～6 克 麦门冬 18 克 五味子 6 克 知母 18 克
花粉 18 克 生地黄 12 克 西瓜翠衣 适量

此方益气生津，清热解暑。适用于中暑之后，气液两亏，暑热未清，心悸喘乏，口渴多汗，胸中烦闷，舌红少苔，脉细数而弱者。方以人参培补元气；五味子敛阴止汗；麦门冬、知母、花粉、生地黄清热除烦，生津止渴。西瓜翠衣性味甘凉，合用而奏清热解暑之效。

如胃阴不足，食谷难下者，加山药、玉竹、谷芽等益胃润燥之品。

8. 安宫牛黄丸（《温病条辨》）

牛黄 郁金 犀角 黄连 朱砂 梅片 麝香 真珠 山梔 雄黄 黄芩

上药配制丸剂（有成药），每用 3 克，研碎化水灌喂。

9. 紫雪丹（《和剂局方》）

黄金 寒水石 磁石 滑石 石膏 犀角 羚羊角 青木香 沉香 玄参 升麻 甘草 丁香 朴硝 麝香 朱砂 硝石

上药研制成紫色粉剂（有成药），每服 1.5 克，日服 1～2 次。

安宫牛黄丸、紫雪丹均适用于热病神昏，俱有清心开窍，醒脑安神之效。用于暑厥神昏属热盛脉实者，取其醒脑回苏以救一时之急。如因热盛脉虚，防其伤害正气，可采用人参汤化下，以收扶正撤热之效。

10. 清荣汤（《温病条辨》）

犀角 6 克（研细冲服） 生地黄 15 克 玄参 15 克

竹叶心10克 麦门冬15克 丹参10克 黄连6克 金银花15克 连翘15克

此方清荣泄热，养血护阴。适用于中暑实证，热入荣分，身热烦渴，烦躁不安，时有谵语，舌红绛无苔，脉细数或滑数，或现斑疹隐隐者。邪热入荣，阴伤血燥，荣气与心气相通，荣热蒸腾，因而出现身热、烦躁、谵语、舌色红绛无苔、或见斑疹隐隐等证。方中犀角、黄连清心荣之热；生地黄、玄参、麦门冬、丹参滋阴凉血，以清荣分之热；金银花、连翘、竹叶宣泄气分之热。合而用之，协奏清荣泄热之效。俟其热退神清，可用养阴宁心、甘淡益胃方药，以调理善后。（表19）

表16 厥证病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
气厥	情绪刺激，或烦劳太过，气机逆乱，阴阳气不相顺接，气盛有余，挟血挟痰挟食逆而上壅，发为实证；气血亏虚，神机失灵，发为虚证	实证	通关开窍 平肝理气	搐鼻散 苏合香丸 乌附芍枳汤
		虚证	益气固脱 培补心脾	独参汤 归芪生脉汤
中暑	烈日或高温下劳作，热蒸汗出，腠理开疏，体液因汗而外泄，体气随汗而消散，轻者为伤暑，重者为暑厥	偏实	清心开窍 清暑泄热	安宫牛黄丸 紫雪丹 竹叶石膏汤 清荣汤
		偏虚	益气固脱 益气生津	独参汤 增液参麦汤

第五节 癲 狂

因于七情所伤，神志失常，表现语言狂乱，不避亲疏

者，称为癫狂。癫与狂的表现有所不同，癫病表情痴呆，静而多喜，喃喃自语，语无伦次；狂病表情妄乱，动而多怒，喧闹打骂，不避亲疏。由于癫病经久，内郁化火，可出现狂证，狂病经久，郁火衰退，亦能出现癫证，故通常以癫狂并称。

本病较好发于青壮年时期，以平素性格孤僻或倔强好胜之人为多见。在此类病员中，其家族多有患癫狂病者。

本病应与温热病中因热入心包而出现的谵语狂乱相鉴别。

一、病因病机

凡平素性格特殊，个性异常孤僻、倔强好胜之人，若因忧思郁怒，积久不释，往往易致精神错乱，发生癫狂。七情所伤，心神失畅，肝气抑郁，肝郁则脾气不伸，脾郁则聚湿成痰，痰气互郁，迷乱神机，因而发病。所以，《证治要诀》指出：“癫狂由七情所郁，遂生痰涎，迷塞心窍。”可见，癫狂病机主因在痰。痰涎偏盛者，表现为癫；痰火相并者，表现为狂。故《难经》有“重阴者癫，重阳者狂”的理论。

癫病多由所欲不遂，忧思久积，损及心脾。思虑过度，心脾气郁，脾气不伸，聚液成痰，气郁痰迷，神志淆乱，因而表情如醉如痴，出言无序。

狂病多由恼怒忿郁，不得宣泄，病在心肝。隐怒不解，肝气内横，木横侮土，脾气难伸，聚液成痰，肝脾气郁，

气盛化火，痰火相并，火炽痰涌，扰乱神机，因而表现喧闹怒骂，妄乱无知。

由此说明，心、肝、脾**气机郁滞**，在互为因果的作用下，产生痰气、痰火迷乱神识，是发生癫狂的主要病机。癫病以心脾气郁为主，如病延日久，痰郁不开，脾气不伸，运化失常，气血日亏，无以涵养心神，神气日渐虚弱，此为痰气留滞，心脾已亏。狂病以心肝郁火为主，如病延日久，痰火未清，暗耗营阴，阴虚不能养神，神气日虚，阴虚不能制火，神舍愈难安宁，此为火盛阴亏，心虚神弱。所以，癫狂起病多属实证，久则实中有虚、虚实并见。此时如病久留连，神气愈虚，痰气愈滞，神迷愈深，多成痼疾。

二、辨证施治

癫狂以神志错乱为主证，在证候上有阴证阳证之分。癫由气郁痰迷，表情沉静呆滞，俗称文痴，属于阴证；狂由火炽痰涌，表情妄乱狂躁，俗称武痴，属于阳证。因此，在辨证上，应首先区别是癫是狂，然后施以不同治法。一般说来，镇心安神，疏肝解郁，涤痰开窍，是治疗癫狂的基本法则。治癫以理气解郁、涤痰开窍为主，重在调治心脾；治狂以镇心涤痰、清肝泻火为主，重在调治心肝。对于病延日久，实中兼虚者，则当根据阴阳气血亏损的不同情况以及虚实多少的差异，分别主次，善为调理。

凡癫狂发病，大都与精神刺激有关，因而对经过治疗，病情得到缓解的患者，要注意消除其刺激因素，是十

分重要的。朱丹溪对此提出“宜以人事制之”的理论，可见纯靠药物，很难取得满意效果。

(一) 癡证

癡证起病缓慢，早期多不被人注意，始见精神抑郁，少言寡欢，喜静喜睡，随即日渐表现对事物冷淡，时而喃喃独语，出言有头无尾。初病痰气郁结，多属实证；久则心脾亏损，实中兼虚。

1. 痰气郁结

主证：表情淡漠，如醉如痴，喃喃独语，出言无序，或歌或喜，或悲或泣，哭笑无常，不知秽洁，饮食少思，舌苔白腻，脉多沉弦或弦滑。

证析：忧思积虑，所求不得，心神不畅，肝气抑郁，故病前少言寡欢，喜静喜睡，病后表情淡漠，如醉如痴。肝气抑郁，脾气难伸，津液不行，聚而成痰，痰气互结，迷蒙神窍，故出现种种神志错乱证候。脾气失畅，故饮食少思。痰浊阻滞，故舌苔白腻。脉沉弦或弦滑，为痰气郁结病象。

治法：理气解郁，化痰开窍。

主方：用加减涤痰汤^①为主方，理气化痰，开通心窍。如神识迷乱较甚，可先用苏合香丸^②以开窍豁痰；对形体壮实者，亦可采用三圣散^③取吐以劫夺痰涎；然后用加减涤痰汤调理。惟劫痰之剂，药性猛烈，应予慎用。

如其证兼见烦躁不寐，舌红苔黄，脉弦数或滑数者，此为痰气化热，宜于方中加入清泻郁热之品，防其由癡转狂。若已出现狂病证候，当从狂证论治。

2. 心脾亏虚

主证：精神萎靡，默默寡言，心悸易惊，善悲欲哭，倦怠喜卧，恍惚多梦，饮食衰少，舌质淡，脉细弱。

证析：癫病日久，脾失健运，气血虚亏。气虚则神弱，神气不振，故精神萎靡，默默寡言，倦怠喜卧。血虚则神舍失守，心神不宁，故心悸易惊，恍惚多梦。血虚神弱，痰气留滞，迷乱愈深，故表情忧郁而善悲欲哭。饮食衰少，为脾虚不运。舌淡脉弱，为气血俱衰。

治法：养心安神，健脾益血。

主方：癫迷较甚，重在养心安神，化痰开窍，可用加味甘麦大枣汤④再加菖蒲、远志；神志较清，重在健脾益血，宁心安神，宜用归脾汤⑤再加柏子仁、五味子。由此交替治疗，调其虚实，神气健全，自能控制病情。

（二）狂证

狂证起病急骤，始见性情急躁，妄想多疑，喜动易怒，少寐多言，有时瞪目怒视，有时自弄鬼脸，随即语言错乱，突然发狂。初病火盛痰涌，属于实证；久则郁火伤阴，实中兼虚。

1. 火盛痰涌

主证：狂乱无知，面红目赤，骂詈叫号，不避亲疏，甚或逾垣上屋，登高而歌，弃衣而走，毁物打人，气力逾常，不食不眠，狂奔乱跑，舌质红绛，苔多黄腻，脉多洪弦滑数。

证析：隐怒忿郁，肝火暴张，挟痰上涌，蒙蔽神窍，故狂乱无知，骂詈不避亲疏。肝火上盛，是以面目红赤。肝主动主怒，怒火冲逆，是以狂暴不休，登高奔走，毁物殴人，不眠不食。舌绛苔黄，脉洪弦滑数，均为痰火涌

盛、阳亢热实之象。

治法：镇心涤痰，清肝泻火。

主方：用生铁落饮⑥为主方，清涤痰火，镇心安神。如火热偏亢，狂暴太甚，宜先用至宝丹⑦或安宫牛黄丸⑧以清心开窍；如痰火壅盛，大便闭结，宜先用礞石滚痰丸⑨以攻泻痰火；然后用生铁落饮调治。惟攻泻之剂，只可暂用，不宜多服，以防损伤胃气。

如狂势消退，神识不清，其状如癫，此属火去痰留，迷蒙神窍，可按癫证施治。

2. 郁火伤阴

主证：狂病日久，狂势转缓，呼之亦能自制，且有疲惫之象，多言善惊，时而烦躁少寐，形体消瘦，颜面泛红，舌质红，脉来细数。

证析：久狂不已，郁火伤阴，阴虚则心神失养，神气已虚，故狂势转缓，已能自制，且有疲惫之象。阴虚不能制火，虚火上炎，故面红舌红，形体消瘦。神气已亏，又为虚火所扰，故见多言善惊，烦躁少寐。脉来细数，为阴虚有热之象。

治法：滋阴降火，化痰开窍。

主方：以百地丹枣汤⑩为基础方，随证按原方加减法外，应加入黄连、朱砂、菖蒲、远志等清心安神、化痰开窍之品，使其痰火兼治，虚实并行。在治疗中，如有烦躁欲狂趋势，可兼服至宝丹以控制病势。

此外，凡癫狂病人，在治疗中还须注意精神因素，避免不良刺激，加强管理保护，以防意外。对病情得到缓解的患者，如能改变调养环境，加强心理方面的治疗，是能

够使之由稳定而得到痊愈的。

三、方药化裁

1. 加减涤痰汤

法半夏12克 胆南星3克 橘皮10克 枳实12克 茯苓20克 菖蒲6克 郁金20克 香附15克 竹茹6克 甘草6克

此即《济生方》涤痰汤去人参加郁金、香附组成，功能理气解郁，化痰开窍。适用于癫证痰气郁结，口多痰涎，舌苔白腻，脉沉弦或弦滑者。方中半夏、胆南星、橘皮、茯苓、枳实利气降痰。郁金、菖蒲、香附解郁开窍。佐竹茹之甘寒，以防郁痰化热。如已见烦躁少寐，舌苔黄腻，有化热趋势者，方中酌加黄连、黄芩苦寒泻热，防其由癫转狂。

2. 苏合香丸

方药见本章中风篇第七方。

3. 三圣散（《圣惠方》）

防风10克 瓜蒂10克 藜芦6克

上药加水煎汤，去渣，徐徐服之，不必尽剂，以吐为度。

此方功能涌吐风痰，可用于癫证神呆，迷乱较甚，一般开窍药无显效者。由于药力峻猛，若非形体壮实者，不可妄投。吐后宜食粥一、二日以调养胃气。

4. 加味甘麦大枣汤

方药见本章郁证篇第四方。

本方再加菖蒲6克，远志6克，适用于癫证日久，实中兼虚，癫迷较甚者。

5. 归脾汤

方药见本章郁证篇第五方。

本方再加柏子仁10克，五味子6克，可用于癫痫病日久，心脾亏虚，神志较清者。惟本方用于癫疾，只宜轻量缓补，不可妄施重剂，以防堵塞痰气，反致癫迷愈深。

余治一杨氏女青年，因其母暴病死亡，惊忧悲戚，致成癫疾。病已年余，神志有时清楚，有时癫迷。癫迷发作，如醉如痴，表情淡漠，不与人言，或呆坐，或嗜卧，不问秽洁，不思饮食。癫迷未发，虽仍寡于言笑，尚能自理生活。舌质淡，苔薄腻，脉沉细弦缓。此属癫病日久，神弱痰迷，当从心脾亏虚论治。用加味甘麦大枣汤加菖蒲、远志与归脾汤加柏子仁、五味子两方交替进服，并嘱选择至好亲属异地调治。如此治疗半年，病情渐趋稳定，现已恢复工作。由此可见，癫迷之疾，如能细心治疗，调其虚实，是能够治愈的。

6. 生铁落饮（《医学心悟》）

天门冬10克 麦门冬10克 贝母10克 胆南星3克
橘皮3克 远志3克 石菖蒲3克 连翘15克 茯苓15克
茯神15克 玄参15克 钩藤15克 丹参15克 辰砂1克
（研细冲服） 生铁落100克（煎水1小时，取水煎药）

此方镇心安神，涤痰开窍，清热养阴。惟方药配合较重于镇静止狂，对清泻郁火尚嫌不足，故用于狂证郁火未盛者颇宜。如见面红目赤，狂躁不安者，加龙胆草、黄芩，以助清泻肝胆实火。

7. 至宝丹

方药见本章中风篇第五方。

8. 安宫牛黄丸

方药见本章厥证篇第八方。

至宝丹与安宫牛黄丸同为辛开凉热之剂，均有清心开窍，醒脑安神作用。其中至宝丹以醒脑开窍作用为优；安宫牛黄丸以清泻火热作用为优。因此，二方用于狂证，可根据病情随证选择。

9. 礞石滚痰丸（《王隐居方》）

青礞石 沉香 大黄 黄芩

上药研制丸剂（有成药），量人虚实，每次服5~10克，以得大便快泻为度，不泻再服1次。

此方逐痰泻火，药力猛烈。适用于积痰郁火，狂躁不休，大便秘结，舌黄腻，脉滑实者。方以礞石重镇降痰，大黄涤荡肠中积热，黄芩清上焦之火，沉香顺利气机。四药合用，能使积痰郁火得一快泻而下。由于药力猛烈，应以得泻即止，过用防其害胃。

10. 百地丹枣汤

方药见本章郁证篇第六方。

本方加黄连6克，菖蒲6克，远志6克，朱砂1克（研细冲服），煎剂。

此方养阴清热，宁心安神，化痰开窍。适用于狂病日久，郁火伤阴，见狂势转缓，多言善惊，烦躁少寐者。

凡久狂之证，多见阴亏神弱，性躁多疑，稍有不遂，狂势反复。此时只宜平剂调治，不可大清大攻，以防愈虚其虚，神迷愈深。本方为轻清平剂，以安定神志见优，除

随证参用原方加减法外,如心烦不寐,可加龙齿、夜交藤镇肝安神;如郁火过旺,有欲狂趋势,可加龙胆草、黄芩清泻郁火。如此调理,使其渐趋稳定而得痊愈。(表20)

表20 癲狂病因病机证治简表

	病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
癲证	忧思久积,病在心脾。心神不畅,肝气抑郁,脾气不伸,聚湿生痰,痰气互结,迷蒙神窍	癲证初起 痰气郁结	理气解郁 化痰开窍	加减涤痰汤 苏合香丸 三圣散
		久癲伤气 心脾亏虚	化痰开窍 培补心脾	加味甘麦大枣汤 归脾汤
狂证	恼怒忿郁,病在心肝。肝气内横,气郁化火,木横侮土,聚液成痰,火盛痰涌,迷乱神志	狂证初起 火盛痰涌	镇心安神 清肝泻火	生铁落饮 至宝丹 安宫牛黄丸 礞石滚痰丸
		狂病日久 郁火伤阴	滋阴降火 化痰开窍	百地丹枣汤 加味

第六节 癲 证

癲证一称癲痫,俗称羊癲风。其特征为反复发作,发病时突然仆倒,昏不知人,肢体抽搐,目睛上视,口吐涎沫,或口中发出类似猪羊叫声,短时即醒,醒后一如常人。

本病发作无常,病情比较顽固,平日起居如常,每因情绪波动,或突受惊骇,或劳累过度,都可引起发病。发作时间长短不一,有数秒钟或数分钟即过的,也有持续数小时的。间歇日期久暂不同,有每日数发,数日一发,或数月一发的,也有间歇数年而重复发病的。发病程度各有

轻重,有表现忽然呆木无知,不动不语,肢体略为震颤,一瞬即过的;有来势骤急,昏倒抽搐,口噤咬牙,口吐血沫的(多为舌被咬破所致)。总的说来,发作时间短,间歇期久,表现证状轻微者,属于轻证;反复发病,愈渐频繁,发作时间愈来愈长,表现证状渐趋加重者,属于重证。

一、病因病机

痫证发病原因,大体分两个方面:(1)在母腹中受病。如《济生方》说:“痫病者,或在母腹中受惊。”此种由先天因素而得的痫病,幼科书中又称胎痫。(2)继发于某些疾病之后。如《儒门事亲》载一病例:“一妇病痫,从六七岁因惊风得之。”可见,后天因素亦能导致痫证发病。本病的病机,主要由于肝肾亏伤,风痰内聚所致。肝肾并居下焦,肾为先天之脏,受藏脏腑津液,肝为风木之脏,能升发精气上济于心。如因先天或后天的因素,致使肝肾亏伤,肝肾气伤不能充分升发精气,则津液停聚而为痰涎;肝肾阴伤,肝木失涵,则风阳易于动扰。平时心情舒畅,肝气和调,痰气隐伏,一如常人。若情志失调,或突受惊骇,或劳累过度,招致肝气逆乱,触及痰涎,阳升风动,痰随气逆,阻塞神窍,壅闭经络,突然发病,昏仆抽搐。移时肝平气降,痰气隐伏,则神志清醒,一如常人。因其痰有聚散,气升则痰聚,痰聚则病作,气降则痰降,痰降则病止,故痫证以作止不定为主证。由此说明,痫证是以痰气隐伏为致病之标,而肝肾亏伤则是致

病之本。所以痫证发作的轻重与肝肾的盛衰、结痰的深浅有着密切关系。

二、辨证施治

根据痫证发作的典型证状，临证辨别不难。一般初起较轻，如反复发病，正气渐衰，结痰不化，愈发愈频，正愈虚则痰愈结，病情亦逐渐加重。又因其病作止不定，所以临床上宜分已发未发、标本虚实进行治疗。已发时，重在平肝息风，涤痰镇痫，以治标为先；未发时，重在扶补肝肾，运化痰涎，以治其本。其间，尤在间歇期的治疗，更为重要。对续发于某些疾病之后者，还须重视原有疾病的治疗，方为图根治本之法。

本病与中风、厥证、中暑均以突然昏倒为主证，其鉴别要点大略如下：（表21）

表21

	鉴 别 要 点
痫 证	昏仆时肢体抽搐，口中发出异常叫声，将醒时吐出涎沫，有反复发作史，醒后一如常人
中 风	病前有肝旺眩晕史，昏仆时口眼歪斜，半身不遂，醒后有后遗症状
厥 证	昏迷无抽搐喘僻不遂，醒后无后遗症状，多属一时性昏厥
中 暑	昏仆时可见肢体抽搐，但本病因于中伤暑热发病，不似痫证反复发作

现以痫证发作时与发作后的不同证治分述如下：

(一) 发作时证治

主证：发作前多有昏晕头痛、胸闷不适等先兆，后即昏倒仆地，神志不清，面色苍白，牙关紧急，目睛上视，继则肢体抽搐，口中发出类似猪羊叫声，甚或大小便失禁。不久，口中吐出白沫（如舌被咬破可见血沫），神志逐渐清醒，证状消失，病员自感头晕倦乏外，饮食起居如常。如发作时仅见短暂昏迷而无抽搐现象，或只见头目肢体轻微颤抖，一瞬即过者，此为小发作。一般发作时脉见沉伏，醒后脉多弦滑，舌苔以白腻为常见。

证析：风阳内动，挟痰上逆，故发作前昏晕头痛，胸闷不适。风动痰升，闭塞神窍，故突然昏仆倒地。风痰壅塞，气机闭阻，窜扰经脉，故面色苍白，口紧抽搐，目睛上视。终于上涌之痰，从口中吐出，痰去则肝平气降，神志渐清，证状消退，一如常人。由于气升痰涌有微有甚，是以发作有轻有重。发作时气机阻闭，故脉见沉伏。脉弦滑，舌白腻，均为风痰内聚之象。

治法：平息肝风，涤痰镇痫。

主方：以定痫丸^①为主方。痫证发作时，可先用针刺人中、内关穴位促其苏醒。醒后，先将本方作煎剂内服，依据病情轻重，有热无热，酌情加减，俟发作稳定，即按间歇期治疗。

(二) 发作后证治

主证：痫证发作过后，大多表现头目昏晕，倦乏无力，经短时休息，饮食起居恢复如常。间歇期如持续表现面色不华，头晕神倦，食少痰多，腰酸腿软，舌淡苔白，脉沉弱者，属脾肾气虚；若见头晕面红，心烦少寐，手足

潮热，腰膝酸软，舌红苔少，脉细滑者，属肝肾阴虚。

证析：痫证发作，耗气伤神，故见头目昏晕，倦乏无力。经短时休息，恢复如常，是正气未衰之象。如精神不振，久久不能恢复如常，多因痫证时发，气阴亏伤所致。偏于气虚者，气虚则神弱，故神倦而萎靡不振。气虚则清阳不升，故头晕而面色无华。气虚则脾弱不运，聚湿生痰，故食少而多痰。肾气不足，腰脊失温，故腰酸腿软。舌淡白，脉沉弱，为脾肾气虚所致。偏于阴虚者，阴虚则阳盛，虚阳浮越于上，则头晕面红；越蒸于外，则手足潮热；内扰神舍，则心烦少寐。肾阴不足，筋骨失养，故腰膝酸软。舌红苔少，脉象细滑，为肝肾阴亏、痰气内蕴之象。

治法：扶补肝肾，运化痰涎。

主方：以河车定痫丸^②为主方。痫证时发，精气多虚，间歇期常服本方，能补精益气，开郁通痰，运化结痰，从本图治，以杜致病之源。对发作频繁不定者，亦可与《心悟》定痫丸配合内服（晨起服定痫丸1次，晚间服河车定痫丸1次），也能收到标本兼治之效。

三、方药化裁

1. 定痫丸（《医学心悟》）

明天麻30克 川贝母30克 姜半夏30克 石菖蒲15克 茯苓30克 茯神30克 胆南星15克 全蝎15克 僵蚕15克 琥珀15克 橘皮21克 远志21克 丹参60克 麦门冬60克 辰砂9克

上药研细，用竹沥一小碗，生姜汁一杯，再用甘草120

克熬膏，配制为丸，以辰砂为衣，每丸重3克，成人每次服一丸，小儿酌减，视病情轻重，日服1~2次。

此方涤痰开窍，定痫息风。适用于痫证发作不定者。方用二陈汤理气除痰作为基础。以川贝、胆南星、竹沥涤痰降逆；天麻、全蝎、僵蚕息风止痉；以琥珀、辰砂、茯神、远志、菖蒲开窍镇痫，安定神志；以丹参、麦门冬养阴活血，开通瘀滞。肝平气降，风息痰除，痫证自止。

凡用本方，于痫证发作时，量人虚实，酌减剂量，先作煎剂内服，以控制痫证发作。如发作时肢体抽搐为甚，宜加钩藤、龙骨、石决明之属，加强镇痫息风之力。如兼心烦胸闷，舌质红，苔黄腻，脉滑数，为痰郁化热，宜加黄连、黄芩清火化痰。经过治疗，病情稳定，体无虚象者，将本方丸剂日服1~2次，持续内服一段时间，以制止痫证反复。

2. 河车定痫丸

紫河车1具（洗净用黄酒炖熟捣烂为泥） 人参15克
远志15克 石菖蒲15克 丹参60克 郁金60克

上方研细，炼蜜为丸，每丸重3克，每次一丸，日服1~2次。

此方补益精气，开郁通瘀，消化结痰。适用于痫证时发，神倦昏沉，久而不复者。痫病日久，精气大亏，非大补肝肾不足以杜致病之源，故以紫河车补精养血，人参益气培元。痫证久发，痰涎固结，纯补非其所宜，故以郁金、丹参开郁通瘀；远志、菖蒲开窍化痰。一则补虚，一则化痰，标本同治，虚实兼顾。凡痫证久发，无明显气、阴偏虚者，皆可以本方主之。如脾肾气虚，食少痰多者，

加白术30克,砂仁15克,以健脾醒胃。如肝肾阴虚,心烦潮热者,加熟地黄30克(熬汁入药),炒黄柏15克,以滋肾坚阴。

吾友曾君,子患胎痫,年17犹发病不休,余为配制《心悟》定痫丸及河车定痫丸各一剂,令其常服。开始晨起服定痫丸一粒,晚间服河车丸一粒,服药一月,痫证发作,逐渐制止。后以二药日服一次,交换进服,约半年未见发病。其父恐反复,令坚持服药2年余。经10年后,痫证突然发作,又按前法治疗年余。今其人已50余岁未见发病。于此可见,虽然痫多痼疾,如坚持治疗,也能取得满意疗效。(表22)

表22 痫证病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
受病于母腹,或继发于病后,皆由肝肾亏伤,风痰内聚,一有触犯,阳动风升,痰随气逆,闭塞神窍,昏仆抽搐,移时气降风息,一如常人	发作时证治	平肝息风 涤痰镇痫 重在治标	《心悟》定痫丸
	未发时证治	扶补肝肾 消化结痰 重在治本	河车定痫丸

结 语

本章所论心肝疾病,都属于神志与血脉方面的病变。由于心、肝与肾关联密切,故病机演变又多涉及于肾。

心、肝、肾有水生木、木生火母子相生的生理关系。心居上焦,属火,藏神,主血脉;肾居下焦,属水,藏志,主精髓;肝为风木之脏,界于心、肾之间,具有调节神

志、协调血脉功能。因此,神志疾病往往心肝同病,而肝病日久又可累及于肾。反之,肾病亦多累及于肝,日久也能累及于心。

郁证、癫狂、痫证都属于神志异常的疾病。郁证是神志抑郁,因郁致病的总称,神郁则肝郁,肝郁则气、血、食、痰、火郁诸证相继发病。如果心肝久郁,痰火内盛,便能迷乱神窍,发生癫狂。痫证以肝肾亏伤,结痰隐伏者居多,常因神志失调触动肝风,痰随风动迷阻神窍而发病,故其证仍以心肝同病为特点。

眩晕、中风、厥证都属于血脉升降失调的疾病。其间多以肝肾病变为致病前因,以神志失调为发病诱因。肝气的虚实,常以心、肾的虚实而为虚实。肾阴不足,肝木失涵,则肝阳偏旺,肝旺则心阳亦旺,心肝有余则血脉上盛而现上盛下虚;反之,心阳虚则肝气亦虚,心肝不足,气血不能上承,则现上下俱虚。眩晕病机就是这样形成的。眩晕病久,若因恼怒、惊骇、烦劳等神志因素刺激,便能导致肝气逆乱,突发昏厥;或火动风升,气血奔迫,发生中风。此即眩晕、厥证、中风在病机演变中的因果关系。

由此可知,本章疾病的发病原因,虽然各有不同,但心、肝、肾互为因果的病机关系,则是一致的。所以,临床上治疗此类疾病,都以治肝为主,重在调理心、肾的虚实,是其基本法则。(表23)

表23 心肝疾病病机简表

心肝疾病	心	肝	肾	忧思隐怒,心肝气郁:郁证	肝郁脾滞,化火生痰,迷乱神窍:癫狂 肝肾亏伤,结痰隐伏,风动痰升:痫证
				肾阴亏虚,肝阳偏旺:眩晕	肝气素盛,偶触恼怒,气机逆乱:厥证 五志过极,火动风升,气血奔迫:中风

第四章 心肾疾病

心藏神，主血脉；肾藏志，主精髓。心悸、不寐、多寐、健忘、遗精、阳痿诸证，大多因于神志与精血的病变引起发病。又因此类病证往往因果相关，故并称心肾疾病作出论述。

本章与第三章心肝疾病相较，虽然俱以心、肝、肾三脏的病变为特点，惟彼以心肝同病而涉及于肾，此以心肾同病而累及于肝；彼多神志异常，此多神志衰弱；彼多实证，此多虚证。

第一节 心 悸

心悸是病人自觉心中跳动不安的一种证候。其证轻者，表现为阵发性，每因惊恐、情绪波动、或劳累发作，此称惊悸；其证重者，外无所惊，常觉心动不宁，稍劳尤

甚，此称怔忡。如惊悸日久，失于治疗，亦可发展成为怔忡。所以，《医学入门》说：“怔忡因惊悸日久而成。”

本病以内虚为主因，多由心、脾、肝、肾亏损所致，并常与眩晕、不寐、健忘等证相并出现。兹就临床常见而以惊悸、怔忡为主的证候，分心脾不足、心肾亏虚、心络血瘀三类作出论述。

一、病因病机

平素心虚胆怯之人，突受外惊，耳闻巨响，目见异物，或登高涉险，即易招致心乱神摇，不能自主，渐至稍有所惊则心悸不已。所以，《济生方》说：“惊悸者，心虚胆怯之所致也。”可见，久受外惊，可以导致心悸发病。

心主血脉，营血不足，心络失养，常常是发生心悸的重要因素。如杨仁斋《直指方》说：“人之所主者心，心之所养者血，心血一虚，神气不宁，此惊悸之所肇端也。”导致心血不足的原因：（1）思虑过度，伤神耗血，久则心血虚少，发生心悸。如《证治要诀》说：“久思所爱，触事不忘，虚耗真血，心血不足，遂成怔忡。”（2）久病脾虚，化源不充，气血日亏，不能奉养于心，渐成心悸。（3）凡失血过多，久病血虚，均可导致本病。所以，《丹溪心法》说：“怔忡无时，血少者多。”

肾为水火之脏，乃身中元阴元阳之宅，心属火，心阳与肾阳互根，肾水与心火相济，肾水不足则水不济火，心

阳内虚则火不制水，二者皆能引起心悸。肾阴亏虚，水不涵木，肝阳偏盛，肝旺化火，耗损心阴，久则心阳独亢，心神不宁，烦悸不已。阳虚不振，心动无力，因虚而悸；阳虚日久，累及于肾，肾虚则水气不化，泛溢肌肤，于是心悸与水肿并见。

心络瘀滞，心气不畅，亦能发生心悸。导致的原因：

(1) 心悸日久，心气亏虚，推动无力，血脉流行不畅，渐致气滞血涩，心络瘀阻。(2) 由患风寒湿痹发展而来。如《素问·痹论》说：“脉痹不已，复感于邪，内舍于心”，“心痹者，脉不通……”。可见久患风寒湿痹，邪阻血脉，内及于心，能使心脉瘀痹而成心悸。

由此说明，心悸一证，皆以内虚为主因，其间因血瘀而成的心悸，又多属虚中夹实证候。

二、辨证施治

心悸以虚证为主，治疗皆以补虚宁心为基本法则。气虚为主，益气为先；阴虚为主，重在养血；气血双虚，则宜培补心脾以充化源。心肾亏虚，偏于阴虚者，治宜壮水制火，养心安神；偏于阳虚者，治宜益气助阳，温肾行水。对心悸日久而成心络血瘀之证，又当采用补虚通瘀、虚实兼顾治法。

(一) 心脾不足

1. 心神虚怯

主证：心悸易惊，恶闻巨响，心中常有恐惧之感，甚或坐卧不安，多梦易醒，舌苔如常，脉现小数，或脉来疏

数不匀。

证析：心神虚怯，惊则气乱，故心悸易惊，恶闻巨响。心虚则多恐惧，气乱则卧寐难安，故神舍不宁，多梦易醒。心主脉，心悸则脉动而小数；脉现疏数不匀，亦因惊而气乱所致。

治法：镇惊宁神，补心养血。

主方：以龙牡参麦汤^①为主方。本方善于宁心止悸，如营阴已亏，再加滋阴养血之品；如寐中易惊，睡眠多梦，再加宁心安神之品。

2. 血虚气弱

主证：心悸不安，头晕目眩，面色不华，倦怠无力，饮食少思，眠差多梦，唇口淡白，舌淡红，脉细弱。

证析：思虑烦劳，耗血伤神，或久病脾虚，化源不充，久则心脾不足，气血双虚。血不养心，则心悸；不能上奉于脑，则眩晕；不能上荣于面，故面色少华，唇口淡白。血虚气弱，则倦怠无力；脾不健运，则饮食少思；血虚神弱，则眠差多梦。舌淡红，脉细弱，为气血双虚之象。

治法：益气养血，宁心安神。

主方：以归脾汤^②为主方。本方益气健脾以补生血之源，气血健旺，心有所主，则悸止神安。

（二）心肾亏虚

1. 阴虚阳旺

主证：心悸不宁，烦躁不安，少寐多梦，头晕耳鸣，面颊潮红，舌质红，脉弦细数、或有结象。

证析：肾阴不足，水不涵木，肝阳内动，上扰心神，

故心悸而烦，少寐多梦。阴亏于下，阳旺于上，故头晕耳鸣，面颊潮红。舌质红，脉弦细数，为阴虚阳旺病证。如兼结脉，则为心阴亏损，营运不足，心气阻滞所致。

治法：滋阴敛阳，养血宁心。

主方：以天王补心丹^③为主方。如心肝阳旺，心悸不已，更宜加入重镇之品；如见脉数而结，尤当重在养血通瘀。

2. 阳虚气弱

主证：心中空虚，惕惕悸动，头晕气短，神倦乏力，舌淡苔白，脉细弱而数，或脉来结代，如因阳虚水泛，则兼见四肢清冷，面浮足肿，小便短频。

证析：心阳不振，鼓动无力，故心中空虚，惕惕悸动。清阳不升，则头晕；胸阳不足，则气短；阳虚神弱，则困倦乏力。舌淡白，脉细弱而数，均为阳虚气弱之证。如兼脉来结代，则为心阳虚衰，气血凝滞所致。若肾阳已虚，阳虚不能温达于四肢，则手足清冷；阳虚不能化气行水，水气泛溢于肌肤，则见面浮足肿，小便短频。

治法：益气复脉，温阳行水。

主方：阳虚气弱，脉来结代，重在益气复脉，宜用归芪生脉汤^④。如阳虚及肾，面浮足肿，宜先用《金匱》肾气丸^⑤补肾温阳，化气行水；俟水肿消退，再用归芪生脉汤振复心阳。

（三）心络血瘀

主证：心中动悸，胸闷不舒，时而胸中隐痛，痛如针刺，舌色紫暗，或舌有瘀斑，脉来虚数，或见涩脉，或脉来结代。如属心痹，可兼有风寒湿痹见证。

证析：本病以时而胸中隐痛，痛如针刺为主证，可继发于各类心悸证候。或以心气内虚，鼓动无力，或以心阴亏损，营运不足，都能导致血流不畅，心络瘀涩。心血运行不畅，故心悸而胸闷；心气阻滞不通，故心络挛急而刺痛。痛有定处，痛如针刺，为瘀血疼痛之证；舌乃心之苗，舌色紫暗，或有瘀斑，为心络血瘀之象。心虚而悸，故脉来虚数；血流不畅则脉涩，气血凝滞，不得宣通，则脉来结代。

治法：益气养血，活络通瘀。

主方：以参七通脉散^⑥为主方，心气偏虚，辅以归芪生脉汤；心阴偏虚，辅以天王补心丹。如属心痹，则当辅治痹诸法，依据风寒湿偏胜不同情况，可参考痹证诸方配合治疗。

三、方药化裁

1. 龙牡参麦汤

太子参24克 麦门冬15克 五味子10克 酸枣仁10克 丹参15克 龙齿20克 牡蛎20克 大枣12克 甘草6克

此方补心养血，镇惊安神。适用于心神虚怯，心悸易惊，多梦易醒者。方以太子参、麦门冬、五味子补养心气；丹参、枣仁养血安神；龙齿、牡蛎镇惊止悸。是方一镇一补，功能调节心律，宁心止悸，用治一般心动过速之证，其效甚优。

如见虚烦不安，夜间出汗，舌红少津者，为营阴不

足，可酌加柏子仁、玄参、生地黄等品以滋阴养血。如心烦不寐，或睡眠多梦者，加夜交藤、合欢花，以助宁心安神之功。

2. 归脾汤

方药见第三章郁证篇第五方。

本方健脾养心，益气补血。适用于久病血虚，心脾不足，证见心悸头晕，倦怠食少，眠差多梦，唇舌色淡，脉来细弱者。气旺则脾健，脾健则血生，气血旺盛，心有所主，则心悸、头晕、眠差诸证自可痊愈。

3. 天王补心丹（《摄生秘剖》）

人参3克 玄参10克 丹参10克 茯苓10克 五味子6克 远志6克 桔梗10克 当归10克 天门冬10克 麦门冬10克 柏子仁10克 酸枣仁10克 生地黄10克
（煎剂，或加量制为蜜丸服用）

此方补心安神，滋阴养血。适用于心阴不足，烦躁不宁，舌红少津，脉弦细数者。方用天门冬、麦门冬、玄参、生地黄以滋阴液；丹参、当归以养心血；人参、茯苓补益心气；枣仁、柏子仁、五味子、远志养心安神；桔梗为诸药之佐，以开宣心气。肾阴不足，心阳偏旺，采用本方滋阴敛阳，两调心肾，可使心静神藏，解除烦躁。

如心肝阳旺，心悸不已，加龙齿、牡蛎，以加强镇心止悸之力。如见脉数而结者，可加重丹参剂量以助活络通瘀力量。

4. 归芪生脉汤

方药见第三章厥证篇第五方。

本方补气养血，宁心止悸。适用于心气不足，心悸气

短，神倦乏力，舌淡白，脉来细弱者。此方功能重在益气宁心，如心阳虚衰，气血不得宣通，见脉来结代者，方中加入丹参、川芎以助益气通络。使气血调和，其心之动悸，脉之结代，自可恢复如常。

如属心痹络瘀，外证兼有肢节疼痛者，更宜再加汉防己、秦艽，以助祛风除湿、通利脉络之力。

5. 肾气丸（《金匱要略》）

熟地黄10克 山药15克 山茱萸10克 茯苓24克
泽泻15克 丹皮10克 肉桂3克 制附片15克

此方补肾温阳，化气行水。适用于肾阳不足，水气泛溢，证见面浮足肿，小便短频，脉沉细弱者。用本方治疗心虚水肿，目的在于温补肾阳，消利水气。如肿势较甚，小便短少，加怀牛膝、车前仁，以增强利水消肿力量。俟水肿消退，仍当用归芪生脉汤补气养血，宁心止悸，以治其本。

6. 参七通脉散

人参30克 云南三七30克 丹参180克 川芎15克

上药共研极细粉末，每服3克，日服2~3次，空胃温水调服。

此方补心益气，通瘀止痛。适用于心络血瘀，心悸胸闷，胸中隐痛如针刺，脉虚数而结，或脉来结代者。方以人参补益心气，作为全方主药。三七、丹参、川芎活血行滞，散瘀通络。心气旺则鼓运有力，脉道通则疼痛自止。故本方以通脉止痛见优。

大凡心痛之证，多由气虚络瘀引起，故可将本方作为治疗各类心痛证的基本方剂。无气阴偏虚者，直以此方常

服，颇能调节心律，解除疼痛，余屡用之，其效良佳。心悸证一般难于根治，如用本方治疗并辅以祛风除湿、舒利经络之剂，亦能取得良好疗效。（表24）

表24 心悸病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
心脾不足	久受外惊，心乱神摇，心悸不已；思虑烦劳，耗血伤神，或久病脾虚，化源不充，心脉失养	心虚 神怯	补心养血 镇惊安神	龙牡参麦汤
		血气 虚弱	培补心脾 益气养血	归脾汤
心肾亏虚	肾阴不足，水不济火，心阳偏旺；心阳内虚，心动无力。甚则火不制水，肾水泛溢	阴阳 虚旺	滋阴敛阳 养血宁心	天王补心丹
		阳气 虚弱	益气复脉 温阳行水	归芪生脉汤 肾气丸
心络瘀滞	心悸日久，心气亏虚，血流不畅，气滞血涩	血心 瘀痛	益气养血 活络通瘀	参七通脉散

第二节 不寐

不寐又称失眠，以经常不易入寐为主证。古文献有称为不得卧、卧不安、目不瞑者。

不寐表现不一，有就寝难以入寐的；有入寐易醒，醒后不能再寐的；有寐而多梦，时寐时醒的；亦有彻夜不能入寐的。不寐持续日久，常与头晕、头痛、心悸、健忘等证兼并出现。

凡以不寐为主证的病证，属于本篇讨论范围。因于其他疾病过程中所出现的不寐，当以治疗原发疾病为主，不可单从不寐论治。

一、病因病机

发生不寐，皆由神不归阴所致。心主火，藏神，肾主水，藏志，火为阳，水为阴，水火相交，阴阳相济，昼则神出于阳而主寤，夜则神入于阴而主寐。如果阴阳失调，神不归阴，则难于入寐。导致的原因，有如下诸端：

思虑劳倦，伤及心脾。思虑过度，耗血伤神，思则气结，脾运失司，无以生化气血。气虚则神弱，血虚则神舍失守，因而卧不安寐，多梦易醒。所以，心脾不足的不寐，关键在于血虚神弱。凡久病血虚、或老年体弱所发生的不寐，大都与心脾不足有关。

肝肾不足，心神虚怯。心神以肾精为其体，肾精以心神为其用。肝藏魂，禀肾中精气而生，随神往来，寤则出于阳而主动，寐则入于阴而主静，故肾虚则肝虚，肝虚则心虚而神弱。形成肝肾不足的原因有二：一为体质柔弱，肝肾素虚，心神怯弱，触事易惊，惊则神摇，渐致不寐。一为久病阴虚，水不济火，肝阳不潜，神不归阴，因而不寐。一般因于情欲不遂而致少寐多梦者，则为心肝失调、神魂不安所致。

宿食痰火，扰及神舍。脾胃并居中焦，司运化而主升降。饮食不节，伤于胃气，食滞中宫，或胃气虚弱，宿食难消，胃中不和，卧寐难安。此因食滞，其病在胃。另一方面，脾失健运，又能聚湿成痰，痰郁化火壅遏中焦，上扰心神，卧不安寐。此因痰火，其病在脾。

由此可见，发生不寐的原因虽多，总由阴阳失调，神

不归阴所致。导致的病机，一由心脾、肝肾之不足，一由宿食、痰火之干扰，前者多属虚证，后者多属实证。

二、辨证施治

不寐有虚证、实证之分。虚证多由营阴亏虚，治宜补其不足；病在心脾，宜于培补气血；病在肝肾，宜于滋阴平肝。实证多因宿食痰火，治宜泻其有余；病由食滞，治宜消导和中；病由痰火，治宜降痰清火。此即《灵枢·邪客篇》所说：“补其不足，泻其有余，调其虚实，以通其道，而去其邪。……阴阳已通，其卧立至。”此外，对一些顽固性失眠的患者，更应着重精神方面的调理，不可纯恃药物方面的治疗。

（一）虚证

1. 心脾血虚

主证：夜梦纷纭，时寐时醒，心悸健忘，体倦神疲，饮食少思，面色不华，舌色淡白，脉象细弱。

证析：心脾亏损，饮食少思，生化之源不足，气虚则神弱，血虚则神舍失守，故多梦易醒，卧不安稳。血不养心则心悸，血不养神则健忘，血不上荣则面色不华而舌色淡白。血少气衰，是以神疲体倦而脉现细弱。

治法：培补心脾，益气养血。

主方：以归脾汤①为主方。本方健脾益气以畅化源，补血养心以安神舍，气旺则神旺，血旺则神安。凡久病血虚、老人不寐属血虚气弱者，用此方轻量缓服，颇能取得良好疗效。

2. 肝肾阴亏

主证：虚烦不眠，难以入寐，或入寐多梦，时易惊醒，舌红津少，脉弦细数，或兼有头晕、耳鸣、梦遗、心悸等证。

证析：肾水不足，肝阳不潜，因而心阳偏亢，神不归阴，虚烦不眠，难以入寐。心神不安于宅，故寐而多梦，易于惊醒。阴亏于下，阳盛于上，则头晕耳鸣。水不济火，心君不宁，则见心悸。肝阳不潜，相火妄动，则见梦遗。舌红津少，脉弦细数，为阴亏阳盛的病象。

治法：养阴宁心，镇肝安神。

主方：以一梦汤^②为主方。依据阴阳偏亏偏盛不同表现，增损化裁。

（二）实证

1. 宿食停滞

主证：卧寐不安，脘腹痞闷，暖气泛酸，大便不爽，舌苔厚腻，脉象弦滑。

证析：宿食停滞，胃失和降，故脘腹痞闷，暖气泛酸，大便不爽。中焦痞塞，扰及神舍，故卧寐难安。舌厚腻，脉弦滑，皆为宿食内停所致。

治法：健胃消食，理气和中。

主方：以加味枳术汤^③为主方。一般偶因食滞而卧寐不安者，不须药治，节食可愈。如常因胃中不和而不寐，多与胃病有关，宜参考胃痛治法，胃和则卧寐自安。

2. 痰火壅阻

主证：卧不安寐，胸闷多痰，心烦口苦，舌苔黄腻，脉象滑数。

证析：痰浊中阻，胸膈不利，故胸闷多痰。因痰生热，心君受扰，神舍不安，故心烦口苦，卧不安寐。舌黄腻，脉滑数，为痰热壅阻病证。

治法：降痰清热，和胃安神。

主方：以加味半夏秫米汤④为主方。此证较多见于湿痰素盛之人，每因思虑烦劳而致痰郁化热发生心烦不寐。如单从安神治疗，每多不效，故须痰去热清，其卧立至。

三、方药化裁

1. 归脾汤

方药见第三章郁证篇第五方。

用本方治血虚不寐，于方中再加五味子、柏子仁，其宁心安神功效更佳。

2. 一梦汤

钩藤20克 龙齿24克 丹参15克 五味子10克 茯神15克 黄连3克 生地黄15克 夜交藤30克

此方养阴宁心，镇肝安神。适用于营阴不足，心肝失调，证见心烦不寐，或多梦易醒，舌红津少，脉弦细数者。方以钩藤、龙齿平镇肝气；黄连入心，清降心火；生地黄入肾，滋养阴液；丹参、五味子、茯神、夜交藤养心安神。水火相济，心肾相交，则肝气内潜，而神安入寐。

见寐中易惊者，加酸枣仁10克，琥珀末6克（分2次冲服），其镇惊安神之效更佳。见虚烦不眠，彻夜不寐者，加肉桂2克，与黄连相配，更具有清降心火、温升肾水、交通心肾以安神志的功能。如兼夜梦遗精者，加金樱子、

莲须，以固肾止遗，其效亦佳。

3. 加味枳术汤

白术20克 枳实10克 山楂15克 建曲15克 南藿香10克

此方健胃消痞，理气和中。适用于宿食停滞，胃中不和，脘痞暖气，大便不爽者。方以枳实、白术健胃消痞；山楂、建曲化食行滞；藿香快气和中。不寐因于食滞者，重在和胃消食，胃气和降，神舍自安。如食滞已去，仍见不能成寐者，可用加味半夏秫米汤和胃安神之剂。

4. 加味半夏秫米汤

法半夏15克 秫米30克 黄芩15克 茯苓20克 枳壳10克 夜交藤30克

此方降痰清火，和胃安神。适用于痰火壅阻，卧不安寐，胸闷多痰，心烦口苦者。方以半夏燥湿化痰，枳壳开胸利气，茯苓健脾渗湿，黄芩清化郁火，秫米、夜交藤养阴安神。痰去火清，卧寐自安。如痰火已去，仍见不能成寐者，可用一梦汤宁心安神之剂。（表25）

表25 不寐病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
虚证	思虑劳倦，心脾亏虚，血虚神弱，卧不安寐。肾水不足，水不济火，肝阳不潜，神不归阴	心血虚	培补心脾 益气养血	归脾汤
		肝阴虚	养阴宁心 镇肝安神	一梦汤
实证	食滞中宫，胃失和降，卧寐不安。痰郁化火，壅阻中焦，上扰神舍，卧不安寐	宿食停	健胃消食 理气和中	加味枳术汤
		痰火壅	降痰清火 和胃安神	加味半夏秫米汤

第三节 多 寐

多寐一称嗜眠，以不论昼夜，困倦欲睡，呼之即醒，醒后复睡为主证。此与一般热病愈后，人喜恬睡，或因劳累神倦欲睡，醒后即神气清爽者，自不相同。

关于某些急性热病、或慢性疾病过程中出现的昏睡证候，每为病情严重的征兆。对此，不应单从多寐治疗，因而本篇不予论及。

一、病因病机

阳主动，阴主静，阴虚阳盛，阳盛则神不归阴，病为虚烦不寐；阳虚阴盛，阴盛则神气不振，病为困倦多寐。因此，多寐的病机，概要言之，皆由阳虚阴盛引起发病。导致原因有内因也有外因，或以湿困脾阳，或以阳虚脾弱。

因于湿困脾阳者，多发于雨湿之季，或因湿痰素盛、居处潮湿。水湿外侵，则卫气失宣，湿痰内困，则脾气难伸，内外相因，阴盛滞阳，故神气不振而困倦多寐。正如《丹溪心法》所说：“脾胃受湿，沉困乏力，怠惰嗜卧。”

因于阳虚脾弱者，多见于中老年人，或以中气不足，脾气不伸，或以大病之后，阳气虚弱。阳虚则神倦，脾弱则运迟，每于食后，脾气愈困，神气愈倦，因而怠惰欲睡。故何梦瑶《医碥》指出：“食入则困倦欲睡者，脾弱不能即运，不运则静，静则欲睡也。”

由此可见，多寐因于湿困者，皆由阴盛滞阳，非关脾气自虚，其证偏实；多寐因于阳虚者，病在脾虚神弱，其证偏虚。前者以感受外湿为主因，后者以脾气内虚为主因。

二、辨证施治

（一）湿困脾阳

主证：倦怠嗜卧，肢体酸重，沉困乏力，胸闷食少，或多痰涎，舌苔白腻，脉多濡缓。

证析：此证多见于雨湿之季。水湿外侵，荣卫失畅，故肢体酸重。脾为湿困，脾运失常，故胸闷食少。外湿与内湿交困，阴盛滞阳，神气不振，故倦怠嗜卧而沉困乏力。因非骤感寒湿，故不现寒热表证。因非脾气自虚，故不现泻利里证。舌白腻，脉濡缓，均为湿痰内困，脾阳不振所致。

治法：益气疏表，和中化湿。

主方：以黄芪防风汤^①为主方。本方功能益气走表以散外湿，和中燥湿以通脾阳，可根据内外湿邪偏轻偏重加减化裁。

（二）阳虚脾弱

主证：每于食后困倦欲睡，舌脉无异常者，属脾气不足，运化迟缓；若见不论昼夜，头晕懒言，食少神倦，怠惰嗜卧，舌淡脉弱者，属中气虚陷，清阳不升。

证析：阳虚则神弱，脾弱则运迟。其证轻者，仅以运化迟缓，表现食后困倦思睡，舌脉多无异常。其证重者，

气愈虚，神愈弱，故不论昼夜，神倦嗜卧。清阳不升，故头晕，神气衰困，故懒言。脾气虚弱，故食少，舌淡脉弱，为气血虚衰之象。

治法：健脾醒胃，补中升阳。

主方：脾弱运迟，重在健脾醒胃，用香砂四君汤②。中气虚陷，重在补中升阳，用补中益气汤③。如病情较重，可将二方交替进服，总以调理脾胃、补益气血为大法。

三、方药化裁

1. 黄芪防风汤

黄芪24克 防风15克 苍术15克 厚朴15克 橘皮10克 薏苡仁15克 南藿香10克 甘草3克

此方益气疏表，祛湿和中。适用于湿困脾阳，倦怠嗜卧，肢体酸重，胸闷食少，舌苔白腻，脉象濡缓者。方中黄芪、防风合用，振作卫气，祛散外湿。黄芪、苍术相辅，通利脾阳，宣化内湿。佐橘皮、厚朴、薏苡仁、藿香等品，宽中理气，宣利湿浊。荣卫畅和，脾气通利，则湿去神爽，嗜卧自愈。

肢体酸重偏甚者，加防己，以助防风走表散湿。胸闷痰多者，加半夏，以化痰降逆。

2. 香砂四君汤

太子参30克 白术15克 茯苓15克 砂仁6克 甘草3克 南藿香10克

此方益气健脾，醒胃和中。适用于脾气不足，运化迟

缓，证见食后困倦欲睡者。方中太子参、白术、茯苓、甘草益气健脾；砂仁、藿香醒胃和中。如欲增强消化功能，亦可酌加焦山楂、谷芽、鸡内金等品。

3. 补中益气汤（《脾胃论》）

黄芪30克 太子参15克 白术15克 当归6克 橘皮6克 升麻3克 柴胡3克 甘草3克

此方补脾养血，益气升阳，是治一切清阳下陷诸证的良方。本方用于阳虚多寐，正如李东垣所说：“形体劳役则脾病，脾病则怠惰嗜卧。”脾居中焦，主司升降，中气健旺，则清阳自升。故阳虚多寐，均以调治脾气为主。

如脾胃虚寒，见肢冷便溏者，可先与香砂四君汤加炮干姜温中健脾。如脾阳已复，仍见怠惰嗜卧者，再进补中益气汤。（表26）

表26 多寐病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
外因	雨湿之季，脾为湿困，阴盛滞阳，沉困嗜卧	湿困脾阳	益气疏表和中化湿	黄芪防风汤
内因	阳虚神弱，脾弱运迟，脾气不足，病为食后欲睡；阳虚气陷，病为昼夜嗜卧	阳虚脾弱	健脾醒胃补中升阳	香砂四君汤 补中益气汤

第四节 健忘

健忘以记忆减退，遇事善忘为主证。医籍中亦称喜忘、善忘。

如因老年神衰而善忘，儿童期恍惚忘事，或生性迟钝

而记忆不聪，多系生理现象，不可指为病证。

一、病因病机

健忘属虚者居多，导致的原因：一以荣血不足，一以阴精亏虚，血虚主于心脾，阴虚主于心肾。

心主血脉，脾为气血生化之源，故血虚与心脾的关系最为密切。平素思虑烦劳，伤神耗血，思则气结，脾运失司，久而荣血亏虚，神舍失养。血虚则神弱，神弱则记忆衰退，遇事善忘。久病血虚之人，神舍不聪，亦能健忘。故《血证论》说：“失血家，心脾血虚，……健忘之证尤多。”

脑为精髓神明之府，肾为生化精髓之源。汪昂指出：“人之精与志皆藏于肾，肾精不足则志气衰，不能上通于心，故迷惑善忘也。”导致肾精亏损的原因有二：一以久病阴虚，伤及肾精；一以素禀不足，劳心过度。心伤则神弱，精伤则脑力不充，因而记忆衰退，令人健忘。

此外，因于外伤或血脉的病变，造成瘀血留滞，阻碍神机，亦能令人健忘。此即《血证论》所说：“心有瘀血，亦令健忘。”

二、辨证施治

健忘常与失眠、头晕、心悸诸证并见，其治疗原则，一般以养心血、补脾肾为主。因于瘀血而致健忘者，当从实证论治，以活血逐瘀为主。

(一) 心脾血虚，记忆不聪

主证：记忆减退，遇事善忘，倦怠食少，失眠心悸，肤发不泽，舌质淡，脉细弱。

证析：心脾不足，饮食减少，荣血亏虚，血虚则神弱，神弱则记忆不聪，故遇事善忘。血为气之母，血虚气亦虚，故倦怠乏力。血不养心则心悸，血不养神则少寐，不为荣泽肌肤，则肤发不泽。舌质淡，脉细弱，为气血不足病证。

治法：培补心脾，益气养血。

主方：可随气血偏虚的不同选用归脾汤①或人参养荣汤②。二方均为培补心脾、益气养血之剂，前方重在益气安神，适用于气虚神弱，眠差多梦者；后方重在养血宁心，适用于血虚心悸者。

(二) 阴精亏虚，脑力衰弱

主证：健忘少寐，头晕耳鸣，腰酸腿软，或有遗精早泄，舌淡红，脉弦细。此多见于久病阴虚之人。

若病出无因，常见神志恍惚，事过即忘，诵读不聪，舌脉如常者，多属禀赋不足，脑力不充。

证析：肾精不能上奉于脑，脑力衰弱，记事不聪，故健忘。阴虚不能养神，神舍不宁，故少寐。阴精亏虚，上不能充灌于脑，则头晕耳鸣；下不能腴养筋脉，则腰酸腿软。肾虚而精关不固，则见滑精早泄。舌淡红，脉弦细，为阴精亏损病象。如属禀赋不足，平素已脑力不充，若以劳心太过，每见神志恍惚，记事不稳，事过即忘。因非因病所致，故一般舌脉如常。

治法：补肾健脑，养阴安神。

主方：以左归饮③为基本方，随病情轻重加味治疗。因于素禀不足者，可用枕中丹④与左归饮合方并用，更具滋阴补肾、开通神智之力。

除上列二证外，尚有瘀血健忘一证。其证以卒然健忘，忽犯忽好为主证，常与头昏头痛并见，多有头部外伤或血脉病变史。因瘀血凝聚，阻碍气机，每于用脑或劳动之际，导致瘀血浮动，壅塞神窍，令人卒然健忘。对此，治宜活血逐瘀为主，可用血府逐瘀汤加郁金、菖蒲方⑤。

三、方药化裁

1. 归脾汤

方药见第三章郁证篇第五方。

此方益气健脾，养血安神。适用于思虑劳伤，心脾不足，荣气偏虚，证见健忘神倦，眠差多梦者。

2. 人参养荣汤（《和剂局方》）

太子参20克 白术15克 茯苓20克 当归10克 白芍10克 熟地黄10克 黄芪20克 肉桂3克 五味子6克 远志6克 橘皮6克 甘草3克 大枣10克 生姜1小片

此方益气健脾，补血宁心。适用于心脾不足，荣血偏虚，健忘心悸，肤发不泽者。方以太子参、黄芪、茯苓、白术益气健脾；当归、白芍、熟地黄滋补荣血；肉桂、五味子、远志温补心气。故用于荣血偏虚而以健忘心悸为主证者为宜。

3. 左归饮（《景岳全书》）

熟地黄10克 山药15克 茯苓15克 枸杞10克 山

茱萸10克 炙甘草3克

此方纯为补益肾阴之剂，凡属肾阴亏虚，均可以本方主治。阴虚健忘，证属纯虚，方以熟地黄、枸杞、山萸滋补肝肾之阴；以茯苓、山药、甘草培土润脾。阴回脾旺，脑力可充。

如少寐多梦者，加酸枣仁、五味子，以养心安神。腰腿酸软者，加怀牛膝、巴戟天，以补益肝肾，强健筋骨。滑精早泄者，加金樱子、菟丝子，以固精止遗。

如久病健忘，精髓已亏，阴阳两虚者，加入龟胶、鹿胶、河车粉等品，其补肾健脑之功更宏。

4. 枕中丹（《千金方》）

龟板24克（炙酥） 龙骨20克 远志3克 菖蒲3克

上药加量研粉制丸剂，每服3克，日服2~3次，常服。

此方补肾健脑，开通神智。适用于素禀不足，记忆不聪者。前人认为，龟为介虫之长，龙为鳞虫之长，二物禀阴阳之灵气，故能补益肾阴，镇肝宁神。方中辅以远志、菖蒲在于交通心肾，开利神窍。补肾即可健脑，开窍则神智自聪。故《千金方》说：“久服令人大聪。”如嫌补肾功能不足，可与左归饮并用，其补脑益智力量更优。

吾乡曾某，晚年得子，已13岁而语言蹇涩，事过即忘，不能诵读。余以枕中丹、左归饮（去龟板用龟胶）配合制丸剂，令其常服。一年后，语言流畅如常人，服药2年，已能入学诵读。由此可见，因于先天不足、智力不聪者，如于发育期施以治疗，亦能取得一定的疗效。

5. 血府逐瘀汤加郁金菖蒲方（《血证论》）

当归10克 生地黄10克 桃仁10克 红花3克 川芎

3克 柴胡3克 枳壳3克 甘草3克 赤芍6克 牛膝6克
桔梗6克 郁金6克 菖蒲6克

此方行气解郁,活血通瘀。适用于血瘀健忘,忽患忽好,它药无效者。本方善治人体上部瘀血内阻之证,加郁金、菖蒲更能行气解郁、破瘀通窍。故用治血瘀而致健忘者颇宜。惟导致本病有外因(如头部外伤),亦有内因(如久病气虚或阴虚),如属气虚而致血涩、或阴虚而致血滞者,又当以补气或滋阴而兼活络通瘀的方药,方为适合。

(表27)

表27

健忘病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
思虑伤脾,久病血虚, 血虚神弱,记事不聪	心脾血虚 记事不聪	培补心脾 益气养血	归脾汤 人参养荣汤
素禀不足,久病阴亏, 肾精亏虚,脑力衰弱	阴精亏虚 脑力衰弱	补肾健脑 养阴安神	左归饮 枕中丹
或因病后,或因外伤, 瘀血留滞,阻碍神机	血瘀健忘	行气解郁 活血通瘀	血府逐瘀汤 加郁金菖蒲

第五节 遗 精

凡成年男子不因交接而精液遗泄者,名为遗精,又称失精。

遗精有梦遗与滑精之分,有梦遗精者,为梦遗;不因梦感而遗,或见色而精自滑出者,为滑精。二者在证候上有轻重之别,梦遗往往为滑精前因,滑精多属梦遗后果。

一般成年男子未婚或婚后,因于久旷而偶有遗泄,遗

后并无不适感觉者,这是精满自溢的现象,并非病态。若三、五天或一、二天遗泄一次,甚或白昼精自滑出,并伴有头昏倦怠,腰酸体瘦,精神萎靡等证状,则当及时治疗。

一、病因病机

发生遗精,主因在于心肾,也有因于湿热而发病的。因此,其导致原因,可分心肾失调与湿热瘀积二方面。

梦遗的病机,多由君相火旺,引起发病。心藏神,心为君火,肾藏精,肾中寓有相火,肝肾居于下焦,肾主封藏,肝主疏泄。青壮年人,气盛多欲,如心有注恋,情思不忘,情动则神动,神动而引动相火,则肝阳随起,促使肾精离位,发生梦遗。初遗不以为意,至再至三,损及肾阴,阴虚则相火偏旺,火旺则更易促使精液走泄,故不梦则已,梦则自遗。

梦遗日久,或青年早婚,恣情纵欲,致令精关久滑,精气亏损。精亏不能养神,则神气衰弱,气虚不能摄精,则封藏不固。于是即可出现:或梦遗与滑精并见,或无梦亦常滑精,甚或白昼间稍有所感而精自滑出。正如《证治要诀》所说:“色欲过度,下元虚惫,泄滑无禁。”又有禀赋不足,肾气素弱之人,若因劳神过度,神不摄精,亦能发生遗精。此即《证治要诀》所说:“用心过度,心肾不摄而遗。”

凡此,主因皆在心肾,或以君相火旺,神动精摇,发生梦遗;或以肾虚不固,神不摄精,发生滑精。

因于湿热瘀积而遗精者，皆由湿热下注，水道不清，湿阻热瘀，扰动精室，精为热迫，肾失封藏，亦可发生精液遗滑。故《明医杂著》说：“梦遗精滑，饮酒厚味，痰火湿热之人多有之。”由此可见，此类遗精并非心肾自虚，主因在于湿热瘀积。

二、辨证施治

遗精一证，首应区别发病新久，有梦无梦，以及伴随的脉证，才能作出确切诊断。大体初病不久，梦遗居多，属君相火旺者多见；久病遗精，无梦居多，多为肾虚不固。若遗精而兼见湿热证状，用一般止遗方药无效者，多属湿热瘀积之证。在治疗上，要依据病情，分别采用清心宁神、补肾固精、清导湿热等治法。本病除药物治疗外，尤须注意精神调养，节制思欲，否则不易取得满意效果。所以张景岳说：“苟欲惜精，先宜净心。”

（一）君相火旺

主证：梦遗居多，次日头昏乏力，体倦神疲，或见耳鸣心悸，或形体日渐消瘦，舌红少津，脉弦带数，或舌脉如常。

证析：君相火旺，则心神不宁而多梦，梦有所感引动相火，则精液走泄而梦遗，故其证以梦遗居多。梦遗频作，暗耗肾阴，阴虚不能上奉于头，则头昏耳鸣；不能上济于心，则心悸；不能济养于神，则体倦神疲；不能充养肌肤，则形体日渐消瘦。病情轻浅者，舌脉多无变化，若见舌红少津，脉弦带数，则为水亏火旺之象。

治法：养阴宁神，清火止遗。

主方：以清火止遗汤^①为主方。本方功能养心宁神，潜制相火，如其人睡眠多梦，可酌加镇肝安神之品。

（二）肾虚不固

主证：无梦滑精，或梦遗与滑精并见，兼阳强易举，举而精滑，头目昏眩，形体瘦弱，舌质红，脉弦细数者，属肾阴偏亏、相火独盛；兼滑精频作，甚或不论昼夜，稍有所感而精自滑出，面色苍白，精神萎靡，舌淡白，脉沉弱者，属肾气偏虚、封藏不固。

证析：梦遗日久，或恣情纵欲，精关久滑，必致伤肾，肾虚则封藏不固，即见始而梦遗与滑精并见，继则无梦而精自滑出。偏于阴虚者，阴虚不能制火，相火独盛，故见阳强易举。封藏不固，易于走泄，故见举而精滑。肾阴亏损，不能上承，故头目昏眩；不能充养肌体，故形体瘦弱。舌质红，脉弦细数，为肾阴亏耗、相火内盛之象。偏于气虚者，多因病久不愈，阴精大亏，阴亏则精不化气，肾气同虚，因而封藏失职，滑精频作，甚则白昼亦见滑泄。真阴内亏，元气虚衰，精气不能上荣于面，故面色苍白；精亏气弱，形神衰惫，故精神萎靡。舌淡白，脉沉弱，为下元虚惫、气血不足之象。

治法：补益精气，潜制相火，固涩精关。

主方：偏于阴虚者，宜于固肾养阴，潜制相火，可用三才封髓丹^②；偏于气虚者，宜于补肾益精，固涩精关，可用水陆固精汤^③。

上列二证，较多见于青壮年人，必须告诫患者，应注意精神调养，排除情思杂念，是治疗本病的关键。同时还

应注意生活调理,如晚餐不宜过饱,睡前少食刺激性食品(如烟、酒、茶之类),禁止阅读风情小说,睡时宜于侧卧,衬裤不宜过紧,已婚者尤应注意节制性欲,等等。

(三) 湿热瘀积

主证:小便热赤,遗精频作,登厕时及小便后,亦见精自滑出,茎中时有痒痛,如欲小便之感,口干苦,苔黄腻,脉滑数。

证析:湿热下注,瘀积膀胱,水道不清,故小便热赤。湿热瘀留,扰动精室,故遗精频作。瘀热为甚,精为热迫,故于登厕或尿后,亦见精液滑出。湿热上蒸,则见口干苦,苔黄腻。湿热下迫,则见茎中痒痛,而有欲便之感。脉滑数,亦为湿热征象。

治法:健脾导湿,清热通瘀。

主方:以苦参白术汤④为主方。本病以下焦瘀热为主因,属实证者居多,不可妄用固涩止遗方药,湿去水清,其精自固。

本病常以轻重程度的不同,尚能出现阳痿、热淋、甚或癃闭等证,临证时须与有关各病种的辨证治法相互参考。

三、方药化裁

1. 清火止遗汤

黄连6克 丹参15克 酸枣仁15克 茯神15克 生地
黄15克 金樱子30克

此方清心宁神,养阴止遗。适用于君相火旺,心神不

宁，夜梦遗精，脉弦带数者。方以黄连清心泻火；丹参、酸枣仁、茯神宁心安神；生地黄、金樱子养阴固精。清心即可潜制相火，火降即可固精止遗。如梦遗为甚者，加五味子、莲须，以敛肾涩精。如睡眠多梦者，加龙骨、夜交藤，以镇肝安神。

2. 三才封髓丹（《卫生宝鉴》）

天门冬10克 熟地黄10克 太子参24克 炒黄柏15克 砂仁3克 甘草3克 肉苁蓉10克（煎剂，或加量制丸剂服）

此方补益精气，潜制相火。适用于肾阴偏亏，阳强易举，滑精早泄者。方中天门冬、熟地黄滋养肺肾之阴；太子参、肉苁蓉益气补肾；黄柏潜制相火；砂仁、甘草和中醒脾，运行药力。是方肺脾肾同补而重在滋阴固肾，故用于精气不足、肾阴偏亏者颇宜。若见滑精频作，方中再加芡实、金樱子，其固肾涩精之力更优。

3. 水陆固精汤

金樱子24克 芡实15克 莲须15克 菟丝子20克 沙苑蒺藜15克 五味子10克 补骨脂10克

此方由《集验方》水陆二仙丹加味组成，功能扶补肾气，固涩精关。适用于肾气偏虚，封藏不固，滑精频作，脉来沉弱者。方中金樱子、芡实、莲须均为固肾止遗要药；与菟丝子、沙苑蒺藜、五味子、补骨脂相配，更能扶补肾气、固涩精关。故本方用于精关久滑，肾虚不固之证，其效甚佳。

如将本方制为丸剂服用，可于方中加入小量黄柏、砂仁二味，更能收到补肾坚阴之效。

4. 苦参白术汤

苦参24克 白术15克 木通20克 丹参20克 生地黄15克 金钱草30克 甘草6克 南藿香10克

此方健脾导湿，养阴清热，消肿通瘀。适用于下焦湿热，瘀积膀胱，精滑不禁，小便热赤，茎中隐痛，苔黄腻，脉滑数者。方用苦参之清利，以消瘀积之热；白术健脾，以杜生湿之源。下焦湿热，非通不利，故以木通、金钱草清利水道。精滑不禁，必伤肾阴，故以生地黄滋阴养肾。湿热蕴积，水道瘀肿，故以丹参祛瘀消肿。佐甘草、藿香和中宣化，以利消导湿浊。瘀去肿消，水道清利，其精自固。如茎中痒痛为甚，可加琥珀以助导湿通瘀之力，如小便已得清利，仍有遗精现象者，可用清火止遗汤调理。（表28）

表28

遗精病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
情思多欲，相火妄动，病为梦遗；恣情纵欲，精气亏虚，病为滑精；湿热下注，水道不清，精为热迫，肾失封藏	君相火旺	养阴宁神 清火止遗	清火止遗汤
	肾虚不固	补益精气 固涩精关	三才封髓丹 水陆固精汤
	湿热瘀积	健脾导湿 清热通瘀	苦参白术汤

第六节 阳 痿

凡男子阳事不举，或举而不坚，或临房伊始，立即痿缩者，即名阳痿。

《灵枢·藏府病形篇》有“阳痿”的记载,张景岳指出:“阳痿者,阳不举也。”由此可见,阳痿即阳痿,同属男子性功能减退的疾病。

年老之人,性功能减退,多属生理现象,不能视为阳痿病态。如青年发育期,病出无因,见阳事痿弱不举者,又称死阴,应考虑是否先天性隐睾所致,必须注意鉴别。

一、病因病机

宗筋弛纵,痿弱无力,发生阳痿。《类证治裁》说:“故阳之痿,多由色欲竭精,斫丧太过,或思虑伤神,或恐惧伤肾。”“亦有湿热下注,宗筋弛纵,而致阳痿者。”由此可见,阳痿的病机,主因在于心肾亏虚,又有湿热伤肾的区别。

久患遗精,或恣情纵欲,或青少年误犯手淫,斫伤太过,损耗肾精,久则精气亏虚,命门火衰,而致宗筋痿弱,阳事不举。亦有因恐惧不释,或临房惊恐而发病者。惊则气乱,恐则气下,致令肾气亏伤,宗筋痿弱,发生阳痿。凡此,主因在于肾虚精亏。

劳心太过,苦用神思,暗耗荣血,久则心虚神弱,气血不足;或忧愁不释,肝气失畅,木不疏土,脾失健运,以致气血化源不充。心虚神弱,则心火不能下交于肾,气血亏虚,则宗筋失于温养,因而宗筋弛纵,阳痿不举。凡此,主因在于心虚神弱。

湿热下注,瘀积膀胱,致精为热迫,引起精滑不禁,久而肾精亏损,精气俱虚;或因湿热久积,湿阻肾阳,热

耗肾精，致令精气不振。凡此，均可导致宗筋痿弱，发生阳痿。

总之，阳痿发病，有精亏、神弱、湿热之分，其病机与心、脾、肝、肾有密切关系，而以心、肾亏虚为其主因。肝主筋，足厥阴之筋，结于阴器，故《灵枢·经筋》说，其病“阴器不用，伤于内则不起”。肝禀肾之精气而生，精亏则肝肾不足，因而宗筋弛纵，阳痿不举。神气衰弱，缘于心脾亏损，气血化源不充，不能温润宗筋，亦能导致阴器痿软无力。湿热下注之阳痿，也因热伤肾精而发病，惟此证一般比较少见，故张景岳有“火衰者十居七八，火盛者仅有之耳”之说。

二、辨证施治

阳痿一证，轻者可不表现全身证状，重者可随病因不同而有不同证候表现。本病属虚证者居多，因湿热所致之阳痿，常多出现虚实互见。

治阳痿以补益肝肾为基本法则，宜于温阳育阴两顾，药宜和平，不宜辛烈，防止动火害阴，反害肾气。属于神弱血虚之阳痿，当以培补心脾为主，兼用补益精气方药。若属湿热下注者，则以清热导湿为先，水清湿去，仍见阳痿，方可酌用温阳育阴治法。

（一）精气亏虚

主证：阳痿不举，或举而不坚，或阴冷精寒，头目昏眩，面色苍白，精神萎靡，腰腿乏力，四肢不温，舌质淡，脉沉细。

证析：此证多因久患遗精或恣情纵欲而发病。肾为水火之脏，精气俱虚，宗筋失于温润，轻者阴器软弱，举而不坚，重者宗筋弛纵，阳痿不举，甚则阴冷精寒而无性感。元阴元阳亏损，脏腑精气衰惫，下而不能温养筋脉则腰腿乏力；上而不能荣泽头目，则头目昏眩，面色苍白；外而不能温充肢末，则四肢清凉；不能济养神气，则精神萎靡。舌质淡，脉沉细，均为精气亏虚所致。

治法：补益肝肾，育阴助阳。

主方：见举而不坚，易于痿缩，舌脉如常者，属精气不足轻证，宜补肾助阳平剂，用五子衍宗丸^①为主方，酌加仙茅、韭菜子、补骨脂等品。见阳痿阴冷而无性感者，属精气虚寒重证，宜补肾温阳重剂，可用景岳赞育丹^②随证加减。

（二）心脾亏损

主证：性欲衰退，或阳痿不举，神倦食少，肤发不泽，眠差多梦，或心悸，或健忘，唇舌淡白，脉细缓弱。

证析：此证多因忧愁思虑或劳心太过而发病。思虑忧郁，伤神耗血，损伤心脾，心虚则神弱，脾虚则化源不充。气血不能温达宗筋，轻者性欲衰退，重者阳痿不举。脾虚气弱，故神倦食少；血虚不能荣泽肌肤，故肤发不泽；血虚不能养神，故眠差多梦；血虚不能养心，则心悸；血虚神弱，则健忘。唇舌淡白，脉细缓弱，皆为气血不足病证。

治法：培补心脾，益肾助阳。

主方：以归脾汤^③为主方。本方调补心脾，益气养血，气血健旺，诸证自愈。阳痿甚者，宜采取心肾同补治

法，用五子衍宗丸与归脾汤交替进服，以共收补肾助阳功效。

（三）湿热伤肾

主证：小便热赤。阳痿不举，或初见遗精，久而阳痿，阴囊湿润，茎中隐痛，舌苔黄腻，脉象沉滑。

证析：湿热瘀积，水道不清，湿阻肾阳，热伤肾阴，精气亏伤，因而阳痿。也有精为热迫，初见遗精，日久阳痿者。湿热互结，蕴蒸于下，湿注阴器，则阴囊湿润；热灼阴络，则茎中隐痛。苔黄腻，苔沉滑，俱为湿热与肾虚互见的病证。

治法：清热导湿，滋肾养阴。

主方：见小便热赤短涩，茎中隐痛者，属瘀热犹甚，宜与苦参白术汤④清热导湿重剂。见小便已通，余热未除，宜用知柏地黄汤⑤养阴渗湿，清泻积热。若湿去水清，仍见阳痿者，属精气未复，可用五子衍宗丸调理。

三、方药化裁

1. 五子衍宗丸（《证治准绳》）

菟丝子20克 覆盆子20克 枸杞子10克 五味子10克 车前子10克（作煎剂或加量制丸剂服）

此为补肾助阳平剂。适用于精气亏虚，遗精阳痿，其证较轻者。方药配合，补肾益精，固涩止遗，且药性和平，补而不涩，故用于遗精阳痿者颇宜。阳痿甚者，加仙茅10克，韭菜子10克，补骨脂10克，其温肾壮阳功效尤佳。余治一阳痿早泄，婚后10年无子，即以本方加味，再加九

香虫20克（炒脆研细），雄蚕娥5个（酒浸捣泥），制为丸剂，早晚各服1次，每服6克，服药1年后，连得子女各一。由此可见，本方以衍宗得名，信可知矣。

2. 赞育丹（《景岳全书》）

熟地黄240克 白术240克 当归180克 枸杞180克
杜仲120克 仙茅120克 巴戟120克 山萸120克 淫羊
藿120克 肉苁蓉120克 韭菜子120克 蛇床子60克 制
附片60克 肉桂60克

上药制蜜丸，每丸重6克，每服1丸，早晚空胃服。

若病久虚甚者，加人参、鹿茸亦佳。

此为补肾壮阳重剂。适用于阳痿精衰，阴冷精寒者。方以大队补益精血、温肾壮阳之品，故用于阳痿阴冷重证为宜。服用方法，以小量缓服为佳，切忌妄求速效。如阴冷已退，阳痿已轻，亦可改用五子衍宗丸加味治法，以巩固疗效。

3. 归脾汤。

方药见第三章郁证篇第五方。

本方用于神弱阳痿之证，重在健脾养血，培补神气，临证运用，仍以轻量缓补为宜。

4. 苦参白术汤

方药见本章遗精篇第四方。

5. 知柏地黄汤（《医宗金鉴》）

生地黄15克 丹皮10克 山药15克 茯苓24克 泽
泻15克 山茱萸10克 知母15克 黄柏15克

此方滋阴渗湿，清泻积热。适用于湿热伤肾而见遗精阳痿者。湿去水清，精气恢复，阳痿可愈。如欲加强清利

湿热力量，加金钱草，其效更宏。（表29）

表29 阳痿病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
久患遗精，惊恐伤肾，精气亏损，宗筋痿弱；忧愁思虑，劳伤心脾，神弱血虚，宗筋失养；湿热瘀积，湿阻肾阳，热伤肾阴，精气不振，发生阳痿	精气亏虚	补益肝肾 育阴助阳	五子衍宗丸 赞育丹
	心脾亏虚	培补心脾 益肾助阳	归脾汤 五子衍宗丸
	湿热伤肾	清热导湿 滋肾养阴	苦参白术汤 知柏地黄汤

结 语

心悸、不寐、多寐、健忘、遗精、阳痿诸证，都以心肾的病变而为基本规律。又因脾为生化气血之源，肝禀肾中精气而生，故心肾的病变往往涉及肝脾而互为因果地发生和发展。

心藏神，主血脉，肾藏志，主精髓，因而心、肾病变多以精、血亏虚导致一系列神志衰弱的疾病。不过，心病或肾病，血虚或精虚，在主、从关系上则是有所区别的。

病于心者，以血虚为辨证中心，以心病及脾、或心病及肾为演变规律。血虚而致心脉失养，心失自主，触事易惊，病为心悸。血虚不能养神，神舍不安，病为不寐。血为气之母，血虚日久，气血同虚，气虚则神弱，神气不振，病为多寐。血虚而致神气衰退，则记事不聪，病为健忘。凡此，大都表现为心病及脾的病变。心有妄想，引动相火，动摇精室，发生遗精，则属心病及肾，主因在心。

病于肾者，以阴虚为辨证中心，以肝肾、或心肾同病为演变规律。肾阴不足，水不济火，心阳偏旺，阳旺则心神不宁，病为心悸。阴虚阳旺，心肾不交，则神不归阴，病为不寐。肾阴亏损，不能济养神志，精亏神弱，记忆不聪，病为健忘。遗精失治，肾气亏损，封藏不固，病为滑精。滑精病久，命门火衰，宗筋痿弱，病为阳痿。凡此，皆以肾病为主，或以心的病变发展而来，或以肾病为主而累及心肝。

由此可见，本章所论各病，虽致病原因各有不同，偏虚偏实证情各异，其病机演变则是互为因果的。如将病种间因果关系综合起来，大体可分心脾亏损、肝肾不足两大类证，而以血虚、阴虚作为辨证重点。在治疗上，则以和调心肾、兼顾肝脾、补益精血为基本法则。（表30）

表30 心肾疾病病机简表

心肾 疾病	心(血虚)	神舍不安: 不寐	心脉失养: 心悸→血虚神弱: 健忘	
		神气不振: 多寐		
	心肾同病(神志失调)		君相火旺: 梦遗 肾气不固: 滑精	精气亏虚: 阳痿
	肾(阴虚)	阴虚阳旺	心悸→神不归阴: 不寐→精亏神弱: 健忘	
心神不宁				

第五章

肝脾疾病

久患疟疾，耗血伤脾，病为疟母（脾肿大）。肝炎迁延，气郁络瘀，病为肝积（肝肿大）。肝积日久，累及于脾，肝脾同瘀，病为肝脾积聚（肝脾肿大）。积聚失治，血脉瘀塞，久则水气瘀积，停聚大腹，病为鼓胀。由此可见，疟疾、肝炎、积聚、鼓胀等疾病的病机演变，均与肝、脾密切相关，故并列一章作出论述。

黄汗、黄胖与黄疸有相似表现，故附列章末以资鉴别。

第一节 疟 疾

疟疾以寒战壮热，休作有时为主证，多发于夏秋季节，且有一定的地区性和传染性。据《礼记·月令》所载：“孟夏之月，寒热不节，民多疟疾。”可见，疟疾是我

国流行最早的传染病之一。

近代已知，疟疾皆由疟蚊传染人体所引起。在历代医籍中，由于诱发病因、体质强弱、寒热偏盛、病情新久的差异所表现的不同证候而有多种类型。本篇分时疟、瘧疟、久疟三类以概括诸证。时疟有一日一发、间日一发、三日一发的，其中以间日一发者较多见。瘧疟多发于岭南山瘧地区，由感受山瘧湿毒发病，是疟疾中比较险恶的疾病。反复发病，久延不愈，称为久疟，遇劳即发者为劳疟，胁下结块者为疟母。正因病情不同，证候各异，必须区别施治。

一、病因病机

疟邪感染人体，常留伏于半表半里之间，正强邪弱，多不发病。若素体薄弱、劳倦过度、或兼感风寒暑湿之邪，以致正气内虚，不能抵抗邪气，邪正相争，发为疟疾。

半表半里乃少阳分野，属于肌腠的分界，是卫气荣血出入之所。喻嘉言说：“疟邪每伏藏于半表半里，入与阴争则寒，出与阳争则热。”由此可知，疟疾发病，表现寒热往来，是疟邪与阴阳相争所造成的。疟邪乘虚内入而与荣血相争，邪并于阴则阴胜，阴胜则阳气被遏，故表现振寒战慄。正气有捍御邪气本能，正邪相搏，正气得胜，驱邪外达，外与卫气相争，邪并于阳则阳胜，阳胜则热，故继寒战而后表现壮热不已。终于正胜邪衰，汗出热退，邪正暂时相离，其病休止。经过一定周期，邪气复胜，又

与卫气相集，寒热再作。正如《素问·疟论》所说：“夫疟气者，并于阳则阳胜，并于阴则阴胜，阴胜则寒，阳胜则热。”“卫气相离，故病得休，卫气集则复病也。”正因寒热休作是疟疾邪正相争的主要表现，所以休作时间的长短，又是判断疟邪深浅的主要标志。一日一发者，为邪居阳分，其病浅；三日、四日一发者，为邪居阴分，其病深。寒热发作，从日间转入夜间者，为疟邪从阳入阴由浅入深之象，反之，则属从阴出阳而为病势向愈之征。

久疟不愈的病机演变，多以耗血伤脾为特性。血为气之母，血虚则气虚，气血虚衰，邪留不去，表现遇劳即发者，为劳疟。久疟迁延，荣血大亏，邪深入脏，络瘀凝聚，结为痞块，居于左胁，则成疟母。瘴疟一证，常来势凶猛，病情险恶，甚或危及生命。一般表现：或以毒热内燔而见壮热持续；或以邪毒内闭而见寒慄不已。虽其证不似时疟之休作有时，在病机演变上则是基本相同的。

总之，本病皆以感受疟邪为主因，是否发病与正气强弱关系密切。正如赵献可《医贯》所说：“夏伤于暑，秋必病疟，……然而有病有不病者，盖邪之所凑，其气必虚，故其人元气不固者，暑邪得以乘之。”

二、辨证施治

本病在临床上要注意似疟与真疟的鉴别。真疟发作，寒热往来，休作有时，有明显的周期性和间歇性。一般疾病发生寒热往来，多为时寒时热，发作无期。所以戴思恭说：“寒热发作有期者疟也，无期者诸病也。”又因此病多

见于在疟疾流行区居住或停留过之人,依据其典型证状是不难诊断的。

在治疗方面,以祛邪截疟为基本法则。疟疾初发,正盛邪实,无兼挟证者,直以祛邪截疟治之,如兼挟风、寒、暑、湿及挟痰、挟食者,又当和调荣卫兼治诸证,然后施以截疟方药。对于久病、体弱的病人,多属正虚邪实,则当扶正祛邪,不可单用截疟治法。现分别论治如下:

(一) 时疟

主证:先寒后热,休作有时,或一日一发,或二日一发,或三日一发。其病发作,先以微寒,继则寒战,厚衣厚被,不觉其暖,约持续一、二小时,寒战停止,继以全身壮热,饮冰去被,不觉其凉,伴剧烈头痛,口渴引饮,持续2~3小时,终于遍身汗出,热退身凉,到一定周期,寒热再作。

疟疾之脉,多随寒热进退而变化,恶寒时脉多沉弦,发热时脉现洪大弦数,汗出热退,脉转平静。

其证表现热多寒少,或但热不寒,伴烦渴喜冷,小便黄赤短少,舌红苔黄,脉洪弦数者,属于疟疾兼暑,邪热偏盛,名曰温疟,或称瘴疟。

其证表现寒多热少,或但寒不热,伴口中不渴,肢体酸疼,汗泄不畅,呕恶胸闷,舌苔白腻,脉象弦缓者,属于疟疾兼寒,寒邪偏盛,名曰寒疟,或称牝疟。

此外,疟证见多痰喜呕者,称为痰疟;见胸脘痞满,暖腐食臭者,称为食疟。

证析:疟邪居于荣卫分腠之间,邪正出入,交相争

搏，是以表现寒热往来。疟邪内与阴争，邪并于阴，阳气阻遏，则阴胜而阳衰，故振寒战慄，厚被不觉其温。正气外与邪争，郁遏之阳驱邪外达，邪并于阳，则阳胜而阴衰，故壮热烦渴，饮冰不觉其凉。邪热上蒸，故头痛如裂。热盛伤津，故口渴引饮。终于正胜邪衰，汗出热退，其病休止。疟多弦脉，阴胜而阳气被遏，故现沉弦；阳胜而邪热蒸腾，故现洪大弦数；脉转平静，为正邪相离之象。

温疟因于内蕴暑热，邪热相并，阳热偏盛，故热多寒少，或但热不寒。热盛伤津，饮水自救，故烦渴喜冷。尿黄短少，舌红苔黄，脉洪弦数，均为暑热伤津之象。

寒疟因于兼感寒邪，阴寒偏盛，阳气运行失常，不能驱邪外达，故寒多热少，或但寒不热。寒邪阻遏，荣卫不利，故肢体酸疼，汗泄不畅。寒邪犯胃，胃失和降，故胸闷呕恶。口不渴，苔白腻，脉弦缓，均为阴寒偏盛所致。

治法：疟疾休止期，宜于疏解少阳，和表清里，首先祛除兼挟之邪；当疟疾发作前，则以祛邪截疟为主；疟疾止住后，宜于培健脾胃，扫荡余邪。

主方：休止期用小柴胡汤^①为主方，依据寒、热偏盛或挟痰、挟食增减化裁。发作前用常山鳖甲丸^②截疟祛邪。疟疾止住后，用青蒿四君汤^③扶健脾胃以清余邪。

凡疟疾初发，每多兼挟寒热之邪，截疟过早，易留后患。疟疾已发，不宜妄投截疟方药，恐药病相争，演生它变。这是治疟必须注意的。

（二）瘧症

瘧症好发于我国南方山岚地带，约在金元时期从南方

传播于北方，而致引起流行。如张子和《儒门事亲》载：

“余亲见泰和六年丙寅征南，师旅大举，至明年军回，是岁瘴疰杀人，莫知其数。”本病因感暑湿疰毒发病，其证险恶，热毒独盛者为热瘴，湿毒独盛者为冷瘴。

1. 热瘴

主证：寒热休止多不规律，初见先有微寒，接着持续发热，头痛面赤，烦渴饮冷，胸闷呕吐，出汗，骨节烦疼，甚或壮热不退，出现谵语神昏，通常经七、八天后，发热减退，其病休止，再经10天左右，又可发作。舌质红绛，或舌苔燥黄，脉弦数或洪数。

证析：瘴气疰毒，邪热独盛，故热多寒微，发热持续。热毒上蒸，则头痛面赤；热耗阴津，则烦渴饮冷；热毒犯胃，则胸闷呕吐；热蒸于外，腠理疏松，则汗出；荣阴亏伤，筋脉失养，则骨节烦疼。如壮热不退，邪陷神明，则见谵语神昏。舌红绛，苔黄燥，脉弦数或洪数，皆为热毒内燔伤及荣阴所致。

治法：祛邪解毒，清热保阴。

主方：用知母鳖甲汤^④为主方，随病情轻重加味治疗。壮热神昏者，宜急用紫雪丹^⑤清心开窍，以防神迷不救。

2. 冷瘴

主证：寒热休止，仍不规律，初起即恶寒战慄，或有微热，或但寒无热，伴有头身疼痛，胸闷呕吐，甚者寒战持续，出现神迷失语，舌苔白腻，脉多沉弦而数。

证析：湿毒独盛，壅闭于内，阳气阻遏，不得宣达，故见寒甚热微，或但寒不热。寒湿阻滞，筋脉不利，故头

身疼痛。湿毒犯胃，故胸闷呕吐。若湿毒内陷，闭阻神窍，则见神迷失语而成哑瘴危证。苔白腻，脉沉弦而数，均为湿邪内困病象。

治法：祛邪解毒，化浊开闭。

主方：用青蒿半夏汤^⑥为主方，随其病情加减化裁。若神迷失语者，宜加服苏合香丸^⑦以宣利气机，开通神窍。

由于瘴疟来势凶猛，寒热休止不甚规律，必须根据当地发病情况，明确诊断，及时治疗。且其证险恶，病变危急，并不限于上述治法。

（三）久疟

疟疾迁延，或反复发病，致成久疟，分劳疟、疟母二证。

1. 劳疟

主证：久疟不愈，寒热时作，遇劳即发，面色萎黄，倦怠食少，形体瘦弱，舌质淡，脉细弱。

证析：久疟不止，伤脾耗血，正虚邪恋，故寒热时作，遇劳即发。脾气虚，故倦怠食少。荣血虚，故面色萎黄。体瘦弱，舌质淡，脉细弱，均为气血亏伤病象。

治法：补中益气，扶正祛邪。

主方：寒热休止时，以补中益气为主，用补中益气汤^⑧。正气已复，寒热又作者，可用常山鳖甲丸截疟祛邪。疟止后，着重扶补脾气，和调荣卫。

实践证明，单以截疟方治劳疟，每多难于取效，而用补中益气法施治，往往又能取得止疟效果。可见，扶正托邪一法，实为治疗久疟虚证的主要法则。

2. 疟母

主证：左胁下结块，扪之有形，或胀或痛，疟仍时作，脘闷不舒，面色萎黄，形体消瘦，舌质淡紫，脉象弦细。

证析：久疟不愈，耗伤气血，邪深入脏，以致血络瘀凝，形成痞块。韩善徵《疟疾论》指出：“其痞居左胁为多。”故见左胁结块，扪之有形。痞块瘀聚，位当脘腹，故见脘闷不舒，或胀或痛。面萎黄，体消瘦，舌淡紫，脉弦细，皆为气血亏虚、脏络瘀凝、虚实互见的表现。

治法：疟疾未止，先从劳疟施治；疟疾已止，正气恢复，宜用攻补兼施之法。

主方：用鳖甲煎丸^⑨攻瘀消积；用人参养荣汤^⑩扶补气血。视其虚实多少，交替进药。

疟母一证，往往虚实互见，治疗宜以慢攻缓补渐次取效为佳。反之，峻攻必害正，大补必碍瘀，求速效则害愈深。

三、方药化裁

1. 小柴胡汤（《伤寒论》）

柴胡10克 黄芩15克 太子参15克 法半夏10克
甘草3克 大枣12克 生姜6克

此方疏表清里，和解少阳，扶正祛邪。适用于疟疾初发，往来寒热，心烦喜呕，口干苦，舌苔薄白或微黄，脉弦或数者。方以柴胡、黄芩疏表清里；太子参、甘草、

大枣扶正祛邪；生姜、半夏和胃安中。疟邪居于半表半里，邪干于外则荣卫不和，邪干于内则胃失和降。其病初发不偏寒热者，直以本方投之，便能取得疏解少阳、扶正祛邪、解除寒热、安中和胃之效。

疟邪兼暑，阳热内盛，热多寒少，或但热不寒，烦渴饮冷者，加青蒿30克，生石膏30克，知母24克，以清解暑热，除烦止渴。疟邪兼寒，阴寒偏盛，寒多热少，或但寒不热，肢体酸疼者，加桂枝10克，白芍15克，以温阳散寒，调和荣卫。其人痰饮素盛，兼见痰多喜呕者，宜加重半夏为15克，再加枳壳12克，以加强降痰止呕力量。若其人兼见胸脘痞满，暖腐食少，此为疟邪挟食，宜加山楂15克，枳实12克，以助消痞化食。

2. 常山鳖甲丸

常山 槟榔 鳖甲上药各等分，研制为丸，如麻子大，每次服10克，疟疾发作前4小时用冷开水冲服1次，隔2小时再服1次，疟疾止住后，再将本方连服2天，早晚空腹各服1次。

凡以常山为主之方，均宜空腹冷服，服后一、二小时内忌热饮热食，以防导致呕吐。

此方即《证治准绳》三圣丸去穿山甲加鳖甲组成，功能祛邪截疟。方中常山、槟榔皆为祛除疟邪主药，二者与鳖甲相配，更能益阴解热，入络搜邪。故本方用于截疟之效，甚为得力。如丸剂备用不及，将三药各用10克，作煎剂，分2次内服亦可。

3. 青蒿四君汤

青蒿30克 太子参24克 白术15克 茯苓15克 甘

草6克

此方扶补脾气,清除疟邪。适用于疟疾已止,脾气已虚,食少口淡,倦怠乏力者。方以青蒿清除疟邪;以太子参、茯苓、白术、甘草扶补脾气。故用于疟疾止后,既可调补脾胃,又能扫荡余邪,以防其病反复。对服常山鳖甲丸有呕吐反映者,亦可改用本方调治。

4. 知母鳖甲汤

知母24克 鳖甲24克 常山10克 青蒿30克 生石膏30克 竹叶10克

此方据《肘后方(原方无名)》去地骨皮加青蒿组成,功能清热解暑,祛邪止疟。适用于温疟、热瘧,壮热不解,烦渴饮冷者。方中常山、青蒿均有祛邪止疟良效。青蒿配以鳖甲,善于清解阴分之热;与知母、石膏、竹叶同用,更能消暑除烦以解阳分之热。热清邪退,则荣卫和而烦渴止。

若见胸闷泛呕,为毒热犯胃,宜减去常山(防其助呕),倍加青蒿用量,加法半夏、黄连以清热止呕。若津液已亏,舌转红绛者,可酌加玄参、麦门冬、石斛、生地之类,以清热生津。

5. 紫雪丹

方药见第三章厥证篇第九方。

本方用于热瘧神昏,在于撤热解毒、清心开窍、挽救危机。一俟热退神清,仍宜进以清解暑热、祛邪止疟方药。

6. 青蒿半夏汤

青蒿30克 姜半夏15克 槟榔10克 苍术15克 茯

苓24克 橘皮10克 甘草3克 南藿香10克

此方芳香化湿，祛邪止疟。适用于冷瘧，恶寒战慄，胸闷呕恶者。方以青蒿、槟榔祛除疟邪；半夏、苍术燥湿止呕；橘皮、茯苓理气运湿；甘草、藿香和中化浊。湿毒宣散，荣卫自和，寒慄可止。

见胸闷泛呕，便溏不爽者，为浊湿郁伏，困阻脾阳。酌加草果仁以温化湿浊。见舌苔黄腻厚浊者，为湿郁伏热，加佩兰、黄芩，以清热化湿。如小便黄少者，加滑石。

7. 苏合香丸

方药见第三章中风篇第七方。

本方用于冷瘧神迷失语，在于辛通开窍，宣利气机，以救一时之急。一俟神识清醒，仍当进以宣化湿毒、祛邪止疟方药。

8. 补中益气汤

方药见第四章多寐篇第三方。

本方补中益气，升阳托邪。久疟气虚，单用截疟药难于取效，因气虚不能托邪外解，故劳疟用此方，颇有良效。

9. 鳖甲煎丸（《金匱要略》）

鳖甲12分（炙） 乌扇（即射干）3分 黄芩3分 柴胡6分 鼠妇（即地虱）3分（熬） 干姜3分 大黄3分 芍药5分 桂枝3分 葶苈1分 石苇4分（去毛） 厚朴3分 牡丹皮5分 瞿麦2分 紫葳（即凌霄花）3分 半夏1分 人参1分 蜚虫5分（熬） 阿胶3分 蜂窠4分（炙） 赤硝12分 蜣螂6分（熬） 桃仁2分

按上列分量比例研制为丸剂,每服6克,日服2次,空胃下。

此方理气理血,攻瘀消积。适用于久症不愈,邪深入脏,左胁结块,成为疟母者。全方药物配合,以攻瘀通络为主,兼能理气养血,扶补正气,是一首治疗疟母脾积的专方。据临床运用,脾积未久,结块不大,用此方施治,确有疗效。若脾积日久,积体坚实,或块大如掌者,一般取效较难。

凡治脾积切勿峻攻急攻,防其伤害正气,反致积块难消。用药宜于轻量缓攻,形体不虚,直以此方投之,形体已虚,则当辅以补益方剂。用攻药要注意胃气,食欲不振,大便微利,即应停攻,胃气恢复,再进攻药。如此治疗,俾使坚顽之积,得以渐次消磨而愈。

10. 人参养荣汤

方药见第四章健忘篇第二方。

本方培健脾胃,益气养血。用此方与鳖甲煎丸配合治疟母虚证的目的,在于扶补气血,运化积块。因此,仍宜轻量缓补,不可重补急补,以防堵塞瘀凝,愈增积滞。在运用上,体气大虚者,先补后攻;虚实参半,边补边攻;攻后体虚,则当停攻进补。总以补虚勿忘实,攻实当顾虚为原则。(表31)

表31 疟疾病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
疟邪藏伏于半表半里，入与阴争则寒，出与阳争则热，正胜邪衰，寒热休止，正邪相集，寒热再作。其病有时疟、瘧疟、久疟之分	时 疟	和表清里 祛邪截疟 健脾荡邪	小柴胡汤 常山鳖甲丸 青蒿四君汤
	热 瘧	清热祛邪	知母鳖甲汤 紫雪丹
	冷 瘧	化浊开闭	青蒿半夏汤 苏合香丸
	劳 疟	补中祛邪	补中益气汤
	疟 母	化瘀消积 益气养血	鳖甲煎丸 人参养荣汤

第二节 传染性肝炎

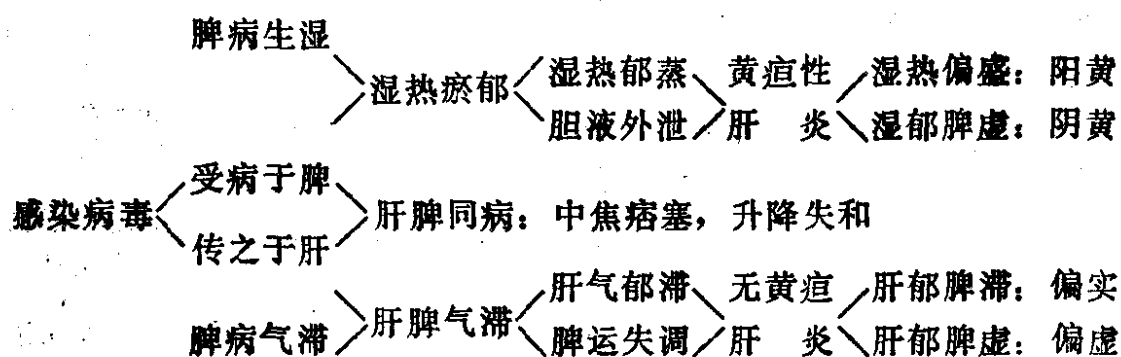
传染性肝炎简称传肝，属于消化道传染病之一，是由感染肝炎病毒所引起。表现黄疸症状者，称为黄疸性肝炎；无黄疸症状者，称为无黄疸性肝炎；后者尤为临床多见。

由于传肝是临床常见疾病之一，且用中医药治疗，颇具卓效。本篇即从中医理、法、方、药的运用作出论述。

一、病因病机

传肝常因接触患者的用具，或病毒携带者排出粪便所污染的食物，传染于他人而致发病。黄疸性肝炎以身黄、目黄、小便深黄、脘腹痞闷、右胁胀满隐痛为主证；无

黄疸性肝炎,除不表现黄疸外,证状和体征一般相同。从这些主证和主征来看,均由肝脾同病,中焦痞塞,升降失和所引起。现将其病机演变简示如下:



肝合胆,脾合胃,肝胆有疏泄脾胃的职责,脾胃与肝胆相互合作,能发挥腐熟水谷、运化精微、和调血脉、升清降浊等功能。肝与脾为脏,脏气主升,以储藏精血、输布津液为本能;胆与胃为腑,腑气主降,以腐熟水谷、排泄糟粕为本能。平常人肝气升发,胆气和降,脾得肝气助益,将胃中腐熟之精微,运化转输,“上注于肺脉”(《灵枢·荣卫生会》),“散精于肝”、“归入于心”(《素问·经脉别论》),注入脉中,化为津液荣血,输布全身。胃得胆液助益,既有助于胃腑消化食物,又有助于肠道传送糟粕,形成粪便,排出体外。这便是肝胆与脾胃体现于消化功能方面的生理关系。

传肝病毒一般随污染食物从口入胃,受病于脾,传之于肝。肝中受病,气机不畅,则胆失和降,肝胆气滞,则疏泄功能失职。于是脾气郁滞,运化无能,而致中焦痞塞,升降失常。在肝脾同病的病机演变中,又可因病情的轻重而有黄疸或无黄疸的不同病变。

脾郁为甚，运化失司，精微津液不循常道输布，壅遏中焦，蕴湿生热，湿热郁蒸，腑气不降，胆液不得下泄，因而外浸肌肤，发生黄疸。正如《临证指南》所说：“湿从火化，瘀热在里，胆热液泄，与胃之浊气共并，上不得越，下不得泄，熏蒸遏郁，侵于肺则身目俱黄。”由此可见，传肝发黄，皆由脾病生湿，蕴湿化热，湿热郁蒸，胆液外浸所引起。如毒热偏盛，热蒸湿壅，身面眼目黄如金色者，名曰阳黄；久病脾虚，湿从寒化，身面眼目黄如烟熏者，名曰阴黄。前者属实，后者虚实互见。这是传肝表现于黄疸证候的一面。

脾郁为轻，壅湿未甚，郁热无多，仅以肝脾气机郁滞，发生脘痞胁痛，无黄疸出现，证状和体征一般轻微，也有临床证状不甚明显者。似此常不被注意，延误病期，及至证候显露，明确诊断，已成慢性疾病。所以，无黄疸性肝炎，常以病程的新久而区别其偏实偏虚。初病不虚，病在气滞，其证偏实；脾滞日久，脾运久亏，日渐伤荣，其证偏虚，而多虚实并见。这是传肝表现于无黄疸证候的一面。必须指出：无黄疸性传肝，在病程经过中，也有蕴湿化热而出现黄疸病变的，其病机与黄疸性传肝一致。

由上所述，又可说明，传肝虽属肝的疾病，实则以脾胃病变为主。由于肝病犯脾，脾病反侮于肝，交相瘀郁，脾病尤甚，所以传肝的病机，始终以中焦升降失调为特征。

二、辨证施治

传肝病人常以持续出现倦怠乏力，食欲不佳，脘腹痞

闷，右胁间胀满隐痛，大便不爽，或兼有面目皮肤黄染而就医诊治。通常经体检发现肝体肿大，并有明显压痛，肝功能检验出现谷一丙转氨酶升高，或其他项目数值高于正常，即可确定诊断。黄疸性传肝着重区辨阳黄阴黄；无黄疸性传肝重在辨别偏实偏虚。

治传肝以清热解毒，通腑行滞，舒肝理脾，开郁散瘀为基本法则。传肝发黄，重在清热解毒，辅以通腑行滞，清热即可消黄，通腑即可去毒，务使湿热郁毒得以从下分消。黄疸消退（包括无黄疸传肝），重在舒肝理脾，辅以开郁散瘀，理气即可开郁，气行则瘀肿自消，务使脾运调畅，肝气条达，则腑气降而痞塞通。尤须指出：传肝之热，热因湿郁，过用栀子、黄芩、芒硝、大黄寒凉攻泻，易于伤害脾胃，脾虚则湿从寒化，由实转虚。传肝之郁，脾滞尤甚，理脾则肝郁自开，若着眼于肝而妄用柴胡升散之品，常易鼓动郁热，劫害肝阴。传肝之肝体肿大，因于气滞络瘀，治宜理气开郁，不可妄行攻瘀，恐凿伤脏气，瘀肿难消。传肝之虚，虚实并见，补虚当顾实，行实勿忘虚，虚实兼顾，当以轻补为宜，尤忌辛温燥烈方药。总而言之，和调脾胃，解除郁滞，是治疗传肝非常重要的基本准则。

（一）黄疸性传肝

1. 阳黄（湿热偏盛）

主证：身目发黄，其色鲜明，黄如金色，脘腹痞满，右胁胀闷隐痛，食少厌油，或有发热，或见恶心呕吐，小便黄赤短少，大便秘涩不爽，或见灰白色大便，舌苔黄腻，脉象弦数。

若病来暴急，其势险恶，起病即见高热烦渴，迅速出现身目深黄，色泽鲜明，胸满腹胀，恶心呕吐，神昏谵语，甚或出现鼻血、呕血、便血、或肌肤斑疹，舌质红绛，舌苔黄燥，脉弦滑数者，名曰急黄，此属阳黄重证。

证析：热重于湿，热蒸湿壅，胆液不循常道，溢于肌肤，热为阳邪，故黄色鲜明，发为阳黄。湿热壅遏中焦，脾气不行，故脘腹痞满；肝气郁滞，故右胁隐痛。湿滞中宫，胃为湿阻，故食少厌油；湿浊犯胃，则见恶心呕吐。胆为热迫，胆液不得下行，肠气失于疏泄，故大便失畅，甚而出现灰白色大便。小便黄赤短少，舌黄腻，脉弦数，均为湿热蕴结、中焦运化不利所致。急黄为阳黄重证，是由毒热炽盛所引起。火性急迅，故来势暴急，病情险恶。由于毒热内炽，不仅迅速出现身目深黄，还可深入荣血，伤及络脉，发生各种出血证候，甚则邪陷心包而见神昏谵语。此病虽偶有一见，但病情危急，如不及时救治，每多陷于死亡。所以《巢源·急黄候》说：“内为毒热所加，故卒然发黄，心满气喘，命在顷刻。”

治法：清热解毒，通腑行滞。

主方：以茵陈解毒汤^①为主方。本方重在清热消黄，可随湿热轻重及中焦郁滞之程度，郁滞为甚，重在通腑，湿滞为甚，重在利湿，务使湿热之邪从下分消。对急黄险证，尤当着重凉热解毒，如已邪陷心包，更应辅以安宫牛黄丸^②或至宝丹^③等清心开窍方药。

2. 阴黄（湿郁脾虚）

主证：身目发黄，其色晦暗，黄如烟熏，头重身困，神疲畏寒，脘闷食少，腹胀便溏，小便黄而不利，舌质

淡，苔腻微黄，脉象沉缓。

证析：素体脾虚，或阳黄期过于清泻，因而形成脾虚湿胜，湿重于热，发为阴黄。湿为阴邪，湿遏热伏，故黄色晦暗，状如烟熏。阴湿内阻，清阳不振，故头身困重，神疲畏寒。脾胃已虚，运化失常，故脘闷食少，腹胀便溏。湿遏热阻，交相蒸郁，故小便黄而不利。舌质淡，苔腻微黄，脉沉缓，皆为湿热留滞，脾气已虚，虚实并见之象。

治法：健脾和胃，利湿消黄。

主方：以茵陈胃苓汤④为主方。本方虚实兼顾而以轻清轻补取胜，依据虚、实程度随证增损。

（二）无黄疸性传肝

本病可始终无黄疸出现，常以右胁下胀满隐痛，脘腹痞闷不适，食欲欠佳为主证。由于起病有新久、体质有强弱，故临床上着重辨别偏实、偏虚两类证候。

1. 偏实（肝脾郁滞）

主证：右胁下胀满隐痛，脘腹痞闷，食后尤甚，大便不爽，时秘时溏，或见口苦尿黄，舌苔薄腻微黄，脉多弦滑。

证析：初病不虚，病在气滞。肝中受病，气机郁滞，络脉随瘀，故见右胁下胀满隐痛。肝气失疏，脾气难伸，胆气不利，胃失和降，因而中焦痞塞，升降失和，故见脘腹痞闷，大便不爽。中焦气机郁滞，最易蕴湿生热，故本病多伴有口苦尿黄证状。舌苔薄腻微黄，脉象弦滑，亦为肝脾失疏、郁而化热之证。

治法：舒肝理脾，开郁散瘀。

主方：以茵陈枳术汤^⑤为主方。是方和调肝脾、理气开郁，可依据肝脾郁滞的轻重程度，随证化裁。脾气畅和，则肝郁解而瘀滞消。

2. 偏虚（肝郁脾虚）

主证：右胁下隐隐作痛，脘腹痞闷，不思饮食，肢体乏力，面色萎黄，大便溏薄，舌质淡，苔薄腻，脉弦细缓。

证析：肝脾郁滞，运化失调，久而损伤脾胃，气血化源不充，于是虚实并见，滞者仍滞，虚者愈虚。右胁隐痛，脘腹痞闷，为肝脾气机郁滞表现。脾气已虚，运化无权，故见不思饮食，大便溏薄。气血不足，不为腠养筋脉肌肤，故见面色萎黄，肢体乏力。舌质淡，苔薄腻，脉弦细缓，皆为气血不足、脾胃虚弱所致。

治法：益气健脾，舒肝开郁。

主方：以黄芪枳术汤^⑥为主方。本方虚实兼顾而重在健脾，脾气升发，胃气和降，则肝气畅而瘀滞消。

总的来说，治传肝总以和调脾胃为首务，运用方药也以不害胃气为准则。对证状表现较轻的病例（如无黄疸传肝），切不可因证状暂时消退轻易停药，防其反复而致病势迁延。在饮食方面，除严禁饮酒外，过多吃糖亦有碍脾害胃之弊。

三、方药化裁

1. 茵陈解毒汤

茵陈24克 栀子10克 板蓝根24克 茯苓24克 泽

泻24克 枳实12克 南藿香10克

此方清热解毒,和中利湿。适用于黄疸性传肝属阳黄实证者。方中茵陈为清解肝胆郁热、除湿消黄主药。以栀子、板蓝根清泄毒热;茯苓、泽泻和脾利湿;枳实通腑行滞;藿香和中化浊。郁热消除,脾胃畅利,湿热邪毒得从二便分消。见呕吐者为湿浊犯胃,可加半夏、青皮降逆止呕。见大便秘涩难通者,为肠中结热,可酌加生大黄通腑泄热,得泄则止,不可过剂,以防害胃。见高热烦渴,来势暴急者,属于急黄重证,宜于方中加黄连10克,犀角6克(研细分3次冲服),以加强凉热解毒之力,防止邪热内陷。

凡用本方,应随时注意胃气,黄消大半,宜改用茵陈胃苓汤和中运湿,以消余黄,恐过于清泻,损害脾胃。

2. 安宫牛黄丸

方药见第三章厥证篇第八方。

3. 至宝丹

方药见第三章中风篇第五方。

安宫牛黄丸与至宝丹同属清热解毒、开窍安神重剂。此二方用于急黄高热,邪陷心包,神昏谵语,重在凉热开窍,挽回危机。热退神清,仍从阳黄施治。

4. 茵陈胃苓汤

茵陈24克 白术15克 茯苓24克 猪苓15克 泽泻15克 厚朴15克 橘皮10克 甘草6克

此方健脾和胃,利湿消黄,适用于黄疸性传肝,脾虚湿胜,湿重于热,表现为阴黄证状者。方用茵陈为主,以清肝胆郁热。白术与厚朴、橘皮、甘草相伍,和胃理气,除

满宽中。白术与茯苓、猪苓、泽泻合配,健脾渗湿,畅利水道。脾运复常,胃气和降,浊湿郁热得以从下分消。见脘腹痞胀,大便溏而不爽者,为脾气郁滞尤甚,加隔山消30克,以助健脾消痞之功。见脘闷食少,大便溏薄者,为脾虚湿困,加砂仁6克,南藿香10克,以温脾止泄,和中化浊。见大便泄利,其质清稀,兼四肢清冷,神疲畏寒,脉象沉迟者,此为脾虚中寒,宜加炮干姜3克,制附片15克,温中助阳,宣化寒湿。但宜中病即止,不可过剂,防止辛燥助热。

5. 茵陈枳术汤

茵陈24克 白术15克 茯苓24克 枳实12克 丹参20克 郁金20克 山楂15克 南藿香10克

此方舒肝理脾,开郁散瘀。适用于无黄疸传肝,肝脾郁滞,其证偏实者。肝脾郁滞,最易积湿生热,故以茵陈清热除湿,作为全方主药。茵陈与茯苓、白术相配,使其健脾渗湿,畅利水道。白术与枳实、山楂、藿香相佐,使其行滞消痞,开利胃气。辅以丹参、郁金二味,使其舒肝开郁,活络散瘀。脾运畅和,肝气得舒,诸证自除。见肝区胀痛甚者,加白芍20克,炒金铃15克,以助缓急止痛之力。见脘腹痞胀甚者,加隔山消30克,以行滞消痞。见口苦尿黄,舌苔黄腻,此为内蕴湿热,可酌加栀子、泽泻,以清热利湿。见大便常燥,口干,舌红苔少者,此为肝胃津亏,去白术、藿香,加山药、玉竹、女贞子、谷芽等甘淡益胃生津之品。

凡用本方切勿以证状暂时消退轻易停药,必须以病情稳定,肝功恢复,肝大消除,作为痊愈标准。据临床所见,

一般连服 1～2 个月后,即能取得良好效果。

6. 黄芪枳术汤

黄芪24克 白术15克 茯苓20克 枳壳12克 丹参15克 砂仁6克 鸡内金6克

此方益气健脾,舒肝开郁。适用于无黄疸性传肝,肝郁脾虚,其证虚实并见者。方用黄芪、白术、茯苓益气健脾,以扶其虚。白术、枳壳健脾消痞,以行其滞。黄芪、丹参益气活络,以散其瘀。砂仁、鸡内金温脾开胃,以止其泄。和调肝脾,虚实兼顾,脾运复常,肝络通畅,诸证自愈。如见小便色黄,舌苔黄腻,此为湿热留滞表现,可加茵陈20克,南藿香10克,以清解郁热,宣化湿浊。

凡用本方治疗,如脾胃功能已见复常(食欲增进,大便调畅),肝郁证状尚未消除(肝区疼痛,肝体肿大),可于方中加入郁金15克,继续调治,以期巩固疗效。(表32)

表32

传肝病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
接触传肝病毒,从口入胃,受病于脾,传之于肝。脾郁为甚,蕴湿生热,湿热交蒸,腑气不降,胆液外浸,病为黄疸性肝炎;脾郁为轻,湿热未甚,中焦痞塞,升降失和,病为无黄疸性肝炎	黄 疸 性 肝 传	阳 黄	清热解毒 通腑行滞
		阴 黄	健脾和胃 利湿消黄
	无 疸 性 肝 传	偏 实	舒肝理脾 开郁散瘀
		偏 虚	益气健脾 舒肝开郁
			茵陈解毒汤
			茵陈胃苓汤
			茵陈枳术汤
			黄芪枳术汤

第三节 积 聚

积聚一名癥瘕，以腹内结块，或痛或胀为主证。本病皆渐积而成，常起因于气机郁滞，渐致络脉瘀阻，久而瘀血停聚，形成结块。一般块形不大，软而不坚，推之移动，胀多于痛，痛有休止，属气病为多，为时尚暂，其病较轻。如块形较大，坚实牢固，推之不移，痛无休止，痛有定处，属病深入血，为时已久，其病深重。

《难经·五十六难》根据结块的不同部位，区别为：“肝之积，名曰肥气”；“心之积，名曰伏梁”；“脾之积，名曰痞气”；“肺之积，名曰息贍”；“肾之积，名曰奔豚”。此外，医籍中还有肠覃、石瘕、瘕（伏）瘕、痞块、痞癖、癖块等名称的记载。由此可见，积病的范围是比较广泛的。本篇仅以肝脾积聚（肝脾肿大）作出论述。

一、病因病机

导致肝脾积聚（肝脾肿大）的病因有多种方面，依据临床所见，较多出现于慢性肝炎或慢性血吸虫病患者。传肝迁延，转为慢性，初以肝积，久而累及于脾，发生脾积。或因田间劳作，或因入水游泳，接触含有血吸虫尾蚴的疫水而被进入皮肤感染发病，病后失治，成为慢性，始而肝大，渐致脾大，甚或出现巨脾。由此可见，上述两种疾患，虽然致病原因各不相同，感染途径亦不一致，但在肝

病累脾而致瘀聚成积这一病机关系上,则是基本相同的。其病机演变可分以下两方面:

(一)肝病伤脾

肝有疏泄脾胃的功能,肝中受病,气机郁滞,疏泄失常,因而脾气难伸,中焦痞塞,升降失和。脾病以后,运化失调,初为气滞食阻,病在气分,久而气滞络瘀,由气入血,病深入脏。脏络阻滞,日渐积久,瘀血停聚,脏体增大,左胁痞胀,扪之有形,成为脾积。

(二)脾病伤肝

脾有运化精微“散精于肝”(《素问·经脉别论》),入肝化血的职能。脾气郁滞,运化失常,积渐日久,脾运亏虚,于是,形成滞者愈滞而虚者愈虚。脾气郁滞,又能阻碍肝气,从而疏泄无权,肝郁愈深。脾运亏虚,入肝化血之源不充,荣运不足则肝络瘀涩。气滞络瘀,迁延日久,瘀阻愈甚,是以肝体肿大,右胁隐疼,扪之肥厚,致成肝积。若始为肝大,日渐变小,多因肝血亏损,络脉瘀结,肝体萎缩所致。

由此可见,肝脾积聚皆由脏气郁滞,交相阻遏,互为因果,积渐形成。其病机演变,始为脏腑功能失调,病在气滞,继则气滞络瘀,由气及血,终于病深入脏,瘀血停聚,而致脏体增大,结为痞块。所以,肝脾结块的大小程度,常常是判断病情浅深的主要标志。如肝体肿大,脾大未甚,其病尚浅;脾大于肝,其病已深;若肝体萎缩,或脾大如掌,则属晚期重证。

二、辨证施治

肝脾积聚常并发于慢性肝炎、慢性血吸虫病、或平素有嗜酒习惯的病员，其鉴别要点如下：（表33）

表33

病 史	有慢性肝病史，或有长期嗜酒史	有血吸虫疫水接触史，粪检有虫卵，孵化有毛蚴
肝脾触诊	肝体肿大或缩小，脾脏轻度或中度肿大	肝体左叶肿大明显，可见巨脾
黄 疸	有轻度黄疸者多见	少见
肝功能检验	有明显损害者多见	一般损害较轻
预 后	早期治疗，效果良好	出现巨脾，恢复较难

本病常以两胁胀闷，隐隐刺痛，脘腹痞胀为主征。其证虚实并见者居多，病程尚暂，病情较轻，证多偏实；病程已久，病情较重，证多偏虚。其治疗大法，一则通瘀开郁以消其积；一则调补脾胃以扶其虚。其证偏实，通瘀为主，兼理脾胃；其证偏虚，攻补兼行，重在扶脾。总以攻积当顾虚，补虚勿碍实为原则。如属血吸虫病，对一般情况较好的病员，则宜首先采取杀虫治法，以消除致病之源（目前以西医杀虫疗法较可靠）。现分别偏实偏虚论治如下：

（一）偏实（络瘀气滞）

主证：积块初成，软而不坚，两胁胀痛并见，胀多于

痛，脘腹胀满，大便不爽，小便黄，脉弦滑，舌苔薄黄，或舌色带紫。

证析：肝居右胁，脾居左胁，脏络瘀阻，气机郁滞，积而成块，故两胁胀痛并见。积犹未久，气滞居多，故软而不坚，胀多于痛。肝脾气滞，疏泄不利，运化失常，故脘腹胀满，大便不爽。小便黄，脉弦滑，苔薄黄，为肝有郁热；舌色带紫，主络脉瘀滞。

治法：宗《医学心悟》“积聚未坚，宜直消之，而后和之”的法则，治宜舒肝理脾，行滞通瘀。

主方：以茵陈枳术汤^①为主方。本方重在舒肝理脾，开利胃气，用治肝脾积聚，宜加入三七、三棱、莪术等品，以增强活络通瘀的力量。肝气舒利，脾运复常，血络通畅，其积自消。

（二）偏虚（络瘀血虚）

主证：积块增大，按之觉硬，胁痛如刺，痛而不移，形体日渐消瘦，身现红缕血痣，面色萎黄，脘闷食少，大便溏薄，舌色紫暗，脉象弦细。

证析：积块日久，气结日深，络瘀益甚，故见积块增大变硬。气滞血瘀，络脉不通，故胁痛如刺，痛处不移。肝脾久郁，脾运日亏，气血化源不足，无以腴养肌肤，故形体消瘦，面色萎黄。脾虚而运化无权，故脘闷食少，大便溏薄。身现红缕血痣，舌色紫暗，主血脉瘀滞。脉弦细，主肝郁血虚。凡此，皆属虚实并见的证候。

治法：宗《医学心悟》“积聚日久，邪盛正虚，法从中治，须以补泻相兼为用”的法则，治宜益气健脾，舒肝开郁，行气通瘀。

主方：以黄芪枳术汤^②为主方。本方重在健脾醒胃，脾虚甚者，先用本方以扶其虚，俟脾运恢复，饮食增进，再于方中加入三七、郁金以理气散结、活络通瘀。对此积久虚证，必须量其虚实，且补且攻，或补多攻少，或补少攻多，总以慢补轻攻为宜，切勿急补猛攻，妄求速效。

凡治肝脾积聚以脾积消退为主要标志。无论偏实偏虚诸证经过治疗，胃口已开，脾运复常，脾积未消或块消及半者，当继以和调肝脾，通瘀消积治法，宜用消痞散^③常服调理。此即《医学心悟》所说“块消及半，便从未治，即住攻击之药，但和中养胃，导达经脉，俾荣卫流通而块自消”的法则。

此外，由于慢肝或慢性血吸虫病导致的肝脾积聚，其证常多虚实互见，实指脏体瘀结，络脉凝滞；虚指脾运亏损，气血不足。虚者宜补，补之不当，反而碍实助瘀，实者宜攻，攻之失宜，亦能损伤脏络。且因此等疾患均非短时可愈，既不可重补猛攻妄求速效，而于攻补方药的运用，尤应加以选择。扶补之方，重在健脾和胃，健脾宜于甘温平补（如太子参、黄芪、茯苓、白术之类），虽见大便泄利，不可妄用辛温大热（如干姜、肉桂、附子之类），恐其燥血助瘀；和胃宜于理气宽中（如厚朴、枳实、砂仁、藿香之类），虽见大便滞结，不可妄用攻泻（如大黄、芒硝之类），防其伤脾害胃。攻积之方，重在活络通瘀，活络以理气开郁为先，通瘀以导达经脉为要，辛窜之品（如当归、川芎），耗气燥血，多非所宜；介类药物（如鳖甲、穿山甲），滞脾害胃，久用亦不相宜。总之，攻补的运用，求其功专性平，渐次取效，并始终以保护胃气为

首务。据临床实践，凡脾积在肋下3厘米以内，如能坚持治疗，确能达到根治的良效。

三、方药化裁

1.茵陈枳术汤

方药见本章传肝篇第五方。

本方舒肝理脾，开郁散瘀。用于慢肝见脾大不甚，积犹未久，其证偏实者，方中宜加重丹参、郁金为24克，再加三七粉3克（分2次冲服），其通瘀消积作用甚优。凡因于血吸虫病日久迁延，脾积较大，其质偏硬者，一般攻积药取效较缓，可再加三棱、莪术各10克，以加强行气攻瘀力量。惟三棱、莪术破血力峻，俟其积体变软，即宜减去，以防损伤脏络。

经用本方治疗，胁间胀痛已见消除，饮食二便已见复常，即可停止汤剂，改用消痞散化瘀消积。

2.黄芪枳术汤

方药见本章传肝篇第六方。

本方益气健脾，舒肝开郁。用于肝脾积聚，脾气偏虚者，宜于方中加入郁金20克，三七粉3克（分2次冲服），则具攻补兼行、通瘀消积之力。一俟脾运复常，病情稳定，即改用消痞散以消瘀积。

3.消痞散

丹参180克 郁金150克 白术100克 枳实60克 砂仁（去壳）30克 鸡内金30克 云南三七30克

上药共研极细粉末，每服4克，日服2次，午晚饭前

一小时用温水调匀（亦可加入少许食糖）送服。

此方舒肝理脾，通瘀消积，因善消脾积，故以消痞立名。方中丹参养血活络，功能去瘀生新。郁金行气解郁，善于消除血中凝滞。三七散瘀消肿，功专效宏。白术、枳实健脾理气；砂仁、鸡内金和中醒胃。诸药合配，攻补兼行，且功专性平，攻不害正，补不碍实。积因血瘀，瘀因气滞，气血流畅，络脉通利，积块自消。

本方以小量久服取效，以3个月为1疗程，视病情轻重可连服2~3个疗程。少数病员于初服时，腹中有灼热感，几天后即渐消失。若灼热较甚难于忍受，可酌减服药剂量，俟灼热消退，再加量进服。

如属血吸虫病肝脾积块，脾积较大，瘀结坚顽，服药进展不大者，可另用水蛭30克（加糯米一小撮，炒令米黄，去米，研极细粉末），每服消痞散一次，加水蛭粉1克，以加强逐瘀散积功能。本品破血力强，俟脾积变软，即宜减去，以防损害血脉。

在服药期间，如出现口苦尿黄、或大便溏薄泄利者，宜暂停药，按偏实偏虚辨证，改用汤剂调治，病情稳定，继续进药。

因于疟疾病久，形成疟母，脾大不甚者，亦可采用本方调治。用于治疗慢肝肝大而脾不大者，可减去三七一味，对恢复肝功、消除肝大亦有良效。

本方如制蜜丸，疗效欠佳。服药期间忌饮酒、忌辛辣食物。

余制本方治疗肝脾肿大，屡用屡效，凡脾大在3厘米以内者，坚持治疗，一般都能完全回缩。惟对巨脾的治

疗，尚有待进一步探索。（表34）

表34 肝脾积聚病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
并发于慢肝或慢性血吸虫病。肝气郁滞，疏泄失常，脾气难伸，中焦痞塞，初为气滞络瘀，久则肝病及脾，瘀血停聚，结为痞块	偏实	舒肝理脾 行气通瘀	茵陈枳术汤 加味
	偏虚	益气健脾 行气通瘀	黄芪枳术汤 加味
	平时调治	舒肝理脾 通瘀消积	消痞散

第四节 鼓 胀

鼓胀以单腹胀大，其状如鼓，腹筋怒起为主证。一称单腹胀，或称蛊胀。

张景岳说：“单腹胀者，名为鼓胀，以外虽坚满而中空无物，其象如鼓，故名鼓胀。又或以血气积聚，不可解散，其毒如蛊，亦名蛊胀。且四肢无恙；胀惟在腹，故又名为单腹胀。”此外，历代医籍中所称石水、水蛊、蜘蛛蛊、水臌、膨脝等病名，其实同属鼓胀一病。

本病常为肝脾积聚的继发证候，因于经络瘀涩，迁延日久，水气瘀阻，停聚大腹，发生鼓胀。鼓胀与水肿不同，水肿先见头面四肢浮肿渐及全身而现腹胀；鼓胀为单腹胀大，四肢不肿，日久或兼下肢肿胀。本篇专论鼓胀，另篇专论水肿。

一、病因病机

慢肝迁延，久患血吸虫病，是形成肝脾积聚的主要因素，而积聚日久则是发生鼓胀的主要病根。所以，《医门法律》指出：“凡有癥瘕、积聚、痞块，即是胀病之根，日积月累，腹大如箕如瓮，是名单腹胀。”关于肝脾积聚发展为鼓胀的病机，概要言之，一因于瘀，一因于虚。瘀指肝脾血瘀，经络痞涩；虚指脾胃损伤，气血亏虚。

（一）肝脾血瘀

肝脾受病，始为气滞络瘀，继则瘀血停聚，形成积块，两胁痞胀，扪之有形。迁延日久，气结日深，血瘀益甚，气血瘀阻，经络痞涩，从而隧道不通，水随瘀蓄。于是水、气、血交相瘀积，停聚大腹，日渐胀大，发生鼓胀。由于腹水停聚的主因在于肝脾瘀积，《巢氏病源》称为“水臌”。如说：“水臌者，由经络痞涩，水气停聚，在于腹内，大小肠不利所为也。其病腹内有结块鞣强，在两胁间膨膨胀满，……所以谓之水臌。”这是因瘀成胀的一面。

（二）脾胃损伤

肝木有疏泄脾土的职责，中焦脾胃受其助益，才能发挥输布精微、生化气血、升清降浊等功能。肝脾受病，气机郁滞，疏泄失常，脾气不伸，久则脾运损伤，精血亏虚。由此发展，一以精血不足，不能腠养肢体，必致形体日渐消瘦，肌肤萎黄不泽。一以脾气郁滞，中焦痞塞，水谷精微不得输布于外奉养身形，浊阴水湿不得转输于下排泄体外，于是清浊相混，壅聚大腹，发生鼓胀。正因脾胃

损伤是形成鼓胀的又一主要因素,所以,《素问·五藏生成篇》说:“腹满臌胀,支鬲肱胁,下厥上冒,过在足太阴阳明。”这是因虚成胀的一面。

鼓胀病机就是在瘀、虚交并互为因果的演变中发展而成的。所以,本病的临床表现,常以虚实并见为特点,以气结、血瘀、水聚为特征。如果病延稍久,肝脾日虚,瘀聚益甚,精血不得下归于肾,肾失资源,肾脏亦虚。肾虚则膀胱气化不行,水浊血瘀壅聚更甚,于是虚者愈虚,实者愈实,以致瘀水难消陷于不治。

二、辨证施治

鼓胀的临床表现,初起腹胀不甚,按之柔软,渐次腹胀增大,按之坚实,甚者腹部青筋怒现,脐心突起,形体消瘦,面色苍黄,或见双目发黄,面颈胸部出现红缕血痣,饮食减少,食后脘腹痞胀,胁下胀痛,大便不爽,或秘或溏,小便短少,可见齿衄、鼻衄、或呕血、便血,甚或神识昏迷。这些证候往往随病情久、暂和体质强、弱而有不同表现。一般说来,鼓胀初起,积块未坚,脾虚未甚,其证偏实;鼓胀已久,积块坚固,脾虚已甚,其证偏虚。其治疗大法,宜于攻补兼施,一则化瘀通络以治其本,一则扶脾行水以治其标,总以攻实当顾虚,补虚勿碍实为原则。现分偏实偏虚论治如下:

(一) 偏实(肝脾郁滞,血瘀湿阻)

主证:鼓胀初起,形体未衰,腹胀不甚(腹围小于90厘米者),按之不坚,胁下胀满或疼痛,脘腹痞胀,食后

尤甚，大便不爽，小便短黄，舌质紫暗，舌苔厚腻，脉象弦滑。

证析：肝脾积块，气滞络瘀，久则瘀血内停，水随瘀阻，发生鼓胀。其病初起，形体未衰，故腹胀不甚，按之不坚。积块瘀聚，肝气不舒，故胁下胀满疼痛。脾运失常，腑气不降，故脘腹痞胀，大便不爽。气滞湿阻，水道不利，故小便短黄。舌紫苔腻，脉象弦滑，均为肝脾郁滞，血瘀水阻所致。

治法：舒肝理脾以治其本，通瘀消水以治其标。

主方：腹水初起，形体未衰，重在治标，用大腹皮饮①通瘀运脾，攻消腹水；水消大半，重在治本，用茵陈枳术汤②加猪苓、泽泻以舒肝运脾、消利水湿；腹水已退，重在化瘀消积，宜常服消痞散③调治，以防腹水再起。

（二）偏虚（肝脾亏损，血瘀水壅）

主证：鼓胀久延，腹大日增（腹围大于90厘米者），按之坚实，动摇有声，腹部青筋怒张，胁下胀痛，形体消瘦，肤色苍黄，脘腹痞满，食少便溏，小便短少，精神萎靡，身有血痣，唇色紫暗，舌现紫斑，脉象弦细或涩。

兼神倦气短，脘闷纳呆，大便溏泄，舌质淡，脉沉弱者，为脾气偏虚；再兼手足清冷，下肢肿胀，尿少尿频者，属脾肾阳虚。

兼虚烦心悸，口燥咽干，舌质红绛少津，脉弦细虚数者，为气阴亏虚；再兼下肢虚冷浮肿，小便频数短少，脉沉细者，属阴阳俱虚。

证析：鼓胀久延，肝脾亏损，由实转虚，血瘀水壅日渐增甚，形体日渐虚衰。腹大坚实，腹筋怒张，脘胁痞胀

疼痛，身现血痣，小便短少，均为血脉瘀结、气机阻滞、津水停聚不得下渗所致。荣血亏虚，肌肤失养，故形体消瘦，肤色苍黄。血虚神弱，故精神萎靡。脾虚胃弱，运化失司，故食少便溏。唇色紫暗，舌现紫斑，脉弦细或涩，皆为血虚络瘀病证。如脾虚累及于肾，或以脾气偏虚累及肾阳，或以荣阴偏亏累及肾阴，即可兼见脾肾阳虚、或阴阳两虚等证。凡此，皆属正虚瘀固的病证。

治法：益气养血以固其本，通瘀消水以治其标，虚实兼顾，攻补并行。

主方：通瘀运脾，消利腹水，用鳅鱼丹薤汤④。体气尚好，可任攻逐者，兼用大腹皮饮。体气已衰，脾气偏虚、或脾肾阳虚者，兼用春泽汤⑤加味；气阴偏亏、或阴阳两虚者，兼用参麦地黄汤⑥，腹水已消，宜常服消痞散化瘀消积，以巩固治疗效果。

总的来说，鼓胀以肝脾积聚为致病之本，以腹水停聚为致病之标，倘能早期治疗，精心调理，见效尚好。若医疗失时，腹水反复，往往正虚瘀固，预后不佳。每见病者苦于胀急，喜行攻利，以求暂时宽快，始行攻利，其胀可消，继则消后复胀，乃至腹胀如石，攻逐罔效。是以治鼓胀切勿急图速效，徒事攻逐，当以通瘀运脾、扶养气血为要法。攻消方药的运用，必须遵守水消大半而止的原则，防止戕害元气，演生恶变。

凡鼓胀久延，见腹大而脉浮无根，发热不休，或寒热如疟者，属真阴虚竭，孤阳无依；见腹大而呕血、便血，脉来时大时伏者，属血虚气脱；见腹大而四肢瘦削，大便滑泄不止者，属脾胃衰败；见腹大而喘急泄利，脉浮大或沉

伏者，属阴阳奔脱。凡此，均属危候。

本病在治疗中，须忌食盐味，因食盐有凝涩助水之弊，故《格致余论》有“却盐味以防助邪”之说。俟腹水消除，病情稳定，方可逐渐增加盐味食物。

三、方药化裁

1. 大腹皮饮

大腹皮15克 莪术15克 丹参20克 郁金20克 茵陈20克 白术15克 茯苓24克 瞿麦24克 枳实12克 橘皮10克 生姜皮3克

此方通瘀散积，运脾消水。适用于鼓胀初起，腹水较甚，形体未衰，其证偏实者。方以大腹皮下气宽中，利水消肿，作为主药。腹水之起，缘于血瘀，故用莪术、丹参、郁金活络散积，以通其瘀。欲通其瘀，当先理气，故用枳实、橘皮理气宽中，以行其滞。水气停聚，因于脾困，故用白术、茯苓、茵陈、瞿麦、生姜皮和中运脾，消利腹水。合而用之，共成通瘀散积、理气和中、运脾消水之功。

如腹胀为甚，大便涩滞不爽者，再加薤白12克，槟榔12克，其下气散结之力更强。如脘胁疼痛较甚，宜加白芍20克，延胡索12克，以缓急定痛。

2. 茵陈枳术汤

方药见本章传肝篇第五方。

本方加猪苓20克，泽泻20克，功能舒肝理脾，开郁散瘀，运脾利水。适用于鼓胀腹水不甚，或经攻利而水消大

半，无气阴偏虚证状者，颇为适宜。如腹胀较甚，加大腹皮10克，橘皮10克，以助理气宽中之力。如食欲不开者，加山楂15克，鸡内金6克，以加强开胃助食。

3. 消痞散

方药见本章积聚篇第三方。

凡治鼓胀，首宜消水以治标，水气消减则当消瘀以治本，否则腹水反复，久延难治。本方舒肝理脾，化瘀消积，于腹水消退后用此方常服调治，确具缓消肝脾积块之良功。

某医院一领导干部，年近六旬，患肝硬化腹水，经治疗腹水稍有消减，仍肝脾肿大（肝肋下1.5厘米，脾肋下3厘米），肝功检验一直异常。初诊：腹部胀大，两胁胀痛，大便不爽，小便短少。因初患腹水，形体尚未见衰，拟从实证论治，令服大腹皮饮4剂。二诊：水消大半，改用茵陈枳术汤加味，兼用消痞散（日服2次，每服5克），连服2周。三诊：腹水全消，食欲增加，令常服消痞散调治。经过治疗半年，病情稳定，脾肿消退，肝功复常，今已7年未见反复。由此可见，本病初起，治疗及时，是能够取得满意效果的。

4. 鳅鱼丹薤汤

鳅鱼150克（去净肠杂） 丹参30克 薤白30克 生姜3克

上药加水文火慢煨，煮汤去渣滤骨，分3~5次服，日尽1剂，连服3~5天，以腹水消及大半为度。

此方理气通瘀，滋阴行水。适用于鼓胀体虚，不耐攻逐方药者。方中鳅鱼滋阴养血，消利水气；丹参导达经

脉，活络通瘀；薤白温中通阳，理气行滞；生姜温胃和中，运行药力。合而用之，协奏通瘀运脾、消利腹水之功。

本方以缓消腹水见优，对气、阴偏亏者，仍当辅以益气运脾、或养阴行水方剂，其效始著。如方中鳅鱼难得，亦可用鲤鱼或鲫鱼代之。

5. 春泽汤（《医方集解》）

猪苓15克 泽泻15克 白术15克 茯苓24克 上桂3克 人参3克

此方益气健脾，温阳行水。适用于鼓胀虚证，脾虚气弱，神倦短气，脘闷纳呆，小便短少，舌苔白腻，脉象沉弱者。方以人参益气，上桂温阳，猪苓、白术、茯苓、泽泻健脾渗湿。共奏扶虚运脾、温阳行水之功。故用于鼓胀虚证消水期间见脾虚气弱者颇宜。

若见下肢肿胀，手足清冷，大便溏薄，脉象沉微者，属脾肾阳虚。方中宜加炮干姜3克，制附片15克，以温肾助阳，化气化水。

6. 参麦地黄汤

人参3克 麦门冬15克 五味子6克 熟地黄10克 丹皮10克 山药15克 茯苓15克 泽泻15克 山茱萸10克

此方益气生津，滋肾行水。适用于鼓胀虚证，气阴亏虚，神倦虚烦，口燥咽干，小便短少，舌红绛少津，脉弦细数者。方以人参、麦门冬、五味子益气生津；六味地黄滋肾行水。补中有泻，虚实兼顾，故用于鼓胀消水期间见气阴亏虚者颇宜。

若见鼻衄齿衄为瘀热伤络，宜加丹参15克，仙鹤草30

克，以化瘀止血。若见下肢虚冷浮肿，小便短频，舌淡红，苔白滑，脉沉弦细者，属阴阳两亏。方中宜酌加制附片、官桂、怀牛膝、车前仁等品，以滋肾温阳，化气行水。

凡鼓胀久延，每因瘀积深固，体气大虚，腹水反复，大多预后不良。余治某医院一职工，四十许人，素有慢肝史，肝体缩小，脾在肋下4厘米，近二年反复出现腹水2次。来诊时，腹大如箕，腹部脉络怒张，胸颈部现红缕血痣，脘胁痞胀，大便溏而不爽，尿短黄，舌黄腻，脉沉弦。观其神气尚好，暂从实证论治，拟与大腹皮饮服3剂。进药两天，大便水泄6次，腹水消及一半，表现腹胀神倦，脘闷纳少，舌转白淡微腻，此为脾虚气弱病征。另拟鳅鱼丹薤汤兼用春泽汤加砂仁、薏苡仁。服药4天，小便清利，口胃已开，腹中尚有小量积水，继用春泽汤去桂加丹参、郁金、砂仁、枳壳、鸡内金、三七粉等品，令连服2周。腹水消尽，食欲增加，二便调畅。停止汤剂与消痞散方，嘱其常服调治。患者服药3个月后，自以为病愈停药，经半年余，于一次饮酒后，暴起腹水，呕吐神昏，终于救治不及而致死亡。此病例说明，凡鼓胀久延，瘀积深固，如能坚持治疗，加意调护，犹可带病延年。反之，瘀积未除，病根犹在，稍有疏忽，终易反复。(表35)

表35

鼓胀病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
肝脾积聚迁延日久，一以瘀积日深，经络堵塞，水随瘀蓄；一以脾运亏损，精血不足，升降失常。瘀虚交并，清浊相混，壅聚大腹，发生鼓胀	偏实	舒肝理脾 通瘀消水	大腹皮饮 茵陈枳术汤 消痞散
	偏虚	益气养血 扶正消瘀	鳅鱼丹薤汤 春泽汤 参麦地黄汤

附：黄 汗

黄汗一病，首见《金匱要略》，是以汗出染衣，色如黄柏汁样为特征的一种病证。此与俗称油汗染衣不同，油汗染衣，其色轻微，勤换衣服，多不明显，属于生理现象，不可指为病态。

一、病因病机

引起黄汗发病的原因，或以汗出入水沐浴，或以居处环境潮湿，或以汗出冒雨等等，均可导致发病。水湿外侵，肌表受邪，阻遏卫阳，致使汗液留滞于肌表之间，不能宣达于体表之外，外湿与内湿交相阻郁，化而为热，热蒸液迫，出为黄汗。正如何梦瑶《医碥》所说：“水寒郁遏汗液于肌肉，为热所蒸而成黄汗。”由此说明，本病皆由湿热郁遏于肌表所致。

二、辨证施治

黄汗与黄疸、历节风、水肿等病均有相似证状，其鉴别要点如下：（表36）

黄汗的表现，汗出染衣，色黄如黄柏汁样，头面浮肿，肢体酸软重痛，不热不渴，舌苔薄腻，脉象沉缓者，属湿胜热微；伴身热口渴，小便黄而不利，舌苔黄腻，脉象弦滑者，属湿郁热胜。

表36

	鉴 别 要 点
黄 疸	黄疸双目肌肤发黄，黄汗仅见汗出黄染而无身目发黄
历 节 风	历节风关节红肿疼痛，其关节处可见汗出黄染，不似黄汗染衣遍及全身而无关节红肿
水 肿	水肿之肿，遍身浮肿，汗出而不染衣

治疗以扶正托邪、清热消黄为原则。外湿偏胜，重在疏表散湿；郁热偏胜，治宜表里分消。用黄芪己芩汤为主方，随其病情加减化裁。

三、方药化裁

黄芪己芩汤

黄芪30克 汉防己20克 秦 芩20克 茵陈20克 白芍15克 甘草6克 大枣12克 生姜3克

此方益气托邪，疏表散湿。适用于黄汗湿胜热微者。方中防己、秦芩能通利经脉，祛散肌表壅滞之湿；白芍、甘草、生姜、大枣和调荣卫，以助疏表散邪。佐茵陈以清化郁热；主黄芪鼓动卫气，祛散湿邪从外而解。

如见湿郁热胜者，去黄芪，加梔子10克，滑石18克，俾使郁湿遏热得以内外分消。

附：黄胖病

黄胖病即钩虫病的俗称，以肤色萎黄，头面浮肿，嗜食易饥，体倦无力为主证。有些地区又称为脱力黄、懒黄病、饕餮病、黄肿病。

本病作粪便检验发现钩虫卵即可确诊。确诊后应及时治疗，否则，对小儿可影响发育，对孕妇可引起流产或早产。

一、病因病机

本病较多见于丘陵地区，或种植棉、麻、蔬菜的区域。钩虫寄生于人体小肠内，虫卵随粪便排出，经过施肥混入泥土滋生幼虫。每因赤脚田间劳动，感染幼虫，侵入皮肤，聚于肠间，伤脾耗血，引起发病。

本病的演变经过，常以虫毒初犯，壅聚肌肤，化生毒热，发为皮疹；如果虫毒内窜，侵犯肺部，损伤肺络，即可出现咳喘痰血。此属钩虫侵入皮肤所引起的早期病变。病延日久，由于钩幼成虫聚集肠间，孳生繁衍，而致亏耗精血、损伤脾气，精血亏耗则荣运不充，肌肤失养；脾气损伤则运化无能，升降失司。于是虚黄嗜食，体倦无力，肢体浮肿，甚或腹大胫肿等证相继出现。由此可见，本病对人体健康的危害，是极为严重的。

二、辨证施治

表37 黄胖与黄疸、鼓胀的鉴别要点

	鉴别要点
黄 疸	黄疸之黄，黄如金色，目珠尽黄；黄胖之黄，萎黄如蜡，目珠不黄
鼓 胀	鼓胀为单腹胀大，四肢消瘦，腹部青筋怒张；黄胖为头面四肢浮肿，渐及腹部肿大，腹部无青筋显露

黄胖要区别前期、后期所出现的不同证候分别治疗。

(一) 前期证候

1. 皮肤毒疹

钩幼随粪毒侵入足趾足踝、或手指手腕皮肤，很快出现红色小疱疹，奇痒难忍，每因搔痒抓伤引起红肿疼痛，俗称粪毒。此属毒热壅聚肌肤所致。

治宜清热解毒，止痒杀虫。用蛇参椒矾洗剂①煎汤热敷或浸洗患处，既能止痒，又可杀虫。

2. 虫毒犯肺

继皮肤毒疹消失数天内，出现咳喘气急，咳痰带血，舌质红，脉象滑数者，此属虫毒内窜，侵犯肺部，损伤肺络，肺热气逆。

治宜清热宁肺，止血杀虫。用桑芩百部汤②连服3~5天，防其久延，损害肺气。

(二) 后期证候

1. 虚黄嗜食

表现面色萎黄，肤发不泽，嗜食易饥，体倦乏力，胸

脘痞闷，脐周隐隐作痛，或有恶心呕吐，或有喜食生米、茶叶、泥土等偏好，舌淡苔薄，脉多细弱。此因虫聚肠间损耗精血，造成胃强易饥、脾弱不运所致。

治疗以祛虫补虚为原则。趁脾胃尚未大衰，先以榧子槟榔汤^③和胃祛虫，以去致病之源；继用针砂丸^④健脾养血，调补其虚。

2. 血虚水肿

虚黄久延，渐次出现全身皮肤色如蜡黄，头面四肢浮肿，肤色干枯，身软无力，劳动则气短心悸，大便溏薄，有时泄利，甚而腹部肿大，唇舌淡白，脉沉细弱。此属脾气亏损、荣血虚少的表现。血虚则荣运不充，水液不行；脾虚则运化无能，升降失司。所以，水气泛溢，黄肿日甚。

治宜扶脾运湿，先治其标，用参苓白术散^⑤配合针砂丸，切忌发汗、逐水方药。防止愈虚其虚。俟水肿消退，神气恢复，再用榧子槟榔汤祛虫以治其本。

总之，治本病以祛虫扶虚为要法。体气未衰，胃气尚好，宜先祛虫而后补虚；体气已衰，胃气虽可，仍宜先补虚而后祛虫。尤对腹水重证，如妄施攻水峻剂，每多预后不良。

三、方药化裁

1. 蛇参椒矾洗剂

蛇床子30克 苦参60克 花椒3克 白矾30克 贯众30克 艾叶30克

上药煎汤作外用洗剂。

此方清热解毒，止痒杀虫。适用于成人、小儿一切风热、湿热皮疹及妇女外阴搔痒等证。

本方用治感染钩幼引起的粪毒皮疹，用小毛巾两块浸入药汤，趁热取出一块挤至半干，热敷皮疹部位（以不烫伤皮肤为原则），每半分钟掉换一次，连续热敷10分钟。如皮疹较多，不便热敷者，可将患手患足放进可以忍受的热汤中浸泡两秒钟取出，稍停再浸，反复热浸20分钟左右。如此热敷或热浸，即可达到止痒杀虫之效。

本方用治成人或小儿皮疹，可倍加剂量煎水洗澡，日洗一次，连洗数天，颇有良效。用治妇女外阴搔痒证，其效亦良（如外阴有抓伤现象，宜减去花椒，否则洗后有疼痛感）。

本方用治颜面湿疹，可将药汁浓缩成膏（湿疹破溃者，去花椒加乳香6克），另将白矾、花椒（或乳香）研极细，混入药膏调匀，涂搽患处，亦有良效。

2. 桑芩百部汤

桑白皮30克 黄芩20克 玄参15克 百部24克 贯众15克 甘草6克

此方清热宁肺，止血杀虫。适用于感染钩幼见咳喘痰血，舌质红，脉滑数者。方以桑白皮、玄参、黄芩清泻肺热，平定喘逆。百部、贯众与诸药合配，又能清热解毒，止咳杀虫。毒热消退，咳血自止。

如喘急为甚者，加葶苈、大枣；咳嗽痰稠者，加冬瓜仁、枇杷叶；咳血为甚者，加仙鹤草、白茅根。

3. 榧子槟榔汤

榧子60克 槟榔30克 贯众15克 南藿香10克

上药浓煎2次，早晚空胃各服一次，每次另用大蒜2~3瓣，去皮切成小粒，随药汤吞服，连服3天。

本方专用驱下钩虫。余曾用治10例钩虫病人，其中2例驱出钩虫。因病例少，疗效还不稳定，故录此以备进一步探索。

4. 针砂丸

针砂（即铁粉，用醋煮赤）250克 皂矾10克（用馒头包裹入火煨红） 白术60克 枳实30克 缩砂仁30克 鸡内金30克 大枣30枚

上药研为极细粉末，将大枣熬膏，入药为丸，每丸重3克，成人每服2丸，小儿每服一丸，日服2次，忌饮茶及生冷食物。

此方健脾养血。适用于血虚脾弱，面色萎黄，肤发干枯，肢体浮肿，大便溏薄，脉象细弱者。方以针砂、皂矾补养荣血；白术、枳实健脾理气；砂仁、鸡内金醒胃化食。合而用之，健脾养血，故用治黄胖病血虚脾弱者颇宜。

5. 参苓白术散（《和剂局方》）

太子参30克 白术15克 茯苓24克 山药15克 白扁豆15克 莲子肉15克 桔梗10克 薏苡仁15克 砂仁6克 甘草6克 大枣4枚

此方益气健脾，和中渗湿。适用于脾虚胃弱，肢体浮肿，大便溏薄，脉沉细弱者。黄胖之肿，因于血虚脾弱，是方益气健脾，补其虚而渗其湿，脾旺则能运湿，湿去则水肿自消。

如气虚为甚者，加黄芪；水肿为甚者，加猪苓、泽泻，以助消水之力。（表38）

表38

黄胖病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
接触钩虫幼虫侵入皮肤，初犯虫毒，发为皮疹；虫毒犯肺，咳喘痰血。久之，虫聚肠间，伤脾耗血，发生虚黄嗜食、血虚水肿	皮肤毒疹	清热解毒 止痒杀虫	蛇参椒矾洗剂
	虫毒犯肺	清热宁肺 止血杀虫	桑芩百部汤
	虚黄嗜食	祛虫补虚	榧子槟榔汤 针砂丸
	血虚水肿	健脾渗湿 和胃养血	参苓白术散 针砂丸

结 语

本章运用中医脏腑病机学说和辨证施治法则并结合临床经验，以肝脾疾病为中心，以感染传肝病毒（或感染血吸虫卵）为主因，从所引起肝脾肿大、肝硬化腹水病机演变的各个阶段，分别于传染性肝炎、肝脾积聚、鼓胀等病种中，较系统地对病因病机、辨证治疗作出详细论述。实践证明，运用中医理法方药治疗急慢性肝炎，除出现巨脾难以全消外，一般都能达到治愈的目的。对肝硬化腹水的早期治疗，也能取得满意效果。惟血吸虫病的杀虫疗法，尚须从实践中进一步探索。

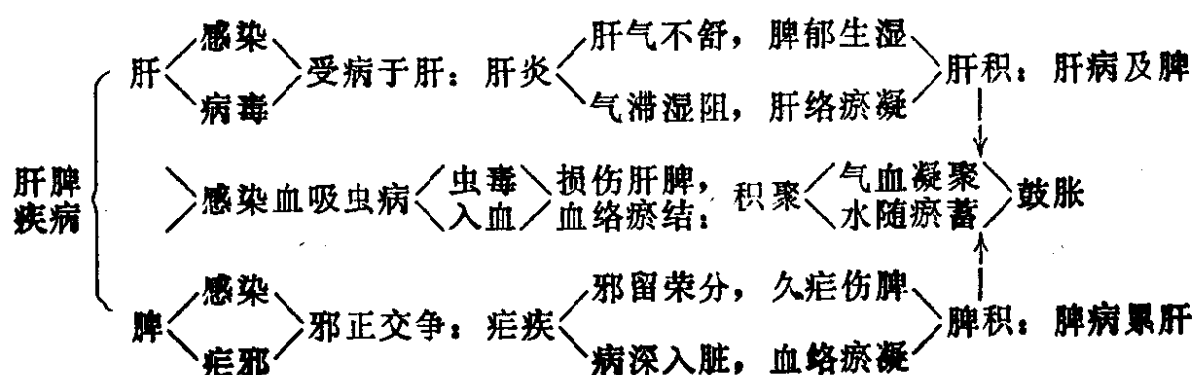
疟母（脾肿大）一证，据临床所见，常有伴随终身而无恶变的，也有久延累肝而致肝脾同瘀的。对此，除防止疟疾反复发病外，大体与肝脾积聚治疗相同。

黄汗一证，属于一时性湿热郁滞肌表所引起。本病不但要同黄疸鉴别，更不可与一般“油汗染衣”者相混淆。

油汗属于生理现象,不可误为病态。

黄胖属钩虫病慢性病证。皆由血虚脾弱所致。本病进入晚期往往因严重水肿而继发腹水。对此,不仅要与鼓胀病之单腹胀大严格区别。且在治法上亦各不相同。鼓胀之腹水,其证偏实,可任攻逐;黄胖之腹水,纯属虚证,切忌攻消,否则反致恶变。(表39)

表39 肝脾疾病病机简表



1900

1901

1902

1903

1904

1905

第六章

脾肾疾病

水肿、消渴、淋证、癃闭、尿频不禁等疾病，皆属人体水液代谢功能失常所引起的一类病变。

肺居上焦，肺气宣畅，外而宣发津液出于肌表为汗，内而通调水道下输膀胱为溺。脾胃并居中焦，脾能助胃输津上归于肺，又能泌别津液下输于肾。肾合膀胱居于下焦，决瀆水道，主司小便。因此，凡肺、脾、肾、三焦气道输布津液功能失调，便可引起体内水液代谢紊乱而致发生上述种种病变。

又因脾主湿，肾为主水之脏，导致人体水液代谢紊乱虽有外因、内因的不同，但大多以内因为主而与脾肾关系最为密切，故并为脾肾疾病一章讨论。

第一节 水 肿

凡头面、眼睑、四肢、腹部、甚则全身表现浮肿者，称为水肿。《内经》称为水病；《金匱要略》称为水气病。

导致水肿的病因病机及所表现的证候是比较广泛的。如《内经》根据病因和证候分为风水、石水、涌水。《金匱要略》从病因脉证分为风水、皮水、正水、石水；又按五脏病机分为心水、肝水、肺水、脾水、肾水。本篇以虚实为纲，将水肿概括为实肿、虚肿两大类，并在此基础上按不同病因证候分别辨证施治。

一、病因病机

人体水液的运行，依赖于气血，气血的强弱，依赖于脏气。如果脏气不足，或因外邪所犯，或因思虑劳倦，或因饮食失调，或因脏腑自病，都能造成水液运行失调的病变。所以，水肿发病，虽有外因、内因的不同，实则脏气先衰是其致病的主要根源。

风邪外袭，阻遏肺气。肺主气，外合皮毛，如肺气不足，复为风邪所阻，肺气失宣，外不能宣达津液出于肌表，内不能通调水道下输膀胱，风遏水阻，泛滥肌肤，发为水肿。

居处卑湿，或冒雨涉水，水湿外侵，肌表受邪。如脾气素虚，内蕴水湿，内外相因，脾为湿困，水气不得外输

下渗，流溢肌肤，致成水肿。

外受湿邪，内蕴水湿，如湿郁化热，湿热交蒸，壅阻中焦，升降失常，水湿不得下行，水热互结，亦可成肿。

或以劳倦过度，或以饮食不调。伤于脾气，脾气亏损，运化失常。脾主健运，具有助胃输精、运行津液、上归于肺、下渗膀胱的职能。脾气虚亏，水液不得充分输布，停聚不行，泛滥横溢，遂成水肿。

肾气内伤，开阖不利。或以脾虚日久，累及于肾；或以风水失治，移热下焦。肾为水火之脏，肺肾精气相通，风水失治，移热下焦，积热伤阴，水热互结，水为热阻不得畅利，则留聚三焦随气上下，泛逆于上则面肿，流注于下则足肿。肾中命火有温生脾土的本能，脾有分别清浊渗利水湿转输于肾的职责。脾虚日久，累及于肾，肾阳内虚，膀胱气化不行，水液内聚，泛滥横溢，致成水肿。

由此可见，导致水肿发病，有内因也有外因，外感风邪与感受水湿之肿，是致病之标，内因脏气之虚，乃为致病之本。《医宗金鉴》指出：“风水得之，内有水气，外感风邪；皮水得之，内有水气，皮受湿邪。”而体内水气的产生，则与肺脾肾三脏的关系最为密切。正如张景岳所说：“凡水肿等证，乃肺脾肾三脏相干之病。盖水为至阴，故其本在肾；水化于气，故其标在肺；水惟畏土，故其制在脾。今肺虚则气不化精而化水，脾虚则土不制水而反克，肾虚则水无所主而妄行。水不归经，则逆而上泛，故传入于脾而肌肤浮肿，传入于肺则气息喘急。虽分而言之，三脏各有所主，然合而言之，则总由阴胜之害，而病本皆归于肾。”由此更可说明，内因之虚，又当以肾气不

足为致病之根。

二、辨证施治

水肿发病,大都眼睑先肿,继则延及头面四肢,也有下肢先肿,然后遍及全身的。本病在临床上首先区辨实证和虚证。凡病起急骤,兼见表邪而有热象者,多实;病来徐缓,不兼表邪而有寒象者,多虚。形色鲜明,气息粗长者,多实;形容憔悴,肤色晦暗,气息短促者,多虚。年青少壮,形体素强者,多实;中年积劳,神疲气弱者,多虚。小便黄赤,大便秘涩者,多实;小便清白,大便溏薄者,多虚。脉象弦滑有力者,多实;脉象沉缓细弱者,多虚。如实证久延,正气渐衰,水肿日盛,此属由实转虚;虚证失治,水肿增剧,则属本虚标实。在治疗上,根据肿病属虚属实,采取发汗、利尿、逐水、健脾运湿、温肾行水等不同治法。这些法则的运用,又当依据病情的轻重缓急,或一法单行,或数法兼施,或先治其标,或标本同治。现分实肿虚肿论治如下:

(一) 实肿

1. 风水泛滥

主证: 来势迅速,初起眼睑头面先肿,继则遍及四肢全身,伴有发热恶风,肢体酸疼,小便不利等证。

见发热无汗,烦渴喘咳,咽喉肿痛,舌质红,苔薄黄,小便黄赤,脉象浮数者,为风热偏盛,属于表实。

见无热恶风,出汗,口不渴,浮肿身重,无咳喘咽痛,舌苔白滑,脉象浮紧者,为风水偏盛,属于表虚。

证析：外风内水，阻遏肌表，泛溢成肿。风为阳邪，故来势迅速，先肿头面。风遏水阻，荣卫不和，故恶风发热，肢体酸疼。水液不得下输，膀胱气化失常，故小便不利。若为风热交蒸，邪阻于外则表实无汗，热蒸于内则发热烦渴，肺为热迫则喘咳咽痛。尿黄赤，舌红苔黄，脉浮数，均为风热偏盛病证。若为表卫气虚，风水独盛，则见汗出恶风，浮肿身重，而无烦渴、发热、喘咳、咽痛证象。舌白滑，脉浮紧，为风水无热表现。

治法：疏风行水。

主方：表实无汗，风热交蒸，宜祛风清热，发汗退肿，用越婢加术汤^①加味；表虚无热，风水独盛，宜益气托邪，祛散水湿，用防己黄芪汤^②加味。

2. 水湿外侵

主证：头面肢体浮肿，按之凹陷没指，身重困倦，小便短少，舌苔白滑厚腻。

见头面肿甚，肢体酸重而喘，舌苔白滑，脉象浮紧者，属外湿偏盛。

见下肢肿甚，脘腹痞闷，舌苔厚腻，脉象沉缓者，属内湿偏盛。

本病以浮肿而无恶风发热、口渴咽痛等证，可与风水鉴别。

证析：水湿之邪，外侵肌表，脾气素亏，内有水气，内外相因，水湿壅阻于肌肤，故头面肢体浮肿；水湿内聚于三焦，故小便短少不利。内外交困，水无出路，故肿势较甚而按之凹陷。湿为阴邪，故不表现恶风发热、口渴咽痛等证。身重困倦，舌苔白滑厚腻，均为水湿内聚，脾阳

不运病证。若表湿偏盛，壅阻卫阳，肺气失宣，则见头面肿甚，肢体酸重而喘，苔白滑，脉浮紧等证。若内湿偏盛，困阻脾阳，水无出路，则见下肢肿甚，脘腹痞闷，苔厚腻，脉沉缓等证。

治法：通阳行水。

主方：外湿偏盛，宜益气通阳，祛散水湿，用防己茯苓汤^③加味；内湿偏盛，宜温通脾阳，化气行水，用五苓散^④加味。

3. 湿热壅阻

主证：遍身浮肿，肤色光泽，胸腹痞闷，心中烦热，小便短赤，大便不爽，或大便秘结，舌苔黄腻，脉滑数或沉数。

本病与风热水肿不同，风热之肿，偏于在表，表现恶风发热、口渴咽痛；湿热之肿，偏于在里，表现胸腹痞闷，二便赤涩。据此可作鉴别。

证析：外有湿邪，内有水气，发生皮水。如湿郁化热，壅阻中焦，则成里实之证。湿热壅阻于外，故身肿而肤色光泽。湿热郁遏于内，故烦热而胸腹痞闷。二便赤涩，舌苔黄腻，脉滑数或沉数，皆为湿热壅阻于内，中焦升降失和的病证。

治法：表里分消，清利湿热。

主方：以苓泽己芩汤^⑤为主方。依据上下表里湿热偏盛不同情况，随证化裁。

实证水肿，原以内因脏气不足为致病之本，外感风、湿、热邪为致病之标。因此发汗、攻利诸方，仅为急则治标而立，实非治本之法。凡用发汗法，以表解则止，不可

过剂,防止伤津耗气,演生它变;攻利之法,当以运脾理气为先,攻消太过,亦易伤害脾气。如风水证,表邪已解,肺热已退,仍见浮肿持续,小便短黄者,多属热移下焦,由肺及肾,当从肾虚水肿论治。又如皮水一证,本为表里同病,如肺气已通,表湿已退,郁热已解,仍有体倦微肿见证者,可按脾虚水肿调治,进以健脾渗湿方药。

(二) 虚肿

1. 脾虚水聚

主证: 遍身浮肿,下肢肿甚,脘腹痞闷,食少便溏,面色萎黄,体倦乏力,小便短少,舌质淡,苔白滑,脉缓弱。

见肿势不甚,能食而大便溏薄,小便通利,舌苔薄腻,脉沉缓者,此为轻证,属于脾气不足、水气不化。

见肿势较甚,按之凹陷没指,手足清冷,大便溏泄,小便短频,舌质淡白,舌苔灰腻,脉沉缓弱者,此为重证,属于脾阳虚衰、水气内聚。

证析: 此证多见于中年积劳,脾气素亏,营养不足之人。脾阳不足,输化无能,水气内聚,泛滥下焦,故浮肿以身半以下为甚。中阳不振,运化失常,故脘腹痞闷,食少便溏。脾虚则血虚,不能荣泽肌体,故面色萎黄,体倦乏力。脾不输精,水液不行,故小便短少。舌质淡,苔白滑,脉缓弱,是脾气不足、水气不化之证。其证轻者,肿势亦轻,胃气尚好,故能食;脾虚不运,故便溏;小便反多,是脾虚而水液偏渗于下之象。苔薄腻,脉沉缓,为脾气不足、水气不化病证。气虚甚者,便是阳虚,阳虚水聚,故肿势更甚。阳虚不能温达四肢,故手足清冷。中焦虚寒,

故大便溏泄。小便短频，是水困下焦不得畅行之象。舌淡白，苔灰腻，脉沉缓弱，皆为阳虚水聚已甚的病证。

治法：温阳健脾，运化水湿。

主方：以参苓白术散^⑥为基本方。本方补气健脾，运化水湿，用于脾虚水肿轻证甚宜。若脾阳已虚，肿势颇甚，则当加入温阳暖中、化气行水之品。脾阳振作，水运复常，小便通利，肿势自消。水肿消退，又当继以培健脾胃治法，以巩固治疗效果。

2. 肾虚水泛

区别阴虚、阳虚、阴阳俱虚辨证施治。

(1) 肾阴虚亏，水热互结

主证：晨起头面浮肿，入暮双足肿甚，小便短黄，或尿色混浊，腰部胀痛，面色苍白，舌质淡红，脉象细数。

见头目昏胀眩晕，脉弦细或弦大者，属肝风内动。

见尿急尿频，尿中带血者，属积热内盛、伤及阴络。

本病见尿急尿血与血淋不同，血淋来势急骤，尿时疼痛淋涩难通，可见脓尿；本病来势较缓，一般无尿痛脓尿。据此可作鉴别。

证析：本病较多见于青壮年人，每因风水肿或湿热水肿移热下焦而发病。肾为藏精主水之脏，热在下焦，损及肾阴，水热互结，则阴虚与水肿并见，水为热阻，留聚三焦，随气上下，故晨起则面肿，入暮则足肿。水热瘀郁，肾气不行，故腰痛而小便短黄，甚则尿色混浊。瘀热稽留，暗耗精血，故面色苍白。舌淡红，脉细数，是阴虚内热病象。如肾阴偏亏，肝木失涵，风阳内动，则见头目眩晕；如积热内盛，损及阴络，则见尿急尿频，尿中带血，

甚或出现血尿。

治法：滋肾行水，清化积热。

主方：以知柏地黄汤⑦为基本方。依据阴虚、积热及水肿、尿血、肝风内动等轻重缓急情况，而与消利水气、凉血止血、平息肝风药品出入化裁。总以利水而不害阴，清热而不伤肾为原则。

（2）肾阳虚弱，水气不化

主证：头面浮肿，腰以下肿甚，按之凹陷不起，腰酸重痛，下阴冷湿，小便短少，畏寒肢冷，面色暗淡，舌淡苔白，脉沉尺弱。

见脘闷呕恶，腹中冷痛，大便溏泄者，属脾肾阳虚、中阳虚寒。

见喘急心悸，不得平卧者，属水气上逆、侮犯心肺。

证析：肾合三焦膀胱，决渎水道，主司小便。肾阳虚衰，膀胱气化不行，水聚下焦，故其肿腰以下肿甚。腰为肾之府，水寒内盛，壅滞于下，故腰酸重痛，下阴冷湿。膀胱水气不利，故小便短少。肾阳不足，命门火衰，不能温养肢体，故面色暗淡，畏寒肢冷。舌淡苔白，脉沉尺弱，均为阳虚阴盛病证。如虚寒太甚，肾中命火不能上达心肺，脾运失职，中焦虚寒，则见脘闷呕恶，腹中冷痛，甚则大便泄利；心阳不足，水气上犯，则见喘急心悸，甚则不得平卧。

治法：温肾助阳，化气行水。

主方：以真武汤⑧为主方。本方温肾行水，使肾阳振作，小便得利，其肿自消。如虚寒太甚，根据心、脾亏虚不同情况，又当佐以暖脾温中、平喘止悸之药。

(3) 阴阳两虚,水气停聚

主证: 头面下肢浮肿,反复发作,时轻时重,精神倦怠,头晕耳鸣,腰酸胀痛,齿龈出血,舌淡红,苔薄腻,脉沉细或数。

证析: 阴虚日久,损及肾阳,形成阴阳两虚。阳虚则水气内聚而泛滥成肿,阴虚则虚阳上扰而见齿龈出血、头晕耳鸣。腰酸胀痛,舌淡红,苔薄腻,脉沉细数,均为阴阳两虚、水气停聚的病证。

治法: 补肾养阴,温阳行水。

主方: 用济生肾气丸^⑨为主方,调补阴阳以去水邪。俟水肿消退,根据病情以本方增减调治,防止肿势反复。

虚证水肿,本缘脏气亏虚,尤多因于脾肾之不足。在治疗上当以健脾运湿、温肾行水为基本法则,切勿着眼于肿单行分利攻消,恐致愈虚其虚,肿势愈甚。张景岳说:“治水肿者必先治水,治水者必先治气,若气不能化,则水必不利。”义即指此。

凡水肿病宜禁食盐味,必须在水肿消退稳定之后,方可进以少量盐味食物,以防肿势反复。

凡水肿久延不愈,如见唇黑齿焦,掌肿无纹,足肿平满,背平脐突,或肿势屡次反复,出现喘急不得平卧,呕吐不食,泄利不止者,均属阴阳衰竭、脏气崩败的危候。

三、方药化裁

1. 越婢加术汤 (《金匱要略》)

麻黄10克 生石膏30克 生姜6克 甘草6克 大枣

15克 白术10克

此方散表退肿,清热和脾,适用于风水表实,恶风发热,无汗烦渴者。方以麻黄、生姜散表祛邪,以通肺气;石膏甘寒清热,以解烦渴;白术健脾利湿,以行水气;甘草、大枣调和诸药,以养胃气。风热解,肺气通,水湿去而肿自消。

如见咳喘气急,为风热壅肺,加桑白皮、杏仁、黄芩,以清热泻肺,平喘降逆。如见咽喉肿痛者,加板蓝根、玄参、射干,以清热利咽。

2. 防己黄芪汤 (《金匮要略》)

汉防己24克 黄芪30克 白术15克 甘草6克 大枣15克 生姜6克

此方益气托邪,健脾祛湿。适用于风水表虚,汗出恶风,身肿无热者。方中防己祛风利水,与黄芪配合,则能益气托邪。配以生姜、大枣更能调和荣卫,祛散在外之湿。防己配以白术、甘草又能培土胜湿,消利在内之湿。表气得通,水湿得下,则风水自退。

如见肢体酸重疼痛者,加秦艽、白芍,以助祛散风湿、和荣止痛之力。如见小便短少不利者,加茯苓、泽泻,以加强运脾利湿之功。

3. 防己茯苓汤 (《金匮要略》)

汉防己24克 黄芪24克 桂枝10克 茯苓24克 甘草6克

此方益气通阳,祛散皮水。适用于皮水身肿,头面肿甚,肢体酸重,苔白滑,脉浮紧,外湿偏盛者。方中防己、黄芪、桂枝同用,重在扶补卫气,温通卫阳,祛散皮水;

而防己、桂枝、茯苓、甘草相配，又能和中运湿，消利水气。卫气振作，内外通利，则湿退肿消。

如兼无汗而喘者，加麻黄、杏仁，以宣通肺气，平喘降逆。

4. 五苓散（《伤寒论》）

猪苓15克 泽泻15克 白术15克 茯苓24克 桂枝10克

此方通阳运脾，化气行水。适用于皮水身肿，外有湿邪，内有蓄水，下肢肿甚，小便不利者。方中桂枝温阳走表，祛散肌表之湿；桂枝与白术、泽泻、猪苓、茯苓合配，又能温脾运湿，畅利水道。合而用之，协奏化气行水之功。

兼脘腹痞闷者，属脾为湿困，可酌加大腹皮、厚朴、橘皮、生姜皮等品，以加强理气运湿力量。

5. 苓泽己芩汤

汉防己20克 秦艽15克 大腹皮10克 枳实10克
茯苓24克 木通20克 泽泻20克 连翘20克 滑石15克

此方疏通表里，清利湿热。适用于皮水身肿，郁而化热，壅阻中焦，心中烦热，胸腹痞闷，二便赤涩者。方中防己、秦艽疏风透表，祛散在表之湿。茯苓、木通、泽泻疏利水道，使在里之湿从小便消利。佐大腹皮、枳实宽中导滞，以通脾气；连翘、滑石凉解郁热，以清水道。郁热解，表里通，则水湿之邪得从上下分消。

如见腹中胀满，大便秘结者，为热结肠间，可加丑牛、生大黄以助攻利之力。但当得泄则止，不可过攻，以防伤害脾气。

如见喘满气急，不得平卧者，此为水热迫肺，加桑白

皮、葶苈子，以泻肺降逆。

6. 参苓白术散

方药见第五章黄胖篇第五方。

本方健脾醒胃，运化水湿。适用于脾虚浮肿，肿势不甚，脘闷便溏，气虚脉缓者。如脾阳已虚，中焦虚寒，肿甚而肢冷溏泄者，当于方中加入制附片、炮干姜以振复脾阳，运化水湿。

7. 知柏地黄汤

方药见第四章阳痿篇第五方。

本方滋肾养阴，清热利湿。适用于阴虚水肿，下焦积热者。是方以知母、黄柏清化下焦积热；以六味地黄滋肾养阴，渗利水湿。如浮肿为甚，小便短少混浊者，宜加重茯苓、泽泻剂量，并酌加车前仁、益母草，其消水退肿之效更佳。如尿中带血甚者，加地榆、白茅根，以凉血止血。如肝风内动，头目昏胀眩晕，颜面冲热者，加钩藤、石决明、夏枯草，以清降肝火，平镇肝风。

8. 真武汤（《伤寒论》）

制附片15克 白术15克 茯苓24克 白芍15克 生姜6克

此方温肾健脾，化气行水。适用于肾阳虚弱，水气内停，肢体浮肿，下肢肿甚，腰酸重痛，畏寒肢冷，苔白不渴，脉沉尺弱者。方以附子温肾助阳；茯苓、白术健脾利水；生姜温中散寒。附子与白芍同用，使之敛阴和阳。共奏温肾散寒、健脾行水之功。

见脘闷呕恶，腹中冷痛，大便溏泄者，属脾肾阳虚，中焦虚寒，方中宜减去白芍，加入人参、炮干姜二味，更

能健脾益气、温中止泄。

见喘息心悸，不得平卧者，属水气上逆、心虚气弱，加半夏、五味子、人参，以平喘降逆，宁心止悸。

9. 济生肾气丸（《济生方》）

熟地黄15克 丹皮10克 山药15克 茯苓15克 泽泻15克 山萸10克 制附片15克 官桂6克 怀牛膝15克 车前仁15克

此方作煎剂，滋肾养阴，温阳行水。适用于阴阳两虚，水气内停，腰重足肿，小便不利者。方以六味地黄滋补肾阴；官桂、附片温补肾阳；佐以怀牛膝、车前仁，则补肾行水之力更佳。故用治阴阳两虚而致水肿者颇宜。

如小便得利，水肿消退，去官桂、附片，以防过用害阴。如欲巩固疗效，防其反复，可加杜仲、巴戟、枸杞一类补益肝肾之品，以调理善后。（表40）

表40

水肿病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
实 肿	外感风邪，内有水气，风遏水阻，肺气失宣；湿邪外侵，内蕴水湿，内外相因，脾为湿困；外有湿邪，内有水气，郁而化热，水热互结	风 水	疏风清热 益气散湿	越婢加术汤 防己黄芪汤
		皮 水	通阳行水	防己茯苓汤 五苓散
		湿 热	表里分消 清利湿热	苓泽己朮汤
虚 肿	脾虚不运，水液停聚，泛滥横溢。 肾气内虚，水气不行，停聚三焦，随气泛逆	脾 虚	健脾运湿	参苓白术散
		肾 虚	养阴清热 温肾行水 滋肾温阳	知柏地黄汤 真武汤 济生肾气丸

第二节 消 渴 病

消渴病即糖尿病。其病以渴而多饮，善饥多食而日渐消瘦，尿多而有甜味为特征。此与一般热病表现渴欲思饮的消渴证是迥然不同的。

唐代医籍对消渴病论述甚详。如《外台秘要》引《古今录验》说：“消渴有三：一、渴而饮水多，小便数，无脂（应作‘有脂’）似麸片甜者，皆是消渴病也；二、吃食多，不甚渴，小便少，似有油而数者，此是消中病也；三、渴饮水不能多，但腿肿脚先瘦小，阴痿弱，数小便者，此是肾消病也。”由此可见，古代医家对本病的临床表现已有颇为细致的观察。本篇即以消渴病多饮、多食、多尿为辨证中心作出论述。

一、病因病机

刘完素《三消论》：“消渴者，本因饮食服饵失宜，肠胃干涸而气液不得宣平，或耗乱精神过违其度，或因大病阴气损而血液衰虚，阳气悍而燥热郁甚之所成也。”据此可知，消渴发病的原因，大体以平素饮食失宜为主因，也有因于耗乱精神或病后伤阴而发病的。导致的病机，大要言之，以脾阴亏损为致病之根，以燥热内盛为致病之标。初起肺胃津亏，燥热内盛；久则精气亏损，肺肾同虚。

脾阴亏损，肺胃津亏。脾能转输胃中水谷精微，上归于肺，下藏于肾，宣达于脏腑经脉肌肤毛发，化而为津液，

化而为脂膏，化而为血肉，化而为精髓，化而为涕、唾、汗、泪、尿液等等。如平素酷嗜肥甘醇酒厚味，蓄积生热，损害脾阴；或因情志过伤，动火伤阴，而致脾阴亏损。脾阴不足，不能输精于上，肺失资源，胃腑失养，一则肺燥津枯，口渴喜饮；一则胃气独亢，消谷善饥；一则脾失统摄，水谷精微随尿下趋。于是口渴多饮、善饥多食、多尿如脂等证相并出现。由此可见，消渴发病，主因是脾阴亏损，脾运失常，引起津液代谢功能紊乱而致表现以“三多”为主证、以阴亏燥热为特征的病变。阴亏是致病之本，燥热是致病之标，在病程演变中，阴亏与燥热互为因果，阴愈亏而热愈盛，热愈炽而阴愈亏。所以，本病常以能食而日渐消瘦为特征。

精气亏损，肺肾同虚。消渴日久，由于水谷精微偏注于下，随尿而出，久则气随精耗，脾气亦虚；又因小便频多，耗散肾气，而致肾气同虚。肺为气之主，肾为气之根，肾虚则肺气亦虚。脾虚则统摄无权，肾虚则封藏不固，肺虚则治节无力。于是饮一溲二，尿甜如膏，肌肤燥痒，短气乏力等证，相继而起。在病程经过中，因津精气血日渐亏损，尚能出现多方面的病机演变。津气不能荣润肌肤，则见皮肤搔痒，甚则蕴毒成脓，发生痈疖。肝肾精气不足，不能上承于耳目，或为重听耳聋，或为目眇雀盲。精气不能润养经脉，血肉虚惫，可致肢体麻木疼痛，甚或枯痿不仁。肺热津枯，肺气痿弱，还可并发肺痿。若阴损及阳，阴阳两虚，一则命火虚衰，阳事不举；一则肾气不固，饮少溲多；一则膀胱水气不化，泛溢成肿。凡此，均为精气亏损，下焦虚惫的病证。

综上所述，消渴一病，是以脾阴亏损为主因。其证候表现有口渴多饮为上消，消谷善饥为中消，尿甜如脂为下消的区分。若从病机演变来看，实可区别为前后两个病期：前期阶段表现为肺胃津枯，燥热偏盛，以口渴多饮，消谷善饥为主证，其证偏实；后期阶段表现为精气亏耗，肺肾同虚，以饮少溲多，尿甜如脂为主证，其证偏虚。在由实转虚、从阴亏进入精气亏虚的病程中，常以皮肤瘙痒易生痈疔的体征最早出现。所以，临床上必须把握病机，及时防治，以免病势继续恶变。

二、辨证施治

消渴一病，中年人居多，男多于女，尤多见于形体特别肥胖、或特别消瘦之人，青壮年患者则偶有所见。本病以饮水多、吃食多、小便多为主证，起病重者，来势骤急，三多并见，起病轻者，来势缓慢，证状亦较轻微。也有仅见一多而其他证状不甚明显的，尤以食欲增进而形体日趋消瘦常为消渴发病的主要病证。现据消渴病机特点，分肺胃津枯、肺肾同虚二类辨证，前者以阴亏胃燥为特征，属于前期病变，其证属实；后者以阴虚气弱为特征，属于后期病变，其证属虚。治本病以养阴益脾为基本法则，前期燥热为甚，宜清胃火，润肺阴，兼滋其肾；后期精气同虚，宜滋肾阴，补肺气，兼益其脾。分别论治如下：

（一）肺胃津亏，燥火内盛

主证：口干舌燥，烦渴多饮，善饥多食，小便频数量多，形体日渐消瘦，大便如常，或见干结，舌红少津，舌

苔薄黄或黄燥，脉滑实或洪数。

证析：脾不输津于肺，肺燥津枯，故烦渴引饮以自救。水不化津，直趋于下，故小便频数而量多。脾阴虚亏，胃燥独盛，水谷精微，随食随消，故善饥多食反而形体消瘦。燥火不甚，津未大伤，肠脏得润，则大便如常。反之，津亏肠燥，则见大便干结。舌红少津，舌苔薄黄或黄燥，脉滑实或洪数，均为燥热里实病证。

治法：清火益胃，润肺滋阴。

主方：用清胃汤①清火生津，以治其标；辅以补脾煎②保阴益脾，以治其本。视其燥热轻重，随证化裁。

本病之燥热，原为致病之标，切勿着眼于热而过用黄芩、黄连、石膏、大黄之品，以防伤折脾气，反致病情加速转虚。

（二）精气亏损，肺肾同虚

主证：小便频数，饮一溲一，尿甜如脂，形体消瘦，皮肤搔痒，或生小疖，困倦乏力，舌质淡红，脉沉细而数。

伴肢体微肿，气短心累，大便溏薄，脉象细弱者，属脾气偏虚。

伴尿频量多，饮一溲二，头面浮肿，下肢肿甚，面色苍白，耳轮干枯，阳痿不举，四肢清冷，舌淡苔白，脉沉细弱者，属脾虚及肾、阴阳两虚。

上证如兼见目眵、重听日益加重者，属肝肾精气亏虚不能上承耳目。

证析：消渴日久，水谷精微随尿消散，气随精耗而致精气同虚。脾虚则统摄无权，肾虚则封藏不固，肺虚则治节无力，故继肺胃津亏之后，即可逐渐出现饮一溲一、尿

甜如脂、困倦乏力、舌淡红、脉沉细而数等气阴同虚之证。水谷精微不能荣润肌肤，不仅形体日趋消瘦，且因皮肤枯燥发生搔痒，易生小疖，甚则蕴毒成痈。在病情发展中，如脾气偏虚，运化失职，水气停聚，则见大便溏薄，肢体浮肿；再兼饮一溲二，身肿而下肢肿甚，阳痿肢冷，则属脾虚及肾，阴阳两虚，水气泛滥。如病程中出现眼目昏瞶、听力减弱日益加重，则因精气亏损不能上承耳目所致。此外，如精气久亏，还可伴发肺痿、肺癆、肢体枯痿麻木等证。

治法：补气滋阴，益脾固肾。

主方：用黄芪杞子汤^③为主方，视脾、肾气、阴偏虚随证化裁。如阴阳两虚，水泛成肿，可先用肾气丸^④调补阴阳，消化水气。俟肾阳回复，水肿消退，再用黄芪杞子汤调补气阴。如见目瞶、重听，可兼服石斛夜光丸^⑤补益肝肾，滋阴明目。此外，如并发肺痿、肺癆、肢体痿弱等证，可参考有关各篇治法。

凡遇消渴久病，如见阴虚气弱证状之一者，切勿因有口渴而肆用石膏，因有便结而妄用芒硝、大黄。反之，伤害脾气，促使恶变。

根据临床所见，本病大多留连于精气亏虚阶段，一般不易根治，且常因饮食、精神失于节制，引起病情反复。正如《儒门事亲》所说：“不减滋味，不戒嗜欲，不节喜怒，病已而复作。”为此，必须告诫患者：（1）耐心治疗，不可轻易停药。（2）保持精神安静，避免过度烦劳，防止情绪过于激动。（3）必须节制饮食，每天食粮要低于病前食量，不可吃饱，也不可过饥，以食米类、豆类、

蔬菜、精肉、鸡蛋、牛乳等品为宜，禁忌辛辣厚味、酒、面、肥甘等类食品。实践证明，采取这些措施，对于本病确有治疗意义。

三、方药化裁

1. 清胃汤

黄连10克 知母24克 花粉24克 明沙参20克 天门冬15克 麦门冬15克 生地黄15克 生淮山药30克

此方清火益胃，养阴生津。适用于消渴初起，烦渴多饮，消谷善饥，大便如常，舌红苔少，脉象滑数者。方以黄连清泻胃火；以天门冬、麦门冬、知母、花粉、生地黄滋养肺肾，生津止渴；以山药补益脾胃。合而用之，清火不害胃，滋阴不滞脾。

如见烦渴特甚，为燥火偏亢，加生石膏、竹叶，以消折其势；消谷特甚，为胃火偏强，加黄芩，以清泻胃火。病势缓和者，去黄芩、黄连、石膏等品，防其伤脾害胃。

如见大便秘结难通，为津枯肠燥，加郁李仁、麻仁，以润肠通便。

2. 补脾煎

生猪胰（切碎）10克 天花粉（研细）10克 淮山药（研细）10克

上药混和，放入饭甑内蒸熟，作一日量，分2次，早晚空胃服。

《衷中参西录》有滋脾散一方，用生猪胰治消渴。张锡纯氏认为：脾为脾之副脏，即《难经·四十二难》所谓

“散膏”。消渴乃脾病累及于脾，猪胰即猪滕，故以动物之滕补人身之滕。余本其义，配以花粉生津，山药益脾，合为一方，用为治疗消渴常服方剂，在部分病员中颇具良效。

如一例50岁女性病员，初患糖尿病，其证三多并见，烦渴特甚。余先以清胃汤清泻肺胃燥火，病情缓解即进补滕煎常服调治。患者坚持服用10余年，病情稳定，未见反复，后因严重脑外伤而致病故。可见本方治消渴糖尿有一定效果。

3. 黄芪杞子汤

黄芪60克 明沙参24克 麦门冬24克 天门冬15克
淮山药24克 五味子10克 熟地黄15克 枸杞子10克

此方补气滋阴，益脾固肾。适用于消渴日久，阴亏气弱，饮少溲多，体瘦困倦，皮肤搔痒，舌淡红，脉沉细弱者。方用黄芪为主，配合山药，重在扶补脾气，振复输精达肺功能。用明沙参、天门冬、麦门冬、熟地黄生津益液，以滋补肺肾之阴。黄芪配合五味子、枸杞，则能敛肺固肾以还封藏之职。凡消渴日久，见上列证状之一者，便可进服本方。依据脾、肾气、阴亏虚轻重程度，随证化裁。

本方以黄芪为主药，其用量可随气虚轻重程度增减（其增减量为30~100克）。如身有痈疖，可加忍冬藤、蕺菜、蒲公英之属，以助解毒化痈力量。口渴为甚，加天花粉、知母清胃生津。小便频数量多，再加山萸肉、益智仁固敛肾气。烦躁不寐，加丹参、枣仁宁心安神。

如见肢体微肿，大便溏薄，小便短频者，此属脾虚不运，水气停聚，宜加白术、茯苓、薏苡仁、砂仁等品，培

健脾胃，运化水湿。

本病常以精气亏虚，持久留连，难予根治，但如坚持治疗，静心调理，颇能取得良好疗效。例如一中年男性病员，数月前因高烧病后继发糖尿病。由于来势骤急，病情甚重，表现消瘦无力，三多并见，烦渴特甚。余先以清胃汤清泻燥火，烦渴缓解，阴虚气弱证象毕露，续用黄芪杞子汤加减施治。经调治一月左右，证状减退，糖尿基本控制。令常服黄芪杞子汤，间日一剂，日服2次，体重增加，渐次康复。现已持续服本方10年，虽其病未能根治，亦未见并发其它疾病。足见，其疗效颇为理想。

4. 肾气丸(《金匱要略》)

方药见第四章心悸篇第五方。

本方补肾温阳，消利水气。适用于消渴日久，肾阳虚衰，伴发尿频浮肿，下肢肿甚，肢冷脉沉者。一般宜作汤剂，桂枝、附片量不宜过重，恐其温烈反害肾阴。

5. 石斛夜光丸(《原机启微》)

天门冬60克 人参60克 茯苓60克 麦门冬30克
熟地黄30克 生地黄30克 菟丝子24克 菊花24克 杏仁24克
草决明24克 山药24克 枸杞子24克 牛膝24克
五味子15克 蒺藜15克 石斛15克 肉苁蓉15克
川芎15克 甘草15克 枳壳15克 青箱子15克 防风15克
乌犀角15克 黄连15克 羚羊角15克

上药蜜制为丸(有成药)，每服6克，日服2~3次。

此方补益精气，清肝明目，以善治内障视物昏花见长。消渴日久，如出现目瞽或听力减退证状，可于治疗消渴同时兼服本方丸剂，一般能控制病情，以防成为雀盲。耳

之证。(表41)

表41

消渴病因病机证治简表

病,因 病 机	辨 证	治 则	方 药
因于脾阴亏损发病。津不上承则烦渴多饮,胃气独亢则消谷善饥,水谷精微随尿下趋则尿甜如脂。日久气随精耗,精气同虚,五脏齐损	肺胃津亏 燥火内盛	清火益胃 润燥滋阴	清胃汤 补脾煎
	精气亏损 肺肾同虚	补气滋阴 益脾固肾	黄芪杞子汤 金匱肾气丸 石斛夜光丸

第三节 淋 证

淋证以小便频急短涩,尿时淋涩刺痛,欲出未尽,是其主要特征。尿中夹有砂石者,名曰石淋(又称砂淋);血随尿出,尿色红赤者,名曰血淋(又称热淋);尿道中有脂液如膏,随尿溢出,小便混浊者,名曰膏淋。本篇即以石淋、血淋、膏淋三类病证作出论述。

一、病因病机

淋证发病,皆因下焦积热引起。肾合膀胱,并居下焦,一主储藏五脏六腑传来之津液,一主决渎水道,排泄小便。《诸病源候论》说:“诸淋者,由肾虚而膀胱热故也。”《证治准绳》说:“脾受积湿之气,小便黄赤,甚则淋。”《景岳全书》说:“或以败精,或以积血,阻塞水道而不通。”由此可见,肾虚积热,脾移热于肾,或尿道瘀积等因素,都是导致淋证发病的主要病机。

肾气不足之人，尿液不得充分排泄，日渐积久，聚湿生热。热煎尿液，渐结成石，或在于肾，或在膀胱，或在尿道，小者如砂，是为砂淋；大者如石，是为石淋。

饮食伤脾，蕴湿成热，湿热郁遏，移注于肾；或尿道感受污秽毒邪，酿成毒热，阻遏下焦。尿为热阻，则淋涩疼痛；热伤脉络，则尿中带血；甚者蕴毒成脓，脓血并见；因而导致血淋发病。

中老年人，肾气渐亏，气虚则血行不畅，日积月累，络瘀成积，阻碍尿路。水道瘀阻，尿液留滞，积久生热，阻遏下焦，瘀热相并，又能壅迫精室而致封藏不固。于是尿为瘀阻，淋涩难通；精为热迫，随尿而下；是以尿出如膏而成膏淋。

二、辨证施治

治淋证以宣通清利为基本法则。其病初起，实热居多，可清可利；病延日久，常多实中兼虚，则当虚实兼顾，随证施治。

（一）石淋

主证：小便黄热频数而痛，有时尿中夹有砂石，有时尿来中断，或突然阻塞，刺痛难忍，摇动体位又能继续排尿，时或腰腹间痛如刀刺，甚则尿中带血，舌脉如常，或脉见滑数。

证析：热煎尿液结成砂石，阻碍尿路，故见小便黄热频数而痛。砂粒较小，有时随尿而下，则见尿中夹有砂石。砂粒较大，阻塞尿路，则见尿来中断，或突然阻塞而刺痛。

难忍。如动摇体位使砂石改变位置，多可继续排尿而感轻快。若见腰腹间痛如刀刺，多系砂石移动，并可刺伤脉络而见尿中带血。由于砂石系渐积而成，有时内热之象并不明显，故舌脉如常，或脉见滑数。

治法：清利水道，消化结石。

主方：石淋发作，小便黄热疼痛，砂石有排出趋势者，用金苇汤①排石通淋；砂石已下，小便已通，可常服金鸡饮②消导余石。

本病常以结石部位不同、大小各异，不可完全采用排石治法。如肾中结石，或结石较多较大，难于随尿排出者，若用消利排石方药，反能加剧淋痛，甚而伤及血脉发生尿血。对此必须加以注意。

（二）血淋

主证：起病急骤，小便淋涩量少，尿频尿急，尿时热涩疼痛，欲出未尽，尿色暗红混浊，甚则出现血尿或脓尿，腰及小腹胀满而痛，或有恶寒发热，舌质红，苔薄黄，脉象滑数。

本病如缠绵日久，常因正气亏耗，邪毒留伏，成为慢性疾病。患者经常腰痛尿频，或尿来淋涩不畅，稍有不慎，或遇劳累，其病复发，伴精神困倦，脉来细弱者，此属正虚邪恋、实中兼虚。

证析：本病以女性患者较多见。湿热邪毒蕴积下焦，水为热阻则艰涩难通，热迫膀胱则淋痛尿频。热伤络脉，酿成脓血，故尿色暗红混浊，甚则可见血尿脓尿。腰为肾之府，水热互结，肾气不利，故腰及小腹胀满而痛。如毒热太盛，热蒸于外，荣卫失和，则见恶寒发热。舌红苔黄，

脉象滑数,均为湿热邪毒内盛之象。若已成为慢性疾患,不但常以劳累气衰,正不胜邪,引起复发,且可因反复日久,肾气愈亏而致缠绵难愈。

治法:急性发作,证属实热,宜清热解毒,利水通淋;已成慢性,虚实并见,宜扶正祛邪,清补兼施。

主方:清热通淋,用通淋解毒汤^③;清补兼施,用黄地鱼公汤^④。

本病在急性期经过治疗,小便淋痛得到消除后,仍须进药2~3周,务以尿检无脓血、细菌为治愈标准。对慢性者亦宜采取已发祛邪治标、未发扶虚治本的原则,并依据肾气肾阴亏虚不同情况,随证用药,不必拘泥常法。

本病无论急性慢性常于发病时出现寒热表证,对此切勿妄施发汗方药,否则汗出伤津,必致小便淋涩加剧。

(三) 膏淋

主证:小便频数,尿色深黄混浊,尿时热涩隐痛,有时自觉阴下坠胀作痛,小便前后或于大便登厕时,有滑腻如膏之物从尿道溢出,可伴遗精、早泄、或阳痿等证,舌质红,苔黄腻,脉多细数。

证析:本病常见于中老年人,大多属于慢性疾患。络脉瘀积,阻碍水道,郁而生热,故见尿频尿黄混浊,尿时热涩隐痛。湿热壅积于下,膀胱气化不行,故常觉阴下坠胀作痛。热聚下焦,壅迫精室,尿时精溺俱下,故见滑腻如膏之物随尿溢出。久则精气亏伤,精关不固,而致伴见遗精、早泄、阳痿等证。舌红苔腻,脉象细数,俱为下焦湿热伤及肾阴病证。

治法:清利湿热,消肿通瘀。

主方：瘀热重者，用苦参白术汤^⑤养阴清热，消肿通淋；瘀热轻者，用四妙汤^⑥健脾泻火，利水通瘀。对伴有遗精、早泄、阳痿等证者，俟小便通利以后，可参考有关各篇治法。

此外，凡属淋证，虽有寒热表证，不可发汗，汗之则津伤血燥；虽有虚象不宜纯补，补之则堵邪助热。所以，古有淋家忌汗、忌补之戒。

三、方药化裁

1. 金苇汤

金钱草100克 石苇30克 冬葵子15克 篇蓄15克
木通15克 车前仁15克 地榆15克

上药水煎，日尽一剂，分3~4次服。

此方清利水道，排石通淋。适用于尿路结石，小便淋痛，砂石有排出趋势者。方用金钱草、石苇为主，以清利水道；配冬葵、木通、篇蓄、车前仁，则通淋之力更强；佐地榆凉血收敛，以防利下太过，伤害血脉。是方功专力强，有使砂石随尿直下之良效。

2. 金鸡饮

金钱草60克 炒杜仲15克 怀牛膝15克 白茅根30克
车前仁15克 鸡内金6克（炒脆研粉，分3次冲服）

此方清利水道，补益肝肾，消化结石。适用于砂石已下，小便已通，余石未尽者。方以金钱草、白茅根清利水道；杜仲、牛膝补益肾气；鸡内金助胃以行药力。肾气盛则水道宣利，小便利则砂石自消。

3. 通淋解毒汤

生地黄15克 木通20克 茯苓20克 篇蓄24克 地榆20克 黄柏15克 鱼腥草30克 蒲公英20克 甘草梢10克

此方清热凉血，解毒通淋。适用于血淋发病，尿急尿频，热涩疼痛，或见血尿脓尿者。方中生地黄、地榆凉血止血；木通、茯苓、篇蓄通利水道；黄柏清泻下焦实火；鱼腥草、蒲公英消肿解毒；甘草梢能直达前阴泻火止痛。合而用之，协奏凉血泻火、通淋止痛之效。凡急慢性肾盂肾炎、膀胱炎于急性发作阶段，一般用本方连服2~4剂，对消除尿急尿痛诸证，其效颇优。

如尿血为甚者，加炒蒲黄20克（包煎），以助消瘀止血之力。腰痛为甚者，加杜仲15克，白芍20克，以缓急止痛。如淋痛已解，小便已利，去黄柏、篇蓄，继续进服2~3周，以防邪毒隐伏而致病情反复。

4. 黄地鱼公汤

黄芪30克 白术15克 茯苓24克 生地黄15克 木通20克 鱼腥草30克 蒲公英20克 甘草6克

此方扶正解毒，清利兼施。适用于血淋久病，正气已虚，邪毒留恋，遇劳即发，其证腰痛尿频，淋涩量少，神倦脉弱者。方以黄芪、白术、茯苓、甘草扶持正气，健脾运湿；生地黄、木通、鱼腥草、蒲公英养阴利水，清热解毒。正胜则能托邪，热去则尿淋自愈。

尿中夹血者，加地榆20克，白茅根30克。腰痛甚者，加杜仲15克，白芍15克。如见浮肿尿少，加薏苡仁15克，泽泻15克。如见食少便溏，加缩砂仁6克，炒谷芽20克。

5. 苦参白术汤

方药见第四章遗精篇第四方。

本方清利水道、消肿通瘀之力颇强，故适用于膏淋瘀热重证。惟方中苦参味苦至极，过用亦能害胃伤脾。所以，凡用本方以小便淋涩得到缓解，即应改用平和方剂以清余热。

6. 四妙汤

白术15克 黄柏15克 丹参20克 金钱草30克

此方健脾泻火，消肿通瘀。适用于膏淋瘀热轻证，见小便黄热，尿流不畅，尿后有脂液物溢出者。方用白术健脾以运湿浊，黄柏泻火以清积热，丹参通络以散瘀肿，金钱草消利以通水道。余常以本方随证加味治疗慢性前列腺炎，其清利水道之效甚佳。（表42）

表42 淋证病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
因于下焦积热发病。肾气不足，蓄水生热，热煎尿液，结成砂石；湿热邪毒，蕴结下焦，热壅伤络，酿成脓血；尿道瘀积，蕴湿成热，湿热壅迫，精随溺出	石淋	清利水道 消化结石	金苇汤 金鸡饮
	血淋	清热解毒 利水通淋	通淋解毒汤 黄地鱼公汤
	膏淋	清利湿热 消肿通瘀	苦参白术汤 四妙汤

第四节 癃 闭

癃闭以排尿困难，甚则小便涓滴不通为主证。癃与闭又有轻重的区分：小便不爽，尿来滴涩短少，病势较缓者，

为“癃”；小便闭塞，欲便难通，病势较急者，为“闭”。正如《类证治裁》所说：“闭则点滴难通”，“癃为滴沥不爽”。因二者仅有轻重缓急的不同，故一般皆以癃闭合称。

癃闭与淋证的鉴别：癃闭只见小便不通；淋证见尿来频急涩痛。

一、病因病机

肾合三焦膀胱，肾为主水之脏，膀胱为藏溺之腑，三焦为津液出入的道路。津液来源于水谷，由脾转输上归于肺，肺气通调下输膀胱，经肾气之施化，乃排泄而为小便。若因肺、脾、肾、三焦病变而致气化不及州都，或尿道有所瘀阻而致水道不得通利，便可引起癃闭发病。其病机可区别为：因于热、因于虚、因于瘀三个方面。

因于热：肺为水之上源，热壅上焦，灼伤津液，热壅气阻，通调失职，因而气化不及州都，发生癃闭。中焦湿热，累及膀胱，水道不清，气化不行，则小便难通。肾与膀胱并居下焦，或肾移热于膀胱，或膀胱积热累及于肾，水热互结，则小便不行。

因于虚：中焦气虚，脾运失职，清气不升，则浊阴不降，因而下焦气化不行，致成癃闭。下焦阳虚，命门火衰，膀胱不得施化，注泄无能，致使溺不得出。此即王启玄所说：“得气海之气施化，则洩便注泄，气海之气不及，则闷隐不通。”

因于瘀：瘀血凝聚，结成肿块，阻塞于尿道膀胱之间，

轻者尿来如线，滴沥不畅，重则瘀闭阻塞，形成癃闭。《证治要诀》说：“有瘀血而小便闭。”《景岳全书》说：“或以积血阻塞水道而不通。”都是指此类病证。

由此说明，大凡各类急性热病，或慢性虚证，在病机演变中，如影响三焦水道运行障碍，致使肾与膀胱气化失常，便可导致癃闭发病。所以，本病多并发于各类急慢性病程中。

二、辨证施治

癃闭一证，除外伤性尿闭、妊娠尿阻外，一般多并发于各种急慢性病程中。其间有初起尿来淋漓，渐至点滴难通的；有突然发病，即见小便闭塞的。病情严重者，可伴发胀满、呕逆、喘急、水肿等证，甚则出现危急证候。所以，张景岳说：“数日不通，则奔迫难堪，必致危殆。”正因本病以尿闭急迫为主证，在治疗上，当根据不同原因而以利水道、通闭塞为急务。小便得利，病势缓和，又当按原发疾病随证调治。现分热闭、虚闭、瘀闭三类辨证施治如下：

（一）热闭

主证：小便热赤，尿来滴沥量少，或涓滴不通，口中干渴，小腹胀满，或大便不畅，舌质红，舌苔黄，脉滑数或细数。

见小腹胀满特甚，无喘急，口渴不甚者，属膀胱积热。

见烦渴欲饮，呼吸喘急，小腹胀满不甚者，属肺热气壅。

证析：肺肾津水相通，三焦壅热，水热互结，热耗津液，则口中干渴；水液不得通利，则尿少难通。热壅三焦，各有偏盛，如小腹胀满特甚，口中不甚干渴，且无喘急证状，据此可知，根源在于下焦积热；如见烦渴欲饮，呼吸喘急，反而小腹胀满不甚，由此可以判断，根源在于肺热气壅。大便不畅，舌红苔黄，脉滑数或细数，均为内热伤津之象。

治法：养阴泻火，利水通闭。

主方：以牛车饮①为主方。本方重在清利膀胱积热，如见肺热气壅证状，则当加入清泻肺热之品，使上清下利，尿闭自通。

（二）虚闭

主证：时有尿意，欲便不得，或尿来滴沥不爽，排出无力，多见于老年病人，或久病体虚患者。

兼肛门重坠，似欲大便，神疲气短，倦怠无力，舌质淡，脉缓弱者，属脾虚气陷，升运无力。

兼腰膝清冷，面色苍白，面肿脚肿，舌淡苔白，脉沉细尺弱者，属肾阳虚衰，水气不化。

兼小便热涩，欲便不得，形体消瘦，手足潮热，舌质淡红，脉沉细数，无阳虚证状者，属肾阴亏虚，水热互结。

证析：脾虚气陷，升运无力，因而津气不布，阻遏下焦，故时有尿意而欲便不得。肛门重坠，似欲大便，神疲气短，体倦无力，舌淡脉弱，均为脾虚气弱无力升提的病证。肾阳虚衰，气化不及州都，水气停聚不得畅利，故小便不爽，排出无力。水气内停，泛溢肌肤，故面肿脚肿。面色苍白，腰膝清冷，舌淡苔白，脉沉细尺弱，均为命门

火衰，下焦虚寒所致。如肾阴亏虚，并无阳虚证状，见小便热涩难通者，则属阴不济阳，水热互结。

治法：升补脾阳，温肾行水。

主方：脾虚气陷，用补中益气汤②加怀牛膝、车前仁，一升一降，小便自通。肾阳虚衰，用济生肾气丸③补肾温阳，化气行水；如肾阴亏虚，可减去方中桂枝、附片加入知母、黄柏以壮水制火，清利小便。

（三）瘀闭

主证：先见小便黄热，尿流不畅，或见小便前后溢出滑腻如膏之物，渐至小便滴沥，或尿来如细线，甚则阻闭不通，小腹胀满隐痛，舌色紫暗，或有瘀点，脉沉涩或细数。

证析：本病多继发于膏淋患者。由于瘀凝肿块日渐增大，水道阻塞，水液停聚，郁而化热，故早期表现小便热涩、尿后溢出脂液如膏之物。瘀块增大，尿道狭隘难通，故尿来滴沥，或如细线，甚或闭塞不通。小腹胀满隐痛，舌现紫暗瘀点，脉沉涩或细数，均为瘀中夹热、虚实并见病证。

治法：消肿通瘀，清利水道。

主方：瘀热偏盛，小便闭塞者，宜先与苦参白术汤④消肿通瘀重剂；小便得利，宜与四妙汤⑤健脾泻火，清利水道。

本病多虚实并见，临证时根据瘀、虚偏轻偏重，随其病情佐以化瘀、扶虚药物。

此外，各类癃闭在尿闭难通之际，还可采用探吐、熨脐等外治方法，在部分病员中亦能取得通利小便之良效。

三、方药化裁

1. 牛车饮

知母15克 黄柏15克 木通15克 生地黄15克 篇蓄15克 怀牛膝15克 车前仁15克

此方养阴泻火，利水通闭。适用于膀胱积热，小便热赤难通，小腹胀满特甚者。方用知母、黄柏清泻下焦积热；用前仁、木通、篇蓄通利水道；用生地滋养肾阴；用牛膝引诸药下行，以发挥导利小便之力。热去阴回，水道自通。

若肺热气壅，烦渴喘急者，方中加黄芩15克，桑白皮30克，麦门冬15克，花粉15克，以清泻肺热、止渴除烦。肺气清降，水道自利。

2. 补中益气汤

方药见第四章多寐篇第三方。

本方加怀牛膝、车前仁治气虚尿闭，能于升补中导利小便，清升浊降，水道自通。

3. 济生肾气丸

方药见本章水肿篇第九方。

本方滋养肾阴，温补肾阳，化气行水。适用于肾阳虚衰，水气不化，肢冷脚肿，小便滴沥不通者。方中以六味地黄补肾阴；桂枝、附片补肾阳；牛膝、车前仁导利水道。阴回阳复，则气化行而小便利。肾为水火之脏，如肾阴偏亏，水不济火，亦能导致水热互结，尿闭难通。如是则当去桂枝、附片，加知母、黄柏，便能取得壮水制火、清利

水道之效。

4. 苦参白术汤

方药见第四章遗精篇第四方

5. 四妙汤

方药见本章淋证篇第六方。

上二方均为清利水道，消肿通瘀之剂。苦参白术汤，适用于瘀热重证，尿闭难通者；四妙汤，适用于瘀热轻证，尿阻不甚者。如瘀肿太甚者，加川牛膝15克，桃仁10克，以增强通瘀散积力量。此即《沈氏尊生书》所说：“血瘀小便闭者，以牛膝、桃仁为要药。”沈氏此说，确有疗效。

如气血已虚者，加黄芪30克，当归10克，更能扶虚以行其瘀。若肾阳虚衰，伴肢冷脚肿者，加肉桂3克，制附片10克，以助温阳通窍之力。

附：癃闭外治法

1. 探吐法

用手指或鹅翎刺喉探吐，有使小便自通作用。此即朱丹溪所说：“上窍开而下窍之水出。”这一方法，较适用于一时性尿闭，如属虚证则当慎用。

2. 熨脐法

用葱白50克，切细捣碎，分2包，用一包置脐上，以热水袋熨5分钟，另换一包，以冷水袋熨5分钟，如此冷热交替，以尿通为度。此即《医宗金鉴》“阴阳熨脐”治法。余治一肛痔手术后尿闭，用此法交替熨脐2次，尿闭立通，足见取效甚捷。（表43）

表43

癃闭病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
三焦壅热，通调失职，水热互结，水道不通。中焦气虚，升运无权，下焦阳虚，水气不行。瘀血凝聚，结成肿块，阻塞水道，小便难通	热 闭	养阴泻火 利水通闭	牛车饮
	虚 闭	升补脾阳 温肾行水	补中益气汤 济生肾气丸
	瘀 闭	消肿通瘀 清利水道	苦参白术汤 四妙汤

第五节 尿频不禁

小便次数增多，日夜十余次，甚至数十次者，称为尿频；小便滴沥不能自忍，甚或睡中自遗不能约制者，称为不禁。因二者多兼并出现，病因亦多相同，故合称尿频不禁。

如尿频不禁伴发于中风、温病、妇人产后以及儿童尿床，则当按原发疾病治疗，不属本篇范围。

一、病因病机

膀胱职司藏溺，三焦职司决渎水道，举凡上焦肺、中焦脾、下焦肾气化不足，而致膀胱不能约制小便，即可发生尿频不禁。导致的病机，大都因虚而与脾肾虚亏的关系最为密切。其间有脾肾气虚属寒者，亦有肝肾阴虚属热者。所以朱丹溪指出：“小便不禁有虚寒、虚热之分。”

肾阴不足，疏泄偏强。肝肾并居下焦，肾与膀胱相合，

肾主闭藏,肝主疏泄。水液由三焦水道下输于肾,藏之膀胱,排泄小便。人体小便之所以能维持其正常的排泄,实有赖于肾之闭藏,肝之疏泄,互为调节,毋太过,毋不及,则无小便不利,或尿频不禁之患。肾阴不足,水不涵木,势必肝气偏强,疏泄胜于闭藏,因而膀胱不能约制小便,发生尿频不禁。肝气有余,表现为热,肝热之起,实由肾阴亏虚,故致病之根仍在于肾。

脾肾气虚,膀胱不固。脾居中焦,转输精微,统摄津气;肾居下焦,受藏津液,施化小便。脾气不足,升运无力,中焦统摄无权,水液偏渗于下,以致尿频不禁。此主因在脾,属于上虚不能制下。肾气虚弱,闭藏失职,下元不固,无权约制膀胱,是以小便频数、甚或小便滴沥自遗。此主因在肾,属于膀胱之气不固。

由此可见,发生尿频不禁的病机演变,虽与肺、脾、肝、肾、三焦、膀胱均有关系,实与脾、肾气化失常的关系最为密切。阴虚则阳盛,故表现为虚热;阳虚则阴盛,故表现为虚寒。

二、辨证施治

现分肝肾阴虚、脾肾气虚二证施治如下:

(一) 肝肾阴虚

主证:小便频数,日夜排尿一、二十次,或更多,尿量多而不能自忍,尿热而尿色清白,烦渴多饮,大便干结,或手足潮热,或心烦失眠,久则形体消瘦,皮肤干燥,汗液减少,舌红少苔,脉弦数或细数。

证析：本病可继发于温热病后，或见于肾阴素亏之人，起病多为渐进性，亦有突然发病者。肾之阴气不足，肝之相火有余，疏泄胜于闭藏，故尿液频数难忍，甚或不禁。因尿多而频，故尿虽热而其色清白。津不上承，肺胃失养，故烦渴多饮以自救。津不下润，肠脏干涸，故大便燥涩难通。阴虚则阳盛，虚热内蒸，故手足潮热。虚热独盛，神不归阴，故心烦不寐。久则阴津大亏，不为腠养形体肌肤，故汗少肤燥而体瘦。舌红苔少，脉弦数或细数，均为阴虚内热病证。

本病表现颇与消渴相似，消渴多饮多尿、小便如脂、尿有甜味；本病渴而多饮，尿色清白，无糖尿出现，以此有别于消渴。

治法：滋阴清火，固敛肾气。

主方：以知柏地黄汤^①为主方。依据病情轻重、燥热偏盛，随证化裁。

（二）脾肾气虚

主证：小便频数，尿量不多，尿色清白，时或尿来滴沥，甚则失禁，或继发于大病之后，或见于老年体弱之人。

伴少腹坠胀而时有尿意，神倦气短，懒言思卧，舌质淡红，脉象缓弱者，属中气不足，脾失统摄。

伴小便滴沥失禁，形衰怯冷，头晕腰酸，或面浮脚肿，舌质淡白，脉沉细尺弱者，属肾气虚衰，下元不固。

证析：脾虚不能统摄，津液偏渗于下，膀胱为下渗津气所迫，故少腹坠胀而尿意频数。气虚则神气不振，故神倦气短、懒言思卧。脾虚则气血不足，故舌淡红而脉缓弱。肾虚不能约束水道，膀胱之气不固，故小便滴沥失禁。

肾虚则精气不足，外而不能温充肌肤，内而不能润养经脉，故形衰怯冷、头晕腰酸，甚则肾阳亏虚，水气不化，泛滥成肿。舌白淡，脉沉细尺弱，均为阳虚阴盛病证。

治法：补中升陷，温肾固涩。

主方：脾虚宜补中升陷，用补中益气汤^②；本方能升提下陷之气，以恢复中焦升运转输职能，膀胱无下渗津气所迫，小便排泄自可归于正常。肾虚宜温肾固涩，用巩堤丸^③为主方；本方重在温阳固涩，可依据病情轻重随证化裁。

三、方药化裁

1. 知柏地黄汤

知母24克 黄柏20克 山萸肉15克 生地黄24克
牡蛎24克 山药24克

此方滋阴清火，固敛肾气。适用于肝肾阴虚，疏泄偏强，小便频数量多，烦渴多饮者。方以知母止渴除烦；黄柏清泻相火；地黄滋补肾阴；山萸肉、牡蛎固敛肾气；山药益脾运行药力。肝肾和调，疏泄适度，尿频可止。

烦渴甚者，加天花粉、麦门冬、天门冬，以生津止渴。大便秘结者，加麻仁、郁李仁，以润肠通便。心烦不寐者，加酸枣仁、丹参，以除烦安神。若尿频日久，见肤燥体瘦，神倦气短者，此属阴亏气弱，加黄芪、五味子，更具益气固肾、清补兼施功能。

关于阴虚多尿一证，也有固涩方药无功，反以清利治法取效者。一男性病员患肾性尿崩证，口渴尿频，量多难忍，日夜排尿二、三十次。前医多用滋阴固涩方药无效，

余投以知柏萸地汤数剂,亦无明显效果。俟据患者自述,少腹部常有胀满隐痛之感,乃思肾阴不足,相火偏强,下焦水热互结,迫及膀胱,亦能导致尿频发病。据此,余采取通因通用法则,仍以知柏萸地汤为主,减去山药、牡蛎,加入《伤寒论》猪苓汤(猪苓、茯苓、泽泻、阿胶、滑石)滋阴利水药物,一面滋肾坚阴,一面清利结热。初服2剂,小便特多,继则排尿次数渐次减少,烦渴饮水亦渐次减退。后以知柏地黄汤调理痊愈。此种病例尚不多见,故录此以备参考。

2. 补中益气汤

方药见第四章多寐篇第三方。

本方用于脾虚尿频,亦可酌加益智仁、补骨脂固敛肾气之品,使其一升一敛,共收脾肾两补之功。

3. 巩堤丸(《景岳全书》)

熟地黄15克 菟丝子15克 五味子10克 益智仁10克
补骨脂10克 制附子10克 韭菜子10克 白术10克
茯苓10克 山药15克

上药作煎剂,或加量制蜜丸,每服6克,早晚空胃各服一次。如兼气虚,加人参3~6克,其效更佳。

此方暖肾益脾,固涩下元。适用于命门火衰,膀胱不固,尿频失禁者。方以熟地黄、菟丝子、附子、五味子等品补肾温阳;以茯苓、白术、山药培健脾气。脾气旺则能统摄,肾气旺则能闭藏,下元巩固,膀胱气化复常,自无尿频不禁之患。

如肾阳尚未大衰,形体虚怯不甚,去附子、韭菜子,酌加潞党参、黄芪,其益气固肾功效亦佳。(表44)

表44

尿频不禁病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
肾阴不足，肝气有余，疏泄胜于闭藏，膀胱不约，尿频量多。脾虚不能统摄，水液偏渗于下；肾虚而膀胱之气不固，小便清沥不禁	肝肾阴虚 疏泄偏强	滋阴清火 固敛肾气	知柏地黄汤
	脾肾气虚 膀胱不固	补中升阳 温肾固涩	补中益气汤 巩堤丸

结 语

三焦乃水液循行的道路，肺脾肾三者是主司水液代谢的主要器官。凡肺、脾、肾、三焦在外因、内因的病机演变中，都能导致水液代谢功能紊乱而致产生种种病变。

外邪阻肺，脾、肾内虚，致使水液代谢障碍，三焦不利，输化无权，外而不能输津以为汗，内而不能下输以为溺，水液潴留，泛溢肌肤，则为水肿。水肿有外因、内因、实肿、虚肿之别，但以内虚为主因，而内虚又以脾、肾不足为主因。

消渴乃脾阴亏损导致水液代谢偏强发病。脾虚不能输津于上，肺胃失养则口中干渴而多饮；胃气偏强则消谷善饥而多食；脾虚不能统摄水谷精微，精微随尿下趋，故多尿如脂而有甜味。是以消渴“三多”并见，而以尿甜如脂为特征。初起肺胃津亏，燥火内盛，其证偏实；久而精气亏损。肺肾同虚，其证偏虚。在治疗上，始终以益脾固肾为原则。

淋与癃均以水道不得宣利而发病。淋以小便频急热涩疼痛为主证；癃以小便闭阻涓滴难通为主证。淋有石淋、

血淋、膏淋之分；痿有热闭、虚闭、瘀闭之别。病因不同，治疗各异。

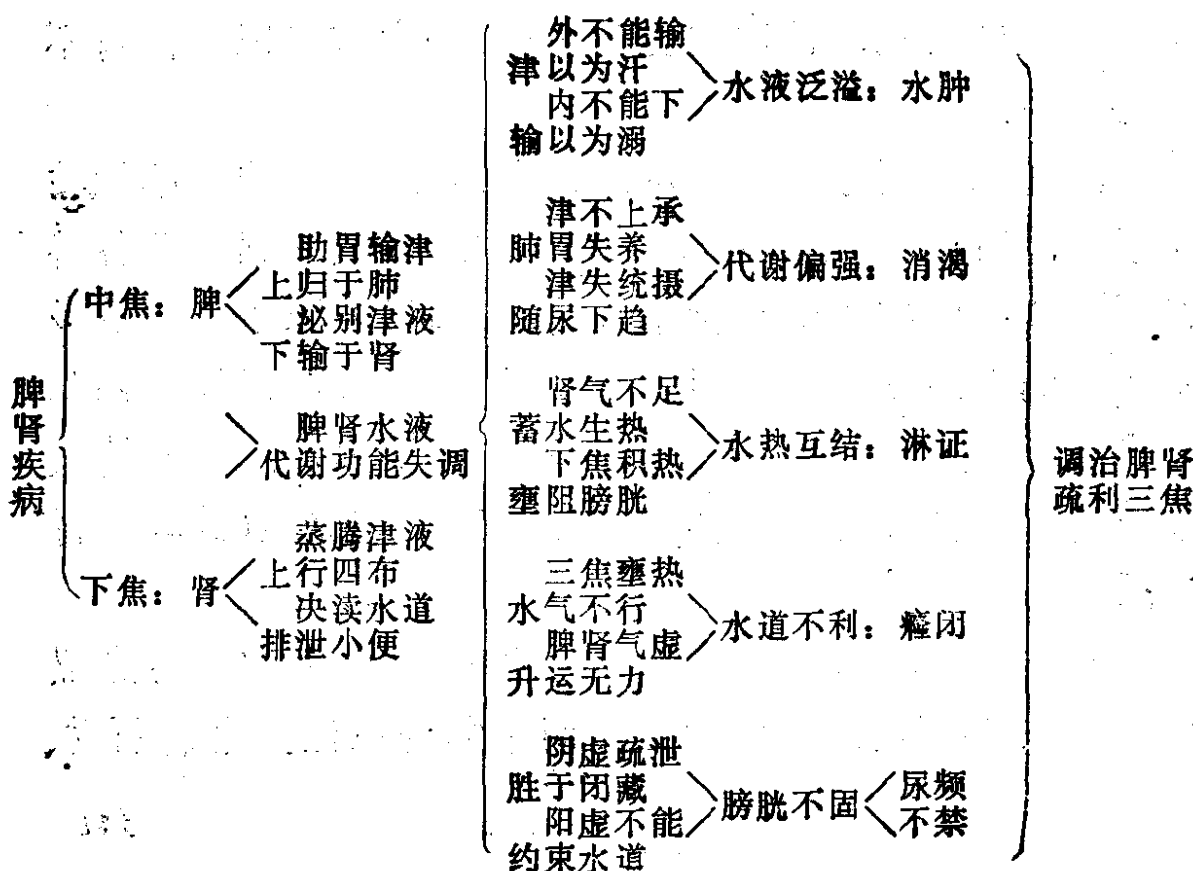
尿频不禁，大都因虚，较多见于老年体弱或病后体虚患者，皆由膀胱不约而致发病。其间有肝肾阴虚，疏泄胜于闭藏，表现为虚热证候者；有脾肾气虚，不能约束水道，表现为虚寒证候者。因此，一般以尿频不禁都属虚寒之说，是不切合临床实际的。

总的来说，本章所论各病，虽病因病机各有不同，辨证施治各有差别，其由肺、脾、肾——尤以脾、肾功能失调导致体内水液代谢紊乱的病机演变则是一致的。据此可知，无论此类疾病因于热、因于虚、因于瘀阻，或因外感，或因内伤，或为实证，或为虚证，或虚中夹热，或实中兼虚，其治疗大法，总以调理脾肾，疏利三焦为基本法则。

(表45)

表45

脾肾疾病病机简表



第七章

肝肾疾病

肝主筋而藏血，肝经脉络起于足趾，循股内侧入阴毛中，环绕阴器至少腹上行，入肝络胆，上膈布胁，上达于喉咙。肾藏精而主骨，在上开窍于耳，在下开窍于二阴。因此，凡筋骨、精血、肝脉、耳窍、阴器等方面的疾病，都与肝肾关系极为密切。本章仅以肝肾病变所引起的痿证、疝证、奔豚气、耳鸣耳聋等病证作出论述。

脚气一病，因与痿证类似，为了便于鉴别，故附列章末。

第一节 痿 证

痿证以肢体筋脉弛缓，肌肉枯萎，皮肤麻木，手足软弱无力，或手足拘急不能随意运动为主证。据临床所见，其证表现不一，有肌肉麻木不知痛痒的；有手足拘挛缩而

难伸，或伸而难屈的；有筋非拘挛，肉非麻木，惟觉骨软不能履地的。一般以两足痿弱不能随意运动及行走者较多见，故痿证又称痿躄。

一、病因病机

人体皮毛、肌肉、筋膜、经脉、骨髓皆有赖于荣气精血，以为灌溉，以为腠养。脾胃为气血生化之源，肝肾为储藏精血之脏，荣气败伤则不能温养皮肉经脉，精血亏虚则不能灌溉筋膜骨髓。所以，痿证多属于虚，尤与肝肾、脾胃亏虚的关系极为密切。导致发病的原因，有内因，也有外因。

因于内因者，多见于温热病后，或久病体虚，脾胃失健，伤于肝肾。肝藏血而主筋膜，肾藏精而主骨髓，精血充盛，筋骨强健，经脉畅和。若因温热邪毒伤于肝肾，精血亏虚，精虚不能灌溉筋膜骨髓，血虚不能荣养肌肉经脉，致使手足拘挛痿弱，发生痿证。此种痿证，大多先伤于阴，阴虚则阳盛，其病初起常见阴虚内热。病延日久，又可因内热耗阴，精血日亏，渐致精不化气，而现精气两虚证候。

因于外因者，大多因于久处湿地，感受外来湿邪，浸渍肌表，积渐不去，伤于气血，致使肌肉筋脉麻痹不仁，成为痿证。正如《素问·痿论》所说：“有渐于湿，以水为事，若有所留，居处相湿，肌肉濡渍，痹而不仁，发为肉痿。”湿为阴邪，留滞肌表，始而阻碍荣卫流行，继而经脉瘀痹，久则受病肢体气血损伤，而致肌肉筋脉失于润

养。气虚则不仁，血虚则不用，故筋脉弛缓，肌肉麻木，形成痿证。此种痿证，由于邪从外至，如正气不虚，郁而生热，湿热互郁，浸淫筋脉，凝滞气血，则表现湿热证候。此即《素问·生气通天论》所说：“湿热不攘，大筋软短，小筋弛长，软短为拘，弛长为痿。”如果湿滞日久，气血败伤，湿从寒化，筋脉瘀痹，则表现筋脉弛缓不用，肌肉顽麻不仁。

除上述病因外，妇人产后，如气血亏虚太甚，筋脉失却濡养，亦能成痿。其病机与气血败伤者，大致相同。

二、辨证施治

痿证以下肢痿弱者为多见，亦有手足均见痿弱的，甚者拘挛强急，足不能履地，手不能持物。起因于温热病中或病后，常突然肢体拘急，渐见痿弱不用，多属肝肾亏虚，筋脉损伤，其治较难，往往不易恢复。起因于湿邪浸渍者，常病来缓慢，渐见肢体痿软，由于邪从外至，病在筋脉，多属气血败伤，筋脉失养，其治较易，一般预后良好。

痿证与痹证、中风的鉴别：久痹可见肌肉消瘦麻木而与痿证相似，但痿证以肢体痿软为主证，一般不表现疼痛证状，不似痹证以关节疼痛为主证。中风后遗证与痿证亦颇近似，痿证不表现半身不遂，口眼歪斜，语言謇涩等证状，据此不难鉴别。

关于痿证的治疗，《素问·痿论》指出：“治痿者独取阳明。”因阳明属胃，胃为水谷之海，为荣气精血生化之源，皮肉经脉赖以润养，筋膜骨髓赖以灌溉，筋脉得润

则束骨而利机关,故益胃健脾是治疗各类痿证遣方用药的基本法则。

本病的虚实辨证,一般来说,痿皆属虚,亦多虚实互见。所以,临床上应区辨虚中有热,虚中夹湿,虚中兼瘀,或湿热互郁诸证,分别施治。

(一) 肝肾亏虚,筋骨失养

此类痿证常以下肢拘挛痿弱、腰脊无力为主证,治宜健脾胃、补肝肾、强筋骨。分阴虚内热、精气亏虚两类辨证。

1. 阴虚内热

主证: 下肢拘挛,渐见痿弱,或不能履地,不能随意运动及行走,头目昏眩,手足潮热,小便黄热,舌质红绛,脉象细数。

证析: 肝主筋膜,筋膜束骨而利机关。肝肾亏虚,精血不足,筋脉失养,是以下肢渐见痿弱;机关不利,是以肢体拘挛。阴虚则阳盛,虚阳上盛,故头目昏眩;虚热内炽,故手足潮热。尿黄热,舌红绛,脉细数,皆为阴虚内热病象。

治法: 滋阴清热,补益肝肾。

主方: 以五痿汤^①补中养阴,清除内热;以虎潜丸^②补益肝肾,强健筋骨。视病情久暂,或一方单行,或二方并用,并依据阴虚与内热的轻重增减变化。

2. 精气亏虚

主证: 病延日久,下肢痿弱不用,腰脊酸软无力,伴神倦怯寒,甚或阳痿遗溺,舌质淡红,脉象沉细无力。

证析: 精血亏虚,久则精不化气,渐致精气两亏。精

气不能温养宗筋,故下肢痿弱不用。腰为肾之府,精亏髓空,故腰脊酸软无力。精虚则神弱,故精神困倦。阳虚不能温达肢体,故怯冷畏寒。命火虚衰则阳痿,肾气不固则遗溺。舌淡红,脉沉细无力,均为精气亏虚之证。

治法: 健脾补血,温养肝肾。

主方: 以归芪四君汤^③健脾补血;以鹿角胶丸^④温养肝肾。二方并用,精气两补,补脾胃以充化源,温肝肾以健筋骨。

(二) 湿热留滞,气血损伤

此类痿证常以肢体痿弱、肌肤麻木为主证,治宜健脾胃、补气血、通瘀痹。分湿热留滞、气虚血痹两类辨证。

1. 湿热留滞

主证: 两足痿软或微肿,自觉两胫蒸蒸作热,肢体酸重,面色暗黄,小便黄赤,舌苔黄腻,脉象濡数。

证析: 湿热留滞,阻碍气血,浸淫筋脉,故足胫痿软,自觉蒸蒸作热。湿热郁蒸于外,故身重而面黄。湿热流注于下,故两足微肿,小便黄赤。苔腻主湿,舌黄主热;脉濡主湿,数为热象。

治法: 清热渗湿,滋养肝肾。

主方: 以加味二妙散^⑤为主方;如内热已除,小便清利,瘀痹不解者,则从气虚血痹施治。

2. 气虚血痹

主证: 两足痿软不用,甚或手足俱废,肌肤麻木,不知痛痒,面色萎黄,肌肉消瘦,唇舌色淡,或舌色紫暗,脉细缓或虚涩。

证析: 气血亏虚不能荣养筋脉,故手足痿软不用。气

虚则不仁，血虚则不用，故受病肢体筋脉瘀痹，甚则肌肉顽麻不知痛痒。面黄肌瘦，唇舌色淡，舌紫暗，脉细缓或虚涩，均为气血亏损，筋脉瘀痹之证。

治法：益气养血，活络通痹。

主方：以加味黄芪桂枝五物汤^⑥为主方；依据瘀、虚轻重随证化裁。

总之，诸痿属顽证者多，尤以发生于温热病中或病后者，常因筋脉损伤，大多不易完全恢复。一般除药物治疗外，尚须配合针灸或按摩疗法，颇能取得一定效果。

三、方药化裁

1. 五痿汤（《医学心悟》）

太子参10克 白术10克 茯苓10克 薏苡仁10克
当归6克 麦门冬6克 黄柏3克 知母3克 甘草3克

此方补中健脾，养阴清热。凡痿证属阴虚内热者，均可以本方为基础，依据病情轻重加味治疗。方以太子参、茯苓、白术、甘草补中健脾；当归、麦门冬滋养荣阴；知母、黄柏清除内热。方药剂量偏轻，取其轻清缓补。病在下肢，加怀牛膝、川续断，以补益肝肾。病在上肢者，加秦艽、白芍，以活络舒挛。肢体拘急者，加丹参、红花，以活血通瘀。如内热偏盛者，加黄连、黄芩。阴虚偏盛者，加生地黄、天门冬。

2. 虎潜丸（《医学心悟》）

龟板120克 杜仲90克 熟地黄90克 黄柏(炒)15克
知母15克 怀牛膝60克 白芍60克 虎骨(酒炙酥) 60

克 当归60克 橘皮12克 干姜6克

上药研细末，酒糊丸，每服3~6克，日服2次，早晚空胃淡盐水下。如体气素虚者，加人参30克。

此方补益肝肾，强壮筋骨，滋阴清热。适用于肝肾虚亏，筋骨痿软，腿足瘦削，步履乏力者。此方用龟板、熟地黄、当归、杜仲、牛膝滋养荣阴，补益肝肾；用知母、黄柏清降虚火。方药配合，补重于清，其中龟板用量独重，足见是方以滋补肝肾为主。由于病在筋骨，故配白芍柔肝舒挛；虎骨强壮筋骨。因恐阴柔之品，碍脾害胃，故佐以小量橘皮理气和胃，干姜温中醒脾。凡痿证属肝肾阴亏有热者，用此方治疗，最为适合。

本方与《丹溪心法》所载虎潜丸在方药和剂量配伍上各有不同。彼方无杜仲、牛膝、当归；此方无锁阳。彼方黄柏用量独重，其立意以降火为主；本方则重在滋补肝肾。依据临床所见，痿多慢性顽证，属虚者多，火旺者少，此方较切实用。

3. 归芪四君汤

黄芪30克 当归6克 太子参20克 白术10克 茯苓10克 甘草3克

此方以太子参、茯苓、白术、甘草培健脾胃；以当归、黄芪益气补血。用本方治疗痿证精气亏虚者，一般与鹿角胶丸配合进服，既可健脾胃以运行药力，又可增强益气补血之功。

如单用本方治疗痿证，加鹿角片、熟地黄、白芍、怀牛膝、续断等温补肝肾之品，亦能取得标本兼顾之效。

4. 鹿角胶丸（《医学正传》）

鹿角胶500克 鹿角霜250克 熟地黄250克 怀牛膝90克 茯苓60克 菟丝子60克 人参60克 当归120克 白术60克 杜仲60克 虎胫骨30克 龟板30克

上药细末，将鹿角胶用酒烱化，制为丸剂，每服3~6克，日服2次，空胃淡盐汤下。

此方温补肝肾，滋养精血，强壮筋骨。适用于痿证日久，肝肾不足，精气亏虚者。方中集大队温补肝肾、滋养精血效力较强之品，并辅以人参、茯苓、白术益气健脾，使胶丸之剂不致碍脾害胃。由于痿多久病顽证，仍当以轻量缓补为佳。如体气大虚，则与归芪四君汤配合，更能协奏精气两补之效。

5. 加味二妙散（《丹溪心法》）

黄柏15克 苍术15克 汉防己15克 萆薢15克 当归10克 牛膝15克 龟板15克

此方清热渗湿，滋阴养血。适用于湿热留滞，浸淫筋脉，致成痿证者。方以黄柏清热，苍术燥湿。配防己、萆薢宣导经络之湿，使从小便而去。佐当归、龟板、牛膝滋阴养血，通利筋脉。如见腿脚奇热，心中烦闷，此为内热偏盛，可加黄连、木瓜宣清郁热。如见两脚浮肿，小便不利，此为郁湿偏盛，宜加茯苓、薏苡仁、泽泻运脾利湿。

如内热已除，小便清利，仍见肌肉麻木，腿脚运动不便者，当从气虚血痹施治。

6. 加味黄芪桂枝五物汤

黄芪30克 桂枝10克 白芍15克 生姜3克 大枣12枚 白术15克 当归6克 丹参15克 秦艽15克

此方益气养血，活络通痹。适用于痿证气虚血痹者。方

用《金匱要略》黄芪桂枝五物汤加味组成。黄芪、桂枝与当归、丹参同用，益气温阳 活血通痹；桂枝、白芍、秦艽合配，又能和调荣卫，舒筋通络。黄芪配白术健脾实表；大枣合生姜温中养荣。合而用之，表里协力，气畅血行，瘀痹通则顽麻解。本方黄芪为全方主药，用量宜重，其效乃佳（病重者可用60~100克）。

因于久处湿地成痿者，加防己、木瓜，以宣散筋脉留滞之湿。下肢痿痹甚者，加怀牛膝、川续断，以温补肝肾，通利筋骨。妇人产后气血亏损成痿者，去桂枝，加熟地黄，更能大补气血，通利经脉。（表46）

表46 痿证病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
伤于内者，肝肾亏虚，精血不足，筋骨失养，肢体痿弱。 伤于外者，湿滞肌表，气血损伤，筋脉弛缓，肌肉顽麻	肝肾亏虚	阴虚内热	滋阴清热 补益肝肾 五痿汤 虎潜丸
		精气亏虚	健脾补血 温养肝肾 归芪四君汤 鹿角胶丸
	气血损伤	湿热留滞	清热渗湿 滋阴养血 加味二妙散
		气虚血痹	益气养血 活络通痹 加味黄芪桂枝五物汤

第二节 疝 证

男子少腹痛引辜丸、辜丸肿痛及女子少腹偏侧气冲部攻撑作痛者，都属于疝证一类的疾病。

尤在泾《金匱翼》指出：“疝者痛也，不特辜丸肿痛为疝，即腹中攻击作痛，控引上下者，亦得名疝，所以昔

贤有腹中之疝与睪丸之疝之说。”

由此可知，疝证指两种疾病：一指睪丸肿痛；一指小肠气疝。

一、病因病机

疝证发病的部位，属于任脉与肝经循行之所。任脉起于会阴，上出毛际深部，为阴脉之海；足厥阴肝经循股内侧，上绕阴器，入于腹里，与任脉并行。所以，疝证与任脉、肝经的病变密切相关，尤与肝经的关系最为密切。一般说来，发生睪丸肿痛，多因感受寒湿邪热；发生小肠气疝，常与先天因素有关。

（一）居处卑湿、或久坐湿地，以致阴寒湿邪凝滞气血，聚于阴分，形成睪丸肿痛之疝。如尤在泾说：“江淮之间，湫澹之处，多感此疾”，“此皆痛在睪丸之疝也”。因湿为阴邪，寒主收引，寒湿搏结于下，致使阴囊间气血凝涩，筋膜挛急，发生囊肿睪痛。

若寒湿留滞，久而化热，或其人素蕴湿热，流注阴囊，湿滞热聚，则成热疝。正如张景岳所说：“疝气之病，有寒证，亦有热证。”“病郁既久，则郁而成热者有之；或以肠脏之内，火因邪聚，而湿热相资者亦有之。”

儿童罹患疝，亦能并发热疝，而致睪丸肿痛。因肝经循喉咙之后，上入颃颥（颈部），任脉亦上循咽喉至颃下（颐下）。所以，温热邪毒从口鼻而入，侵袭经脉，便可发生疝（又称发颐）。如循其经脉入里内窜，下入阴分，聚于阴囊，即可并发睪肿疝痛。

(二) 先天不足, 或婴儿期过于号哭努挣, 以致宗筋弛纵, 筋膜不固, 气坠少腹, 而成小肠气疝。任脉有总任一身阴脉的职责, 肝主筋膜, 脐下至横骨属宗筋部位, 宗筋上络胸腹, 下贯骹尻。如禀赋不足, 任脉不固, 复因婴儿期号哭努挣, 最易导致筋膜弛纵, 久则不易还纳, 而致气坠少腹, 或为疝瘕, 或为偏气。此病男女皆有, 有自幼及长, 病随终身的; 有初病轻微, 随形体发育而自愈的; 也有年长体弱, 复因举重操劳, 致中气虚陷而发作的。总之, 本病大多与先天因素有关, 较常见于小儿, 大体非药物所能根治。如张子和所说: “小儿亦有此疾, 俗曰偏气……胎中病也, 此疝不治。”

二、辨证施治

分睾丸肿痛和小肠气疝二类, 前者着重区辨寒热, 后者着重区辨虚实, 分别论治如后。

(一) 睾丸肿痛

1. 寒证

主证: 睾丸肿硬疼痛, 阴囊清冷, 喜暖畏寒, 阴茎不举, 或形寒足冷, 舌苔白腻, 脉沉弦或沉紧。

若见阴囊水肿, 状如水晶, 冷痛而囊湿出水者, 称为水疝。

若见阴囊肿硬坠胀, 麻木不知痛痒, 久久不愈者, 称为癰疝。

证析: 肝脉络于阴器, 寒入厥阴, 络脉凝滞, 故睾丸阴囊冷硬肿痛, 甚则坚硬如石, 痛引少腹。寒为阴邪, 得

暖则舒，遇寒更甚，故以喜暖畏寒为特征。阴寒内阻于下，则下焦阳气不布，故阴茎不举，甚则形寒足冷。舌苔白腻，脉沉弦或沉紧，均为阴寒内闭病象。若因寒气内阻而致下焦水气不得宣化，水湿停聚，流注阴囊，则成水疝。若因寒疝日久，血随气凝，气血瘀痹，阴囊肿硬顽麻。则成癰疝。

治法：温经散寒，理气活血。

主方：以暖肝煎^①为基本方剂。依据病程久暂，阴寒偏盛，重在温经散寒；水湿停聚，当先逐水；气血瘀痹者，则宜辅以消坚行瘀方药。

2. 热证

主证：阴囊红肿疼痛，喜凉畏热，或伴发热恶寒，小便黄赤，甚或尿闭不通，舌苔黄腻，脉象滑数。

小儿疝瘕并发热疝，可见耳下一侧、或双侧腮部肿胀疼痛，或伴咽喉红肿，其阴囊肿痛亦较剧烈。

如热疝阴囊肿胀持续不愈，扪之有波动状者，应注意有化脓成痈趋势。

如热疝迁延日久，见睾丸硬结，疼痛轻微，伴手足潮热，小便黄少，舌红苔剥，脉象细数，久久不愈者，此属肾阴亏伤，热留不去。

证析：湿热流注阴囊，壅滞脉络，故阴囊红肿疼痛。热为阳邪，遇凉则舒，得热更甚，故以喜凉畏热为特征。湿热外蒸，荣卫失和，故恶寒发热。湿热内闭，下焦气化失常，故小便黄赤，甚则尿闭不通。舌黄腻，脉滑数，皆为湿热内盛所致。小儿疝瘕并发热疝，多因温热邪毒循经内窜引起发病，在辨证上又当有所区别。凡热疝持续不

愈,如因热伤脉络,血肉瘀腐,则能蕴毒成痈;如因肾阴亏伤,热留不去,又可形成睾丸硬结,久久不愈。对此,临床上都应加以密切注意。

治法:消肿解毒,泄利湿热。

主方:以夏枯煎^②为基本方剂。本方重在清泻肝经实火,对并发于疝者,当与消肿利咽合并治疗。如有成痈趋势,则应着重清解热毒;对肾阴亏伤,热留不去者,又当施以滋肾养阴、清热散结之法。

凡睾丸肿痛无论属寒属热,都可采取外治法配合治疗。肿胀甚者,宜卧床休息,或用布块托起阴囊,以减轻痛苦。另外,可用蛇参椒矾洗剂^③煎汤敷洗,寒证宜热熏或热敷,热证红肿较甚,可采取冷敷方法。如已化脓成痈,则当配合外科治疗。

(二) 小肠气疝

1. 实证

主证:少腹偏侧气冲部有形如瘕,结滞不舒,瘕形大小不一,或如桃李,或如瓜状,偏坠胀痛,缓急无时,每因忿怒、号哭、过劳而发作,舌脉一如常人。

证析:筋膜弛纵,肠气下坠不能还纳,故少腹偏侧有形如瘕,结滞不舒。平时气机流畅,一如常人,若忿怒、号哭、或劳累负重,则气窜于下而偏坠胀痛。由于气机升降聚散无常,故其证发作缓急无时。体气不虚,故舌脉如常。

治法:舒肝散结,理气止痛。

主方:以《局方》导气汤^④为主,依据疼痛轻重加味治疗。

2. 虚证

主证：阴囊偏有大小，时上时下，卧则入腹，立则入囊，稍劳则气坠阴囊，胀痛俱作，每因年老体虚，或昔肥今瘦，坠痛频作，舌淡白，脉沉缓弱。

证析：禀赋不足，筋膜弛纵，肠气坠入阴囊，故阴囊偏有大小。立则筋膜松弛，卧则筋膜还纳，故卧则入腹，立则入囊。正因其疝时上时下，出入往来，与狐相似，故又称狐疝。体气不虚，形体肥盛，劳逸适度，一般不致发病。若年老体弱，形体渐瘦，便可因气虚不能摄纳，稍劳则气坠入囊，胀痛俱作。如见坠痛频作伴舌淡白、脉沉缓弱者，则属气虚不固所致。

治法：补中益气，升阳举陷。

主方：以补中益气汤^⑤为主方，依据病情辅以理气缓痛之药。

凡小肠气疝，大体非药物所能根治。无论实证虚证，坠痛发作，急令患者平卧，将双腿蹠曲抬起，用手轻轻按摩向上推送，使其回入腹中，其痛自止。对气坠频作者，亦可采用布袋兜住，以免坠痛发作。

三、方药化裁

1. 暖肝煎（《景岳全书》）

当归6克 枸杞10克 茯苓15克 肉桂3克 乌药10克 沉香3克 小茴香6克 生姜2片

此方温养肝肾，理气散寒。适用于寒疝阴囊肿硬冷痛，阴茎不举者。邪之所凑，其气必虚，故以当归、枸杞温补

肝肾以治其本。阴寒闭阻，气机凝涩，故以肉桂、小茴香温经散寒以治其标。佐乌药、沉香理气止痛；配茯苓、生姜和脾温胃运行药力。阴寒解散，气血畅和，肿痛可除。

见阴冷疼痛，伴形寒足冷者，此属阴寒太甚，加吴茱萸、制附片，以温寒止痛。如疼痛太甚，加金铃子、延胡，活血利气，以加强止痛力量。

见阴囊水肿，状如水晶者，此为水湿停聚，去当归、枸杞，加猪苓、泽泻，使与肉桂、茯苓配合而具温阳行水之功。

见阴囊肿硬麻木，不知痛痒者，此为气血瘀痹，方中宜与红花、桃仁、丹参、白芍、昆布、海藻、荔枝核、橘核等活血理气消坚之品，出入化裁，以加强通瘀消肿功能。

2. 夏枯煎

夏枯草30克 龙胆草10克 黄柏15克 木通15克
车前仁10克 白芍15克 荔枝核20克 橘核20克 甘草6克

此方清肝散结，泄利湿热。适用于湿热流注，阴囊红肿热痛者。方以夏枯草清热散结为主，配龙胆草、黄柏清泻肝经实火。以木通、前仁泄利湿热；以白芍、甘草舒挛缓急；以荔枝核、橘核理气止痛。火清湿去，肿痛可消。

伴恶寒发热者，加柴胡、黄芩，以疏表清里，和调荣卫。伴尿痛尿闭者，加篇蓄、金钱草清利水道，泻利积热。疝痛并发于疝瘕者，去龙胆草，加桔梗、玄参、板蓝根、大青叶等品，以加强清热解毒，消肿利咽功能。疝痛如有成痈趋势，加连翘、忍冬藤、蒲公英之属，以助清热消痈之力。热疝迁延，肾阴亏伤，久久不愈者。去龙胆草、木

通,加生地黄、知母,亦能取得滋阴清热散结止痛良效。

3. 蛇参椒矾洗剂

方药见第五章黄胖篇第一方。

本方温清合配,外用燥湿解毒,止痒止痛。用于治疗阴囊肿痛,一般采取煎汤趁热坐浴熏洗,亦可用毛巾拌药汤热敷。热疝不喜热敷者,将药汤放凉,采取冷敷亦佳。

4. 导气汤 (《和剂局方》)

川楝子12克 木香10克 小茴香6克 吴茱萸3克

此方舒肝散结,理气止痛,是一首治疝痛的通用方剂。适用于小肠气疝,少腹结滞疼痛,脉证不虚者。方以川楝子入肝舒利筋膜之挛急,木香行气导滞以通气机之壅结,小茴香调中理气,吴茱萸暖肝行滞。四药合配,其导滞止痛之效甚优。

如坠胀为甚者,加乌药、荔枝、橘核;疼痛为甚者,加延胡、白芍。如久病兼虚,坠痛频作者,加黄芪、太子参,益气固摄,更能虚实兼顾,缓解病情。

5. 补中益气汤

方药见第四章多寐篇第三方。

本方补中益气,升阳举陷。适用于小肠气疝,中气不足,劳则气坠,脉沉缓弱者。体虚气弱,当以补中益气为主,脾旺则能统摄筋膜,故疝证气虚用此方,颇有良效。如欲加强理气止痛功能,可与乌药、小茴香、荔枝、橘核、吴茱萸等品出入化裁。(表47)

表47

疝证病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
寒丸 肿痛	寒湿邪热，凝滞气血，囊 肿举痛，寒湿闭阻为寒疝， 湿滞热聚为热疝	寒证	温经散寒 理气活血	暖肝煎 蛇参椒矾洗剂
		热证	消肿解毒 泄利湿热	夏枯煎
小肠 气疝	肝肾不足，宗筋弛纵，气 坠阴囊不易还纳，体气未虚， 其证偏实；久病体弱，其证 偏虚	实证	舒肝散结 理气止痛	导气汤
		虚证	补中益气 升阳举陷	补中益气汤

第三节 奔豚气病

奔豚气是一种发作性的疾病。其病发作，自觉有气从少腹上冲胸咽，壅塞烦乱，难过欲死，少时发过，一如常人。由于冲气发作，如豕奔突，故名奔豚。

奔豚气一名，始见于《金匱要略》，认为此病发生“皆从惊恐得之”。《巢源·奔豚候》也认为“起于惊恐忧思所生”。由此可见，本病属于情志因素所引起的疾病。

《难经·五十六难》有“肾积贲（奔）豚”的记载，这是五脏积聚中的一种，位于少腹，扪之有形，属于积病。奔豚气病，起因于精神刺激，发作无常，扪之无形，属于气病。因此，二者名虽同而病实异。

本篇对肾积奔豚不作讨论。

一、病因病机

奔豚气病常以惊、恐、忧、思久久不释而发病。心藏神，肾藏志，肝气往来于心肾之间，调节神志，适应事物变化。惊伤肝，恐伤肾，惊则气乱，恐则气下，忧则气郁，思则气结。如因惊恐忧思久而不释，心神不畅，肝气内郁，肝郁则肾气不伸，气乱而下结。肝经之脉，下起少腹，上行挟胃，属肝络胆，贯膈布肋，循喉咙之后；肾经之脉，从肾上贯肝膈，入肺中，循喉咙。肝肾经气郁结于下，再因情绪波动，即能导致结郁之气循肝肾二经上冲胸腹咽喉，引起奔豚发作。由此可见，本病的病机，皆由心、肝、肾调节神志功能失常所引起而与肝肾经气的关系最为密切。所以，其病常以情绪舒畅，一如常人，偶触不遂，立即发病，发病时亦以种种神志不宁证候为主证。由于体质强弱各有差异，表现证候则有寒、热、虚、实之分。如肝气素盛之人，气盛有余，最易化火，气逆热动，上冲胸咽，则为冲气挟热；肾阳素虚之人，阳虚则水寒内盛，气逆则水寒之气随之冲逆，则为冲气挟寒。所以本病以气逆为主因，挟热因于气盛，挟寒因于阳虚，前者属实，后者属虚。

二、辨证施治

本病好发于中年男女，以女性较多见，一般都有精神刺激因素病史，常因情绪波动引起突然发病。

主证：自觉有气从少腹上冲胸咽，壅塞烦乱，难过欲死，惊悸不宁，恶闻人声，心中涌涌，欲言不得，胸腹烦满，似痛非痛，或喘逆气急，或涌涌欲呕，少时发过，仍如常人，一般舌脉如常。

如肝阳素旺，形体素盛，发病伴有乍寒乍热，口渴心烦，面赤唇紫，舌红苔黄，脉弦数者，属冲气挟热。

如肾阳素虚，形体素弱，发病伴有手足清冷，腹中冷痛，心悸不宁，呕吐清水，面白唇青，舌苔白腻，脉沉紧者，属冲气挟寒。

证析：肝肾结郁之气循其经脉奔冲上逆，故其病发作以气冲胸腹咽喉为主证。逆气冲心，神舍不安，故心中踊踊，惊悸不宁，恶闻人声。逆气壅滞于胸腹，故胸腹烦满，似痛非痛。气冲于上，肺失肃降，故喘急咽塞，欲言不得。肝气犯胃，胃失和降，故涌涌欲呕。气得下还，则心静神安，一如常人。如气盛化火，热随气逆，耗伤津液，则见口渴心烦；肝气挟热，逆滞于上，则见面赤唇紫；血随气逆，荣卫失和，则见乍寒乍热；舌红苔黄，脉弦数，均为冲气挟热病象。阳虚则阴胜，水因寒聚，随气而动，阴寒偏盛，故见手足清冷，腹中冷痛，面白唇青；水气凌心，则心悸不安；水气犯胃，则呕吐清水；苔白腻，脉沉紧，皆为冲气挟寒病证。

治法：平肝安神，顺气降逆。

主方：以沉香琥珀散^①为主方。本方重在顺气降逆，不偏寒热者，宜兼用芍药甘草汤^②平肝缓急，肝和则气顺，气顺则神安。冲气挟热实证，宜兼用《金匱》奔豚汤^③平肝清热，和荣降逆。冲气挟寒虚证，宜兼用《心悟》奔豚

丸④ 理气降逆，温阳散寒。本病在治疗中，必须告诫患者，重视精神调理，对治疗本病更有重要意义。（表48）

表48 奔豚气病、肾积奔豚、小肠气疝鉴别要点

	奔豚气病	肾积奔豚	小肠气疝
病因	因于精神刺激发病	因于气血湿痰瘀滞凝聚	因于先天不足，筋膜不固
症状与体征	表现发作性，发时冲气上逆，阻塞胸咽，发过一如常人	少腹部积块，扪之有形，或痛或不痛	少腹偏侧坠胀作痛，痛引睾丸，立则痛甚，卧则痛减

三、方药化裁

1. 沉香琥珀散

沉香10克 琥珀20克

上药共研极细粉末，每服3克，日服2~3次。

此方以沉香顺气降逆，以琥珀镇惊安神，用于奔豚发作，功能平制冲逆，安定神志。发病轻者，单用本方，即可取效。如冲逆较甚，或兼寒兼热者，则当配合适宜方药，其效始著。

2. 芍药甘草汤（《伤寒论》）

白芍24克 甘草10克

此方以白芍平抑肝气，以甘草和中缓急。用本方煎剂配合沉香琥珀散治疗奔豚发作，冲逆较甚，不偏寒热者，即以平肝缓急之力，共收安神降逆之功。

一例 40 许女性病人，两月前因其父暴病，闻讯骤惊，突发奔豚气病。其病发作无常，时轻时重，稍有不遂，立

即发作，气从少腹上冲，咽喉如塞，欲言不得，难过欲死。前医曾用《金匱》诸方，其效不显。观其证不偏寒热，余制沉香琥珀散，另以芍药甘草汤煎汤配合进服，日尽一剂，连服一周，其病缓解。因患者恐其反复，又令单用沉香琥珀散剂继服2周，未见发病。以后施治数例，俱用沉香琥珀散为主，依据挟寒挟热不同情况，辅以清热、温寒方药，均获良效。

3. 奔豚汤（《金匱要略》）

甘草6克 川芎6克 当归6克 法半夏15克 黄芩15克 葛根15克 白芍24克 生姜2薄片 甘李根白皮30克

此方平肝清热，理气和荣。适用于冲气挟热，其证偏实者。方中李根白皮大寒无毒，除烦降逆，是治热证奔豚主药。以黄芩、葛根疏解寒热；以半夏、生姜和胃降逆；以川芎、当归、芍药、甘草平肝缓急，理气和荣。依据表现证候增减剂量，如寒热为甚者，加重葛根、黄芩；呕逆为甚者，加重半夏、生姜；无腹痛者，去当归、川芎。

4. 奔豚丸（《医学心悟》）

川楝子10克 茯苓15克 橘核20克 荔枝核20克 肉桂3克 制附片3克 吴茱萸3克 小茴香3克 木香3克

此方温阳散寒，理气降逆。适用于冲气挟寒，其证偏虚者。肾阳素虚，非桂、附不足以振复其阳；寒气上冲，非茴香、吴茱萸、荔枝核、橘核不足以平制其逆；药量轻用，以防助逆致烦。惟运用本方，仍应依据病情增减化裁。

如虚寒不甚，无手足清冷，腹中冷痛者，去肉桂、附片。心悸不宁，气虚脉弱者，加太子参、五味子，以益气

宁心。呕吐清水者，加半夏、生姜，以和中止呕。（表49）

表49 奔豚气病病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
因于惊恐忧思发病。惊伤肝，恐伤肾，肝肾之经气下结，气逆上冲，其病发作，气还则止，一如常人	冲气上逆	平肝安神 顺气降逆	沉香琥珀散 芍药甘草汤
	冲气挟热	平肝清热 和荣降逆	《金匱》奔豚汤
	冲气挟寒	温阳散寒 理气降逆	《心悟》奔豚丸

第四节 耳鸣耳聋

耳鸣、耳聋都属于听力失常的病证。耳鸣指耳内哄哄鸣响，或如蝉鸣，或如潮声，妨碍听觉；耳聋指听力减退，或重听不聪，甚或听觉丧失，不闻外声。由于耳聋多自耳鸣发展而来，病机亦多一致，故常并为一证论述。

《景岳全书》分耳聋为五类：（1）因于诸经之火壅塞清道者，属火闭；（2）因于悲怒忧郁肝胆气逆者，属气闭；（3）因于风寒外感乱其荣卫者，属邪闭；（4）因于挖伤、雷炮震伤、或久患聾耳溃脓，以致内耳损伤者，属窍闭；（5）因于年老体衰，大病以后，劳倦过度，精脱肾虚者，属虚闭。张氏此说，已将耳鸣耳聋病因病机概括无遗了。

根据临床所见，凡因挖伤、暴震、痈疮致内耳损伤及先天性耳聋、或因药物中毒已成慢性的耳鸣耳聋，大体非药物所能治愈。本篇对此类疾病不作论述。

一、病因病机

导致耳鸣耳聋的病机,一般来说,与肝肾病变有关,尤与肾的关系最大。其发病因素,有外因有内因,但总不外因于热、或因于虚两个方面。

(一) 因于热

外因风热,内因肝火,均可导致耳鸣耳聋发病。风热外乘,侵袭肌表,阻犯肺窍,肌表受邪,荣卫失畅,则邪热内壅;肺窍不通,鼻咽不利,则清窍失聪。于是,邪阻于外,热壅于内,清窍失灵,耳鸣哄哄,甚则闭塞如聋。

足少阳胆经之脉,上络于耳,下络于肝,肝为刚脏,性喜条达。如肝阳素盛,暴怒忧郁,肝气内横,气盛化火,肝胆郁火循其经脉上壅于耳,清窍失聪,发生耳鸣耳聋。此即《素问·藏气法时论》所说:“肝病者,……气逆则头痛、耳聋不聪、颊肿。”

由此可知,外因邪热者,主因在表,属于肺卫不得宣畅;内因肝火者,主因在里,属于肝气不得条达。凡此,以急性暴闭为多见。此类暴闭,如久延失治,或因反复外感,亦能导致经络瘀塞而成慢性久闭。

(二) 因于虚

肾虚日久,或久病脾虚,常为导致耳鸣耳聋的主要病机,并常与眩晕、失眠、健忘等证伴随出现,也有单独以耳鸣耳聋为主证的。肾藏精而主骨髓,脑为髓海,耳为肾之外窍,肾精充足,脑海得濡,精气上通于耳,故听觉聪灵。如年老精衰,病后伤阴,或恣情纵欲,致肾精亏耗,

不能上充清空。脑海空虚，清窍失养，则轻者耳鸣、重者耳聋。如《灵枢·决气篇》说：“精脱者耳聋”，“液脱者耳数鸣。”《灵枢·海论篇》说：“脑海不足，则脑转耳鸣。”

脾胃为气血生化之源，气血灌注于十二经脉，上于面而内通于耳。《灵枢·邪气藏府病形篇》说：十二经脉三百六十五络，其气血皆上于面而走空窍，……其别气走于耳而为听。”由此可见，如因久病脾虚，气血化源不充，致使经脉空虚，不能上奉于耳，即可发生耳鸣耳聋。

由此可知，因于肾虚者，主因在于精气不足；因于脾虚者，主因在于气血亏损。凡此，以慢性久闭为常见。

二、辨证施治

耳鸣耳聋，病有新久，证有虚实，大体新病多实，久病多虚，暴起者多邪热壅闭，渐起者多精血亏虚。张景岳指出：“暴聋者多易治，久聋者最难为力。”可见，此种疾病应重视早期治疗，否则不易恢复。现分暴闭、久闭论治如下：

（一）暴闭

1. 风热上攻

主证：耳鸣哄哄，有时如聋，恶风发热，头目昏痛，或鼻塞咽肿，或耳内肿痛，口干舌红，脉象浮数。

证析：风热耳鸣常并见于感冒风热重证。风热侵袭肌表，荣卫不畅，故恶风发热，头目昏痛。风热壅阻肺窍，鼻咽不利，清窍失聪，轻者耳鸣哄哄，妨碍听觉，重则耳

内肿痛，闭塞如聋。口干舌红，脉浮数，均为风热上攻病证。

治法：疏风散邪，清热消肿。

主方：以普济消毒饮^①为主方。本方重在消肿利咽，清除毒热，可依据病情轻重随证化裁。

2. 肝胆火盛

主证：突然耳鸣或耳聋，头痛面赤，口中干苦，心烦易怒，怒则更甚，或夜寐不安，大便秘结，小便黄赤，舌红苔黄，脉多弦数。

证析：此证较多见于肝阳素旺之人，每因郁怒而发病。肝火壅逆于上，清窍失聪，故耳鸣耳聋，头痛面赤。肝火内盛，耗伤津液，津不上承，则口中干苦；津不下润，则大便干结。肝火旺则易怒，怒则肝气上逆，故耳鸣耳聋更甚。肝气上逆，扰乱神舍，故心烦而夜寐不安。舌红苔黄，脉弦数，均为肝火旺盛之证。

治法：条达肝气，清泄肝火。

主方：以龙胆泻肝汤^②为主方，本方清泻肝火之力甚强，凡肝火上盛，暴发耳聋者，可先以本方直折其势；如肝火已平，头昏耳鸣未见清除，则用滋阴潜阳方药调理善后。

(二) 久闭

1. 肾精亏虚

主证：耳内鸣响，或细或暴，头目眩晕，腰膝酸软，或有遗精，舌质红，苔花剥，脉弦细。

如见耳鸣重听，腰膝清冷，或有阳痿，舌淡红，苔薄白，脉沉弱者，此属精气俱虚。

证析：肾虚耳鸣多见于病后阴亏、久病遗精、或老年精衰之人。肾精不足，阴不敛阳，一以清窍失养，一以虚阳不潜，故耳鸣与眩晕伴随出现。腰为肾之府，肾精不能充养筋骨，故腰膝酸软乏力。肾精不能潜制相火，相火妄动，干扰精室，则易遗精。舌质红，苔花剥，脉弦细，皆肾精亏耗病证。如精亏日久，精不化气，则见精气亏虚证候。

治法：滋阴潜阳。补益肾精。

主方：肾阴偏虚，宜滋阴潜阳，主与耳聋左慈丸^③；精气俱虚，宜补肾益精，主与河车大造丸^④。

2. 脾弱血虚

主证：耳如蝉鸣，或如潮声，形神倦怠，食少心悸，健忘少寐，大便易溏，舌淡白，脉缓弱。

证析：此证多见于劳倦过度、久病脾虚之人。脾虚不运，饮食减少。大便易溏，从而气血化源不充，不能上奉于耳，故耳鸣如蝉。经脉空虚，故形神倦怠。血虚不能养心，则心悸。血虚神弱，则健忘而少寐。舌淡白，脉缓弱，皆为气血不足所致。

治法：培健脾胃，益气补血。

主方：以归脾汤^⑤为主方。依据不同病情增减化裁，脾虚为甚，重在健脾；血虚为甚，重在补血。如属气虚下陷，则当辅以升阳举陷之品。

此外，由于导致耳鸣耳聋原因颇多，尤须善于辨证求因，不必拘泥上列方法。一般来说，起因于病后者，易于调治；因于老年精血虚衰者，不易恢复。

三、方药化裁

1. 普济消毒饮（《温病条辨》）

金银花15克 连翘15克 薄荷10克 荆芥10克 僵蚕10克 桔梗10克 玄参10克 牛蒡子10克 马勃6克 板蓝根24克 苇茎30克 甘草6克

此方疏风散邪，清热消肿。适用于风热耳聋伴恶风发热、耳咽肿痛者。方以金银花、连翘、荆芥、薄荷、牛蒡子、僵蚕轻疏风热，解散表邪；以桔梗、甘草、板蓝根、玄参、马勃、苇茎开宣肺气，清除毒热，邪去热退，耳聋自愈。如无耳咽肿痛，宜减去板蓝根、马勃，兼有咳嗽，再加桑白皮、紫苑。

2. 龙胆泻肝汤（《医宗金鉴》）

龙胆草10克 黄芩10克 栀子10克 泽泻10克 木通10克 当归3克 柴胡6克 生地黄10克 车前仁6克 甘草3克

此方清泻肝火，条达肝气。适用于肝火上逆，暴发耳鸣耳聋，伴头痛面赤，口苦心烦，小便黄赤者。方以龙胆草、黄芩、栀子泻肝清火，解除烦热。佐当归、生地黄滋养肝阴；辅以柴胡条达肝气；配泽泻、木通、前仁清利水道。凡肝火暴盛、非此方不足以折其势。如肝火已平，头昏耳鸣未见消除，多因内热伤阴，肝阳不潜，可用耳聋左慈丸调理。

3. 耳聋左慈丸（《中国医学大辞典》）

熟地黄10克 山药15克 茯苓15克 丹皮10克 山

茺莢10克 泽泻6克 五味子6克 磁石(醋淬)15克

此方滋养肾阴,镇肝敛阳。适用于肾阴不足,肝阳不潜,发为头晕耳鸣者。方用六味地黄滋养肾阴,配以五味子、磁石镇肝敛阳,故用于阴虚耳鸣颇宜。

4.河车大造丸(吴球方)

紫河车1具(洗净焙干) 败龟板60克(童便浸3日酥炙黄) 黄柏45克(盐酒炒) 杜仲45克(酥炙) 怀牛膝30克(酒浸) 天门冬30克(去心) 麦门冬30克(去心) 人参30克 熟地黄60克(入天门冬、麦门冬,加砂仁18克,茯苓18克同煮,去茯苓不用)

上药将熟地黄、天门冬、麦门冬共杵为泥,浓缩成膏,余共为末,与地黄膏混匀,制为丸剂,每服6克,日2次,早晚空胃温水或淡盐汤送下。

此方补益肝肾,益气坚阴。适用于肝肾亏损,精气俱虚,耳鸣重听,阳痿滑精,脉来沉弱者。方用河车补益精血,人参补气;熟地黄、龟板、天门冬、麦门冬养阴生津;杜仲、牛膝温补肝肾。佐黄柏潜制相火,以坚其阴;加砂仁、茯苓配制诸药,使其补而不滞。全方配合得宜,实为补益肝肾之良剂。

一例50余岁病员,素有遗精史,于40岁后出现耳鸣,渐至重听失聪,阳痿不举,服中西药无显效。证属肝肾亏损,精气不足,主与河车大造丸,日服2次,每次6克,兼用麦味地黄汤煎汤送下。病员服药一年左右,耳鸣渐消失,听觉接近正常,而阳痿滑精诸证,亦渐恢复如常。由此可见,本方治肾虚耳鸣颇有良效。

5.归脾汤

方药见第三章郁证篇第五方。

本方培补心脾,益气养血。适用于心脾不足,气血亏虚,头晕耳鸣,心悸健忘,食少眠差,脉来缓弱者。本方用于血虚耳鸣,重在益气补血。如见食少难化,大便易溏者,此属脾胃偏虚,去当归、远志、木香,加丹参、砂仁、鸡内金等养血醒脾开胃之品。

如其病起于妇女产后亡血,崩中漏下,荣血偏虚者,加熟地黄,以加强气血双补功能。

如耳鸣伴头晕倦怠,少气懒言,腹中气坠者,此属气虚下陷,清阳不升,去木香、远志,加重参、芪药量,酌加升麻、柴胡,以益气升阳。(表50)

表50 耳鸣耳聋病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
暴闭	外感风热,邪阻于外,热壅于内,耳窍失聪。 郁怒伤肝,肝气内横,气盛化火,循经上壅	风热上攻	疏风清热	普济消毒饮
		肝胆火盛	清肝泄火	龙胆泻肝汤
久闭	肾精不足,不能上承,清窍失养,听觉不灵。 脾虚血少,经脉空虚,不能上奉于耳	肾精亏虚	补益肝肾	耳聋左慈丸 河车大造丸
		脾弱血虚	健脾补血	归脾汤加减

附：脚 气

脚气是以病从脚起,腿脚软弱,或肿或不肿为主证的一种疾病。一称软脚病、脚弱病。

关于脚气的文献记载,最早见于隋代巢元方《诸病源候论》一书,并认为:“凡脚气病,皆由感风毒所致。”后世医家大多认为,本病与不服水土、饮食失调、感受风毒水湿等因素有关。本篇分外因湿毒、内因脾虚两类证候作出论述。

一、病因病机

(一) 湿毒乘虚, 侵袭脚胫

从隋、唐医籍《巢源》、《千金》而后,多以脚气是由外感风湿毒邪发病,尤以遭受湿毒的侵袭最为主要。如《脚气治法总要》说:“风湿毒气,中于足胫,遂为脚气。”《脚气勾要》亦说:“一种水毒,地气所生,其发必始于夏,终于秋。”《张氏医通》论脚气引李东垣之说,也指出:“南方卑湿,清湿乘虚,则病起于下,此是外感。”还说:本病“南方多见两足粗大与疾偕老者。”由此可知,此种脚气是以外感湿毒为主因,以南方低洼地区为多见,以夏秋时令为好发季节。长夏之季,天暑地湿,尤于南方卑湿地区,暑蒸湿郁,最易酿成湿毒。如因劳作,常履其间,或坐卧湿地,湿毒乘虚,侵袭脚胫,皮肉受邪,壅滞筋脉,阻碍经络,气血不得宣畅,而致发生腿脚肿重,麻木酸疼。如湿毒上犯,还可波及两股及少腹出现肿块或胀满病变。

(二) 饮食失调, 水土不服

大凡南北异居,对饮食习惯未能适应,或平时饮食偏嗜,长期进食精米白面。或饮食饥饱不节等因素,都能导

致脚气发病。《千金要方》说：“自永嘉南渡，晋朝士大夫不习水土，所患皆脚软之疾。”南北气候不同，欲食种类、生活习惯亦不太相同。所谓“不习水土”的实质指两方面：一是南方地势卑湿，易于外感湿邪而患湿毒脚气；一是饮食习惯不同，易使脾胃不相适应而患脾虚脚气。由此可知，凡以饮食失调为主因的脚气，皆由脾胃功能衰退而致发病。此种脚气的病机演变，如脾虚不运，水湿不化，流注脚胫，壅遏络脉，则现两脚肿重而成湿脚气病。如脾运不足，气血化源不充，荣阴亏虚，肢体失养，络脉空虚，则现足胫瘦弱而成干脚气病。无论干、湿脚气，如果病久失治，还可因荣气大亏而突发脚气冲心危证。此证虽少见，若治不及时，亦易陷于不救。

从上所述可知，脚气有外因、内因之别，自外而感者，因于湿毒乘虚，病在皮肉筋脉，其证属实；由内而致者，因于饮食失调，病在中焦脾胃，其证属虚。二者同属脚气，病因不同，虚实各异，证候和体征也是各有差别的。

二、辨证施治

分湿毒脚气、脾虚脚气辨证如下：

（一）湿毒脚气

本病以南方卑湿地区为多见，好发于夏秋季节，且有一定的地区性，发病有轻有重有缓有急。

主证：初起微觉腿脚有异，饮食如故，人多不觉，渐次出现腿脚肿重，麻木酸疼，软弱无力，行动不便，重者

伴恶寒发热，腿股局部现肿块，灼热疼痛，状如流火，小便黄赤，大便秘涩，舌苔黄腻，脉象滑数。

本病常表现周期性或不定期反复发病。随着病情的反复和发展，腿脚肿大逐渐不消，皮肤粗糙变厚，状如象皮，顽痹麻木，搔之如隔衣物，或兼阴囊肿硬，或兼少腹胀满隐疼，或小便不利，尿如米泔。以舌苔白腻，脉象缓濡为多见。

证析：湿毒外侵，病起于下，故本病以腿脚病变为主证。初起正胜邪微，虽感腿脚有异而多不自觉，且病在经络不在脏腑，是以饮食一如常人。邪毒有微甚，邪微则病轻而来势缓（有经一、二月而渐次显现症状的），邪甚则病重而来势速（经过数日即现明显症状）。邪袭经络，壅滞皮肉筋脉，气血不得宣通，故古人称本病为壅疾，而以腿脚肿重、麻木酸疼为特征。湿毒化火，上窜筋脉，故腿股局部可见肿块，痛如火灼。湿热外蒸，荣卫失和，则见恶寒发热。湿热内阻，水道不清，则见小便黄赤不利。热壅下焦，腑气不行，则见大便秘涩。舌黄腻，脉滑数，均为急性期湿热内盛病证。如本病初起失治。湿毒稽留，反复发病。致使皮肉筋脉壅滞日深，终于气血瘀痹，腿脚肿重不消，以致皮肉变厚，状如象皮。如湿毒上犯，壅滞于阴囊，则见阴囊肿硬如癰疽。如湿毒壅滞于下焦，膀胱气化不行，则见小腹胀满隐疼，或小便不利，尿如米泔。舌白腻，脉濡缓，均为慢性期阴湿壅阻常见病象。

治法：逐湿祛毒，活血舒筋。

主方：急性期以逐湿祛毒为主，辅以活血舒筋，主与贯众槟榔汤^①；慢性期以活血舒筋为主，辅以理气导湿，

主与当归牛膝散^②。在治疗中,如腿脚肿痛甚者,可用蛇参椒矾洗剂^③煎汤熏洗,对祛湿解毒,消除肿痛,亦有良效。

由于湿毒脚气属于邪壅气实,只宜宣通,切忌补法。所以,《千金方》指出:“脚气之疾,皆由气实而死,终无一人以服药致虚而殁者。”本病以早期治疗,其效较佳;已成慢性多属顽疾,其腿脚粗大往往不易消退而伴随终身。

(二) 脾虚脚气

本病成人、小儿均可发病,大多起病缓慢,一般伴有脾胃证状,分湿脚气、干脚气、冲心脚气辨证施治。

主证:初起肢体倦怠,软弱乏力,懒于行动,渐次腿脚麻木酸疼,行动不便,甚则小腹及唇指均有麻木感觉,一般以舌淡苔薄,脉象细弱为多见。

兼脚胫浮肿,按之凹陷,软弱无力,饮食减少,或能食而脘腹痞闷,大便溏薄,小便清利,或尿频不禁,舌苔白滑,脉沉缓或缓濡,此为湿脚气,属于脾气偏虚。

兼腿胫不肿,反而日渐消瘦,麻木酸疼,软弱无力,食欲不振,恶心干呕,大便时秘时溏,舌质淡红,脉象弦细,此为干脚气,属于荣阴偏虚。

兼突然呼吸急促,心悸烦乱,呕吐不食,神志恍惚,语言错乱,唇面苍白,满头冷汗,甚则出现惊厥神昏。并发于湿脚气者,口中不渴,唇舌淡白,脉多沉细;并发于干脚气者,唇焦舌红,口中干渴,脉多细数。此为脚气冲心,属于荣气大虚。

证析:气血来源于水谷,饮食失调,营养不充,久则脾胃功能衰退而致气血日虚。气血不足,经脉空虚,故

起病即见腿脚软弱，麻木酸疼，甚则小腹、唇、指均有麻木感觉等证。如脾气偏虚不能运化水湿，水气内聚，流注于下，则为湿脚气病。脾气不振，健运失司，故食少脘闷、便溏尿频等证相继出现。舌苔白滑，脉沉缓濡，皆脾虚湿性之象。如荣阴偏虚，血虚不能充润肌肤，筋脉失养，则为干脚气病。脾运失常，胃失和降。故食少于呕、便秘或溏等证伴随出现。舌淡红，脉弦细，皆荣阴不足之证。如病延日久，荣气大虚，即可因虚阳上逆而致突发脚气冲心。并发于湿脚气者，因脾虚湿盛，故口不渴而唇舌淡白，脉象沉细；并发于干脚气者，因阴亏阳越，故口干渴而唇焦舌红，脉象细数。此证至危，若见惊厥神昏，常为阴阳虚脱之候，救治不及，往往陷于死亡。

治法：健脾运湿，益气养血。

主方：湿脚气重在健脾胜湿，切忌消水通利方药，主与参苓白术散④；干脚气重在益气养血，益气着重健脾，养血切忌滋腻，主与人参养荣汤⑤；冲心脚气，治宜益气敛阳，以防虚脱，宜用生脉散⑥为主方，依据气、阴偏虚加味治疗。

由于脾虚脚气以饮食失调为主因，经过治疗，脾胃功能得到恢复以后，必须针对病情纠正饮食习惯，尤宜重视饮食调补，以防病情反复。（表51）

表51 脚气、痿证、痹证鉴别要点

脚 气	痿 证	痹 证
干脚气，腿脚消瘦，软弱无力，麻木酸疼。 湿脚气，两脚浮肿，脚胫不热。 湿毒脚气，腿胫局部现有肿块，红肿热痛	腿胫枯痿，行动受限，肌肉麻木，不觉疼痛。 湿热成痿，双脚微肿，两胫蒸蒸作热，但无肿块热痛	痹证肢体消瘦与关节疼痛合并出现。 热痹红肿热痛见于关节部位。 行痹痛处发红，见于关节，且痛后自行消失

三、方药化裁

1. 贯众槟榔汤

贯众15克 槟榔12克 防己15克 木瓜15克 黄柏12克 知母12克 荆芥10克 南藿香10克

此方逐湿祛毒，宣利气机，舒筋通络。适用于湿毒脚气急性期，证见腿胫红肿，状如流火，身有寒热，小便黄赤，舌黄腻，脉滑数者。方以贯众、槟榔逐湿祛毒；木瓜、防己通络除湿；黄柏、知母清解湿热；荆芥、藿香宣利气机。诸药合配，祛湿以去邪，清热以解毒，通络以行滞，宣气以散壅。

如腿股疼痛较甚者，加白芍、没药，以散瘀止痛。小便黄赤不利者，加木通、车前仁，以清利湿热。

如不见寒热，不见红肿，但觉脚胫肿重，麻木冷痛者，去黄柏、知母，加吴茱萸、橘皮、生姜、威灵仙等温散寒湿，舒筋活络之品。

2. 当归牛膝散

全当归15克 川牛膝15克 威灵仙15克 海桐皮15克 木瓜15克 槟榔15克 吴茱萸10克 水蛭（火焙）10克 苍术10克

上药共研极细粉末，每服3~6克，日服2~3次，温水调下。

此方活血通络，除湿消瘀。适用于湿毒脚气慢性期，证见腿脚粗大，麻木冷痛，或兼阴囊肿硬，舌白腻，脉沉缓者。方以全当归、川牛膝、水蛭活血破瘀，以消壅滞；

灵仙、木瓜、海桐皮祛湿宣痹，以通筋脉；吴茱萸、苍术温寒燥湿，以利气机；槟榔逐湿下行，以解邪毒。

兼小腹胀满，尿如米泔者，属湿邪郁滞，用萆薢、木通煎汤送服。兼脚胫热痛者，属湿郁化热，用黄柏、知母煎汤送服。兼腿脚挛急，行动不便者，属筋脉不利，用白芍、甘草煎汤送服。如病久体虚，用黄芪、大枣煎汤送服。

3. 蛇参椒矾洗剂

方药见第五章黄胖篇第一方。

本方用治湿毒脚气腿脚肿痛，或用药汤淋洗，或用毛巾浸入药汤，趁热取出热敷脚胫，亦可取得解毒消肿良效。如不见红肿，但觉麻木冷痛者，方中酌加当归、川芎、紫苏、吴茱萸等辛香药品，以加强疏利散壅之力。

4. 参苓白术散

方药见第五章黄胖篇第五方。

本方健脾醒胃，益气胜湿。适用于脾虚脚气，脚胫浮肿，食少便溏者。是方健脾以胜湿，醒胃以和中，药性平和，两调脾胃，用治脾虚脚气，其效颇佳。

见小便频数不禁者，属气虚不摄，加黄芪、益智仁，以温补肺肾，统摄下元。见大便泄利，腹中冷痛者，属中焦虚寒，加炮干姜，以温中止泄。

5. 人参养荣汤

方药见第四章健忘篇第二方。

本方培健脾胃，益气养荣。适用于脾虚脚气，荣阴偏虚，脚胫瘦弱，麻木酸疼者。如见大便溏薄，属脾虚已甚者，去当归、熟地黄，加缩砂仁，以温中健脾。如见干呕

食少,属胃气不顺,加山楂、枳壳,以和胃降逆。

6.生脉散(《内外伤辨惑论》)

人参3克 麦门冬15克 五味子10克

此方补气敛阳,生津止汗。适用于脚气冲心,呼吸急促,心悸烦乱,面白头汗,脉来虚弱者。方以人参补气,麦门冬生津,五味子益阴敛阳,共成扶虚敛阳之功。如见手足厥冷,大汗如雨,神恍面青,脉微欲绝者,此属虚阳暴脱危候,加制附片以助回阳救脱之力。(表52)

表52 脚气病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
湿毒脚气	湿毒乘虚,侵袭脚胫,壅滞筋脉,阻碍气血,腿脚肿重,麻木酸疼	急性期	逐湿祛毒 清热舒筋	贯众槟榔汤
		慢性期	活血通络 除湿消瘀	当归牛膝散
			外治	蛇参椒矾洗剂
脾虚脚气	饮食失调,脾胃衰减,脾虚湿胜,发为湿脚气;荣阴偏虚,发为干脚气;荣气大亏,发生脚气冲心	湿脚气	健脾醒胃 益气胜湿	参苓白术散
		干脚气	培健脾胃 益气养荣	人参养荣汤
		冲心脚气	补气敛阳 生津止汗	生脉散

结 语

由肝肾病变所引起的痿证、疝证、奔豚气病、耳鸣耳聋四个病种。概要言之,其病机特点有两方面:一是精血亏虚,一是经气受病。

肝主筋而藏血,肾主骨而藏精,痿证属于筋脉病变,导致的病机,主因在于血脉亏损;耳鸣耳聋属于清窍失聪,主因在于精气不足。

血虚不能荣养筋脉,故筋脉弛纵挛急;血虚不能荣养肌肉,故肌肉痿弱消瘦。所以,痿证以手足痿弱拘急不能随意运动为特征。其因湿热留滞而发病者,亦由气血损伤、筋脉失养所致,否则痿证不能成立。

耳为肾之外窍,脑为精髓之海,诸经脉络皆上于面而走空窍,精虚不能上承,则脑海不充,血虚不能灌溉,则经脉空虚。精血亏虚,清窍失养,轻者耳如蝉鸣,重者重听如聋。因于风热、或肝火而发病者,大多病于一时,经过治疗,易于恢复。

疝证、奔豚气同以肝肾经气受伤而发病。疝证表现筋脉病变;奔豚气表现气机病变。

疝证因于先天不足,筋膜不固,肠气偏坠于下者,发为小肠气疝,一般非药物能根治;因于湿热留滞阴囊,筋脉不利者,发为睾丸肿痛,一般较易治疗。

奔豚气属于神志疾病,皆从惊恐得之。惊恐不释,则肝肾气机郁结于下,每因情绪波动而发病,因属气病,药物可治。

脚气起因于外感湿毒者为湿毒脚气;起因于饮食失调者为脾虚脚气。二者病因不同,治法各异,切勿混淆。

(表53)

表53

肝肾疾病病机简表

肝：肝主筋而藏血，变动为惊，其经脉下络阴器上达喉咙					
肝肾疾病	病机	精血亏虚	筋脉失养	精虚不能灌溉 血虚不荣肌肉	下肢痿弱不用：痿证
			脑海不充	精虚不能上承 血虚清窍失养	耳窍听觉不聪：耳鸣耳聋
		经气受伤	筋脉受病	下焦筋膜不固：肠气偏坠于下 阴囊筋脉阻闭：睾丸肿胀疼痛	疝证
			气机郁结	因于惊恐忧思 肝肾气机郁结	冲气上逆胸咽：奔豚气
肾：肾主骨而藏精，变动为恐，上开窍于耳下开窍于二阴					

第八章 胃系疾病

凡因食道和胃腑功能失常所引起的病变，统属于胃系疾病一类。

从舌根咽部下行，经胸腔下膈至贲门（胃上口），属于食道部分，称为上脘；再从胃上口下至幽门（胃下口），属于胃腑部分，位于上腹心窝处，称为中脘。食道是食物通向于胃的必经之路，胃腑有容纳食物、腐熟食物、将食物送入小肠的职能。

呃逆、噎膈属于食道间病，胃痛、呕吐、反胃常因胃中腐熟食物功能失调引起。胃中有病可波及食道，而食道有病亦能累及于胃，故此类疾病皆以胃为辨证中心。

第一节 呃 逆

呃逆以膈胃气逆，呃呃连声，声短而频，令人不能自制为主证。

《内经》、《金匱》称呃逆为“哕”，唐代以后医籍，多与咳逆、干呕、噫气等病相误谬。所以，《景岳全书》指出：“哕者呃逆也，非咳逆也。咳逆者，咳嗽之甚者也，非呃逆也。干呕者，无物之吐，即呕也，非哕也。噫者饱食之息，即暖气也，非呃逆也。”从此，呃逆与咳逆、干呕、噫气诸证，得以明确辨别。

一、病因病机

膈胃气机不顺，气逆上冲，是导致呃逆的主要病机。凡暴饮暴食，情绪失畅，脾胃虚弱等因素，均可引起发病。

暴饮暴食，吞咽过急，气不顺行；过食生冷，阻遏胃气，致胃气逆乱，上冲于膈，发生呃逆。

情志失畅，肝气横逆，侮犯于胃，或气郁化火，肝胃气逆，壅滞胸膈，冲逆为呃。

久病体虚，或汗吐下太过，伤于胃气，致胃中虚冷，谷气不降，逆而为呃；或热病伤阴，胃液亏损，致胃燥气逆，虚火动膈，而成呃逆。

总之，呃逆以膈胃气逆为致病之本，病情有寒热虚实之分。实证呃逆，或为寒滞，或为热壅；虚证呃逆，或为气虚，或为阴虚。

二、辨证施治

呃逆常有一时性气机不顺而偶然发作的，大都不药可

愈。如呃逆发作,持续不断,必须治疗,始能渐愈。若久病大病出现呃逆,则多属胃气衰败的严重病证。本病着重区辨寒热虚实,审其因而理其气,总以和胃利膈、降逆平呃为基本治法。

(一) 实证

实证之呃,呃声洪亮,气盛有力,形体壮实,病来急骤,分寒证和热证二类。

1. 胃寒气滞

主证: 呃声缓而有力,胸脘痞闷,得热则减,得寒则甚,舌苔白润,脉沉缓有力。

证析: 寒气阻遏,气不顺行,故逆而作呃。胃气不虚,故呃声缓而有力。胃气阻滞,升降失调,故胸脘痞闷不舒。寒为阴邪,寒气得热则易流通而呃势减缓,得寒则阻滞愈甚而呃势加剧。舌白润,脉沉缓,均为阴寒病象。

治法: 温中祛寒,理气降逆。

主方: 用丁香散^①为主方,根据病情加味治疗。

2. 胃火上逆

主证: 呃声连连,其声洪亮,胸膈痞满,心烦口臭,小便短黄,大便不爽,或大便艰涩,舌苔黄,脉滑数。

证析: 或因宿食积热,或因肝郁化火,胃为热壅,气逆动膈,故呃声连连,其声洪亮。肝气壅滞,故胸膈痞满。热壅于内则心烦,胃有宿食则口臭。尿黄便涩,舌黄脉数,皆胃热内盛之象。

治法: 清火泄热,和胃降逆。

主方: 用丹溪泻心汤^②加柿蒂、竹茹;依据郁热轻重,随证加味。

(二) 虚证

虚证之呃，呃声低微，气短无力，形体怯弱，病来缓慢，分气虚和阴虚二类。

1. 胃气虚弱

主证：呃声低弱，气不接续，食少困倦，手足欠温，舌质淡，脉沉缓；兼畏寒肢冷，大便溏泄，脉沉迟者，属脾虚中寒。

证析：中焦脾胃司运化而主升降，中气足，膈胃宽舒，升降和顺。中气虚弱，膈气不利，则胃气不顺，虚逆致呃。声低气短，食少困倦，手足欠温，舌淡脉缓，为气虚胃弱病证。如脾阳已虚，运化失职，则见大便溏泄；阳虚不能布达肢体，则见畏寒肢冷；脉来沉迟，为阳虚已甚。

治法：益气温中，和胃安冲。

主方：用参赭益气汤^③为主方；如脾阳已虚，则当加入温中助阳之药。

2. 胃阴不足

主证：呃声急促而不连续，口舌干燥，心烦口渴，舌质红绛，脉象细数；兼困倦短气，不思饮食，脉细数乏力，则属气阴两虚。

证析：阴虚胃燥，气失和降，虚火动膈，则气逆作呃。津不上承，故口舌干燥。虚火动扰，故心烦口渴。舌红绛，脉细数，俱为阴虚有热病象。如胃气兼虚，则见困倦短气，不思饮食，脉现虚数乏力等证。

治法：益胃生津，和中止呃。

主方：用加减益胃汤^④为主方；如胃气已虚，则当加

入益气扶虚之品，以奏津气两补之功。

上列实呃和虚呃二类病证，如在各种急慢性病程中出现，仍当依据原发疾病，针对病情，加以调治，其效方著。

三、方药化裁

1. 丁香散（《医统方》）

丁香3克 柿蒂30克 高良姜3克 甘草6克

此方暖胃温中，降逆止呃。适用于呃逆实证，胃寒气滞者。方用丁香、高良姜暖胃温中，以散寒气；柿蒂、甘草和中顺气，以止呃逆。柿蒂善于降逆止呃，惟用量宜重，其效方显（依据病情可用100克左右）。如见脘闷暖腐者，乃食滞中脘，加白术、枳实，以健脾消食。如见呕恶冷沫者，乃寒气太甚，加半夏、吴茱萸，以温寒降逆。

2. 丹溪泻心汤加柿蒂竹茹方

黄连6克 法半夏12克 生姜3克 甘草6克 柿蒂30克 淡竹茹10克

此方清火泄热，降逆止呃。适用于呃逆实证，胃火上逆者。方以黄连泻火，半夏降逆，生姜、甘草和中益胃；加柿蒂、竹茹则清降止呃功效更宏。如见口渴引饮者，属阳明火盛，加石膏、知母，以清胃火。如见口苦心烦者，属肝火内郁，加栀子、龙胆草，以清泻肝胆实火。如见大便艰涩者，加大黄，以通泄肠中积热。

3. 参赭益气汤

太子参20克 代赭石15克 法半夏10克 丁香3克

生姜3克 大枣12克 甘草6克

此方扶虚益胃，温中降逆。适用于呃逆虚证，胃气虚弱者。方用太子参、生姜、大枣、甘草益气和中，以扶其虚；赭石、半夏、丁香暖胃镇逆，以止其呃。胃气和顺，冲逆自平。如脾阳已虚者，加白术、炮干姜、制附片，以温阳健脾。

4. 加减益胃汤

明沙参20克 山药15克 麦门冬15克 玉竹10克
生地黄15克 柿蒂30克 淡竹茹10克

此方益胃生津，降逆止呃。适用于呃逆虚证，胃阴不足者。方以《温病条辨》益胃汤生津养胃；加山药甘淡补脾；配柿蒂、竹茹清降虚火；合用而成养阴止呃之效。如胃气已虚，则当津气两补，可加适量人参。（表54）

表54

呃逆病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
实证	饮食过急，胃气不顺， 或情志不畅，肝气内横， 膈胃不和，逆气上冲	胃气寒滞	温祛中寒	丁香散
		胃上火逆	清降火逆	丹溪泻心汤
虚证	久病体虚，或汗吐下太过， 伤于胃气，膈气不利， 谷气不降，虚逆致呃	胃虚气弱	益安气冲	参赭益气汤
		胃不阴足	养止阴呃	加减益胃汤

第二节 噎 膈

噎指吞咽食物，梗阻不顺；膈指膈间阻塞，饮食难下；噎而且膈，即名噎膈。

噎证能单独出现，但又常为膈证的早期病证。噎由气机郁滞，膈由食道瘀塞。如久噎不愈，由气分累及血分，日渐积而为瘀，便能由噎成膈。所以，临床上要注意噎证与膈证的区别，更要注意噎证的及时治疗。本篇分痰气交阻、痰血瘀积二类，前者噎证居多，后者则已由噎成膈。

一、病因病机

《素问·阴阳别论》说：“三阳结，谓之膈。”张隐庵《内经集注》阐明其义，指出：“三阳，太阳也，太阳为诸阳主气。太阳之气……从内膈而出于胸胁，从胸胁而达于肤表，阳气结则膈气不通。内膈之前，当胃脘贲门之处，膈气逆则饮食亦膈塞而不下矣。”由此说明，导致噎膈的病机，皆由食道气机结滞引起发病。其发病原因，有情志因素，有饮食因素，尤以情志因素最为主要。

因于情志因素导致噎膈发病，首见于《素问·通评虚实论》中，如说：“膈塞闭绝，上下不通，则暴忧之病也。”此后，《巢源·噎候》亦说：“此由忧患所致，忧患则气结，气结则不宣流，使噎。”《景岳全书》也说：“噎膈一证，必以忧愁思虑，积劳积郁，或酒色过度，损伤而成。”因于饮食因素导致噎膈发病，如《济生方》谓其因

于“饮食乖度”。何梦瑶《医碥》又说：“酒客多噎膈，饮热酒者尤多，以热伤津液，咽管干涩，食不得入也。”由此可见，本病多以情志忧郁为主因，对不适当的饮食因素，亦能引起发病。

肝经脉络与胃经并行，上贯胸膈；脾经脉络联络胃腑，上膈挟咽。所以，肝气条达，则胸膈宽舒，脾气畅运，则胃气和顺。积忧积郁，可致肝失条达，脾运不畅，肝郁则胸膈不得宽快，脾郁则津液不得宣流，从而波及于胃，累及食道。气机不得顺行，遂致津随气滞，聚为痰涎，痰气交阻，结滞胸膈，因而发生吞咽食物梗噎不顺。如果气滞日久，由气及血，积渐成瘀，痰血瘀积，阻塞食道，遂致膈食难下，食后复吐。这便是成噎、成膈的主要病机。因于饮食因素者，平素嗜食辛香燥热之品，久而积热消阴，津伤则血燥，初以食道干涩，梗噎不顺，久则瘀热停聚，贲门不纳，膈食难下，因成噎膈。

二、辨证施治

噎膈一证，较多见于中年以上病人，噎证可单独出现，又每为膈证的早期病证。噎证为痰气交阻，膈证为痰血瘀积，因而应权衡轻重，区别治疗。

（一）痰气交阻，梗噎不顺

主证：以吞咽梗噎为主证。开始时，每因情绪波动或进食干燥食品出现胸膈间有梗噎或灼热感，后即渐次加重，胸膈痞满隐痛，吞咽食物梗噎不顺，每于梗噎时须呕出一些带有涎液食物后，始觉宽快。一般伴有大便不畅，

或大便艰涩,形体逐渐消瘦,舌苔厚腻,脉多沉弦或弦细。

噎证属偶然出现者,每与吞咽过急有关,如能改变进食习惯,多可不药而愈。

证析:肝脾气郁,每因忧思恚怒而起病。初期病轻,故情绪舒畅一如常人,情绪波动则见发病。气结于上,津液不得宣流,日久气结痰聚,停滞胸膈,络脉失畅,故见胸膈痞满隐痛,吞咽梗噎,必须呕出痰涎为快。气结以后,或气郁化火而见胸中灼热;或津气郁滞不得润降而见大便艰涩。胃气不顺,脾运失常,无以生化精微充养形体,是以逐渐消瘦。舌苔厚腻,主痰涎壅滞;脉象沉弦,主肝气内郁;如脉见弦细,则为病久阴亏。

治法:宽胸开郁,顺气化痰。

主方:梗噎轻证,主以启膈散^①;梗噎重证,主以瓜蒌郁积汤^②。依据病情新久及痰气血郁滞微甚,随证化裁。

(二) 痰血瘀积,膈食难下

主证:以咽食梗阻,食入即吐为主证。开始吞干燥食物梗噎不顺,后即渐次加重,虽进软食亦梗塞难下,食入拒膈而复吐出,甚则水浆不入。胸膈疼痛,大便坚如羊粪,或吐下如赤豆汁,形体消瘦,肌肤枯燥,舌红少津,或舌色紫暗,脉多细涩。

如见饮水难下,胸痛如刀割,吐下如赤豆汁,形体极度消瘦,或经治疗稍能进食,不久又膈塞难下者,均为病趋恶化证象。

证析:痰气血瘀滞成积,阻碍食道,因而贲门不利,咽食梗阻,食入即吐。初起病轻,气结为主,虽见梗噎,

尚能进食。久则气结络瘀，津聚为痰，痰血相裹，停聚成积，梗阻于食道贲门，是以由噎成膈而见吞咽困难，食入拒膈而复吐出。瘀积有形，其位固定，故见胸膈疼痛。若因瘀久郁热，络脉损伤，则见吐下如赤豆汁。反复呕吐，水谷难下，阴液亏损，肠中失润，则见大便干结如羊粪。久则荣阴大亏，肌体失养，故体瘦而肤燥。舌质红或紫暗，脉象细涩，均为阴亏血瘀病证。

治法：益胃养阴，通瘀散积。

主方：以益胃通膈汤^③为主方；如噎膈塞太甚，药难下咽者，可先服玉枢丹^④通关散积，随后再用煎剂调治。

噎膈一证，据临床所见，噎证治较易，由噎成膈，多属恶疾，其治较难。因此，在治疗上不必拘泥一方一法。

三、方药化裁

1. 启膈散（《医学心悟》）

明沙参15克 丹参15克 茯苓10克 川贝母6克 郁金15克 砂仁壳3克 荷叶蒂2个 杵头糠3克（或生谷芽15克）

此方醒胃开郁，宽胸利膈。适用于吞咽食物梗噎不顺，舌脉如常，其证较轻者。方以沙参、茯苓益胃生津；郁金、丹参开郁通络；砂壳、川贝理气化痰；荷叶蒂、杵头糠升发胃气；合用而成醒胃利膈之功。

如见呕恶痰涎者，加瓜蒌10克，橘皮10克，以消痰理气。如胸脘痞满，暖腐食臭者，加莱菔子10克，山楂15克，以和胃消食。如老人食噎，气虚脉弱者，可加入参3克，

以扶补胃气。

2. 瓜薤郁枳汤

方药见第三章郁证篇第一方。

本方宽胸开郁，理气消痞。适用于胸膈不利，吞咽梗噎，脘痞腹胀，大便不爽，其证较重者。是方宽胸消痞力量颇强，常用于肝胃气郁而致脘痞暖气、食噎不顺诸证，俱以矢气畅通而得胸腹宽快。

胃中畏寒，喜热恶冷者，加高良姜3克，以温中理气。胸中灼热，畏进热食者，加黄连3克，以清郁火。脘痞暖腐，食入不化者，加莱菔子10克，神曲10克，以和胃消食。大便艰涩难通者，加火麻仁15克，郁李仁15克，以润肠通便。

3. 益胃通膈汤

明沙参20克 山药15克 瓜蒌15克 半枝莲15克
丹参15克 郁金15克 仙鹤草30克 荷叶蒂2个 生谷芽20克

此方益胃养阴，通瘀散结。适用于膈食不下，食入复吐，或吐下如赤豆汁，胸膈灼热疼痛者。方以明沙参、山药生津益胃；瓜蒌利膈消痰；丹参、郁金通瘀开郁；半枝莲清热消肿；仙鹤草散瘀止血；佐荷叶蒂、谷芽升发胃气。瘀通结散，咽食可下。

胸痛甚者，加白芍20克，甘草10克，以舒挛缓痛。呕血较甚，加生三七粉3克（冲服），以散瘀止血。如形体大虚，气短脉弱者，加人参3~6克，以扶补胃气。

若大便干结，坚如羊粪者，可另用火麻仁30克，煎汁去渣，加白蜜30克，调匀，频频呷服，亦能取得滋阴养血润肠通便功能。

4. 玉枢丹（又名紫金锭《片玉心书》）

山慈姑60克（去皮，焙） 续随子60克（去壳去油）
五倍子60克 麝香10克 朱砂15克 雄黄15克 红芽大戟30克 上药研末和匀，制为丸剂（有成药）。

此方解诸毒，疗疮肿，效用极宏。凡瘟疫、痧胀、中毒、疮疖、疔肿、痈疽等证，既可外用，亦可内服，其解毒消肿、通关散积之效，甚为得力。

本方用治膈食难下之证，取其通关散积，可用片剂2粒研细，以生姜汤送下。服后，或见呕吐，或见微利，可收通膈进食之效。得效后，即宜停药，以防伤胃。（表55）

表55 噎膈病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
噎证	积忧积郁，肝脾失畅， 气结于上，咽喉梗噎	痰气交阻 梗噎不顺	宽胸开郁 顺气化痰	启膈散 瓜蒌郁积汤
膈证	气结日久，由气及血， 痰血瘀积，贲门不纳	痰血瘀积 膈食难下	益胃养阴 通瘀散积	益胃通膈汤 玉枢丹

第三节 胃痛

胃痛又称胃脘痛，胃脘正当上腹近心窝部位，因而胃痛以近心窝处发生疼痛为主证。

古代文献所称心痛、心下痛，大多包括胃脘痛的病证。如《素问·六元正纪大论》说：“民病胃脘当心而痛。”《医学正传》说：“古方九种心痛，详其所由，皆在胃脘，而实不在于心。”

《灵枢·厥病篇》所称之“真心痛”与胃脘痛大不相同，真心痛以左胸虚里（左乳下）部位发生疼痛为主证，其病轻者胸闷隐痛，痛如针刺；重者剧烈绞痛，手足青冷，甚而可致“旦发夕死，夕发旦死”。由此可见，心痛与胃痛是有区别的。

一、病因病机

发生胃痛的原因，大体有两方面：一以忧思积虑，情怀不畅，肝气不舒，胃气郁滞，因而发病；一以饮食失调，损伤脾胃，脾不健运，胃失和降，因而发病。

忧思积虑，肝气郁结，肝郁失于疏泄，则脾气难伸，胃失和降。于是气滞食阻，积渐而成胃痛。气滞日久，如气郁化火，灼伤胃腑，则疼痛经常，反复发作。如久痛入络，胃络瘀滞，则不仅疼痛缠绵，且每因胃络损伤发生呕血、便黑。

酒食不节，嗜食生冷，饥饱不常，都能损伤脾胃而致胃痛发病。脾气受伤，寒自内生，脾弱胃寒，运化迟缓，饮食稍有不慎，或偶遇寒邪，便能触及于胃，发生疼痛。如寒滞日久，不仅能使胃络瘀滞而令疼痛经常，且因久痛伤络，亦能出现呕血、便黑。

于此说明，胃痛发病，既有饮食因素，也有情志因素。饮食所伤，主因在于伤脾；情志所伤，主因在于伤肝。肝胆、脾胃相为表里，肝胆有疏泄脾胃的职能，脾得肝气之助，升运精微，上归心肺，输布周身；胃得胆气之助，腐熟水谷，传入小肠，蒸化津血。所以，肝、脾失

调,都能伤及于胃发生胃痛。

二、辨证施治

胃痛以上腹近心窝处隐隐作痛为主证,见剧烈疼痛者较少,一般伴有脘闷、泛酸、嗳气等证。其病初起,经过治疗,大都可以治愈,但如不注意情志、饮食的调理,即易经常发作,成为慢性疾病。

胃痛的临床证候,着重区辨虚实寒热,在气在血。一般来说,新病不久,气滞居多,痛久入络,血瘀居多。胀痛拒按,饥时痛减,得食痛甚者,属实;痛而喜按,饥时作痛,得食痛减者,属虚。寒证之痛,喜热饮,喜温熨;热证之痛,喜冷饮,畏辛辣。气滞者,胀痛为主,走窜胸胁;血瘀者,刺痛为主,痛处固定。

治胃痛以保胃和中为基本法则。新病不久,实证居多,当以理气行滞为主;久痛入络,虚证居多,当以健脾行瘀为先;寒者当温,热者当清。不过,根据临床所见,胃痛常多喜温畏凉,而慢性胃痛又多虚实互见。且胃寒过温,每易化燥伤络;胃热过清,每易伤气害脾;消导太过能害胃,补益太过能助瘀。所以温、清、消、补的运用,必须依据虚、实、寒、热偏多偏少,或一法单行,或数法兼施,用药宜于平和,总以不害胃气为原则。

现分偏实偏虚两类证候施治如下:

(一) 偏实

1. 气滞食阻,胃失和降

主证: 胃脘胀痛,走窜连胁,按之则舒,食后加重,

暖腐食臭，舌苔白腻，脉象弦滑。

证析：食滞中脘，停积不化，是以胃脘胀痛，暖腐厌食，食后更甚。胃气结滞，失于和降，是以胀痛而走窜连胁。以手揉按，气得下行，故能取得暂时舒快。舌白腻，脉弦滑，均为气滞食阻病象。

治法：宽中消积，理气行滞。

主方：胀痛不甚，大便如常者，主以楂曲平胃汤^①加味；胀痛为甚，脘腹痞满，大便不畅者，主以瓜蒌郁枳汤^②。积食消除，胃气和降，其痛自止。

2. 肝气犯胃，郁滞化火

主证：脘腹灼热而痛，胃中嘈杂，暖气泛酸，口苦厌食，情绪快愉，其痛轻减，情绪波动，其痛加剧，舌质红，苔薄黄，脉沉弦或弦滑。

证析：肝气犯胃，郁滞化火，故脘腹灼热而痛。胃气不畅，宿食难消，故嘈杂泛酸；暖气厌食。热滞于胃，胆气不降，泛而上溢，故口苦与暖气并见。情绪快愉则肝气舒缓，情绪波动则肝气急迫，故此类胃痛与情绪关系最为密切。舌红苔黄，脉沉弦或弦滑，皆为肝热滞胃病证。

治法：舒肝泄热，和胃消积。

主方：用莢连枳术汤^③为基本方。如痛势急迫，当以缓急止痛为主；如郁火伤阴，又当配合养胃生津；如有伤络动血趋势，则当加入保胃止血之品。

（二）偏虚

1. 脾弱运迟，胃寒气滞

主证：胃脘疼痛，喜热畏凉，得暖则痛减，得寒则痛甚，脘腹痞闷，泛吐清水，食少神倦，大便溏薄，舌白

淡，脉沉缓。

证析：脾阳不足，运化迟缓，故食少脘闷。脾阳已虚，寒气内停，故喜暖畏寒。胃失和降，故泛吐清水。脾不健运，故大便溏薄。神气倦乏，舌白淡，脉沉缓，均为脾阳不足所致。

治法：温胃健脾，理气消痞。

主方：胃寒气滞，主以良附枳术汤④；脾弱运迟，主以香砂四君汤⑤加台乌、香附；若脾胃同虚则二方合用，酌情化裁。

2. 气滞血瘀，久痛伤络

主证：胃痛拒按，痛有定处，痛如针刺，或饥时作痛，食后稍安；或食后痛甚，移时稍减；伴有呕血、便黑、嗳气、反酸等证。舌质紫暗，脉多细涩。

证析：胃痛起因于胃气郁滞，久则胃络随瘀，故痛如针刺而拒按。血瘀有形，固定一处，故痛有定处而不移。瘀凝部位各有不同，故有饥饿作痛，或食后痛甚的差异。如久痛伤络，即可出现呕血、便黑。若因反复出血，气随血耗，还可兼见唇面苍白、头目昏晕、气短神倦等气血亏虚证候。舌紫暗，脉细涩，为血虚络瘀病象。

治法：保胃行瘀，健脾止血。

主方：已见呕血便黑，主以白芨丹参饮⑥化瘀止血；如失血过多，气血亏虚者，当于方中加入益气摄血之品。经过治疗，便血已止，宜常服保胃散⑦和胃健脾，散瘀止痛，以图根治。

胃痛一证，属慢性者居多，不但易于反复发作，常因久痛伤络，形成溃疡，最易发生出血病变。所以，切勿因

胃痛已止疏忽治疗,更应注意饮食调理。余制保胃散一方,功能保胃健脾,理气宽中,化痰止痛。凡慢性胃痛已发时,按上列寒热虚实诸方辨证治疗,未发时即以保胃散常服调治。根据临证运用,既能防止出血,亦能和胃止痛,如此治疗,多能取得根治良效。

三、方药化裁

1. 楂曲平胃汤

苍术15克 厚朴15克 橘皮10克 甘草3克 山楂15克 神曲15克 生姜2薄片 大枣2枚

此方健脾和胃,理气消积。适用于食积胃痛,脘腹痞满,噎腐厌食者。方中用《局方》平胃散为基础,以健脾和胃,理气宽中;加山楂、神曲以消化食积。胃气和降,其痛自止。如脘腹痞胀为甚者,加枳实、隔山消,以荡积消痞。胃痛为甚者,加郁金、香附,以开郁理气。恶心呕吐者,加半夏、藿香,以和中降逆。

2. 瓜蒌郁枳汤

方药见第三章郁证篇第一方。

本方宽胸开郁,理气消痞。适用于食积胃痛,脘腹痞胀,大便不畅,胀痛较甚者。是方用治肝胃不和而致气滞食阻,发生胃脘痞胀作痛,痛连胸胁者,能以矢气通畅而得胸脘宽快。如胃中畏寒,喜热恶凉者,加高良姜3克,以温中止痛。胃中灼热,畏进热食者,加老黄连3克,以清郁热。食积为甚者,加山楂、神曲。

3. 黄连枳术汤

老黄连6克 炒吴茱3克 白术15克 枳实10克 制香附15克 南藿香10克

此方清肝泄热,和胃消痞,理气止痛。适用于火郁胃痛,胃中灼热,脘腹痞闷,口苦泛酸者。方用黄连之苦寒以清郁火,佐吴茱之辛温以开郁滞。辅以枳实、白术健脾消痞;配藿香、香附和胃止痛。合而用之,清火不害胃,健脾不碍滞。

如痛势急迫者,加白芍15克,延胡索10克,以缓急止痛。如有动血趋势者,加白芨20克,藕节20克,以保胃安中。如郁火伤阴,见口咽干燥,舌红少津者,加明沙参、麦门冬、玉竹等养胃生津之品。

4. 良附枳术汤

高良姜3克 制香附10克 白术20克 枳实10克

此方温胃止痛,健脾消痞。适用于寒气胃痛,遇冷即发,脘腹痞闷者,方以高良姜温胃散寒,香附理气止痛,白术健脾开胃,枳实下气消痞。胃本喜温,寒去则气畅;胃喜和降,气顺则胃安。如见泛吐清水者,加法半夏、南藿香,以助和胃止呕之效。

若胃痛经常,遇冷则发,可将本方加量研制粉剂,胃痛发作,用温开水冲服3~6克,其温胃止痛之效亦佳。

5. 香砂四君汤

方药见第四章多寐篇第二方。

即本方加台乌10克,香附15克,水煎服。

此方健脾醒胃,温中止痛。适用于胃寒脾弱,脘腹冷痛,神倦食少,大便溏薄者。方以人参、茯苓、白术、甘草培健脾气;砂仁、藿香醒胃温中;配以台乌、香附理

气止痛。故治寒气胃痛偏于脾虚者最宜。

6. 白芨丹参饮

白芨24克 丹参15克 白术（炒）15克 枳壳（炒）10克 蒲黄（炒，包煎）24克 藕节30克 南藿香5克

此方保胃和中，化瘀止血。适用于血瘀胃痛，呕血便黑，正气未虚者。方用白芨保胃敛阴作为主药，以丹参活络化瘀为佐。辅以蒲黄、藕节收敛止血；配白术、枳壳、藿香和中理气。方药性味和平，不偏寒热，止血而不助瘀，通瘀而不害胃，用治胃及十二指肠溃疡出血之证，其效颇佳。如出血过多，见气虚脉弱者，加黄芪30克，白芍12克，其益气摄血之力更强。

7. 保胃散

白芨120克 丹参60克 制香附60克 白术100克 枳壳60克 砂仁（去壳）30克 鸡内金30克

上药烘脆，研极细粉末，每服3克，一日3次，饭前一小时温开水调下。

此方功能保胃健脾，理气和中，散瘀止痛。胃痛日久，伤络动血，故以白芨敛阴保胃，防其出血。胃痛始于气滞，继则络瘀，故以香附、丹参理气散瘀。久痛则伤脾，脾弱则运化失司，故以白术、鸡内金健脾化食。胃常喜温喜降，胃弱则食滞难消，故以砂仁、枳壳温中快气。胃气和调，络脉畅利，脾运复常，胃痛自安。

凡胃及十二指肠溃疡之证，常用本方治疗，一般都能防止出血，缓和胃痛，渐次取得根治良效。对其他类型的慢性胃痛，其效亦佳。

本方宜于粉剂进服,如制丸剂,疗效不佳。(表56)

表56 胃痛病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证		治 则	方 药
忧思积虑，饮食失调， 肝郁气滞，胃失和降，久 则气滞络瘀，胃痛经常， 甚则久痛伤络，发生呕血 便黑	偏实	食积胃痛	宽中消积 理气行滞	楂曲平胃汤 瓜蒌郁积汤
		火郁胃痛	舒肝泄热 和胃消积	黄连枳术汤
	偏虚	寒气胃痛	温胃健脾 理气消痞	良附枳术汤 香砂四君汤
		血瘀胃痛	保胃健脾 化瘀止血	白芨丹参饮 保胃散

第四节 呕 吐

有声有物曰呕,有物无声曰吐,词义虽异,其病相同,因而合称呕吐。

任何一种病变,只要损及于胃而致胃气逆乱,都能发生呕吐。本篇以临床常见因于外感风寒邪热、饮食失调及脾胃虚弱而致虚不受纳引起以呕吐为主证的病变,分实证和虚证二类作出论述。伴发于其他疾病的呕吐,应从原发疾病论治,兹不详列。

一、病因病机

因于外感:外感风寒,脘腹受凉,侵犯胃腑,胃失和降,以致胃气逆乱,发生呕吐。长夏季节,伤于暑热,胃

腑为邪热所侵,因而导致胃中水谷涌逆作呕。如《古今医统》说:“卒然而呕吐,定是邪容胃腑,在长夏暑邪所干,在秋冬风寒所犯。”实则风寒呕吐四时可见,不必限于秋冬。

因于伤食:暴饮暴食,或过食生冷油腻之物,食停中脘,消化不及,胃气不得和降,遂上逆而为呕吐。正如《济生方》所说:“饮食失节,温凉不调,或喜餐腥脍乳酪,或贪食生冷肥甘,……中焦为之痞塞,遂成呕吐之患焉。”又如误食不洁之物、或毒性药品而致发生呕吐,也是颇为常见的。

因于胃虚:热病之后,胃阴亏损,胃失濡养,不得润降,食入则停滞不行,逆而为呕。气虚胃弱,脾阳不振,中焦运化失常,难于消化水谷,偶因饮食稍多,胃腑不能承受,遂涌而上逆,发生呕吐。

总之,呕吐属于胃病,外邪所犯,饮食所伤,体虚胃弱,而致胃失和降即可发生。一般来说,外因呕吐,属寒者多,属热者少;内因呕吐,伤食者多,因虚者少。胃虚之呕,又以阴虚者少,气虚者多。又因呕吐不止,往往亏耗津液,由实转虚,甚则气随液脱发生危候。因此,对呕吐的及时治疗,是十分必要的。

二、辨证施治

发生呕吐的原因很多,总的来说,可分虚实二类辨证:外邪犯胃,饮食所伤,多为实证;虚证多因脾胃虚弱,运化失常所致。治实证以祛邪降逆为先,治虚证以扶虚益胃

为主。如因饮食停滞、或食物中毒而引起的呕吐,常为胃中排除有害物的应有现象,不可骤用止呕方药,防其堵塞胃气而致邪无出路。呕吐伤津,多伴有大便干结,呕止津回,大便自通,如妄施攻下,必致败伤胃气。尤须指出,凡治呕诸方,对药物气味的优劣,更宜加以选择,要避免辛燥、极苦、极咸及一切劣味之品,否则入口便吐,反致病情加剧。现分别论治如下:

(一) 实证

1. 风寒犯胃

主证: 恶心呕吐,寒热头痛,胸脘满闷,或有疼痛,舌苔薄白,脉浮。

证析: 风寒袭表,脘腹受凉,在外荣卫失畅,故寒热头痛;在内胃气逆乱,故恶心呕吐。脘腹满闷而痛,皆为寒食相并壅滞于胃所致。苔薄白,脉浮,为风寒袭表之证。

治法: 疏表散寒,和胃止呕。

主方: 用藿香正气散^①为主方。表邪偏甚,重在疏表;食积为甚,重在行滞;酌情变化,随证治疗。

2. 暑热内侵

主证: 突然呕吐,胸脘烦闷,口渴思饮,小便短赤,舌苔黄,脉滑数。

证析: 长夏之季,伤于暑热,热蒸于内,动扰胃腑,故胸脘烦闷,上逆为呕。暑热伤津,引水自救,故口渴思饮,小便短赤。舌黄脉数,为暑热内盛之象。

治法: 清暑解热,和胃降逆。

主方: 用连藿六一汤^②为主方。呕吐已止,应从生津

益胃调治。

3. 饮食停滞

主证：呕吐酸腐，脘腹胀满，或胀痛拒按，暖气厌食，大便不爽，或溏或结，舌苔腻，脉滑实。

证析：食停中脘，运化不及，故脘腹胀满，上逆为呕，吐出酸腐食物。食滞于胃，胃气受阻，故胀痛拒按，暖气厌食。胃失和降，传导失常，故大便不爽，或溏或结。苔腻脉滑，主饮食停积。

治法：消食行滞，和调胃气。

主方：用楂曲平胃汤^③为主方。依据食积轻重，夹寒夹热，随证化裁。如其病初起，见脘腹胀闷疼痛，欲吐不得吐者，可先用指探喉作吐，或用淡盐汤探吐（频频饮服，以吐为度）之法。吐后，再进本方调治。

（二）虚证

1. 胃阴不足

主证：时作干呕，有时吐出食物，口燥咽干，似饥而不欲食，大便干涩不爽，舌红少津，脉多细数。

证析：阴虚胃燥，气失和降，故时作干呕；甚而胃燥气逆，则见呕吐食物。燥热独亢，故知饥；运化失常，故饥不欲食。津液不得上承，故口燥咽干。津液不得下润，故大便干涩。舌红少津，脉象细数，主阴津亏损，虚中有热。

治法：养阴益胃，和中降逆。

主方：用麦门冬汤^④为主方。津伤太甚，着重养阴；呕逆为甚，首先止呕；酌情增减，随证化裁。

2. 胃气虚寒

主证：饮食稍多即吐，时作时止，食少口淡，倦怠乏力，四肢欠温，大便溏薄，舌淡苔白，脉象缓弱。

证析：胃气虚弱，脾阳不振，不能承受水谷，故食多即吐，食少稍安。阳虚不能温布于外，故四肢欠温，倦怠乏力。脾虚不能运化精微，故大便溏薄，甚或泄利。舌淡脉弱，为胃气不足之象。

治法：温中健脾，和胃止呕。

主方：用砂半理中汤^⑤为主方。止呕之后，当以健脾醒胃方药调理。

三、方药化裁

1. 藿香正气散（《和剂局方》）

藿香10克 紫苏3克 白芷3克 大腹皮3克 茯苓3克 白术6克 橘皮6克 法半夏6克 厚朴6克 桔梗6克 甘草6克 生姜2片 大枣2枚

此方疏表散寒，和胃止呕。适用于外感风寒，内兼食滞，脘闷呕吐，寒热头痛者。方以藿香和中止呕为主。紫苏、白芷、甘草、桔梗疏表散寒，开利肺气。合二陈、平胃诸药和中降逆。佐腹皮理气消积。故本方治四时感冒外有风寒、内有积滞而致呕吐泄泻之证，其效颇良。

表寒为甚，寒热无汗，肢体酸痛者，加荆芥、防风，以祛风解表。食积为甚，脘腹胀满，胃中呆滞者，加莱菔、山楂，以导滞消食。脘腹疼痛，喜暖畏凉者，加高良姜、香附，以理气散寒。

2. 连藿六一汤

黄连6克 南藿香10克 法半夏12克 枳壳12克 滑石18克 生甘草3克 鲜荷叶0.5张

此方清热解暑，和中止呕。适用于感伤暑热，内有食滞，脘闷呕吐，烦渴思饮，小便短赤者。方以黄连、荷叶清解暑热；藿香、半夏和中止呕；佐枳壳以消积滞；合滑石、甘草（六一散）清利下焦暑热。热证作呕，暑季尤多，是方取效甚捷。

烦闷为甚者，加焦栀子清心除烦。口渴为甚者，加知母、花粉，以生津止渴。食滞为甚者，加炒谷芽、山楂，以消食行滞。

3. 楂曲平胃汤

方药见本章胃痛篇第一方。

本方健脾和胃，理气消积。适用于伤食呕吐，脘腹胀满，暖气厌食者。食积已去，胃气和降，呕吐自止。

呕吐为甚者，加半夏、藿香，以和胃降逆。痞胀为甚者，加枳实、隔山消，以荡积消痞。如因冷食停滞，呕吐而脘痛喜暖者，加高良姜、香附，以理气逐寒。如因食滞积热，呕吐而口渴口臭、苔黄、脉数者，加黄连、竹茹，以清解胃热。

4. 麦门冬汤

方药见第二章肺痿篇第一方。

本方益胃生津，降逆止呕。适用于胃阴不足，时作干呕，饥不欲食，口燥咽干者。方用人参、麦门冬、粳米、甘草益胃生津，以扶其虚；用半夏和中降逆，以止其呕。故用治阴虚呕逆甚宜。

如津亏过甚者，加山药、玉竹、石斛，以生津益胃。

如欲开胃助食者，加炒谷芽、山楂、鸡内金等品。若大便干涩难通者，酌用火麻仁、白蜜润肠通便。

5. 砂半理中汤

太子参30克 白术15克 炮干姜3克 甘草6克 法半夏12克 砂仁3克

此方温中健脾，和胃止呕。适用于中焦虚寒，食少口淡，多食即吐，大便溏薄者。方中太子参、白术益气健脾；生姜、甘草和胃温中；砂仁、半夏醒胃降逆。脾气复常，胃气和顺，呕泄俱止。

如胃中虚冷为甚，呕吐清水不止，加丁香3克，吴茱萸3克，其暖胃温寒降逆止呕作用甚优。如脾阴已虚，大便泄利，肢冷脉沉者，酌加制附片，更能暖肾温脾而止泄利。（表57）

表57 呕吐病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
实证	外感风寒邪热侵犯胃腑，或过食生冷油腻之物，胃失和降，发生呕吐	风寒犯胃	疏表和中	藿香正气散
		暑热内侵	清胃降逆	连藿六一汤
		饮食停滞	消食导滞	楂曲平胃汤
虚证	胃阴不足，不得润降，脾胃虚寒，运化不及，饮食稍多，上逆呕吐	胃阴不足	益胃生津和中降逆	麦门冬汤
		胃气虚寒	温中健脾和胃止呕	砂半理中汤

第五节 反胃

凡饮食入胃以后，经数小时或更久，呕吐出不消化食

物,并以反复出现朝食暮吐、暮食朝吐为主证者,即称反胃,又称翻胃、胃反。

反胃、噎膈、呕吐同属食入反吐的病证。其鉴别要点:噎膈之吐,食道阻塞,谷食难下,食入即吐。呕吐之吐,胃失和降,食后乃吐,大多病于一时。反胃之吐,胃气虚弱,朝食暮吐,暮食朝吐,宿食不化,属于久病。

反胃一证,因于呕吐、胃痛日久由实转虚而发病者为多见,大都以胃虚为辨证中心,依据不同病情,施以扶虚益胃治法。

一、病因病机

张景岳引王太仆曰:“食入反出,是无火也。此一言者,诚尽之矣。”由此可见,无论发生反胃的原因有多种,其病机皆由胃气虚衰所致。据临床所知,反胃继发于呕吐日久、或久患胃痛者比较多见。

(一) 呕吐日久

呕吐失治,转为慢性,每因饮食稍多,或情绪失畅,胃腑不能相容,涌逆而吐,久则损及脾阳,胃中虚冷。中焦虚寒,饮食停留不化,食后数小时或更久,终于上逆而出,发生反胃。若反胃迁延,往往脾虚累及于肾,以致下元火衰,脾肾同虚。于是胃中水谷愈加不能腐熟,从而反复出现朝食暮吐,暮食朝吐。此即张景岳所说:“食入幽门,内火不能传化,故久而复出,此命火之阳虚也。”

(二) 久患胃痛

胃痛失治,久痛入络,胃络瘀滞则疼痛缠绵。如疼痛

日久,累月经年,一则胃气日虚,难于腐熟水谷;一则瘀滞日增,幽门梗塞,胃中食物难于传化。于是形成瘀虚交并,反复出现朝食暮吐,暮食朝吐。似此,则病情更加顽固。另外,如因久吐伤津,气阴并虚,一以胃虚不能腐熟水谷,一以津亏失于润降,亦能导致宿食不化,发生反胃。

二、辨证施治

治反胃以扶虚益胃、和中降逆为基本法则。现分中焦虚寒、气虚阴亏两类证候施治如下:

(一) 中焦虚寒

主证:食后脘腹痞满,朝食暮吐,暮食朝吐,吐出宿食不化,神倦乏力,面色不华,舌淡苔薄,脉象细缓。

如兼面色苍白,四肢清冷,唇色淡白,大便溏泄,脉沉无力,此为反吐日久累及于肾,脾肾同虚。

证析:脾胃虚寒,食停不化,是以食后脘痞,久而复吐,吐出宿食。食物不能化生精微濡养肢体,是以神倦乏力,面色不华。舌质淡,脉细缓,为气血不足之象。如久吐不已,脾虚而累及于肾,下元火衰,中阳愈虚。脾虚则运化无权,故大便溏泄。阳虚不能布达于外,故四肢清冷。唇舌淡白,脉沉无力,均为脾肾同虚表现。

治法:健脾醒胃,温中降逆。

主方:脾胃虚寒,用枳术丁砂散^①健胃消痞,温中降逆;脾肾阳虚,宜先用附子理中汤^②温阳扶脾,俟脾阳振复,再用枳术丁砂散调治。

(二) 气虚阴亏

主证：食后脘腹胀胀，久而反吐，吐出宿食不化，吐后即觉宽快，唇口干燥，大便干涩，舌红少津，脉象细弱。

证析：食后脘胀，反吐宿食，是胃气虚弱病象。久吐伤津，胃失润降，愈致食滞难下，故终于以吐出为快。胃阴不足，津不上承，则唇口干燥；津不下润，则大便干涩。舌红少津，脉象细弱，为气阴两亏之象。

治法：益气生津，和胃降逆。

主方：反吐为甚，先用大半夏汤③ 益气生津，降逆止吐；反吐已止，继以养胃汤④ 益胃养阴，和中消痞。

总的来说，反胃多为久病虚证，尤以虚寒者为多见，一般病程较长，最易反复，必须告诫患者注意精神，饮食调养。反吐止住以后，仍须针对病情继续调治，方能巩固疗效。对因幽门梗阻（狭窄）所引起的反胃吐食，一般药物多难取效，尤当重视饮食方面的调理。

三、方药化裁

1. 枳术丁砂散

白术100克 枳壳50克 丁香10克 缩砂仁（去壳）30克 鸡内金30克

上药炒脆，研为粉剂，每次3克，日服2~3次，饭前半小时温水调下。

此方健胃消痞，温中降逆。适用于胃气虚弱，宿食不化，反胃吐食者。方以白术、枳壳健胃消痞；丁香、砂仁

温中降逆；佐鸡内金以助胃化食。因久虚之病，当从缓治，故以粉剂小量缓服为佳。

2. 附子理中汤（《医方集解》）

制附片（久煎）15克 太子参 24克 炮干姜 6克
白术15克 甘草6克

此方补益脾肾，温中扶阳。适用于反胃日久，脾肾阳虚，肢冷溏泄者。方以附子温肾扶阳；太子参、白术益气健脾；甘草、干姜和胃温中。脾阳振作，胃气温和，吐泄自止。如虚寒太甚，反吐频作，可酌加吴茱萸、丁香，以助温中降逆之力。

3. 大半夏汤（《金匱要略》）

法半夏15克 人参6克 白蜜30克

此方益气生津，降逆止吐。适用于气阴亏虚，反胃吐食，口干便涩者。方用半夏降逆止吐，人参补虚益胃；重用白蜜，既能甘润和中，又能润导大便。腑气和降，反吐可止。

4. 养胃汤

太子参 24克 山药15克 麦门冬15克 玉竹10克
山楂15克 炒枳壳12克 谷芽20克 白蜜适量

此方益胃养阴，和中消痞。适用于胃气虚弱，胃阴偏亏，反胃吐食，口燥便干者。方用太子参、山药甘淡益胃；麦门冬、玉竹、白蜜甘润养阴；佐枳壳理气消痞；辅以山楂、谷芽助胃化食。津回气顺，胃腑得安。（表58）

表58

反胃病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
呕吐失治，胃痛日久，损伤胃气，或脾胃虚寒，或气虚阴亏，因而宿食不化，发生反胃	中焦虚寒	健脾醒胃 温中降逆	枳术丁砂散 附子理中汤
	气虚阴亏	益气生津 和中止吐	大半夏汤 养胃汤

结 语

正常人消化饮食的全部经过，是由肝胆脾胃相互合作来实现的。脏气以升运为常，腑气以和降为顺，饮食从口而入，经食道下至贲门进入胃腑，食物在胃经腐熟后，其中精微由脾转输上归心肺，其余食物下出幽门送入小肠。肝气从下而上贯膈上行，脾得肝气之助，得以升运精微，胆气从上而下假道于胃肠，胃得胆气之助，得以传送食物。这便是肝木疏泄脾土表现于消化食物的功能和作用。

发生胃系疾病的主要原因，可归纳为两方面：一为饮食不节；一为情志失和。饮食伤脾，情志伤肝，肝病则胆气不利，脾病则胃气失和，肝郁可致脾气不畅，脾气郁滞亦能阻碍肝气。在此相互牵累、相互因果的病机作用下，或波及于食道，或累及于胃腑，于是呃逆、噎膈、胃痛、呕吐、反胃各随其病因病机的不同而发病。

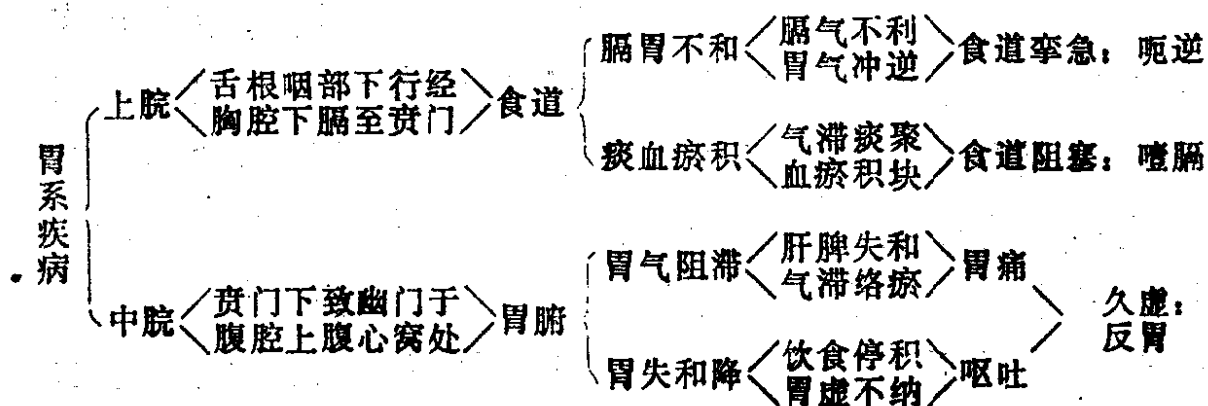
在食道者，病为呃逆、噎膈。呃证因于膈胃气逆，或以膈气不利，波及于胃，或以胃气冲逆，累及于膈，从而导致食道挛急发生呃逆。若食道间因于痰血瘀凝，渐成积

块,阻碍食道,则成膈证。呃证属于气病,轻浅易治;膈证属于积病,顽固难医。

在胃腑者,病为胃痛、呕吐、反胃。腑气不畅,气滞络瘀,发生胃痛;饮食停积,胃气上逆,发生呕吐;脾胃久虚,宿食难化,久而复吐,是为反胃。总之,胃腑疾病常与肝脾失调有关,故治胃同时还须注意舒肝理脾治法。胃常喜温畏凉,虽有积热不可过于清泄,防止败伤胃气反致其虚,故治胃宜用温和方药。(表59)

表59

胃系疾病病机简表



第九章

肠系疾病

因于小肠、大肠发生病变所引起的疾病，统称肠系疾病。

小肠连接幽门，位于腹腔中、下部，是消化道最长的一个部分。共分三段：上为十二指肠，中为空肠，下为回肠。空肠与回肠在腹腔内相当于腹脐周围部位。大肠与回肠相连接，其连接处为阑肠（又称阑门），阑肠在腹腔内右下腹部分。大肠下端连接直肠（又称广肠），直肠末端为肛门。从幽门下至小肠大肠，统称为胃之下脘。小肠功能是继续消化由胃传来的食物，吸取其中精微，并将食物糟粕逐渐送入大肠。糟粕进入大肠形成粪便，经大肠传导作用送至直肠，定时地排出体外。

此即小肠、大肠所具有的分别清浊和传导糟粕的本能。

霍乱、泄泻、痢疾、肠痛、便

秘、虫证等疾病,虽然发病原因各不相同,病变部位各有差异,但皆同属肠道间病,故列为一章论述。

第一节 霍 乱

霍乱以起病急骤,上吐下泻,吐泻交作为主证。因其病势凶险,挥霍撩乱,故名霍乱。

本病首见于《灵枢·五乱篇》中,说:“乱于肠胃,则为霍乱。”《伤寒论》说:“呕吐而利,此名霍乱。”

《千金方》指出本病与饮食的关系,如说:“原夫霍乱之为病也,皆因饮食,非关鬼神。”清王孟英从上海地区霍乱流行的经历,指出本病与季节、环境污浊关系密切。如所著《霍乱论》载:“今夏余避地来游,适霍乱臭毒番痧诸证盛行,而臭毒二字切中此地病因。”由此可见,本病好发于夏秋季节,多由环境秽浊、饮食不洁引起发病。

本病如因偶感湿邪、或饮食所伤而发病者,称为寻常霍乱,病来虽骤而无传染;如因触犯暑湿秽毒引起传染流行者,称为时疫霍乱,其证凶恶,病变顷刻。本篇据《外台秘要》分湿霍、干霍二类:上吐下泻,吐泻交作者,名曰湿霍;腹中绞痛,欲吐不得吐,欲泻不得泻者,名曰干霍。湿霍中又当区别寒霍、热霍二证。在治疗上,皆以治乱安胃为基本法则。

一、病因病机

夏秋之季,暑湿蒸腾,若环境不洁,滋生臭毒,加以

飞蝇传播,污及食物,或贪凉而过食生冷瓜果,或饮水而伤于水毒,或暴饮暴食,或误食馊腐食物,凡此种种,即可导致毒食相并,清浊相混,乱于胃肠,胃乱则吐,肠乱则泻,是以吐泻交作,发生霍乱。伤于暑热,复感秽毒者,毒热偏盛,发为热霍。如《素问·六元正纪大论》说:

“不远热则热至,热至则身热吐下霍乱。”贪凉饮冷,伤于脾胃者,寒湿偏盛,发为寒霍。如王孟英《霍乱论》说:

“若其中人阳素馁,本以土不胜湿,而复袭凉饮冷,则湿从寒化而成霍乱。”

若暑湿秽毒阻遏中焦,致使胃肠气机闭塞,上下不得宣通,发生腹中绞痛,欲吐不得吐,欲泻不得泻,烦闷难忍者,则为干霍乱。此证《疫疹一得》名为“闷痧”,《霍乱论》名为“绞肠痧”,是霍乱中最危急的一种证候。总的来说,感受时邪秽毒,饮食不慎,是发生霍乱的两个主因,二者相互为因,阻遏中焦而致升降机能失常,或肠胃气机逆乱,上吐下泻而成湿霍;或肠胃气机闭塞,吐泻不得而成干霍。凡此,大都病来急骤,病势凶险,救治不及,往往津气厥脱,陷于危殆。

二、辨证施治

霍乱系肠胃同病,来势险,病变速,治疗以和调脾胃,分别清浊,平息逆乱为基本法则,并宜兼用急救方法,以免延误时机。现分湿霍乱、干霍乱施治如下:

(一) 湿霍乱

以突然吐泻交作为主证,分热霍、寒霍二证。

五、1. 热霍

主证：吐泻交作，势如喷射，初起所下带有稀粪，继则下利如米泔水，不甚臭秽，胸脘闷乱，头痛烦热，口渴引饮，小便短黄，舌质红，苔黄腻，脉濡数。

见四肢酸楚，足腓坚硬，拘挛转筋者，为津液亏伤，筋脉失养。

见烦渴尿闭，面青肢冷，神识迷乱，声音嘶哑，六脉沉伏者，为气阴大亏，毒热内伏，病势危殆。

证析：暑湿秽浊，乱于肠胃，故胸脘闷乱，吐泻交作。中焦逆乱，清浊不分，水津随粪下趋，故初起泻下水粪，继则下如米泔水，不甚臭秽。毒热上蒸，故烦热头痛。吐泻伤津，毒热内炽，故口渴引饮，小便短黄。舌质红，苔黄腻，脉濡数，为暑湿蕴伏病征。由于来势凶险，最易伤津耗气而致病变顷刻：如津液亏伤，筋脉失润，毒热壅闭于经络，则见四肢酸楚，足腓坚硬，拘挛转筋；如吐泻不止，气随津耗，津亏则烦渴尿闭，气虚则面青肢冷，甚则神迷声哑，六脉沉伏，呈现虚极欲脱危候。

治法：清热化浊，安胃救逆。

主方：暑热内炽，烦闷口渴甚者，主以燃照汤①；湿热壅闭经络，足腓转筋者，主以蚕矢汤②；吐泻太甚，宜兼服急救回生丹③。如气阴已亏，现虚极欲脱病象，宜用生脉救中汤④扶正救脱，俟津回气复，再进调治方剂。如足腓拘挛转筋，痛楚难忍，可用手蘸白酒用力揉摩，或用蚕砂、食盐炒热入布囊热熨，多能缓解挛急减轻疼痛。

凡热霍乱口渴喜饮凉水者，宜以冷开水少少与之，如烦渴难忍，可尽量与之，任其随饮随吐，亦为借凉饮以解

毒热之法。

2. 寒霍

主证：初起呕吐下利，继则下利清稀，不甚臭秽，脘腹痞闷，腹痛或不痛，头痛身酸，四肢欠温，舌苔白腻，脉象沉缓。

见面色苍白，手足清冷，神疲懒言，唇舌淡白，脉象沉迟者，为中阳虚衰，重伤脾胃。

见眼眶凹陷，神识昏沉，肢体厥冷，唇面色青，拘挛转筋，脉沉欲绝者，为津亏阳微，虚极欲脱。

证析：寒湿秽浊，壅遏中焦，清浊不分，肠胃逆乱，故上吐下泻。寒邪偏盛，损伤脾阳，故下利清稀而不甚臭秽。寒邪挟食，阻滞中脘，故脘腹痞闷。寒甚气滞则腹痛，寒甚气虚则无痛。寒阻于外，荣卫失和，故头痛身酸。寒阻于内，中阳不能宣达，故四肢欠温。苔白腻，脉沉缓，均为寒湿困脾所致。由于寒性伤阳，吐下伤津，如吐泻过剧，或中阳败伤而见面白肢冷、神疲懒言、唇淡脉迟；或津亏阳微而见面青眼凹、神昏拘挛、肢体厥冷、脉沉欲绝。凡此皆有虚极欲脱趋势。

治法：温中散寒，和脾安胃。

主方：初起宜温中安胃，止呕止泻，主以治乱保安汤^⑤随证加减；中阳虚衰，宜于温中健脾，扶阳救逆，主以附子理中汤^⑥。如津亏阳微，危在顷刻，切忌骤与辛温大剂，虑其劫耗阴津，宜先与生脉救中汤益气保阴以防虚脱，俟津回气复，再进调治方剂。

凡寒性霍乱，如属吐泻重证，宜兼服卫生防疫宝丹^⑦以助温寒救逆之力。津亏阳微，已见肢体厥冷，神识昏

沉、脉沉欲绝危象者，可急用食盐填满脐中，上置生姜一片，取艾团置姜片上灸之，亦能取得温阳救脱良效。

（二）干霍乱

主证：起病急骤，卒然腹中绞痛，欲吐不得吐，欲泻不得泻，烦躁闷乱，难于忍受，甚则面色青惨，四肢厥冷，头汗如雨，六脉沉伏。

证析：暑湿秽浊之邪，闭阻中焦，肠胃壅塞，清者不升，浊者不降，上下不通，邪正交争，故腹中绞痛，欲吐不得，欲泻不能。阴阳闭格，邪热内壅，故烦闷难忍。阳气闭阻，不得宣通，故肢冷脉伏。面色青惨，头汗如雨，皆为烦乱腹痛所致。

治法：辟秽解毒，宣壅开闭。

主方：以玉枢丹^⑧为主方，取其辟秽解毒，开闭逐邪。吐泻已通，腹痛缓解，用连藿六一汤^⑨调理。

本病来势骤急，仓卒之间，汤药不及，可用盐汤探吐，并配合针刺委中、十宣出血以宣泄毒热。还可采用刮痧一法：用细口小瓷碗，碗口涂以菜油，先从背脊两旁自上而下刮之，次刮其胸胁，次刮其四肢内侧弯曲处，以刮处尽红为度，亦有助于流通血脉引邪外出。如腹痛剧烈，手足厥冷者，可用蚕砂、食盐炒热，盛入布囊，热熨脘腹、脐下及双足涌泉穴，也能取得温通阳气、减轻腹痛之效。

另外，由于霍乱一证，起病急，病变速，有时是寒是热，疑似难辨。试诊之法：以生黄豆一、二粒令患者细嚼之，如不知腥味，多属热证；以生姜一、二片令患者嚼之，如不知辣味，多属寒证。此一方法，可作临床参考。

三、方药化裁

1. 燃照汤（《霍乱论》）

滑石18克 香豉10克 焦栀子10克 黄芩10克 佩兰6克 厚朴10克 法半夏10克 白蔻仁3克（煎汤凉服）

此方清暑渗湿，和中止呕。适用于热霍乱烦闷脘痞，口渴尿少者。方以滑石清暑渗湿为全方之主。栀子、黄芩苦寒泄热；栀子、香豉同用，清热除烦。厚朴、半夏降逆止呕；佩兰、白蔻辛香化浊。是方寒温并用，寒以泄热，温以和中，清浊已分，吐下可止。

2. 蚕矢汤（《霍乱论》）

晚蚕砂15克 薏苡仁12克 大黄豆卷12克 木瓜10克 黄连6克 黄芩6克 焦栀子6克 法半夏10克 通草3克 炒吴茱萸3克（煎汤凉服）

此方清热和中，舒筋宣湿。适用于热霍乱吐下烦渴，肢体酸楚，足腓转筋者。方用黄芩、黄连、焦栀苦寒泄热；薏苡仁、通草、豆卷分利浊湿；半夏、吴茱萸和中止呕；蚕砂、木瓜舒筋宣湿，活络止痛。故本方以治霍乱转筋见优。

3. 急救回生丹（《衷中参西录》）

朱砂50克 冰片9克 薄荷冰6克 甘草30克

上药共研极细，每次3克，日服2~3次，温水送下，吐剧者宜于吐后送服。

此方凉热解毒，醒脑安胃。凡热性霍乱，吐下烦渴，闷乱转筋，肢体厥冷，六脉沉伏等证，皆可兼服本方，其

清心除烦、安胃救逆之效甚佳。

4. 生脉救中汤

人参10克 麦门冬15克 五味子10克 山药15克
茯苓15克 炙甘草6克 麝香0.1克

上方一剂，浓煎2次，去渣，入麝香调匀，徐徐喂服。服药后，身温脉出，即宜减去麝香。

此方益气保阴，扶危救脱。适用于霍乱吐泻，津亏阳微，神识昏沉，肢体厥冷，六脉沉微，甚或无脉者。方以人参大补元气；麦门冬补液生津；五味子益阴敛阳。辅以山药、茯苓、甘草健脾和中；佐麝香以开窍醒脑。凡霍乱吐泻日夜不休，津气衰竭，危在顷刻，此时因寒因热不可深究，惟宜本方扶危固脱，俟其身温脉出，危象缓解，再议调治方剂。

5. 治乱保安汤（《时病论》）

南藿香10克 台乌药10克 广木香10克 法半夏12克
白茯苓15克 茅苍术10克 缩砂仁6克 伏龙肝15克

此方理气和中，止呕止泻。适用于寒霍乱上吐下泻，脘痞腹痛者，方用藿香、半夏和胃止呕；砂仁、伏龙肝温中止泻；茯苓、苍术健脾燥湿；台乌、木香理气止痛。寒退气和，肠胃得安。

表寒偏盛，头痛身酸者，加白芷、荆芥疏表散寒。里寒偏盛，脘腹冷痛者，加良姜、吴茱萸温寒止痛。拘挛转筋者，加蚕砂、木瓜。

6. 附子理中汤

方药见第八章反胃篇第二方。

本方健脾益胃，温中扶阳。适用于霍乱吐泻，中阳已

虚,手足逆冷,舌淡脉迟者。拘挛转筋者,加吴茱萸、木瓜,以温寒通络。头汗肢冷,脉沉欲绝者,为虚极欲脱危象,加人参、麦门冬、五味子,以益气保阴,扶危固脱。

7. 卫生防疫宝丹 (《衷中参西录》)

粉甘草300克 北细辛45克 香白芷30克 薄荷冰12克 冰片6克 朱砂90克

上药分别研细,混匀,作为散剂,或制丸剂,每次3克,日服2~3次,温水送下,吐剧者宜于吐后送服。

此方较急救回生丹多细辛、白芷,其性温凉并用,重在温寒解毒,芳香化浊。用于寒性霍乱,上吐下泻,四肢厥冷,神识昏沉,六脉沉伏等证,尤具温寒安胃、开窍醒脑之功。

本方和急救回生丹,皆为张锡纯氏治时疫霍乱的经验良方。1940年夏季,吾乡霍乱流行,余按方制药,依据因寒因热,轻者单与是方送服,重者配合汤方施治,一般都能取得良好疗效。足见张氏此方,非常可贵。

8. 玉枢丹

方药见第八章噎膈篇第四方。

本方用治干霍乱证,取其宣壅泄浊,开闭逐邪。每用3克研细,生姜汤送下,服后得呕吐下利,壅闭已通,闷乱腹痛得以轻减。

9. 连藿六一汤

方药见第八章呕吐篇第二方。

本方清解暑热,和中安胃。适用于干霍乱吐泻已通,胃气不和,暑热未尽者。如腹中疼痛,舌黄苔腻者,为湿滞犹甚,加木香、佩兰,以理气化湿。如见口渴唇干,舌

红少津者,为胃阴不足,去半夏,加麦门冬、玉竹,以养胃生津。(表60)

表60

霍乱病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
夏秋之季,受暑食凉,饮食不洁,乱于肠胃,发生霍乱。肠胃逆乱,吐泻交作,是为湿霍,伤于暑热为热霍;伤于寒湿为寒霍。肠胃闭塞,闷乱腹痛,不得吐泻者,则为干霍乱	热霍乱	清热化浊 安胃救逆	燃照汤 蚕矢汤 急救回生丹 生脉救中汤
	寒霍乱	温中散寒 和脾安胃	治乱保安汤 附子理中汤 卫生防疫宝丹
	干霍乱	辟秽解毒 宣壅开闭	玉枢丹 连藿六一汤

第二节 泄 泻

泄与泻微有不同,泄指大便溏薄,其势轻缓;泻指大便如水样,势如倾注。所以,凡大便次数增多,粪便溏薄,甚或泻如水注者,统称泄泻。

本病《内经》名为“泄”,如《素问·宣明五气篇》说:“大肠小肠为泄。”《金匮要略》称为“下利”。宋代以后医籍,统称为泄泻。凡方书所称濡泄、飧泄、洞泄、暑泄、酒泄、食泄、溏泄、鹜泄、滑泄、胃泄、脾泄、肾泄等,都属于本病范围。

本篇分泄泻为暴泄、久泄二类:暴泄因于感受外邪、饮食所伤,多属实证;久泄因于脏腑虚衰,或暴泄失治,由实转虚,多属虚证,或虚中挟实。治疗大法,总以随其所因,调理脾胃,分别清浊为准则。

一、病因病机

胃为水谷之海,脾司运化,转输精微,小肠泌别清浊,清者渗利于前,下入膀胱为溺,浊者传导于后,下入大肠而为粪便。如因外感湿邪,饮食所伤,脏腑虚衰,导致脾胃功能失常,肠道清浊不分,水谷混杂并走大肠,即可发生泄泻。

(一) 外感因素

六淫之邪,导致泄泻发病,以感受风寒暑湿者为多见。脾居中焦,喜燥恶湿,喜暖畏凉。如贪凉饮冷,坐卧湿地,寒湿之邪,外袭肌表。内犯肠胃,致脾阳困阻,清浊不分,便成泄泻。如《素问·举痛论》说:“寒气客于小肠,小肠不得成聚,故后泄腹痛矣。”又如夏秋季节,暑湿交蒸,如酒食不节,口腹不慎,湿热之邪,内犯中州,热滞肠间,传化失常,遂成腹痛泄泻。

(二) 饮食因素

暴饮暴食,停滞肠胃;恣食肥甘,妨碍消化;过食生冷,损及脾阳;或误食馊腐不洁之物,伤于脾胃。凡此种种,都能使脾胃运化失常,以致水谷相混,并走大肠,发生泄泻。

(三) 内虚因素

内虚之泄,以脾虚为主因,多以新病暴泄,失于治疗,由实转虚,成为久泄。脾虚不能升运精微,或热邪隐伏,留滞肠间,或脾阳亏损,寒从内生,每多虚实并见。饮食适度则泄止,饮食不慎则泄作,往往累月经年,时泄时止。

由于因虚易泄，因泄愈虚，久之，又能损及肾阳，脾肾同虚。肾阳不足，命门火衰，火不温土，脾阳更虚，胃中水谷愈难消化，甚或发生滑泄不禁。

此外，因于感染痢虫，侵蚀肠间，形成肠痢久泄，与脾虚肠热之泄，颇相类似，亦为临床常见。

总的来说，泄泻之本，无不关系脾胃，外邪所犯，饮食所伤，脾失健运，水谷不分，造成湿盛，湿盛反困于脾，相互为因，故暴泄以湿盛为主，多见水泻。久泄伤脾，运化失司，饮食不慎，泄泻复发，故久泄以脾虚为主，多见时泻时止。

二、辨证施治

大便次数增多，一日三、五次至十数次或更多，粪便溏薄或如水样，是泄泻的主要见证，并随病因不同而见不同的兼夹证候。一般来说，新病暴泄，多属实证，慢性久泄，多属虚证。治实证以祛邪止泻为先，治虚证以扶正固本为主，分别病因与兼证的不同，采用疏解、分利、清热、消导、健脾、温中、升提、固涩诸法，或一法单行，或数法兼施，总以调理脾胃，分别清浊为基本大法。现分暴泄、久泄施治如下：

（一）暴泄

1. 寒湿泄泻

主证：下利清稀，腹痛肠鸣，脘闷暖气，恶寒发热，头痛身酸，苔白脉浮。

见泄下稀便，寒热头痛者，属表邪偏胜；见泄如水样，

小便短少，表证不甚明显者，属内湿偏胜。

证析：寒湿之邪，外袭肌表，内犯肠胃，内外合邪，困阻脾阳，清浊不分，故肠鸣泄泻。食滞肠胃，邪正交争，故腹痛而脘闷暖气。寒邪袭表，荣卫失畅，故恶寒发热，头痛身酸。苔白脉浮，为寒湿阻滞之象。内外合邪，各有偏胜，外寒为甚，则表证重而泄下轻；内湿为甚，则表邪轻而泄下重。

治法：散寒和中。

主方：表邪偏胜，宜疏表散寒，和胃宽中，主以藿香正气散①；内湿偏胜，宜温中燥脾，分利清浊，主以胃苓汤②。

2. 湿热泄泻

主证：腹痛即泄，粪色黄褐，或泻如水样，或粪中带有粘液，心烦口渴，小便短赤，舌质红，苔黄腻，脉滑数。

见烦渴热痛，泄带粘液者，为热胜于湿；见烦渴不甚，泄如水样者，为湿胜于热。

证析：湿热壅遏中焦，热迫肠间，传化失常，故腹痛即泄。热胜于湿，迫使肠中津液随粪而下，则见粪色黄褐，带有粘液。湿胜于热，清浊相混，并走大肠，则见泄如水样，甚或暴注下迫。热蒸于内，故心烦。津不上承，故口渴。水液下走肠间，不能尽从膀胱渗利，故小便短赤。舌质红，苔黄腻，脉滑数，均为湿热内盛病证。

治法：清热渗湿。

主方：用黄芩滑石汤③为主方。热胜于湿，重在清热；湿胜于热，重在分利，随证变化，分消湿热，泄泻自止。

3. 伤食泄泻

主证：肠鸣泄泻，脘腹胀痛，泻后痛减，泻下不爽，所泻粪便臭如败卵，暖气厌食，舌苔厚腻，脉象滑实。

证析：食阻肠胃，水谷不化，是以脘腹胀痛，肠鸣泄泻。宿食停滞，气机不顺，是以暖气厌食，泻下不爽。泻后宿食下行，故胀痛轻减。未化之物，淤积腐败，故泻下粪便臭如败卵。舌厚腻，脉滑实，为宿食停滞病象。

治法：消食导滞。

主方：用楂曲平胃汤^④为主方。如食滞较甚，酌加荡积之品，宿食消除，肠胃得安，泄泻自愈。

（二）久泄

1. 脾胃气虚

主证：大便时溇时泻，泻下粪便多未尽消化食物残渣，口淡食少，食后脘闷不舒，饮食节制则稍安，偶食油腻生冷则泻作，面色萎黄，神疲倦怠，舌淡苔白，脉象细缓。

证析：脾虚不能升运精微，胃弱难于腐熟水谷，故大便时溇时泻，泻下多未尽消化食物残渣。胃气虚弱，故口淡食少。脾运衰退，故食后脘闷。脾胃已虚，消化不及，是以饮食稍多、或偶食油腻生冷，即能发生泄泻。久泻不已，脾胃愈虚，生化气血之源不足，故面色萎黄，神疲倦怠。舌淡苔白，脉象细缓，为气血不足病证。

治法：健脾醒胃，益气温中。

主方：用香砂四君汤^⑤为主方。如脾虚偏寒，或气虚下陷，则宜佐以温中、升提治法。

2. 脾虚伏热

主证：肠鸣漉漉，大便常稀，腹中隐痛，泻后痛减，

偶食辛辣厚味，痛泻加剧，粪带粘液，久久不愈，食少口淡，舌红苔薄，脉多虚数。

证析：热泻失治，由实转虚，邪热隐伏，因成久泻。久泻脾虚，水谷不化，故肠鸣漉漉，大便常稀。热伏肠间，肠络失畅，故泻时腹痛，泻后痛减。每因口腹不慎，触及伏热，热迫肠道，传化失常，故痛泻并作，粪带粘液，甚则泻如水样。食少口淡，舌红苔薄，脉象虚数，为气虚伏热、虚实互见之象。此证极为常见，往往累月经年，久久不愈。

治法：健脾益胃，清化肠热。

主方：用参术鱼地汤^⑥为主方。脾虚为甚，重在健脾；肠热为甚，重在清热。总以健脾防助热，清热不害脾为原则。

3. 脾肾气虚

主证：黎明之前，腹中作痛，肠鸣即泻，泻后则安，腹部畏寒，下肢觉冷，时有腹胀肛坠之感，舌淡苔白，脉象沉细。

证析：肾为胃之关，主司二便，久泻不已，累及于肾，脾肾同虚。脾虚则运化失司，肾虚则关门不固，故泄泻多见于黎明之前，即所谓“阴盛阳衰”之际。肾气不足，故腹部畏寒，下肢觉冷。脾气虚陷，故时感腹胀肛坠。舌淡白，脉沉细，为脾肾气虚病象。

治法：健脾补肾，温中止泻。

主方：脾肾气虚，泄泻不甚者，治宜益气扶脾，温肾固肠，主以芪术四神汤^⑦；脾肾阳虚，完谷不化者，治宜暖肾扶阳，温中健脾，主以附子理中汤^⑧。

泄泻是临床常见的病种之一。一般泄泻初起，较易治疗，泄泻日久，调治较难。又因慢性久泄，每多寒热兼夹，虚实互见，过温则助热，过清则害脾，偏于补虚则碍实，偏于下实则愈虚。所以，治久泄须辨证准确，更须守法守方，调节饮食，坚持治疗，方能取得满意效果。

三、方药化裁

1. 藿香正气散

方药见第八章呕吐篇第一方。

本方疏表散寒，宽中和胃。适用于外感风寒，内伤湿滞，寒热头痛，脘腹痞满，恶心呕吐，肠鸣泄泻者。

无恶心呕吐者，去半夏；肢体酸痛者，加防风；脘痞为甚者，加山楂、枳壳。

2. 胃苓汤（《丹溪心法》）

苍术10克 厚朴15克 橘皮10克 甘草3克 白术10克 茯苓15克 猪苓15克 泽泻15克 肉桂3克

此方温中燥脾，分利清浊。适用于湿困脾阳，清浊不分，脘痞暖气，下利水粪，小便短少者。方以苍术、白术健脾燥湿；肉桂、白术同用，温中通阳；术得二苓、泽泻，能使湿从小便分利；术得厚朴、橘皮，能理气除满以和胃气。脾胃和，清浊分，泄泻自止。

3. 黄芩滑石汤

黄芩20克 白芍20克 滑石18克 甘草6克 南藿香10克

此方清热渗湿，和中止痛。适用于湿热壅迫肠间，腹

痛下泻，泻带粘液者。方用黄芩、滑石清肠热而利水道；白芍、甘草舒挛急而止腹痛；佐藿香利气机而宣湿浊。

热胜于湿，烦渴为甚，加黄连、知母，以清热除烦。湿胜于热，脘痞水泻，小便短少者，加茯苓、泽泻，以分利湿热。如兼脘痞食滞者，加山楂、麦芽，以消导积食。

4. 楂曲平胃汤

方药见第八章胃痛篇第一方。

本方消食导滞，和胃宽中。适用于宿食停滞，脘腹胀痛，肠鸣泄泻者。如脘腹痞塞，食滞较甚，加枳实、隔山消，以推荡食积。

5. 香砂四君汤

方药见第四章多寐篇第二方。

本方健脾益气，醒胃温中。适用于脾虚胃弱，大便时溇时泻者。方以人参、白术、茯苓、甘草健脾益气；砂仁、藿香醒胃温中。方药配合，补而不滞，温而不燥，理虚止泻，效果良佳。

脾虚偏寒，遇冷即泻者，加炮干姜3克，以温中散寒。久泻气陷，时觉虚胀肛坠者，加黄芪30克，以益气举陷。如食后脘痞，胃中呆滞者，加枳壳10克，鸡内金6克，以行滞化食。

一女病员，初因产后饮食不慎发生腹泻，后即大便常稀，饮食稍多或食油腻之物，必致泄泻发作。逐渐饮食减少，食后呆滞不化，一年以来，每日只能进食少量流汁食物。前医多用温补方药无显效。来诊时，形体极度消瘦，月经停闭半年，面色萎黄，唇舌白淡，六脉细弱如丝，大便溇薄量少，行动即觉腹胀肛坠。此属久泻脾虚，胃气衰

败。虚羸之疾，大补已难胜任，温阳反害其阴，先宜平补脾胃，理虚止泻。投以香砂四君汤加黄芪、炒枳壳、鸡内金，令煎汤少量缓服。患者进药一月，肛坠消除，大便转干，间日一次，已能进食软食。因胃口初开，久服汤药易于伤胃，为拟枳术鸡砂散（枳壳50克，白术100克，丹参50克，郁金50克，鸡内金30克，砂仁30克，制粉剂，每服3克，日服2~3次），令常服调理。服药期间，偶因泄泻反复，再进前方汤剂治疗，泻止仍服粉剂。如此调治一年，月经已通，体重恢复，病得痊愈。由此可见，凡以脾虚为主因的肠胃疾病，但治其脾，则仓廪固而气血旺。反之，着眼于虚，妄施温补，实非所宜。

6. 参术鱼地汤

太子参24克 白术15克 茯苓15克 枳壳12克 鱼腥草30克 生地榆20克 南藿香6克 炒谷芽24克

此方健脾清肠，和中理气。适用于久泻脾虚，肠中伏热，脘痞肠鸣，腹痛下泻，粪带粘液者。方用太子参、白术、茯苓培健脾气，以扶其虚；鱼腥草、地榆清化肠热，以去其实；辅以枳壳、藿香、谷芽和胃开痞，以升发胃气。方药配合，虚实兼行，补脾不助热，清热不害胃。

如食少泻多，腹痛不甚者，属脾气偏虚，加黄芪24克，砂仁3克，以扶补脾气，温中止泻。如泻而能食，腹痛多于腹泻，泻下粘液量多者，属肠热偏胜，加黄连3克，木香6克，以清化肠热，理气止痛。如兼腹部畏寒，遇冷即泻，此属久泻脾虚，寒热并见，加炮干姜3克，以两解寒热。

本方用于治疗肠痹泄泻，亦有良效。

一李姓病员，患腹痛腹泻已3年，其病时轻时重，日

泻2~3次或4~5次不等，无痢疾史，多次粪检均见红白细胞少量，或偶见脓球。西医诊断：慢性肠炎，肠功能紊乱。经中西药治疗，服西药抗菌素，服药则泻止，停药则泻作，服中药数百剂无显效。初诊：体瘦能食，肠鸣腹泻，日泻3~4次，泻前腹痛，泻下不爽，粪带粘液，舌苔薄黄微腻，脉细略数。此属久泻脾虚，肠中伏热，热胜于虚。检视前医诸方，或偏于补而用参芪苓术姜桂等品；或偏于清而用香连丸、芍药汤、白头翁汤诸方。补之腹胀腹痛加剧，清之则肠鸣泻下增多。余投以参术鱼地汤加黄连3克，砂仁3克，令日尽1剂，连服2周。嘱停用西药，暂忌辛辣食物。二诊：肠鸣腹痛减轻，大便日泻2次，粪检白细胞少量，按原方减去黄连，加山楂15克，令再服2周。三诊：大便转干，日泻1次，苔黄已退，便前尚有轻微腹痛，粪检正常，仍照原方日服2次，连服1月以巩固疗效。停药后，偶因口腹不慎，复作泄泻，再进前方2~3剂，便能止泻复常。由此说明，凡脾虚肠热之泻，关键在于衡量虚实多少，针对病情两调虚实，偏清偏补，或虽已虚实兼顾而药量配伍失当，均难取效。

7. 芪术四神汤

黄芪30克 白术15克 茯苓15克 补骨脂10克 五味子6克 肉豆蔻6克 吴茱萸3克 生姜1薄片 大枣4枚

此方益气扶脾，温肾固肠。适用于脾肾气虚，黎明泻泄（又称五更泄），腹部畏寒，肠鸣腹痛，气陷肛坠者。方以古方四神丸加味组成，功能温肾暖脾，益气固肠。四神丸温肾止泻，而以善治肾虚泄泻著称，惟肾泄多因脾虚日久而成，辅以黄芪、茯苓、白术脾肾同治，使火旺土强，

更能止泻。尤须指出，脾虚肠热之泄，于静止期亦多表现黎明腹痛而泻的证候。对此，应注意辨别，不可混同施治。

8. 附子理中汤

方药见第八章反胃篇第二方。

本方暖肾扶阳，温中健脾。适用于虚寒泄泻，腹中冷痛，下利完谷，肢冷脉沉者。方药配合，脾肾两补，温阳安中。惟药性温烈，不可过剂，见手足已温，泄泻稍止，应改用健脾醒胃方剂调治。如肾虚为甚者，宜与芪术四神汤；脾虚为甚者，则与香砂四君汤。（表61）

表61 泄泻病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
暴泄	外感风寒暑湿之邪，或过食油腻生冷之物，脾为湿困，清浊不分，食滞肠胃，水谷不化，发生泄泻	寒湿泄	散寒和中	藿香正气散 胃苓汤
		湿热泄	清热渗湿	黄芩滑石汤
		伤食泄	消食导滞	楂曲平胃汤
久泄	暴泄失治，由实转虚，或脾虚伏热，或脾虚中寒，或脾肾同虚，时泻时止，成为久泻	脾胃气虚	健脾温中	香砂四君汤
		脾虚伏热	健脾清肠	参术鱼地汤
		脾肾气虚	健脾温肾	芪术四神汤 附子理中汤

第三节 痢 疾

痢疾是夏秋季常见的消化道传染病之一。腹痛，里急后重，滞下不爽，下痢赤白脓血，为本病的主要特征。

本病《内经》称为“肠澼”。如《素问·通评虚实论》说：“肠澼下血。”《金匱要略》统称“下利”，如说：“热利下重者，白头翁汤主之”；“下利便脓血者，桃花汤主之”。晋代《肘后方》提出：“天行毒病，挟热腹痛下痢。”由此明确了本病的传染性，并确立了下痢的病名。刘宗厚《玉机微义》更明确指出：“时疫作痢，一家一方之内，上下传染，是疫毒痢也。”由于本病有轻重久暂的不同，证候表现各不一致，所以方书中又有赤白痢、血痢、白痢、滞下、重下、噤口痢、久痢、休息痢等名称的记载。本篇分湿热痢、疫毒痢、噤口痢、休息痢四类证候论述。

本病与泄泻的鉴别：泄泻四时可见，痢疾常见于夏秋季节。痢疾之泻，里急后重，滞下不爽，下痢脓血，赤白相杂，或如白脓杂有薄血；泄泻之泻，腹痛即泻，水粪俱下，或带粘液而无脓血。

一、病因病机

夏秋季节，暑湿盛行，滋生疫毒，如因热求凉，口啖生冷污染饮食，致疫毒侵入肠胃，壅滞肠间，邪毒与气血交相搏结，肠络溃腐，化为脓血，剥迫而下，发生下痢。

《医宗必读》指出：“痢起夏秋，热蒸湿郁，本乎天也；因热求凉，过食生冷，由于人也。”由此说明，暑湿郁蒸，是疫痢传染流行的条件；口啖污染食物，才是痢疾发病的主要原因。本病如因互相传染，即可在一个地区先后续发，而致引起散在性流行。

痢疾受病于大肠,邪毒与气血交相搏结,肠气壅阻,欲通难通,是以里急后重,滞下不爽。热伤肠络,化为脓腐,剥迫而下,是以腹中疼痛,下痢脓血。气分偏伤,剥迫肠液,白多于赤,则为白痢;血分偏伤,迫及肠络,赤多于白,则为赤痢;气血俱伤,脓血俱下,赤白相兼,则为赤白痢。毒热极盛,肠络大伤,来势暴急,痢下鲜紫,病情险恶者,是为疫毒痢。毒热蕴积,上攻于胃,痢下而不能进食者,是为噤口痢。初痢失治,迁延日久,脾气已虚,邪留不去,时发时止者,是为休息痢。

总的来说,痢疾病机可区别为急性与慢性二类:湿热痢、疫毒痢、噤口痢均为痢疾急性期所表现的轻重不同证候。急性期失于治疗,由实转虚,邪留不去,则成慢性久痢。久痢不愈,反复发作,往往耗散津血,损伤脾胃,导致形体衰惫。故痢疾在急性期的治疗,是十分重要的。

二、辨证施治

痢疾起病,轻重不一,轻者仅见腹痛腹泻,重者伴有寒热头痛表证。腹泻开始,泻下稀粪或如水样,随即出现里急后重,滞下不爽,每次痢下少量脓血粘液,一日七八次或二、三十次不等。一般以湿热痢为多见;疫毒痢为痢疾重证,来势急,病势险;初痢噤口,多因胃中积滞,久痢噤口,多因胃气衰败。休息痢皆由痢久失治转变而成。至于虚实之辨,一般来说,初痢属实,久痢兼虚;又因痢下不休,耗伤脾气,故初痢亦能致虚。因此,本病的虚实,必须针对病情,切勿拘泥初痢无虚之说。

治痢以清火导滞,和调气血为基本大法。清火即可消除毒热,导滞即可推荡积秽,故治痢始终以清火导滞为主。里急后重,因于肠气阻滞,调气则后重可除;痢下脓血,因于肠络瘀腐,和血则便脓自愈;故治痢必须着重和调气血。同时针对寒热虚实偏甚,热者凉之,实者荡之,寒者温之,虚者补之,逆者降之,瘀者行之,陷者升之,脱者固之,以清法为主,或虚实兼行,或寒热并施,总以始终顾及胃气为要务。

凡治痢疾,虽见寒热表证,不可发汗;虽见小便短赤,切忌利尿;虽见滞下难通,不可妄用芒硝、大黄。但以清肠治痢为主,毒热消除,寒热自退,小便自清,大便自通,否则耗伤津液,滞涩愈甚。又因痢下不休,亏损津液,多见口中干渴,切勿因其口渴妄用石膏、知母,以防败伤胃气。更不可因其利下不休,而妄施收敛固涩方药,以防留邪遗患。

(一) 湿热痢

主证:起病较急,开始可见恶寒、发热、头痛,随即腹痛腹泻,里急后重,一日泻下十余次至数十次不等,大便先为稀粪或水粪,粪量较少,泻下不畅,后即每次排出纯为脓血,量少粘稠,赤白相兼,小便短赤,舌苔黄腻,脉多滑数。

证析:湿热邪毒蕴积肠间,热蒸于外,荣卫失和,故寒热头痛。肠气阻滞,传导失常,故腹痛而泻下不畅。毒热攻迫,欲便难通,故里急后重。肠络瘀腐,剥迫而下,故痢下脓血,赤白相兼。毒轻则病轻,毒重则病重,是以痢下次数的多少,正是判断毒热轻重的标志。尿短赤,苔

黄腻，脉滑数，均为湿热积滞病证。

治法：清热导滞，和调气血。

主方：用香连化滞汤①为主方。依据病情轻重，赤白多少，体质强弱，随证加味。

（二）疫毒痢

主证：起病暴急，开始见壮热口渴，烦躁不安，随即腹痛腹泻，腹痛窘迫，里急异常，痢下脓血，或下纯血，其色鲜紫，日夜数十行，甚者可见神昏惊厥，舌质红绛，脉象洪数。

如见神识昏沉，面青肢冷，脉见沉数或沉伏者，此为毒热内陷，病势危急。

证析：毒热极盛，充斥肠间，故起病暴急。肠络大伤，故泻下脓血鲜紫，或下纯血。疫毒壅积，肠气窘迫，故日夜痢下数十行，腹痛里急异于寻常。热盛于内，故壮热。热盛伤津，故口渴。热犯神舍，则烦躁不安，甚则可见神昏惊厥。舌红绛，脉洪数，为毒热内燔伤及荣阴之象。如出现神昏肢冷，脉象沉伏，则属热毒内陷，热深厥深，主病势危急。

治法：清热解毒，凉血止血。

主方：用加味白头翁汤②为主方，依据病情加减化裁。如见壮热神昏，可兼用紫雪丹③清心开窍。热退神清，痢下不止者，可按湿热痢治法调理。

由于本病来势急，变化速，治不及时，常可危及生命。对此，必须把握病机及时治疗，不必拘泥一方一法。

（三）噤口痢

主证：以痢下不能进食为主证。初痢不食，伴胸脘胀

满,暖气呕恶,苔黄腻,脉滑数有力者,属实证;痢下日久,饮食不进,伴恶心呕吐,神倦体瘦,舌淡苔腻,脉濡数或虚弱者,属虚证。

证析:初痢噤口,常因宿食停滞,肠热上攻,故胸脘胀满不能进食。食滞于胃,胃失和降,故暖气呕恶。苔黄腻,脉滑数有力,为实热病证。久痢噤口,常因痢下不休,败伤胃气,胃虚则输化无权,故不能食。肠热上攻,胃失和降,故恶心呕吐。神倦体瘦,舌淡苔腻,脉虚数,均为胃气大伤,内蕴毒热,虚实并见之象。

治法:清热开噤,和胃降逆。

主方:用藿香开噤汤④为主方;依据虚实偏胜,病情轻重,增减化裁。噤口已开,胃气已和,痢下未止,仍按痢疾病情继续治疗。

(四) 休息痢

主证:泻痢日久,累月经年,时发时止,时轻时重,寒热有节,饮食适度,泻痢休止,遇冷遇热,口腹不慎,泻痢发作。发时里急后重,便如胶冻,或红或白,或赤白相杂,状如脓涕,反复发作,日久难愈,伴倦怠食少,形瘦怯冷,舌淡苔腻,脉沉细或缓弱。

证析:初痢失治,迁延日久,脾气亏虚,邪留不去,隐伏肠间,成为久痢。生活有节则稍安,生活不慎,触及肠热,其病复发,故时发时止,缠绵不愈。肠毒未去,故里急后重、便如脓涕,或红或白。脾气已虚,故倦怠食少。气血耗伤,故形瘦怯冷。舌淡苔腻,脉沉细缓弱,与上列诸证并见,均属虚实寒热夹杂的病象。

治法:益气运脾,和胃化滞。

主方：用参术鱼地汤^⑤加马齿苋为主方，依据虚实寒热轻重不同，随证加减。如久痢缠绵，诸方无效者，可兼用至圣丹^⑥。

本病常虚实互见，治宜清补兼施，但须防止清热害脾，补虚助热，故大温大补大清方药均非所宜。

关于痢疾的预后：大抵身不发热者轻，发热者重；能食者轻，不能食者重；痢下有粪者轻，无粪者重；痢下五色胶冻，或如鱼脑，或如猪肝者重；痢下纯血，或如屋漏水者危。不过，仍当全面观察，不可执一而论。

三、方药化裁

1. 香连化滞汤

黄连10克 广木香10克 马齿苋30克（鲜品加倍）
白芍20克 南藿香10克

此方清热化浊，调气行滞。适用于湿热痢下痢赤白，里急后重，舌黄腻，脉滑数者。方中黄连、马齿苋清除肠热，以解痢毒；木香、白芍调气舒挛，以行积滞；藿香芳香和中，以化湿浊。清肠则便脓可止，调气则后重自愈。

初起兼有寒热者，加金银花、连翘，以清解毒热。痢下白多于赤者，加鱼腥草，以清气分之热。赤多于白者，加地榆，以清血分之热。如兼食滞而见脘痞暖气者，加山楂、枳实，以消食行滞。如见小便短赤涩痛，非清利不可者，加滑石，小便通利即应减去。

如平素体虚，或老年体衰，因痢下不休而见气短难支者，可用人参6克，另煎呷服，亦能取得振作元气、缓和

痢下功能。但须适可而止，不可过量，以防堵塞毒邪。

2. 加味白头翁汤

白头翁15克 黄柏15克 黄连10克 秦皮15克 白芍18克 生地榆15克

此方清热解毒，凉血止痢。适用于疫毒痢下痢鲜紫，或下纯血，腹痛窘迫者。《伤寒论》白头翁汤治毒热内盛，深陷肠络，痢下纯血，最为得力。方中加地榆、白芍，其凉血止痢、舒挛缓急功效更优。

如见壮热烦渴，加金银花、连翘、玄参、花粉等品，以助清热解毒，生津除烦。

如见痢下无度，体弱难支，亦可用人参另煎呷服，以振作元气，减缓泻痢。

3. 紫雪丹

方药见第三章厥证篇第九方。

本方用于疫毒痢壮热谵语，甚或神昏惊厥之证，取其凉热镇惊、清心开窍，以缓解病势。如见脉来沉弱，呼吸微弱，面青肢冷者，此为邪热内陷，伤及元气，可用人参、五味子、麦门冬煎汤送服，使其扶持元气以解毒热。俟热退神清，危象已解，仍按治痢方法调治。

4. 藿香开噤汤

南藿香10克 黄连6克 甜石莲子10克 枳壳12克 鲜荷叶0.5张 陈仓米（炒焦）1撮

此方清热开噤，和胃降逆。适用于痢下不食，恶心呕吐，胸脘痞胀，其证属实者。方以藿香和中止呕；黄连、石莲清除肠热；枳壳、陈仓米养胃消痞；佐荷叶之清香，以宣发胃气。热降胃和，口噤自开。

如兼呕吐者，加半夏、生姜，以降逆止呕。如兼食滞者，加山楂、隔山消，消食行滞。如兼口中干渴，舌质红绛少津，脉来细数者，此属胃阴亏伤，加明沙参、山药、麦门冬、玉竹等品，以益胃生津。

如兼气短神倦，呕恶不食，甚或绝粒不能进口，舌淡脉弱者，此属胃气大伤，加人参、麦门冬，益气生津，以防胃气衰败。

5. 参术鱼地汤

方药见第八章泄泻篇第六方。

本方加马齿苋30克（鲜品加倍），功能益气扶脾，清肠止痢。适用于久痢脾虚，日久不愈，时发时止者。方以太子参、白术、茯苓、枳实健脾和胃；鱼腥草、地榆与马齿苋配合，更能清化肠热，凉血止痢。是方虚实兼顾，补虚不碍实，清热不害胃，余屡用之，其效颇佳。

如食少泻多，腹痛不甚者，属脾气偏虚，宜加缩砂仁，以助温中运脾。如泻而能食，腹痛为甚，或遇辛辣食物泻痢即发者，属肠热偏甚，加黄连、白芍，以助清热缓急。如气短神倦，痢下肛坠者，属脾虚气陷，加黄芪，以益气举陷。

凡用本方，切勿因泻痢暂止间断服药，须视病情轻重持续治疗1~2月，否则易于反复，终难治愈。

6. 至圣丹（《幼幼集成》）

鸦胆子一味（轻轻锤破，去其外壳）

成人每次量，鸦胆子15粒，用桂圆肉包裹（每包三四粒，搓成圆形，以能吞下为度），一日2次，早晚空胃吞服，连服一周，未愈，停药两三天，再服一周。

此方清肠治痢，一物单行，功专效宏。方用桂圆肉包裹吞服，正欲其直下肠间以除痢毒。陈复正氏谓本方：“冷痢久痢，百方无验者，一服即愈。”张山雷氏还说，本方“不但善治血痢，凡诸痢疾皆可用之，即纯白痢用之亦效。”实践证明，此方对菌痢、阿米巴痢均有很好的疗效。（表62）

表62

痢疾病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
夏秋季节，因热求凉，口 啖生冷不洁饮食，痢毒侵入 肠胃，壅滞肠间，肠络瘀腐， 化为脓血，剥迫而下，致成 痢疾	湿热痢	清热导滞 调气和血	香连化滞汤
	疫毒痢	清热解毒 凉血止血	加味白头翁汤 紫雪丹
	噤口痢	清热开噤 和胃降逆	藿香开噤汤
	休息痢	益气运脾 和胃化滞	参术鱼地汤 至圣丹

第四节 肠 痛

肠痛是肠内发生肿痛的一种疾病，《金匱·疮痍肠痈浸淫病脉证并治篇》对肠痛证候、治法均已作了论述；后世医籍如《疡医心得》又有大肠痈、小肠痈的分别。即腹痛现右脚曲而不伸者，为大肠痈；腹痛现左脚曲而不伸者，为小肠痈。因之，本病又名缩脚肠痈。

据临床所见，肠痈好发于阑肠部位，阑肠位于右下腹部，所以肠痈发病，常以右下腹持续疼痛，右脚蹠曲则痛缓，伸直则痛剧为本病特征。

一、病因病机

阑肠居于小肠、大肠连接部分,《难经·四十四难》称为阑门,位于腹腔内右下腹部,具有分阑水谷、泌别清浊功能。由胃传入小肠的水谷,经消化之后,下达阑肠,再经泌别,清者渗利于前,入膀胱为溺,浊者传导于后,归大肠为粪。如大小肠间分阑水谷转输不利,便能导致阑肠部清浊蕴积,瘀腐化脓,发生肠痈。导致的原因,大抵与饮食、劳伤关系密切。

(一) 饮食因素

凡暴饮暴食,嗜食辛辣油腻或生冷食物,尤以过饥过饱,担负重物,最易导致食滞肠间,阻碍传化,久则气血瘀凝,蕴积生热,热蒸肉腐,发生痈脓。如《冯氏锦囊》说:“肠痈是膏粱积热所致。”《外科正宗》也说:“饥饱劳伤,负担重物,……或生冷并进,气血乖违,湿动痰生,多致肠胃痞塞,运化不通,气血凝滞而成。”由此可见,本病与饮食的关系,颇为密切。

(二) 劳伤因素

凡强力负重,暴急奔走,跌仆损伤,孕妇产前产后,均能导致肠络瘀滞,肠内传导不得舒利,久则蕴积化热,聚腐成痈。如《外科医镜》说:“登高蹲下,跳踯挫跌,致瘀血凝阻肠中,而成肠痈。”《外科正宗》也说:“暴急奔走,以致肠胃传送不能输利,败血浊气壅遏而成。”妇女肠痈发生于产前,多因胎气阻遏肠络,发生于产后者,常与产中用力,损伤肠络有关。所以,《外科正宗》说:

“妇人孕育败瘀，或坐草艰难，用力太过，以致败血停积，结滞而成。”由此可见，凡能引起肠络瘀滞的一切因素，都能导致肠痈发病。

总之，饮食停积，肠络瘀滞，常常是互为因果的，食滞则络瘀，络瘀则传化不行，从而清浊相混，积湿蕴热，热蒸肉腐，变生痈脓。

二、辨证施治

肠痈起病，先觉脐周疼痛逐渐加剧，可见恶心呕吐，随即疼痛移向右下腹，现持续性疼痛，或阵发性疼痛。疼痛拒按，腹皮紧急，转侧不便，右脚喜蹠曲，牵引之，则疼痛加剧。伴有恶寒发热，大便不畅，或粪便夹有脓血。

本病应分初起、成脓、破溃三个阶段，在病程中，对舌、脉的诊断甚为重要。如舌苔薄腻转厚腻，或舌苔微黄转黄糙，脉微数转洪弦滑数者，多为痈肿向成脓发展的趋势；反之，舌苔黄腻渐次退化，脉数渐次转缓，多为痈脓渐趋内消的证象。若身热渐退，粪便中时下脓血，则为痈脓溃破的主要病证。在治疗上，以去瘀散结、泄热消痈为基本法则，依据各个阶段不同情况，分别施治。

（一）肠痈初期

主证：腹痛阵作，初为绕脐疼痛，随即转为右下腹持续作痛，按之痛剧，腹皮微急，右脚常喜蹠曲，发热恶寒，恶心呕吐，大便不爽，或秘结难通，舌苔薄腻而黄，脉紧数有力。

证析：肠痈初期，痈脓未成，肠中积热，肠络瘀滞，

故腹痛阵作。阑肠居右下腹，为肠痈好发部位，故疼痛限于右下腹部。痈肿因热，属于实证，故其痛拒按。瘀热内聚，邪正交争，荣卫失和，故恶寒发热。肠热蒸腾，胃失和降，故恶心呕吐。肠中积滞，传化不行，轻者大便失畅，重者秘结难通。舌薄腻而黄，脉紧数有力，均为痈肿初期，肠内积热，尚未成脓之象。

治法：去瘀荡积，泄热解毒。

主方：用红藤桃仁煎^①为主方；依据毒热微甚，积滞轻重，加减化裁。

本病在初期阶段，趁其痈脓未成，及时治疗，效果最佳。

（二）痈脓已成

主证：腹痛持续，更加痛剧，腹皮紧急，拒按，右下腹可触及肿块，身热不退，或壮热出汗，小便短赤，舌苔黄厚而腻，脉象洪数。

证析：毒热蕴积，蒸腐化脓，故腹痛加剧，腹皮更加紧急，并可在右下腹触及成脓肿块。身热不退，或壮热汗出，舌苔薄腻转为黄厚，脉紧数转为洪数，均为实热蒸腾、脓毒内蕴的病证。

治法：清热解毒，散瘀消痈。

主方：用加减清肠饮^②为主方；切忌攻下方药，防止损伤肠络，导致病情恶变。

（三）痈脓溃破

主证：腹痛轻缓，腹皮软濡，大便时下脓血秽浊，身热减退，或有微热，舌苔薄腻微黄，脉象缓濡。

如腹痛未除，按之较软，大便无明显脓血秽浊，身无

大热，神疲食少，脉现细弱者，此为脓成正虚、日久不溃。

证析：腹皮软濡，时下脓血，为肠痈已溃病证。脓有出路，毒热消散，故腹痛轻缓，身热减退。舌苔薄腻微黄，脉象缓濡，属脓毒未清、气血已虚之象；也有脓成正虚，日久不溃的。故本病后期，无论已溃未溃，每多虚实互见。

治法：益气托毒，消痈排脓。

主方：用黄芪托毒汤^③为主方；本方重在扶正排脓，如体气不虚，仍宜继用加减清肠饮以清热消痈。

肠痈预后：腹痛不甚，六脉微缓，无寒热者轻；小腹肿硬，六脉洪数，壮热持续者重；大便时下脓血，日夜无度，腹痛不减，身热更甚者险。

本病在初期阶段，应注意与疝证、蛔虫腹痛鉴别。

三、方药化裁

1. 红藤桃仁煎

红藤30克 丹皮10克 桃仁10克 紫花地丁15克
连翘15克 冬瓜仁15克 白芍15克 郁李仁15克

此方去瘀荡积，泄热解毒。适用于肠痈初期，腹痛拒按，大便不爽，恶寒发热者。方中红藤消痈散结，为治肠痈主药。丹皮、桃仁凉血行瘀；紫花地丁、连翘清热解毒；冬瓜仁、郁李仁、白芍舒挛荡积。合用而成泄热荡积去瘀消痈之功。

如毒热为甚者，加黄芩20克，以清泄内热。如大便秘结不通者，可用生大黄6~10克，另煎加入汤剂进服1~2

次，既可推荡肠中积滞，亦能清泄毒热。但以得大便通下为度，不可过剂，恐因峻下损伤肠络。

2. 加减清肠饮

金银花24克 玄参15克 黄芩15克 生地榆15克
红藤24克 蒲公英15克 全瓜蒌15克 白芍15克 甘草6克

此方即《疡医大全》清肠饮加减而成，功能散瘀消痈，清热排脓。适用于肠痈痈脓已成，右下腹触及肿块，痛而拒按，身热出汗者。方用金银花、玄参、黄芩、蒲公英清解毒热，以消脓肿；地榆、红藤清热凉血，散瘀消痈；瓜蒌利气排脓；白芍、甘草舒挛缓急。

本方与红藤桃仁煎相较，彼以痈脓未成，尚可通下，重在通瘀荡积，消散痈肿；此以痈脓已成，不可攻下，重在清解毒热，促使痈脓内消。

3. 黄芪托毒汤

黄芪30克 明沙参20克 山药15克 薏苡仁15克
红藤24克 生地榆20克 鱼腥草30克 败酱草30克 甘草6克

此方益气运脾，托毒排脓。适用于肠痈破溃，正气亏虚，时下脓血，身无大热者。方用黄芪、沙参益气生津，扶持元气；红藤、薏苡仁清热行瘀，消除结滞；地榆、鱼腥草、败酱草清热凉血，消解脓毒；山药、甘草和中运脾，以利排脓。是方用于脓成体虚，日久不溃者，亦具扶正托里、消散痈脓之功。（表63）

表68

肠痈病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
饮食停滞，劳伤肠络，食滞络瘀，聚湿蕴热，热蒸肉腐，变生痈脓，发生肠痈	痈脓未成	泄热荡积	红藤桃仁煎
	痈脓已成	清热消痈	加减清肠饮
	脓溃正虚	扶正排脓	黄芪托毒汤

第五节 便秘

大便秘结不通，排便时间延长，或欲便而艰涩不畅者，称为便秘。《素问·至真要大论》称为大便难；《伤寒论》称为脾约。

便秘在方书中有风秘、寒秘、气秘、热秘、湿秘及风燥、热燥、阳结、阴结的区分，因立名太烦，难得其要。本篇以临床常见习惯性便秘为主并区别为实秘、虚秘二类。至于其他疾病所兼见的便秘，应从原发疾病论治，不在本篇论述。

一、病因病机

大肠位居下焦，主司传导糟粕，排泄大便，肠气流畅，津血充润，则大便通调，否则传导失常，排便艰涩。肺主气，肺与大肠相表里，肺气不降，则传导不行。肾藏精，肾与大肠并居下焦，肾精不足，不得润养，则肠脏干涩。脾居中焦，输布精微，主司升降，脾不升运，则浊气不降。由此可见，便秘一证，虽属大肠传导功能失常的病变，实

与肺、脾、肾三者关系密切。导致的原因，有多种方面，大要言之，可分如下诸端：

燥热内盛，耗伤津液。凡阳盛之体，偏嗜辛辣脂膩厚味，致肠中积热，暗耗津液，津伤则肠燥，燥热互结，故大便干涩。如《张氏医通》说：“辛热厚味，渐渍助火，耗散真阴，津液亏少，故令大便结燥。”《伤寒论》所说“脾约”便坚，也因肠胃积热，耗及脾阴，脾阴不足，无以输津下润，所以大便干结，难于排泄。

忧思少动，肠气郁滞。脾主思，思则气结，忧则气郁，故凡思虑过度、情绪忧郁、久坐少动之人，往往脾气不得宣畅，脾郁则肠胃气滞，通降失调，是以大便秘结。正如《证因脉治》所说：“忧愁思虑，诸气怫郁，则气壅大肠而大便乃结。”

气血不足，传导不行。凡劳倦内伤，发汗利尿，产后亡血，病后津气未复，老年气血亏虚，都能累及肠道传导功能发生便秘。肺脾气虚，可致肠道传送无力，欲便难通；津亏血虚，能使肠脏失润，排便艰涩。如果病及于肾，则如《金匱翼》所说：“下焦阳虚则阳气不行，阳气不行则不能传送而阴凝于下；下焦阴虚则精血枯燥，精血枯燥则津液不到而肠脏干槁。”由此可见，凡气血津液亏损，都能发生排便困难。甚则秘结不通。

阴寒凝滞，肠道艰涩。素体阳虚，或高年体衰之人，真阳虚亏，不能蒸运津液，温润肠道，凝阴固结，留滞肠中，因而阳气不通，津液不行，肠脏艰于传送，病为冷秘。此即朱丹溪所说：“虚人脏冷而血脉枯，老人脏寒而气道涩，此大肠之挟冷然也。”说明冷秘一证，实则因于阳

虚。

总之，肠气不畅，津血不足，是导致便秘的主要病机，并与其人素体因素、生活习惯关系密切。另有平素未能养成定时排便习惯，也是造成便秘的原因之一。所以，便秘的发生，不可完全指为病态，如在生活上注意劳逸适度，饮食有节，排便定时，实为防治便秘的有效措施。

二、辨证施治

便秘的表现，排便时间延长，三五天或更久排便一次，粪质干燥坚硬，排出困难。有的粪便并非干燥，但排泄不畅，或努挣乏力，难于顺利排出。有些患者，除便秘外，无其他兼证可见；另一些患者，则伴有头昏头痛，腹中胀满，脘闷食少，睡眠不安等证。也有一些因长期便秘而致发生痔疮、或肛门裂伤者。在治疗方面，切忌采用单纯的攻下方法，因攻下耗伤肠液，往往愈下愈秘，这是必须注意的。现分实秘、虚秘论治如下：

（一）实秘

1. 燥热内结

主证：大便干燥，艰涩难下，腹胀口臭，或唇舌生疮，小便短黄，舌质红，苔黄燥，脉滑有力。

证析：肠中积热，耗伤津液，故大便干结。燥屎内停，故腹中胀满。浊气不降，燥热内蒸，故口臭口疮。热移膀胱，故小便短黄。舌质红，苔黄燥，主积热伤津，脉滑有力，主阳明里实。

治法：润肠通便。

主方：用麻子仁丸^①为主方。本方通润缓泄，肠道润，腑气通，便秘可愈。

2. 气滞不行

主证：脘腹痞满，暖气食少，矢气不畅，粪非干结，欲便不得，舌苔薄腻，脉弦滑或沉弦。

证析：忧思少动，脾气郁结，肠气壅滞，故脘腹痞满，暖气食少。气滞则通降失调，故矢气不畅。气滞则传导不行，故粪非干结而欲便不得。因非燥热，故苔现薄腻；因属气滞，故脉现沉弦或弦滑。

治法：宽中行滞。

主方：用瓜蒌仁汤^②为主方。此类便秘，只宜顺气，不可攻下，故本方重在快气通肠，气顺则大便自通。

(二) 虚秘

1. 血虚肠燥

主证：大便燥结，努挣难下，头晕心悸，面色少华，口咽干燥，舌嫩红，苔花剥，脉弦细。

证析：阴血亏虚，不为下润肠道，故大便燥结；不为上润咽喉，故口咽干燥。血虚不能奉养于心，则心悸；头目失养，则头眩；不为荣泽肌肤，则面色少华。舌嫩红，苔花剥，脉弦细，皆为津血亏少病证。

治法：养血润燥。

主方：用当归郁李仁汤^③为主方。本方养血润肠，通下燥结，大便已通，仍当针对病情扶虚补血，乃为治本之法。

老人阴血偏亏，大便常燥，努挣难通者，可用首乌女贞膏^④常服，颇能取得通润大便之效。

2. 气虚不运

主证：气短神疲，大便并非坚硬，临厕努挣乏力，不能顺利排泄，或时有便意，屡欲登厕，虚坐努责，或便后肛门坠迫，久久不适，舌质淡，脉缓弱。

证析：气虚神弱，故气短神疲。气虚则传导无力，故粪非坚硬，虽努挣而难于排泄。欲便而虚坐努责，便后肛门坠迫，皆由气虚下陷所致。舌质淡，脉缓弱，为气虚病证。

治法：益气润肠。

主方：用黄芪汤^⑤为主方。此类便秘多见于老年体弱之人，是方重在益气润下，仍须依据气虚轻重及粪质软硬等情况，酌情增损化裁。

3. 阴寒凝滞

主证：面色青暗，腹中攻窜，或有疼痛，大便艰涩难下，喜热畏冷，甚或四肢不温，小便清长，舌苔白润，脉沉迟或沉涩。

证析：虚人脏寒，阳气不运，肠道凝滞固结，不得传送，故腹中窜痛而大便难于排泄。病由阳虚，故小便清长而喜热畏冷。面色青暗，苔淡润，脉沉迟涩，皆阳虚内寒之象。

治法：温阳通便。

主方：用半硫丸^⑥为主方。本方重在温寒行滞，开通闭结，得效后宜继以温润方药调理，防止过用害阴，秘结愈甚。

此外，凡老人、小儿及各类便秘，尚可采用白蜜润导一法^⑦，亦有通下大便良效。

三、方药化裁

1. 麻子仁丸（《伤寒论》）

麻仁30克 杏仁10克 枳实12克 生大黄10克 厚朴12克 白芍15克

水煎服，或加量制蜜丸，每丸重6克，每服1~2丸，以得大便通利为度。

此方清润泄热，通腑下燥。适用于燥热便秘，腹胀口臭，苔黄脉实者。方以厚朴、枳实、大黄泻下肠中积热；配麻仁、杏仁、白芍润肠和里；合用而成通下缓泄之功。一般先用汤剂，大便已通，宜去大黄，继服2~3剂，以巩固疗效。

2. 瓜蒌仁汤

全瓜蒌20克 薤白12克 枳实12克 乌药10克 香附15克 郁李仁20克

此方宽中行滞，快气通肠。适用于肠气郁滞，脘腹痞满，矢气不畅，欲便不得者。方以瓜蒌滑润多脂，宽中利气；薤白辛润通阳，下气散结；乌药、香附顺气开郁；枳实、郁李仁消痞通肠。气顺则矢气畅，气畅则大便通。故本方以快气通便见优。

本方用治因于肠粘连引起脘痞腹胀，大便不爽，其效亦佳。

3. 当归郁李仁汤

秦当归10克 麻仁20克 柏子仁15克 郁李仁20克 枳壳12克

此方滋阴养血，润肠通便。适用于妇女产后及老人阴血亏虚，肠燥便秘者。方用当归辛润养血；麻仁、柏子仁、郁李仁滋阴润肠；佐枳壳以理气下行。合而用之，取其润肠下气以通燥结。

如兼心烦口渴，舌红苔剥，脉来细数者，为阴虚有热，加知母、花粉、玉竹等生津清热之品。

4. 首乌女贞膏

生何首乌100克 女贞子100克 肉苁蓉50克

上药共煎3次，去渣，用慢火浓缩成膏，放凉后，加入适量白蜜，每服一匙，日服1~2次，空胃下。

此方温养肝肾，滋补精血。适用于老年体弱，精血不足，大便常燥，艰涩难下者。方中首乌生用久煎，既能补益肝肾，又能通润大便。女贞子补肾之阴，滋而不腻。肉苁蓉补肾之阳，质润而降。三药合配，温而不燥，补而不滞，通而性缓，润而不滑，故用于老人便秘，甚为适宜。

5. 黄芪汤（《金匱翼》）

黄芪30克 橘皮10克 麻仁20克 白蜜适量

此方益气和中，润肠通便。适用于气虚便秘，临厕努挣，传送无力者。方用黄芪扶补正气；橘皮理气和中；麻仁、白蜜润养肠脏。补气则传送有力，润肠则燥粪可通。

如见时欲登厕，虚坐努责，或便时肛门坠迫者，属气虚下陷，宜加重黄芪量，或加升麻以助益气举陷之力。

6. 半硫丸（《和剂局方》）

半夏 硫黄各等分

以生姜汁同煮制丸剂，每服6克，温水送下，以得大便通利为度。（有成药）

此方补火祛寒，温阳开秘。适用于虚人脏寒，大便艰涩难通者。方用硫黄补火祛寒，温通凝滞；硫黄性味臭烈，配以半夏、姜汁温降和中，既能助其温阳荡积，亦能防其害胃致呕。

本方性味燥烈，不宜过用，得效之后，如欲巩固疗效，可用首乌女贞膏调理。

7. 白蜜润导法

白蜜一味

隔水火蒸15分钟，放冷，用注射器注入肛门30毫升左右，能取得通下大便功效。此法适用于老人、小儿和各类便秘患者。（表64）

表64

便秘病因病机证治简表

	病因病机	辨证	治则	方药
实秘	嗜食脂膩厚味，积热伤津，燥热互结；忧思少动，肠气郁滞，传导不行	燥热内结	润肠通便	麻子仁丸
		气滞不行	宽中行滞	瓜蒌仁汤
虚秘	汗利亡血，津亏血虚，肠道失润；体虚气弱，传导无力，欲便难通；下焦阳虚，寒凝气滞，便结难下	血虚肠燥	养血润燥	当归郁李仁汤 首乌女贞膏
		气虚不运	益气润肠	黄芪汤
		阴寒凝滞	温阳开秘	半硫丸

第六节 虫 证

虫证指临床常见的蛔虫、蛲虫、绦虫三种肠道寄生虫病。蛔虫又称长虫、虵虫。绦虫又称寸白虫、白虫。

关于诸虫的形态及临床特征,在《诸病源候论》“三虫候”、“九虫候”各篇有较详的叙述。如说:“长虫,蛲虫也”;“长一尺,亦有长五六寸者”;“其动则腹中痛,发作肿聚,去来上下,痛有休止,亦攻心痛,口喜吐涎及清水”。“蛲虫至细微,形如菜虫,居胴肠(大肠)间,多则为痔,剧则为癰,因入疮处以生诸痛疽癖”。“寸白虫者,九虫内之一虫也,长一寸而色白,形小扁”;“白虫相生,子母转大,长至四五尺,亦能杀人”。

本篇即以蛔虫、蛲虫、绦虫三种肠寄生虫病作出论述。

一、病因病机

诸虫发病的因素有两方面:一为杂食生冷,一为脾胃虚弱,前者是导致虫子内生的主因,后者则是虫子繁聚的条件。

蛔虫寄生于小肠,蛔虫卵随粪便排出,通过沾有虫卵的食物,经口入于肠胃而发病。蛲虫寄生于大肠,常于夜间爬出肛门发生奇痒,往往以手搔痒沾染指甲,既可污染食物传与他人,又能带入口内而致自体感染。绦虫寄生肠中,形扁色白如带状,体长可达五六尺以上,其最后一段体节,常脱离虫体随粪排出,故称为寸白。此种排出虫体被牲畜吞食后,如人们误食未经煮熟之猪牛羊肉类,或被污染的水和食物,经口传入肠中,即可发育而为成虫。由此说明,凡误食未经清洗的生冷瓜果蔬菜及未经煮熟的肉类食品,均易导致虫证发病。正如《奇效良方》所说:

“杂食生冷甘肥油腻等物,或食瓜果与畜兽内脏遗留诸虫子类而生。”这是导致诸虫发病的主因之一。如果其脏气强盛,尚能随食随化不及致病,若脾胃虚弱,运化不及,便可生存繁聚而致发病。所以,张景岳指出:“凡脏强气盛者,未闻其有虫,正以随食随化,虫自难存。而虫能为患者,终是脏气之弱,行化之迟,所以停聚而渐致生虫耳。”因此,诸虫能在体内繁聚,实与脾胃虚弱有关。

二、辨证施治

一般虫证患者,多数无明显证状,如虫病日久,耗损肠内水谷精微,即可出现形体逐渐消瘦,并可表现喜食生米、茶叶、泥土及其他种种嗜异证状。除大便排出虫体可以确诊外,蛔虫、蛲虫、绦虫均各有其特有证候,可以鉴别。

(一) 蛔虫

主证:一般便有下蛔虫史,多见于青少年与儿童,脐腹周围隐隐作痛,时作时止,胃中嘈杂,贪食,面黄肌瘦,口流涎沫,喜吐清水,唇内舌间有小点如粟粒状,或面上有白色虫斑,或鼻孔作痒,睡中磨牙,梦中惊叫。

如腹中突然阵阵剧痛,扪之有块,推之移动,汗出肢冷,呕吐蛔虫者,此属蚘厥。

如脘腹右胁突然剧痛难忍,呕吐蛔虫,甚至出现双目黄如金色者,此属蛔虫钻胆。

如右下腹忽然疼痛拒按,右腿蹇曲不伸,呕吐蛔虫者,此属蛔虫窜入阑肠。

证析：蛔踞肠间，饥则求食而动，动则脐周作痛，胃中嘈杂，喜垂涎水；得食则静，静则蛔安痛止。蛔虫吸食水谷精微，耗伤气血，是以贪食而反见面黄肌瘦。睡中磨牙，鼻孔作痒，唇舌小点，面上白斑，均为蛔虫病常见特征。蛔在肠中，性喜团聚，且好钻窜，如蛔聚成团，阻塞肠间，则腹中剧痛，扪之有块；上逆犯胃，则呕吐蛔虫；甚则汗出肢冷，发为蚘厥。如蛔虫上窜钻入胆道，则右胁剧痛难忍；胆气逆乱，胃失和降，则发生呕吐；胆液不降，外溢肌肤，则身目发黄。如蛔虫下窜钻入阑肠，则右下腹痛而拒按；筋脉拘急，牵引下肢，则右腿蹇曲不伸。凡此皆属蛔聚肠中上钻下窜所能引起的种种突然病变。

治法：一般先驱虫而后健脾；对蚘厥、钻胆、窜犯阑肠等仓卒之变，又当首先安蛔缓急，然后施以驱虫治法。

主方：驱虫宜用楝根槟榔汤①或驱蛔丸②。安蛔缓急，蚘厥宜用乌梅丸③；蛔虫钻胆或窜犯阑肠，可用椒梅槟榔汤④随证加减。蛔虫已下，宜健脾和中，可用香砂六君子汤⑤调理。

（二）蛲虫

主证：肛门发痒，夜间尤甚，睡眠不安，睡后肛门周围可见如菜虫样白色小虫子，粪便中有时也可找到，肛门周围可伴发痒疹或痛疖。此病小儿较多见。

证析：蛲虫于夜间爬出肛门，骚动作痒，故睡眠不安。因痒而抓伤肛门，故肛周皮肤发生痒疹，甚则感染虫毒发生痛疖。

治法：内服驱虫药，外用包肛法。

主方：以使君槟榔散^⑥内服驱虫；睡前用百部雄黄包肛法^⑦止痒杀虫。如已见肛门痒疹，宜用蛇参椒矾洗剂^⑧熏洗肛门，既可止痒又能杀虫。

此外，平时勤换衣裤被褥，注意手指清洁，防止自体重复感染，对防治本病更为必要。

（三）绦虫（寸白虫）

主证：腹中胀满或隐痛，肛门痒痛，大便溏薄，时或泻利，贪食善饥，久则面黄肌瘦，倦怠乏力，粪便中发现如带状寸白虫体，在病人衬裤及被褥上亦可发现。

证析：虫居肠中，饥则骚动，故时有腹胀或隐痛之感。虫体脱节排出，扰动肛门，故肛门痒痛。虫体盘踞，肠胃运化失常，故大便溏薄，时或泻利。绦虫吸食水谷精微，故善饥贪食。久则气血耗伤，故肌瘦乏力。

治法：首先驱下虫积，然后调补脾胃。

主方：驱下虫积，主以一味槟榔煎^⑨；调补脾胃，主以香砂六君子汤。如虫体已下，头节未下者，宜间隔一周，再服驱虫药一次。

三、方药化裁

1. 楝根槟榔汤

苦楝根皮30克 槟榔12克 乌梅10克 南藿香10克

上药加水久煎，空胃顿服一次，连服两天，小儿随年龄减量。

此方利气和中，驱蛔下积。适用于蛔虫腹痛，大便不爽者。方用楝根毒杀蛔虫；槟榔行滞下积；藿香、乌梅和

中安蛔。合而用之，既可防止蛔虫窜逆，又能迅速驱下虫体，屡用屡验。

2. 驱蛔丸

苦楝根皮300克（用鲜品取深入泥土部分，刮去外层老皮） 花槟榔100克（炒脆研极细粉末） 麦芽 适量（炒脆研极细粉末）

上方先将苦楝根皮加水煎3次，去渣，再用慢火浓缩成糊状，先入槟榔粉混匀，再掺入麦芽粉（适量），加糖制丸剂，每丸重6克，成人每服一丸，小儿按年龄减量，日服1~2次，早晚空胃时，用乌梅2枚，生姜1薄片，煎汤送下。

此方和胃驱蛔，效力可靠。曾于1958年某山区除害灭病期间，将本方制为成药普治蛔虫病，一般都能驱下蛔虫，未见不良反映。

3. 乌梅丸（《伤寒论》）

乌梅300枚 细辛180克 干姜300克 当归 120克 附子（炮）180克 蜀椒120克 桂枝180克 黄柏 180克 黄连480克 人参180克

上药合制丸剂，每服6克，空胃下。（有成药）

此方安蛔止呕，温中救逆。适用于虻厥腹痛，烦闷呕吐，腹痛吐蛔，汗出肢冷者。本方酸苦辛温，寒热并用，虚实兼顾。蛔虫得酸则静，得辛则伏，得苦则下，温以回阳，补以救逆，故用于虻厥正虚，病变仓卒者，其安蛔止呕止痛救逆之效甚佳。如丸剂不及配制，可师其方意，减量改为汤剂，其效亦良。

4. 椒梅槟榔汤

开口川椒20粒 乌梅10克 黄连6克 高良姜3克
细辛3克 槟榔12克 南藿香10克

此方安蛔缓急，降逆止呕。适用于蛔虫窜逆，脘腹疼痛，烦闷呕吐，常自吐蛔者。本方酸辛苦温合用，惟温阳补虚之力逊于乌梅丸方，用于蛔虫窜逆未见虻厥证状者，其安蛔降逆驱下虫体之效，亦颇良佳。

如腹中剧痛为甚者，加白芍24克，炒金铃15克，以舒挛止痛。如属蛔虫钻胆，呕吐胁痛，身目发黄者，加茵陈24克，枳实12克，龙胆草10克，以利胆降逆。

一山区农妇，腹痛呕吐不食，腹中有拳大肿物五六枚，推之移动，时吐清水，有时吐出蛔虫，诊为蛔虫团聚，上逆犯胃。投以椒梅槟榔汤安蛔降逆，并温灸中脘、三里等穴，以助和胃安中。进药1剂，呕止进食，2剂得大便1次，便出蛔虫数条。因胃气和降，蛔虫安伏，继用原方3天，每天早晚兼服驱蛔丸各一次，连续下蛔虫七八十条，后以调补脾胃痊愈。

5. 香砂六君子汤（《和剂局方》）

太子参24克 白术15克 茯苓15克 甘草3克 法半夏10克 橘皮10克 广木香6克 砂仁6克

此方健脾醒胃，理气和中。适用于各类虫证驱虫后，脾胃不健，饮食少思，脘腹痞闷，暖气恶心，大便不实者。方以太子参、白术、茯苓、甘草培补脾气；橘皮、半夏理气降逆；广木香、砂仁醒胃和中。凡驱下蛔虫后，都应调理脾胃，可用本方为主随证加减。

6. 使君槟榔散

使君子10克（取仁去其两端头尖） 花槟榔5克

上二味可按比例加量，炒脆研为细末，成人每次服6克（小儿按年龄减量），日服2次，早晚空胃凉开水送下，连服3天，服药后一小时内，不宜进热茶热食，以免致呃作呕。

此方缓下驱虫，不仅能驱下蛲虫，亦能驱下小儿蛔虫。每次用量不宜过大，防其致呃作呕，如与热茶同服，或服后进热饮热食，亦易引起呕吐腹泻。

7. 百部雄黄包肛法

土百部30克 雄黄3克

上药共研细末，用两层纱布作成布袋，装入适量药粉，于睡前包护肛门，晨起取下，日换一次，连包一周。

此方杀虫止痒，用于驱杀蛲虫，尚能避免以手搔痒产生自体重复感染。一般蛲虫轻证，单用此法亦能治愈。

8. 蛇参椒矾洗剂

方药见第五章黄胖篇第一方。

本方善于止痒杀虫，蛲虫病人已见肛门痒疹，日用本方煎汤熏洗1~2次，尚能避免肛周发生痈疖。

9. 一味槟榔煎

花槟榔120克（儿童减半）

上药加水煎熬一小时，空胃一次顿服。

一方先用生南瓜仁60克，嚼碎吞下，于2小时后，进服槟榔煎一次，其驱下绦虫功效亦佳。

此方驱下绦虫之效，最为得力。余曾治一例绦虫病人（西藏女干部），投以一味槟榔煎，令空胃进服一次，据患者自诉：服药后4小时许，驱下虫体一条，长约六七市尺。因恐头节未下，间隔一周，再进一剂，药后得大便畅

泻一次,未发现虫体。后以五味异功散调理痊愈。由此又可说明,用巨量槟榔驱下绦虫,仍以缓下取胜,而无峻泻害脾之弊。(表65)

表65

虫证病因病机证治简表

病 因 病 机	辨证	治 则	方 药
杂食生冷是虫证发病的主因,脾胃虚弱是诸虫繁聚的条件。蛔居小肠,喜团聚而好钻窜;蛲居大肠,形如菜虫,窜扰肛门;绦虫形扁色白,虫体可随大便脱节排出	蛔 虫	或先驱虫而后健脾 或先安蛔而后驱虫	楝根槟榔汤 驱蛔丸 乌梅丸 椒梅槟榔汤 香砂六君子汤
	蛲 虫	内服驱虫药 外用包肛法	使君槟榔散 百部雄黄包肛法 蛇参椒矾洗剂
	绦 虫	驱下虫积 调补脾胃	一味槟榔煎 香砂六君子汤

结 语

胃与小肠、大肠皆属于腑,腑气以和降为顺,并对饮食消化、吸收和排泄各有分工。简言之,小肠接受胃中传来已经腐熟之水谷,大部分在小肠中进行分别清浊的工作。大肠把小肠下移而来已经消化不被吸收的糟粕变成粪便,并经大肠进行传送和排泄。详言之,小肠上连于胃下接大肠,胃主纳食水谷加以腐熟送入小肠。脾主运化,胃与小肠已腐熟之水谷精微,由脾转输,上归心肺,输布全身。小肠中经过消化、吸收后剩余的废水向前渗入膀胱排出而为小便,糟粕向后归于大肠而为大便。此即饮食在胃肠中进行消化、吸收、排泄的全部过程。即是说,小肠的

10. 11. 1944

11. 11. 1944

12. 11. 1944

13. 11. 1944

14. 11. 1944

15. 11. 1944

16. 11. 1944

17. 11. 1944

18. 11. 1944

19. 11. 1944

20. 11. 1944

21. 11. 1944

22. 11. 1944

23. 11. 1944

24. 11. 1944

25. 11. 1944

26. 11. 1944

27. 11. 1944

28. 11. 1944

29. 11. 1944

30. 11. 1944

31. 11. 1944

32. 11. 1944

33. 11. 1944

34. 11. 1944

35. 11. 1944

第十章

痛 证

凡以疼痛为主征的疾病，通称痛证。人体内外各部，都可发生疼痛，而导致疼痛的病机大都因于经络阻滞，气血瘀涩引起，其涉及的疾病是极为广泛的。本章以临床常见的头痛、面颊痛、肩臂痛、胸胁痛、关节痛、腰痛诸证作出论述。至于伴随其他疾病表现的痛证，已见各章疾病者，则参略。

第一节 头 痛

头痛指全头或头的某一部分发生以疼痛为主要表现的一种病证。

头痛一证，可出现于多种急慢性疾病，一般分外感头痛、内伤头痛两大类；也有将因于外感者，称为头痛，因于内伤者，称为头风的。《证治准绳》指出：“医书多分头痛、头风为二门，然一病也，但又

有新久去留之分耳。浅而近者为头痛，其病卒然而至，易于解散速安也。深而远者一名头风，其痛作止不常，愈后遇触复发也。皆当验其邪所从来而治之。”由此说明，头痛、头风同属一病，仅有新病久病、病浅病深的区分。外因头痛多为新病，兼有恶寒发热表证，常痛无休止，其病浅，病愈则痛止。内因头痛多为久病，不兼寒热，其病深，其痛时轻时重，日久难愈。但须指出，慢性头痛多因反复外感，以致邪深入络而成，往往偶触外邪，其痛加剧，故外感与内伤又多互为因果。

本篇着重以临床常见因于风痹、鼻渊、气虚、血瘀所引起的慢性头痛作出论述。

一、病因病机

头为诸阳之会，诸经脉络，脏腑气血，皆上会于头而走空窍。凡风寒湿邪上犯头巅，邪留脉络阻蔽清阳，或气血内虚不能上荣于头，或久病络瘀，或外伤跌仆等，都能导致气血失畅，发生头痛。

风痹头痛起因于起居不慎，坐卧当风，或感受寒湿，引起发病。风寒湿邪，侵袭头巅，寒凝气滞，阻蔽血络，如未及时祛散，则邪留脉络，阻遏清阳，形成久痛不已。每因天气骤变，吹风遇寒，则凝涩愈甚而致头痛加剧。

鼻为肺窍，司呼吸，主嗅觉。伤于风者，上先受之，故外感风邪，首犯鼻窍。鼻为邪阻，络脉不利，发生壅塞多涕，称为鼻鼽（鼽音求，指鼻塞不通）。如鼻鼽失治，拖延日久，表现鼻流腥臭浊涕，甚或不闻香臭者，称为鼻

渊。鼻窍的经络，从山根而上，连接督脉，上通于脑。因此，鼻渊一病，常因鼻窍壅塞，上干头巅，发生头目昏胀作痛，且每因偶感风邪而致头痛剧作。此病如已见嗅觉完全消失，大多不易根治。所以，张景岳说：“此证一见，即宜早治，久则甚难为力。”

气虚头痛较多见于中老年人，每与操劳过度，饮食失调，病后气虚等因素有关。中老年人，如素平中气不足，再以劳倦伤气，饮食伤脾，中气愈虚则清阳不升，不能上荣于头，清窍不利，血络不畅，即可发生头晕头痛。

气为血帅，气行则血行，气滞则血滞，因此，凡头痛病久，往往从气入血，由浅入深，始而邪留气滞，久则气滞络瘀。所以，头痛经久，如见痛处固定，痛如针刺者，则属络脉瘀涩证象。起因于外伤跌仆者，也因络脉损伤，离经之血，瘀凝不去，血瘀则气滞，不通则痛作。

总之，临床上对慢性头痛，必须详察病因，并根据头痛久暂、头痛部位以及在气在血、属虚属实的不同，才能作出准确的辨证和治疗。

二、辨证施治

大凡久病头痛之证，一般痛势较缓，时轻时重，每因偶触外邪，或情绪波动，致头痛加剧而求医，且多病情顽固，又多虚实互见。对此，首应区别起病原因，头痛久暂，在气在血，属虚属实，分别施治。一般来说，头痛尚暂，邪在气分，多属实证，当以祛邪为主；头痛已久，邪深入络，每多虚实互见，宜于气血同治、虚实兼顾。如兼外邪，则

当采取急则治标，缓则治本之法。现分别论治如下：

(一) 风痹头痛

主证：头痛经久，重痛如蒙，时轻时重，吹风遇寒，头痛加剧，或痛连项背，或流窜作痛，或麻痛并作，常喜棉帛裹头，口不渴，舌苔薄白，脉象弦缓，或舌脉一如常人。

证析：风寒湿邪，阻犯头巅，留滞不去，故头痛经久，头重如蒙。寒为阴邪，得温则痛缓，故喜棉帛裹头。得寒则阻痹愈甚，故吹风遇寒，头痛加剧。太阳经脉，上会头巅，下行项背，故多连接项背而痛。偏于气滞，则流窜作痛；偏于血滞，则麻痛并作。因无内热，故口不渴。因属寒邪郁滞，故苔薄白，脉弦缓。若无大虚，则舌脉一如常人。

治法：祛风宣痹，活血通络。

主方：用芎蝎芷芩汤^①为主方；依据头痛久暂，痛势轻重、酌情加味。如痹滞已深，头痛为甚，当以通痹为主；气血已虚，则当益气养血，扶正祛邪；兼有外邪，又当以祛风散寒为先。

(二) 鼻渊头痛

主证：头部前额昏胀作痛，鼻窦一侧或双侧阻塞不通，时流浊涕，或带腥臭，或带血丝，或兼咽痛，每因偶触风寒，头痛加剧，多有反复感冒史，未兼寒热一般舌脉如常。

证析：鼻窦上通于脑，鼻窦阻塞，清窍不利，故本病以头部前额昏胀作痛为主证。致病之因在鼻，故头痛的轻重多随鼻病的轻重而差异。鼻塞知香臭者轻，嗅觉失灵者

重；鼻流浊涕无腥臭者轻，带腥臭脓涕者重。如鼻窍瘀塞，郁而化火，伤及络脉，即可出现鼻涕带血；灼及咽喉，则兼咽痛。本病最为常见，大多平时不加注意，偶遇外感，头痛剧作，就医求治。

治法：辛散温通，宣肺利窍，内外兼治。

主方：内服加减苍耳散^②；外用鼻渊薰剂^③；兼有咽痛者，宜用芷黛煎^④漱口方。

本病虽为小疾，拖延日久，每多顽固难愈。一般以外治法为主，如能坚持治疗，是可以取得良好效果的。

（三）气虚头痛

主证：头晕头痛，绵绵不已，过劳则甚，体倦乏力，食欲不振，畏寒少气，舌淡苔白，脉象缓弱。

证析：气虚则清阳不升，清窍不利，故头痛绵绵。劳则气耗，故过劳则痛甚。气虚不能抵御外寒，故畏寒。气虚不能供应呼吸，故少气。体倦食少，舌淡脉弱，均为气虚证象。

治法：补中益气，升阳散邪。

主方：用补中益气汤^⑤加白芷、川芎。本方补散兼行，取其标本同治以止头痛。

（四）血瘀头痛

主证：头痛缠绵，经久不愈，痛处固定，痛如针刺，或有头部外伤史，或因头痛日久演变而来，舌质紫暗，脉弦细或涩。

证析：初患头痛，邪留气分，久则邪深入络，气血同瘀，瘀有定处，故头痛经久而痛处固定。也有因头部外伤，离经之血，瘀凝不去，以致血瘀气滞而发病。舌紫暗，脉

弦细涩，皆为瘀血病证。

治法：活血化瘀，通阳开窍。

主方：用通窍活血汤^⑥为主方；依据头痛轻重，已虚未虚，酌情加味。

综上各证，可知头痛一病，病因不同，治法各异，必须详察起病原因，辨明气分血分，分清标本虚实，方能作出准确的治疗方法。否则头痛医头，决难取效。

三、方药化裁

1. 芎藭芷朮汤

白芷12克 秦艽20克 全蝎3克（研粉分2次冲服）
丹参12克 木瓜15克 白芍15克 大枣12克 甘草6克

此方祛风宣痹，活血通络。适用于风痹头痛，经久不愈，吹风遇寒，疼痛加剧者。凡风痹头痛，切忌过用疏风动汗方药，防其伤害卫气，反致邪留不解。本方白芷、秦艽祛散风湿，通利经络，且无动汗伤卫之弊。全蝎搜风解痉；川芎、丹参活血通络；配以木瓜、白芍、大枣、甘草等品，又能活络舒挛，和调荣卫。痹滞已通，络脉和畅，头痛自愈。

如痹滞较深，头痛为甚者，加僵蚕12克，蜈蚣2条，其搜风逐痹力量更强。如因久痛，气血已虚者，加黄芪24克，当归10克，以益气养血，扶正宣痹。如头痛发作，兼有外邪者，加藁本10克，细辛3克，以散寒止痛。

一万姓女教师，于10年前因产后感冒遗留头痛不止，屡经治疗，未见显效。其证头重如裹，昏痛如蒙，每遇天

气骤变，吹风遇寒，头痛加剧，痛连项背。来诊时，面色萎黄，食少眠差，舌苔白淡，脉象细弱，此属风痹头痛，心脾不足。投以芎蝎芷羌汤加僵蚕、蜈蚣、黄芪、当归补虚宣痹之法。二诊：患者自诉，10年中头及项部从未出汗，服前方3剂，头及项背已得微汗，自觉头身轻快，如释重负。因恐余邪未尽，嘱按原方日服2次，再进3剂。三诊：头痛已愈，已无怕风感觉，继以归脾汤补益心脾调理善后。随后观察多年，未见反复。

2. 加减苍耳散

钩藤24克 白芷12克 苍耳10克 辛夷10克 桔梗12克 玄参15克 黄芩12克 甘草6克

此方温清并用，辛散通窍，清利头目。适用于鼻渊头痛，鼻流浊涕，不知香臭者。方用钩藤除风热以利头目；白芷、苍耳、辛夷散寒邪以通鼻窍；桔梗、甘草宣利肺气以开壅塞；配黄芩、玄参既可清化郁热，又能防止白芷、苍耳辛燥动火。故本方温通鼻塞颇为得力。

如见鼻流腥臭脓涕者，加鱼腥草、冬瓜仁，以清热排脓。如头痛兼有外邪者，加蔓京子、细辛，以散寒止痛。如郁火伤络，鼻衄并见者，加小蓟、茅根，以清热止血。

3. 鼻渊熏剂

苍耳 白芷 细辛 荆芥 薄荷 川芎 菊花

上药各等分，将药混和，日置一大撮加水煎沸，趁热熏鼻，每次熏10分钟左右，下次再煎再熏，日熏3~5次，不可间断，以一个月为一疗程，根据病情轻重持续治疗。

此方用大队辛香开窍之品，采取外熏治法，使从局部治疗以达辛散温通之效。用此方法治慢性鼻炎、或萎缩性

鼻炎均有良效，且久用无害。++般轻型鼻渊，单用本方熏治1~2个疗程即能取效。如属重证，则宜内服加减苍耳散配合治疗，不过，仍应采取外治为主，内治为辅为佳，防止温散过度，演生他变。

4. 芷芩煎漱口方

方药见第二章失音篇第四方。

据临床所见，大多鼻渊患者，兼有轻重不同慢性咽喉红肿之证，采用本方既可清利咽喉，亦能温通鼻窍，但应持续治疗，其效方捷。

5. 补中益气汤

方药见第四章多寐篇第三方。

此方益气养血，补中升阳。适用于久病体虚，中气不足，头晕头痛，过劳即发者。一般单用本方即可取效。如头痛为甚者，加香白芷、川芎，以加强止痛之力。

6. 通窍活血汤（《医林改错》）

赤芍10克 川芎6克 桃仁10克 红花6克 老葱3根 生姜2薄片 红枣7枚 麝香0.05克（绢包煎）

此方活血散瘀，通阳开窍。适用于血瘀头痛，痛如针刺，痛处固定者。方用赤芍、川芎、桃仁、红花活血散瘀；老葱、麝香通阳开窍；生姜、红枣和调荣卫。故本方以善治血瘀头痛见优。

如久病气虚者，加黄芪、当归扶正通瘀。

如麝香难得，可减去不用，再加丹参、没药，以助散瘀之力。

一曾姓女干部，患头痛10余年，初为右侧头痛，时发时止，服去痛片可以止痛，渐次遍头俱痛，服各类止痛药

无效。近半年来，痛无休止，痛如针刺，麻痛并作，有时伴恶心呕吐。其人常以棉帛裹头，面色青暗，面目浮肿，二便如常，舌淡苔薄，脉沉细涩，舌间有紫色瘀点。诊为头痛日久，气虚络瘀，治宜益气通瘀，止痉止痛。投以通窍活血汤加黄芪30克，丹参15克，全蝎3克，嘱服4剂。头痛止，面肿消，惟觉头皮麻木如有蚁行，此瘀滞初开，气血未复之象。按原方加黄芪量为60克，加当归10克，以加强益气养血功效，嘱服6剂。头裹已去，未见头痛发作，舌间瘀点已退，尚有头皮不适之感。因恐病势反复，仍以原方减去桃仁，红花、老葱、生姜、麝香等品，嘱服半月，以巩固疗效。此例病员仅进药20余剂，使多年宿疾，得以痊愈。（表67）

表67 头痛病因病机证治简表

病因病机	辨 证	治 则	方 药
风寒湿邪，侵袭头巅，留滞脉络， 头痛不已，反复外感，邪留鼻络，鼻 窍壅塞，上干头巅，中气不足，不能 上荣于头，血络不畅，头晕头痛，头 痛日久，邪深入络，或因外伤，瘀血 留滞，不通则痛	风痹头痛	疏风宣痹 活血通络	芎蝎芷羌汤
	鼻渊头痛	温通利窍 内外兼治	加味苍耳散 鼻渊煎剂 芷薰煎
	气虚头痛	补中益气 升阳散邪	补中益气汤 加白芷川芎
	血瘀头痛	活血化痰 通阳开窍	通窍活血汤 加味

第二节 面 颊 痛

面颊痛是指面颊一侧呈阵发性剧烈疼痛为主证的一

种疾病。其痛区见于阳明经筋分布区域，疼痛表现间歇性反复发作，可持续数月至数年或更久。

因于风热发颐、面部疮痈、或外伤所引起的面颊肿痛，则非本篇所论范围。

一、病因病机

感伤风毒，邪中于面，传入阳明筋络，便可导致面颊疼痛。阳明经筋脉络上行于颈而分布于口唇、面颊、颧骨、耳前、眼睑等区域。《灵枢·邪气藏府病形篇》指出：

“若饮食汗出，腠理开而中于邪，中于面则下阳明。”因头面居上，易受风邪，如腠理开疏，风毒入侵，留滞于阳明筋络，久而气滞血瘀，脉络不通，不通则痛。

宋代医籍《本事方》载一病例：“王检正希皋，昔患鼻额间痛，或麻痹不仁，如是者数年。忽一日连口唇、颊车、发际皆痛，不可开口，虽言语饮食亦相防，左额与颊上常如绷紧，手触之则痛。余作足阳明经络受风毒，传入经络，血凝滞而不行，故有此证。”由此可见，本病正是由于风毒入侵，邪中于面，留滞阳明经筋脉络所引起。

二、辨证施治

本病多见于中年以上之人，女性较多于男性。

主证：面颊一侧阵发剧痛，每因洗脸、刷牙、进食、说话引起疼痛发作。痛时面颊灼热，痛如刀割，且因疼痛而致面肌抽搐，可见闭目、歪嘴、咬牙、流泪、流鼻涕以

及口角流涎等现象。疼痛一次，经过数秒钟至数分钟不等，一天发作数次至数十次。未发痛时一如常人。

本病多呈间歇性反复发作，其证亦随再次发作渐次加重加密。

本病舌诊和脉象，常以患者体质强弱及病情轻重各有差异。

证析：风毒留滞，阻痹经络，气血不通，不通则痛，疼痛限于面颊一侧，正当足阳明经筋分布区域。风为阳邪，郁则化热，瘀热相击，其痛发作，故痛如刀割，痛如火燎。经筋不利，痛则挛急，故痛时面肌抽搐而见种种拘挛病象。本病发作与间歇时间，大体与瘀阻轻重关系密切。瘀阻轻则郁热轻，其痛易于缓解，间歇期比较长；反之，瘀重则热重，疼痛持续时间长，间歇期比较短暂。故本病发作一次，其痛亦渐次加密。

治法：搜风祛毒，凉热通瘀。

主方：用搜风解痛汤为主方，依据瘀热轻重、体质强弱与益气养血、清热活络之品出入化裁。

三、方药化裁

搜风解痛汤

钩藤24克 白芷10克 秦艽15克 丹参15克 川芎9克 僵蚕12克 全蝎6克 地龙24克 白芍20克 木瓜12克 大枣12克

此方搜风祛毒，凉热通瘀。适用于面颊疼痛，痛如火燎，面肌挛急，歪嘴咬牙，疼痛难忍者。方中钩藤、白芷、

秦艽、木瓜祛散风邪，通利经络；僵蚕、全蝎搜风解痉；白芍舒挛缓急；地龙凉解瘀热；丹参、川芎活血行瘀。邪去瘀消，络脉畅和，其痛可解。故本方以搜风解痛著称。

如风毒顽踞者，加蜈蚣2条，以加强搜风逐痹力量。如久病气虚者，加黄芪30克，以扶正驱邪。若荣血不足者，加生地15克，以养血通瘀。

一秦姓女干部，患右侧面颊痛已数年，初觉面颊部抽掣作痛，疑为牙病，治疗无效。后即时痛时止，渐次加重，发作渐密。西医诊断为三叉神经痛，曾用针灸、封闭疗法兼服中西药无显效。两年来痛无休止，右面颊连接头额如火灼样抽掣剧痛，痛时口角歪向一侧，并伴见眼目流泪，口角流涎。每于洗脸、刷牙、进食即诱发剧痛，患者深感痛苦。脉沉细乏力，舌质淡红，舌苔薄白。证属风毒入络，受病于阳明经筋，瘀热留滞，久病气虚。主以搜风解痛汤祛风通络，凉解瘀热，嘱服4剂，患者面痛大减，面颊部尚有轻微热感，脉现沉弱，舌淡不红，舌苔薄白。此属瘀阻顽踞，正气不足，主以扶正托邪，搜风逐痹治法，按原方加黄芪30克，蜈蚣2条，嘱服4剂。面颊疼痛已消失，已能随意进食、洗脸、刷牙，面颊尚觉轻微酸胀，脉沉略缓，舌润苔薄。瘀阻已通，虑其反复，仍按原方嘱间日一剂，连服2周。后经3个月，面痛小发作一次，仍进前方数剂，其痛消失。观察3年，未见发病。后经多例同类疾病，按上方加减治疗，均获良效。（表68）

表68

面颊痛病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
风毒入侵，邪中于面，留滞于阳明经筋，血瘀络阻，筋脉挛急，抽搐疼痛	风毒面痛	搜风祛毒 凉热通瘀	搜风解痛汤 随证加减

第三节 肩臂痛

肩臂痛是指肩臂一侧绕肩胛而痛，其痛牵连项背，甚则肩不能举，运转不利为主证的一种疾病。

因于跌打外伤引起的肩臂疼痛，本篇不作论述。

一、病因病机

从肩至肘，名为肱；从肘至腕，名为臂。手三阳经筋脉络，起于手指末端，结于腕部，沿臂入肘，循肱上行，绕于肩胛，上行于颈部。如肩胛经筋脉络拘挛强急，便可发生肩胛周围牵引疼痛，甚则不能抬举，运转不便。

发生肩臂痛的原因，多以坐卧不慎，感伤风寒湿邪，或以睡眠时肩臂露出被外，为寒邪所侵。筋脉受邪，留滞不去，血凝气涩，拘挛强急，肩痛难举。此外，如提挈重物，持久劳动，伤于筋脉，亦能引起发病。

二、辨证施治

本病多见于中老年人，且多久痛留连，经年不愈。

主证：一般多见于肩臂一侧，绕肩胛而痛，痛连项背，

肩不能举，运转不利，抬肩或运转则痛势加剧，痛处喜暖畏寒，得暖则痛缓，得寒则痛甚，不兼寒热表证，舌脉一如常人。

证析：荣卫稍衰，易受寒侵，故本病多见于中老年人。寒在筋脉，血凝气涩，故肩臂拘挛强急，抬举则痛。寒性凝涩，遇寒更甚，故得暖则痛缓，遇寒则痛剧。寒凝筋络，往往不易解散，故多久痛留连，甚至累月经年。邪气留滞，限于肩臂，未及全身，所以，不显寒热表证，大多舌脉如常。

治法：温阳通痹，和调荣卫。

主方：用加味黄芪桂枝五物汤为主方，依据病情，随证加减。如痛势已久，病情深重，尚宜配合针灸、按摩治法，更能提高疗效。

三、方药化裁

加味黄芪桂枝五物汤

方药见第七章痿证篇第六方。

此方温阳活络，补散兼行。适用于中老年人，寒凝筋络，肩臂疼痛，运转不便者。是方益气温阳，和调荣卫，表里协力，舒筋活络。卫气通畅，寒凝可解，疼痛自愈。

寒凝筋络之肩臂痛者，加木瓜15克，威灵仙15克，其舒筋止痛效力更佳。提掣重物发生肩臂疼痛者，去桂枝、生姜，加丹参15克，没药6克，乳香6克，以加强散瘀定痛力量。

—55岁男性病员，患左侧肩臂痛已5年。初以搬运重

物起病，治愈不久，复因睡后露肩而致肩痛复发，痛势较前加重。肩胛不能抬举，运转不便，痛处喜暖畏凉，前医累用温散通瘀方药无效。此为中老年人荣卫稍衰，寒凝筋络，不能祛散，当治以补散兼行之法。主以加味黄芪桂枝五物汤，嘱日进一剂，并嘱配合按摩治疗。如此调治一月，其病痊愈。

由此说明，本病之所以缠绵难愈，大多因于荣卫稍衰，寒凝经筋脉络，不易祛散之故，所以单用温散通瘀难于取效。且因经筋脉络，位居体表，纯靠药物，亦难宣达，故以内外兼治为佳。（表69）

表69 肩臂痛病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
寒凝经筋，留滞不去，拘挛强急，肩痛难举	寒凝肩臂	温阳通痹 调和荣卫	加味黄芪桂枝五物汤

第四节 胸 胁 痛

凡胸部与肋肋间发生疼痛的疾病，称为胸胁痛。导致的原因，大抵与心、肺、肝、胆的病变有关，除肺癆、肺痛、心痹络瘀、肝炎、蛔虫钻胆等疾病发生的胸痛与胁痛，已有专篇论述，可资鉴别外。本篇着重以癆饮积胸、胆热瘀积导致的胸胁痛作出论述。

一、病因病机

癆饮积胸，起病于肺。感染癆虫，侵袭肺络，疰蚀津

血，化生癆热，病为肺癆。肺居胸中，司呼吸，宣发津气，通调水道。如癆热侵犯胸络，脉道瘀阻，胸中气塞，肺之通调否塞，水液不得宣行，水聚为饮，停滞胸胁，病为癆饮积胸，水停胁间，不上不下，悬结不散，阻碍气机，而致欬唾引痛。此与《金匱·痰饮篇》所论悬饮，同属一类疾病。

胆热瘀积，因于肝郁。肝居右胁，胆附于肝，其经脉布于胁肋，故胁痛与肝胆的关系最为密切。如平素焦劳忧虑，情怀抑郁，则肝气失畅，肝郁则胆气不利，久则胆液留滞，瘀郁积热，病为胆热胁痛。肝胆有疏泄脾胃的职能，如过食肥甘，酒食不节，亦能滋生湿热，阻遏肝胆，引起发病。在肝胆郁热、胆液留滞的病机演变中，如因瘀热煎熬，形成结石，还能阻塞胆道，病为胆石胁痛。

二、辨证施治

（一）癆饮胸痛

主证：大多有肺癆病史，午后发热，胸胁间胀满疼痛，每因咳唾、呼吸而致胸痛加剧，常喜偏卧于一侧，伴有干咳、呼吸短促等证。舌苔和脉象常因劳热进退而差异，发热期可见舌色嫩红，脉弦滑或弦数；发热已退，多表现舌苔白滑，脉沉弦或沉缓。

证析：肺癆侵犯胸络，劳热内蒸，故见午后潮热。水停胸胁，气滞络瘀，故胸胁间胀满而痛。胸胁乃呼吸出入之所，故咳唾呼吸均能牵引胸胁而致疼痛加剧。水气停聚，每多偏于一侧，故患者常喜偏于患侧而卧。正因水停胸

中,阻碍肺气,上干于肺则咳嗽;肺气不得宣降,则呼吸短促。舌嫩红,脉弦滑数,主劳热内蒸;舌白滑,脉沉弦缓,主水饮停聚。

本病应与肺痈、心痹络瘀之胸痛相鉴别。

治法:宽胸泻肺,行瘀消饮。

主方:用桑白皮汤①为主方。本方宽胸活络,制劳肃肺,肺气宣降,胸络畅利,积饮自消。切忌妄施攻逐峻剂,耗阴伤络,演生他变。如水气已消,可按肺癆治法调理。

(二) 胆热胁痛

本病女性多于男性,尤以中年妇女最为多见。

主证:初起右上腹季肋间持续疼痛逐渐加剧,甚而表现剧烈绞痛,疼痛牵引右侧肩背,恶心呕吐,恶寒发热,厌食油腻,口苦尿黄,或见黄疸,舌苔黄腻,脉象弦数。

本病缓解后,每因瘀热留滞转为慢性。患者常觉脘腹痞闷,暖气食少,剑突下偏右肋缘区经常隐隐作痛,按之痛甚。偶因恼怒、饱餐或食油腻而致疼痛发作。

证析:胆腑位于剑下偏右肋缘区,胆热瘀积,腑气不通,不通则痛,故本病以右胁痛引肩背为特征。胆气不降,逆而犯胃,故恶心呕吐。瘀热内蒸,荣卫失和,故恶寒发热。如有结石阻塞胆道,即可出现绞痛和黄疸证象。至于厌油、口苦、尿黄、苔黄腻、脉弦数均为湿热瘀积的病证。

本病应与胃痛、传肝、肠痛、蛔虫钻胆等病鉴别。

治法:利胆和胃,清热消积。

主方:急性发作,主与加味四逆汤②透解郁热,和胃降逆,通其腑道,缓解疼痛。如属慢性,或有砂石瘀积,

主与榔术散②利胆和胃，缓消积滞。

三、方药化裁

1. 桑白皮汤

桑白皮30克 全瓜蒌15克（壳仁各半） 薏苡仁15克
丹参15克 白芍15克 胡黄连12克 夏枯草30克

此方清热泻肺，宽胸活络。适用于癆饮胸痛，干咳短气者。方用桑白皮泻肺行水，全瓜蒌宽胸行滞，薏苡仁和脾渗湿，以通水道；丹参、白芍活络舒挛，以解胸痛；胡黄连、夏枯草清热肃肺，以除劳热。水道通利，胸络畅和，则停饮消而胸痛止。

如兼咳嗽气喘者，属于水饮迫肺，加炒葶苈15克，大枣10克，以加强泻肺行水力量。如潮热已退，积饮未消者，加白芥子10克，取其辛散温化，宣通壅滞。如停饮消退，兼有肺癆证候者，可按肺癆证治调理。

一藏族女干部，素有肺癆史，于3月前患胸胁疼痛，西医诊断：结核性胸膜积液。因对抗结核药过敏，转而服用中药，前医投控涎丹数剂，反致胸胁胀痛加剧。初诊：右侧胸胁胀满疼痛，咳嗽痰少，呼吸短促，常喜偏卧右侧，咳唾、呼吸或转侧体位则胸痛加剧，每日午后身有微热，舌体嫩红，舌苔薄腻，舌心有豆大紫斑一块，脉弦略数。此属癆饮积胸，胸络瘀滞。主与桑白皮汤加白芥子10克，使其温清并用，宣化壅滞，通利水道。二诊：服前方6剂，胸水已消大半，潮热已退，胸痛大减，尚有咳嗽，仍按原方去白芥子、胡黄连，加山药、茯苓、枇杷叶健脾渗湿。

止咳降逆。三诊：经2周服前方10剂，咳嗽胸痛消失，继以培健脾胃理肺养阴方药调理而愈。由此观察多例同类疾病来看，施以上列治法，均有良效，如用攻泻逐饮方药皆非所宜。

2. 加味四逆汤

柴胡10克 白芍24克 黄芩15克 枳实15克 郁金20克 金铃子（炒）15克 延胡索12克 甘草6克 金钱草30克 藿香10克

此方利胆和胃，清热降逆。适用于胆热胁痛，恶寒发热，恶心呕吐者。方用《伤寒论》四逆散加味组成。方中柴胡、黄芩疏达肝气，透解郁热；郁金、枳实泻腑开郁，以通胆胃壅滞；金铃子、延胡索、白芍、甘草泄热舒挛，缓急止痛；藿香、金钱草和胃止呕，宣利湿热。腑气通利，热去呕止，疼痛自解。

兼有黄疸者，加龙胆草、茵陈，以增强清泻湿热之力。兼大便秘结不通者，加大黄，以通积滞。如寒热已退，呕止痛减，见脘腹痞胀，胁间隐痛未消者，去柴胡、黄芩，加白术、隔山消，和胃消痞，以防病势反复。

3. 榔术散

槟榔100克 白术60克 郁金120克 鸡内金30克 砂仁10克

上药制为粉剂，每服4克，日服2次，午晚饭前半小时温水调下。

此方开郁和胃，缓消积滞。适用于胆热胁痛已成慢性，脘腹痞满，胁间隐痛者。方以槟榔、白术健胃消积；郁金开郁行滞；鸡内金、砂仁和中运脾。方药配合，消补

兼行，胃气和降则胆气通而积滞消。

本方取其缓消积滞而不害胃，宜坚持常服，其效方著。在治疗中，必须保持大便通畅，以利排泄。

如属胆石瘀积（或为泥砂、或结石较小易于通下者），宜用金钱草60克，煎汤代茶配合内服，其利胆排石功效亦佳。

一40余岁张姓病员，原有慢性胆囊炎病史，于3月前突然呕吐剧痛，经某医院检查确诊，胆囊中有黄豆大结石30余粒，因病员不愿手术，来我院门诊治疗。初诊：脘腹胀，右季肋下隐隐作疼，按之痛甚，大便不爽，小便微黄，舌苔黄而薄腻，脉象弦缓。此属胆石瘀积，腑气不畅，治宜利胆和胃，行滞消积。主与加味四逆汤去柴胡、黄芩，加入白术15克，嘱服2周。二诊：食欲如常，大便通畅，季肋下已不觉痛，尚有坠胀之感，舌常苔，脉弦缓。此瘀热已退，当从缓治。主与榔术散日服3次，每服3克，另以大金钱草60克煎汤代茶，日尽1剂，嘱连服2月。本病共治疗3个月，经原检查医院复查两次，第一次发现胆囊中有结石10余粒；第二次胆囊显影清晰，未见结石。由此可见，本病采取和胃缓消治法，确能取得良效。（表70）

表70

胸胁痛病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
癆虫袭肺，侵犯胸络，络瘀气塞，水聚为饮，停滞胸肋，咳唾引痛；肝气失畅，胆气不利，胆液留滞，瘀郁积热，腑气不通，不通则痛	癆饮胸痛	宽胸泻肺 行瘀消水	桑白皮汤
	胆热肋痛	利胆和胃 清热消积	加味四逆汤 榔术散

第五节 关节痛

凡身体各部足踝、指、腕、肩、肘、腰、背、髌、膝等大小关节发生一处或多处肢节疼痛酸楚，甚或红肿变形者，称为关节痛。

有关关节痛的文献记载，早在《素问·痹论》中，就有行痹、着痹、痛痹三类证候的论述。《金匱要略》所论的历节病及后世医籍所论的痛风、历节风等，亦属本病范畴。

本病大都因于杂感风寒湿热之邪，壅蔽关节，引起发病。邪热偏胜，关节肿痛，病为热痹，起病较急；风寒湿邪偏胜，关节酸楚，病为行痹、着痹、痛痹，起病较缓。本篇分风寒湿痹、热痹二类作出论述。

一、病因病机

风寒湿邪，壅痹关节。《素问·痹论》说：“风寒湿三气杂至，合而为痹。”“其风气胜者为行痹，寒气胜者为痛痹，湿气胜者为着痹也。”由此可知，本病皆由杂感风寒湿邪引起发病。大凡居处环境潮湿，气候多变地区，或汗出入水，或贪凉露宿，或汗出当风，都能招致风寒湿邪侵袭肢体，留滞经络，壅蔽关节，发生酸楚疼痛。初起邪留肌肤，其病尚浅，久则邪深入络，留连筋骨，成为久痛缠绵。一遇天气变阴，或触冷受寒，受害肢节，阻闭愈甚，必致疼痛加剧。感受邪气各有偏胜，风邪偏胜，发为

行痹；寒邪偏胜，发为痛痹；湿邪偏胜，发为着痹。风性走窜，易于化火，故行痹之痛，游走不定，痛处发红。寒气伤阳，其性凝涩，故痛痹之痛，疼痛剧烈，痛有定处。湿性粘滞，阻碍气血，故着痹之痛，多麻痛并作，固定一处。这便是杂感风寒湿邪表现为行痹、痛痹、着痹各类关节痛证的病机演变和临床特征。

邪阻经络，遏郁化热。杂感风寒湿热之邪，留滞经络，交相阻遏，热为寒郁，不得消散，邪阻经络，气血难通，寒郁热阻，壅蔽关节，久则关节红肿，灼热而痛，成为热痹。此外，风寒湿痹经久未愈，邪留经络遏郁蕴热，也能出现热痹证候。《类证治裁》所说“初因风寒湿邪郁痹阴分，久则化热攻痛”，即是指此。

凡风、寒、湿、热诸痹，如邪阻经络，壅蔽关节，久延不愈，尚能产生筋骨变形、内脏瘀痹等方面的病变。人体各部大小关节是经脉、经筋、筋膜汇合转输之所，十二经脉，外行体表，内通脏腑；十二经筋，联系筋膜，行于体表肢节，不入内脏。因此，如邪留经络，伤于经脉，邪气得以循经深入伤及内脏，产生脏腑诸痹。正如《素问·痹论》所说：“五藏皆有合病，久而不去者，内舍于其合也。”“脉痹不已，复感于邪，内舍于心。”“心痹者，脉不通……。”此即临床常见患风寒湿热诸痹并发心痹络瘀的病变。如邪留经络，伤于经筋，筋伤则筋膜不利，骨节瘀阻，久则关节增大变形，发生拘挛强急伸屈不便。病至于此，多难恢复，但经筋受病不连脏腑，只伤筋骨，不干内脏。由此可知，凡风寒湿热导致关节疼痛，必须注意及时诊治，如已并发心络瘀痹、或关节增大变形，大多成

为终身疾病。

二、辨证施治

本病无性别年龄的区分，且为临床常见，尤以环境潮湿、气候多变地区发病最多。一般来说，关节知痛知痒者，邪浅病轻；久痛而渐至不痛不仁者，邪深病重。肢节痛而活动如常者，属于病在肌肤经络，证轻易治；痛而伸屈不利，甚至关节增大变形者，属于病在筋骨，大多不易恢复。在治疗方面，大体以祛邪通络为基本法则，并依据风寒湿热何邪偏胜而运用祛风、散寒、除湿、清热诸法。

痹证与痿证的鉴别：痿证以肢体痿软为主征，一般不表现关节疼痛；痹证日久，亦能出现肌肉消瘦麻木，但多麻痛并作，可资鉴别。

现分风寒湿痹、热痹二类论治如下：

（一）风寒湿痹

主证：肢体各部大小关节，或限于一处，或多处肢节，酸楚疼痛，天气变阴或霉雨季节，其痛加剧，反复发作，或见关节增大变形，影响活动。分行痹、痛痹、着痹三证：

行痹——关节疼痛，游走不定，痛时关节发红，痛后渐次消散，或见恶寒发热，脉多浮弦。

痛痹——疼痛剧烈，宛如锥刺，痛有定处，得热痛减，遇寒痛甚，痛处肤色不红，扪之不热，脉多弦紧或沉紧。

着痹——疼痛重着，肌肤麻木，固定一处，关节笨重，活动不便，脉多缓濡或沉缓。

证析：风寒湿邪，留滞经络，壅蔽关节，气血不得宣通，不通则痛。天气变阴或霉雨季节，邪气愈甚，阻滞愈深，故本病之痛，常与气候变化有关。行痹之痛，风邪偏胜，风性走窜，随经流注，故其痛历节转注游走不定。风为阳邪，最易化火，故见痛处发红，痛后消散。如风邪太盛，阻遏肌表，邪正相争，则见恶寒发热。脉象浮弦，为风邪在表之证。正因行痹以痛处发红、痛无定处为特点，故有流火、鬼箭风之称。痛痹之痛，寒气偏胜，寒性伤阳，凝滞一处，闭涩更深，故以痛有定处、疼痛剧烈而有痛风、白虎历节风之称。寒性凝滞，得热则气血稍通，故其痛减，得寒则凝涩愈甚，故其痛更剧。痛处不红不热，脉弦紧或沉弦，均为阴寒凝滞病象。着痹之痛，湿气偏胜，湿性重着粘滞，固定不移，是以其痛固定一处，但不似痛痹疼痛剧烈，而以肢节笨重不甚灵活为特点。又因阴湿留滞阻碍气血，故本病常以受害关节麻痛并作为主证。脉象缓濡或沉缓，亦属湿邪偏胜之象。

治法：祛散邪气，通利经络。

主方：用独活己芎汤^①为主方。本方重在益气和荣，舒筋活络，祛散风寒湿邪，可依据受病关节不同部位以及风寒湿三气偏胜增减化裁。

治行痹疏风为主，参以养血清火之药；治痛痹散寒为主，但非辅以大辛大热之品，不能解其凝寒；治着痹除湿为主，佐以益气补脾之品，脾旺即可胜湿，气足则顽麻自除。

（二）热痹

主证：起病较急，肢体关节红肿热痛，得冷则舒，痛

不可近,关节不能活动,可涉一处或多处关节,可见皮肤红斑,或关节周围出现豆大圆形硬结,并多兼有恶风发热、口渴、烦闷等证,舌红苔黄,脉象滑数。

证析: 风寒湿热交相阻遏,留滞经络,壅蔽关节,故关节红肿热痛。邪热瘀阻,络脉失畅,热入荣分,故关节周围出现红斑或豆大圆形硬结。邪热内蒸,扰及荣卫,故见恶风发热。至于口渴、烦闷、舌红苔黄,脉象滑数,均为邪热内盛病证。

治法: 清热活络,疏风除湿,内外兼治。

主方: 用知苳己苳汤②为主方;依据病情轻重随证化裁。另用七妙散③外敷红肿关节,更能清热消肿,散瘀止痛。

凡风寒湿痹经久不愈,非汤药能取速效者,还可随其病情选用乌头合剂丸④、小活络丹⑤或大活络丹⑥内服一些时间,亦有消除疼痛、防其反复的效力。

无论何种痹证,还可配合针灸、推拿、按摩以及熏洗等治法,对本病均有良好效果。

各类痹证,如邪深入脏并发心悸者,可参考心悸篇心痹治法。

三、方药化裁

1. 独活己苳汤

独活20克 汉防己15克 秦苳15克 黄芪24克 鸡血藤15克 当归10克 白芍15克 大枣12克 甘草6克

这是一首通用于风寒湿痹的基础方剂,功能益气祛

邪，舒筋活络。方以独活、防己、秦艽疏散风寒湿邪，鸡血藤、当归行血活络，配以黄芪、白芍、大枣、甘草益气祛邪，和调荣卫。气行则血行，邪去则痛去。
 痛在肩背者，加葛根、桂枝，以通经温阳，祛散邪气。
 痛在腰膝者，加续断、怀牛膝，以温养肝肾，疏利关节。
 治行痹重在疏风佐以清火，方中去黄芪，重用白芍，加防风、黄芩，既能散风止痛，又可防止辛燥诸药燥热劫火。

治痛痹重在温阳逐寒，方中加麻黄、附片、乌头，止痛之力颇强，惟乌头大毒，必须慢火久煎（一般须煎熬1~2小时以不麻口为度），以防毒害。

治着痹重在除湿佐以补脾益气，方中应重用黄芪，加桂枝、川芎、薏苡仁，使能利湿祛风，入络通痹。

凡风寒湿痹，如久痛留连，病情顽固，反复发作者，方中亦可酌加蜈蚣、全蝎、乌梢蛇或白花蛇等品，其搜风止痛之效更宏。

2. 知母己芩汤

知母18克 黄芩18克 汉防己24克 秦艽15克 白芍20克 海桐皮15克 晚蚕砂15克

此方清热祛风，除湿通络。适用于热痹关节肿痛，恶风发热者，方以知母、黄芩清热除烦；防己、秦艽散湿祛邪；白芍舒挛缓急；海桐皮、蚕砂祛风除湿，通利经络。邪热去，经络通，红肿可消，疼痛可止。

痛在上肢者，加葛根、桑枝。痛在下肢者，加木瓜、牛膝。发热口渴甚者，加生石膏、竹叶。关节红肿甚者，加丹参、没药。

不入如见，壮热烦渴，关节红肿热痛如刀割，舌绛绛，脉弦数者，此为热聚筋骨深入荣阴。方中再加犀角、生地黄、牡丹皮等品，以加强清热解毒，凉血散瘀之力。此方用于用。

3. 七妙散 (《薛麟台兰》) 每服6克

京06苍术 西黄柏03 生地黄 当归尾 乳香 没药 北细辛
京00上药各等分，研为极细粉末，全用味以蜂蜜或鸡蛋清调为糊状，敷红肿关节，日换6次，肿消为度。京00黄柏
京00地龙泻热消肿散瘀止痛，适用于痰火留滞，京00黄柏
脾热者。方药配合，寒温并用，既可宣散壅滞之湿，又能清泻瘀郁之热，外敷患处，取效尤捷。京00香 京00香

4. 乌头合剂丸 (成都中医药大学方) 京00将药料
京00麻黄6克 京00白芍6克 独活6克 细辛6克 杏仁6克 黄
薹苡仁6克 京00甘草6克 黄芪15克 制川乌15克 京00防风

按上方药量的倍加倍将药料，川乌煎煮3次去渣，再用微火收取浓汁，另将余药研为细末渗入药汁混匀，加蜜制为丸剂，京00每丸重3克，京00每服9丸，日服2次。京00共

此方温寒除湿，祛风止痛。(适用于寒湿痹阻关节，未
阴痛剧，不可伸屈者。于是方用《金匱》乌头汤为基础，加
独活、细辛、薹苡仁、杏仁等散寒除湿之品，更能深入筋
节，祛散留邪。京00制丸剂小量缓服，取其稳定病情以防反复，
余常用之，确有良效。效如神速，非他药可比。

5. 风祛络丹 (《和剂局方》) 川乌180克 草乌180克 合地龙180克 天南星180克
乳香66克 没药66克 (IV级)。京00共

上药各炮制为丸，每丸重3克，每服一丸，日服1~2次。
(有成药)

此方温阳逐寒，消痰散瘀。适用于风寒湿痹，日久不愈，关节疼痛，遇冷痛甚者。方药配合，重在逐寒通络，以用于体气壮实而无热象者为宜。

6. 大活络丹（《兰台轨范》）

白花蛇60克 乌梢蛇60克 威灵仙60克 两头尖60克
草乌60克 天麻60克 全蝎60克 首乌60克 龟板60克
麻黄60克 贯众60克 甘草60克 羌活60克 官桂60克
藿香60克 乌药60克 黄连60克 大黄60克 木香60克
沉香60克 熟地黄60克 细辛30克 赤芍30克 没药30克
丁香30克 乳香30克 僵蚕30克 南星30克 青皮30克
骨碎补30克 白蔻仁30克 安息香30克 黑附子30克
黄芩30克 茯苓80克 香附30克 玄参30克 白术30克
防风75克 葛根45克 虎胫骨45克 当归45克 血竭21克
地龙15克 犀角15克 麝香15克 松脂15克 牛黄5克
片脑5克 人参90克

上药共各研细混匀，蜜制为丸，每丸重3克，每服--丸，日服1~2次。（有成药）

此方扶补气血，祛风活络。适用于风寒湿痹经久不愈，正虚邪实，筋脉拘急，关节不利者。是方寒温并用，虚实兼顾，功能补气补血，祛风止痛，故用于久痹正虚者为宜。

大凡顽痹宿疾，非汤药能取速效者，当用峻厉方药作丸剂缓攻，取其缓慢搜剔渐次取效。所以，凡治风寒湿痹经久不愈者，无论选用乌头合剂丸、大小活络丹都以小量缓服为佳。（表71）

表71

关节痛病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
杂感风寒湿邪，壅蔽关节，邪阻经络，关节疼痛。风气偏胜为行痹，寒气偏胜为痛痹，湿气偏胜为着痹；邪阻经络，遏郁化热，病为热痹	风寒湿痹	祛散邪气 通利关节	独活己苳汤
	热痹	清热活络 疏风除湿	知苳己苳汤 七妙散
	久痹宿疾	温寒逐痹 扶正通络	乌头合剂丸 小活络丹 大活络丹

第六节 腰痛

凡疼痛限于腰部的病证，通称腰痛。腰为肾之外府，筋膜、经脉贯肾络腰，为人体之主要关节，全身活动无不赖以支撑，故腰痛与肾和筋骨经脉的关系至为密切。

本篇以临床常见因于湿阻经络、劳伤筋骨引起的腰痛病证作出论述。至于以肾病为主伴随出现之腰痛，当从原发疾病施治，可参考各章有关肾病治法。

一、病因病机

感受湿邪，阻滞经络。凡坐卧湿地，涉水冒雨，或身劳汗出，衣着冷湿，均能伤于湿邪，留着不去，凝滞经络，致气血运行不畅，因而发生腰痛。此种腰痛又称肾着，如《金匱·五脏风寒积聚病篇》说：“肾着之病……身劳汗出，衣里冷湿，久久得之，腰以下冷痛，腹重如带五千钱。”此属寒湿留滞，邪在经络，实非肾病。湿为阴邪，

遇寒则从寒化，遇热则从热化。因此，如长夏之季，湿热交蒸，感受其邪，阻遏经脉，湿滞热郁，亦能发生腰痛。若寒湿久蕴，郁而化热，也可出现类似湿热腰痛病证。

劳力闪挫，伤于筋骨。凡久劳负重，或闪挫跌仆，伤于筋骨，致气血瘀凝，留滞腰节，因而发生腰痛。如张景岳说：“跌仆伤而腰痛者，此伤在筋骨而血脉凝滞也。”筋膜主束骨而利关节，伤于筋则拘挛不利，伤于骨则转摇不能。若筋伤而又损及于骨，每多留为暗疾，常以操劳用力，遇冷着凉，而致腰痛反复发作者，临床上并不少见。

二、辨证施治

本病在辨证方面，首应区别新痛久痛，虚实寒热。大体新病腰痛，其证多实；久病腰痛，证多虚实互见。实证以治标为先，或疏邪气，或通瘀滞；虚实并见者，则当依据虚实多少，治宜养气血、舒筋络，总以标本兼顾为要。

（一）寒湿腰痛

主证：腰节重着冷痛，甚则如坐水中，不能伸屈转侧，常喜棉帛裹护，遇冷触寒则疼痛加剧，口不渴，小便清利，舌苔薄白而腻，脉沉弦或沉缓。

证析：湿为阴邪，寒性伤阳，留着不去，凝滞经络，故腰节以重着冷痛不能转侧为特征。寒凝气滞，得暖则舒，遇寒则甚，故常喜棉帛裹护。邪在经络，非关肾脏，故小便清利。口不渴，苔白腻，脉沉弦缓，均为寒湿阻滞之象。

治法：散寒祛湿，温经通络。

主方：用独活已苳汤^①为主方。依据病情酌加温经散

寒之药。

若痛势轻减，气血亏虚，余痛不已者，治宜标本兼顾，可用独活寄生汤②扶正祛邪。

(二) 湿热腰痛

主证：腰节酸重而痛，痛有热感，转侧不利，或见腰及阴股间汗出粘衣，小便短赤，舌苔黄腻，脉象濡数。

证析：湿遏热蒸，阻滞经络，故腰节酸重而痛，痛有热感。湿热蒸郁，溢于肌表，故腰及阴股汗出粘衣。湿郁热蒸，水道不清，故小便短赤。苔黄腻，脉濡数，为湿热蕴结病证。

治法：清热除湿，通利经络。

主方：用加味二妙散③为主方，酌加舒筋活络之药。

如热去水清，腰痛不解，此属湿邪留滞，可酌情选用独活已苳汤、独活寄生汤调治。

(三) 劳伤腰痛

主证：腰痛如锥刺，痛有定处，痛处拒按，静卧则痛减，活动则痛剧，甚则俯仰转侧不得，轻者舌脉如常，重者可见舌质紫暗或有瘀斑，脉象沉涩。

本病多有劳力失当或跌仆闪挫史，常以初起失治转为慢性，每因操劳用力或触凉受寒而致反复发病。

证析：腰节有支撑全身活动的功能，筋膜束骨而利关节，如劳力失当或跌仆闪挫，最易损伤筋膜发生腰痛。损伤之处，气血瘀滞，故痛如锥刺而有定处。筋膜拘挛，腰节不利，故静则稍安，动则痛剧，甚则俯仰不便，转侧不能。病轻则瘀滞亦轻，舌脉多无变化；病重则瘀滞亦重，可见舌色紫暗或有瘀斑、脉象沉涩等瘀血病证。

治法：舒筋通络，补养肝肾。

主方：新病腰痛，主与归泽化痰汤④舒筋通络，化痰止痛；久病腰痛，主与加味青娥丸⑤补肾行瘀，标本兼顾。

本病单用内治法一般疗效欠佳，尚须配合针灸、按摩、敷药等外治方法，更能提高治疗效果。

无论因于寒湿、湿热、劳伤所致之腰痛，在去邪化痰后都必须妥为调治。又因腰与肾经脉相通，调治之法：当以治肾为本，方能巩固疗效，使腰痛不再反复。

三、方药化裁

1. 独活己苕汤。

方药见本章关节痛篇第一方。

本方散瘀祛湿，舒筋活络。用于新病寒湿腰痛，宜去黄芪，加威灵仙、狗脊、续断、怀牛膝等品，以加强散寒祛湿、温经止痛之力。邪去络通，其痛可止。

2. 独活寄生汤（《千金方》）

独活15克 桑寄生10克 秦艽10克 防风10克 熟地黄10克 白芍10克 杜仲10克 怀牛膝10克 茯苓10克 当归6克 川芎6克 细辛3克 桂心3克 人参3克 甘草3克

此方益肝肾、补气血、祛风湿、止腰痛。适用于寒湿腰痛，痛势轻减，气血不足，余痛不已者。方中多补益肝肾气血之品与祛散风寒湿邪之药配合，共成扶正祛邪之剂。本方用于寒湿腰痛，虚实互见者，能使气血足而祛散余邪，强肝肾而止腰痛。

3. 加味二妙散

方药见第七章痿证篇第五方。

本方清热祛湿，通利筋脉。用于湿热腰痛者，加木瓜、威灵仙，其舒筋活络除湿止痛功效更佳。

4. 归泽化瘀汤

全当归12克 泽兰15克 丹参15克 没药6克 白芍15克 甘草6克 续断15克 怀牛膝15克

此方舒筋通络，化瘀止痛。适用于劳伤腰痛不能转侧者。方用全当归、泽兰、丹参活血行瘀，以通凝滞；白芍、甘草、没药舒挛活络，以止疼痛；配续断、怀牛膝温养筋骨，以疏利经脉。去瘀凝，通筋脉，可使疼痛得以渐次消除。

如腰痛因于跌仆闪挫者，加三七粉3克（冲服），以加强散瘀止痛力量。

5. 加味青娥丸

补骨脂10克 杜仲15克 胡桃仁10克 当归10克 川芎6克 白芍15克 熟地黄10克 续断15克 怀牛膝15克 没药6克 威灵仙15克

此方以《局方》青娥丸加味组成，功能益肾壮腰，养血通络，散瘀止痛。适用于劳伤腰痛，经久不愈，转侧不利者。方中用补肾壮腰、强筋健骨诸品作为主药，配以当归、川芎、白芍、地黄养血通络；没药、威灵仙散瘀止痛。补肾则筋络易通，瘀通则疼痛自除。

如兼气虚者，加黄芪。兼有风湿者，加独活、秦艽。

如腰痛已成慢性，亦可加量制成丸剂常服，使其缓慢通舒渐次取效。（表72）

表72

腰痛病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
外感湿邪，阻犯经络，留滞不去，湿从寒化为寒湿，湿从热化为湿热。 劳力闪挫，伤于筋骨，气血凝滞，瘀阻经络	寒湿腰痛	散寒祛湿 温经通络	独活己苳汤 独活寄生汤
	湿热腰痛	清热除湿 通利经络	加味二妙散
	劳伤腰痛	舒筋通络 补养肝肾	归泽化痰汤 加味青娥丸

结 语

痛证是临床上最为常见的一类病证。引起人体内外各部发生疼痛的病机，无不由于脏腑瘀塞、经络阻滞所致，即所谓痛则不通的缘故。

人体五脏六腑、四肢百骸、五官七窍、皮毛血脉等器官和组织，都是依靠经络系统的联络进行内外上下的密切联系。所以，人体精津气血，由内达外，宣上导下，荣左养右，循环运行，皆以经络作为通路来保持其平衡和协调。正如《灵枢·本藏篇》说：“经脉者，所以行血气而荣阴阳，濡筋骨而利关节者也。”临床上常见的肺病胸膈痛，心病左胸痛，肝病胁痛，脾病腹痛，肾病腰痛等，都是内脏有病由所属经络从里达外的反映。外邪侵袭体表经络沿其途径由表及里，也可产生内脏病变。如风寒湿痹，始为邪留经络阻滞气血，发生关节疼痛，久则邪气循经内传，导致《素问·痹论》所说心痹、肺痹、肝痹、脾痹、肾痹、肠痹、胞痹等疾病。由此可见，经络与脏腑的关系

极为密切。

然而外邪侵犯头面肢体所发生的各种痛证中,也有仅留滞于体表各个部分而不内传脏腑的,这便是受病于经筋的缘故。人体十二经筋属于经络系统运行于体表筋肉间的组织,手足三阴三阳经筋起于四肢末端,盘旋于指、腕、腋、肩、踝、膝、股、髀等肢节,而后布于颧颊、阴器、胸背、头身。其运行道路,皆在体表肢节,不入内脏。所以,经筋受病所反映的痛证,大多表现于体表各部,绝少涉及内脏病变。

本章所论头痛、面颊痛、肩臂痛、胸胁痛、关节痛、腰痛各证,除劳饮积胸、胆热瘀积属胸肺、肝胆内脏疾病引起胸胁痛外,其余多属体表间经络阻滞所致,而又大多属于经筋的病变。正因痛证的发生无不由于脏腑瘀塞、经络阻滞引起,故所列诸方皆以通瘀行滞、导达经络、理气活血为基本法则,即所谓通则不痛的道理。(表73)

表73

痛证病机简表

身体各部 发病	头部	〈头为三阳经脉汇合之所 又是脏腑气血聚集之地〉	病机	〈风寒湿邪痹阻头巅 气血亏虚清空失养〉	头痛
	面部	〈足阳明经筋络上颈挟 口、合于颧颊结于耳前〉	病机	〈风毒入络受病经筋 络脉拘急瘀滞不通〉	面颊痛
	肩部	〈手三阳经筋起于手指结 于腕挟臂循肘上绕肩脾〉	病机	〈寒邪侵袭凝滞筋脉 提挈重物伤及筋络〉	肩臂痛
	胸胁	〈肺居上焦主呼吸通水道 肝胆居于肋下职司疏泄〉	病机	〈胸络瘀塞水液停聚 胆热瘀郁腑气不通〉	胸胁痛
	肢节	〈十二经络分布周身通达 表里内联脏腑外络肢节〉	病机	〈风寒湿邪壅蔽关节 留滞经络阻塞气血〉	关节痛
	腰部	〈腰为肾之外府,筋膜经 脉皆贯于肾而络于腰节〉	病机	〈坐卧湿地湿阻经络 劳力负重损伤筋骨〉	腰痛

第十一章

血 证

凡血液不循常道而溢出于体外的疾病，称为血证。血溢于上，出于口鼻，称为吐血、衄血；血渗于下，出于二阴，称为尿血、便血；血液溢出于肌肤，称为汗血、肌衄。由此可见，血液涉及的范围颇为广泛，并可出现于许多急慢性疾病之中，

人体血液的生化、输布、统摄、调节及血液中废物的排泄都是在心、肝、脾、肺、肾五脏及其所属经络的分工合作下进行的。饮食入胃，生化精微，脾助胃输精，上归心肺。心主血脉，精微入心化血，注入于脉，运行周身。肝为藏血之脏，动则血归于心，静则血归于肝，故肝有调节和平衡全身血量的功能。肺主一身之气，气为血帅，血随气行，血液的运行和输布，必须依赖肺气以为动力。肾为水脏，受藏脏腑津液，肾与膀胱相合，职司排泄小便，而血液中之废物，即

通过肾与膀胱随尿排泄于体外。把血液在人体中的这一经过概括起来，就是：生化于脾，藏受于肝，总统于心，输布于肺，施泄于肾。血液在人体中循环运行升降出入的道路，是以经络为途径来实现的。脏腑经络通达表里，内联脏腑，外络肢体，大要分之，可区别为阳络、阴络两部分：上部的、体外的、上行的脉络，属于阳络；下部的、体内的、下行的脉络，属于阴络。阳络统摄于上焦心肺；阴络统摄于下焦肝肾；脾居中焦，具有平衡气血、统摄升降的职能。所以，人体血液在经脉系统的统摄之下，气之与血，相辅为用，运行于脉道之中，和调于五脏，洒陈于六腑，出入升降，环周不休，充润营养于全身各个部分。

导致出血的病机，正如《灵枢·百病始生篇》所说：

“阳络伤则血外溢，血外溢则衄血；阴络伤则血内溢，血内溢则后血。”由此可见，发生各种出血病变的主要原因，皆由脉络损伤所致。伤于阳络者，多因心肺受邪，致血溢于上而见咳血、呕血、鼻衄、齿衄、目衄、肌衄、或为斑疹；伤于阴络者，多因肝肾受邪，致血渗于下而见尿血、便血、或为妇女崩漏。其致病因素，有外感，有内伤；其病机演变，多与火热、气逆、内虚的关系至为密切。火盛则迫血妄行，气逆则血不循经，内虚则血失统摄；上溢则假道于肺胃，下溢则假道于二阴。又因气为血之帅，血为气之母，气附于血，血随气行的缘故，气盛则血热，气逆则血逆，气虚则血脱，故气机的盛衰也是导致血证发病的主要因素之一。

关于血证的治法，虽然血证有多种，病因不同，治法各异，但止血、消瘀、宁血、补血则是通治血证的四个纲

领大法。出血初起，止血为先，止血之要，在于消除病邪，如徒事止血，血终难止。止血必须防瘀，否则离经之血瘀留经隧，必致遗留后患。如内有瘀血盘踞于脏腑经络之间，血脉阻滞，流行不畅，致血不循经而出血者，瘀血不去，血亦难止，此则当以消瘀为要法。血已止，瘀已消，当从宁血、补虚论治，以防出血反复。宁血必先宁气，宁气之要，善于补虚，补虚宜从调治肝脾着手。血之不宁，缘于出血过多，或血耗阴亏，阳气独盛，血不得安；或气随血耗，气虚不固，血难统摄。阳盛气实者，重在养阴平肝，肝气平静，血得安宁；气虚不摄者，重在补气扶脾，脾旺则能统摄血脉。总之，治血诸法的运用，止血要防瘀，宁血要善补，总以不留后患为目的。

本章着重论述咳血、呕血、鼻衄、齿衄、尿血、便血等证；由于崩漏、风疹块颇为临床多见，故附章末以供参考。

第一节 咳 血

咳血又称嗽血，有远血、近血的区分。

血随咳嗽而出，称为咳血，其血由肺而来，谓之远血，必见痰血相兼，或纯血鲜红，挟有泡沫。不咳而一咯即出，称为咯血，其血来于喉间，谓之近血，必见喉间作痒，或喉痛声嘶，治同咳血。

肺癆咳血，已有专篇论述，本篇不予论及。

一、病因病机

喉以下从气道以至于肺之脉络损伤，即可出现咳血或咯血的病变。在内科杂病中，以外感风热、久咳伤络、或继发于心痹疾患者，较为常见。

外感风热之邪，上犯肺系，热壅于肺，化火伤阴，阴虚则肺燥，燥热相搏，气逆为咳，因咳伤络，血溢于肺，随痰咳出者，发为咳血。热伤咽喉，喉中作痒，血溢于喉，不咳而一咯即出者，发为咯血。如热势为甚，由喉及肺，则咳血与咯血并见。

久患咳嗽，损及肺阴，阴虚肺燥，肺失清肃，肺气逆，因咳伤络，络伤则咳痰带血，或咳出纯血鲜红。此类咳血也有因肺络损伤难于恢复，或感外邪，或触恼怒，甚或饮食辛燥醇酒，均可动火生热触及于肺，而致反复发作为咳血。如是则多成为终身暗疾。

杂感风寒湿邪，留滞经脉，壅蔽关节，邪气内传，损伤心络，致成心痹。心肺并居上焦，心脉与肺脉相通，心络瘀痹，久则肺络随瘀，心肺同瘀，肺气壅遏，气壅络伤，即可发生咳血。

由此可见，导致咳血的病机，因于外邪袭肺者，主因在热；因于久咳伤络者，主因在虚，而以阴虚肺燥为多见；继发于心痹者，主因在瘀，皆由心肺同瘀所致。

二、辨证施治

咳血有虚实之辨，风热袭肺多属实证，久咳伤络、心痹络瘀则多虚实互见。因于风热者，治宜清热降逆；因于久咳者，治宜敛阴保肺；因于心痹者，治宜化瘀止血。

（一）风热袭肺

主证：起病先有恶风发热，继则咳嗽气急，喉中作痒，胸中隐痛，咳痰带血，或咳出纯血鲜红，口干鼻燥，舌质红，苔薄黄，脉浮数。

证析：风热袭表，荣卫失宣，故起病即见恶风发热。邪热犯肺，清肃失职，故咳嗽气急，喉中作痒。热壅于肺，灼伤肺络，故胸中隐痛，咳痰带血。口干鼻燥，舌红苔黄，脉浮数，均为邪热伤津所致。

治法：清热宁肺，止咳降逆。

主方：用桑杏知贝汤^①为主方，加入凉血止血之药。

凡风热咳血，但宜凉热轻疏，不宜辛散发表，防其劫伤肺液，必致咳血加剧。又如桔梗一类开肺祛痰之品，也当慎用，以防促使咳血。

（二）久咳伤络

主证：有反复咳血史，或偶感外邪，或触恼怒，或劳动用力，发作咳血，痰血相兼，或咳出多量纯血鲜红，胸闷隐痛，舌质红，脉弦或数。

证析：此类咳血多起因于小儿麻疹、百日咳，也可继发于肺癆、肺痛以及慢性咳喘等病。多因肺阴亏损，咳伤肺络而致发病。肺络已伤，难于恢复，故偶感外邪、触犯

恼怒、或劳动用力触及于肺，均可导致咳血发作。血出于肺，故痰血相兼，甚或纯血鲜红。胸闷隐痛，舌质红，脉弦或数，为肺络损伤、阴亏有热之象。

治法：敛阴保肺，止咳止血。

主方：用白芨枇杷汤②为主方，依据病情随证化裁。

本病如并发于肺癆病人，可见午后潮热，夜间盗汗；继发于肺痈病后者，可见咳唾腥臭脓痰。对此，可按肺癆、肺痈治法参酌治疗。

本病宜慎用桔梗类开肺祛痰药品，以防加剧咳血趋势。

（三）心痹咳血

主证：素有心痹病史，心中动悸，胸满气急，咳嗽痰血，或咳出纯血鲜红，或有胸痛，舌质紫暗，或有瘀斑，脉来结代或涩。

证析：心络瘀痹，心气不畅，故心中动悸。心肺同瘀，肺气壅塞，迫血妄行，故胸满气急，咳嗽出血。胸痛为肺络壅滞之象；舌色紫暗或有瘀斑，脉结代或涩，均为瘀血凝滞之证。

治法：养心宁肺，化瘀止血。

主方：用参麦化瘀汤③为主方；依据病情轻重加味治疗。咳血已止，肺气已平，可常服参七通脉散④调治。

本病常兼有风寒湿痹证候，治宜避免羌、防、桂、辛之类风燥方药，防止温燥动血加重病情。（表74）

表74

几种咳血病证鉴别要点

	鉴 别 要 点
风热咳血	起病急，先见恶风发热，或寒战壮热，随即咳嗽胸痛，最初咳嗽无痰，渐即咳出血色痰沫
久咳伤络	有慢性咳嗽或反复咳血史，咳血量有多有少，多者咳血量很大，少者仅见痰带血丝，一般健康情况较好
心脾咳血	有风寒湿痹宿疾及多年心中动悸病史，可见结代脉象
肺病咳血	起病急，先有恶寒壮热，咳嗽胸痛，经数日后咳出多量腥臭脓痰，或脓痰带血
肺癆咳血	先有较长时间午后潮热，夜间盗汗，形体渐次消瘦病史，一般以咳痰带血为多见
其 他	中年以上之人，已往健康情况尚好，如突然出现持续干咳，咳痰带血，血多痰少，病情进展很快者，应考虑是否肺癌可能，必须进一步诊断以图早治

三、方药化裁

1. 桑杏知贝汤

方药见第一章咳嗽篇第四方。

本方清宣凉润，止咳降逆。用于风热壅肺，证见咳痰带血者，加焦栀子、茜草根，以加强凉热止血力量。

如见壮热烦渴者，加生石膏、竹叶，以清热除烦。兼见咽喉肿痛者，加板蓝根、玄参，以消肿利咽。如见咳喘气急者，加桑白皮、地骨皮，以泻肺平喘。若见咳血量多者，加仙鹤草、侧柏叶（炒炭），以凉血止血。

2. 白芨枇杷汤

白芨24克 藕节30克 桑白皮20克 地骨皮15克

冬瓜仁12克 枇杷叶15克 甘草6克

此方敛阴保肺，止血降逆。适用于久咳伤络，咳嗽痰血，或咳出纯血鲜红者。方用白芨、藕节敛阴止血，兼能化痰以保肺络。桑白皮、地骨皮泻肺降逆，以清肺气。冬瓜仁、枇杷叶利痰润肺以止咳逆。肺气宁静，咳血可止。

肺热为甚者，加黄芩。咳嗽为甚者，加紫苑。咳痰不利者，加川贝母。如咳血量多者，加炒蒲黄、或仙鹤草，其行瘀止血之力更优。本病如并见于肺癆病人，伴潮热盗汗者，加胡黄连、百部、夏枯草等品，以清除劳热。本病如继发于肺痈病后，兼见咳唾腥臭脓痰者，加鱼腥草、瓜蒌皮、苇茎等品，以清热排脓。本病如因久咳而致咳血频作者，在咳血止住后，可将本方煎制膏剂，加入适量白蜜，每服一小匙，日服2~3次，颇能取得防止咳血反复之效。

3. 参麦化痰汤

太子参24克 麦门冬15克 五味子10克 丹参20克
郁金15克 白芍15克 甘草6克 云南三七6克（研粉冲服）

此方补心敛肺，化痰止血。适用于心痹咳血，心悸气短，脉来结代者。方以太子参、麦门冬、五味子补心敛肺；丹参、郁金行气通瘀；白芍、甘草平肝降逆；辅以三七散瘀止血。方药配合，虚实兼顾，通补并行，气降则血降，瘀通则血止。

本病一般不易根治，于止血后应重视心痹的治疗。

4. 参七通脉散

方药见第四章心悸篇第六方。

本方补心益气，通瘀活络。心痹咳血于止血后，可用本方粉剂轻量常服，对部分病员确能取得稳定病情，防止咳血反复之效。（表75）

表75 咳血病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
风热壅肺，化火伤络，热壅气逆，咳痰带血。 久咳伤阴，阴虚肺燥，肺燥气逆，咳伤肺络。 心痹日久，肺络同瘀，络瘀气壅，迫血妄行	风热袭肺	清热宁肺 止咳降逆	桑杏知贝汤 加味
	久咳伤络	敛阴保肺 止咳止血	白芨枇杷汤
	心痹咳血	养心宁肺 化瘀止血	参麦化瘀汤 参七通脉散

第二节 呕血

血随呕吐而出，称为呕血，又称吐血。

呕血有近血、远血之分，血色鲜红，不夹食物者，为近血，其血来自贲门（食道）；血色紫暗，血随食物呕出者，为远血，其血来自胃腑。不过，血出于胃，如出血量多，出血迅速，亦可见呕出鲜红色血；血出贲门，如血液渗入胃腑，随食物呕出，也可见呕出紫暗色血。无论呕出之血来自于胃或来自贲门，由于未尽吐出之血渗入肠中随粪排出的缘故，都可同时伴有黑色粪便证候。

呕血一证，大多属于胃腑的病变，也有因于他脏疾病累及于胃而发病的，尤以肝病日久累及于胃者为常见。胃病呕血多有慢性胃痛史，肝病呕血多有慢性肝炎史。本篇着重以肝、胃疾病所发生的呕血作出论述。

一、病因病机

《症因脉治》指出：“内伤吐血，时而呕吐纯血一连数口，此胃家吐血之症；若倾盆大出者，则肝家吐血也。”由此可见，呕血发病与胃和肝的关系最为密切。

胃病呕血，一般久患胃痛病史。胃痛起病，皆由气滞食阻，胃失和降，发生疼痛，久则气滞络瘀而致胃痛反复发病。发病时可经数日或数周，缓解后可经数月或数年不发疼痛。如因病情发展，即可表现疼痛期渐长，缓解期渐短，甚则疼痛经常，缠绵不已。如在胃痛缓解期间，患者不加注意，偶因酗酒暴食，胃中壅积，动火伤络，即可导致血出于胃，发生呕血。

肝病呕血，一般有慢性肝炎病史。慢肝久延，肝气郁滞，肝郁不为疏泄脾胃，则脾运失常，脾气不伸，累及于胃，则胃失和降。所以，肝病的病机演变，始而肝脾气滞，继则气滞血瘀，肝脾积块（肝脾肿大），久之则胃络同瘀。病在此际，如为饮食所伤，或因恼怒气逆，即可触犯于胃，损伤胃络，导致气逆血奔，发生突然呕吐大量鲜血。

此外，膈证、胆热胁痛、胃癌等疾病，都可出现呕血。对此，必须详加鉴别。

二、辨证施治

呕血初起，或因火热，或因气逆，或因积食，多属

实证；如呕血量多或日久不止，每易由实转虚。凡治呕血，但止其血，其呕自止，止血以和中降逆为先，有治胃治肝之分。胃病为主，但治其胃；肝病为主，则当肝胃同治；若已见气虚、阴虚证象，用药必须兼顾。

（一）胃痛伤络

主证：有胃痛史。呕血前可见胃痛加剧，呕血后往往胃痛减轻或消失，血随食物呕吐而出，血色紫暗或鲜红，伴大便色黑或便秘，舌质红，苔黄腻，脉滑数。若见面色薄白，短气少气，舌淡脉弱者，此属气随血耗，气血亏虚。

证析：胃痛日久，胃络瘀滞，或以酗酒动火，或以积食伤络，而致发生出血。血溢于胃，随食呕吐，故血色紫暗。如出血量多，奔逆而出，则见血色鲜红。已出之血，渗入肠中，随粪而下，故见黑色粪便。如呕吐伤阴，腑气不降，则见大便秘结。呕血初起，多因胃中积热，故见舌红苔黄，脉象滑数。若见面白短气，舌淡脉弱，多因出血量多，气随血耗，由实转虚所致。

治法：和中降逆，保胃止血。

主方：用白芨丹参饮^①为主方；依据兼夹郁火、积食以及气虚等不同见证加减化裁。呕血已止，宜常服保胃散^②调治。

凡胃病出血，必须重视饮食调理，宜于少吃多餐，不宜过饥过饱，宜食容易消化之物，避免辛辣动火之品。

（二）肝郁犯胃

主证：有慢性肝炎史。经常右胁隐痛，脘腹痞胀，大便不爽，时秘时溏，偶以触犯恼怒，或伤于饮食，突然

呕血，血色鲜红或紫暗，可见肝脾积块（肿大），或身现血痣，舌色瘀紫，脉多细涩。

证析：肝居右胁，肝气郁滞，肝络随瘀，故慢肝病人常见右胁隐痛如针刺。肝郁则脾气难伸，胃失和降，故脘腹痞胀，大便不爽，时秘时溏。肝脾气郁，络脉同瘀，故见肝脾积块（肿大），身现血痣。在此肝脾胃相互瘀郁的病机演变中，如因恼怒、伤食触犯胃络，即可产生气逆血奔而致暴发呕血。舌瘀紫，脉细涩，均为血脉瘀滞病证。

治法：舒肝降逆，化瘀止血。

主方：降逆止血，主与丹鹤芍甘汤^③；呕血已止，主与舒肝理脾，通瘀消积，可用消痞散^④常服调治。

肝病呕血属虚实互见者居多，治宜虚实兼顾而以消瘀通络为基本法则。因本病多继发于慢肝疾病，于止血之后，尚须按慢肝诸法调理治疗。

此外，无论胃病或肝病呕血，在暴发呕血时，应使病人情绪安定，静卧少动，进以适宜饮食，甚或暂时禁食，以防呕血加剧。如见血出如涌，当首先采取救急方法：呕血而见心烦面赤，舌红脉数者，属于火盛气壅迫血奔逆，急宜平肝清火凉血止血，可用黄芩24克，白芍24克，甘草6克，煎汤加入三七粉3克调服；如呕血而见面白肢冷，汗出脉弱者，多因出血过多，恐有气虚欲脱之危，急宜益气固脱敛阴止血，可用人参6克，麦门冬15克，五味子10克，煎汤加入三七粉3克调服。俟病势缓和，再按上列诸方辨证施治。（表76）

表76

几种呕血病证鉴别要点

鉴 别 要 点	
胃病呕血	过去胃脘部经常隐隐作痛，或表现为周期性发作，饥时作痛，食后稍安，伴有反酸暖气等证
肝病呕血	过去有慢肝史，经常右肋间隐隐刺痛，突然呕出多量鲜红色血，伴肝脾积块（肿大）或身现血痣等证
胆热呕血	右上腹剧烈绞痛，右肋下触痛明显，呕血后疼痛减轻，伴口苦尿黄或双目黄疸等证
膈证呕血	持续出现少量呕血，伴胸痛、吞咽困难、食入即吐等证
胃癌呕血	呕血如赤豆汁，气味腥臭，脘腹积块，扪之有形，胀满疼痛，呕血后常持续出现大便黑色，伴食欲不振，形体消瘦，面目萎黄等证

三、方药化裁

1. 白芨丹参饮

方药见第八章胃痛篇第六方。

本方保胃和中，化瘀止血。适用于胃痛伤络，呕血便黑，正气未虚者。

兼脘腹痞满，暖气食臭者，为食积壅滞，加炒莱菔、鸡内金，以和中消食。兼心烦口苦，舌红脉数者，为胃中郁热，加黄连、竹茹，以清泻郁火。兼腹满便秘者，为阴亏肠燥，加麻仁、郁李仁润肠通便。如呕血已止，大便瘀黑久久不净。见气虚脉弱者，为气虚不摄，加黄芪、白芍，以助益气敛阴之力。

2. 保胃散

方药见第八章胃痛篇第七方。

本方保胃健脾，散瘀止痛。适用于胃痛呕血，出血已止，胃痛未除者。胃痛缘于络瘀气滞，呕血虽止，病根未除，常服本方确能防止出血，缓解疼痛，渐次取得根治胃痛之良效。

3. 丹鹤芍甘汤

丹参24克 仙鹤草30克 郁金15克 枳壳12克 白芍20克 甘草6克 三七6克（研粉分3次冲服）

此方平肝降逆，化瘀止血。适用于肝郁犯胃。呕吐鲜血者。方以丹参、郁金舒肝开郁，活络通瘀。白芍、甘草平肝降逆。枳壳下气止呕。仙鹤草、三七散瘀止血。是方通瘀而不动血，止血而不留瘀。

4. 消痞散

方药见第五章积聚篇第三方。

本方舒肝理脾，通瘀消积。适用于肝郁犯胃，呕血已止，肝脾肿大尚未消除者。肝胃络瘀，呕血虽止，脾积未消，病根未除，用本方调治，既可防止呕血反复，又能渐次消除脾积，但须坚持治疗，其效方著。（表77）

表77 呕血病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
胃痛日久，气滞络瘀，酗酒暴食，动火伤络。 慢肝久延，累及于脾，久则胃，络同瘀，恼怒伤食，触及胃络，气逆血奔	胃痛伤络	和中降逆 保胃止血	白芨丹参饮 保胃散
	肝郁犯胃	舒肝降逆 化瘀止血	丹鹤芍甘汤 消痞散

第三节 鼻 衄

血从鼻窍而出，称为鼻衄。如衄血量多，呛入口中，口鼻俱出，又称脑衄，治同鼻衄。

鼻衄一证，可出现于多种疾病，在内科杂病中，较多见于风热外袭、阳明积热、肝火上亢等疾患。至于外伤、妇女倒经所致鼻衄，本篇不予论及。

一、病因病机

肺开窍于鼻，风热外袭，首犯鼻窍，阻遏肺气，邪阻气壅，郁而化火，灼伤鼻络，迫血妄行，发为鼻衄。

足阳明之脉，上交鼻额；手阳明之脉，下夹鼻孔。如饮酒过度，或恣食辛辣厚味，胃肠积热，循经上逆，损及络脉，迫血妄行，因而衄血。

肝阳素旺之人，多因肾水虚亏，水不涵木，易动肝火。如肝火乘肺，循经上逆，血随火升，溢出清窍，则为鼻衄。

由此可见，鼻衄属火盛、阴亏者居多，尤以素有慢性鼻腔宿疾者更常见。所以唐容川《血证论》指出：“此证鼻塞者尤多。”

二、辨证施治

(一) 风热袭肺

主证：鼻中衄血，鼻燥口干，头痛恶风，咳嗽痰稠，或身热咽痛，舌质红，脉浮数。

证析：风热袭肺，邪阻热壅，损伤鼻络，故鼻燥口干，鼻中衄血。风热袭表，荣卫失和，故头痛恶风，或有身热。邪热壅肺，肺气不宁，故咳嗽痰稠。如热伤咽喉，则见咽喉肿痛。舌质红，脉浮数，为风热阻遏卫肺之象。

治法：清泻肺热，凉血止血。

主方：用桑芩泻肺汤^①为主方；依据病情随证加味。本病虽有表证，切忌发汗，发汗伤津，津伤血燥，必致衄血难止。

(二) 阳明积热

主证：鼻中衄血，鼻燥口臭，烦渴引饮，或大便秘结，舌质红，苔黄燥，脉象洪数。

证析：阳明积热，消灼胃津，故烦渴引饮。阳明经脉上交鼻额，下夹鼻孔，邪热蒸腾，循经上逆，故伤络衄血，鼻燥口臭。津亏肠燥，腑气不通，则见大便秘结。舌红苔黄，脉象洪数，皆为燥热病证。

治法：清胃泻热，降逆止血。

主方：用黄芩石膏汤^②为主方；衄血为甚，酌加凉血止血之药。

本病与风热衄血皆为热证，彼因外邪，病在卫肺，故以清肺泻热为主；此因内热，病在阳明，故以泻胃降

逆为主。这是临床上最常见的两类鼻衄证候，尤多见于素有鼻腔宿疾的患者。对此，于衄血止住后，必须注意治疗鼻腔疾病，否则衄血不易根除。

（三）肝火上亢

主证：头目昏胀，眩晕耳鸣，鼻中衄血，心烦善怒，眠差多梦，或双目红赤，舌质红，脉弦劲或弦数。

证析：肝火上亢，冲击头巅，故头目昏胀，眩晕耳鸣。肝火上扰，损及阳络，故鼻中衄血。木火上盛，神舍难安，故心烦善怒，眠差多梦。肝开窍于目，如肝火过旺，则见双目红赤。舌质红，脉弦劲数，为阴亏肝旺之象。

治法：平肝清火，滋阴降逆。

主方：用钩藤汤^③为主方；衄血甚者，加入止血降逆之药。

本病常为肝旺眩晕的并发证候，多由肝阴亏虚、络脉失养而致衄血。于衄血止住后，尚须继以养阴柔肝方药，宜参考眩晕治法。

除上列各类治法外，对鼻衄较甚者，还可采取塞鼻止血方法。用棉花蘸入云南白药塞入鼻腔；或用湿棉条蘸白矾粉（研极细）塞鼻，亦能取得止血良效。

此外，由于鼻衄一证，既可见于许多急慢性疾病，又可见于多种鼻腔疾病。因此，如遇反复出现鼻衄的病人，必须审证求因，明确诊断，寻求根治方法。其中尤以气虚不摄，血无所主，因而鼻衄、齿衄、肌肤瘀斑合并出现之证，大多从虚治本，切勿妄用凉血治标方药。

三、方药化裁

1. 桑芩泻肺汤

桑白皮24克 枯黄芩20克 小蓟15克 茜草根 24克 甘草6克 白茅根30克

此方清肺泻热，降逆止血。适用于肺热鼻衄，咳嗽气逆，脉象浮数者。方以桑白皮、黄芩清肺降逆；小蓟、茜草根、白茅根凉血止血。气降则血降，热清则血止。

2. 黄芩石膏汤

枯黄芩20克 生石膏24克 知母15克 麦门冬15克 生地黄15克 白芍20克 甘草6克

此方清泻胃热，滋阴降逆。适用于胃热鼻衄，烦渴引饮，脉洪数有力者。方用黄芩、石膏清泻阳明胃热；知母、麦门冬、生地黄养阴滋阴液；白芍、甘草和荣降逆。清火可以保阴，养阴可以润燥，降逆即可宁血。

如见大便秘结者，加生大黄，以助通腑泻热之力。衄血太甚者，加地榆、炒蒲黄，以增强凉血止血力量。

3. 钩藤汤

方药见第三章眩晕篇第一方。

本方平肝清火，滋阴降逆。适用于阴虚肝旺，头目昏胀眩晕者。本方治疗肝旺鼻衄，宜加重黄芩剂量，加白芍，以加强清热降逆，凉血止血力量。

如衄血为甚者，加茜草根、小蓟。肝火过旺，见面红目赤，心烦口苦者，加焦栀子、龙胆草，以清肝泻火。

(表78)

表78

鼻衄病因病机证治简表

病 因 病 机	辨 证	治 则	方 药
风热外袭，阻犯鼻窍，邪阻热壅，伤络衄血；阳明积热，循经上逆，伤及鼻络，迫血妄行；肝火乘肺，循经伤络，血随火升，溢出清窍	风热袭肺	清泻肺热 凉血止血	桑苳泻肺汤
	阳明积热	清泻胃热 降逆止血	黄芩石膏汤
	肝火上亢	平肝清火 滋阴降逆	钩藤汤加味

第四节 齿 衄

血从齿龈齿缝溢出，称为齿衄，又称牙宣。

齿衄多因齿龈间发生慢性或破坏性病变形成，亦可与其他慢性疾病合并出现。由于阳明经脉环绕于上下齿龈，肾主骨，齿乃骨之所终。故本病常以胃与肾的病变为辨证中心。

一、病因病机

齿衄有实火、虚火之分，或以胃中积热，循经上逆，迫血妄行；或以肾水不足，虚火上炎，损伤脉络。凡此，均可导致齿衄发病。

手阳明经脉入于下齿，足阳明经脉入于上齿。如酒食不节，偏嗜辛辣厚味，阳明积热，循经伤络，血随火动，则见齿龈衄血，甚则龈间腐烂肿痛。

肾主骨，齿乃骨之余。若肾阴亏虚，阴不敛阳，虚火

上炎，则口齿不固而松动；虚火伤络，则见齿缝渗血。

唐容川《血证论》说：齿属肾，口乃胃之门户，牙床为胃经脉络所绕，胃中实火，血随火动，口渴龈肿；肾虚火旺，阴血不藏，齿豁血渗。可见，齿衄与胃火、肾虚的关系最为密切。

二、辨证施治

齿衄初起，有牙龈发痒或灼热感，渐即出现牙齿松动出血，或睡时渗出少量血液，醒后则止。在病程中，可见衄血时轻时重，甚或牙龈红肿腐烂，如日久失治，反复发病，还可因齿根损伤而致牙齿脱落。

治齿衄以清火养阴为基本法则。衄血而牙龈红肿腐烂者，主与清胃泻火兼养其阴；衄血而牙不痛、口不臭、无红肿腐烂者，主与滋肾固齿兼清虚火。在治疗中，配合外用凉血解毒方药漱口治法，更能取得良好疗效。

（一）实火

主证：牙龈红肿疼痛，齿缝出血，血色鲜红，甚或腐烂溢脓，口干口臭，或大便秘结，舌苔黄厚，脉象滑数。

证析：阳明经脉环绕上下牙龈，阳明积热，蒸腾于上，循经伤络，故牙龈肿痛出血，甚则热蒸肉腐而致溃烂溢脓。胃中积热，故口干口臭。肠中积热，则见大便秘结。苔黄厚，脉滑数，为阳明实火病象。

治法：清胃泻火，凉血消肿。

主方：用清胃散毒汤^①为主方；兼用芷黛煎漱口，以清解口腔毒热。

(二) 虚火

主证：齿龈渗血，血色淡红，或睡后溢血，醒后血止，齿摇不坚，或松动倾斜，口不臭，牙不痛，或微痛不甚，舌质红，脉细数。

证析：肾水亏虚，阴不敛阳，虚火浮动，故齿不固而松动。虚火伤络，阴血不藏，故齿龈渗血或睡后溢血。口不臭，牙不痛，舌质红，脉细数，均为虚火病象。

治法：滋阴固齿，清降虚火。

主方：滋阴固齿，主与安肾固齿汤^③；清降虚火，外用芷黛煎漱口。

此外，齿衄尚有因于其他全身性慢性疾病引起发病的。对此，仍应审证求因，针对病情，予以治疗。如属齿龈间病变发生衄血而无其他证状表现者，单用芷黛煎漱口治疗，亦可取得清火消肿、止血固齿之良效。

三、方药化裁

1. 清胃散毒汤

黄连6克 连翘24克 地榆15克 玄参15克 鱼腥草30克 甘草6克

此方清火凉血，消肿散毒。适用于实火牙宣，齿龈衄血，红肿疼痛者。方以黄连、连翘清泻火热；玄参、鱼腥草、甘草消肿散毒；地榆凉血止血。肿消热退，衄血自止。

齿衄为甚者，加炒蒲黄。齿龈溃腐化脓者，加蒲公英。大便秘结者，加生大黄，以通腑泻热，取效更捷。

2. 芷黛煎

方药见第二章失音篇第四方。

本方生津泻火，消肿止痛。外用煎汤漱口治疗齿衄肿痛，尚须加地榆（生用），其消肿止血功效甚优。如遇慢性牙周病，尚可常用本方漱口，颇能取得消肿固齿之良效。

3. 安肾固齿汤

熟地黄10克 丹皮10克 山萸10克 山药15克 茯苓15克 枸杞10克 炒阿胶6克 怀牛膝10克 骨碎补10克

此方滋阴降火，补肾固齿。适用于阴虚火炎，齿摇不固，牙缝渗血者。方中地黄、丹皮、枸杞、阿胶滋补肝肾之阴，壮水即可清降虚火。山药、茯苓性味甘淡，补益脾胃之阴，土润又能养肺滋肾。怀牛膝导血下行，以降上炎之火。骨碎补收敛浮阳，以固浮动之齿。阴回火降，齿可固而血可止。

衄血为甚者，加茜草根、白茅根。虚火偏旺，手足潮热者，加知母、炒黄柏。

如遇慢性齿衄，齿摇不坚，非久治不足为功者，可将本方制丸剂常服，并用芷黛煎加地榆方配合漱口，更能取得标本同治之效。（表79）

表79 齿衄病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
酒食不节，阳明积热，循经伤络，口齿肿痛衄血。 肾阴不足，阴不敛阳，虚火浮动，齿摇渗血	实火	清胃泻火 凉血消肿	清胃散毒汤 芷黛煎
	虚火	滋阴固齿 清降虚火	安肾固齿汤 芷黛煎

第五节 尿 血

血随尿出,称为尿血,又称溲血、溺血。尿血多少各有不同,尿血量微,尿色多无异常;若尿血量多,小便可现淡红色或酱油色。

尿血与血淋不同,临床上常以尿血无痛或微痛者,称为尿血;尿血而兼小便滴沥涩痛者,称为血淋。《张氏医通》指出:“痛属火盛,谓之血淋;不痛属虚,谓之溲血。”可见,血淋与尿血有实火虚火、有痛无痛的区别。本篇专论尿血,血淋已详淋证一篇。

一、病因病机

肾与膀胱并居下焦,受藏脏腑津液,主司小便排泄。如肾与膀胱积热,阴络损伤,血渗水道,随尿而出,则为尿血。导致的病机,据临床所见,或以风水失治,移热下焦;或以癆热内传,损及肾络;甚或尿血日久,肾气亏虚而致血随气陷。凡此,均为尿血常见的发病原因。

风水起因于风邪袭表,阻遏肺气,肺气失宣,外不能布达津液出于肌表,内不能通调水道下输膀胱,风遏水阻,泛滥肌肤,发为水肿。肺与肾津气相通,风为阳邪,易于化热,如风水失治,移热下焦,水热互结,损伤肾络,即可发生尿血。

癆虫传染,传变不一,或为肺癆,或为癆暗喉疮,或为马刀挟瘦,或为骨髓癆损,或为肠癆久泄。究其病机,

正如《外台秘要》引《苏游论》所说：“内传毒气，周遍五脏。”因此，如癆热内传，下移及肾，疰蚀津血，损伤肾络，便能发生肾癆尿血。

由此可见，尿血发病，皆由下焦蓄热损及阴络所致。如尿血日久，阴血亏伤，气随血耗，又能出现气阴同虚的病变。肾气已虚，封藏不固，血随气陷，则尿血愈频。所以，尿血前期多见阴虚结热证候，而尿血后期则多气阴同虚的病变。

此外，如劳力创伤，或他脏有病累及于肾，也能导致尿血发病。

二、辨证施治

尿血一证，其致病原因各有不同，但皆由于下焦蓄热损及阴络所致。其证属虚实互见者居多，因而着重区辨阴虚结热、气阴同虚两类证候。一般来说，尿血未久，多属肾阴亏损、下焦结热，其证偏实，治宜滋阴清火、凉血止血；尿血日久，或反复发病，多属气阴同虚、血随气陷，其证偏虚，治宜益气养阴、摄血止血。在治疗中，仍应依据致病之原因，邪热之有无，来确定治疗法则的运用。

（一）肾阴亏损，下焦结热

主证：小便灼热，尿短尿频，尿中带血，尿时或有微痛，心烦口干，腰部酸胀作痛，或见手足潮热，夜间盗汗，舌质红，脉弦细数。

因于风水起病者，多有反复浮肿证候出现。因于癆热内传者，常有癆瘵病史，并多伴有午后潮热，夜间盗汗，

形体消瘦等癆热见证。

证析：下焦结热，水道不清，故小便灼热。膀胱为热所迫，故尿短尿频。热伤阴络，血随尿出，故尿中带血。如火热偏盛，灼伤尿道，则见尿时微痛。尿血耗阴，火性炎上，虚火上扰，故心中烦闷。阴不上承，故口中干渴。虚热内蒸，故潮热盗汗。舌质红，脉弦细数，均为阴虚内热病象。至于尿血起于何因，又当依据其病史和平素证候表现，详加区别。

治法：滋阴清火，凉血止血。

主方：用知柏地黄汤^①为主方。属于肾热尿血兼有浮肿者，重在滋肾行水，肾清则水清，水清则血宁。属于肾癆尿血兼有潮热盗汗者，重在养阴制癆，养阴即可降火，制癆即可止血。

（二）气阴两虚，血随气陷

主证：尿中带血，日久不愈，小便频数，甚或不禁，面浮脚肿，体倦神疲，面色萎黄，腰部酸痛，唇舌白淡，脉象细弱。

证析：尿血日久，气随血耗，肾气同虚，肾虚则封藏不固，因而小便频数或不禁。肾虚则气化不及州都，因而水聚三焦，泛滥成肿。阴血亏虚，不为腠泽肌肤，故面色萎黄，唇舌白淡。气虚神弱，故体倦神疲。腰为肾之府，肾虚则脏气不和，故腰部酸痛。脉细弱为气血双虚病征。

治法：益气养阴，补肾摄血。

主方：用益肾理血汤^②为主方。本方重在滋肾行水，益气摄血，可依据病情轻重有热无热，随证化裁。

大凡尿血无痛之证，一般属慢性者较为多见，如能早

期治疗,效果较佳,若拖延日久,下元已亏,不但病变多端,且易成为难治顽疾。又因导致尿血的病因颇多,甚而有不表现其他证状,仅见反复出现尿血者。对此更应详察病因,明确诊断,及早图治。

三、方药化裁

1. 知柏地黄汤

方药见第四章阳痿篇第五方。

本方滋肾养阴,清泻结热。适用于肾阴亏损,下焦结热,尿中带血,小便短频,或兼面浮脚肿者。方以六味地黄汤滋肾行水;知母、黄柏清泻下焦结热。热去水清,尿血可止。

兼面目浮肿,小便短少混浊者,宜加重茯苓、泽泻剂量,或再加车前仁、益母草,其化瘀行水之效更佳。如尿血量多者,再加地榆、茅根,以凉血止血。如腰痛为甚者,加白芍、杜仲,以舒挛止痛。如属肾癆尿血者,去知母、黄柏,加胡黄连、夏枯草,其消除癆热之效尤佳。

2. 益肾理血汤

黄芪30克 熟地黄10克 丹皮10克 山药15克 茯苓24克 山萸10克 泽泻15克 益母草30克

此方滋肾行水,益气摄血。适用于尿血日久,气阴亏虚,血随气陷,面肿脚肿者。方中以六味地黄汤为基础,补益肾阴,泻利水湿。黄芪与六味地黄配合,功能肺肾同治,益气摄血。益母草有化瘀止血、消水退肿之功,合用而奏气阴双补止血消肿之效。

如肢体浮肿，兼见四肢清冷，面色苍白，舌质白淡，脉象沉弱者，为肾阳已虚，水气不化。宜于方中加入制附片15克（火煎），肉桂3克，以加强温阳行水力量。

本方用于治疗慢性肾炎出现顽固性水肿和大量蛋白尿之证，亦颇有疗效。（表80）

表80 尿血病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
风水失治，移热下焦，或癆热内传，损及肾络，发生尿血。初起伤阴耗血，久则气随血耗，气阴两虚	肾阴亏损 下焦结热	滋阴清火 凉血止血	知柏地黄汤 加减
	气阴两虚 血随气陷	益气养阴 补肾摄血	益肾理血汤

第六节 便 血

血从大便而出，或鲜红，或暗黑，或紫鲜并见，或在便前，或在便后，或杂糞而下，或下纯血者，统称便血。

《金匱要略》以大便先后下血，而分远血近血。张景岳发挥其义，如说：“血在便前者，其来近，近者或在广肠，或在肛门；血在便后者，其来远，远者或在小肠，或在于胃。”后世医家又以血色之鲜浊而分肠风、脏毒、痔疾三类。如《本事方·肠风泻血痔漏脏毒篇》说：“下清血色鲜者，肠风也；血浊而色暗者，脏毒也；肛门直射如血线者，虫痔也。”依据临床所见，大体愈近于肛门之便血，血色愈见鲜红；愈离肛门较远之便血，血色愈见暗浊；若胃或小肠下血，则见便如漆黑。从下血与大便的关系，亦可测知出血的不同部位，如大便后见鲜血如线滴出

者，多属肛门出血（如肛门内痔或肛门裂伤）；粪便中夹有鲜血，或紫鲜并见者，多属直肠或大肠出血；粪便与血液混合而下，色黑如漆者，则属胃或小肠大量出血。

胃病出血，已详胃痛、呕血各篇，本篇只就肠道下血作出论述。至于痔瘕便血，必须配合痔科疗法，方能根治。

一、病因病机

大肠乃传导糟粕、排泄大便的器官，肠络损伤，血不循经，血渗肠中，随粪排出，即可发生便血。导致的病机，可分两个方面：一由于火，一由于虚。因于火者，如平素酒食不节，嗜食辛辣厚味，蕴积生热，损及肠络，发生便血；或因肠热泄泻失于治疗，热结肠间，损伤肠络，而致久病留连，粪中带血，反复发病。因于虚者，如初病便血，或以出血量多，或以日久失治，致气随血耗，血失统摄，由实转虚；或因久病泄泻。脾气已虚，脾虚则泄泻愈频，久泄又能损伤肠络，此属因虚而泄、因泄动血。诚如张景岳所说：“大便下血，……由火者多，然未必尽由于火也。故于火证之外，则有脾胃阳虚而不能统血者，有气陷而血亦陷者，有久病滑泄而血因以动者。……大都有火者多因血热，无火者多因虚滑。故治血者，当知虚实之要。”张氏此说，实为便血的辨证要诀。惟据临床所见，便血属纯虚者少，虚实互见者多。

二、辨证施治

肠道下血，以粪中带血为常见，大多与腹痛、泄泻伴随出现，根据病程新久，可分肠中结热、脾虚肠热两类证候。新病下血，多属火热，脾气未虚，多为实证；久病下血，或下血量多，气随血耗，伤及脾胃，则多虚实互见。

如反复出现排便以后，有鲜红血液如线滴出者，大多属于内痔下血，必须注意鉴别。

（一）肠中结热

主证：腹痛下泻，或泻而不爽，粪中带血，或血色鲜红，或紫鲜并见，随粪而下，舌质红，苔黄厚，脉滑数。

证析：肠中结热，肠为热迫，故腹痛下泻，或泻而不爽。热伤肠络，血渗肠间，故粪中带血，随粪而下。血来较近，则血色鲜红，血来较远，则紫鲜并见，甚或紫暗瘀黑。舌红苔黄，脉来滑数，皆为内有结热之象。

治法：益胃清肠，凉血止血。

主方：用参芍榆连汤^①为主方。依据下血多少，血色清浊，随证化裁。

（二）脾虚肠热

主证：大便溏泻，腹中隐痛，粪中带血，血色紫暗，面色萎黄，食少体倦，舌质淡，脉细缓。

证析：便血日久，气随血耗，中气不足，虚寒内生，故血色紫暗，随粪而下。脾气已虚，运化失常，故大便溏泄。肠热未去，留滞肠间，故腹中隐痛。面色萎黄，食少体倦，舌淡脉弱，俱为脾虚血亏所致。

治法：健脾益气，清肠止血。

主方：用参术鱼地汤②为主方。本方补虚清热，扶脾摄血，可根据虚实多少加减化裁。（表81）

表81 几种便血病证鉴别要点

	鉴 别 要 点
肛 痔	排便以后，鲜血如线滴出，每于大便干燥时出现
肛 裂	大便干燥，排便肛门疼痛，大便带有少量鲜红血液
胃 出 血	一般有胃痛史，大便色黑如漆，可同时出现呕血症状
久 痢	既往有痢疾史，大便混有脓血，赤白相兼，伴里急后重
肠 癌	中年以上，见反复便血，粪中混有污浊脓液，伴腹痛腹泻，如腹部扪到包块，应疑为结肠癌肿；如伴肛门肿硬，大便不畅，排便变细，应疑为直肠癌肿

三、方药化裁

1. 参芍榆连汤

明沙参24克 白芍15克 山药15克 生地榆24克
黄连6克 甘草6克

此方益胃清肠，凉血止血。适用于肠热便血，血随粪下，腹痛下泻者。方以明沙参、山药养阴益胃；地榆、黄连清热止血；芍药、甘草舒挛止痛。合用而成清肠止血之功。

如下血如溅，血色鲜红，此为血热太甚，迫血下注。亦称肠风，宜加黄芩、槐花，以加强清热凉血力量。

如肛门肿胀，下血污浊，此为湿热蕴遏，壅迫肛门，

亦称脏毒，宜减去明沙参、山药，加苍术、黄柏、赤小豆、蒲公英等品，以清热化湿，消肿解毒。

凡痔疮下血，兼有内热而无虚象者，亦可用本方主之。

2. 参术鱼地汤

方药见第九章泄泻篇第六方。

本方健脾温中，清肠止血。适用于脾虚肠热，肠鸣腹痛，大便溏泄，粪中带血，舌淡脉弱者。方用太子参、白术、茯苓培健脾气，以扶其虚；砂仁温中运脾，以止其泻；鱼腥草、地榆清化肠热，以止其血；谷芽、枳壳开胃消痞，以和其胃。是方虚实兼顾，扶虚不助热，清热不害脾。

见出血量多者，加白芨、仙鹤草，以敛阴止血。见食少泻多，肛门坠迫者，属脾气偏虚，加黄芪，以扶补脾气。见能食而泻，泻前腹痛，泻下不爽者，属肠热偏盛，加黄连，以清化肠热。见腹部畏寒，遇冷即泻者，属脾虚挟寒，加炮姜，以助寒热两解。（表82）

表82 便血病因病机证治简表

病因病机	辨证	治则	方药
肠中结热，损伤肠络，血随粪下，初为热迫，多属实证，久则气随血耗，虚实互见	肠中结热	益胃清肠 凉血止血	参芍榆连汤
	脾虚肠热	健脾益气 清肠止血	参术鱼地汤

附：崩漏

妇女月经期间排经量超过正常，或行经时间延长，因而经量增多，称为月经过多。若行经期间（或不在行经期

间)大量下血,或淋漓不断,过期不止,称为崩漏,又称崩中漏下。一般以来势急,血量特多,势如泉涌者,称为崩;来势缓,血量不多,持续不断者,称为漏。

根据临床所见,月经过多与崩中漏下,在病情上虽有轻重缓急之分,在病程中亦多互相转化,交错出现。如月经过多,拖延日久,损伤冲任,可致暴崩;久崩不已,气随血耗,失于统摄,必致成漏;久漏不止,亦易成崩。本篇以妇女常见的机能性子宫出血作出论述。

一、病因病机

机能性(或称功能性)子宫出血,多见于青春期和40岁以上的中年妇女,常以月经过多,或行经时间延长,甚或血量特多,月经周期紊乱,妇科检查无异常发现,是其主要特点。导致的病机,皆由冲任不固,或月信初潮,生活不节,失于调护;或经期前后,劳倦忧思,损伤心脾;或有瘀血,留滞经脉,致血不归经,发生崩漏。揆其原因,多是血热、气虚、气郁、血瘀而以血热、气虚者最为常见。

女子胞宫是主司月信的器官。冲脉起于胞中,属于血海;任脉起于会阴,络于胞中,属于阴脉之海;冲任二脉,同起异行,络于带脉。带脉环绕腰部,有约束经脉、联络冲任的职能。冲任统于肝肾,带脉统于脾经,故月经病变常与肝肾脾三者关系密切,尤以肝脾的病变最为常见。如素体气盛,或情志过极,肝气有余,气盛化火,疏泄过强,迫血妄行;或思虑伤脾,劳倦伤气,脾虚气陷,血失

统摄；中年以后，体气渐虚，或孕育过多，肾气亏损，冲任不固；或经期产后，余血未尽，留滞经脉，瘀血不去，新血难安。凡此种种，均可导致月经失常，周期紊乱，轻者月经过多，重者崩中漏下。

二、辨证施治

本病见于青春者，血热居多；见于中年以上妇女者，气虚居多。治疗应根据急则治标、缓则治本的原则，首先采取益气、清热、止血以治其标，经血已止，则宜益气固冲以治其本。《血证论·崩漏篇》指出：“血乃中州脾土所统摄，脾不摄血，是以崩漏，名曰崩中，示人治崩必治中州也。”由此可知，治崩漏又当以扶脾摄血为基本法则。

主证：月经量多，过期不止，有初起暴崩，血如泉涌，继而淋漓，日久不绝的；有初起淋漓，血如屋漏，忽然暴崩的。一般经期延长，六七天或更久，甚至可达2周左右。月经周期紊乱，周期缩短（20天左右）或延长（40天左右），也有周期无变化的。

见血色鲜红，其质稠粘，间有小块，腰腹胀痛，心烦面红，舌红脉数者，为血分壅热、迫血妄行。

见血色淡红，其质清稀，小腹空坠，心悸气短，食少懒言，肢体困倦，唇淡舌白，脉虚大或细弱者，为心脾不足、血失统摄。

见血来淋漓不止，时少时多，小腹胀痛连及胸胁，脉沉弦者，为肝气郁滞、经血逆乱。

见血来淋漓或骤然下血甚多，血色紫暗有块，小腹疼痛拒按（血块排出，腹痛减轻），舌苔如常或有紫点，脉沉涩者，为瘀血留滞、血不归经。

证析：崩中漏下或月经过多，虽有血热、气虚、气郁、血瘀之分，总以冲任不固为主要病机，且出血过多，气随血耗，气血已亏，冲任更难固摄。所以患此病者，常累月经年，月经周期缩短或延长，行经期间血量特多，过期不止，或暴崩，或漏下，或淋漓不绝。其证虚实互见，多以气虚不固为主证，以夹热夹郁夹瘀为兼证，这是本病的主要特点。

治法：行经期间，宜于扶脾调肝，益气止血；经血已止，宜于调补脾肾，养血固冲。

主方：益气止血，用三黄益母汤①为主方；调补脾肾，用固冲汤②为主方。依据病程新久、病势缓急以及血热、气郁、血瘀等兼证增减化裁。

治本病当以益气固经为先，切忌当归、川芎一类辛窜动血方药。兼有血热，佐以清热凉血，但不可过用寒凉，防止离经之血瘀凝经隧；兼有血瘀，辅以活血行瘀，但不可过用攻逐，防止动血助崩。对因于其他疾病引起的崩中漏下，在月经静止期间，更应着重原发疾病的治疗。

三、方药化裁

1. 三黄益母汤

黄芪30克 太子参24克 白术15克 生地黄15克
地榆24克 炒蒲黄24克（包煎） 白芍20克 甘草6克

益母草30克

此方扶脾调肝，益气止血。适用于机能性月经过多，崩中漏下，或过期不止，淋漓不绝者。方以太子参、黄芪、白术甘温益气，扶脾摄血。生地黄性味甘寒，滋阴养血，使其温而不燥。地榆、蒲黄、益母草行血止血，使其止血而不留瘀。芍药、甘草和调肝气，使其补而不滞。方药配合，虚实兼顾，其调经止血功效极优。

兼血热者，加牡丹皮10克，栀子炭10克，以凉解血中郁热。气虚为甚，血量特多，宜将黄芪加量为60克，以增强益气摄血功能。兼气郁者，加郁金10克，香附10克，以助理气开郁之力。兼血瘀者，加丹参10克，泽兰10克，以助活血行瘀。

凡月经过多，经期延长，或崩中，或漏下，一般情况尚好，可将本方从行经第一天起，日进一剂（煎服三次），经净停药，能使血量减少，经期缩短。如此按月治疗，便能促使经量和周期逐渐恢复正常。余常用之，其效颇佳。

2. 固冲汤

黄芪24克 太子参20克 白术15克 茯苓15克 丹参10克 白芍10克 熟地黄10克 五味子6克 枸杞6克 益母草10克 大枣10克 甘草3克

此方调补脾肾，养血固冲。适用于冲任不固，月经量多，经期紊乱者。方以太子参、黄芪、茯苓、白术益气扶脾，脾旺则能统血。丹参、熟地黄、五味子、枸杞补肾养血，肾强则能固冲。白芍、甘草和调肝气；丹参与益母草同用，又能调经理血。合而用之，协奏调经固冲之功。

如气虚甚者，加重参、芪药量。血虚甚者，加生地黄、

制首乌。脾虚便溏者，加缩砂仁。经前腹痛者，加延胡索、制香附。

凡月经过多，经期延长，气虚偏甚者，可将本方于月经前连服三、四天（日尽1剂），如行经期间血量不多，直服至经净为止。若血量太多，改用三黄益母汤连服数天。月经已净，再服本方三、四天。如此按月治疗，颇能取得经量减少，经期缩短，促使月经周期恢复正常的良好疗效。

附：风疹块

风疹块古名隐疹(疹)，是以时隐时现，遇风易发，皮肤瘙痒，隆起疹块，或赤或白，大小不一，成团成片，反复发作作为主证的一种疾病。

本病如发作一次或数次后，反复发作，缠绵不愈，则成慢性疾患。

一、病因病机

《金匱·中风历节篇》指出：“邪气中经，则身痒而隐疹。”《诸病源候论》称为风瘙隐疹，认为导致的病机：

“人皮肤虚，为风邪所折，则起隐疹。”“邪气客于皮肤，复逢风寒相折，则起风瘙隐疹。”由此可知，本病是以皮肤虚，风邪乘虚，入中经络，为起病主因；邪客皮肤，留伏经络，又以复逢风寒为复发诱因。故其病常多反复发作。

人体肌肤是经络荣卫出入之所，荣行脉中，荣运血脉，输布全身，内注脏腑，外养肢体；卫行脉外，温充肌肤，司腠理开合，捍卫外邪。风疹块发病，即以卫气不足，肌肤不密，风邪乘虚而入，客于荣分，留伏经隧所致。风为阳邪，最易化热，邪客荣分，为热所迫，外透肌肤，发为疹块。正因本病形成，一因于虚，一因于热，故疹块出现常多红白相兼。血热偏盛，赤疹多于白疹；卫气偏虚，白疹多于赤疹。热甚者遇热辙发，得凉则减；虚甚者遇冷辙发，得暖则减。此即《巢源·风瘙身体隐疹候》所说：“热结成赤疹也，得天热则剧，取冷则减也”；“白疹得天阴雨冷则剧出，风中亦剧，得晴暖则减，著衣身暖亦瘥也”。所以，本病一经发病，往往邪留不去，时隐时现，反复发作。若因发作频繁，耗伤卫气，更能导致正虚邪恋，成为慢性疾病。如饮食冷热，或气候变化，或情绪波动，或异常气味（如花香、鱼腥等），以及各种刺激因素，偶有所触，都能引起发病。发病一次，经过病程愈来愈长，或经数周数月，甚至经年不愈。所以，古人有“风疹不时举发，致成终身之累”之说。

二、辨证施治

主证：起病迅速，皮肤瘙痒异常，用手搔抓，疹块随手而起。其状大小不一，或小如豆粒，或大如钱币，有疹块成片如朵云成团的，有成小疹如蚊迹蚤痕的。疹块多少不一，有赤色有白色，或赤疹多于白疹，或白疹多于赤疹，可出现于全身任何部位。有一日间时发时退的，有连发数

天即愈的,有反复发作而经久不退的。一般疹块消退,皮肤不留痕迹。

见疹块色赤,或赤疹多于白疹,得热则剧,得凉则减,或夜甚昼轻,口中干渴,舌质红,苔薄黄,脉滑数者,为风热入荣,血热偏盛。

见疹块色白,或白疹多于赤疹,遇冷则剧,得暖则减,或昼甚夜轻,口不渴,舌淡红,苔薄白,脉略数或如常者,为卫气偏虚,荣分伏热。

证析:风疹块皆由肌肤不密,风邪乘虚,热留荣分而发病。病程有新久,素体有强弱,受邪有微甚,因而表现证候亦多轻重不一。一般属热者多,属虚者少,新病不久,素体强壮,热盛居多;反复发作,经久不愈,素体虚弱,兼虚居多。又因荣行脉中,有内注脏腑、外输肢体的职能,如邪热内闭,不能外透于肌肤,热壅于内,胃肠逆乱,还可出现胸闷腹痛、呕吐泄泻等证。

治法:清热凉血,止痒消疹。

主方:以四地化疹汤为主方,依据病情久暂偏热偏虚随证化裁。

三、方药化裁

四地化疹汤

地龙24克 丹皮10克 赤芍15克 生地黄15克 生地榆20克 地肤子24克 白藓皮24克 南藿香10克

此方凉解血热,散风消疹。适用于风疹块发作,赤疹肤热,遇热则剧者。方中多清热凉血之品,地龙、丹皮、

赤芍、生地黄合用，能养阴活络、和荣散瘀；地肤子、白藓皮相伍，能祛散皮肤风热；佐地榆凉血清肠，防止肠中壅热；配藿香芳香和中，使其凉而不滞，运行药力。风热解除，荣血得安，疹块自消。

见疹块色白，或白疹多于赤疹，遇冷则剧，得暖则减，或经久不愈者，方中加入黄芪30克，以助益气固表、托散邪热之力。

见疹块发作，胸闷腹痛，呕吐泄泻者，加法半夏12克，黄连10克，以降逆止呕，清肠止泻。

大体风疹块属热者多，一般以此方投之，屡用屡效，颇为可靠。

凡疹块发作与某种诱因有关者，应注意避免。

结 语

血证范围广泛，本章仅以杂病中常见之咳血、呕血、鼻衄、齿衄、尿血、便血作出论述。关于崩漏、风疹块的病机和治法，仅抒管见，附列章末。

人体气血总统于心肝脾肺肾五脏，气为血帅，血随气行，以经脉为道路，出入升降，循其常轨，循环不休，脏气逆乱，络脉损伤，便可发生种种出血病变。心肺受邪，损伤阳络，假道于肺胃，病为咳血、呕血、鼻衄、齿衄；肝肾受邪，损伤阴络，假道于二阴，病为尿血、便血、崩中漏下。导致病机虽有外因、内因的不同，总不外血热、气逆、内虚而发病。血热则迫血妄行，气逆则血不循经，内虚则血失统摄，因而伤于阳络者，上逆而出于口鼻；伤

于阴络者，下渗而出于二阴。新病出血，多为阳热有余，实证居多；久病出血，耗伤气血，常多由实转虚。故出血着重实证、虚证的辨别。

脉诊在血证中颇为重要，出血多见芤脉，也有气随血耗脉现细缓而弱的，此为脉证相合，属于顺证。如出血之脉，现数大无根、或弦急不调，此为阴血亏竭，阳热独亢，属于逆证，应防暴脱。

治血证以止血、消瘀、宁血、补虚为要法。出血初起，止血为先，止血必须防瘀，以免遗留后患。因于血瘀出血者，则当以消瘀为主法。血已止，瘀已消，宜从宁血、补虚论治，宁血之要，善于补虚，方能防止出血反复。在治疗中，无论实证虚证，血逆于上者，应着重平肝降逆，肝平则气降，气降则血宁；血渗于下者，应着重扶脾敛阴。扶脾则能统血，敛阴则血自固藏。这又是治血诸法中的一个基本法则。（表83）

表83

血证病机简表

血证	{	血热迫血妄行	{	阳络损伤	{	咳血	呕血	治则	{	止血	血出于上： 平肝降逆			
		气逆血不循经		出于口鼻		衄血				消瘀				
		气虚血失统摄		阴络损伤	{	尿血	便血			宁血				
				出于二阴		血崩漏				补虚				

Images have been losslessly embedded. Information about the original file can be found in PDF attachments. Some stats (more in the PDF attachments):

```
{
  "filename": "6ISP6IWR6K+B5rK75paw57yWXzEwMjl4MzYyLnppcA==",
  "filename_decoded": "\u810f\u8151\u8bc1\u6cbb\u65b0\u7f16_10228362.zip",
  "filesize": 35426336,
  "md5": "ee18ab33d427e70455a32063bee4101f",
  "header_md5": "ac94d72acc0fc846235025803dc2c908",
  "sha1": "c1f9adaa335519a19f964d6f88c3372fcbfe4bde",
  "sha256": "a692b76ce1e2937998dda6ad0f637f27d7cef49210d955abe6c76e2c680deb20",
  "crc32": 4275337512,
  "zip_password": "",
  "uncompressed_size": 35623026,
  "pdg_dir_name": "\u2558\u03b1\u2555\u00a1\u2553\u00f1\u2553\u256c\u2568\u252c\u2592\u03b1_10228362",
  "pdg_main_pages_found": 542,
  "pdg_main_pages_max": 542,
  "total_pages": 553,
  "total_pixels": 2164516130,
  "pdf_generation_missing_pages": false
}
```